



单位代码： 10369

学 号： 2019201101008

安徽中医药大学

2022 届博士研究生学位论文

先秦两汉经脉腧穴演变研究

THE EVOLUTION OF MERIDIANS AND ACUPOINTS IN THE PERIOD OF PRE-QIN AND TWO HAN DYNASTIES

学 科 专 业： 中 医 学

研 究 方 向： 针灸经络腧穴基础与应用研究

导 师： 王 荃 教授

博 士 生： 马 强

论文完成单位： 安徽中医药大学

2022 年 5 月 · 合肥



密 级： 公开

学 号： 2019201101008

安徽中医药大学

2022 届博士研究生学位论文

先秦两汉经脉腧穴演变研究

THE EVOLUTION OF MERIDIANS AND ACUPOINTS IN THE PERIOD OF PRE-QIN AND TWO HAN DYNASTIES

作者姓名：马强

申请学位级别：博士

指导教师姓名：王荃

职称：教授

学科专业：中医学

研究方向：针灸经络腧穴基础与应用研究

学习时间自：2019 年 09 月 01 日起

至：2022 年 06 月 30 日止

论文提交日期：2022 年 03 月 19 日

论文答辩日期：2022 年 05 月 21 日

学位授予单位：安徽中医药大学

学位类型：学术学位

目录

图表目录	VII
说明	1
中文摘要	3
ABSTRACT	8
引言	17
1 研究背景	19
1.1 研究现状	19
1.1.1 经脉、腧穴演变研究的“新材料”	19
1.1.2 经脉、腧穴演变研究的“新方法”	20
1.1.3 简帛针灸文献文本特点	21
1.1.4 出土经脉、腧穴文献整理情况	23
1.2 研究选题	24
1.2.1 选题依据	24
1.2.2 研究目的	24
1.2.3 研究意义	25
1.2.4 创新点	25
1.2.5 研究内容	25
1.2.6 研究方法	26
2 先秦两汉经脉理论演变分述	27
2.1 十二经脉理论演变梳理	27
2.1.1 手太阴脉	27
2.1.1.1 出土文献、文物手太阴脉考订	27
2.1.1.2 讨论	31
2.1.2 手厥阴脉	35
2.1.2.1 出土文献、文物手厥阴脉考订	35
2.1.2.2 讨论	37

2.1.3	手少阴脉	41
2.1.3.1	出土文献、文物手少阴脉考订	41
2.1.3.2	讨论	44
2.1.4	手阳明脉	47
2.1.4.1	出土文献、文物手阳明脉考订	47
2.1.4.2	讨论	50
2.1.5	手少阳脉	53
2.1.5.1	出土文献、文物手少阳脉考订	53
2.1.5.2	讨论	57
2.1.6	手太阳脉	60
2.1.6.1	出土文献、文物手太阳脉考订	60
2.1.6.2	讨论	64
2.1.7	足太阴脉	67
2.1.7.1	出土文献、文物足太阴脉考订	67
2.1.7.2	讨论	69
2.1.8	足厥阴脉	73
2.1.8.1	出土文献、文物足厥阴脉考订	73
2.1.8.2	讨论	75
2.1.9	足少阴脉	78
2.1.9.1	出土文献、文物足少阴脉考订	78
2.1.9.2	讨论	80
2.1.10	足阳明脉	83
2.1.10.1	出土文献、文物足阳明脉考订	83
2.1.10.2	讨论	86
2.1.11	足少阳脉	90
2.1.11.1	出土文献、文物足少阳脉考订	90
2.1.11.2	讨论	95
2.1.12	足太阳脉	101

2.1.12.1	出土文献、文物足太阳脉考订	101
2.1.12.2	讨论	108
2.2	奇经八脉理论演变梳理	112
2.2.1	冲脉	112
2.2.2	任脉	115
2.2.3	督脉	118
2.2.4	带脉	121
2.2.5	跷脉	123
2.2.6	维脉	125
2.3	经别理论演变梳理	127
2.4	经筋理论演变梳理	129
2.4.1	“筋”“经筋”“十二经筋”概念演变	129
2.4.2	“经筋”与“经脉”异同处	131
2.4.3	经筋理论的自身特点	134
2.4.3.1	通行卫气与解结	134
2.4.3.2	经筋病诊查方法	136
2.4.3.3	经筋病症的分类	137
2.4.3.4	经筋病治疗方法	138
2.4.4	经筋理论未来研究刍议	140
2.4.4.1	对病灶“筋结点”进行详辨	140
2.4.4.2	膜系统理论与内脏建立联系	141
2.4.4.3	从解剖层面阐释经筋实质	142
2.4.5	小结	142
2.5	络脉理论演变梳理	144
3	先秦两汉经脉理论演变讨论	147
3.1	经脉理论的起源	147
3.1.1	“脉”“血脉”“经脉”概念演变	147
3.1.2	精气学说促成“血气”概念	148

3.1.3	先秦两汉巫医并用	150
3.1.4	早期针灸实践经验的积累	152
3.2	经脉命名演变	155
3.3	经脉数量演变	157
3.4	经脉循行方向演变	161
3.5	经脉分支的产生、演变及其意义	161
3.5.1	经脉分支产生的原因	162
3.5.1.1	古人观察、解剖实体经验的积累	162
3.5.1.2	“象”思维影响下比附自然河流	162
3.5.1.3	临床诊疗经验的积累	163
3.5.2	出土文献、文物中经脉分支情况	164
3.5.3	《灵枢·经脉》篇经脉分支特点	168
3.5.4	经脉分支演变意义	171
3.5.4.1	解释临床病症	171
3.5.4.2	构建经脉环形流注体系	172
3.5.5	小结	174
3.6	经脉主治病症演变	175
4	先秦两汉腧穴理论演变分述	177
4.1	足太阳脉腧穴	177
4.1.1	老官山漆人足太阳脉腧穴演变梳理	177
4.1.2	足太阳脉其余腧穴演变梳理	187
4.2	足少阳脉腧穴	193
4.2.1	老官山漆人足少阳脉腧穴演变梳理	193
4.2.2	足少阳脉其余腧穴演变梳理	195
4.3	足阳明脉腧穴	199
4.3.1	老官山漆人足阳明脉腧穴演变梳理	199
4.3.2	足阳明脉其余腧穴演变梳理	201
4.4	手太阴脉腧穴	209

4.4.1	老官山漆人手太阴脉腧穴演变梳理	209
4.4.2	手太阴脉其余腧穴演变梳理	210
4.5	手厥阴脉腧穴	216
4.5.1	老官山漆人手厥阴脉腧穴演变梳理	216
4.5.2	手厥阴脉其余腧穴演变梳理	217
4.6	手少阴脉腧穴	220
4.6.1	老官山漆人手少阴脉腧穴演变梳理	220
4.6.2	手少阴脉其余腧穴演变梳理	222
4.7	手阳明脉腧穴	224
4.8	手少阳脉腧穴	227
4.9	手太阳脉腧穴	229
4.10	足太阴脉腧穴	232
4.11	足厥阴脉腧穴	235
4.12	足少阴脉腧穴	237
4.13	督脉腧穴	239
4.14	任脉腧穴	242
5	先秦两汉腧穴理论演变讨论	245
5.1	腧穴理论的起源	245
5.1.1	早期腧穴理论载体	245
5.1.2	腧穴形成因素探讨	245
5.1.3	早期腧穴、经脉的“共存关系”	247
5.2	腧穴数量演变	248
5.3	腧穴命名演变	249
5.4	腧穴归经、定位逐渐明确	254
5.5	腧穴主治病症形成	257
5.5.1	临床经验的积累	257
5.5.2	中医理论的推理	257
5.5.3	抄录经脉病症或针灸方	258

结语	259
参考文献	265
古代文献	265
学术专著	266
学术论文	270
综述	288
个人简介	309
致谢	310

图表目录

表格

表 1	先秦两汉手太阴脉演变特点对比	31
表 2	先秦两汉手厥阴脉演变特点对比	37
表 3	先秦两汉手少阴脉演变特点对比	44
表 4	先秦两汉手阳明脉演变特点对比	50
表 5	先秦两汉手少阳脉演变特点对比	57
表 6	先秦两汉手太阳脉演变特点对比	64
表 7	先秦两汉足太阴脉演变特点对比	69
表 8	先秦两汉足厥阴脉演变特点对比	75
表 9	先秦两汉足少阴脉演变特点对比	80
表 10	先秦两汉足阳明脉演变特点对比	86
表 11	先秦两汉足少阳脉演变特点对比	95
表 12	帛书《阴阳》是动病“部位+厥”命名	99
表 13	先秦两汉足太阳脉演变特点对比	108
表 14	“十二经筋”概念定义对比	130
表 15	先秦两汉十二经脉命名对比	155
表 16	出土文献、文物及《灵枢·经脉》篇经脉分支数目表	168
表 17	《灵枢·经脉》篇经脉分支分类情况	171
表 18	先秦两汉时期天柱穴命名、定位演变	180
表 19	先秦两汉时期八髎穴主治病症演变	189
表 20	《内经》《明堂经》光明穴主治条文对比	197
表 21	《内经》《明堂经》足三里穴主治条文对比	205
表 22	《内经》《明堂经》上、下巨虚穴主治条文对比	206
表 23	《内经》《明堂经》丰隆穴主治条文对比	206

表 24	老官山漆人足三阳脉与特定穴关系	208
表 25	《刺数》《内经》《明堂经》天府穴演变简表	212
表 26	《内经》十二经脉井穴定位	214
表 27	老官山漆人手三阴脉疑似腧穴点与特定穴对比	223
表 28	《内经》《明堂经》合谷穴、阳溪穴主治病症对比	224
表 29	《内经》《明堂经》后溪穴主治条文对比	229
表 30	《内经》《明堂经》隐白穴主治条文对比	232
表 31	《内经》《明堂经》商丘穴主治条文对比	233
表 32	《内经》《明堂经》大钟穴主治条文对比	238
表 33	老官山《刺数》位于动脉搏动处的腧穴	246
表 34	老官山医简《刺数》腧穴名称演变	250
表 35	出土文献经脉、腧穴名称对比	252
表 36	先秦两汉时期腧穴名称演变来源	253

图片

图 1	《阴阳》(甲本)衍文“之间”	2
图 2	老官山漆人手太阴脉循行路径	29
图 3	双包山木人手太阴脉循行路径	30
图 4	老官山漆人手厥阴脉循行路径	36
图 5	双包山木人手厥阴脉循行路径	37
图 6	老官山漆人手少阴脉循行路径	42
图 7	双包山木人手少阴脉循行路径	43
图 8	老官山漆人手阳明脉循行路径	48
图 9	双包山木人手阳明脉循行路径	50
图 10	老官山漆人手少阳脉循行路径	55
图 11	双包山木人手少阳脉循行路径	56
图 12	老官山漆人手太阳脉循行路径	62

图 13	双包山木人手太阳脉循行路径	63
图 14	老官山漆人足太阴脉循行路径	69
图 15	老官山漆人足厥阴脉循行路径	75
图 16	老官山漆人足少阴脉循行路径	80
图 17	老官山漆人足阳明脉循行路径	85
图 18	双包山木人足阳明脉循行路径	86
图 19	老官山漆人足少阳脉循行路径	94
图 20	双包山木人足少阳脉循行路径	95
图 21	老官山漆人足太阳脉循行路径	106
图 22	双包山木人足太阳脉循行路径	107
图 23	老官山漆人疑似任脉线循行路径	115
图 24	双包山木人督脉循行路径	118
图 25	新石器时代砭石	152
图 26	新石器时代砭石	153
图 27	战国青铜砭针	153
图 28	西汉金针	153
图 29	老官山漆人足太阳脉腧穴分布示意图	178
图 30	老官山漆人足少阳脉腧穴分布示意图（右侧）	193
图 31	老官山漆人足阳明脉腧穴分布示意图	199
图 32	老官山漆人手太阴脉腧穴分布示意图	209
图 33	老官山漆人手厥阴脉腧穴分布示意图	216
图 34	老官山漆人手少阴脉腧穴分布示意图	220

说明

1. 对诸文献、文物的名称及其简称说明：

马王堆帛书《足臂十一脉灸经》在文中简称《足臂》；《阴阳十一脉灸经》在文中简称《阴阳》，其后又以甲本、乙本、丙本区分不同传本；老官山医简曾命名为《十二脉》《别脉》者现归入《脉书·下经》，《刺数》也改称为《刺数》，但由于整理小组重新定名后的《天回医简》还未正式出版，且学术界已发表的论文中习惯以《十二脉》《别脉》《刺数》相称，故笔者在文中也称为《十二脉》《别脉》《刺数》；《黄帝内经》简称《内经》；《黄帝内经素问》简称《素问》；《灵枢经》简称《灵枢》；《黄帝八十一难经》简称《难经》；《黄帝明堂经》简称《明堂经》；《黄帝内经太素》简称《太素》。四川省绵阳市永兴镇双包山汉墓出土的针灸经脉漆木人形，马继兴先生在其论文中简称为“针灸木人”，笔者遵从马老称法，并根据考古学命名方法中的“小地名原则”^[1]，在本文中简称为“双包山木人”。四川省成都市天回镇老官山汉墓出土的经穴髹漆木人，笔者在文中简称为“老官山漆人”。此外，由于经脉名称在出土文献以及传世文献中并不一致，故笔者在文中以“手/足+阴/阳+脉”的形式统一指称，如用“手太阴脉”代指出土文献中“臂泰阴温”（《足臂》）“臂钜阴脉”（《阴阳》甲本）“臂巨阴脉”（《阴阳》乙本）“臂钜阴之脉”（《阴阳》丙本）“辟大阴脉”（《十二脉》）以及传世文献中“肺手太阴之脉”（《灵枢·经脉》），其余十一条经脉指称方式依此类推。

2. “先秦两汉经脉理论演变分述”一章中，《足臂》《阴阳》原文以裘锡圭先生编写的《长沙马王堆汉墓简帛集成》为主，并参考其他学者的研究进行考订，老官山医简《十二脉》《别脉》《刺数》原文，以及老官山漆人和双包山木人的循行路线根据目前整理人员公开发表的文献进行考订，文中用到的特殊符号说明如下：

- 1.1 （）号：异体字和假借字，一般随文注出正体字和本字；
- 1.2 〈〉号：表示简帛原有讹误字，随文注出正字；
- 1.3 □号：简帛图版中有残存笔画但不能识别的字，一个□号代表一个字；

^[1] 夏鼐. 关于考古学上文化的定名问题[J]. 考古, 1959(04): 169-172.

- 1.4 □号：因残损而完全缺失的文字，所缺字数不能确定；
- 1.5 某字加正方形外框，如：，表示原字残损，根据别本或文字补出；
- 1.6 【】号：其中文字完全残失，根据上下文、别本或其它古籍补入的字；
- 1.7 {}号：衍文，如马王堆帛书《阴阳》（甲本）中有“起於臂兩骨之間（間）{之間（間）}”，即图1所示，红圈所示之处为衍文“之間”。
- 1.8 =号：重文，如“耳聾煇=膊=（煇煇膊膊）”；
- 1.9 ·号：分段号，见于《阴阳》（乙本）；
- 1.10 A（B—C）：表示括号前的A字相当于B，B相当于C，如“嬰（要—腰）”。



图1 《阴阳》（甲本）衍文“之间”

3. 在“先秦两汉经脉理论演变分述”一章中引用图片来源说明：

老官山漆人照片及经脉循行绘制图来自期刊论文：程施瑞,周兴兰,邱科,等. 成都老官山汉墓经穴髹漆人像十二经脉循行考证（英文）[J]. *World Journal of Acupuncture-Moxibustion*, 2022, 32(01): 40-48.

双包山木人经脉循行绘制图来自期刊论文：马继兴. 双包山汉墓出土的针灸经脉漆木人形[J]. *文物*, 1996(04): 55-65+98.

在“先秦两汉腧穴理论演变分述”一章中引用图片来源说明：

对足三阳脉腧穴演变梳理中照片及绘制图来自期刊论文：程施瑞,周兴兰,邱科,等. 成都老官山汉墓经穴髹漆人像十二经脉循行考证（英文）[J]. *World Journal of Acupuncture-Moxibustion*, 2022, 32(01): 40-48. 又根据整理人员硕士学位论文（张乙小. 成都老官山汉墓经穴髹漆人像足三阳脉腧穴考证研究[D]. 成都中医药大学, 2020.）标记腧穴点。

对手三阴脉腧穴演变梳理中照片及绘制图来自整理人员硕士学位论文：黄柳杨. 老官山汉墓出土经穴髹漆人像手三阴经腧穴特点研究[D]. 成都中医药大学, 2017.

中文摘要

经脉、腧穴是针灸理论体系的核心概念，随着出土文献、文物的增多，先秦两汉时期经脉、腧穴理论发展演变面貌也日见斑斓，逐渐清晰起来，早期经脉、腧穴理论受各种因素影响而呈现多层次、多系统的特点，其形式及内涵经历了由实践经验积累到高度理论固化的过程，而《内经》《明堂经》则分别是先秦两汉时期经脉、腧穴理论相对固化的代表。

● 选题依据

本研究综合文献、文物资料，梳理先秦两汉时期经脉、腧穴理论的演变过程，描绘早期经脉、腧穴发展概貌，通过对相关理论研究现状的综述，认为深入研究出土医学文献中经脉、腧穴相关内容特点，尤其是与传世文献进行对比分析很有必要，但目前针灸实验及临床主要依据院校教材进行指导，对先秦两汉时期的针灸理论特点关注度不够，而先秦两汉又是针灸理论演变、成熟的关键时期，对经脉、腧穴等针灸理论中核心概念的准确认识，影响着现代针灸学理论体系的建设与发展，故本研究从文献学角度出发，探讨先秦两汉这一中医学萌芽及早期发展时期经脉、腧穴理论的演变问题。

● 研究目的

本研究拟解决的问题主要包括以下两点：

第一：梳理先秦两汉时期从出土文献、文物，到《内经》《明堂经》中经脉、腧穴理论的具体演变过程。

第二：对早期经脉、腧穴相关概念进行探讨，对理论研究相对空白之处进行补充，使相关概念和理论得到较为准确的诠释与完善。

● 研究意义

本研究的理论意义在于，依据最新出土的地下材料，结合传世文献，理清经脉、腧穴理论早期发展的脉络及特点，尤其是还原经脉、腧穴在产生及早期发展阶段的实质，准确把握相关概念的内涵及界限，此外对秦汉医家哲学观、身体观、疾病观也有一定程度的探讨补充。

本研究的实践意义在于，对早期经脉、腧穴理论演变的梳理，首先有助于对

传世医籍字词及医理的正确理解；其次客观认识秦汉医家的治疗经验，可以避免科研、临床过程中对针灸基本概念（如经脉循行路径、腧穴主治病症等）产生认识误差或过度夸大，在一定程度上对未来针灸文献研究提供参考。

● 研究材料

本研究主要基于先秦两汉时期记载有经脉、腧穴相关内容的文献、文物，分为“出土文献、文物”和“传世文献”两类，介绍如下：

全国各地出土包含有经脉、腧穴内容的简牍、帛书，主要有：

湖南长沙马王堆汉墓帛书《足臂》《阴阳》（甲、乙本）；

湖北江陵张家山汉墓医简《脉书》载《阴阳》（丙本）；

四川成都老官山汉墓医简《十二脉》《别脉》《刺数》；

甘肃武威旱滩坡汉墓《武威汉代医简》；

湖北荆州胡家草场汉墓相关医简。

出土文物主要有两具：

四川绵阳双包山汉墓针灸经脉漆木人形；

四川成都老官山汉墓经穴髹漆木人。

“传世文献”主要包括：

医学专著如《内经》《难经》《明堂经》等；

涉医文献如《庄子》《史记》等。

需要说明的是，马王堆帛书、张家山汉简可查阅到原始图版，成都老官山汉墓医简还未公开所有图版，因此对老官山文献、文物的研究，只能根据整理人员公开发表的资料，属于“二次文献”。出土文物中，河南南阳医圣祠曾出土一具东汉陶人，全身遍布排列成行的小孔，被认为是穴位点，但由于相关资料不足，故本研究仅分析双包山与老官山出土的两具针灸文物。在分析传世文献如《内经》《难经》《明堂经》的过程中，适当参考了后世医家注解以及现代研究成果。

● 研究方法

主要用到文献学定量研究法、历史分析法、科学研究法：

本研究首先采用文献学定量研究法，对先秦两汉时期文献、文物中的经脉、腧穴相关资料进行搜集、整理；其次借助历史分析法，研究先秦两汉社会背景、

文化背景等因素对经脉、腧穴演变的影响，在此基础上，对经脉、腧穴具体演变过程进行梳理，并借助相关科学研究方法，如利用“科学比较法”对比不同文本经脉之间的异同点，从而认识其特点及发展规律；利用“理论抽象法”对经脉、腧穴演变的原因、具体过程及其意义进行解释；利用“科学归纳法”将经脉、腧穴演变的结果进行分析，总结规律性的认识。多学科研究方法综合分析经脉、腧穴的演变过程，尤其是站在秦汉医家的立场下进行思考，能避免在研究过程中掺杂现代人的思维观念。

● 研究结果

主要体现在以下五个方面：

第一：先秦两汉时期影响经脉、腧穴形成和演变的因素众多。主要包括：①解剖实体组织的认识；对体表动脉搏动、浅表静脉的诊察；利用骨针、石针进行早期医疗活动而积累的经验；巫医并用时代，对邪魅入侵体内路径的认识，促使先民形成“脉”“经脉”等概念；②“精气学说”的形成，尤其将“气”这一概念引入血脉、身体局部中，形成“血气”“头气”“足气”等下位概念，促进了经脉运行血气、经脉环形流注体系以及“气街”等理论认识的形成；③哲学数术观念“天六地五”“十二月”“八极”“三百六十五日”等，影响经脉、腧穴数量的演变。

第二：经脉命名从早期“足/臂+阴/阳+脉”（《足臂》）“阴/阳+脉”“身体部位+脉”“臂+巨（泰）/少阴+脉”（《阴阳》）等较为复杂的命名方式演化为《灵枢·经脉》中“脏/腑+手/足+阴/阳+脉”的统一命名方式，其影响因素不仅与经脉循行起止点的变化相关，还与先秦两汉医家习惯性的用语、行文有关。**经脉数量**方面，主要体现在“心有四支”（《晏子春秋》《淮南子》）“人有四经”（《素问·阴阳别论》）“十一脉”（《足臂》《阴阳》）“十脉”（双包山木人）“十二脉”（老官山漆人、《十二脉》《灵枢·经脉》）之间的变化，尤其是手厥阴脉的产生以及手三阴脉循行及主治病症的演变。**经脉循行**方面，主要体现在循行路径的延长（从腕踝延伸至指趾末端），以及循行方向（向心性、远心性）的变化。**经脉病症**方面，先秦两汉医籍主要用“是动病”“所产（生）病”进行归纳，出土文献与传世文献之间存在明显的传承关系，而经脉病症又与腧穴主治病症的形成相关，《明堂经》中所记载的腧穴主治病症，有很大一部分来源于所属经脉的“是动病”“所产（生）病”。

第三：先秦两汉时期大致完成了经脉分支的产生、演化以及定型。经脉分支的产生主要与临床经验的积累有关，为解释不断增加的主治病证所在部位，秦汉医家便建立经脉分支进行联系，如《足臂》3条分支均与临床诊治经验相关，经脉分支在演变过程中，逐渐被赋予了新的内涵，如老官山漆人13条经脉分支以及双包山木人5条经脉分支，与《足臂》相比不仅数量上有增加，在功能上除可以联系病症部位之外还有联系经脉的作用，至《灵枢·经脉》中，经脉分支增至17条，其中有10条支脉专门用于构建表里经脉之间的联系，进一步构建十二经脉环形流注模式，经脉分支的功能从“联系病症部位”转变为了“构建循环理论”。

第四：十二经筋在早期演化过程中，逐渐变为十二经脉的附属结构。“经筋”是秦汉医家长期对运动系统解剖结构及生理病理特点认识基础上形成的，十二经筋循行及主治病症与帛书相似度较高，理论核心是“通行卫气”，取穴特点主要是“在筋守筋，以痛为输”“维筋相交”“依脉引筋气”等，随着《灵枢·经脉》篇所构建的十二脉环形流注体系的形成与流行，十二经筋逐渐演变为经脉理论的附属结构，使得经脉理论的包容性越来越强，但实用性、针对性反而被削弱。

第五：先秦两汉时期腧穴数量呈现由少变多的发展趋势，老官山漆人体表有116个疑似腧穴点，《内经》记载148个有名称的腧穴，而汉末《明堂经》中腧穴的数量多达349个，呈现“井喷式”的增长，腧穴数量增加的形式主要有：①骨名演变为腧穴名；②脉名演变为腧穴名；③一个部位演变为多个腧穴；④在常用穴的附近或经脉循行路径上增加腧穴。腧穴数量的增加也引发了**腧穴命名**的演变，老官山针方简《刺数》中腧穴主要以“身体部位+阴/阳”的方式进行命名，如“肱阳明”“项钜阳”“耳前少阳”等，这种命名方式《内经》仍存，直至《明堂经》中彻底抛弃，转而使用我们目前所熟知的腧穴名称。**腧穴归经**是腧穴数量增多以及腧穴命名改变影响下形成的，老官山漆人已经出现了腧穴归经的现象，从已公布的手三阴脉腧穴分布特点来看，所归经的腧穴主要在动脉搏动处，体现早期“脉穴合一”的特点，而后演变至《内经》《明堂经》，主要将四肢肘膝关节以下的五输穴归入相应经脉，而其余部位的腧穴以“脉气所发”按部位进行归纳。**腧穴主治病症**的形成因素，有医疗实践经验的积累、中医理论的推理、经脉主治病症和早期针灸方主治病症的移植等。

● 研究结论

主要得出以下四点结论：

第一：先秦两汉时期经脉理论的转型受多种因素影响，象数思维、哲学意识等非医疗实践因素也不可忽视，故不能单从某一方面对其进行阐释，对于“十一脉”到“十二脉”之间的转变，也不能看作是一个简单的线性发展过程；腧穴主治病症的形成中包含有实践因素和非实践因素两部分，尤其《明堂经》中腧穴主治病症的非实践因素较多，并且被后世针灸文献所转引，准确辨别腧穴主治病症中非实践因素，对针灸临床规范化至关重要。

第二：“经脉”概念最早来源于先民对血管形态和功能的观察，《足臂》内容提示早期经脉的发展受灸疗活动影响较深，在用于联系病症部位的过程中，逐渐演化出了经脉分支，经脉分支的功能转变与经脉理论内涵之间密切相关，随着十二经筋“附属”于十二经脉，以及秦汉时期藏象学说、阴阳五行学说的影响下，经脉的“理论指导”作用越来越强。

第三：腧穴概念的产生以及早期分布位置，与体表触诊所及的动脉搏动点相关，在腧穴数量逐渐增多的过程中，其定位也越来越明确，早期腧穴名称中的经脉命名元素，随着腧穴命名的改变而逐渐隐退，必然导致腧穴归经专门化现象的出现，秦汉时期对腧穴归经情况主要记载于《内经》《明堂经》中，两者认识较为一致，主要是分经排列与分部排列两种归经方式的结合。

第四：在对先秦两汉经脉理论进行考察时，除了依据《足臂》《阴阳》《十二脉》《别脉》《灵枢·经脉》等文本文献外，还应该综合出土文物资料，即老官山漆人与双包山木人，特别是双包山木人所记载的经脉体系尤为迥殊，综合诸文献、文物，才能对定型以前的经脉体系有一个全面的了解，经脉的定型则以《灵枢·经脉》篇的形成为代表。

关键词：出土文献 经脉 腧穴 《黄帝内经》 《黄帝明堂经》 先秦两汉

ABSTRACT

Meridians and acupoints are the core concepts of the theoretical system of acupuncture and moxibustion. With the increase of unearthed documents and cultural relics, the development and evolution of meridians and acupoints in the pre-Qin and Han dynasties gradually became clear. The early acupuncture theory was affected by various factors and presented multi-level and multi-system characteristics. The form and connotation have undergone a process from the accumulation of practical experience to a high degree of theoretical solidification, and *The Yellow Emperor's Inner Canon* (《黄帝内经》) and *The Yellow Emperor's Ming Tang Classic* (《黄帝明堂经》) are the representative of the relatively solidified theory of meridians and acupoints respectively.

● Topic Selection Basis

By reviewing the current status of relevant theoretical research, it is necessary to conduct in-depth research on the characteristics of the meridians and acupoints in the unearthed medical literature. However, at present, the experimental research and medical practice of acupuncture and moxibustion are mainly guided by the textbooks of colleges and universities, and there is not enough attention to the theoretical characteristics of acupuncture and moxibustion in the pre-Qin and Han dynasties. The pre-Qin and Han dynasties were a critical period for the evolution and maturity of acupuncture theory, and the accurate understanding of the core concepts in acupuncture theory such as meridians and acupoints affected the construction and development of modern acupuncture theory system.

● Research Purpose

The research objectives mainly include the following two points:

First, to sort out the specific evolution process of the theory of meridians and acupoints in the pre-Qin and Han dynasties, based on the unearthed documents, cultural relics,

The Yellow Emperor's Inner Canon (《黄帝内经》) and *The Yellow Emperor's Ming Tang Classic* (《黄帝明堂经》) .

Second, discuss the related concepts of meridians and acupoints in the pre-Qin and Han dynasties, and supplement the relative blanks of theoretical research, so that the related concepts and theories can be more accurately interpreted and perfected.

● Research Significance

The theoretical significance of this study is to sort out the development context and characteristics of the meridian and acupoint theories in the pre-Qin and Han dynasties, accurately grasp the connotation of the relevant concepts, and also have a certain discussion and supplement to the philosophical views and body views of the Qin and Han physicians.

The practical significance of this study is helpful for a correct understanding of the relevant content of handed down medical books; an objective understanding of the treatment experience of Qin and Han physicians, avoid misunderstanding or over exaggeration of the basic concepts of acupuncture, and provide reference for future literature and experimental research.

● Research Materials

This research is mainly based on the documents and cultural relics that contain meridians and acupoints in the pre-Qin and Han dynasties. It is divided into two categories, “unearthed documents, unearthed cultural relics” and “handed down documents”, the introduction is as follows:

Bamboo slips and silk books containing the contents of meridians and acupoints have been unearthed all over the country, mainly including:

Zubi Shiyimai Jiujing (《足臂十一脉灸经》 *Moxibustion Therapy on the Eleven Meridians of Legs and Arms*) and *Yinyang ShiyiMai Jiujing* (《阴阳十一脉灸经》 *Moxibustion Therapy on the Eleven Meridians of Yin and Yang*) from the Mawangdui

Han Tomb in Changsha, Hunan Province.

Mai Shu (《脉书》 *Pulse Book*) from the Zhangjiashan Han Tomb in Jiangling, Hubei Province.

Shi Er Mai (《十二脉》 *Twelve Meridians*), *Ci Shu* (《刺数》 *Needling Methods*), *Bie Mai* (《别脉》) from the Laoguanshan Han Tomb in Chengdu, Sichuan Province.

Wuwei Medical Slips of the Han Dynasty (《武威汉代医简》) from the Hantanpo Han Tomb in Wuwei, Gansu Province.

Medical Slips Related to the Han Tomb in Hujia Caochang, Jingzhou, Hubei Province.

There are two main artifacts unearthed:

Meridian lacquered wood human figure from the Shuangbaoshan Han Tomb, Mianyang, Sichuan Province.

Lacquer-painted wooden figures on the meridians and acupoints of the Laoguanshan Han Tomb in Chengdu, Sichuan Province.

“handed down documents” mainly include:

Medical books such as: *The Yellow Emperor's Inner Canon* (《黄帝内经》), *The Yellow Emperor's Ming Tang Classic* (《黄帝明堂经》), *Nan Jing* (《难经》 *The Classic on Medical Problem*), etc.

Involving medical literature such as: *Chuang Tzu* (《庄子》), *Shi Ji* (《史记》), etc.

● Research Methods

This study firstly uses the quantitative research method of philology to collect and sort out the relevant data of meridians and acupoints in the documents and cultural relics of the Pre-Qin and Han Dynasties; secondly, with the help of historical analysis method, it studies the social background and cultural background of the Pre-Qin and Han Dynasties and other factors on the evolution of meridians and acupoints. On this basis, sort out the specific evolution process of meridians and acupoints, and use relevant scientific research methods, such as using “scientific comparison method” to compare the similarities and differences between meridians in different texts, so as to understand

their characteristics, use the “theoretical abstract method” to explain the reasons, specific processes and meanings of the evolution of the meridians and acupoints; use the “scientific induction method” to analyze the results of the evolution of the meridians and acupoints to provide a regular understanding. Multidisciplinary research methods comprehensively analyze the evolution process of meridians and acupoints, especially thinking from the standpoint of Qin and Han physicians, which can avoid mixing modern people's thinking concepts in the research process.

● Research Results

The research results are mainly reflected in the following five aspects:

- a) There are many factors affecting the formation and evolution of meridians and acupoints in the pre-Qin and Han dynasties. Mainly include: Understanding of anatomical solid tissue; diagnosis of surface arterial pulsation and superficial veins; experience accumulated in early medical activities using bone needles and stone needles; the witch doctor's understanding of the path of evil spirits invading the body prompted the ancestors to form the concept of “pulse” and “meridian”; The formation of the “Essential Qi Theory”, and the introduction of the concept of “Qi” into the blood vessels and parts of the body, and the formation of subordinate concepts such as “Blood Qi” (血气), “Head Qi” (头气) and “Foot Qi” (足气), promoted the running of Blood Qi in the meridians, the circulation and infusion system of the meridians and the The formation of awareness such as “Qi Street”. Philosophical concepts such as “heaven six, earth five” (天六地五), “twelve months” (十二月), “eight poles” (八极) and “three hundred and sixty-five days” (三百六十五日) affect the evolution of the number of meridians and acupoints.
- b) The naming of meridians from the early days “foot/arm + yin/yang + meridian” *Zubi Shiyimai Jiujing* (《足臂十一脉灸经》 *Moxibustion Therapy on the Eleven Meridians of Legs and Arms*), “yin/yang + meridian”, “body part + meridian”, “arm + giant (Thai)/shaoyin + meridian” *Yinyang ShiyiMai Jiujing* (《阴阳十一脉灸经》

Moxibustion Therapy on the Eleven Meridians of Yin and Yang), the more complex naming method evolved into the unified naming method of “zang/fu + hand/foot + yin/yang + meridian” in *Lingshu • Meridian* (《灵枢 • 经脉》), and its influencing factors are not only related to the change of the starting and ending points of the meridians, but also It is related to the habitual language and writing of pre-Qin and Han physicians. In terms of the number of meridians, it is mainly reflected in “the heart has four branches” (*The History of Yanzi* 《晏子春秋》) (*Huainanzi* 《淮南子》), “humans have four meridians” (*Su Wen* 《素问》 *Plain Question*) “eleven meridians” (*Zubi Shiyimai Jiujing* 《足臂十一脉灸经》 *Moxibustion Therapy on the Eleven Meridians of Legs and Arms*) (*Yinyang ShiyiMai Jiujing* 《阴阳十一脉灸经》 *Moxibustion Therapy on the Eleven Meridians of Yin and Yang*), “ten meridians” (Meridian lacquered wood human figure from the Shuangbaoshan Han Tomb), “twelve meridians” (*Shi Er Mai* 《十二脉》 *Twelve Meridians*) (Lacquer-painted wooden figures on the meridians and acupoints of the Laoguanshan Han Tomb) (*The Yellow Emperor's Inner Canon* 《黄帝内经》) especially the generation of the Hand Jueyin Meridian and the evolution of the path of the Hand Sanyin Meridian and the main symptoms. In terms of the meridian's traveling path, its evolution characteristics are mainly reflected in the extension of the traveling path (extending from the wrist and ankle to the end of the fingers and toes), and the change in the traveling direction (centripetal, telecentric). In terms of meridian diseases, physicians in the pre-Qin and Han dynasties mainly use “movement disease (是动病)” and “caused (produced) disease (所生/产病)” to summarize. There is a clear inheritance relationship between unearthed documents and handed down documents. The main symptoms of acupoints recorded in *The Yellow Emperor's Ming Tang Classic* (《黄帝明堂经》) are mainly derived from the “movement disease” and “caused (produced) disease” of the meridians they belong to.

c) The generation, evolution and finalization of the branches of the meridians were roughly completed in the pre-Qin and Han dynasties. The generation of meridian branches is mainly related to the accumulation of clinical experience. In order to explain

the location of the increasing number of main diseases, physicians in Qin and Han Dynasties established meridian branches to connect them. For example, the three branches of *Zubi Shiyimai Jiujiing* (《足臂十一脉灸经》 *Moxibustion Therapy on the Eleven Meridians of Legs and Arms*) are related to clinical diagnosis and treatment experience. In the process of evolution, the branches of the meridians have gradually been given new connotations, such as the 13 branches of the meridian on the surface of the Laoguanshan lacquer human body and the 5 branches of the human body of Shuangbaoshan wood. Compared with *Zubi Shiyimai Jiujiing* (《足臂十一脉灸经》 *Moxibustion Therapy on the Eleven Meridians of Legs and Arms*), not only the number has increased, In addition to contacting the parts of the disease, it also has the function of contacting the meridians. In *Lingshu • Meridians* (《灵枢 • 经脉》), the number of branches of the meridians has increased to 17, of which 10 branches are specially used to build the connection between the external and internal meridians, and further build the circular flow mode of the twelve meridians, the function of meridian branches has changed from “connecting disease sites” to “theory construction”.

d) In the early evolution process, the twelve tendons gradually became the subsidiary structure of the twelve meridians. The concept of tendons was formed on the basis of the long-term understanding of the anatomical structure and physiological and pathological characteristics of the motor system by physicians in Qin and Han Dynasties, the path of the twelve tendons and the main symptoms are highly similar to the unearthed silk books. The core of its theory is “passing Wei Qi”(通行卫气), and the characteristics of acupoint selection are mainly “consolidating tendons when tendons involved in disorders, tender-point”(在筋守筋, 以痛为输), “interactions of twelve tendons”(维筋相交), “inducing the tendons qi according to the meridians”(依脉引筋气), etc. However, with the formation and popularity of the twelve-meridian circulation system constructed in the chapter *Lingshu • Meridians* (《灵枢 • 经脉》), the twelve tendons gradually evolved into the subsidiary structure of the meridian theory, making the meridian theory more and more inclusive, but practical Features and

pertinence have been weakened.

e) The number of acupoints in the pre-Qin and Han dynasties showed a trend from less to more. There are 116 suspected acupoints on the surface of the Laoguanshan lacquer body. There are 148 named acupoints in *The Yellow Emperor's Inner Canon* (《黄帝内经》), and 349 acupoints in *The Yellow Emperor's Ming Tang Classic* (《黄帝明堂经》), showing “blowout growth”. The main forms of the increase in the number of acupoints are: (1) the name of the bone evolves into the name of the acupoint; (2) the name of the pulse evolves into the name of the acupoint; (3) a body part evolves into multiple acupoints; (4) Adding acupoints near the commonly used points or on the path of the meridians. The increase in the number of acupoints also reflects the evolution of the nomenclature of acupoints. The acupoints in the Laoguanshan Medical Slip *Ci Shu* (《刺数》 *Needling Methods*) are mainly named in the way of "body part + yin and yang". This naming method can still be seen in the *The Yellow Emperor's Inner Canon* (《黄帝内经》). Until *The Yellow Emperor's Ming Tang Classic* (《黄帝明堂经》) was completely abandoned, it became the well-known name of acupuncture points. The return of acupoints to the meridian is formed under the influence of the increase in the number of acupoints and the change in the naming of acupoints. The phenomenon of acupoints returning to the meridian has already appeared in the lacquer wood humanoid figure of Laoguanshan. Judging from the published distribution characteristics of the acupoints in the Sanyin meridian of the hand, the acupoints that return to the meridian are mainly at the pulse of the arteries, reflecting the early characteristics of “merging of acupoints and pulses” (脉穴合一). *The Yellow Emperor's Inner Canon* (《黄帝内经》) and *The Yellow Emperor's Ming Tang Classic* (《黄帝明堂经》) mainly classify the five acupoints below the elbow and knee joints of the four limbs into the corresponding meridians, while the other acupoints are summarized according to their parts by “originating from the pulse and qi” (脉气所发). The formation factors of the acupoint indications include the accumulation of medical practice experience, the reasoning of Traditional Chinese Medicine theory, and the transplantation of meridian diseases.

● Research Conclusion

The main conclusions of this study are as follows:

- a) The transformation of meridian theory in the pre-Qin and Han dynasties was affected by many factors, and non-medical practice factors such as numerical thinking and philosophical awareness cannot be ignored, so it cannot be explained from a single aspect. The transition from “eleven meridians (十一脉)” to “twelve meridians (十二脉)” cannot be regarded as a simple linear development process, the formation of acupoint indications includes practical factors and non-practical factors. In particular, there are many non-practical factors of acupoints indications in *The Yellow Emperor's Ming Tang Classic* (《黄帝明堂经》), and it has been quoted by later acupuncture literatures. Accurate identification of the non-practical factors in acupoint indications is very important for the standardization of acupuncture clinical practice.
- b) the concept of meridians first originated from the ancestors' observation of the shape and function of blood vessels. *Zubi Shiyimai Jiujing* (《足臂十一脉灸经》 *Moxibustion Therapy on the Eleven Meridians of Legs and Arms*) suggests that the development of early meridians was deeply affected by moxibustion activities. In the process of linking disease parts, meridian branches have gradually evolved, and the functional transformation of meridian branches is closely related to the theoretical connotation of meridians. With the “twelve tendons (十二经筋)” attached to the “twelve meridians (十二经脉)”, and under the influence of the theory of zang-fu organs (藏象理论) and the theory of yin and yang and five elements (阴阳五行理论) in the Qin and Han Dynasties, the theoretical guiding role of the meridians has become stronger and stronger.
- c) The generation of the concept of acupoints and their early distribution locations are related to the arterial pulsation points that can be reached by palpation on the body surface, in the process of gradually increasing the number of acupoints, their positioning has become more and more clear, the meridian naming elements in the early acupoint names gradually receded, which inevitably led to the emergence of the phenomenon of

acupoints returning to the meridian specialization. In the Qin and Han Dynasties, the return of acupoints to the meridian is mainly recorded in *The Yellow Emperor's Inner Canon* (《黄帝内经》) and *The Yellow Emperor's Ming Tang Classic* (《黄帝明堂经》), and the two have a relatively consistent understanding, it is mainly a combination of two ways of returning to the meridian: the arrangement of the meridians and the arrangement of the body parts.

d) When examining the meridian theory of the Pre-Qin and Han Dynasties, in addition to the texts and documents such as *Zubi Shiyimai Jiujiing* (《足臂十一脉灸经》 *Moxibustion Therapy on the Eleven Meridians of Legs and Arms*), *Yinyang ShiyiMai Jiujiing* (《阴阳十一脉灸经》 *Moxibustion Therapy on the Eleven Meridians of Yin and Yang*), *Shi Er Mai* (《十二脉》 *Twelve Meridians*), *Bie Mai* (《别脉》), *Lingshu • Meridians* (《灵枢 • 经脉》), etc. we should also synthesize unearthed cultural relics, i.e. The Meridian lacquered wood human figure from the Shuangbaoshan Han Tomb and the Lacquer-painted wooden figures on the meridians and acupoints of the Laoguanshan Han Tomb, in particular, the meridian system of Meridian lacquered wood human figure from the Shuangbaoshan Han Tomb is very special. Only by integrating various documents and cultural relics can we have a comprehensive understanding of the meridian system before the finalization. The stereotype of the meridians is represented by *Lingshu • Meridians* (《灵枢 • 经脉》).

Key Words Unearthed Documents; Meridian; Acupoints; *The Yellow Emperor's Inner Canon* (《黄帝内经》); *The Yellow Emperor's Ming Tang Classic* (《黄帝明堂经》); Pre-Qin and Han Dynasty

引言

早期医家为何提出经脉、腧穴的概念？

经脉、腧穴理论在先秦两汉时期又是如何发展演变的？

对于这些问题，古今理论研究者、科研工作者、临床实践家已经进行了太多的思考与探讨，经脉、腧穴是祖国医学范畴中最具特色的理论之一，在外行人眼中，“任督二脉”“穴位”似乎带有某种虚幻的武侠色彩，在针灸工作者眼中，经脉、腧穴又似乎有其特定的解剖基础，是真实存在着一般，自从1956年经络研究被列为全国自然科学发展规划重点项目之后，几十年间针灸工作者孜孜不倦地追求着经脉、腧穴的实体结构，从上世纪60年代朝鲜学者声称发现了经络实质^[1]，到近年来美国学者的研究引起了对“经络组织间液”的探讨^[2]。学术界借助现代实验技术对经脉的实质进行了多学科、多角度的研究^[3]，但是到目前为止，对于经脉是否存在解剖结构基础的提问，还无法给出一个确定的答案。对于腧穴理论的研究亦是如此，从宏观到微观，甚至研究至细胞、分子水平，仍未寻找到腧穴的特定结构^[4]。其实，当我们站在现代科学的视角，去审视古人的思维，甚至以现代科学思维去评价古人的经验认识成果时，难免会出现两个极端：要么将其全盘否定，要么将其神秘化、超科学化。

我们是否应该站在古人的角度去思考？

王国维先生说：“古来新学问起，大都由于新发见。”^[5]出土文献、文物为经脉研究提供了从文献学角度出发的另一条途径，自上世纪70年代起，马王堆、张家山、双包山出土的简帛医书以及承载着经脉循行的髹漆木人，逐渐为人们揭开了早期经脉、腧穴的发展实貌，山田庆儿先生如此比喻马王堆医书的价值^[6]：

马王堆医书的发现真可以比喻为在漆黑房间的墙壁上突然打开了明亮的小窗户，直接射入的不过是一小束光，但当眼睛习惯后，就能逐渐看清屋内散乱的东西，并可以进行整

^[1] KIM B H. On the Kyungrak System[J]. J Acad Med Sci DRP Korea, 1963, 90: 1-41.

^[2] BENIAS P C, WELLS R G, SACKKEY-ABOAGYE B, et al. Structure and distribution of an unrecognized interstitium in human tissues[J]. Sci Rep, 2018, 8(1): 4947.

^[3] 宋晓晶, 王广军, 李宏彦, 等. 经络研究60年——一条多学科交叉之路[J]. 针刺研究, 2021, 46(06): 527-532.

^[4] 余琛, 徐东升, 崔晶晶, 等. 腧穴结构研究的思考[J]. 针刺研究, 2018, 43(05): 285-289.

^[5] 王国维. 古史新证[M]. 长沙: 湖南人民出版社, 2010: 58.

^[6] [日]山田庆儿. 中医学的历史与理论. 科学: 中国与世界[M]. 北京: 科普出版社, 1992: 109-119.

理。同样，借助于马王堆医书之光，可以一点一点地看清中医学的起源、及其形成过程。

山田先生形象地描述了出土医学文献的价值，借助马王堆医书，我们不仅可以大致了解在《内经》成书之前经脉理论的发展特点，还能直观认识到当时巫医并用的时代特征（这一点在2018年荆州胡家草场出土的“已痢方”中进一步得到证实^[1]）。2012年7月至2013年8月，四川成都老官山汉墓群M3出土了951支竹简以及一具经穴髹漆木人^[2]，为“漆黑的房间”里照射进了更多的光芒，掀起了早期经脉、腧穴理论研究热潮，本课题利用文献学定量研究法、历史分析法、科学研究法等方法，对出土文献、文物以及传世文献中的经脉、腧穴理论演变过程进行挖掘、探讨。在笔者看来，古人用竹简、缣帛承载文字，用人体模型刻画经脉腧穴，无非是想表述当时医家对身体观、疾病观、治疗观的思考认识，其字里行间无不体现出简练古朴的特点，通过出土文献中经脉理论的多样性我们也可以看出，承载着秦汉医学的文献、文物，只是在客观地记录着临床实践经验，并非是用某种严格的尺度去规定这些概念和理论，因此，对于“经脉是什么”“腧穴是什么”这样的问题，本研究无法（也无需）给出一个确切的答案，而通过对先秦两汉时期经脉、腧穴的演变过程及特点的梳理、探讨，以期大致还原在针灸学萌芽及发展阶段，先民是如何创建并运用这一理论，也许使我们能够进一步接近经脉、腧穴理论的本质。

^[1] 周琦,李志芳.荆州胡家草场西汉墓医方木牍“已痢方”初探[J].简帛研究,2020(02):150-161.

^[2] 金陵,曾帆,薄咏,等.四川成都天回汉墓医简整理简报[J].文物,2017(12):48-57.

先秦两汉经脉腧穴演变研究

1 研究背景

1.1 研究现状

通过 CNKI、万方、全国图书馆参考咨询联盟等相关网站,检索涉及先秦两汉时期经脉、腧穴演变研究的期刊、会议、硕博学位论文,以及相关专著,本文正是在这些研究成果基础上所作的进一步探讨,现将这些研究成果简述如下:

1.1.1 经脉、腧穴演变研究的“新材料”

先秦两汉相关学术研究的新起,与出土文献密切相关,简牍文书、殷墟甲骨、敦煌文书、明清大内文档,被誉为 20 世纪中国考古学界的四大发现^[1],百年前傅斯年先生就指出^[2]:新材料、新方法、新工具对于一门新学问有重要作用,傅先生对历史语言研究所制定的工作之一,就是“寻求新材料”(即新出土的简牍、帛书、甲骨文等),出土文献启发学者对早期史学进行多元性的思考^[3],经脉、腧穴理论早期演变过程是中医学发展史的一个重要分支,出土记载有经脉、腧穴的文献、文物大多属随葬品,与医学文献具有一定的实用性相关,此外,像日书、兵书等都是具有实用性的书籍,随葬的目的主要是为了“以备死者急用之需”^[4]。

在论及先秦两汉时期的书籍载体时,学者常引《墨子》中“书于竹帛,镂之金石”^[5]一语,有研究表明,远在商朝后期已经出现了竹简,并在纸发明之前逐渐成为书写的主要载体,且较其他材料更为长久,甚至在纸发明以后数百年间,竹木仍作为书写材料继续流通^[6]。帛可能晚一些,用帛来写字大约始于春秋时期,到南北朝,就明令不用竹木简,所有的文书或书籍都用纸书写^[7]。“书于竹帛”的文献,目前所能看到的都没有早于战国时期^[8],战国之后,贵族大夫没落,随之文化知识和图书典籍也流入民间,官学变为私学,学术文化的下移,又是诸学兴起的

[1] 李均明,刘国忠,刘光胜,等.当代中国简帛学研究 1949-2019[M].北京:中国社会科学出版社,2020:3.

[2] 桑兵.近代学术转承:从国学到东方学——傅斯年《历史语言研究所工作之旨趣》解析[J].历史研究,2001(03):29-44+189.

[3] 杨博.出土战国秦汉简牍典籍的史料特点[J].简帛研究,2020(01):336-344.

[4] [英]鲁惟一著;张书生译.秦汉简帛与秦汉史研究[J].简帛研究,1993:34.

[5] [战国]墨翟撰;蒋重母,邓海霞译注.墨子译注[M].长沙:岳麓书社,2014:130.

[6] 钱存训.印刷发明前的中国书和文字记录[M].北京:印刷工业出版社,1988:55.

[7] 李学勤.文物中的古文明[M].北京:商务印书馆,2008:7.

[8] 冯胜君.出土材料所见先秦古书的载体以及构成和传布方式[J].出土文献与古文字研究,2011:195.

源头^[1]，学术流通的过程需要文献载体，相较于缣帛，竹、木的价格低廉，制作方便，故在纸发明以前的书籍流通中占据了主导地位。简帛是中国早期主要的藏书对象，虽然流传至今的先秦文献较少，但根据近年来所发现的资料，如上海博物馆1994年从香港购买的楚简中，含有将近百余种先秦文献，而传世文献可对照者不到10种，由此可见先秦文献的丰富性^[2]，同时古书之间的包含关系也不可忽视，由于“公共素材”（故事、说理和短语^[3]）的存在，战国秦汉时代的许多古文献，其书虽亡，其文可能未尽亡，如“古史书”“诸子说理书”“数术、方技”等^[4]。

记载在文献上的学术演化历程，一般称为“学术史”，而简帛文献的丰富性为“重写学术史”提供了丰富的资源^[5]。出土文献大量出现之前，对中国早期医学史的研究，主要依赖于传世文献的记载，如陈邦贤先生《中国医学史》第一篇“上古的医学”所引征文献，除《内经》《难经》《神农本草经》之外，就是一些其他零散论及医学的非医文献^[6]，上世纪简帛医学文献呈“井喷式”出土后，改写了早期中医学发展史，出土医药文献提示在秦汉时期，医学就出现了专门的分科^[7]，中医学基础理论体系在此时也大致确立^[8]，我们对早期经脉、腧穴理论的演变研究虽称不上是“重写”针灸学术史，但对其进行梳理与分析，也是基于马王堆、老官山等汉墓中简帛医学文献的丰富性^[9]。

1.1.2 经脉、腧穴演变研究的“新方法”

将出土文献与传世文献进行对比研究，是经脉、腧穴理论演变研究中的重要方法，百年前，顾颉刚先生提出中国古史是“层累地造成的”，1926年出版的《古史辨》在学术界掀起了疑古的浪潮^[10]，以顾先生为代表的古史辨派终结了经学时代。王国维先生针对疑古派过度怀疑古史的问题提出“二重证据法”，在出土文献研究方法中影响较广，陈寅恪先生加入“国外古籍与国内古籍相互补证”构成“三

[1] 李瑞良. 中国古代图书流通史[M]. 上海: 上海人民出版社, 2000: 25.

[2] 张显成. 论简帛的文献学研究价值[J]. 古籍整理研究学刊, 2005(01): 34-40.

[3] 徐建委. 战国秦汉间的“公共素材”与周秦汉文学史叙事[J]. 中山大学学报(社会科学版), 2012, 52(06): 1-9.

[4] 徐建委. 文本革命——刘向、《汉书·艺文志》与早期文本研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2017: 34-37.

[5] 傅荣贤. 出土简帛与中国早期藏书研究[M]. 北京: 知识产权出版社, 2013: 2.

[6] 陈邦贤. 中国医学史[M]. 郑州: 河南人民出版社, 2017: 3.

[7] 张显成. 论简帛的中医药学史研究价值[J]. 简牍学研究, 2004(00): 251-263.

[8] 赵容俊. 秦汉中国医学基础理论确立的考察[J]. 医疗社会史研究, 2016, 1(02): 75-110+329.

[9] 柳长华. 天回医简整理研究引领中医学术前沿[J]. 天府新论, 2021(03): 2+161.

[10] 桑兵. 从眼光向下回到历史现场——社会学人类学对近代中国史学的影响[J]. 中国社会科学, 2005(01): 191-204+209.

重证据法”，此外还有“四重”“五重”的提出^[1]。50年代以后，由于考古事业的发达，陆续发现大批战国秦汉时期的出土文献，这些出土文献帮助学界“走出疑古时代”，开始了古典学的第二次重建^[2]。李学勤和裘锡圭先生援引陈寅恪先生的认识，认为复原出土文献的过程，就像是出土了许多古画残片，想要将其复原，则需要参考古画摹本^[3]，这里所讲的“摹本”，就是传世文献。针灸文献也是如此，尽管出现了马王堆、老官山这样拥有大量简帛医书的汉墓，但是无论在完整性还是丰富性上，都无法与传世文献（《内经》《明堂经》等）相比，因此在研究出土文献的过程中，传世典籍以及历代学者对传世典籍的注释及研究仍是基础。

裘锡圭先生指出，先秦两汉时代的历史与我们现代的历史之间存在着不间断的关系，尽管两者之间已经很不一样了，但也由于这种“传承关系”，便无需将先秦时代各个方面的研究从相关学科分割出来，纳入古典学的范畴^[4]，笔者认为先秦两汉时期的经脉、腧穴内容，无论是从框架体系还是具体内容上，均较为古朴，但传承至现代，其实用性、指导性并未有褪色，因此，像如“古典中医学”“古典针灸学”的提法，近年来比较流行，实际上大可不必将先秦两汉时期的方药、针灸从中医学体系中划分出来，归入古典学的范畴，否则可能会出现古代中医学体系与现代中医学体系这样的割裂现象，不利于传统医学的继承与发展。

1.1.3 简帛针灸文献文本特点

先秦古书是由“章”构成的，大约在汉代，学者便将“章”组合成为我们现在所看到的文本，可称之为“篇”“书”。其中，“章”是基本构成单位，“篇”“书”则是基本流通单位^[5]，正如夏含夷先生所讲：“许多早期文献由‘章’这一基本单元构成……某些‘章’在编纂成书之前曾经独立流传……它们通常被称作‘篇’。”中国古代最初的“书籍”，就是由这些“篇”在各种编联方式下形成的^[6]，先秦古书一般没有书名，但一些偏于实用性的技术书，如日书、算术书、医书和法令之类，却有书名^[7]，比如张家山汉墓出土的《引书》，就是原简自命名，书名写在了

[1] [日]西山尚志. 古书新辨——先秦出土文献与传世文献相对照研究[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2015: 1.

[2] 周书灿. 论“走出疑古”与古史重建[J]. 贵州大学学报(社会科学版), 2007(06): 51-57.

[3] 裘锡圭, 曹峰. “古史辨”派、“二重证据法”及其相关问题——裘锡圭先生访谈录[J]. 文史哲, 2007(04): 5-16.

[4] 裘锡圭. 出土文献与古典学重建[J]. 出土文献, 2013(00): 1-18.

[5] 谢科峰. 早期古书流传问题研究——以相关出土文献与传世文献的比较为例[D]. 上海大学, 2015.

[6] [美]夏含夷著, 周博群译. 重写中国古代文献[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2012: 46-47.

[7] 来国龙. 论战国秦汉写本文化中文本的流动与固定[J]. 简帛, 2007: 515-527.

第一支简的背面^[1]。

出土文献的内容，大致可以分为文书与书籍两类，此种分类方法也见于世界其他文明的早期写本中，如古埃及草纸、欧洲古代写本等^[2]，李学勤先生对书籍和文书进行了区分，认为书籍主要指《汉书·艺文志》的分类，而文书则是官方或私家的文件、档案等^[3]，战国秦汉时期的书籍在流通过程中，通过不断地校阅整理，从而产生较为固定的文本，“典籍”是秦汉早期医学传承体系的中心^[4]。对历代书籍的流通特点，李零先生比喻为：战国秦汉时期的古书像是气体，隋唐古书像是液体，而宋以后的古书则是固体^[5]，这对我们理解中医古籍的发展特点颇有启发。

战国秦汉古书流传方式有“抄写文本”“口耳相传”两种方式，均可造成流传过程中的文本变化，有学者通过对比出土文献各版本《诗经》中的异文现象，认为中国早期文本的流传主要依靠口传记忆，或是一人念一人抄^[6]。先秦两汉医籍绝大部分都是口语性极强的文献，“古朴与口语性并重”是其特点^[7]，陈梦家先生指出，汉代学者所传诵的经典，多属于传抄本，“抄书”这一行业在当时已经较为常见，并且出现了职业抄书人^[8]，傅荣贤先生认为，抄写本与原本之间是有一定差异的，这种差异使得传抄本也有了“创作”的特点在内^[9]，目前所见的出土文献中，相同墓葬中可以出现某一文献的不同抄本，即“复本”，这些“复本”之间并不相同，在个别文字甚至内容文意方面多有差异，简帛经脉文献也保留了这一特征，我们从《阴阳》三个版本的异同情况就可以看出来。此外，周琦先生对老官山医简的刮削校改痕迹研究后，认为其主要是通过“抄写文本”的方式而成^[10]，出土文献中的传抄内容，与墓主人的学术取向和兴趣爱好相关，杨伯峻先生指出，随葬品一般是墓主人生前喜爱或习用之物，即古人“书殉笔葬”的风气，可以反映墓主人的思想倾向^[11]。《荀子·礼论》：“事死如事生，事亡如事存。”^[12]汉代文化

[1] 彭浩. 张家山汉简《引书》初探[J]. 文物, 1990(10): 87-91+106.

[2] [法] 风仪诚: 古代简牍形式的演变——从丧葬物疏说起[J]. 简帛, 2009: 357.

[3] 李学勤. 简帛书籍的发现及其影响[J]. 文物, 1999(10): 7.

[4] 王玉德, 吕金伟. 晚周秦汉初医学知识传承研究[J]. 医学与哲学(A), 2014, 35(10): 80-82.

[5] 李瑞良. 中国古代图书流通史[M]. 上海: 上海人民出版社, 2000: 80-81.

[6] [美] 夏含夷, 孙夏夏. 出土文献与《诗经》口头和书写性质问题的争议[J]. 文史哲, 2020(02): 21-38+165.

[7] 张显成. 先秦两汉医学用语汇释[M]. 成都: 巴蜀书社, 2002: 15.

[8] 陈梦家. 汉简缀述[M]. 北京: 中华书局, 1980: 299.

[9] 傅荣贤. 出土简帛与中国早期藏书研究[M]. 北京: 知识产权出版社, 2013: 296.

[10] 周琦. 天回医简中的刮削校改痕迹研究[J]. 简帛研究, 2018(01): 185-201.

[11] 杨伯峻. 孙臆和《孙臆兵法》杂考[J]. 文物, 1975(3): 6.

[12] [战国] 荀况. 荀子[M]. 长沙: 岳麓书社, 2019: 235.

认识中的死后世界和生人世界一样高度官僚化^[1]。如武威汉代医简记载有方剂 30 多个，张显成教授称“估计是墓主人长期临床实践经验的总结性记录”^[2]。由于文化的传承性，我们对先秦两汉时期古人医学思想的研究，最主要的目的就在于挖掘出可以“为今所用”的价值，也就是李学勤先生所讲的“决今”^[3]。

1.1.4 出土经脉、腧穴文献整理情况

1972 年甘肃武威旱滩坡汉墓出土的医简，整理人员编为《武威汉代医简》，由文物出版社于 1975 年出版，张廷昌先生撰有《武威汉代医简研究》（1996）《武威汉代医简注释》（2006）；马王堆汉墓整理小组将 5 张帛书上记载的古医书编为《马王堆汉墓帛书·肆》由文物出版社于 1982 年出版；马继兴先生《马王堆古医书考释》（1992）《中国出土古医书考释与研究》（2015）；魏启鹏、胡翔骅《马王堆汉墓医书校释》；周一谋、萧佐桃《马王堆医书考注》（1988）；裘锡圭先生主编《长沙马王堆汉墓简帛集成》（2014）。

1983 年张家山汉墓出土了《脉书》，其中《阴阳》（丙本）可与马王堆帛书相互弥补，整理小组出版《张家山汉墓竹简（二四七号墓）》（2001），并于 2006 进行了释文修订；高大伦先生《张家山汉简〈脉书〉校释》（1992）《张家山汉简〈引书〉研究》（1995）。绵阳双包山汉墓出土的经脉漆木人形，马继兴先生对其进行了专门的研究^[4]，并且在其《中国出土古医书考释与研究》中进一步进行了论述。2006 年整理小组出版了《绵阳双包山汉墓》。

2012 年成都老官山汉墓出土了大量医简，目前整理人员已经通过论文与专著陆续公布了部分简文内容，出土的经穴髹漆木人，学界的研究重点在其体表刻画在白线系统，目前老官山医简《十二脉》《别脉》《刺数》部分内容以及老官山漆人手三阴脉、足三阳脉的疑似腧穴点已经公布。老官山文献整理工作由成都中医药大学牵头，并且于 2019 年初专门创立了中国出土医学文献与文物研究院，整理小组将老官山汉墓研究成果编著为《天回医简》^[5]，预计 2022 年底出版。

^[1] 郭珏. 秦汉出土文献中的“知死”与“事死”——一个基于“形成框架”的试分析及方法论上的思考[J]. 简帛, 2013(00): 49-67+579.

^[2] 张显成. 简帛文献学通论[M]. 北京: 中华书局, 2004: 81.

^[3] 李学勤. 清华简及古代文明[M]. 南昌: 江西教育出版社, 2017: 10.

^[4] 马继兴. 双包山汉墓出土的针灸经脉漆木人形[J]. 文物, 1996(04): 55-65+98.

^[5] 柳长华. 天回医简整理研究引领中医学术前沿[J]. 天府新论, 2021(03): 2+161.

1.2 研究选题

1.2.1 选题依据

出土医学文献在先秦两汉医学发展研究中占有重要地位,上世纪70年代以来,全国各地陆续出土了大量的简牍、帛书以及载有疑似经脉线、腧穴点的髹漆木人,出土医学文献中经脉理论内容非常丰富,如马王堆帛书《足臂》《阴阳》,以及老官山医简《十二脉》《别脉》等,均是论述经脉理论的专篇,老官山漆人与针方简《刺数》中又含有丰富的腧穴内容,填补了早期腧穴理论演变的空白,出土文献与传世文献之间有明显的承载关系,《内经》在继承先秦两汉针灸理论体系的基础上,又进行了一定程度的改造,使经脉理论基本定型,而腧穴理论则在汉末《明堂经》中形成体系。

先秦两汉时期经脉、腧穴理论的发展演变过程较为复杂,老官山汉简与经穴漆人的出土,为梳理经脉、腧穴的早期发展提供了更为丰富的原始资料,对于我们研究早期针灸理论的发展及特点有重要意义,然而目前相关研究较为零散,且论经脉者多,论腧穴者较少,综合出土文献与传世文献的系统性研究则更少。本研究综合文献、文物资料,梳理了先秦两汉时期经脉、腧穴理论的演变过程,描绘早期经脉、腧穴理论的发展概貌,通过相关理论研究现状的综述,认为对出土医学文献中经脉、腧穴相关内容特点进行深入研究,尤其是与传世文献进行对比分析很有必要,但目前针灸实验、临床主要依据的是院校教材,对先秦两汉时期的针灸理论特点关注度远远不够,而先秦两汉又是针灸理论演变、成熟的关键时期,对经脉、腧穴等针灸理论中核心概念的准确认识,影响着现代针灸学理论体系的建设与发展,故本研究从医史文献角度出发,探讨先秦两汉这一中医学萌芽及发展时期经脉、腧穴理论的演变问题。

1.2.2 研究目的

本研究拟解决的问题主要包括以下两点:

第一:梳理先秦两汉时期从出土文献、文物到《内经》《明堂经》中经脉、腧穴理论的具体演变过程,总结早期经脉、腧穴理论演变的具体内容及特点。

第二:对早期经脉、腧穴相关概念进行探讨,并对理论研究相对空白处进行补充,如经脉分支和经筋理论等,使相关概念和理论得到较为准确的诠释及完善。

1.2.3 研究意义

本研究的理论意义在于，依据最新出土的地下材料，结合传世文献，梳理经脉、腧穴理论早期发展的脉络及特点，尤其是还原经脉、腧穴在产生及早期发展阶段的实质，准确把握相关概念的内涵及界限，对秦汉医家哲学观、身体观、疾病观也有一定程度的探讨补充，可为当前学术界对经脉、腧穴的理论研究提供参考，以补充目前从单一角度讨论经脉或腧穴理论演变的不足与缺失，使早期经脉、腧穴理论的特点得到广泛的关注。

本研究的实践意义在于，对早期经脉、腧穴理论演变的梳理，首先有助于传世医籍相关内容的正确理解，如字词、医理等；其次客观认识秦汉医家的治疗经验，可以避免科研、临床过程中对针灸基本概念（如经脉循行路径、腧穴主治病症）产生认识误差或过度夸大；在一定程度上对未来针灸文献研究提供参考。

1.2.4 创新点

本研究的创新点主要有：

第一：综合目前所见的出土文献、文物以及传世文献资料，全面梳理先秦两汉时期经脉、腧穴的发展演变过程及特点，尤其是对于部分理论研究空白处，如经筋理论早期发展特点以及经脉分支的演变过程等，进行了补充完善。

第二：综合运用多种学科研究方法及成果，如利用考古学、古文字学、古史学（医学史）等多学科交叉研究，从宏观与微观角度，全面把握先秦两汉时期的医学文化背景以及从字词考释角度准确理解出土文献中的思想内涵。

1.2.5 研究内容

主要包括：搜集先秦两汉时期出土文献、文物及传世文献中的经脉、腧穴的相关内容，首先从古文字学角度对其进行分析，将现行文本释读过程中的谬误、遗漏进行修改、补充，尽可能接近简帛医书成书时期原貌，以期最大程度还原文本的最初含义，把握原始文献理论内涵，并在此基础之上分析经脉、腧穴理论的演变过程及特点。

第一：先秦两汉经脉理论演变情况

以《足臂》《阴阳》《十二脉》《内经》以及双包山木人、老官山漆人为主要研究对象，分别以十二经脉、奇经八脉、经筋、经别、络脉为单位进行梳理分析，

详细考证各概念的演变特点，其次对经脉理论的整体发展演变特点进行讨论，对于十二经筋、经脉分支等理论的演变进行重点论述。

第二：先秦两汉腧穴理论演变情况

从老官山漆人体表所标记的疑似腧穴点切入，首先分析漆人足三阳脉与手三阴脉体表疑似腧穴点在先秦两汉时期的演变情况，对于出土文献、文物中未记载的其余腧穴，利用《内经》《明堂经》进行对比分析，对每个腧穴主要从定位与主治病症两方面进行探讨；其次对腧穴的整体演变特点进行讨论，重点在于腧穴命名、归经的演变，以期从宏观与微观两个角度全面把握腧穴的演变情况。

1.2.6 研究方法

本研究主要采用了文献学定量研究法、历史分析法、科学研究法：

文献学定量研究法，主要是对先秦两汉时期文献、文物中的经脉、腧穴相关内容进行搜集、分析，包括简牍帛书等出土文献的原始图版和整理小组释文，老官山漆人、双包山木人的清晰照片、绘制图，以及学术界围绕其展开的讨论，包括专著、期刊论文、会议论文、学位论文等，全面掌握研究材料。

历史分析法，本研究对先秦两汉社会背景、文化背景等因素进行简要分析，尤其是与医学相关的社会风气、文化意识形态等，将经脉、腧穴理论的演变过程置身于其原始成长环境中进行梳理、分析。

科学研究方法主要运用到了科学比较法、理论抽象法、科学归纳法。科学比较法主要用于对比不同文本之间的相同点与差异点，从而认识其特点，总结其发展规律。理论抽象法用于在分别对经脉、腧穴理论进行比较研究之后，对其演变的原因、整体特征及其意义进行分析。科学归纳法主要用于对经脉、腧穴演变的结果进行分析，发掘规律性的认识。利用多学科交叉研究的方法综合分析经脉、腧穴理论的演变过程，尤其是站在秦汉医家的立场下进行思考，能避免在研究过程中掺杂入现代人的思维观念。

2 先秦两汉经脉理论演变分述

2.1 十二经脉理论演变梳理

2.1.1 手太阴脉

2.1.1.1 出土文献、文物手太阴脉考订

马王堆《足臂十一脉灸经》

臂泰(太)陰溫(脈): 循筋^[1](筋)上兼(廉), 以奏臑內, 出夜(腋)內兼(廉), 之心。其病: 心痛, 心煩而意(噫)。諸病此物者, 皆久(灸)臂泰(太)陰溫(脈)。

马王堆《阴阳十一脉灸经》(甲本)

臂鉅陰脈(脈): 在於手掌中, 出內陰兩骨之間(間), 上骨下廉, 筋(筋)之上, 出臂【內陰, 入心中】。是動(動)則病: 心滂_二(滂滂)如痛(痛), 缺盆痛(痛), 甚【則】交兩手而戰, 此為臂廢(廢一厥), 【是臂鉅陰脈主】治。其所產病: 胸(胸)痛(痛), 臂(肩)痛(痛), 【心痛】, 四末痛, 段(瘕), 為五病。

马王堆《阴阳十一脉灸经》(乙本)

臂巨(鉅)陰肱(脈): 在于手常(掌)中, 出內陰兩骨【之間(間), 上骨】下廉, 筋(筋)之上, 出臂內陰, 入心中。是動(動)則病: 心滂_二(滂滂)【如】肅(痛), 缺汾(盆)肅(痛), 甚則交兩手而單(戰), 此為臂厥, 是臂巨(鉅)陰之肱(脈)主治。其所產病: 胸肅(痛), 癰(肩)肅(痛), 心肅(痛), 四指(肢)肅(痛), 假(瘕), 為五病。

张家山《脉书》载《阴阳十一脉灸经》(丙本)

•臂鉅陰之脈, 在於手掌中, 出臂內陰兩骨之間, 上骨□□□□□□□□【陰, 入心中】。是動(動)則病: 心彭_二(彭彭)如痛, 缺□□□□□□□□□□□□□□□□□□【陰之脈主】治。其所產病: 胸痛, 臂痛, 心痛, 四末痛, 段, 為五病。

^[1] 原整理小组释作“筋”, 裘锡圭先生厘定为“筋”, 查阅原图版后, 该字右下角写作“刀”, 故释作“筋”。

老官山《十二脉》

辟（臂）大陰脈，𢇛（繫）手掌中，循辟（臂）內陰兩骨之間，上骨下廉，【筋之上】，□（出）辟（臂）內陰，至亦（腋），入心^[1]。

老官山《经脉》残简

□臂内□阴两骨之間（间），□□□□□□□^[2]。

老官山漆人手太阴脉

目前所见的公开文献中，对本脉循行路径一共有三处不同的论述，笔者据相关论文发表时间分别简称为“2016年”“2018年”“2022年”：

2016年：仅有一条主干（图2中红色线），起点在“大指端”，沿着鱼际、寸口，走行于上肢屈面桡侧缘，经过肘横纹后，在上臂屈面中部向内移行（与手厥阴脉相交）后，走行于手厥阴脉与手少阴脉之间，止点在“腋下”^[3]。

2018年：有一条主干与一条分支，其中主干与2016年论文相同，支脉仅见于右侧（图2中蓝色线），整理人员提到“[右侧支脉]次指内廉端”^[4]。

对比绘制图可见，2018年论文中右侧手太阴脉分支是从鱼际发出，到达次指内廉。值得一提的是，2016年和2018年的论文中，提到左右侧手太阴脉起始处均位于“大指端”，但2022年论文中（图2所示）^[5]，可以见到左侧手太阴脉起始部位在寸口，而右侧手太阴脉起始部位在手大指端，但整理人员在列表对比时，称手太阴脉的“Starting point”（起始点）在“Tip of the thumb”（手拇指端），且并未提及左右侧有差异，故推测应该是绘图失误（笔者在图2中用红圈标示）。

^[1] 黄龙祥. 老官山出土汉简脉书简解读[J]. 中国针灸, 2018, 38(01): 97-108.

^[2] 顾漫, 周琦, 柳长华, 等. 天回医简《经脉》残篇与《灵枢·经脉》的渊源[J]. 中国针灸, 2019, 39(10): 1117-1123.

^[3] 邱科. 老官山汉墓经穴髹漆人像六阴经循行特点研究[D]. 成都中医药大学, 2016.

^[4] 邱科, 曾芳, 孙睿睿, 等. 成都老官山汉墓经穴髹漆人像手三阴经循行考证[J]. 中华中医药杂志, 2018, 33(04): 1480-1482.

^[5] 程施瑞, 周兴兰, 邱科, 等. 成都老官山汉墓经穴髹漆人像十二经脉循行考证（英文）[J]. World Journal of Acupuncture-Moxibustion, 2022, 32(01): 40-48.

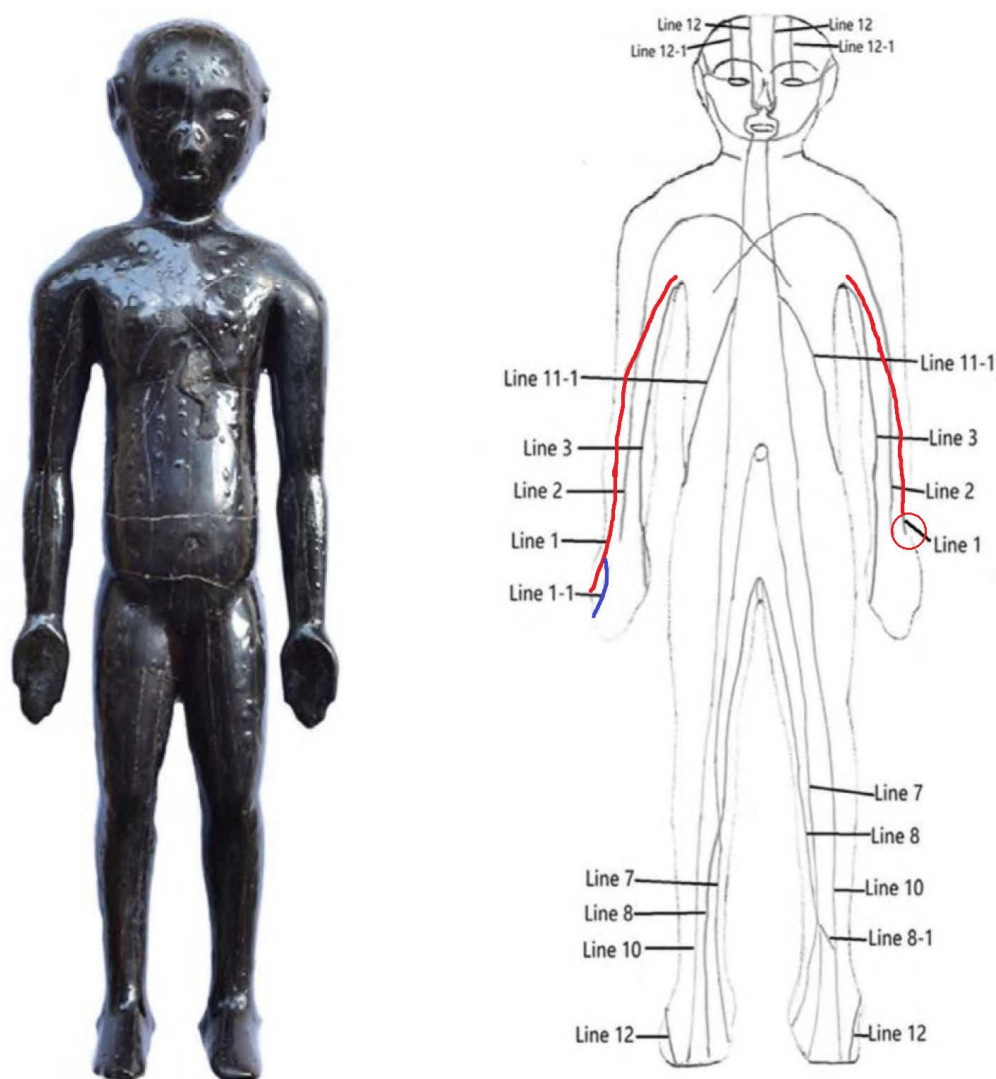


图 2 老官山漆人手太阴脉循行路径

双包山木人手太阴脉

包括一条主干和两条分支，主干（图 3 中红色线）起自口角，起点正好位于足阳明脉循行路线上，而后向后下方走行，在耳垂正下方与手厥阴脉交叉，经过颈、肩，沿着上肢屈面外侧缘走行，到腕关节处发出了两条分支，其中分支一进入拇指内端（图 3 中蓝色线），而分支二沿着手背走行，并入手阳明脉（图 3 中黄色线），主干则继续沿着鱼际、拇指桡侧廉，到达拇指端^[1]。

^[1] 马继兴. 双包山汉墓出土的针灸经脉漆木人形[J]. 文物, 1996(04): 55-65+98.

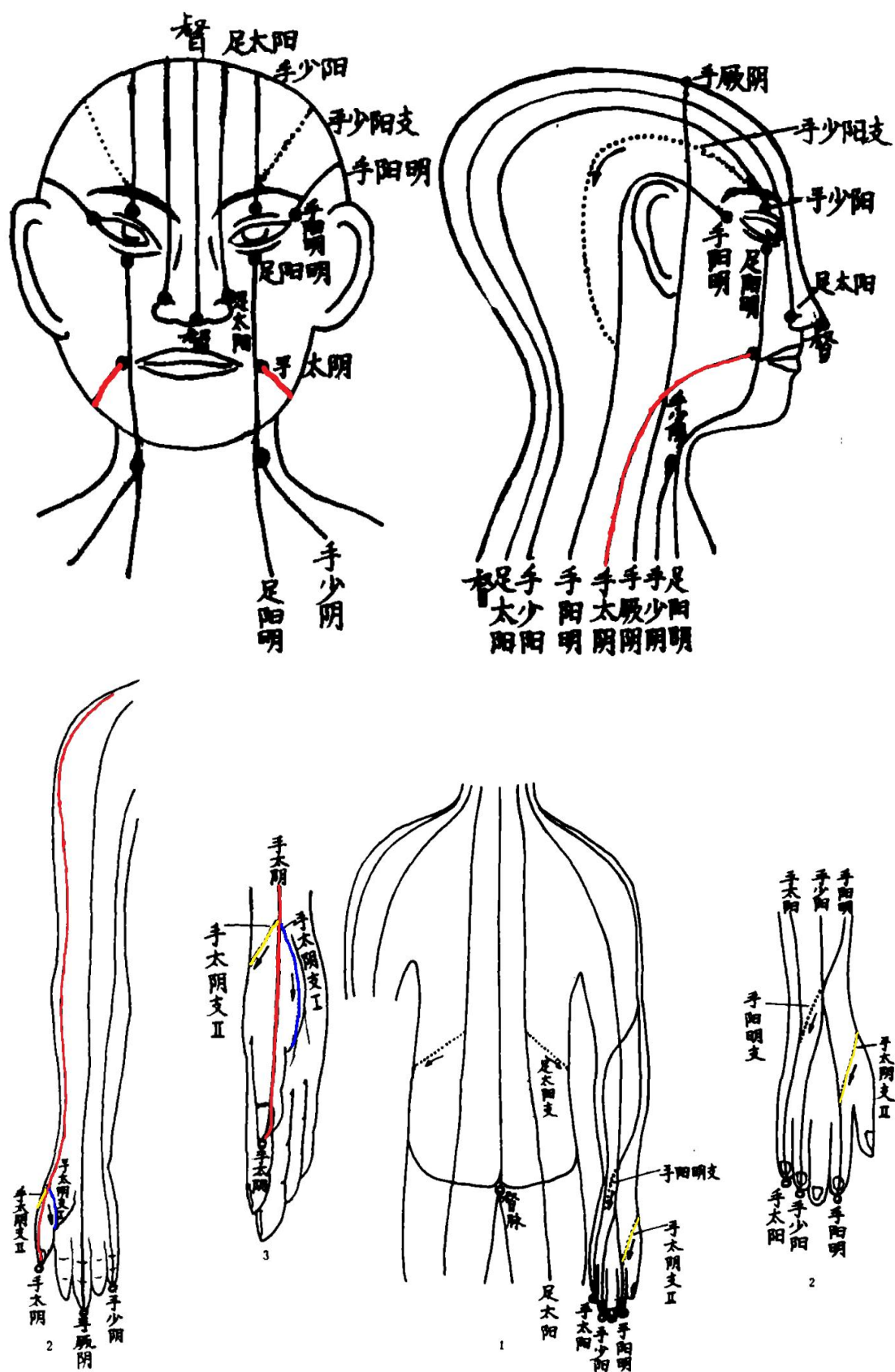


图 3 双包山木人手太阴脉循行路径

2.1.1.2 讨论

表 1 先秦两汉手太阴脉演变特点对比

	《足臂》	《阴阳》 (甲本)	《阴阳》 (乙本)	《阴阳》 (丙本)	《十二脉》	老官山 漆人	双包山 木人	《灵枢·经 脉》
命名	臂泰陰溫	臂鉅陰脈	臂巨陰脈	臂鉅陰之 脈	辟大陰脈	/	/	肺手太阴 之脉
起点	臂	手掌中	手掌中	手掌中	手掌中	大指端	口角	中焦
止点	心	心中	心中	心中	心	腋下	拇指外端	大指端
流注方向	向心性	向心性	向心性	向心性	向心性	向心性	远心性	远心性
支脉	无	无	无	无	无	1 条	2 条	1 条
脏腑	心	心	心	心	心	/	/	肺、胃、大 肠
官窍	无	无	无	无	无	无	口角	无

出土文献《足臂》《阴阳》《十二脉》中手太阴脉无论是循行路径还是主治病症，其最大的特点是均与心有联系，先民对“心”的认识起源较早，《史记·殷本记》中记述商纣王“剖比干，观其心”，并称“吾闻圣人心有七窍”^[1]，这里的“七窍”应指出入心脏大血管的开口，而《晏子春秋》：“寡人之有五子，犹心之有四支。”^[2]此处“四支”最初也是指出入心脏的血管^[3]，《管子·内业》中记载：“凡心之刑，自充自盈。”^[4]其中“刑”通“形”，是指外形、形状之意，“自充自盈”是对心脏正常搏动状态的描述，这些均是先民对心脏解剖及生理活动的初步认识，说明秦汉医籍中所提到的“心”，就是解剖实体所见的心脏^[5]，心脏于胸腔内跳动不歇，在先民对自身进行观察的过程中，很容易受到重视，心脏为脏腑之“大主”，杜正胜先生认为，先秦时期对人体内部器官的认识中，基本上是以心为主，而其他器官的认识则较为模糊^[6]。

心脏的跳动，与体表可触及的动脉搏动频率一致，因此“心”与“脉”之间建立关系是顺理成章的，《内经》中随处可见“心”与“脉”合并而论，如“心者……其充在血脉”“心主身之血脉”等。出土文献、文物中手太阴脉在上肢均大致循行于屈面桡侧缘（尤其是前臂），寸口处桡动脉的搏动在体表又易触及，因此早期经

[1] [汉]司马迁. 史记[M]. 北京: 中华书局, 1959: 108.

[2] [春秋]晏婴著; 李新城, 陈婷珠译注. 晏子春秋译注[M]. 上海: 上海三联书店, 2018: 54.

[3] 严健民. 经脉学说起源·演绎三千五百年探讨[M]. 北京: 中国古籍出版社, 2010: 28-29.

[4] [春秋]管仲. 管子[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2015: 326.

[5] 赵坤, 李成卫, 王庆国. 基于《黄帝内经》形气观分析心与血脉的关系[J]. 中医杂志, 2018, 59(05): 361-364.

[6] 杜正胜. 从眉寿到长生: 医疗文化与中国古代生命观[M]. 台北: 三民书局股份有限公司, 2006: 88.

脉文献便将手太阴脉与心脏建立联系，而《灵枢·经脉》为建立特殊的经脉-脏腑相关理论以及经脉环形流注体系，将手太阴脉与肺相关联，体现在其循行路径与主治病症上，如将《足臂》《阴阳》《十二脉》的“之心”“入心中”，改为“起于中焦，下络大肠，还循胃口，上膈属肺，从肺系横出腋下”，尤其是将《阴阳》手太阴脉主病“心滂滂如痛”径改为“肺胀满膨膨而喘咳”，和心脏相关的经脉循行及主治病症则与手厥阴脉、手少阴脉建立关系。

先秦两汉时期手太阴脉的命名转变较晚，出土文献均与“臂”相关，《说文解字》：“臂，手上也。”是指从肩到腕之间的部分，包括现代解剖学术语中的“上臂”与“前臂”，直至《灵枢·经脉》中才改为“手”，但《阴阳》《十二脉》起点均为“手掌中”，尤其是两具出土文物，循行已经到达拇指端，因此可见，尽管经脉循行已经到达手掌中或手指端，但经脉名称仍然是“臂XX脉”，笔者推测可能与早期医家的习惯性用语有关，在这种语境下，“臂”实际上可能已经有指代整个上肢（包括“手”在内）的含义，是属于词义的泛化。

经脉循行方面，出土文献与传世文献中手太阴脉均大致位于上肢屈面桡侧缘，这是判定出土文物中手太阴脉循行线的重要参考标准，诸文献、文物手太阴脉循行最大的区别在于起止端的位置差异，《足臂》起点提到“循筋（筋）上兼（廉）”，而没有“起于”或者“系”这样比较准确的定位描述，“循”是描述经脉循行经过的术语，因此《足臂》的起点并不明确，可暂定为“臂”，笔者认为应该大致位于寸口桡动脉搏动处。《阴阳》《十二脉》起点已经出现了“手”这一关键字，《说文解字》：“手，拳也。”段玉裁注解为：“舒之为手，卷之为拳，其实一也。”说明“手”是指上肢远端手腕以下的部分，《阴阳》《十二脉》手太阴脉的起点均位于“手掌中”，即“手心”^[1]，老官山漆人与双包山木人手太阴脉循行均到达了手拇指端，根据“先秦两汉腧穴理论演变分述”一章中对早期井穴位置的分析，笔者推测应该位于大拇指尖端（并不是甲根旁），老官山漆人手太阴脉循行方向是向心性，因此“拇指端”属于起点，《足臂》《阴阳》《十二脉》止点均在于心，老官山漆人止点在于腋下，但需注意，由于漆人经脉循行路线只能刻画在体表，是否进入体内与心相连则无从考察。双包山木人手太阴脉循行方向是远心性，故起点在口角，

^[1] 孙迪,朱鹏举,陈磊,等.《黄帝内经》“手”相关术语研究[J].长春中医药大学学报,2021,37(03):497-500.

手三阴脉循行上头面，是双包山木人独有的特点，因此秦汉时期手太阴脉只有双包山木人与官窍（口角）有联系，其止点在于拇指端，《灵枢·经脉》手太阴脉的循行方向也是远心性，因此起点在于中焦，止点在于手大指端。从“臂→手掌中→大指端”这一循行端点演变过程可以看出，手太阴脉上肢远端的循行路径在先秦两汉时期呈现出从“臂腕”不断向手指端延伸的特点，这为后来手太阴脉与手阳明脉在手指端相交接做铺垫。

老官山漆人与双包山木人手太阴脉均与手厥阴脉相交，但是相交的部位不同，老官山漆人在肘窝附近（左侧大致位于肘窝中，右侧位于肘窝上方），双包山木人手太阴脉与手厥阴脉相交的位置大致位于下颌角处，此外，双包山木人手太阴脉的起点，正好位于足阳明脉的循行路径上，与之重合。在经脉分支方面，老官山漆人右上肢鱼际靠近腕关节处，发出一条支脉到达次指内廉，而双包山木人从同样的位置发出两条支脉，其中支脉1止于拇指内端，支脉2走向手背，并入手阳明脉。《灵枢·经脉》中手太阴脉的分支为“其支者，从腕后直出次指内廉，出其端”，与老官山漆人和双包山木人支脉有相似性，可能存在传承关系。

在经脉主治病症方面，《足臂》手太阴脉主治病症较为简单，为心系病变，属于心痹的典型症状，如《素问·痹论》对“心痹”的症状描述为“烦则心下鼓，暴上气而喘，啞干善噫，厥气上则恐”，而《素问·举痛论》中提到寒邪侵袭致病时称“寒气……客于脉中则气不通，故卒然而痛”，因此“心痹”既有心脏本身的症状“心痛”，也有情绪改变“心烦”以及消化系统病变“噫”，类似现代内科学中心绞痛、心肌梗死的表现^[1]。《阴阳》手太阴脉的“是动则病”中提及“心滂滂如痛”，“其所产病”也出现“心痛”，结合《足臂》《阴阳》手太阴脉循行止点均在心，说明秦汉时期医家常选取手太阴脉治疗心系疾病，在《内经》一些篇章中，也有心病选取手太阴脉进行治疗的遗存，如《灵枢·杂病》：“心痛，但短气不足以息，刺手太阴。”然《灵枢·经脉》手太阴脉的主治病症中“肺胀满膨膨而喘咳”“咳，上气喘渴”均与肺系病症相关，《灵枢·经脉》与《足臂》《阴阳》之间主治病症的差异，归因于经脉-脏腑相关理论的转变，《足臂》《阴阳》手太阴脉与心相关，而《灵枢·经脉》则与肺相关，但黄龙祥先生通过分析《明堂经》中手少阴脉腧

^[1] 林果为,王吉耀,葛均波主编.实用内科学(第15版)(上册)[M].北京:人民卫生出版社,2017:982.

穴的主治病症后认为,《灵枢·经脉》篇将手太阴脉与肺建立联系的这种方式,对于汉代的针灸临床似乎并未产生影响^[1]。

在秦汉早期,手太阴脉与心的关系密切,马王堆帛书《足臂》《阴阳》手太阴脉与肺在经脉循行以及主治病症上毫无关联,此时手太阴脉与肺的联系并没有建立,这从老官山出土医简中古穴“辟阳明”的主治病症中可见一斑,《刺数》载:“咳,上气,两辟阳明各五、右心落。”而老官山《脉书·下经》载:“咳,上气,胸胁盈口,口臂阳明。”可见“咳”“上气”与“辟(臂)阳明”的关系较为密切,“辟阳明”大概相当于合谷、阳溪穴所在的部位,肺系病症选取手阳明脉进行治疗,在《内经》中仍有遗存,如《素问·五脏生成》中提到:“咳嗽上气,厥在胸中,过在手阳明、太阴。”《素问·缪刺论》中有:“邪客于手阳明之络,令人气满胸中,喘息而支胫,胸中热。”此外《内经》有些篇章治疗肺病时常将手阳明与手太阴合称,如“肺主秋,手太阴阳明主治……肺苦气上逆”(《素问·脏气法时论》)“肺热病者……热争则喘欬,痛走胸膺背,不得大息……刺手太阴阳明,出血如大豆,立已”(《素问·刺热》),均提示手阳明脉与肺系病变出现的“咳喘”“上气”症状相关联,直至《灵枢·经脉》篇肺手太阴之脉病候包括了:“咳,上气喘渴。”值得一提的是,尽管后来“咳”是作为肺系疾病的典型症状,如张家山汉简《脉书》中载有:“在肺,为上气、咳。”但《素问·咳论》开篇即讲:“五藏六府皆令人咳,非独肺也。”可能基于这一理论认识,肺系病症才与经脉之间的归属关系较为混乱,手太阴脉与肺建立关系,根据目前文献记载来看,应该是发生在秦汉晚期。

^[1] 黄龙祥. 心经、肺经“是动”病新解——解读经络学说的新证据[J]. 中国中医基础医学杂志, 2005(11): 19-21.

2.1.2 手厥阴脉

2.1.2.1 出土文献、文物手厥阴脉考订

老官山《十二脉》

心主之脉，𦰩（繫）掌中，上出辟（臂）中，出肘（肘）中，走亦（腋）下，□□，入匈（胸），循匈（胸）里，上加大阴，上循□𦰩，下𦰩（繫）心^[1]。

老官山漆人手厥阴脉

目前整理人员对老官山漆人“心主之脉”循行路径的推测可见三处：

2016 年学位论文^[2]以及期刊论文^[3]中，心主之脉起点在“中指内侧”，循行经过掌中、腕，在前臂屈面走行于手太阴脉与手少阴脉之间，在上臂屈面与手太阴脉相交后，走行在桡侧，最后在胸前壁“左之右，右之左（心包）”。

2018 年的期刊论文^[4]中，对心主之脉循行描述与 2016 年学位论文主要不同之处在于起点变为“腕”，之后的循行路径一致。

笔者通过对 2022 年英文论文^[5]中公布的老官山漆人经脉循行绘制图进行考察，如图 4 中红色线所示，可见手厥阴脉起始点应该定位于手腕，最初循行路径中的“中指→掌中”一段，误。因此，老官山漆人手厥阴脉的循行可以简述为“（起点）腕掌侧横纹中→前臂两骨间→肘窝→上臂桡侧缘（与手太阴脉相交）→肩前→胸前壁交叉（与足阳明脉相交）→（止点）对侧乳下，与上方环体横线汇合”。

^[1] 黄龙祥. 老官山出土汉简脉书简解读[J]. 中国针灸, 2018, 38(01): 97-108.

^[2] 邱科. 老官山汉墓经穴髹漆人像六阴经循行特点研究[D]. 成都中医药大学, 2016.

^[3] 邱科, 周兴兰, 孙睿睿, 等. 从西汉出土经穴髹漆人像看手厥阴经脉的循行演变[J]. 中国中医基础医学杂志, 2016, 22(10): 1372-1373+1390.

^[4] 邱科, 曾芳, 孙睿睿, 等. 成都老官山汉墓经穴髹漆人像手三阴经循行考证[J]. 中华中医药杂志, 2018, 33(04): 1480-1482.

^[5] 程施瑞, 周兴兰, 邱科, 等. 成都老官山汉墓经穴髹漆人像十二经脉循行考证（英文）[J]. World Journal of Acupuncture-Moxibustion, 2022, 32(01): 40-48.

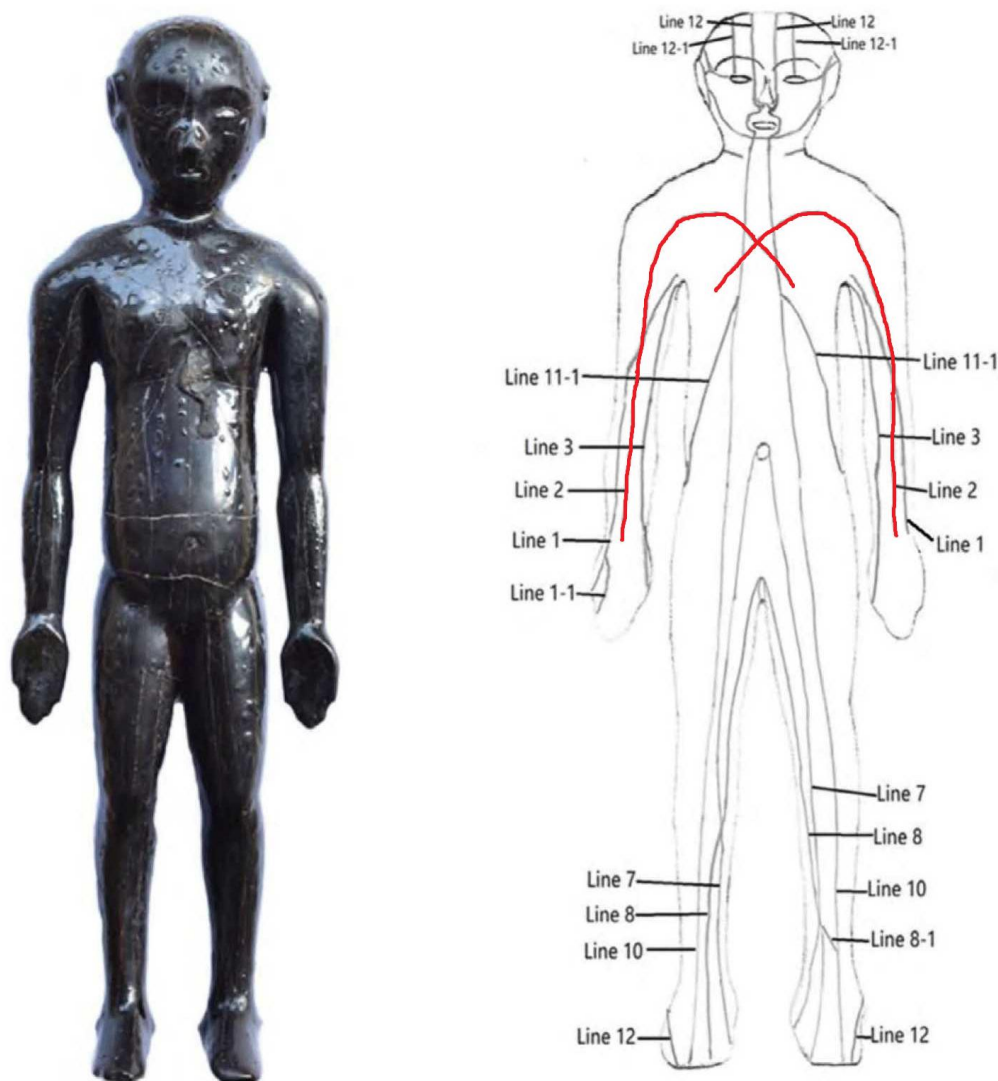


图 4 老官山漆人手厥阴脉循行路径

双包山木人手厥阴脉

只有一条主干（图 5 中红色线），没有分支，起点在头顶正中线，百会穴向前一寸处，刚好位于督脉循行路线上，而后沿着头两侧（耳前）向下走行，分别与足太阳脉、手少阳脉主干及分支、手阳明脉、手太阴脉有交叉，而后经过侧颈、肩前，在上肢走行于屈面中央（手太阴脉与手少阴脉之间），再经过手掌心，沿着中指腹侧面，循行至中指端为止点^[1]。

^[1] 马继兴. 双包山汉墓出土的针灸经脉漆木人形[J]. 文物, 1996(04): 55-65+98.



2.1.2.2 讨论

表 2 先秦两汉手厥阴脉演变特点对比

	《十二脉》	老官山漆人	双包山木人	《灵枢·经脉》
命名	心主之脉	/	/	心主手厥阴心包络之脉
起点	掌中	腕	头顶正中线略前方	胸中
止点	心	胸前壁	中指端	中指端
流注方向	向心性	向心性	远心性	远心性
支脉	1 条	无	无	1 条
脏腑	心	/	/	心包、三焦
官窍	喉咙	无	无	无

目前所见的《十二脉》《灵枢·经脉》以及两具出土文物中手厥阴脉一致特点是循行于上肢屈面中线，其起止点相差较大，手厥阴脉《足臂》《阴阳》未载，老官山《十二脉》是目前最早提出该脉命名的文献，称之为“心主之脉”，循行起点在于掌中，止点“系心”，同墓出土的老官山漆人起点在于腕，止点在胸前壁，胸前壁为心脏体表投影所在，老官山漆人手厥阴脉在胸前壁呈现出左右相交特点的原因，笔者推测，可能由于老官山漆人体表经脉循行线无法进入体内，且心脏位于胸腔偏左侧，因此左右“心主之脉”在胸前壁通过“左之右，右之左”这样的形式与心脏建立联系。双包山木人手厥阴脉的循行较为特殊，其起点在于头顶正中中线前方，正处于督脉循行路径上，在侧头部沿着耳前向下，与足太阳脉、手少阳脉主干及分支、手阳明脉、手太阴脉均有交叉，循行止点在中指端。值得注意的是，《灵枢·邪客》中提及了“心主之脉”的循行路线，可以简单描述为“中指端→中指内廉→掌中→两筋之间→肘内廉→胸中，内络于心脉”，明显有早期经脉文献的特点，其循行方向为向心性，循行路径与老官山《十二脉》重合较多，故依此推测《灵枢·邪客》成文时间可能要早于《灵枢·经脉》。

在经脉分支方面，笔者认为老官山《十二脉》中“上循喉咙”虽然没有用“其支者”引出，但应属于一条支脉。老官山漆人和双包山木人手厥阴脉未见刻画支脉，《灵枢·经脉》中手厥阴脉有一条支脉“别掌中，循小指次指出其端”，这条支脉明显是为建立十二经脉环形流注体系而设，与手少阳脉（起点为“小指次指之端”）建立联系。值得注意的是，《灵枢·经脉》手厥阴脉的循行路径描述中有两处“其支者”，其中第一处“其支者，循胸出胁，下腋三寸，上抵腋……”应该是对经脉主干的描述，将“其支者”改为“其直者”更为恰当。在与脏腑联系方面，《十二脉》《灵枢·经脉》均与心相关。在与官窍联系方面，《十二脉》提及与“喉咙”相关，但是目前还未公开《十二脉》“心主之脉”的主治病症，因此“心主之脉”的主治病症是否与喉咙相关还待公布，在《灵枢·经别》中载有：“手心主之正，别下渊腋三寸，入胸中，别属三焦，出循喉咙，出耳后，合少阳完骨之下。”^[1]《灵枢》通过经别的方式让心主之脉与喉咙建立了联系。

《灵枢·经脉》中与手厥阴脉联系的是“心包络”，有学者认为“心包”与“心包络”之间有差异，“心包络”是指心脏表面的动静脉，而“心包”则是早

^[1] [春秋]佚名. 灵枢经[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2012: 39.

期医家杜撰出来的一个脏腑^[1]，还有学者通过考察《内经》相关条文认为，“心”指解剖所见的“心脏”，“心包”指心脏外围的心包膜，“心主”是指中枢神经^[2]。老官山《十二脉》称此脉为“心主之脉”，其循行直接与心相关，而《十二脉》中“臂少阴脉”“臂太阴脉”也与心直接相关，虽然《十二脉》并未建立经脉-脏腑相关理论，但出现了“一脏分属三脉”的特殊情况（即手太阴脉“入心”，手心主脉“下系心”，手少阴脉“入心中”），而且“心主之脉”的命名方式也比较特殊，与“臂少阴脉”这种“足/臂+阴/阳+脉”的形式不同，反而与《阴阳》中“肩脉”“齿脉”“耳脉”这种“身体部位+脉”的命名方式相似，我们可以将“心主之脉”直接翻译为“与心脏有关的脉”，老官山《十二脉》中“心主之脉”“臂太阴脉”“臂少阴脉”皆与心相关，实际上体现了心脏在秦汉早期脏腑理论中占有重要地位，也体现出“心-血脉-经脉”之间千丝万缕的关系，《灵枢·经脉》将手太阴脉归属于肺，将心分为“心”与“心包络”，分别归属于手少阴脉和手厥阴脉，主要是为建立经脉-脏腑相关理论以及十二脉环形流注体系，偏向于理论层面的修改。有学者认为《灵枢·经脉》将心的概念一分为二后，其中与手少阴脉相连的是虚设的心（不受邪），与手厥阴脉相连的心才是真正的心^[3]，也有学者认为“心主”可以称为第六藏，其阳的功能归于心包，阴的功能归于膻中^[4]。

经脉数量方面，《足臂》《阴阳》为“十一脉”，而后在《十二脉》、老官山漆人以及《灵枢·经脉》中增加至“十二脉”，一般认为其所增加的经脉就是手厥阴脉（《十二脉》称“心主之脉”，《灵枢·经脉》称“心主手厥阴心包络之脉”），双包山木人缺少足三阴脉，但是多一条督脉，因此可认为属于“十脉”系统。值得讨论的是，手厥阴脉虽然在《阴阳》中没有记载，但是《阴阳》中手少阴脉的循行路径“起于臂两骨之间，之下骨上廉”近似于手厥阴脉所在的位置^[5]。手厥阴脉从无到有的现象困扰着学术界，相关学者提出了较多的解读或假说，有学者认为马王堆帛书“十一脉”中缺少的不是手厥阴脉，而是手太阴脉^[6]，李鼎先生

[1] 张建斌,王玲玲.“心包经”质疑[J].中国针灸,2001(03):37-38.

[2] 周波.心主是中枢神经的佐证——兼探讨心包络的实体[J].医学与哲学(人文社会医学版),2010,31(11):80-81.

[3] 洪晓帆,陈思婷,李红霞.“心主手厥阴心包络之脉”早期演化考[J].中国针灸,2021,41(03):349-353.

[4] 刘峰,黄晓红,龚小钢,等.心主刍议[J].医学与哲学(A),2016,37(12):84-86+97.

[5] 李瑞超,李岩,焦召华,等.手厥阴心包经刍议[J].山西中医,2013,29(6):37-45.

[6] 侯书伟,胡志强.帛书《经脉》缺手太阴脉论[J].山东中医学院学报.1989,13(4):49-50.

则认为马王堆帛书是将手太阴脉与手厥阴脉混为一脉而谈^[1]，也有学者认为，秦汉早期的十一脉并非是不完整的经脉学说，“阴经对应五脏，阳经对应六腑”这样的认识是当时的医学理论常态，如《灵枢·邪客》提及气的运行“注之于脉……内注五藏六腑”，所以廖育群先生认为“十一脉”学说并非是未发现手厥阴脉，而是根据天六地五的数术观念发展起来的^[2-3]，也有学者通过系统考证之后，强调了自然哲学观念对早期医学理论的影响^[4]，李永明先生则认为前臂遗留正中动脉的发现，是古人建立手厥阴脉的解剖学依据^[5]。先秦两汉时期经脉数量的多样性提示我们，早期医家（尤其是《灵枢·经脉》成篇之前）可能并未刻意规定经脉的数量，无论上肢还是下肢，分布三阴三阳六条经脉是一个比较合理的数目，以上肢为例，若手阴脉手阳脉各有两条，则不足以解释临床现象，若手阴脉手阳脉各有四条，则显得过于繁琐，同样不利于临床使用。

秦汉时期手厥阴脉主治病症载于《灵枢·经脉》，不仅有心脏本身的病变，如“心中憺憺大动”“心痛”，还包括有情志病变如“烦心”“喜笑不休”，是在“心主神志”的认识下对病症进行的归类。其中“所生病”（烦心心痛，掌中热）与《足臂》手太阴脉的“其病”（心痛，心烦而噫）类似，只是多出“掌中热”这一症状，可能与经脉循行路线逐渐延伸至手掌有关，《灵枢·经脉》手厥阴脉“是动病”中又有“手心热”。“掌中热”与“手心热”实为一症，可推测“是动病”与“所生病”并非一人一时之作，且两者所包含的病症之间多有重合。

[1] 李鼎.《脉书》臂五脉与手六经及其经穴主治关系的分析[J].上海中医药大学上海市中医药研究院学报,1996(2):34-37.

[2] 廖育群.《阴阳十一脉灸经》研究——兼论经络体系的形成与发展[J].中华医史杂志,1989(1):20-24.

[3] 韩健平.经脉学说的早期历史:气、阴阳与数字[J].自然科学史研究,2004,23(4):326-333.

[4] 张苇航.“手心主脉”考——兼论早期经脉学说的演变[J].医疗社会史研究,2016,1(02):111-121+330.

[5] 李永明.汉代十一脉到十二经脉转变的解剖依据[J].中国针灸,2021,41(10):1153-1158.

2.1.3 手少阴脉

2.1.3.1 出土文献、文物手少阴脉考订

马王堆《足臂十一脉灸经》

臂少阴【温（脉）】：循筋下廉（廉），出臑内下廉（廉），出夜（腋），
奏（凑）臂。其病：臂痛。诸病【此】物者，皆【久（灸）】臂少阴【温（脉）】。

马王堆《阴阳十一脉灸经》（甲本）

臂少阴脉（脉）：起於臂两骨之间（间）{之间（间）}，{之}下骨上廉，筋（筋）
之下，【出】臑内阴，【入心中】。【是动则病：心】痛，益（咽）【乾】，渴
欲饮（饮），此為臂蹇（蹇一厥），是臂少阴脉（脉）主治。其所產【病】：臂痛
（痛），為【一病】。

马王堆《阴阳十一脉灸经》（乙本）

臂少阴脉（脉）：起於臂两骨上<之>间（间），下骨上庸<廉>，筋（筋）
之下，出臑内阴，入心中。是动（动）则病：心痛，咽乾，【渴】欲饮（饮），
此為臂厥，是臂少阴脉（脉）主治。其所產病：臂痛（痛），為一病。

张家山《脉书》载《阴阳十一脉灸经》（丙本）

【·臂少阴之脉】，起於臂两骨之间，下骨上廉，筋之下，出臑内阴，入心
中。是动（动）则病：心痛，咽渴欲饮，此為臂蹇（厥），是臂少阴之脉主治。
其所產病：脇痛，為一病。

老官山《十二脉》

辟（臂）少阴脉，轂（繫）掌中，循辟（臂）内阴两骨之间，下骨上廉，筋
之下，以上入肘内廉，出臑内阴，下出亦（腋）下，入心中^[1]。

^[1] 黄龙祥. 老官山出土汉简脉书简解读[J]. 中国针灸, 2018, 38(01): 97-108.

老官山漆人手少阴脉

2016 年^[1]学位论文中，左右侧手少阴脉起点不一致，右侧起于小指桡侧，沿着掌内后廉（待考证），到达腕横纹尺侧，而左侧起于腕横纹尺侧。之后左右侧均沿着上肢屈面尺侧缘，到达腋下。

2018 年^[2]期刊论文中，与 2016 年不同之处在于左右侧均起于小指桡侧，之后的循行路线一致。笔者又对比 2022 年发表的英文论文^[3]中所公布的绘制图，认为“小指桡侧→掌内后廉→腕横纹尺侧→臂内后廉→肘内→臑内后廉（太阴厥阴之后）→腋下”是老官山漆人手少阴脉的循行路线，如图 6 中红色线所示。

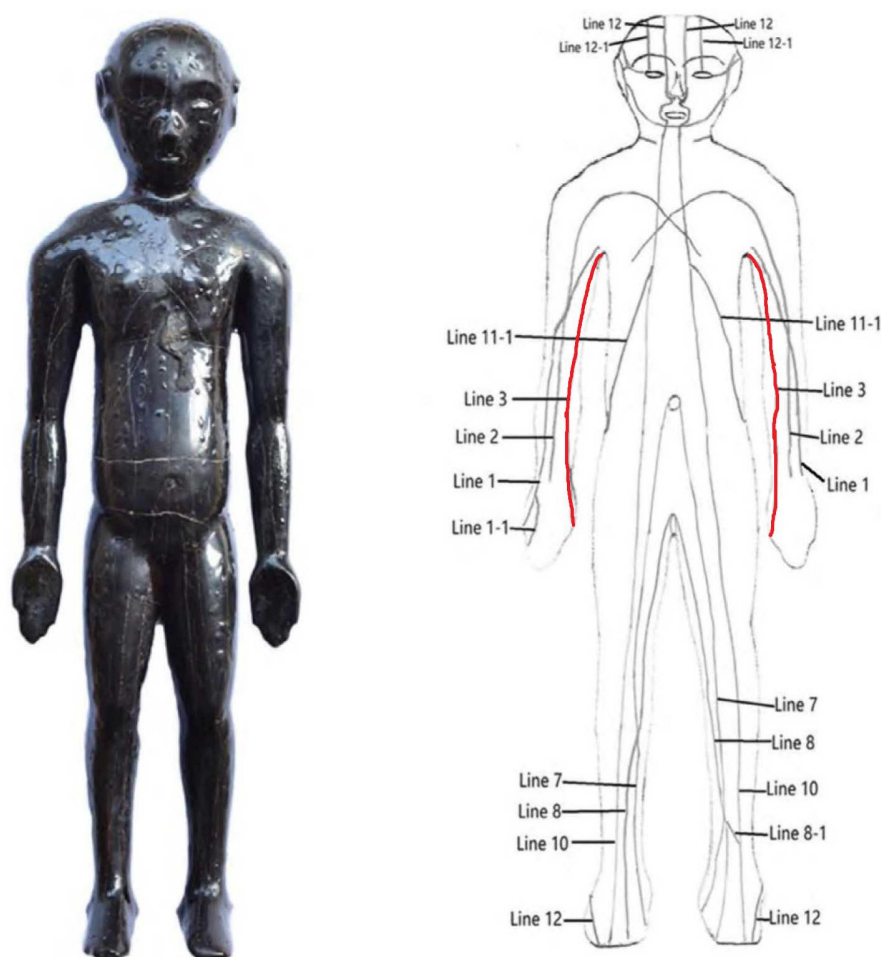


图 6 老官山漆人手少阴脉循行路径

^[1] 邱科. 老官山汉墓经穴髹漆人像六阴经循行特点研究[D]. 成都中医药大学, 2016.

^[2] 邱科, 曾芳, 孙睿睿, 等. 成都老官山汉墓经穴髹漆人像手三阴经循行考证[J]. 中华中医药杂志, 2018, 33(04): 1480-1482.

^[3] 程施瑞, 周兴兰, 邱科, 等. 成都老官山汉墓经穴髹漆人像十二经脉循行考证(英文)[J]. World Journal of Acupuncture-Moxibustion, 2022, 32(01): 40-48.

双包山木人手少阴脉

本脉只有主干（图7中红色线），无分支，起自颈部前方喉两侧，起点正位于足阳明脉循行路线上，而后向外下方走行，经过缺盆、肩前，到达腋前纹头，在上肢沿着屈面内侧缘走行，最终到达手小指端，循行过程中仅起点处与足阳明脉交汇^[1]。

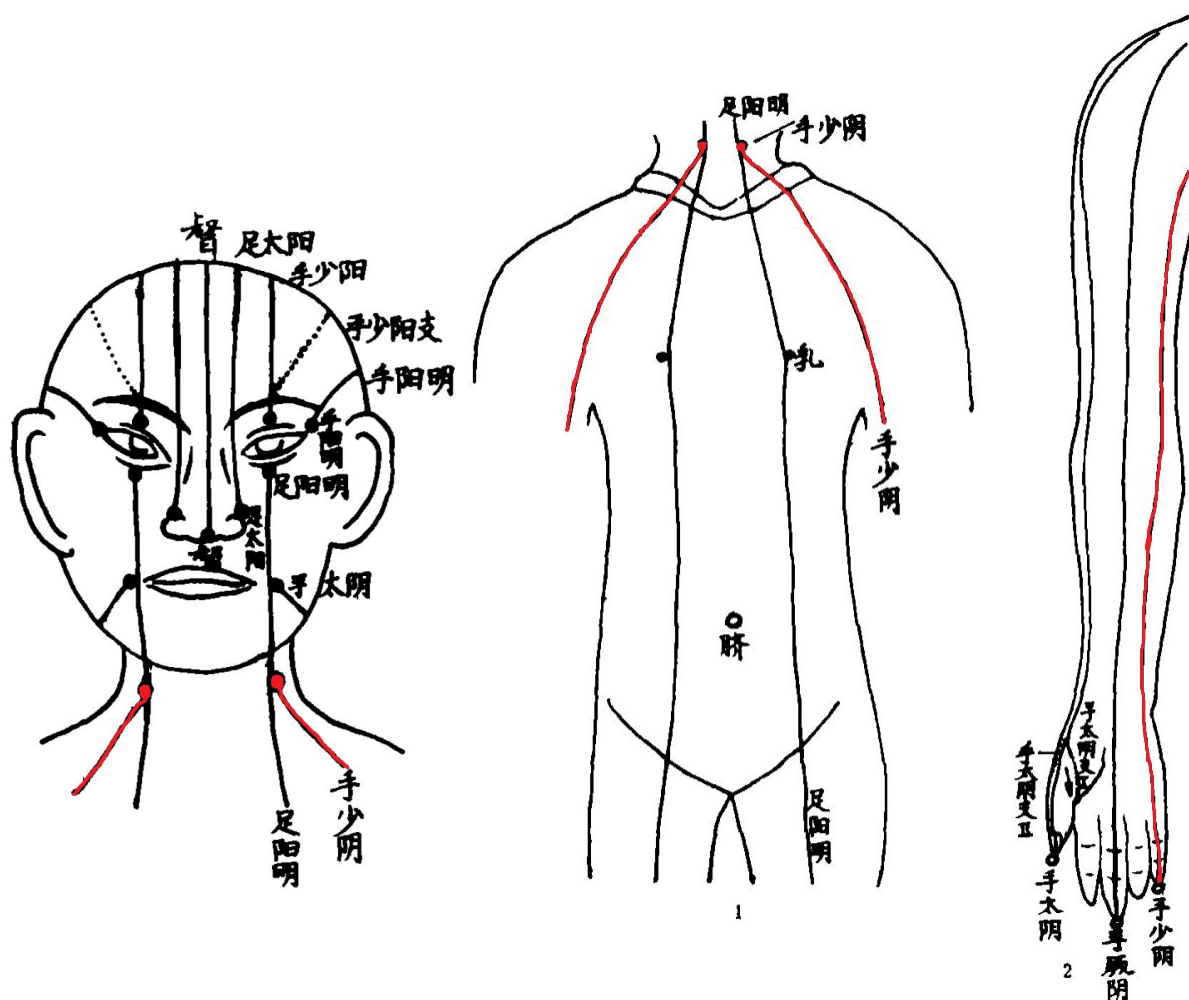


图7 双包山木人手少阴脉循行路径

^[1] 马继兴. 双包山汉墓出土的针灸经脉漆木人形[J]. 文物, 1996 (04): 55-65+98.

2.1.3.2 讨论

表 3 先秦两汉手少阴脉演变特点对比

	《足臂》	《阴阳》 (甲本)	《阴阳》 (乙本)	《阴阳》 (丙本)	《十二脉》	老官山 漆人	双包山 木人	《灵枢· 经脉》
命名	臂少阴温	臂少阴脉	臂少阴脉	臂少阴之脉	辟少阴脉	/	/	心手少阴 之脉
起点	臂	臂两骨之 间	臂两骨之 间	臂两骨之 间	掌中	小指桡侧	颈前部	心中
止点	肘	心中	心中	心中	心中	腋下	小指屈侧 端	小指端
流注方向	向心性	向心性	向心性	向心性	向心性	向心性	远心性	远心性
支脉	无	无	无	无	无	无	无	1条
脏腑	无	心	心	心	心	/	/	心、小肠
官窍	无	无	无	无	无	无	咽	咽、目

《足臂》《阴阳》手少阴脉之间最大的区别，在于是否与“心”建立了联系，《足臂》与心相关者只有手太阴脉，手少阴脉循行与主病皆与心无关，而《阴阳》手少阴脉循行“入心中”，主病也有“心痛”，因此《阴阳》手太阴脉与手少阴脉循行路径及主治病症皆与心相关，即“一脏分属于两脉”，而老官山《十二脉》手三阴脉均与心相关（手太阴脉“入心”，手心主脉“下系心”，手少阴脉“入心中”），体现秦汉早期医家对作为“五脏六腑之主”的“心”较为重视。由于《阴阳》（丙本）是老官山医简《十二脉》的底本，所以《十二脉》手少阴脉循行也提到“入心中”，手少阴脉与心之间的关联被《灵枢·经脉》继承，并将经脉名称从“臂少阴（之）脉”改为了“心手少阴之脉”。

诸文献、文物中手少阴脉的共同特点是循行路径多位于上肢屈面尺侧缘，但起止点之间的差异较大，《足臂》未提及本脉起点，根据“循筋下兼（廉）”一语，暂定起点为“臂”，《阴阳》起点为“臂两骨之间”，老官山《十二脉》起点延伸至“掌中”，但仍命名为“辟（臂）少阴脉”，其循行经过“辟（臂）内阴两骨之间”，此处“两骨”指的是上肢前臂的尺骨与桡骨，因此《阴阳》《十二脉》所述的手少阴脉与后世手厥阴脉的位置相似，表明秦汉早期对手三阴脉的循行描述还较为混乱，未形成固定的认识，老官山漆人手少阴脉起点位于“小指桡侧”，双包山木人

与《灵枢·经脉》手少阴脉循行也到达小指端，但由于二者循行方向是远心性，因此小指尖端处是作为循行止点，手少阴脉上肢远端起止点从“臂”到“掌中”再到“小指端”，说明秦汉时期手少阴脉从“臂腕”逐渐向手指端延伸，其他经脉也多有此规律。双包山木人手少阴脉的起点在颈前部，大致位于咽两侧，可能是因为《阴阳》中手少阴脉主治病症有“嗑干”，因此双包山木人手少阴脉与咽部建立了联系。《足臂》手少阴脉止点在胁，而《阴阳》《十二脉》顺势入心，并且在主治病症中也增加了“心痛”，笔者推测可能是由于秦汉早期医家在手少阴脉的循行路线上积累了治疗“心痛”的经验，于是将此脉与心脏建立联系，对比双包山木人与帛书《阴阳》手少阴脉的循行特点，可知病症所在部位是经脉建立以及循行路线不断延伸的重要影响因素。手少阴脉支脉仅在《灵枢·经脉》中有提及，即“从心系上挟咽，系目系”，应该与“所生病”中的“目黄”一症相关，故经脉分支的出现，与病症所在部位相关，可归纳为“主治所在，经脉所及”。与脏腑联系方面，《阴阳》《十二脉》与心联系，《灵枢·经脉》则与心和小肠联系。与官窍联系方面，双包山木人与咽联系，《灵枢·经脉》与咽、目联系。

在主治病症方面，《足臂》手少阴脉尚未与心建立联系，主治病症仅为“胁痛”，《阴阳》与心建立联系后，其“是动则病”中包括有心系病症，即“心痛，嗑干，渴欲饮”，此外“其所产病”与《足臂》同为“胁痛”。《灵枢·经脉》中手少阴脉的“是动则病”为“嗑干心痛，渴而欲饮”，与《阴阳》完全相同，只是前后排列顺序有差异，可能存在传承关系，而“是主心所生病”中除“胁痛”外，还有“目黄……臑臂内后廉痛厥，掌中热痛”，多属于经脉循行路径上的痛症。其中“嗑干”与“渴欲饮”提示热证，与《灵枢·热病》中的“心热病”“脾热病”的症状表现类似，《说文》：“嗑，咽也。”“嗑”字单用时有吞咽困难之意^[1]，“嗑干”表示咽部干涩，欲饮水润之，偏向于表示热证，当然也必伴有吞咽困难的症候，有学者考证后认为《内经》中有 11 条经络与咽嗑病变相关，包括局部病变以及传导功能失常等^[2]，黄龙祥先生认为^[3]古人将心脏与咽喉病变建立联系，与现代临床上冠心病

^[1] 吕晓雪,王育林.考释“咽”“喉”“咙”“嗑”“噎”“嘶”“喝”[J].浙江中医药大学学报,2020,44(04):391-393+406.

^[2] 孟凡琪,张荷,陈秀华.《黄帝内经》中的“咽嗑”病[J].中国医药导报,2020,17(10):122-125.

^[3] 黄龙祥.心经、肺经“是动”病新解——解读经络学说的新证据[J].中国中医基础医学杂志,2005(11):19-21.

患者出现咽部不适（如声音沙哑等）的“心-咽综合征”相类似，表明古人观察疾病较为细致，现代学者研究表明，非心脏性胸痛可能会出现包括咽部感染在内的一组综合症状，表明了咽部感染可能与胸痛之间有联系^[1]，古人的认识与现代研究之间不无关系。

手少阴脉在《内经》中还常用于诊断，即《灵枢·论疾诊尺》中提到的“女子手少阴脉动甚者，妊子也”，在《素问·平人氣象论》中也有相同的论述，只是将“女子”改写作“妇人”，其中，手少阴脉搏动之处大致在神门穴范围内^[2]，“动甚”是指此处动脉搏动要比平常更为明显，滑寿称“愚谓动甚非指动脉形状，谓脉来过于滑动也”^[3]，古代由于医疗水平低下，胎儿存活率远低于现代，妊娠生理过程以及病理表现，是早期医家医疗活动中的一个重要关注点，在甲骨文已经有“妇好有子？三月”的记载^[4]，马王堆《胎产书》中也记载了很多早期医家对于孕育以及生产的认识^[5]，秦汉医家除开创通过脉象诊察妊娠现象及胎儿性别外，还存在有很多养胎保胎的方法，甚至早期还有利用巫术进行祈求怀孕、祈求生男等行为，实际上体现古人对于知晓妊娠以及妊娠安全的渴望。

^[1] 周昌清,严江涛,范巧,等.咽、颈、胸痛与心脏反应新的临床综合征[J].中华心血管病杂志,2010(02):147-151.

^[2] 王雪,朱鹏举.《黄帝内经》“手少阴脉动甚者妊子”说古注述评[J].国医论坛,2022,37(01):14-16.

^[3] [元]滑寿.读素问钞[M].北京:人民卫生出版社,1998:46.

^[4] 李良松,郭松涛.中国传统文化与医学[M].厦门:厦门大学出版社,1990:49.

^[5] 吕亚虎.帛书《胎产书》所见早期孕育信仰浅析[J].江汉论坛,2009(06):70-77.

2.1.4 手阳明脉

2.1.4.1 出土文献、文物手阳明脉考订

马王堆《足臂十一脉灸经》

臂陽明^[1]（明）溫（脈）：出中指間（間），循骨上廉（廉），出臑【□□】上，
 奏臑（枕），之口。【其】病_二（病：病）齒【痛】，【□□□□】。【諸】病此物者，
 皆久（灸）臂陽明（明）溫（脈）。

马王堆《阴阳十一脉灸经》（甲本）

齒脈（脈）：起於次指與大指上，出臂上廉，入肘中，乘臑，【穿】頰，入齒
 中，夾（挾）鼻。是【動】則病：齒痛（痛），臑（頰）腫（腫），是齒脈（脈）
 主治。其所產病：齒痛（痛），臑（頰）腫（腫），目黃，口乾，臑痛（痛），為五
 【病】。

马王堆《阴阳十一脉灸经》（乙本）

齒𦵿（脈）•起【于次指與大】指上，出臂上廉，入肘中，乘臑，穿頰，入齒
 中，夾（挾）鼻。是動（動）則病：齒痛（痛），臑（頰）腫（腫），是齒𦵿（脈）
 主治。其所產病：齒痛（痛），臑（頰）腫（腫），目黃，口乾，臑痛（痛），為五
 病。

张家山《脉书》载《阴阳十一脉灸经》（丙本）

【•】齒脈，起於次指與大指上，出臂上廉，入肘中，乘臑，穿頰，入齒中，
 夾（挾）鼻。是動（動）則病：齒痛，臑（頰）腫（腫），是齒脈主治。其所產病：
 齒痛，臑（頰）腫（腫），目黃，口乾，臑痛，為五病，及□咽□。

老官山《十二脉》

• 手陽明脈，𦵿（繫）次指與大指之上，出辟（臂）上廉，入肘中，乘臑，

^[1] 明，原释文作“明”，《集成》识作“明”，经核查图版，可从。古代“明”与“明”同义。田蕤衡曰：“古皆从日月作明，汉乃从目作明。”可参。

出肩前廉，循颈穿颊，入口中。其病：齿齲痛，口辟（僻），𩑦（頔）种（肿）。

老官山《经脉》残简

- 臂阳明脉，起手大指与次指，上循臂^[1]。

老官山漆人手阳明脉

循行路径大致为：大指次指之端→指上廉→腕→臂上廉→肘外廉→臑外前廉→至肩上→循颈→直上绕耳→目锐眦^[2]。

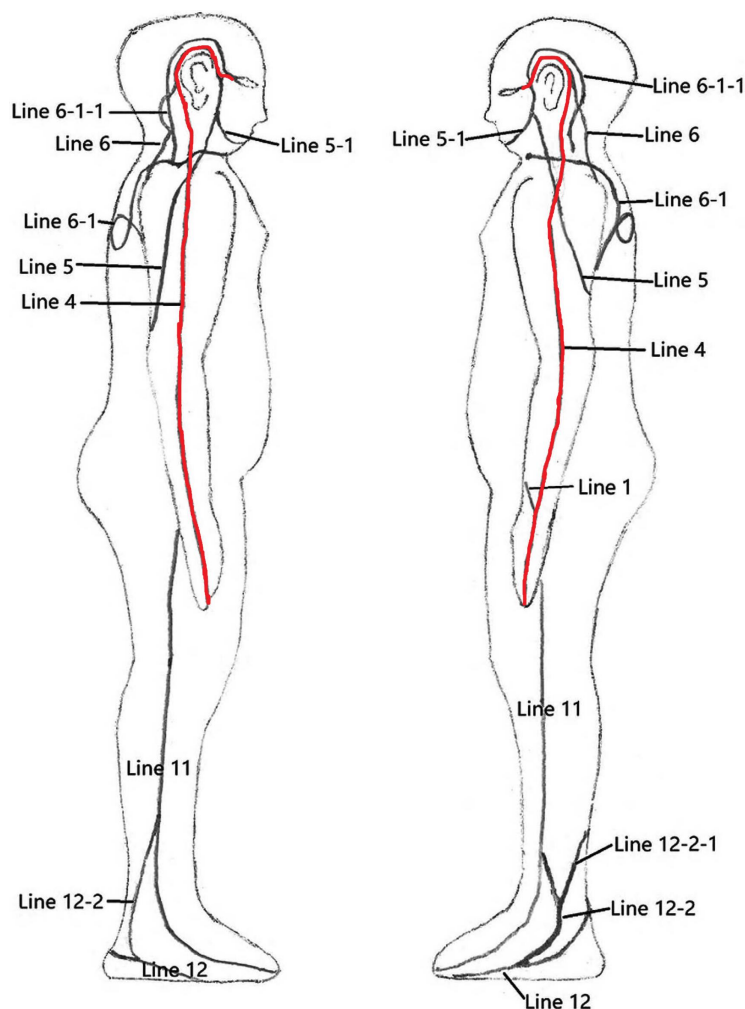


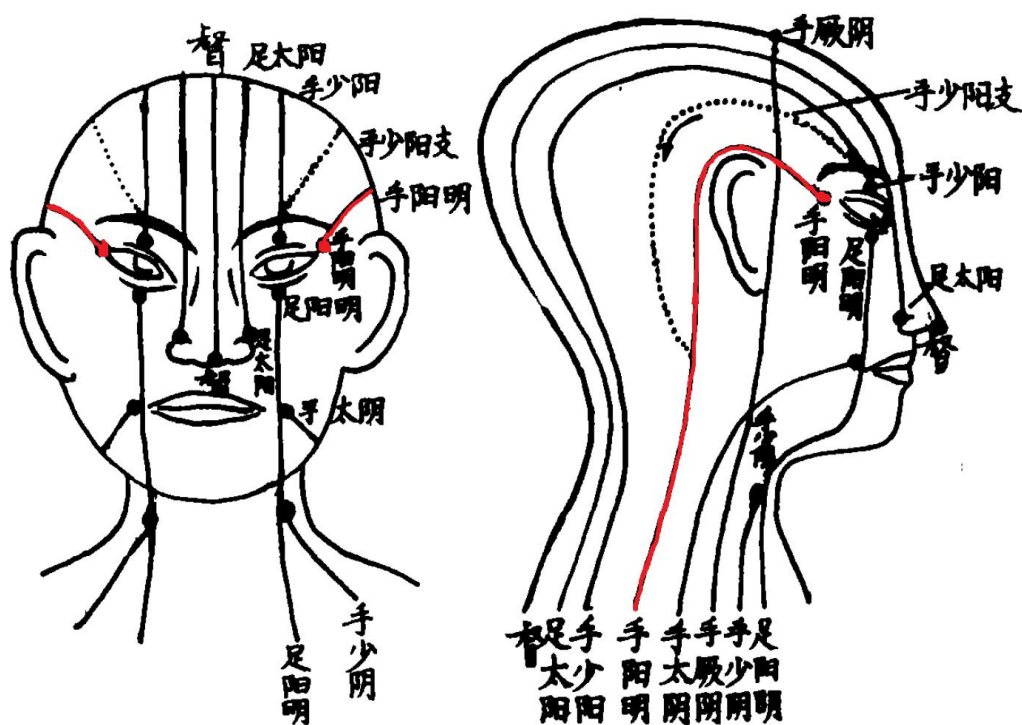
图 8 老官山漆人手阳明脉循行路径

^[1] 黄龙祥. 老官山出土汉简脉书简解读[J]. 中国针灸, 2018, 38(01): 97-108.

^[2] 张乙小, 周兴兰, 曾芳, 等. 老官山汉墓出土经穴髹漆人像手阳明经脉循行演变研究[J]. 中医杂志, 2019, 60(23): 1985-1987+1992.

双包山木人手阳明脉

包括一条主干与一条分支，主干（图9中红色线）起点在目外眦，绕行耳后，在耳垂后下方（大约与下颌角同一水平面处），接受手少阳脉分支汇入，而后经过侧颈部、肩，进入上肢，沿着上肢伸面外侧缘，大约在上臂循行路径的中点处，与手太阳脉的起点重合，在前臂靠近腕关节处，与手少阳脉主干重合一小段路径后，沿着手背、食指背面，到达食指端。在与手少阳脉汇合处发出一条分支（图9中蓝色线），该分支向下内走行，最终汇入手太阳脉。此外，在食指指背根部，手阳明脉还接受来自手太阴脉的支脉^[1]。



^[1] 马继兴. 双包山汉墓出土的针灸经脉漆木人形[J]. 文物, 1996 (04): 55-65+98.

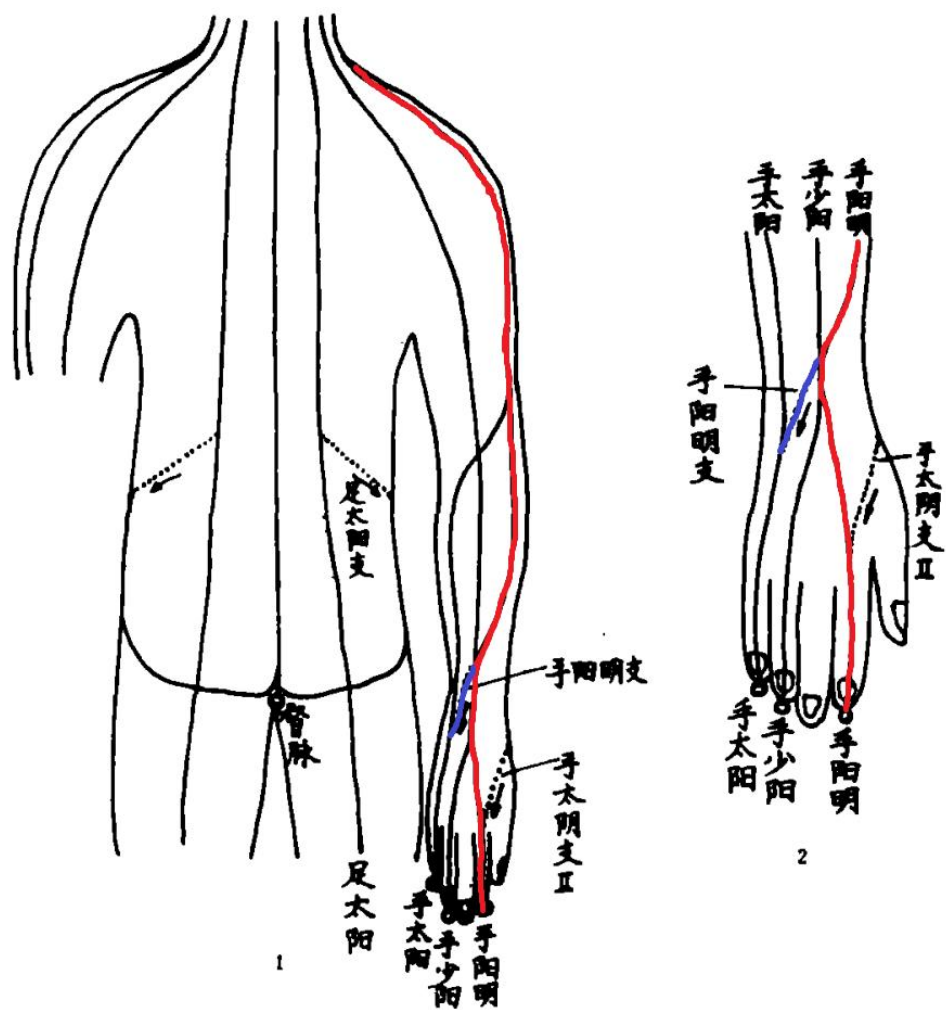


图 9 双包山木人手阳明脉循行路径

2. 1. 4. 2 讨论

表 4 先秦两汉手阳明脉演变特点对比

	《足臂》	《阴阳》 (甲本)	《阴阳》 (乙本)	《阴阳》 (丙本)	《十二 脉》	老官山 漆人	双包山 木人	《灵枢· 经脉》
命名	臂陽明溫	齒脈	齒肱	齒脈	手陽明脈	/	/	大腸手陽明 之脈
起点	中指间	次指與大 指上	次指與大 指上	次指與大 指上	次指與大 指之上	大指次指 之端	目外眦	大指次指之 端
止点	口	鼻	鼻	鼻	口中	目外眦	示指端	鼻
流注 方向	向心性	向心性	向心性	向心性	向心性	向心性	远心性	向心性
支脉	无	无	无	无	无	无	1 条	1 条
脏腑	无	无	无	无	无	/	/	肺、大腸
官窍	口	齿、鼻	齿、鼻	齿、鼻	口	目	目	齿、口、鼻

秦汉时期手阳明脉的名称中,“臂阳明温”(《足臂》)和“手阳明脉”(《十二脉》)是“手/足+阴/阳+脉”的命名形式,《足臂》冠以“臂”,而《十二脉》冠以“手”,但早在《足臂》中手阳明脉循行已到达手指,起于“中指间”,《十二脉》将“臂”改为“手”,至《灵枢·经脉》则是以“脏/腑+手/足+阴/阳+脉”的命名形式,最主要的特点是加入了“脏腑”的命名元素,老官山汉墓医简成书时间大致介于马王堆帛书与《内经》之间,从“臂阳明温→手阳明脉→大肠手阳明之脉”的经脉名称演变过程可以看出,秦汉医家对经脉的命名受到循行路径改变以及经脉-脏腑相关理论建立等因素的影响,而《阴阳》三个版本均是以“身体部位+脉”的形式进行命名,即“齿脉”,“齿痛”是《足臂》《阴阳》《十二脉》中手阳明脉的第一个主治病症,但只有《阴阳》提到了经脉循行“入齿中”,可见《阴阳》无论是经脉名称、循行路径,还是主治病症均与齿相关。

诸文献手阳明脉从腕部到肩颈部的循行路径大致相同,最大的区别在于起止点位置有差异,在经脉起点方面,双包山木人经脉循行方向经马继兴先生考证为远心性,故起点在目外眦,其余文献、文物手阳明脉循行方向皆为向心性,故起于手指,但具体起于哪根手指,又有“中指间”(《足臂》)“次指与大指上”(《阴阳》)“大指次指之端”(《十二脉》《灵枢·经脉》)的区别,在经脉止点方面,本文文献分别与口、齿、鼻相关,但老官山漆人与双包山木人均与目外眦相连,尤其是老官山同墓出土的《十二脉》与漆人之间手阳明脉止点不同,令人费解,《十二脉》止点在“口中”,而漆人止点在“目外眦”,我们观察漆人绘制图可见,即使手阳明脉通过借助手少阳脉的分支(即图8中line 5-1),也无法与“口中”这一部位进行联系,这种同一墓葬出土的经脉记载出现明显差异不止此一处,比如同属于马王堆汉墓出土的帛书《足臂》《阴阳》之间经脉循行路径及主治病症的记载也多有差异,应该不是抄写人员或者墓主人失误所致,而是经脉发展不同阶段的产物,或者属于不同医学流派之间的认识差异。双包山木人即使借助手太阴脉的支脉2,同样也只能到达口角,老官山漆人与双包山木人的手阳明脉循行路径也有较大的相似性。在与官窍联系方面,诸文献记载与口、齿、鼻相关,而两具文物则均与目相关,提示出土文物中手阳明脉循行的特殊性。此外,《足臂》《阴阳》《十二脉》手阳明脉与脏腑之间无联系,两具文物与脏腑的关系无法考察,而《灵

枢·经脉》则与肺、大肠相联系。

秦汉时期手阳明脉主治病症方面,《足臂》为“齿痛”,《阴阳》则包括“是动则病”与“其所产病”两种类型,但两者之间重合病症较多,如均有“齿痛,頄肿”,也见于《灵枢·经脉》的“是动则病”,此外《灵枢·经脉》“所生病”中的“目黄”“口干”也见于《阴阳》。《灵枢·经脉》中增加的病症有“鼽衄”“喉痹”“大指次指痛不用”。其中“鼽衄”属于鼻部病症,在出土文献中,手阳明脉主治病症中并无鼻部病症,但《阴阳》手阳明脉循行止点为“夹鼻”,因此,《灵枢·经脉》手阳明脉新增鼻部病症“鼽衄”可能是受到了《阴阳》手阳明脉循行的影响。此外,上述文献、文物中手阳明脉与耳之间并无直接的连属关系,但是老官山漆人与双包山木人手阳明脉从肩到目外眦之间的经脉循行均为绕耳一周,《内经》治疗耳部疾患有时会选取手阳明脉,如《灵枢·杂病》:“聋而痛者,取手阳明。”《素问·缪刺论》也提及:“耳聋,刺手阳明。”《灵枢·经脉》手阳明脉新增的“大指次指痛不用”,是属于经脉循行所过的病症。

2.1.5 手少阳脉

2.1.5.1 出土文献、文物手少阳脉考订

马王堆《足臂十一脉灸经》

臂少陽溫（脈）：出中指，循臂上骨下廉（廉），奏耳。其病：產聾，【頰】痛。諸病【此物者，皆】久（灸）臂少陽之溫（脈）。

马王堆《阴阳十一脉灸经》（甲本）

耳脈（脈）：起於手北（背），出臂外兩骨之間（間），【上骨】下廉，【出肘中】，入耳中。是動（動）則病：耳聾輝_二_一（輝輝_二_一），噤種（腫），是耳脈（脈）主治。其所產病：目外漬（背）痛（痛），頰【痛】，耳聾，為三病。

马王堆《阴阳十一脉灸经》（乙本）

耳_二_一（脈）·起【于手】北（背），出【臂外兩骨】之間（間），上骨下廉（廉），出肘中，入耳中。是動（動）則病：耳聾輝_二_一（輝輝_二_一），噤腫（腫），是耳_二_一（脈）主治。其所產病：目外_二_一（背）_二_一（痛），頰_二_一（痛），耳聾，為三病。

张家山《脉书》载《阴阳十一脉灸经》（丙本）

·耳脈，起手北（背），出臂外廉兩骨之間（間），上骨下廉，出肘中，入耳中。是動（動）則病：耳輝輝_二_一，益（噤）種（腫），是耳脈主治。其所產病：目外際痛，頰痛，耳聾，為三病。

老官山《十二脉》

手少阳脉，繫□上出臂外□□之間，上骨下廉，出□上腭外廉，出□^[1]。

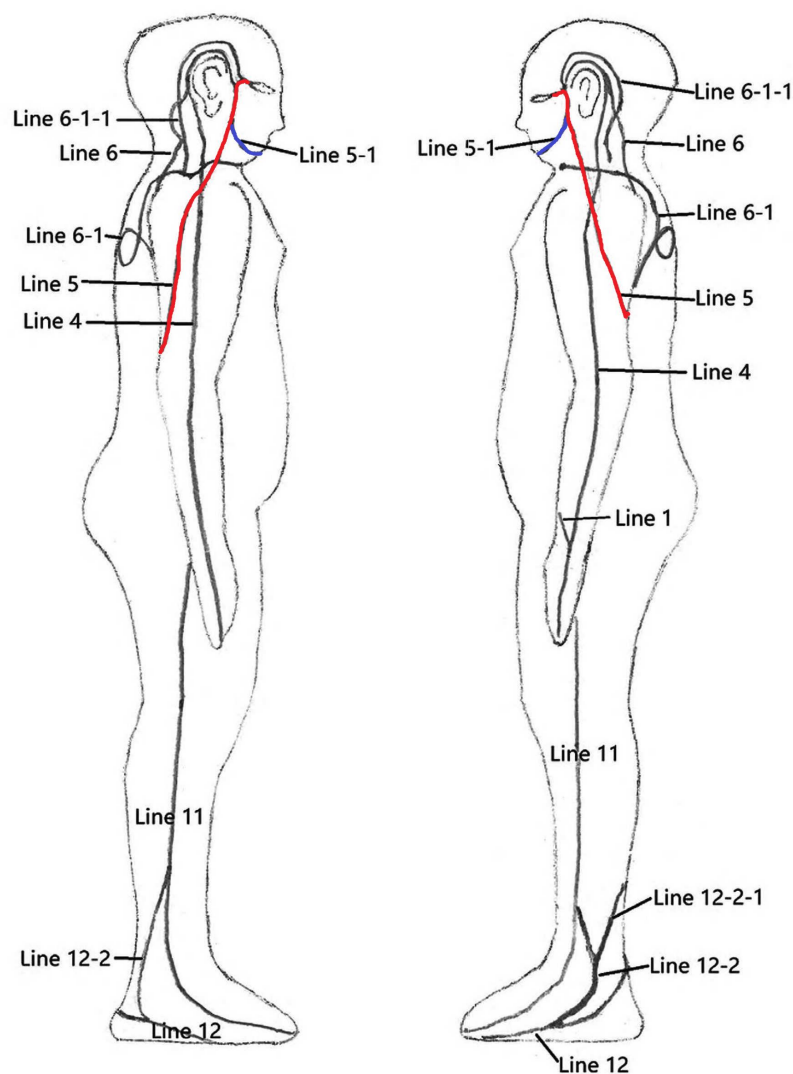
老官山《经脉》残简

^[1] 周兴兰,张乙小,曾芳.成都老官山汉墓出土髹漆经穴人像手少阳脉循行特点研究[J].中医杂志,2020,61(11):942-945.

種（肿）。所生病，目外颜肿（肿），耳后、肩、腭（腭）后廉痛，汗出，中指不用，戾（喉）痹^[1]。

老官山漆人手足少阳脉

包含一条主干和一条分支，其中，主干（图 10 中红色线）起于中指，循行路径经过手背、腕背侧、上肢伸面桡侧、肩、侧颈部，再从耳前向上，到达目外眦，一条分支（图 10 中蓝色线 line 5-1）从耳前发出，沿着面颊向前下方循行，交汇于口唇下方（即下颌正中）^[2]。



^[1] 顾漫,周琦,柳长华,等. 天回医简《经脉》残篇与《灵枢·经脉》的渊源[J]. 中国针灸, 2019, 39(10): 1117-1123.

^[2] 周兴兰,张乙小,曾芳. 成都老官山汉墓出土髹漆经穴人像手少阳脉循行特点研究[J]. 中医杂志, 2020, 61(11): 942-945.

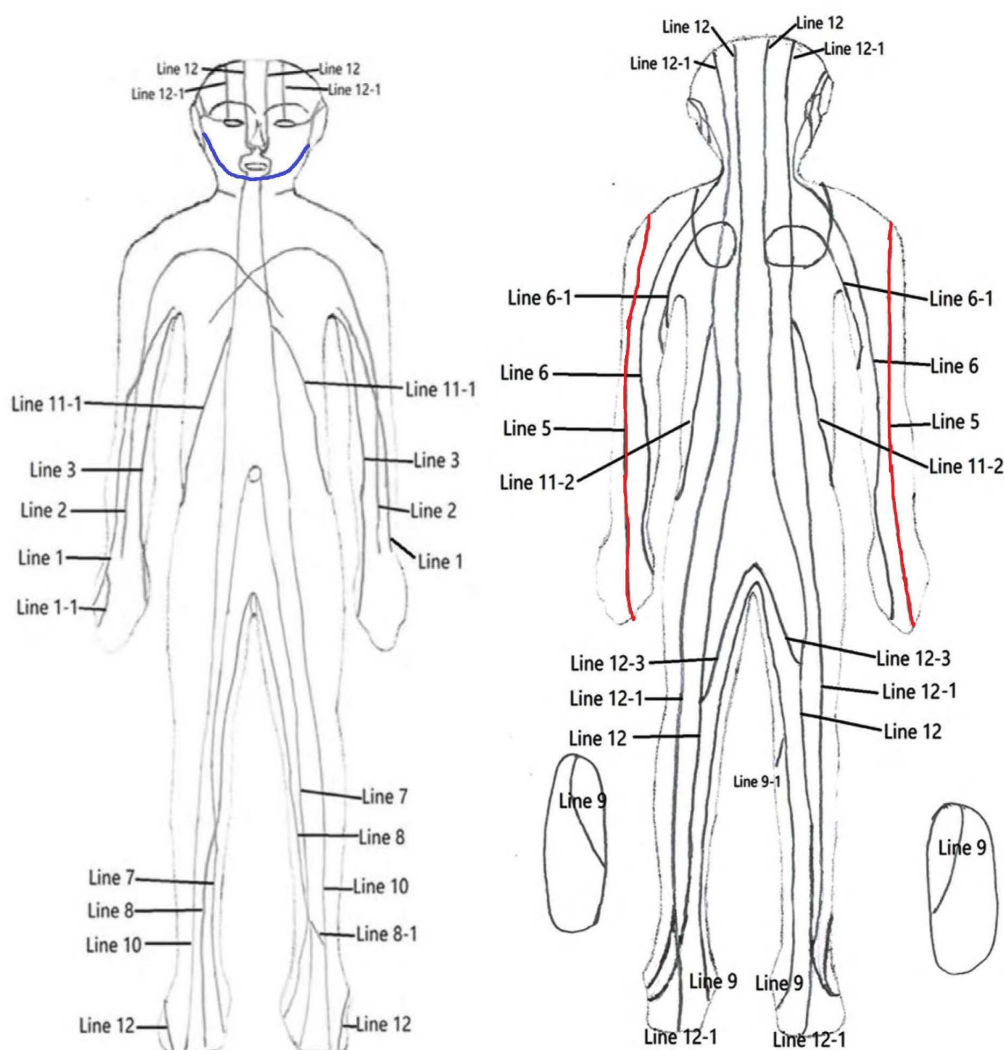


图 10 老官山漆人手少阳脉循行路径（侧面观、正面观、背面观）

双包山木人手少阳脉

包含有一条主干与一条分支，主干（图 11 中红色线）起点在目上中央，绘制图显示位于上眼睑中央，向上经过眉毛中央，并且在眉毛中央发出手少阳脉的分支（图 11 中蓝色线），分支在侧头部绕耳一周后，在耳垂后下方并入手阳明脉。主干从眉毛中央向上经额，绕侧头部一周（与督脉平行），并且与手厥阴脉有交叉，而后经过后颈部、肩胛区，进入上肢伸面，在上臂靠近肘关节处与手太阳脉交叉，在前臂靠近腕关节处与手阳明脉有一小段重合，最后沿着手背、无名指（环指）背，止于无名指端^[1]。

^[1] 马继兴. 双包山汉墓出土的针灸经脉漆木人形[J]. 文物, 1996(04): 55-65+98.

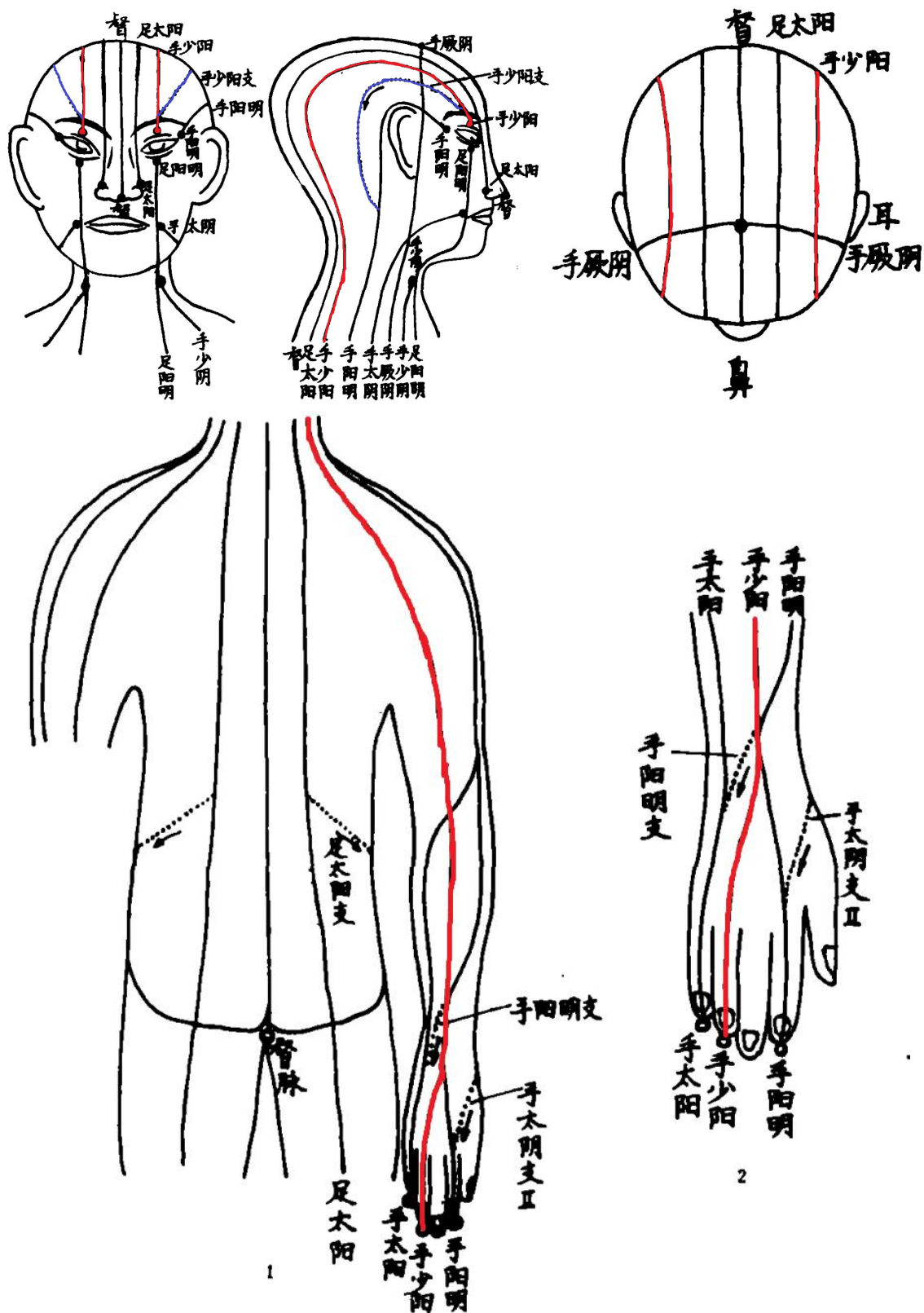


图 11 双包山木人手少阳脉循行路径

2.1.5.2 讨论

表 5 先秦两汉手少阳脉演变特点对比

	《足臂》	《阴阳》 (甲本)	《阴阳》 (乙本)	《阴阳》 (丙本)	《十二脉》	老官山 漆人	双包山 木人	《灵枢·经脉》
命名	臂少阳温	耳脉	耳脉	耳脉	手少阳脉	/	/	三焦手少阳之脉
起点	中指	手背	手背	手背	待考	中指端	目上中央	小指次指之端
止点	耳	耳中	耳中	耳中	待考	目锐眦	环指外端	目锐眦
流注方向	向心性	向心性	向心性	向心性	向心性	向心性	远心性	向心性
支脉	无	无	无	无	无	1 条	1 条	1 条
脏腑	无	无	无	无	待考	/	/	三焦、心包
官窍	耳	耳	耳	耳	待考	目	目	耳、目

经脉命名方面,《足臂》本脉尽管循行起点已经延伸至“中指”,但仍称为“臂少阳脉”,《阴阳》称为“耳脉”,是因此脉循行路径与主治病症均与耳相关,属于“身体部位+脉”命名方式的典型,《十二脉》目前公开的释文不全,其命名根据《揭秘》一书为“手少阳脉”,《灵枢·经脉》中加入脏腑的元素,称为“三焦手少阳之脉”。“三焦”这一概念出现时间较晚,与“心包”互为表里,“三焦”作为部位概念引入经脉循环理论中,与手厥阴脉的循行密切相关,笔者认为《灵枢·经脉》中“心主手厥阴心包络之脉”提及的“出属心包络,下膈,历络三焦”这一描述与主动脉的结构走行有很高的相似度,“出属心包络”像似主动脉弓,“下膈”像似胸主动脉穿过膈肌主动脉裂孔,“历络三焦”像似对胸主动脉、腹主动脉连通躯干上下的描述,此外,《灵枢·营卫生会》中对三焦位置已经有了确切的记载,上焦位置在“胃上口,并咽”,大概是在胸腔内的范围,中焦位置“并胃中,出上焦之后”,就是胃腑所居的范围,大致在上腹部,下焦位置在“别回肠,注于膀胱”,大致位于脐区与下腹部的范围,此处上、中、下三焦的位置也相当于是胸主动脉、腹主动脉所经过的范围,可能基于此类解剖实体结构的认识,《灵枢·经脉》篇的编者将手少阳脉冠以“三焦”,与“手厥阴心包络之脉”配为表里。此外,有学者

认为,“三焦”的前身是“三谷”(马王堆《十问》)^[1]“橐龠”(张家山《引书》)^[2],在“精气学说”的影响下,三焦本作为部位的概念,在《内经》中逐渐被赋予了“气化”的功能,而由于“三焦气化功能”这一认识更贴近中医学的思维方式,为秦汉时期的医学理论创新,故受秦汉医家所重视,这可能也是将三焦与手少阳脉建立联系的原因之一。

经脉循行路径方面,诸文献、文物手少阳脉均大致循行于上肢伸面中线,起止点的差异较大,《足臂》《阴阳》止点均在耳,但《足臂》起点在“中指”,《阴阳》起点在“手背”,《十二脉》由于释文公布较少,仅能看出是向心性流注,无法辨识起止点以及所联系的脏腑官窍。老官山漆人起点在中指端,与《足臂》相同,但止点在目锐眦,双包山木人循行方向经马继兴先生考证为远心性,故起点在于目上中央,而止点则在环指(小指次指)外端,值得注意的是,老官山漆人手少阳脉是从耳前上行,而双包山木人是从耳后下行,《灵枢·经脉》循行起点在小指次指之端,而止点在目锐眦。可见,在秦汉早期经脉文献中,手少阳脉与耳关系密切,《足臂》称“凑耳”,《阴阳》称“入耳中”,两具出土文物均是环绕耳周围,《灵枢·经脉》虽然止点在目,但是其循行“从耳后入耳中,出走耳前”,将“耳后”与“耳前”均顾及到。

《足臂》《阴阳》《十二脉》中手少阳脉与其他经脉无交叉,老官山漆人手少阳脉则在肩部交出手阳明脉之前,在颈部则又与手太阳脉的支脉2(图10侧面观中line 6-1)相交。双包山木人手少阳脉主干在头顶与手厥阴脉相交,在上肢先后与手太阳脉、手阳明脉交叉,此外在侧头部,手少阳脉分支与手厥阴脉相交,并且绕耳后汇入手阳明脉。《灵枢·经脉》虽两次提及“其支者”,实指手少阳脉主干,笔者认为仅“系耳后直上,出耳上角,以屈下颊至頄”这一循行路径属于支脉。老官山漆人与双包山木人手少阳脉也各有一条支脉,且均位于头面部,老官山漆人支脉从耳前发出后,交汇于唇下方(图10侧面观中line 5-1),并在唇下方与足阳明脉相交,双包山木人手少阳脉分支从眉毛中央发出后,在耳后下方汇入手阳明脉。与脏腑的联系方面,出土文献中均未提及,《灵枢·经脉》提及三焦与心包。与官窍联系方面,出土文献均与耳相关,而两具文物均与目相关,《灵

^[1] 孙玉龙. 三焦名实考[J]. 北京中医药大学学报, 2008(03): 153-157+161.

^[2] 卫杨. 三焦气化理论研究[D]. 广州中医药大学, 2017: 17.

枢·经脉》则与耳、目皆有联系。可以看出，足少阳脉在秦汉时期主要与耳相关，也是《阴阳》命名为“耳脉”最主要的原因。

在经脉主治病症方面，《足臂》主治“聋”“颊痛”，其中“聋”与经脉循行“凑耳”相关，“颊痛”与循行路径是否相关，仅从《足臂》简短的文字记载中是无法考察的，《灵枢·经脉》记载手少阳脉循行支脉“以屈下颊至頄”，老官山漆人也由支脉联系颊。《阴阳》手少阳脉主治病症主要有“耳聋”“咽肿”“目外眦痛”“颊痛”，其中“咽肿”“目外眦痛”这两个病症部位，直到老官山漆人以及《灵枢·经脉》中才逐渐建立了联系，可见病症描述在前，经脉联系在后，符合“病症所在，经脉所及”的演变规律。老官山《经脉》残简中手少阳脉“所生病”，提到了目外、耳后、中指、喉等部位的病症。尤其是“耳后”这一部位与老官山漆人循行“耳前”不一致，提示秦汉时期经脉理论的多样性，尤其是在经脉循行的起止端部位，可能存在多种经脉理论体系。《灵枢·经脉》除耳目等五官病症外，还增加了经脉循行所过的痛症“耳后肩髃肘臂外皆痛”以及“小指次指不用”等病症。

2.1.6 手太阳脉

2.1.6.1 出土文献、文物手太阳脉考订

马王堆《足臂十一脉灸经》

臂泰（太）陽溫（脈）：出小指，循骨下廉（廉），出臑下廉（廉），出肩外廉（廉），出項，【□】目。其【病】：外漬（背）痛，【□】臂外廉（廉）痛。諸病此物者，皆久（灸）臂泰（太）陽溫（脈）。

马王堆《阴阳十一脉灸经》（甲本）

肩脈（脈）：起於耳後，下肩，出臑外【廉】，出【臂外】肱（腕）【上】，乘手北（背）。是【動則病：領（領）腫痛】，不可以顧，肩以（似）脫，臑以（似）折，是肩脈（脈）主治。【其所產病】：領（領）痛，【喉踝<蹠一痺>，臂痛，肘外】痛（痛），為四病。

马王堆《阴阳十一脉灸经》（乙本）

肩肱（脈）【•起於耳後，下肩，出臑】外廉，出臂外，出指上廉。【是動則病：嗑痛，領（領）】腫（腫）肅（痛），不可以顧，肩以（似）脫，臑以（似）折，是肩【脈】主治。其所產病：領（領）肅（痛），侯（喉）湮（痺），臂肅（痛），肘肅（痛），為四病。

张家山《脉书》载《阴阳十一脉灸经》（丙本）

• 肩脈，起於耳後，下肩，出肘內廉，出臂外館（腕）上，乘手北（背）。是動（動）則病：領<領—領>種（腫）痛，不可以顧，肩以（似）脫，臑以（似）折，是肩脈主治。其所產病：領<領—領>痛，喉（喉）踝<蹠>，肩痛，肘外痛，為四病。

老官山《十二脉》^[1]

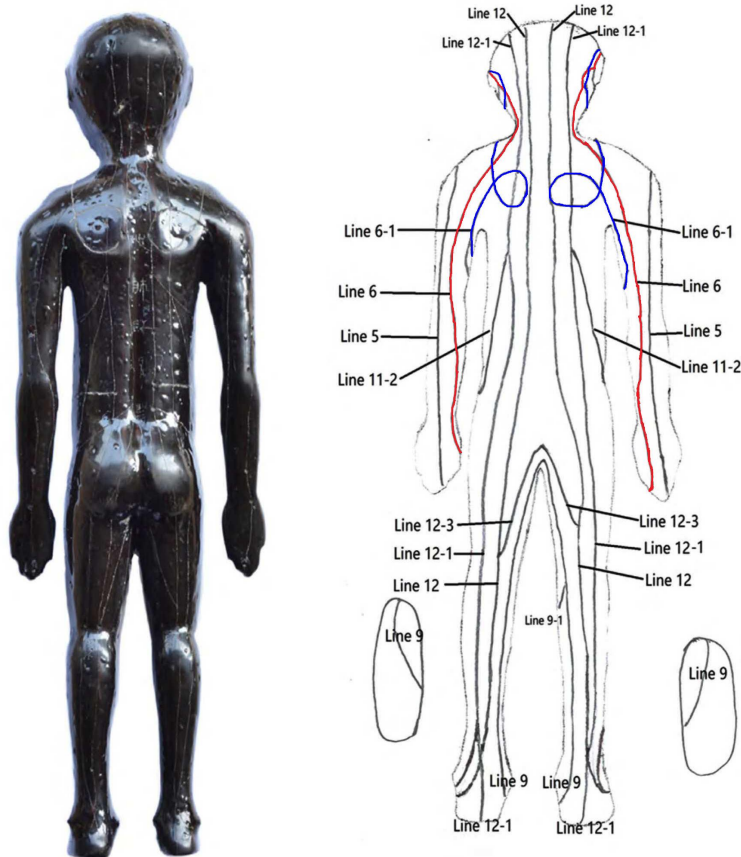
^[1] 黄龙祥. 老官山出土汉简脉书简解读[J]. 中国针灸, 2018, 38(01): 97-108.

• 手大（太）陽脈，穀（繫）小指，循臂骨下廉，出肘內廉。出臑下廉，上肩，循頸出耳后，屬目外眦（眦）。治所生病^[1]：領腫（腫），痛戾（喉）。

残简 471：貞痛，臑痛，肩□，臑痛，肘痛，頸痛，辟（臂）外痛，手背痛。

老官山漆人手太阳脉

包括一条主干和两条分支，主干（图 12 中红色线）起于“小指外侧”，循行经过掌背、腕背尺侧，再沿着上肢伸面内侧缘向上，经过肩胛区、后项部，从耳后绕耳到达目外眦；支脉 1（图 12 中蓝色线）左侧起自腋下，右侧大致起于上臂正中，而后两侧均在肩胛区环绕一圈后，上肩，绕耳后到达目外眦；支脉 2（图 12 侧面观中黄色线）从侧颈部发出，止于喉两侧^[2]。



^[1] 此处原整理小组读作“属目外眦（眦）溜，所主病”，黄龙祥先生核查图版之后认为应改作“属目外眦（眦）。治所生病”，于文意更通，可从。

^[2] 张迪，周兴兰，曾芳，等. 成都老官山汉墓出土髹漆经穴人像手太阳小肠经循行研究[J]. 中医杂志, 2019, 60(08): 636-639.

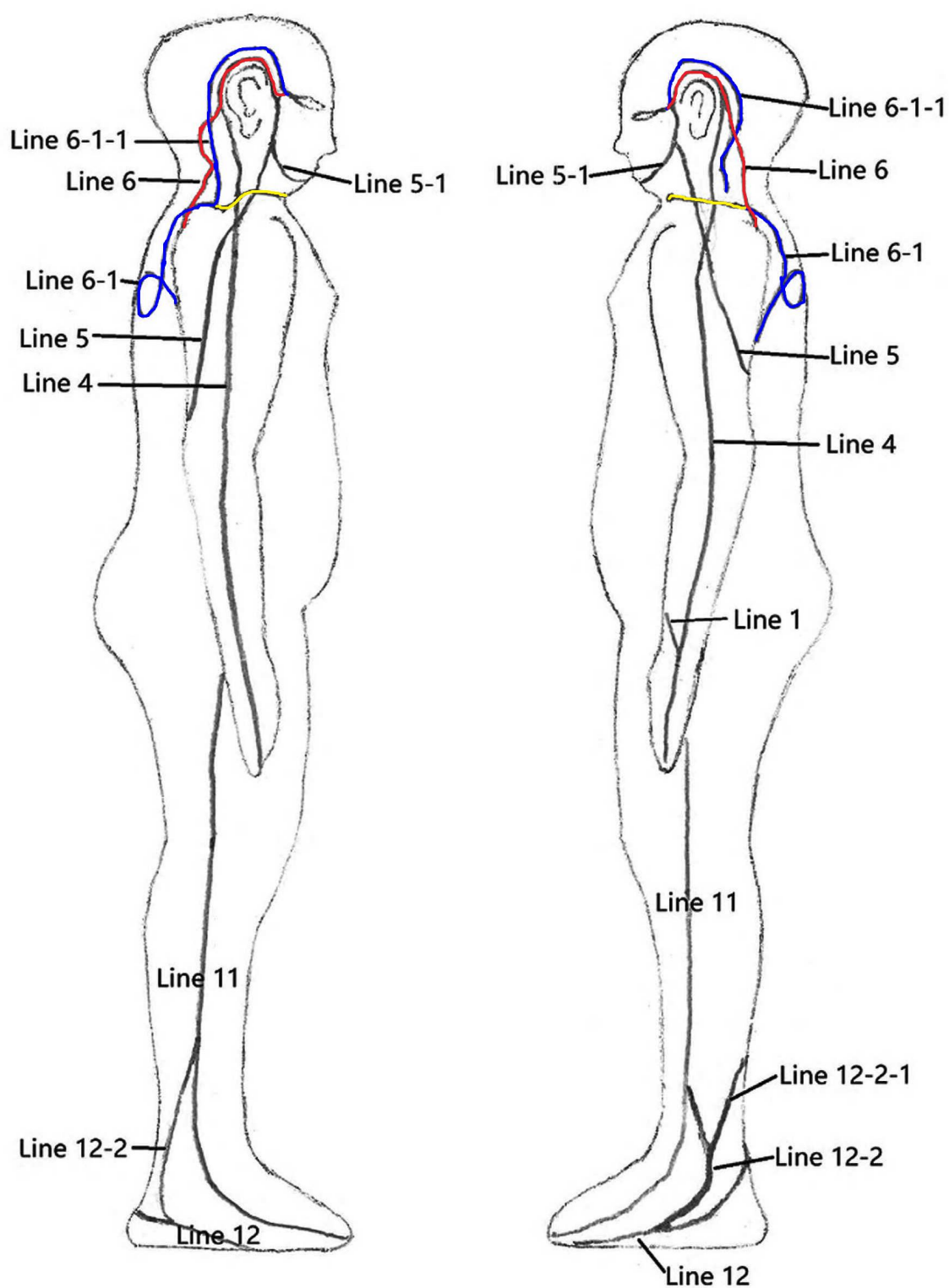


图 12 老官山漆人手太阳脉循行路径（背面观、侧面观）

双包山木人手太阳脉

循行路径只有一条主干，没有支脉，主干（图 13 中红色线）起点在上臂伸面靠近肘关节处，起点正好位于手阳明脉循行路径上，而后向内下方走行，与手少阳脉交叉后，沿着上肢伸面内侧缘向下走行，在靠近腕关节处接受来自手阳明脉的分支，最后沿着手背、小指背，到达小指端^[1]。

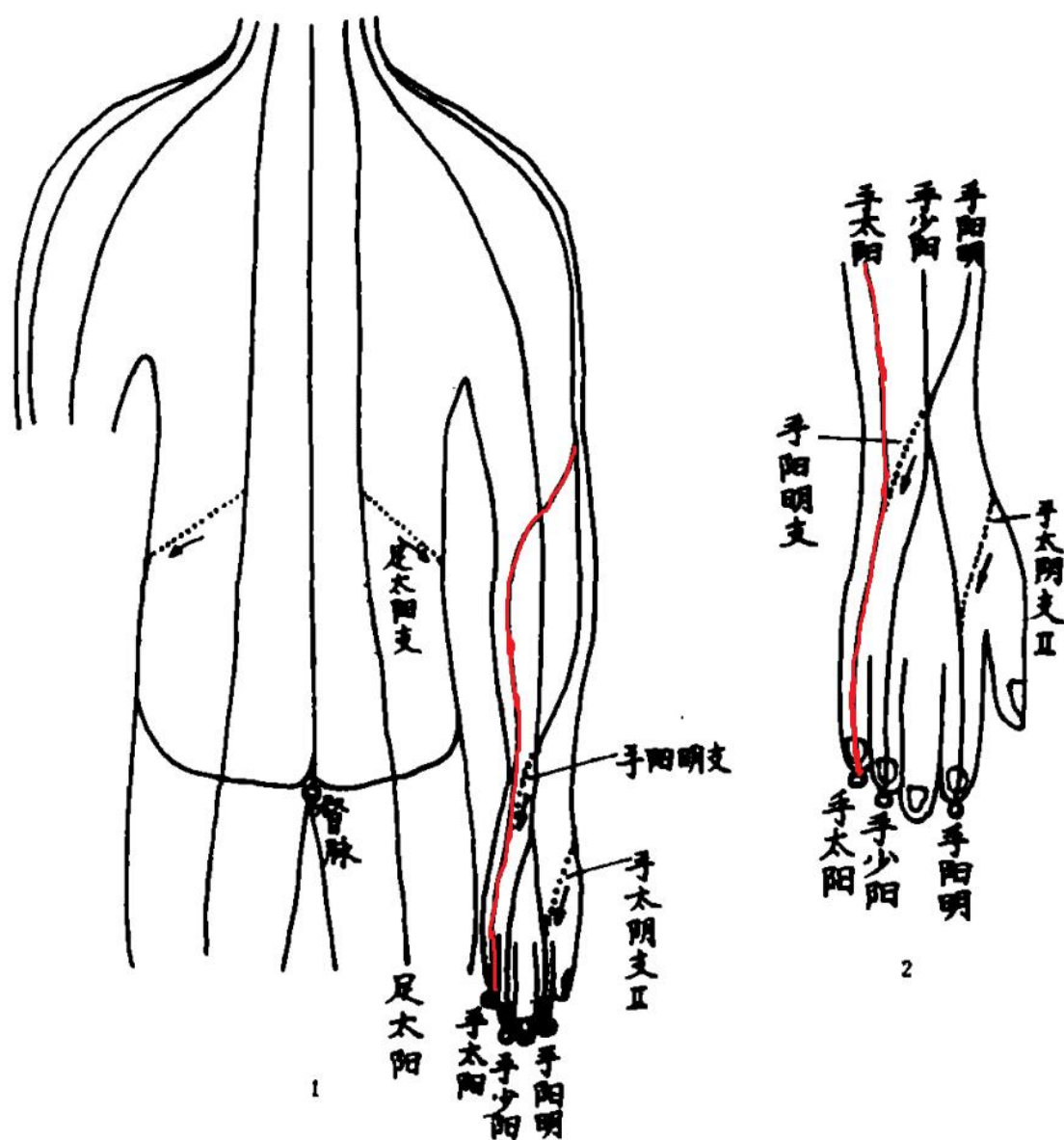


图 13 双包山木人手太阳脉循行路径

^[1] 马继兴. 双包山汉墓出土的针灸经脉漆木人形[J]. 文物, 1996 (04): 55-65+98.

2.1.6.2 讨论

表 6 先秦两汉手太阳脉演变特点对比

	《足臂》	《阴阳》 甲本	《阴阳》 乙本	《阴阳》 丙本	《十二 脉》	老官山 漆人	双包山 木人	《灵枢·经脉》
命名	臂泰陽溫	肩脈	肩胛	肩脈	手太陽脈	/	/	小腸手太陽之脈
起点	小指	耳后	耳后	耳后	小指	小指外侧	肱部下方	小指之端
止点	目	手背	指上廉	手背	目外眦	目外眦	小指外端	目内眦
流向	向心性	远心性	远心性	远心性	向心性	向心性	远心性	向心性
支脉	无	无	无	无	无	2条	无	1条
脏腑	无	无	无	无	无	/	/	心、胃、小腸
官窍	目	无	无	无	目外眦	目、耳、喉	无	咽、耳、鼻、目

首先，诸文献对于手太阳脉的命名存在差异，尤其是《阴阳》称之为“肩脉”，明显不同于其他文献，学者对于“肩脉”“耳脉”“齿脉”这种特殊的经脉命名方式讨论较多，在某些问题上（比如这种命名方式属于早出还是晚出）得出了截然相反的认识，赵争先生认为“肩脉”这种直接以部位作为经脉名称的现象，是比三阴三阳更早的命名方式^[1]；何宗禹先生则认为“肩脉”“耳脉”“齿脉”并非原始的命名方式，而属后起，是对经脉的简称^[2]；李鼎先生认为这种命名方式产生的原因，只有从经脉的远道主治来理解^[3]；而顾植山先生则认为《阴阳》中除“肩脉”“耳脉”“齿脉”以外的八条脉是为了配合九宫八卦的需要^[4]；对此，李建民先生也认为《阴阳》脉名背后可能含有某种术数观念^[5]。老官山《十二脉》将此脉命名为“手太阳脉”，与《足臂》《阴阳》相比，突出了“手”，意为经脉循行起点在手，实际上《足臂》和《阴阳》（乙本）此脉循行中已经涉及到手指，为经脉命名的改变做出了铺垫，再到《灵枢·经脉》编者所处的时代，经脉与脏腑之间的关系越发“紧密”，经脉名称中又加入了脏腑元素，即“脏/腑+手/足+阴/阳+脉”的命名方式，将手太阳脉与小肠相联系，完全是出于经脉脏腑相合的目的，

^[1] 赵争. 古书成书与古书年代学问题探研——以出土古脉书《足臂十一脉灸经》和《阴阳十一脉灸经》为中心[J]. 中国典籍与文化, 2016(01): 7-12.

^[2] 何宗禹. 马王堆帛书《足臂十一脉灸经》有关的问题再探[J]. 中华医史杂志, 1984, 14(3): 172-175.

^[3] 李鼎. 针灸学释难（重修本）[M]. 上海: 上海中医药大学出版社, 2006: 49.

^[4] 顾植山. 六经探源[J]. 安徽中医学院学报, 1991(03): 2-5.

^[5] 李建民. 发现古脉——中国古典医学与术数身体观[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2007: 197.

在出土文献中，小肠与手太阳脉的循行毫无关系，在《灵枢·经脉》中，虽然手太阳脉的循行与小肠建立了联系，但是经脉主治病症仍与小肠无关，表明手太阳脉与小肠之间建立关系并非是来源于临床实践，可能仅是为建立经脉-脏腑相关的理论形式^[1]。此外，在经脉循行的描述上，老官山《十二脉》中的“出肘内廉”独与张家山《阴阳》（丙本）相同，故黄龙祥先生认为《阴阳》（丙本）应该是老官山《十二脉》的底本之一^[2]。

通过对诸文献、文物中手太阳脉的循行路线分析，可知双包山木人手太阳脉与手少阳脉主干、手阳明脉主干以及手阳明脉分支在上肢均有交叉汇合，而老官山漆人手太阳脉在耳后与手阳明脉相交叉汇合，两具出土文物均显示出手太阳脉与手阳明脉的关系密切，然《足臂》《阴阳》《十二脉》《灵枢·经脉》中均未提及手太阳脉与其他经脉的交叉汇合情况。可能是由于文本文献限于字数及表达方式所致，老官山漆人和双包山木人由于可以直接观察经脉的循行路径，所以循行部位以及与其他经脉的交汇情况较文字记载更为丰富。

在循行起止点方面，《足臂》《十二脉》、老官山漆人以及《灵枢·经脉》保持了一致性：即起点在小指，止点在目，通过对腧穴演变的梳理，我们发现早期经脉井穴多位于手指尖端，因此可以推断“出小指”“系小指”“起于小指之端”这样的描述，应该是起于小指尖端（并非甲根旁）。止点方面，《足臂》未提及是目内眦还是目外眦，《十二脉》与老官山漆人止点在于“目外眦”，《灵枢·经脉》止点在于“目内眦”，但是又通过支脉联系了“目锐眦”。《阴阳》三个版本起点均在耳后，终点则不同，甲本、丙本在“手背”，乙本在“指上廉”。笔者认为这一现象说明《阴阳》手太阳脉的内容较早形成，甲本、乙本虽然同属于马王堆汉墓，但甲本手太阳脉止点在手背，乙本却在指上廉，不仅说明同一时代存在不同的经脉学说（或是不同学派，或是同一学派不同发展阶段的学说），还说明秦汉时期医家对经脉学说在不断地补充完善。

在出土文献、文物中，只有老官山漆人手太阳脉有支脉，其中，支脉1与《灵枢·经脉》中的“出肩解，绕肩胛，交肩上”相似，但是不同之处在于老官山漆人“绕肩胛”之后又上行绕耳到达“目锐眦”，《灵枢·经脉》却绕过肩部，到

^[1] 赵京生. 针灸经典理论阐释[M]. 上海: 上海中医药大学出版社, 2000: 33.

^[2] 黄龙祥. 老官山出土汉简脉书简解读[J]. 中国针灸, 2018, 38(01): 97-108.

达缺盆后进入体内，与心、胃、小肠等脏腑相联系。手太阳脉从颈到目外眦之间这一段的循行路径，秦汉时期有两种不同的处理方法，目前所见出土文献、文物中均从耳后上行，而《灵枢·经脉》则从耳前上行，对于这一问题，黄龙祥先生在其著作《经脉理论还原与重构大纲》中已有详细论述。值得注意的是，《灵枢·经筋》中记载手太阳经筋的循行路线与老官山漆人手太阳脉的体表循行有很高的重合度，提示《灵枢·经筋》可能要比《灵枢·经脉》更加贴近出土文献文物所在时代（即秦汉早期）的经脉学说。

在手太阳脉主治病症方面，可考察的文献包括《足臂》《阴阳》《十二脉》《灵枢·经脉》，其中《足臂》主治病症为“外眦痛，臂外廉痛”，均属于经脉循行所过的痛症，《阴阳》主治病症分为“是动则病”与“其所产病”两部分，即：“是动则病：颌肿痛，不可以顾，肩似脱，臑似折……其所产病：颌痛，喉痹，臂痛，肘外痛。”可见，《足臂》与《阴阳》主治病症重合者只有“臂外廉痛”，《阴阳》比较特殊之处在于其循行起点位于“耳后”，但是主治病症中并未出现耳部的病症，《阴阳》将其称为“肩脉”，可能是秦汉早期医家认为此脉与肩部病症的关系密切，即特征性的症状“肩似脱，臑似折”，老官山《十二脉》手太阳脉主治病症为“颌肿，痛喉”，均见于《阴阳》中，表明了《十二脉》与《阴阳》之间的关系密切。《灵枢·经脉》手太阳脉主治病症也分为“是动则病”与“（主液）所生病”两大类，与《阴阳》主治病症有很高的相似性，说明《灵枢·经脉》篇的作者参考了帛书《阴阳》，《灵枢·经脉》手太阳脉“所生病”可以分为头面五官病症“耳聋，目黄，颊肿”，以及循经所过的痛症“颌肩臑肘臂外后廉痛”两个方面。其中，《灵枢·经脉》中新增加了“耳聋”这一症状，《内经》其他篇章中也提及耳聋与手太阳脉相关，如《素问·厥论》：“手太阳厥逆，耳聋，泣出。”赵京生先生认为可能是同名经脉（即足太阳脉）病症移植所致^[1]。

^[1] 赵京生. 阳经五官病候及治疗用穴分析——兼论经脉病候与腧穴主治关系[J]. 针刺研究, 2007(06): 411-418.

2.1.7 足太阴脉

2.1.7.1 出土文献、文物足太阴脉考订

马王堆《足臂十一脉灸经》

足泰（太）陰^[1]溫（脈）：出大指內兼（廉）骨蔡（際），出內踝上兼（廉），
 揠肱內【兼（廉），上】韜（膝）內兼（廉），出股內兼（廉）。其病_二（病：病）
 足大指廢，肱內兼（廉）痛，股內痛，腹痛，腹張（脹），復【□】，不耆（嗜）
 食，善意（噫），心_二煩_一，善肘（疔^[2]）。諸病此物者，皆久（灸）足泰（太）陰溫
 （脈）。

马王堆《阴阳十一脉灸经》（甲本）

鉅陰脈（脈）：是胃脈（脈）毆。彼（被）胃，下出魚股陰下廉，膕上廉，
 出內踝之上廉。是動（動）則病：上【當】走心，使復（腹）張（脹），善噫，
 食【則】欲歐（嘔），得後與氣則怏然衰，是鉅陰脈（脈）主治。其所【產病】：
 獨心煩，死；心痛（痛）與復（腹）張（脹），死；不能食，不○臥，強吹（欠），
 三者同則死；唐（澹）泄，死；【水與】閉同則死，為十病。

马王堆《阴阳十一脉灸经》（乙本）

【巨（鉅）陰】肱（脈）：是胃（胃）肱（脈）也。被胃，【下】出魚股陰
 下廉，膕上廉，出內果（踝）之上廉。是動（動）則病：上當走心，使腹張（脹），
 善意（噫），食則欲歐（嘔），得【後】牙（與）氣則逢_二遊_一怏然衰，是巨（鉅）
 陰【肱（脈）】主治。其所產病：獨心煩，死；心痛（痛）牙（與）腹張（脹），
 死；不【能】食，不臥，強吹（欠），三者同則死；唐（澹）泄，死；水牙（與）
 閉同則死，為十病。

张家山《脉书》载《阴阳十一脉灸经》（丙本）

^[1] 原释文识作“足泰（太）陽溫（脈）”，此处“陽”应该写作“陰”，应该是整理小组最初发表时排版印刷失误。

^[2] 《說文》“疔，小腹病。”《玉篇·疔部》“疔，心腹疾也。”

• 泰陰之脈，是胃脈毆，被胃下，出魚股之陰下廉，腓上廉，出內踝之上廉。是動（動）則病：上走心，使腹張（脹），□□□□□□□□□□**怏然衰**，是泰陰之脈主治。其所產**病**：獨心煩死；**心痛與**腹張死；不能食，者<耆>臥，強立<欠>，此三者同則死；唐（塘）泄死；水與閉同則死，為十病。

老官山《十二脉》

足大（太）陰脈：毆（繫）大指，循足（跗）內廉，【出內】果（踝）□廉，循胛骨內廉，出膝內廉，【循股】內廉，而上入腹【屬】腸胃，系【咽】^[1]。

老官山《经脉》残简

煩也=（心，心）**痛**，□□**洩**，水闭，黄**瘁**，股□□□□□**種**（肿）**癢**，不卧，强欠，大指**不用**□□^[2]。

老官山漆人足太阴脉

2016 年学位论文^[3]中公布足太阴脉仅有一条主干（图 14 中红色线），起点位于“足大指内侧”，循行路径首先经过足内廉、内踝前，再沿着下肢内侧向上，穿过腹股沟（靠近前阴处），止点在脐。在循行过程中，与足厥阴脉相交，其中左侧相交处靠近脚踝，右侧相交处靠近膝关节。

整理人员还提到，老官山漆人足太阴脉左侧（正面）大腿根部发出一条分支，交于足阳明脉，且认为与《灵枢·经别》中足太阴经别的循行路径“上至髀，合于阳明”有关，但由于图片资料中的正面照较为模糊，笔者未能识出此条分支，还待更清晰的局部照片公布。

^[1] 黄龙祥. 老官山出土汉简脉书简解读[J]. 中国针灸, 2018, 38(01): 97-108.

^[2] 顾漫, 周琦, 柳长华, 等. 天回医简《经脉》残篇与《灵枢·经脉》的渊源[J]. 中国针灸, 2019, 39(10): 1117-1123.

^[3] 邱科. 老官山汉墓经穴髹漆人像六阴经循行特点研究[D]. 成都中医药大学, 2016.

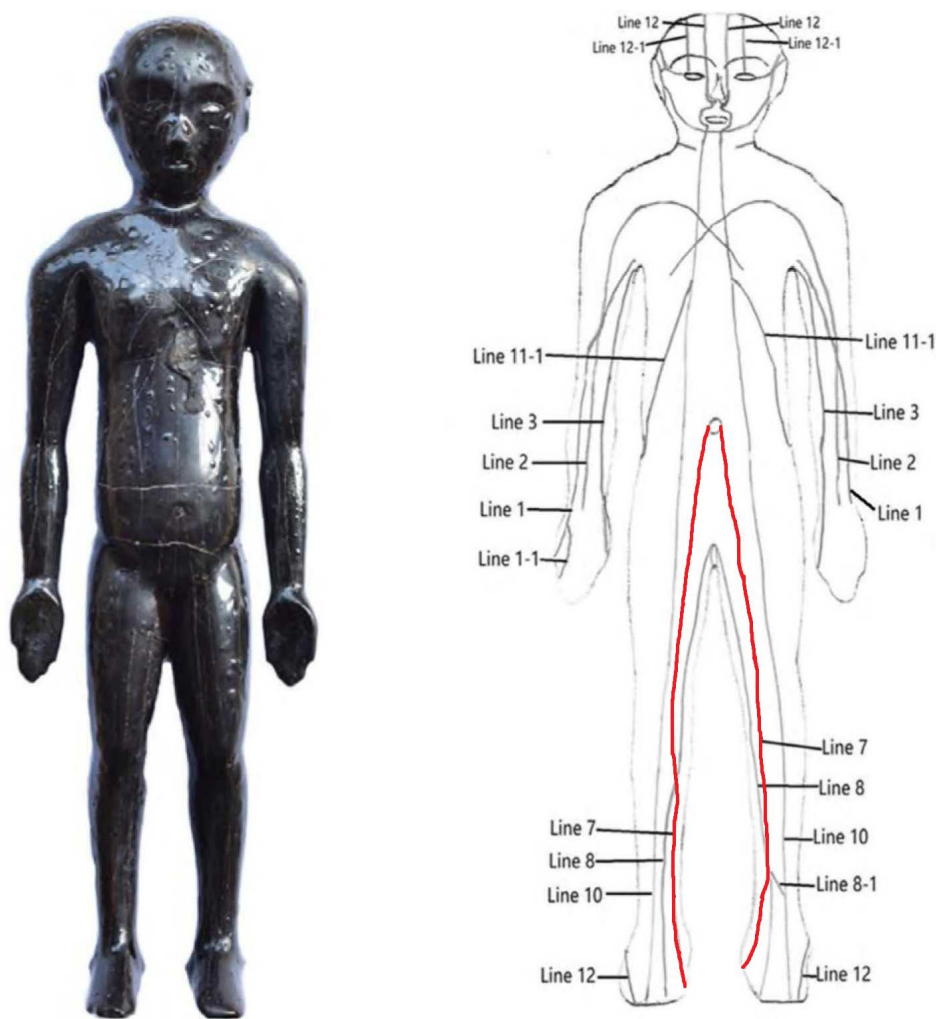


图 14 老官山漆人足太阴脉循行路径

2.1.7.2 讨论

表 7 先秦两汉足太阴脉演变特点对比

	《足臂》	《阴阳》 (甲本)	《阴阳》 (乙本)	《阴阳》 (丙本)	《十二 脉》	老官山 漆人	双包山 木人	《灵枢· 经脉》
命名	足泰陰溫	鉅陰脈	巨陰跗	泰陰之脈	足大陰脈	/	/	脾足太陰之 脉
起点	大指内廉	胃	胃	胃	大指	足大趾 内侧	无此脉	大指之端
止点	股内廉	内踝上廉	内踝上廉	内踝上廉	咽	脐	/	舌
流注方向	向心性	远心性	远心性	远心性	向心性	向心性	/	向心性
支脉	无	无	无	无	无	1条(待 考)	/	1条
脏腑	无	胃	胃	胃	肠胃	/	/	脾、胃、心
官窍	无	无	无	无	咽	无	/	舌

经脉命名方面,《足臂》《阴阳》两者之间最大的差异在于有无“足”字,《足臂》可能是为反映先足脉后臂脉的行文顺序及严谨性,故添加“足”字,而《阴阳》经脉命名则保留了早期经脉名称的多样化,《阴阳》在描述足太阴脉的循行时,开头就提到“是胃脉也”(也可能是一种注文)，“胃脉”与手三阳脉的别称“肩脉”“耳脉”“齿脉”命名方式类似,但“肩脉”“耳脉”“齿脉”为“身体部位+脉”的命名方式,“胃脉”较为特殊,是“脏/腑+脉”的命名方式,且这种方式只出现了“胃脉”这一处,推测秦汉早期还可能会存在其他“脏/腑+脉”的经脉命名方式,如“肾脉”“胆脉”“肺脉”之类,《内经》中还有“厥阴者,肝脉也”(《灵枢·经脉》)“脾脉者,土也”(《素问·玉机真脏论》)“故宗气积于胸中,出于喉咙,以贯心脉”(《灵枢·邪客》)等这种命名方式的遗存。

在经脉循行路径方面,马王堆帛书《足臂》《阴阳》足太阴脉之间最大的区别,其一在于流注方向相反,《足臂》十一脉均为向心性,《阴阳》肩脉与太阴脉则是远心性,其二是《足臂》足太阴脉循行只到“股内廉”,但“其病”中已经包含有脾胃病变,如“腹胀”“不嗜食”等,赵争先生认为这种情况表明经脉主治病症与经脉脏腑之间通过循行路径进行联系的模式还未定型^[1],而《阴阳》足太阴脉与胃建立了联系,表示秦汉早期医家对足太阴脉治疗胃病认识较早,“胃”在早期医学体系中的位置较为重要,可能曾属于五脏之一,而后才被“脾”所取代^[2]。《十二脉》虽然是以《阴阳》为底本,但经脉循行方向与《足臂》一致为向心性,与脏腑的联系提及“属肠胃”。到《灵枢·经脉》中,足太阴脉除了与“脾胃”联系外,还联系“心”。老官山漆人足太阴脉与足厥阴脉相交,但相交的部位不同,左侧交腠下,右侧交腠中,此外《灵枢·经筋》中记载的足太阴经筋分布位置与老官山漆人足太阴脉的循行路径较为一致,但《灵枢·经筋》在“结于脐”之后还继续向上循行与“腹里”“肋”“脊”联系,《十二脉》足太阴脉“上入腹属肠胃”以及《灵枢·经脉》中“入腹属脾络胃,上膈,挟咽,连舌本,散舌下;其支者,复从胃,别上膈,注心中”均无法在漆人模型上刻画,所以漆人止点虽在脐,但并不代表未与体内器官相联系。

在联系官窍方面,《灵枢·经脉》提到咽与舌,其中“咽”只是经脉循行所过,

^[1] 赵争. 古脉书《足臂十一脉灸经》与《阴阳十一脉灸经》相对年代问题考论[J]. 出土文献, 2015(02): 193-215.

^[2] 黄龙祥. 扁鹊医籍辨佚与拼接[J]. 中华医史杂志, 2015, 45(01): 33-43.

并且“是动病”“所生病”中未见与咽有关的病症,《灵枢·经脉》中足太阴脉主治病症与舌相关。此外老官山《十二脉》中公布的释文仅涉及足太阴脉的循行,其“系咽”中的“咽”字是整理小组释读时所补入,黄龙祥先生也提及在所有出土文献中不见足太阴脉与“咽”相关,并且老官山漆人也与“咽”无联系,因此“不详整理小组据何补咽字”^[1]。但有学者根据《神农本草经》中麦门冬主治病症“胃络脉绝”一语,并且系统考察出土文献后,认为麦门冬可通过“胃络”而针对治疗咽嗑症状^[2],仲景在《金匱要略》中用麦门冬汤治疗“火逆上气,咽喉不利”,《素问·热论》中也提及“太阴脉布胃中,络于嗑”,种种记载提示足太阴脉与咽喉之间有联系,可能《神农本草经》中的“胃络”就是《素问·热论》中的“太阴脉布胃中,络于嗑”。

在经脉分支方面,出土文献、文物中足太阴脉未见有分支,《灵枢·经脉》中有一条分支“其支者,复从胃,别上膈,注心中”,主要与“心”建立联系,《足臂》《阴阳》主治病症中已与心关联,《足臂》提及“心烦”,《阴阳》提及“上当走心”,这可能是《灵枢·经脉》专门设立一条分支“注心中”的原因。

在经脉病症演变方面,我们知道,《灵枢·经脉》中各经脉主治病症一般是参考《足臂》《阴阳》整理而成^[3],《足臂》《阴阳》代表秦汉早期医家经验,《灵枢·经脉》代表秦汉后期医家的认识。笔者分析《足臂》中足太阴脉的主治病症,认为可以分为两组,其中第一组是经脉循行所过部位的痛症“病足大指废,脘内兼(廉)痛,股内痛,腹痛”,而第二组主要是脏腑的病症“腹胀(胀),复【口】,不耆(嗜)食,善意(噫),心【烦】,善肘”。《阴阳》足太阴脉的主治病症主要分为“是动则病”与“其所产病”两类,其中“是动则病”与《足臂》的第二组病症有重合之处,并增加了“上当走心”与“食则欲呕,得后与气则快然衰”,实际上也是属于脏腑病变,“其所产病”的内容较为特殊,讲述了五组“死”症,与之类似的还有足厥阴脉的“所生病”以及《足臂》足三阴脉后论述脉死候的内容,赵争先生对这些内容文本结构进行相互对比分析之后,认为与其相对成书年代的关

^[1] 黄龙祥. 老官山出土汉简脉书简解读[J]. 中国针灸, 2018, 38(01): 97-108.

^[2] 俞海跃, 郑文江, 李卓明. 以出土文献视角考证《神农本草经》“胃络脉绝”[J]. 中医药导报, 2021, 27(11): 201-203+210.

^[3] 黄龙祥. 中国针灸学术史大纲[M]. 北京: 华夏出版社, 2001: 368.

系较为密切^[1]。《灵枢·经脉》中足太阴脉的主治病症分为“是动则病”和“所生病”两种，其中“是动则病”明显与帛书《阴阳》相似，增加了“舌本强”与“身体皆重”，“所生病”情况则较为复杂，其中“食不下，烦心……股膝内肿厥，足大指不用”已见于《足臂》，只是文字表述上稍有差异，此外“烦心，心下急痛，溏、瘕、泄、水闭、黄疸，不能卧”均来自于《阴阳》的五组死症，但已经有所改动，如“心痛”改为“心下急痛”，“强欠”改为“强立”等等^[2]，老官山《经脉》残简中所记载的足太阴脉主治病症，与《灵枢·经脉》重合度较高，提示两者之间可能存在某种渊源关系。

^[1] 赵争. 古书成书与古书年代学问题探研——以出土古脉书《足臂十一脉灸经》和《阴阳十一脉灸经》为中心[J]. 中国典籍与文化, 2016(01): 7-12.

^[2] 王宝华, 赵京生. 足太阴经“所生病”辨析[J]. 中国针灸, 2011, 31(08): 761-763.

2.1.8 足厥阴脉

2.1.8.1 出土文献、文物足厥阴脉考订

马王堆《足臂十一脉灸经》

足蕞（厥）陰溫（脈）：循大指間（間），以上出肱內廉（廉），上八寸，交泰（太）陰溫（脈），□股內，上入脛間（間）。其病_二（病：病）脛瘦，多弱（溺），耆（嗜）飲（飲），足跗（跗）種（腫），疾畀（痹）。諸病此物者，【久（灸）】蕞（厥）陰溫（脈）。

马王堆《阴阳十一脉灸经》（甲本）

蹇（蹇—厥）陰脈（脈）：繫（繫）於足大指菴（叢）毛之上，乘足【跗上廉】，去內踝（踝）一寸，上踝（踝）五寸而【出太陰之後】，上出魚股內廉，觸少腹，夾憤^[1]旁。是動（動）則【病：丈】夫則【癰山（疝）】，婦人則少腹腫，要（腰）痛【其】不可以印＜印—仰＞，甚則噎乾，面疵，是蹇（蹇—厥）陰脈（脈）主治。【其】所產病：熱中，【癰，癰，偏疝，為五_二病_二（五病。五病）】有而心煩，死，勿治_毆（毆）。有陽脈（脈）與之俱病，可治_毆（毆）。

马王堆《阴阳十一脉灸经》（乙本）

厥陰跗（脈）：繫（繫）于足大指菴（叢）毛上，乘足_跗（跗）上廉，去內踝（踝）一寸，上踝（踝）五寸【而】出于大（太）陰【之】後，上出魚股內廉，_觸（觸）少腹，大資（背）旁。是動（動）則病：丈夫則_癰（癰）山（疝），婦人則少腹腫（腫），_要（要—腰）_痛（痛）不可以印（仰），甚則噎乾，面疵，是厥陰之跗（脈）主治。其所產病：熱中，降（癰），_癰（癰），_偏（偏）山（疝），【為五_二病_二（五病。五病）病有【而】煩心，死，勿治也；有陽_跗（脈）牙（與）【之】俱病，可治也。

张家山《脉书》载《阴阳十一脉灸经》（丙本）

^[1] 原释文写作：大潰（眈），黄龙祥先生反复核查原图版之后，认为应写作“夹愤”，笔者亦以为是。

老官山《十二脉》

老官山《经脉》残简

老官山漆人足厥阴脉

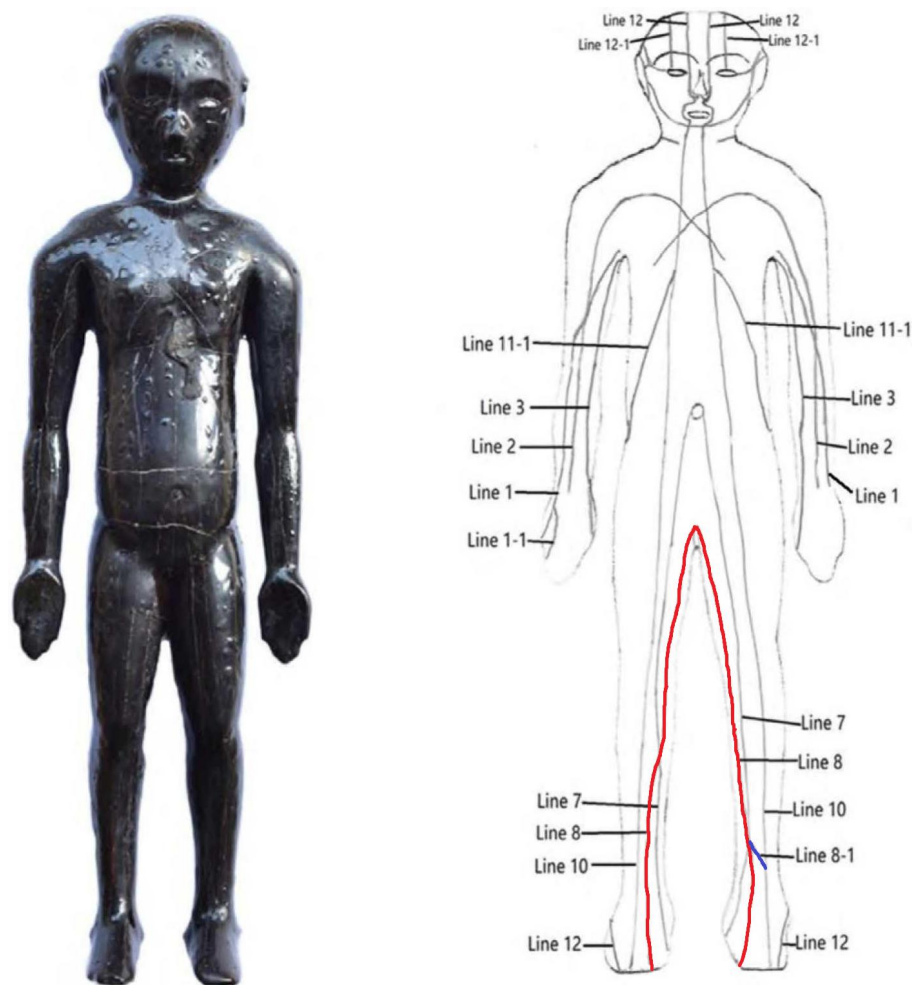


图 15 老官山漆人足厥阴脉循行路径

2.1.8.2 讨论

表 8 先秦两汉足厥阴脉演变特点对比

	《足臂》	《阴阳》 (甲本)	《阴阳》 (乙本)	《阴阳》 (丙本)	《十二 脉》	老官山 漆人	双包山 木人	《灵枢·经脉》
命名	足蕤陰温	蕤陰脈	厥陰𦵏	蕤陰之脈	蹶陰脉	/	/	肝足厥阴之脉
起点	大指間	足大指叢 毛之上	足大指叢 毛上	足大指叢 毛之上	足大指丛 毛上	足大趾外 间	无此脉	大指丛毛之际
止点	脛間	夹犢旁	大資旁 (?)	夾紉旁	齐(脐)	阴器	/	巅
流注方向	向心性	向心性	向心性	向心性	向心性	向心性	/	向心性
支脉	无	无	无	无	无	1 条	/	2 条
脏腑	无	无	无	无	无	/	/	胃、肝、胆、肺
官窍	无	前阴	前阴	前阴	前阴	前阴	/	前阴、喉咙、頄 頄、目、唇

诸文献、文物足厥阴脉均循行于下肢内侧，且均为向心性流注，其差异之处主要在于起止点，其起点均与足大趾相关，《足臂》作“大指间”，而《十二脉》作“足大趾外间”，指向更为明确，《阴阳》作“足大指丛毛之上”被《灵枢·经脉》所承载，为“大指丛毛之际”（即大敦穴），位于足大趾背部生毛处（今奇穴三毛穴所在）。《足臂》足厥阴脉止点在“脛间”，刘春语先生认为“脛”的部位，大致位于前阴之上至小腹之间腹腔部位^[1]。《阴阳》（甲本）足厥阴脉止点原作“大渍（眦）旁”，黄龙祥先生考察后认为应作“夹幘旁”，可从。那么《阴阳》（乙本）原释作“大資旁”，也应改为“夹幘旁”，《阴阳》（丙本）作“夹紕”，《十二脉》作“夹佩”，均是对前阴部的婉称，故《阴阳》足厥阴脉止点在前阴部。老官山漆人足厥阴脉止点在阴器，说明秦汉早期医家认为足厥阴脉与阴器之间有紧密的关联，足厥阴脉止于前阴，《灵枢·经筋》记载足厥阴经筋无论循行还是主治病症，均与前阴相关，如循行路径“结于阴器”，当足厥阴经筋病变时，出现“阴器不用”，以及由于寒热病邪导致的“阴缩入”“纵挺不收”等。《灵枢·经脉》记载“足厥阴之别”的循行与主病也与前阴相关，其循行路径有“径脛上臑，结于茎”，病症为“臑肿卒疝”。

《足臂》《阴阳》《十二脉》足厥阴脉均无分支，老官山漆人记载有一条分支，但仅见于左侧足厥阴脉（图15中line 8-1），与足阳明脉相联系。《灵枢·经脉》中记载有两条分支，分别是“从目系下颊里，环唇内”“复从肝别贯膈，上注肺”，这两条分支均是为构建十二经脉环形流注体系而设。在脏腑官窍的联系方面，出土文献、文物中足厥阴脉均与前阴有联系，此外，足厥阴脉气“终绝”还可以出现“舌卷卵上缩”（《灵枢·终始》）“腹胀泾溲不利……阴缩肿”（《素问·厥论》）等本经特征性病变^[2]，《灵枢·经脉》中足厥阴脉与胃、肝、胆、肺、前阴、喉咙、颧颞、目、唇均有联系。

在足厥阴脉病症演变方面，《足臂》主治病症为“脛瘦，多溺，嗜饮，足跗肿，疾痹”，其中“脛瘦，多溺，嗜饮”是典型的消渴病的表现^[3]。《阴阳》“是动则病”

^[1] 刘春语. 汉简帛医书十三种字词集释[D]. 西南大学, 2016.

^[2] 李晓彤, 何丽云, 付璐, 等. 浅析秦汉时期足厥阴经的形成及早期演变[J]. 中华中医药杂志, 2021, 36(03): 1567-1570.

^[3] 赵京生, 王为群. 足厥阴经与消渴[J]. 中国针灸, 2002(09): 60-62.

与“其所产病”描述的均是“阴疝”的症状,《说文解字》:“疝,腹痛也。”^[1]秦汉早期用“疝”来代指腹部疼痛,《内经》中多处描述了“疝”的症状,如“病在少腹,腹痛不得大小便”(《素问·长刺节论》)^[2]“腰尻痛,不可以俯仰”(《灵枢·本脏》)^[3]“小腹痛,下为卵痛,其圆直为茎痛”(《灵枢·五色》)^[4],之所以将“疝”的典型症状与足厥阴脉相关联,是与太冲穴诊疗经验的积累相关^[5]。此外,《阴阳》足厥阴脉“其所产病”中有“热中”,“中”是指肠胃,有学者对《史记》中仓公所诊的四个关于“中热”的医案进行专门研究,认为出土文献记载的“热中”与传世文献记载的“中热”,均可以伴见“溺赤”“不洩”等症^[6],早期足厥阴脉由于经脉循行的关系与小便病症联系密切,后来在脏腑理论的影响下,肾、膀胱与小便的关系密切,在治疗小便病症时便选取足少阴脉、足太阳脉,如“内闭不得洩,刺足少阴、太阳与骶上以长针”(《灵枢·癫狂》),小便病症的经脉归属,体现了经脉辨证与脏腑辨证之间的错杂并存及转换^[7]。《灵枢·经脉》足厥阴脉主治病症与《阴阳》相似度较高,但是增加了“胸满”“呕逆”“飧泻”,新增的这些病症可能与脏腑理论的影响有关^[8],此外,老官山《经脉》残简中“癰,遺溺”对应《灵枢·经脉》足厥阴脉“所生病”中的“遺溺”“闭癰”,老官山《经脉》残简中提到的“凡十一病”,正好是《灵枢·经脉》中足厥阴脉的病症数量,这一巧合提示《灵枢·经脉》成篇的时间可能更早,或者《灵枢·经脉》中的主治病症是转抄自某本早期的经脉典籍。

现代学者对足厥阴脉与肝之间的联系,也提出了很多有价值的认识,尤其是认为在秦汉时期经脉-脏腑相关学说影响下,衍生出来的某些症状不应该属于经络辨证的依据,如肝气逆导致的“胸满”“呕逆”等,而与足厥阴脉密切相关的应该是前阴部的症状,可见,从出土文献中挖掘经脉腧穴的适应症,能够为经脉学说的发展提供一定参考^[9]。

[1] [汉]许慎.说文解字[M].北京:中华书局,2015:151.

[2] [春秋]佚名.黄帝内经素问[M].北京:人民卫生出版社,2012:195.

[3] [春秋]佚名.灵枢经[M].北京:人民卫生出版社,2012:86.

[4] [春秋]佚名.灵枢经[M].北京:人民卫生出版社,2012:93.

[5] 黄龙祥.从“厥阴脉”概念的形成过程看经络学说的意义与价值[J].针刺研究,2003(04):280-287.

[6] 杨峰,赵京生.出土经脉文献中足厥阴经脉病候“热中”的由来与演变——从《史记·扁鹊仓公列传》之“中热”说起[C]//中国针灸学会针灸文献专业委员会2006年学术年会论文汇编,2006:86-88.

[7] 赵京生.足厥阴肝经主小便病候的由来与演变[J].上海针灸杂志,1999(02):42-43.

[8] 王为群.唐以前足厥阴经主治病症的研究[D].南京中医药大学,2001.

[9] 吴晓玲,林怡,彭超,等.足厥阴肝经循行与肝联系之析疑[J].福建中医药,2021,52(12):28-30.

2.1.9 足少阴脉

2.1.9.1 出土文献、文物足少阴脉考订

马王堆《足臂十一脉灸经》

足少阴温（脉）：出内踝窻（婁）中，上贯腓（腓），入趺（腓—却），出股，入腹，循脊内廉（廉），出肝，入肱，𦨇（繫）舌。其病𠄎（病：病）足热，腓（腓）内痛，股内痛，腹街、脊内廉（廉）痛，肝痛，心痛，烦心，咽（咽）□□□□，舌𦨇（𦨇），□，旦（瘡），尚（上）气，□□数𦨇（喝），牧牧，耆（嗜）臥以𦨇。【諸】病此物【者，皆久（灸）】足少阴【温（脉）】。

马王堆《阴阳十一脉灸经》（甲本）

少阴脉（脉）：𦨇（繫）於内踝（踝）外廉，穿腓，出𦨇（腓—却）【中】央，上穿脊之【内】廉，𦨇（繫）於腎（腎），夾（挾）舌【本】。【是動則病】：𦨇𦨇（𦨇𦨇）如喘，坐而起則目瞶如毋見，心如縣（懸），病飢，氣【不】足，善怒，心腸＜惕＞，恐【人將捕之】，不欲食，面黧若𦨇（𦨇—地）色，𦨇則有血，此為骨𦨇（𦨇—厥），是少【陰】脉（脉）主【治】。其所產【病：口熱】舌𦨇（𦨇—圻），𦨇乾，上氣，𦨇（𦨇），𦨇中𦨇（痛），瘡，耆（嗜）臥，𦨇，音（瘡），為十病。【少】陰之脉（脉），【灸則強食，產肉，緩帶】，被𦨇（髮），大丈（杖），重履而步，久（灸）幾息則病已（已）。

马王堆《阴阳十一脉灸经》（乙本）

少阴𦨇（脉）：𦨇（繫）于内踝（踝）外廉，穿腓，出【𦨇（却）中央，上穿脊之内廉，繫於腎，挾舌本。是動（動）則病：𦨇𦨇（𦨇𦨇）如喘】，坐而起則目芒然无（無）見，心如絕，病飢，氣不足，善怒，心易（惕），恐人將捕之，不欲食，面黧若𦨇（地）色，𦨇【則】有血，此為【骨厥，是少】陰之𦨇（脉）主治。其所【產病：口熱，舌圻，𦨇乾，上氣】，𦨇，𦨇中𦨇（痛），單（瘡），耆（嗜）臥，𦨇，音（瘡），為十病。

少陰之脉，久（灸）則強食，產肉，【緩帶】，大杖，被𦨇（髮），重履而步，

久（灸）希息則病已（已）矣。

张家山《脉书》载《阴阳十一脉灸经》（丙本）

• 少陰之脈，𦵏（繫）於內踝之外廉，穿腠，出𦵏（却）中央，上穿責（脊）之內廉，𦵏（繫）於臀，夾舌本。是動（動）即病：悒_二（悒悒）如亂，坐而起，則目眈如無見，心如縣（懸），病飢，氣不足，善怒，心狄（惕）狄（惕）恐人將捕之，不欲食，面黯若地色，欬（咳）則有血，此為骨蹶（厥），是少陰之脈主治。其所產病：口熱，舌𦵏（坼），嗑乾，上氣，噎（噎），嗑中痛，痺，者<耆>臥，欬（咳），音（瘖），為十病。

• 少陰之脈，久（灸）則強食產肉，緩帶被髮，大丈（杖），重履而步，久（灸）幾息則病已矣。

老官山《十二脉》

足少陰脈，𦵏（繫）□□，出內果后脛□循□□□內廉，穿陰股而上，夾脊內廉，【系于腎】，上夾舌本^[1]。

老官山《经脉》残简

□上气，嗑干痛，烦心_二（心，心）痛，□□內廉痛，癢（厥）痿，耆（嗜）卧，足下热^[2]。

老官山漆人足少阴脉

具体循行路径为“起于足中趾之下→斜走足心→腠内廉→脛内廉→股内后廉→阴部”^[3]，邱科先生学位论文中提到足少阴脉只有本脉，无分支。不同的是，整理人员 2022 年发表的英文论文中^[4]，右下肢足少阴脉绘有一条分支（即图 16 中 line 9-1，笔者用蓝色线标记）。

^[1] 黄龙祥. 老官山出土汉简脉书简解读[J]. 中国针灸, 2018, 38(01): 97-108.

^[2] 顾漫, 周琦, 柳长华, 等. 天回医简《经脉》残篇与《灵枢·经脉》的渊源[J]. 中国针灸, 2019, 39(10): 1117-1123.

^[3] 邱科. 老官山汉墓经穴髹漆人像六阴经循行特点研究[D]. 成都中医药大学, 2016.

^[4] 程施瑞, 周兴兰, 邱科, 等. 成都老官山汉墓经穴髹漆人像十二经脉循行考证（英文）[J]. World Journal of Acupuncture-Moxibustion, 2022, 32(01): 40-48.

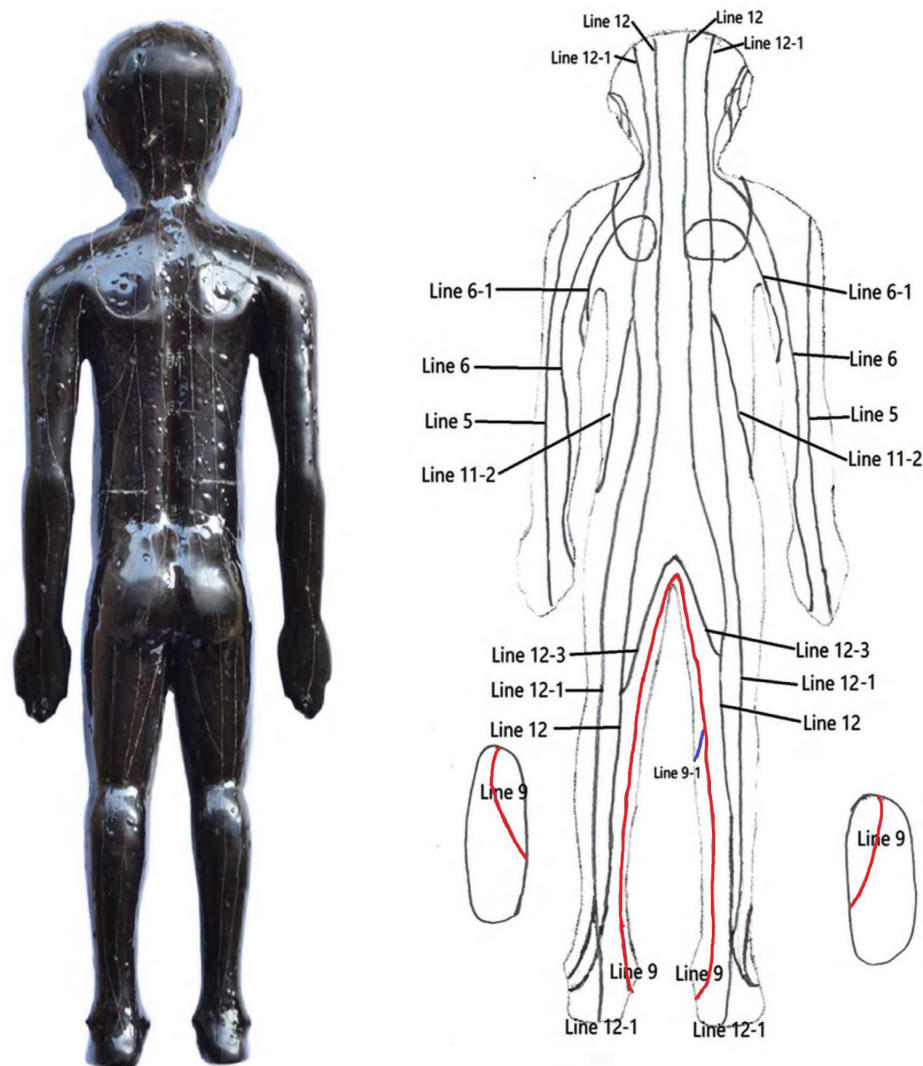


图 16 老官山漆人足少阴脉循行路径

2.1.9.2 讨论

表 9 先秦两汉足少阴脉演变特点对比

	《足臂》	《阴阳》 (甲本)	《阴阳》 (乙本)	《阴阳》 (丙本)	《十二 脉》	老官山 漆人	双包山 木人	《灵枢·经脉》
命名	足少阴温	少阴脉	少阴朋	少阴之脉	足少阴脉	/	/	肾足少阴之脉
起点	内踝婁中	内踝外廉	内踝外廉	内踝之外 廉	缺	足中趾之 下	无此脉	(足)小指之下
止点	舌	舌本	舌本	舌本	舌本	阴部	/	舌本
流注方向	向心性	向心性	向心性	向心性	向心性	向心性	/	向心性
支脉	无	无	无	无	无	1 条	/	1 条
脏腑	肝	肾	肾	肾	肾	/	/	肾、膀胱、肝、 肺、心
官窍	舌	舌	舌	舌	舌	无	/	喉咙、舌

在经脉循行方面，诸文献、文物中足少阴脉相同之处在于均循行于下肢内侧，主要区别之处在于起止点和联系脏腑方面。由于循行方向均为向心性流注，所以起点位于四肢远心端，《足臂》《阴阳》足少阴脉的起止点具体位置保持了高度的一致性，结合足少阴脉主治病症的数量较多且有规律，说明秦汉早期医家已经对足少阴脉的认识较为成熟（其余十条经脉起止点均有差异）^[1]，《足臂》《阴阳》足少阴脉起点均位于内踝附近，而老官山漆人以及《灵枢·经脉》延伸至足趾下，不同之处在于老官山漆人起于足中趾下，而《灵枢·经脉》起于足小趾之下。诸文献、文物足少阴脉的止点多与舌相连，唯老官山漆人止点在于阴部，但是本文文献中足少阴脉在躯干部均是深入体腔联系脏腑后，才上行与舌相连，由于老官山漆人只能在体表刻画经脉循行路线，无法表现体内经脉循行路线，因此只能刻画至“阴部”而止。

在联系脏腑方面，《足臂》足少阴脉与肝相连，《阴阳》《十二脉》与肾相连，而《灵枢·经脉》除肝、肾外，还与膀胱、肺、心相连。在联系官窍方面，诸文献、文物均与舌相连，而且出土简帛文献中，与舌相连的只有足少阴脉^[2]，由于足少阴脉与舌之间的特殊联系，《内经》在舌体病变时，也多选取足少阴脉进行治疗，如“舌纵涎下，烦惋，取足少阴”（《灵枢·寒热病》），《灵枢·经脉》还提到“循喉咙”，在主治病症中又有“咽肿……嗑干及痛”，因此《灵枢·经脉》中足少阴脉也联系喉咙，而不是仅仅作为循行所过。

在经脉分支方面，《足臂》《阴阳》《十二脉》中足少阴脉只有主干，老官山漆人最新公布的绘制图中，右侧足少阴脉于大腿中部向前下方发出一条分支（图 16 中 line 9-1），但笔者考察漆人正面照片以及绘制图，未能识出该条分支的止点，是否止于膝关节内侧？还待更详细的资料公布。《灵枢·经脉》中足少阴脉也有一条分支“从肺出络心，注胸中”，是为联系脏腑而设。

在病症演变方面，《足臂》足少阴脉主治病症与其循行部位有关，《足臂》足少阴脉循行路径大体可以归纳为“内踝娄中→腓→郄→股→腹→脊内廉→肝→肱→舌”，其主治病症也大致按照这一部位顺序进行排列，《足臂》循行进入体腔内，

^[1] 赵争. 从出土文献看早期经脉学说[J]. 医疗社会史研究, 2016, 1 (02): 51-74+328-329.

^[2] 赵京生. 阳经五官病候及治疗用穴分析——兼论经脉病候与腧穴主治关系[J]. 针刺研究, 2007 (06): 411-418.

与肝脏相连，因此主治病症也有“肝痛”，体现了循行部位与主治病症的高度吻合，值得注意的是，《足臂》足少阴脉循行路径与心尚未建立联系，但是经脉主治病症中出现了“心痛”“烦心”“牧牧”（即“静卧不语”之意^[1]），《阴阳》足少阴脉循行路径也没有与心建立联系，但经脉病症中同样有“心如悬”“心惕”的心系病变，这种疑问实际上是由于现代“经脉-脏腑相关理论”的定式思维推理而导致的，在《足臂》《阴阳》所处的秦汉早期，经脉-脏腑相关理论还没有完全建立起来，脏腑辨证也并不成熟，因此心系病变也可能出现在不相关的经脉病症中^[2]。《阴阳》主治病症分为“是动则病”和“其所产病”两类，比较特殊之处在于“是动则病”中包含了较多关于情绪、精神异常的症状，如“坐而起则目瞋如毋见……善怒，心惕，恐人将捕之……”。在《阴阳》（丙本）足少阴脉病症“为十病”之后，还有一句疑似后人补入的条文，即“久（灸）则强食产肉，缓带被髮，大杖（杖），重履而步，久（灸）几息则病已矣”，笔者认为此句是在针对足少阴病症“病饥”“不欲食”而言，经过艾灸治疗后，患者开始增进饮食（强食）、生长肌肉（产肉），由于体重增加，所以松弛腰带（缓带），“被发”“大杖”“重履而步”应该是在描述某种导引术^[3]。

《灵枢·经脉》足少阴脉主治病症也分为“是动则病”与“所生病”，并且与《阴阳》重合度较高，其中“是主肾所生病者”增加症状有“脊股内后廉痛……足下热而痛”，均属于经脉循行所过部位产生的病变，老官山《经脉》残简中记载足少阴脉病症有“上气，嗌干痛，烦心心痛……内廉痛，厥痿，嗜卧，足下热”，与《灵枢·经脉》足少阴脉的“所生病”有很高的吻合度，可惜这部分医简残损严重，否则作为《灵枢·经脉》的祖本^[4]，可能会给我们揭示更多先秦两汉时期经脉主治病症演变的细节。

^[1] 李丽,王育林.《足臂十一脉灸经》“牧牧”考[J].吉林中医药,2016,36(04):421-425.

^[2] 赵争.古脉书《足臂十一脉灸经》与《阴阳十一脉灸经》相对年代问题考论[J].出土文献,2015(02):193-215.

^[3] 刘立安.宋以前灸疗学术发展史研究[D].北京中医药大学,2020:30.

^[4] 顾漫,周琦,柳长华,等.天回医简《经脉》残篇与《灵枢·经脉》的渊源[J].中国针灸,2019,39(10):1117-1123.

2.1.10 足阳明脉

2.1.10.1 出土文献、文物足阳明脉考订

马王堆《足臂十一脉灸经》

足陽明（明）溫（脈）：循肱中，上貫膝中，出股，夾（挾）少腹，上出乳內兼（廉），出臙（臙），夾（挾）口，以上之鼻。其病_二（病：病）足中指廢，肱痛，膝中種（腫），腹種（腫），乳內兼（廉）痛，□外種（腫），頰痛，𩑦（𩑦）洎（衄），數熱，汗出，脰瘦，顏（顏）寒。諸病此物者，皆久（灸）陽明（明）溫（脈）。

马王堆《阴阳十一脉灸经》（甲本）

陽明（明）脈（脈）：𦵏（繫）於髀骨外廉，循髀而上，穿臙（臙—臙），出魚股【之廉】，上穿【乳】，穿頰，【出目外】廉，環【顏】□。是動（動）則病：洒_二（洒洒）病寒，喜龍，婁（數）吹（欠），顏（顏）【黑，病種（腫）】，病【至則惡人與火，聞】木音則𩑦<惕>然驚，心腸<惕>，欲獨閉戶牖而處，病甚則欲【乘高而歌，棄】衣【而走，此為】髀𦵏（𦵏—𦵏），是陽明（明）脈（脈）主治。其所產病：顏（顏）痛（痛），鼻肌（𩑦），領（領）【頸痛，乳痛】，心與肱痛（痛），腹外種（腫），陽（腸）痛（痛），𦵏（膝）跳，付（跗）【上踝<跗>】，為十病。

马王堆《阴阳十一脉灸经》（乙本）

陽明（明）𦵏（脈）：•𦵏（繫）於髀骨外廉（廉），𦵏<𦵏—循>𦵏（髀）【骨】而上，穿實（實—臙），出魚【股之廉，上穿】乳，穿頰，出目外廉，環顏（顏）。【是動則病：洒洒】病寒，喜信（伸），數吹（欠），顏（顏）黑，病腫（腫），病至則亞（惡）人與火，聞木音則易（惕）然驚，欲獨【閉】戶牖而處，病甚【則欲乘高】而歌，棄衣而走，此為髀𦵏（𦵏），是【陽明（明）脈主治】。其所產病：顏（顏）𦵏（痛），鼻肌（𩑦），領（領）頸𦵏（痛），乳𦵏

（痛），心牙（與）肱痛，腹外腫（腫），腸甬（痛），郛（膝）、足臂（痿）
 涿（瘳），【為十病】。

张家山《脉书》载《阴阳十一脉灸经》（丙本）

• 陽明之脈，繫（繫）於髀骨之外廉，循髀而上，穿臑（臑），出魚股之廉，
 上穿乳，穿頰，出目外廉，環頤（頤）。是動（動）則病：洒洒病寒<寒>，喜
 信（伸），數吹（欠），頤（頤）墨，病種（腫），至則惡人與火，聞木音則狄
 （惕）然驚，心惕然，欲獨閉戶牖而處，病甚則欲乘高而歌，棄衣而走，此為髀
 蹶（厥），是陽明脈主治。其所產病：頤（頤）痛，鼻肌（鼽），領<領—領>
 疾，乳痛，腎痛，心與肱痛，腹外種，腸痛，郛（膝）外，拊（跗）上踝<蹠—
 瘳>，為十二病。

老官山《十二脉》

据公开发表的资料仅能查到其命名为“足阳明脉”。

老官山《经脉》残简

……□上□贯乳，夹戾（喉），回口，属鼻……是动则病，洒_二（洒，洒）^[1]。

老官山漆人足阳明脉

只有一条主干（图 17 中红色线），无分支，起于“小趾次趾”，沿着足背向上
 走行，左侧足阳明脉在踝关节前方接受来自足厥阴脉的分支（图 17 中 line 8-1），
 主干继续沿着下肢伸面向上走行，分别经过膝关节前方、腹股沟、腹部、胸前壁
 （乳内廉），在乳内廉处接受来自足少阳脉的分支（图 17 中 line 11-1），在胸前
 壁还与手厥阴脉相交叉，而后沿着胸骨线，向上经过喉两侧，环绕口角后，到达
 鼻孔正下方^[2]。

^[1] 顾漫,周琦,柳长华,等. 天回医简《经脉》残篇与《灵枢·经脉》的渊源[J]. 中国针灸,2019,39(10):1117-1123.

^[2] 印帅,程施瑞,曾芳,等. 从成都老官山汉墓髹漆人像看足阳明经脉循行演变[J]. 辽宁中医杂志,2017,44(01):71-73.

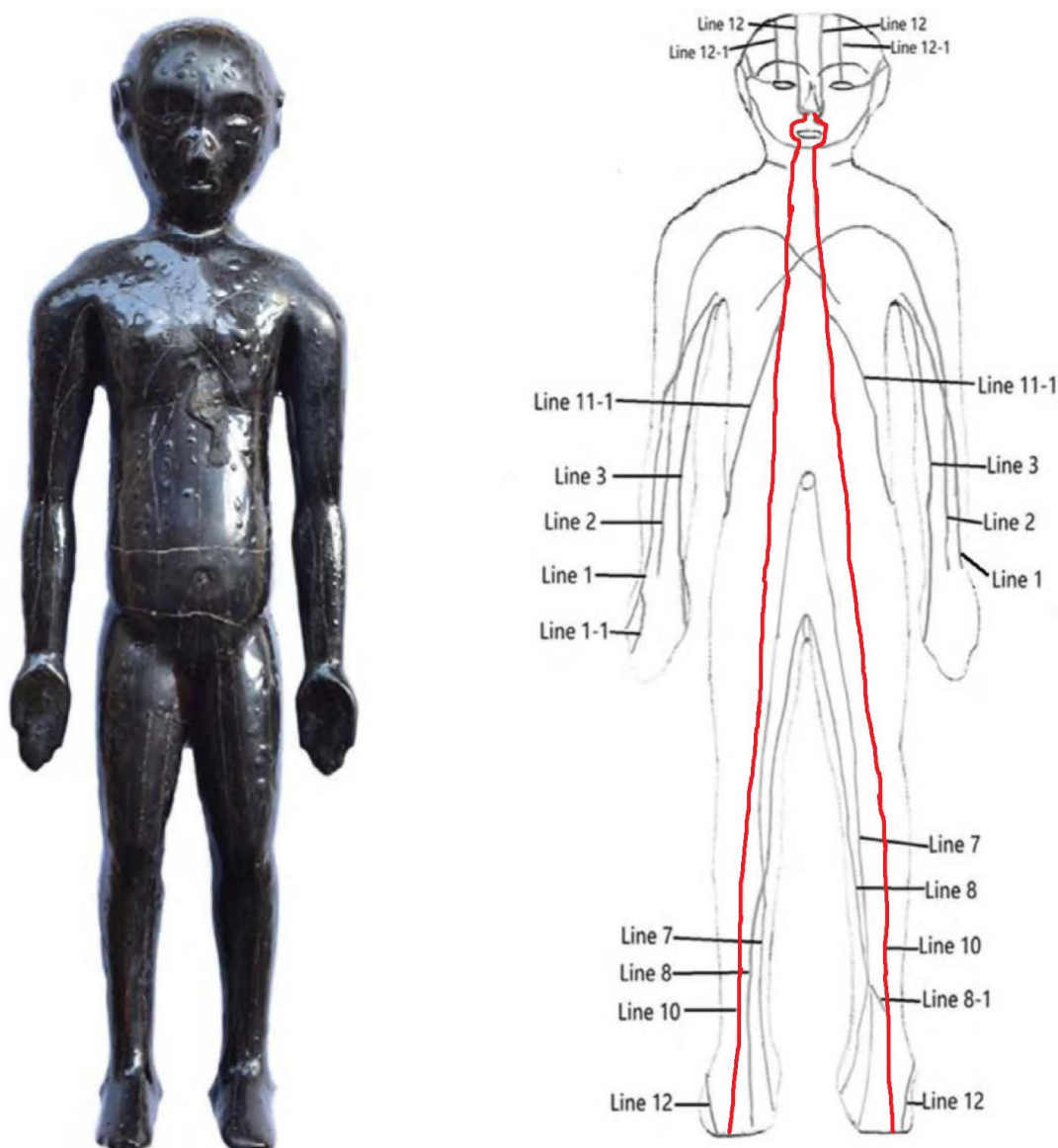


图 17 老官山漆人足阳明脉循行路径

双包山木人足阳明脉

只有一条主干（图 18 中红色线），没有分支，其循行起点在“目下”，观察绘制图发现在下眼睑正中央，向下分别经过口角旁手太阴脉的起始点，颈部前方手少阴脉起始点，经过胸前壁（穿过乳头）、腹部，穿过腹股沟中央，向下经过大腿前方（伸面）正中线、膝盖正前方、足背正中线后，到达足中趾端^[1]。

^[1] 马继兴. 双包山汉墓出土的针灸经脉漆木人形[J]. 文物, 1996(04): 55-65+98.

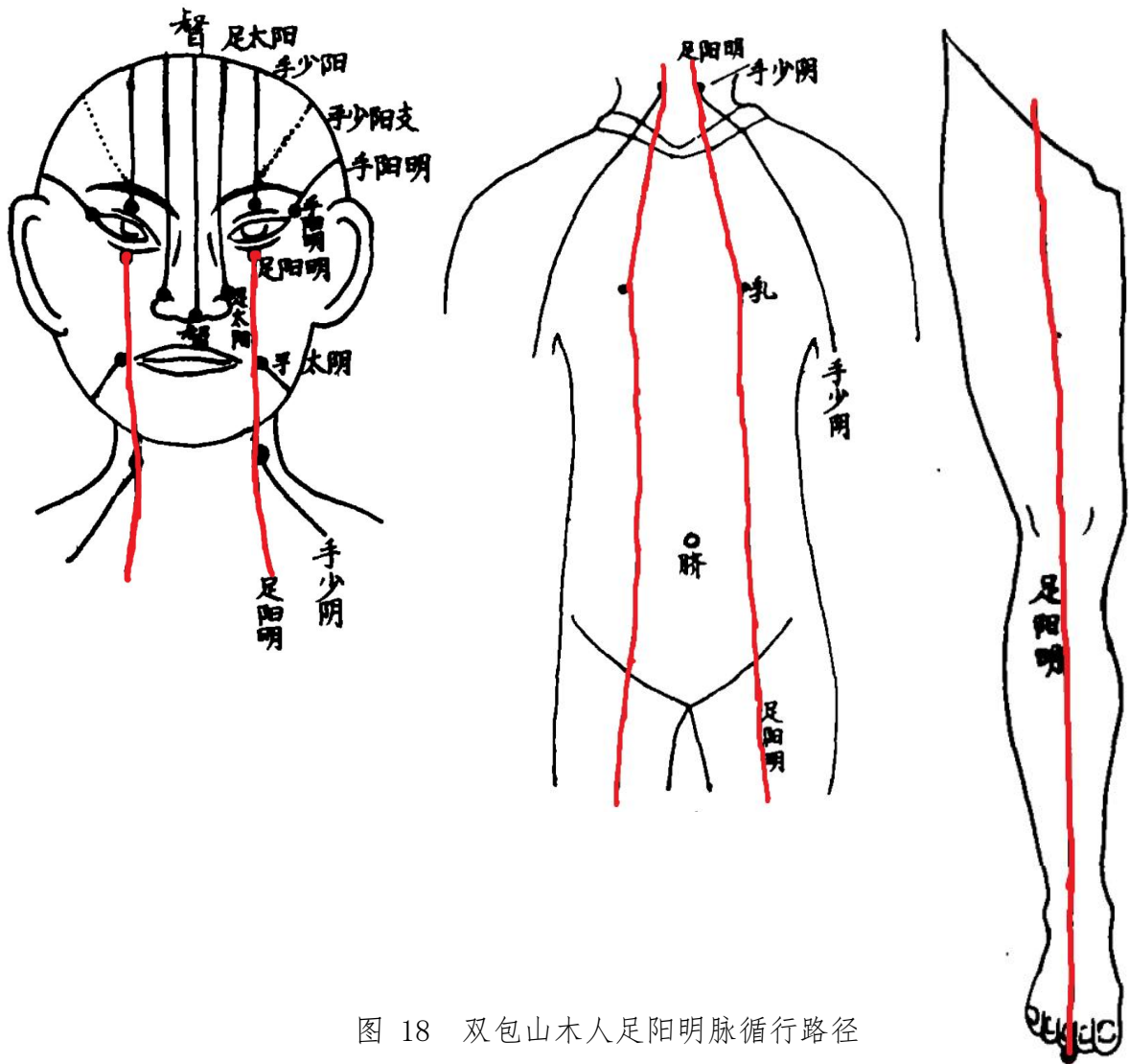


图 18 双包山木人足阳明脉循行路径

2. 1. 10. 2 讨论

表 10 先秦两汉足阳明脉演变特点对比

	《足臂》	《阴阳》 (甲本)	《阴阳》 (乙本)	《阴阳》 (丙本)	《十二脉》	老官山 漆人	双包山 木人	《灵枢· 经脉》
命名	足阳明温	阳明脉	阳明𦵏	阳明之脉	足阳明脉	/	/	胃足阳明 之脉
起点	肱(小腿)	骭骨外廉	骭骨外廉	骭骨之外 廉	/	小趾次趾	目下正中	鼻
止点	鼻	颜	颜	颜	/	鼻	足中趾端	中指内间
流注方向	向心性	向心性	向心性	向心性	/	向心性	远心性	远心性
支脉	无	无	无	无	/	无	无	3 条
脏腑	无	无	无	无	/	/	/	脾、胃
官窍	口、鼻	目	目	目	/	口、鼻	目、口	鼻、口、 齿、耳

在经脉循行方面，出土文献、文物足阳明脉仅有一条主干，未出现分支，相同之处在于均大致经过“小腿→膝关节前方→大腿→腹部→乳房→面部”，其差异主要在于起止点的位置，《足臂》《阴阳》均起于小腿，经过胸前壁时，《足臂》经“乳内廉”而上，而《阴阳》则是“上穿乳”，表明《阴阳》足阳明脉与乳房的关系更为密切，此外两者之间最主要的差别还在于头面部的循行路径完全不同，《足臂》是“挟口……之鼻”（足太阳脉止点也是“之鼻”），而《阴阳》则是“出目外廉，环颜”，老官山漆人足阳明脉起点延伸至（足）小指次指，而面部循行与《足臂》描述类似，双包山木人循行方向是远心性，因此其起点在于“目下正中”，而止点则在足中趾端。《灵枢·经脉》循行方向也是远心性，起点位于鼻，且面部循行类似《阴阳》，有“环颜”的特点，止点在足中趾内间，但通过支脉又与足中趾外间联系（《足臂》足阳明脉病症有“足中指废”）。在经脉分支方面，出土文献、文物足阳明脉皆未见分支，《灵枢·经脉》中出现3条分支，这3条分支均是为构建经脉-脏腑相关理论以及十二脉环形流注体系而设。老官山漆人足阳明脉循行过程中与其他经脉之间有较多交叉之处，左侧足阳明脉与足厥阴脉的分支（图17中line 8-1）相交，在胸前壁又分别与足少阳脉的分支（图17中line 11-1）、手厥阴脉相交，在鼻部又与足太阳脉第一侧线相交，而双包山木人则仅在口角、颈前部分别与手太阴脉以及手少阴脉的起始点重合，两具出土文物足阳明脉仅有经脉交叉而无经脉分支的情况，进一步说明了《灵枢·经脉》中足阳明脉3条分支多来自于后人添加。

在与脏腑联系方面，出土文献中足阳明脉均未提及脏腑属络情况，《灵枢·经脉》与脾、胃产生联系，尽管《灵枢·经脉》是用“其支者”引出“下膈属胃络脾”，但笔者认为此处仍属于足阳明脉主干循行路径，或者可以将“下膈属胃络脾”这一段循行视作主干的延伸，是为建立经脉-脏腑相关理论而设。在与官窍联系方面，《足臂》足阳明脉循行与口、鼻相连，相关官窍病症为“𪔐衄”，《阴阳》足阳明脉循行则与“目外廉”相连，但在主治病症中却无目病，而是与经脉循行无关的“鼻衄”，《灵枢·经筋》篇中足阳明经筋无论循行还是病变均与目相关，如足阳明经筋循行“阳明为目下纲”，其主病“急者目不合，热则筋纵，目不开”，提示《灵枢·经筋》与出土文献之间的相似性。《灵枢·经脉》足阳明脉循行与鼻、

口、齿、耳相连，相关官窍病症有“鼽衄”“口喎唇疹”。

秦汉时期足阳明脉主治病症的演变：《足臂》足阳明脉循行可以简化为“肱中→膝中→股→少腹→乳内廉→嗌→挟口→鼻”，其主治病症与经脉循行一致，可见足阳明脉所经过的部位与该部位产生的病变密切相关，其中，《足臂》足阳明脉主治病症首先是“足中指废”，其后才是“肱痛”，说明病症部位可能是足阳明脉起点从小腿延伸至足趾端的影响因素之一，双包山木人与《灵枢·经脉》循行止点均在足中指，且《灵枢·经脉》足阳明脉“所生病”中有“（足）中指不用”，与《足臂》一致，足中指在出土文献中不仅与足阳明脉相关，《阴阳》足少阳脉“其所产病”中也有“足中指痹”，此外，《灵枢·本输》中记载足阳明脉井穴厉兑的定位在“足大指内次指之端”，但《灵枢·经脉》中足阳明脉在足趾末端与足中指相关，《素问·气府论》中足阳明脉气所发中记载“三里以下至足中指各八俞”，均表示秦汉时期某一阶段（或某一医派）认为足阳明脉无论循行路径还是主治病症均与足中趾相关，故有学者认为厉兑穴应该定位于足中趾端，《灵枢·本输》的记载有误^[1]，秦汉时期足阳明脉在足趾端与“足中趾”和“大趾次趾”关系密切，这提示我们应该思考老官山漆人将足阳明脉起点定于“小趾次趾”是否妥当，笔者观察老官山漆人照片以及绘制图，似乎可以将足阳明脉起点定位于足中趾端，但漆人整体照片较模糊，绘制图也较简略（如漆人足部前面观，经脉线 line 10 与 line 12 之间缺少 line 11，但足部侧面观可明显见到 line 11 循行至足趾端），这些疑点还待局部高清照片的公布。

《足臂》足阳明脉主治病症条文中，“鼽衄”之后的“数热，汗出，脰瘦，颜寒”应该是属于后人添加的注解。《阴阳》足阳明脉主治病症分为“是动则病”与“其所产病”两种类型，其中“其所产病”与经脉循行所过密切相关，以甲本为例，《阴阳》（甲本）经脉循行大致经过“髀骨外廉→髀→鱼股→乳→颊→目外廉→颜”，与《足臂》不同的是，《阴阳》“其所产病”对主治病症的描述顺序与经脉的循行相反。此外，《阴阳》中的“是动则病”描述的症状属于精神情志类疾病，与经脉循行路径关系不大，即“恶人与火，闻木音则惕然惊，心惕，欲独闭户牖而处，病甚则欲乘高而歌，弃衣而走”，在《灵枢·经别》中提及足阳明经别可以

^[1] 王凡，曹一鸣. 关于《内经》中阳明经几个问题的探讨[J]. 天津中医学院学报, 1987 (03): 2-5.

“上通于心”，而心为“神明所出”（《素问·灵兰秘典论》），通过心胃之间的联系，可解释足阳明脉出现精神情志类疾病的原因，黄龙祥先生则认为，“是动病”直接移植自腕踝部脉口处的诊脉病候，并不需要（也无法）按照经脉的循行进行归类。此外，在《素问·脉解》以及《素问·阳明脉解》中对足阳明脉出现精神情志病变的原因以及病机进行了分析，尤其《素问·阳明脉解》篇是对足阳明脉“是动病”进行解释的专文，如解释“弃衣而走”的原因是“热盛于身”，“登高而歌”的原因是“阳盛则四支实”，“恶人”的病机是“阳明厥则喘而惋，惋则恶人”，《素问·阳明脉解》强调阳热内盛，《素问·脉解》则从阴阳盛衰角度进行分析^[1]，现代学者对足阳明脉的病症也多有讨论，如石学敏院士将足阳明脉的“是动病”所表现的症状从轻到重分为两个不同的阶段，其中“洒洒振寒”是属于寒邪在表的自我感觉症状，“善呻数欠”属于阳明热证初起阶段的表现，“颜黑”则属于在“洒洒振寒”基础上体温进一步升高的表现，“病甚……”之后则属于典型精神病（狂躁型以及抑郁型）的症状，而“贲响腹胀”则属于胃肠道功能紊乱的表现^[2]。张建斌等学者对足阳明脉的“是动病”所表现的症状进行深入分析，认为可以分为一般症状表现、初发病和病情加重三个方面^[3]。此外，对于“洒洒振寒”的含义，有学者认为并非是一般的表证，而应该是受寒导致全身发颤的现象^[4]，“独闭户牖而处”一般也认为是抑郁症或者抑郁型精神病的表现^[5]。《灵枢·经脉》中的“是动病”“所生病”与《阴阳》保持了高度一致性，可以看出《灵枢·经脉》是以《阴阳》为底本。老官山《经脉》残简无论是循行路径还是主治病症，均与《灵枢·经脉》保持较高的相似性。

[1] 周国琪. 试从《内经》探析足阳明脉与精神疾病的关系[J]. 中国中医基础医学杂志, 2010, 16(11): 981-983.

[2] 天津中医学院第一附属医院针灸科. 石学敏针灸临证集验[M]. 天津: 天津科学技术出版社, 1990: 526-529.

[3] 张建斌, 王玲玲. 足阳明脉“是动病”病候探讨[J]. 安徽中医学院学报, 2005(06): 1-4.

[4] 高薇, 李瑞, 张雯, 等. 足阳明胃经病候“洒洒振寒”与胃之关系浅析[J]. 中国针灸, 2020, 40(04): 435-438.

[5] 刘枫凤, 李瑞. 论“独闭户塞牖而处”与抑郁症[J]. 中国针灸, 2018, 38(03): 315-318.

2.1.11 足少阳脉

2.1.11.1 出土文献、文物足少阳脉考订

马王堆《足臂十一脉灸经》

足少陽溫（脈）：出於踝前，枝於骨間（間）^[1]，上貫臑（膝）外兼（廉），出於股外兼（廉），出脅；枝之肩薄（薄-膊）；其直者貫腋，出於項、耳，出臑（枕），出目外漬（眚）。其病_二（病：病）足小指次【指】廢，肱外兼（廉）痛，肱寒，膝外兼（廉）痛，股外兼（廉）痛，脾（髀）外兼（廉）痛，脅痛，肩_二^[2]痛，產馬，缺盆痛，癰（癰），聾，臑（枕）痛，耳前痛，目外漬（眚）痛，脅外種（腫）。諸【病】此物者，皆久（灸）少陽溫（脈）。

马王堆《阴阳十一脉灸经》（甲本）

【少】陽脈（脈）：穀（繫）於外踝之前廉，上出魚股之【外，出脅】上，【出耳前。】是動（動）則病：【心與脅痛】，不可以反稷（側），甚則无（無）膏，足外反，此為陽【厥】，是少陽脈【主】治。其所產【病：口痛，項痛，頭】頸痛（痛），脅痛（痛），瘡，汗出，節盡痛（痛），脾（髀）【外】廉【痛】，魚股痛（痛），臑（膝）【外廉】痛（痛），振寒，【足中指】踝<蹠一瘳>，為十二病。

马王堆《阴阳十一脉灸经》（乙本）

【少陽】肱（脈）：• 穀（繫）于外踝（踝）之前廉，【上】出【魚股之】外，出【脅】上，出耳前。是動（動）則病：心牙（與）脅痛，不可以反則（側），甚則无（無）膏，足外【反，此】為陽瘳（厥），是少陽肱（脈）主治。【其所產病：口痛，項痛】，頭頸痛，脅【痛】，瘡（瘡），汗出，節盡【痛，髀外廉】痛，股痛，臑（膝）外【廉】痛，振寒，足中指蹠（瘳），為十二病。

张家山《脉书》载《阴阳十一脉灸经》（丙本）

^[1] “間”整理小组为“間”，《集成》识作“聞”，经核查图板后，可从。

^[2] 原释文作“口痛”，上文足少阳脉循行“出脅；枝之肩薄（薄-膊）；其直者貫腋”，出土经脉文献病症一般均与经脉循行相关，此处前为“脅痛”，对应“出脅”，后为“其直者貫腋”，对应“產馬”，故“口痛”应与“枝之肩薄（薄-膊）”相关，刘春语识为“肩痛”，可从。

• 少陽之脈，繫（繫）於外踝之前廉，上出魚股之外，出脇上，出耳前。是動（動）則病：心與脇痛，不可以反瘦（瘦），甚則無膏，足外反，此為陽厥，【是少陽脈主治。其所產病】：口痛，項痛，脇痛，瘧，汗出，節盡痛，脾（脾）廉痛，魚股痛，郛（膝）外廉痛，晨（振）塞〈寒〉，足中指踝〈蹠一痺〉，為十二病，及溫。

老官山《十二脉》

夜（腋），循□而上耳前，系目外眦。其病：足小指之次指痛，足附上廉痛，外果（踝）前痛，胫外廉痛，郛（膝）魚股外廉痛，胃痛，脇^[1]。

老官山《经脉》残简

少阳脉，起小指之次，循外踝前廉，上循□/□□臂外廉，支者至□□^[2]。

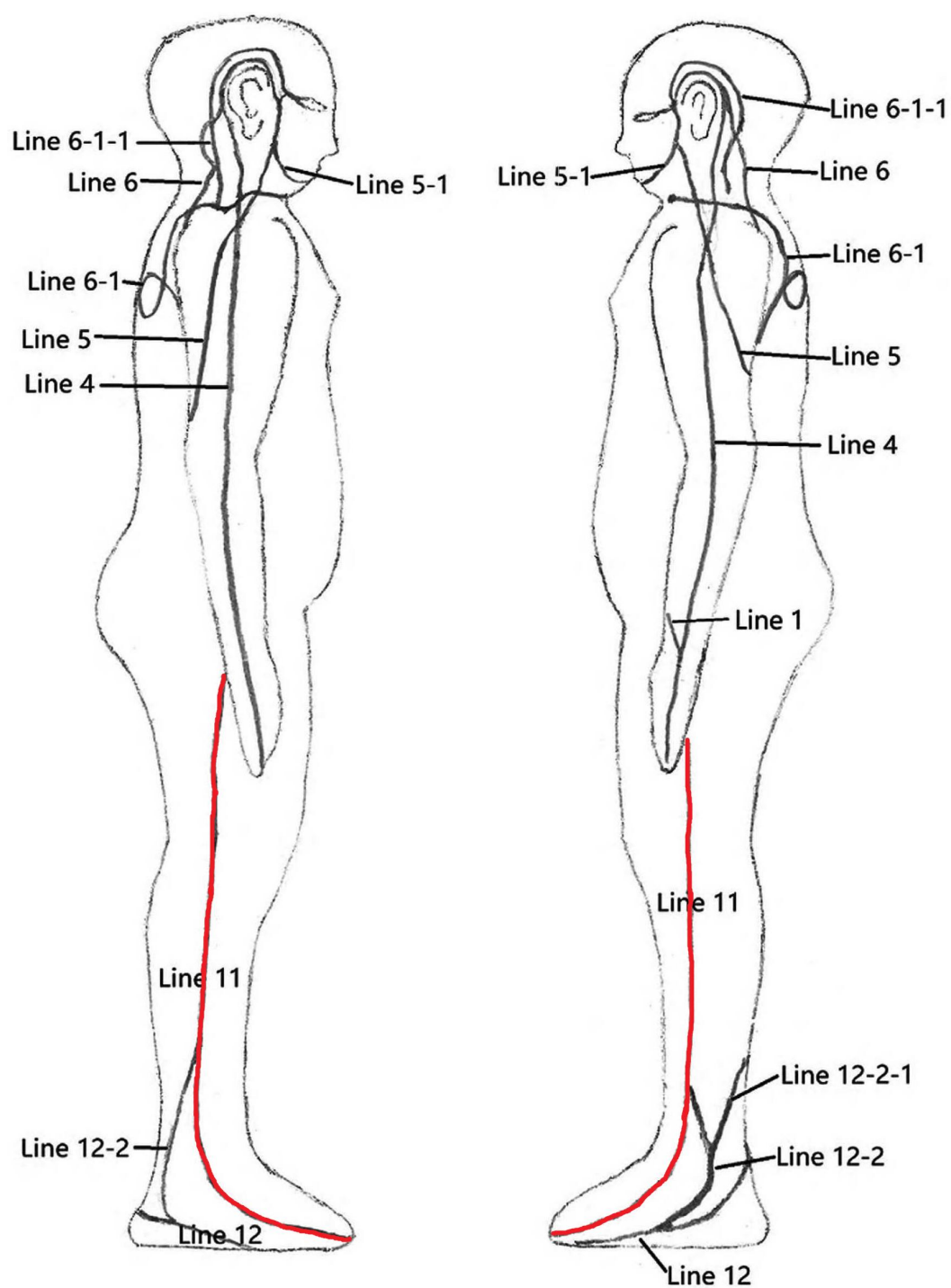
老官山漆人足少阳脉

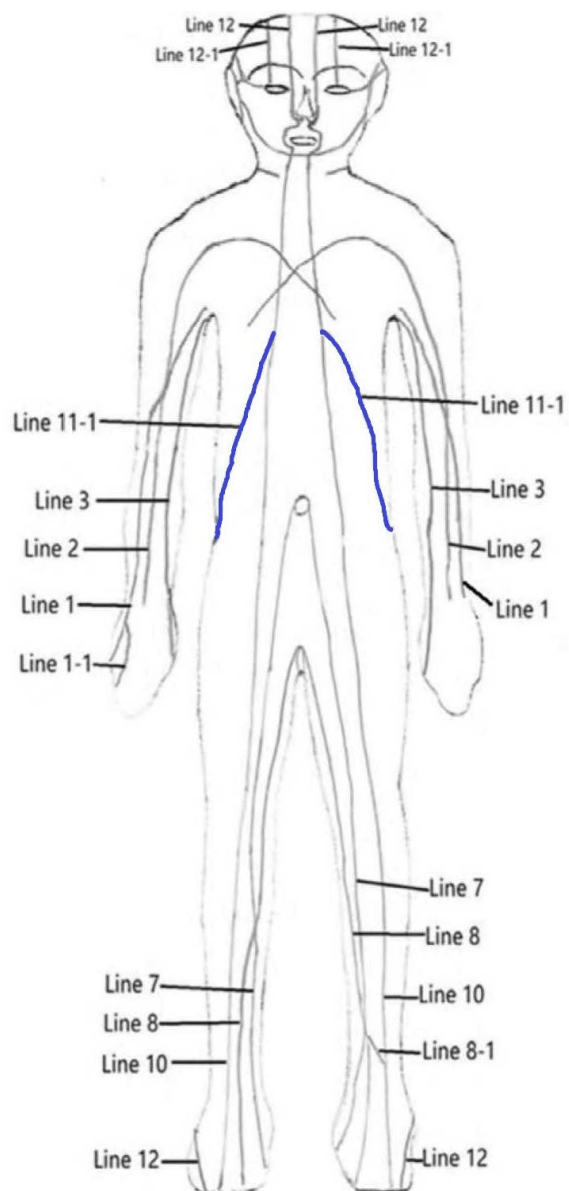
包含有一条主干以及两条分支，主干的起点在“小趾次趾”，沿着足背外侧缘，经过外踝前方向上，沿着下肢外侧缘（图 19 中红色线 line 11），向上穿过髌枢、侧腹部、胁，止于腋下。两条分支均从髌枢发出，一条向前与足阳明脉交于乳内廉（图 19 中蓝色线 line 11-1），另一条向后与足太阳脉第二侧线交于肩胛区（图 19 中黄色线 line 11-2）^[3]。

^[1] 黄龙祥. 老官山出土汉简脉书简解读[J]. 中国针灸, 2018, 38(01): 97-108.

^[2] 顾漫, 周琦, 柳长华, 等. 天回医简《经脉》残篇与《灵枢·经脉》的渊源[J]. 中国针灸, 2019, 39(10): 1117-1123.

^[3] 黄柳杨, 曾芳, 周兴兰, 等. 从西汉出土经穴髹漆人像看足少阳经脉的循行演变[J]. 成都中医药大学学报, 2017, 40(01): 91-94.





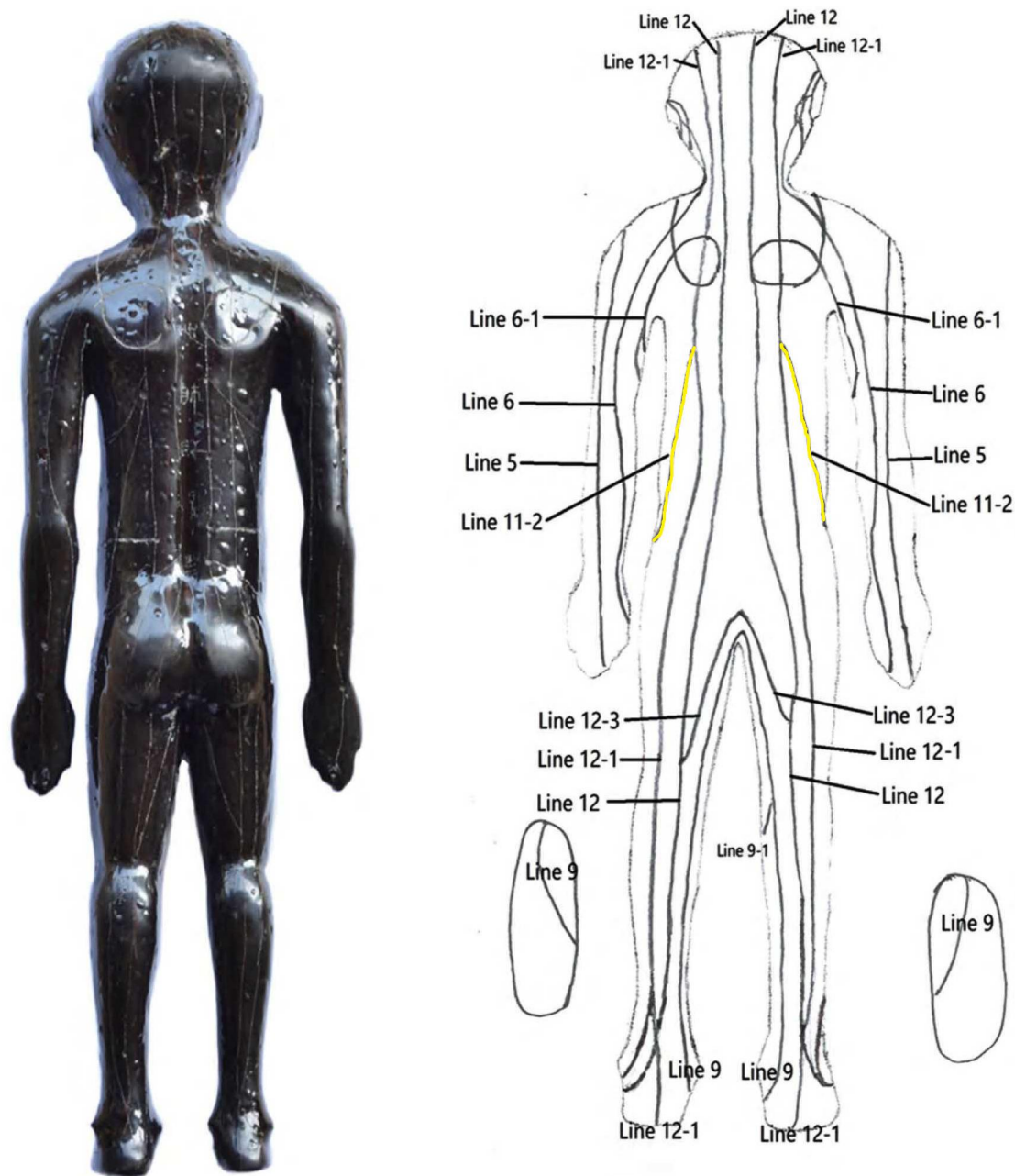


图 19 老官山漆人足少阳脉循行路径（侧面观、正面观、背面观）

双包山木人足少阳脉

只有一条主干（图 20 中红色线），没有分支，起点位于腋窝部正中，向下经过肋、侧腹部，大概在脐水平的位置接受来自足太阳脉的分支，向下经过下肢外侧正中线，穿过外踝中点后直向下到达足底外侧缘^[1]。

^[1] 马继兴. 双包山汉墓出土的针灸经脉漆木人形[J]. 文物, 1996 (04): 55-65+98.

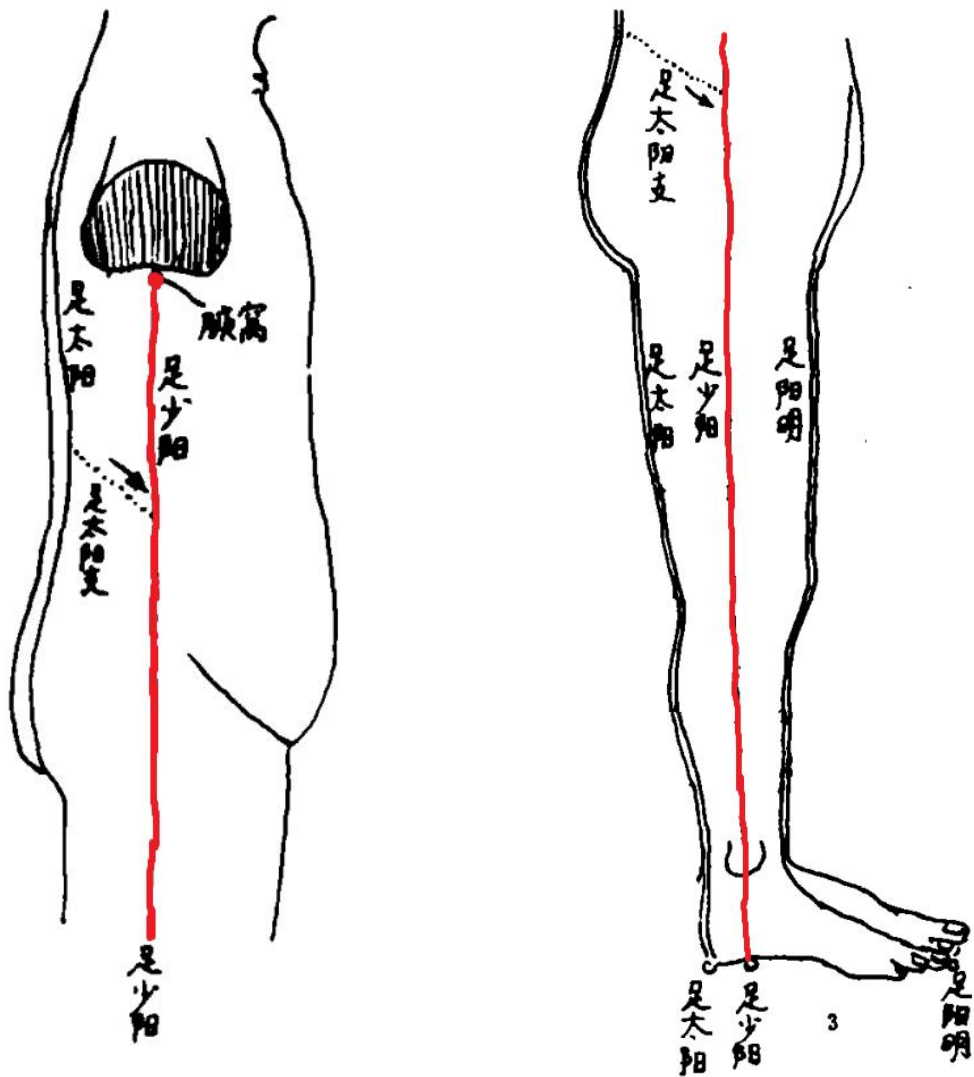


图 20 双包山木人足少阳脉循行路径

2.1.11.2 讨论

表 11 先秦两汉足少阳脉演变特点对比

	《足臂》	《阴阳》 (甲本)	《阴阳》 (乙本)	《阴阳》 (丙本)	《十二 脉》	老官山 漆人	双包山 木人	《灵枢·经脉》
命名	足少陽溫	少陽脈	少陽𦵏	少陽之脈	少阳脉	/	/	胆足少阳之脉
起点	外踝前	外踝之前 廉	外踝之前 廉	外踝之前 廉	腋	小趾次趾	腋窝部 正中	目锐眦
止点	目外眦	耳前	耳前	耳前	目外眦	腋下	足底外 侧	小指次指之间
流注方向	向心性	向心性	向心性	向心性	向心性	向心性	远心性	远心性
支脉	1 条	无	无	无	无	2 条	无	2 条
脏腑	无	无	无	无	无	/	/	肝、胆
官窍	耳、目外眦	耳	耳	耳	耳、目	无	无	耳、目外眦

在经脉命名方面,《足臂》称“足少陽温”,是以“手/足+阴/阳+脉”的方式进行命名,“手足”命名元素已经出现在了经脉名称中,而《阴阳》则称为“少陽脈”,是直接以“阴/阳+脉”的方式进行命名,“手足”命名元素未出现在《阴阳》足少阳脉的名称中,说明“阴阳”这一命名元素最初可能单纯应用在足脉上,而《十二脉》残简中也是称为“少阳脉”,与《阴阳》保持一致,推测老官山《十二脉》可能是以《阴阳》为底本进行抄写。

在足少阳脉循行路径上,《足臂》与《阴阳》大体一致,起点均为外踝前,《足臂》用“出于”引出“踝前”,而《阴阳》用“系于”,在具体循行路径的描述上,《足臂》要详于《阴阳》,《阴阳》对足少阳脉循行路径只是简单地描述了主干,起点位于“外踝之前廉”,下肢经过“鱼股之外”,躯干经过“胁”,头面部止点为“耳前”,未提及支脉,《足臂》不仅对足少阳脉循行过程描述较为详细,同时也提到了一条支脉“枝之肩髃”,周一谋先生对此条支脉考证为^[1]:“此处足少阳脉出胁以后,枝者走肩,直者贯腋出于项,《经脉》篇对此作了较大的变动,是从颊车下颈合缺盆以下胸中,贯膈络肝属胆,再循胁里。”值得注意的是,《足臂》足少阳脉循行还有“枝于骨间”,描述的是经脉主干经过小腿的胫骨与腓骨之间,而非支脉。《足臂》《阴阳》中足少阳脉呈向心性流注,老官山漆人足少阳脉根据同墓出土的医简有关记载,也呈向心性流注。双包山木人足少阳脉根据马继兴先生考证为远心性流注,《灵枢·经脉》篇足少阳脉循行也呈现远心性。

《足臂》足少阳脉止点在目外眦(手太阳脉止点也在目外眦),但《足臂》循行过耳,即“出于项、耳,出枕”,《灵枢·经脉》足少阳脉的起点与《足臂》止点相同,均在目外眦。对于《阴阳》足少阳脉止点“耳前”,《灵枢·经脉》设立一条支脉进行联系,即“从耳后入耳中,出走耳前,至目锐眦后”。可印证《足臂》《阴阳》是《灵枢·经脉》篇成文的参考文献之一。出土两具针灸模型的足少阳脉循行方向相反,双包山木人的起点(腋窝正中央)与老官山漆人的止点(腋下)位置一致。《足臂》足少阳脉循行有“其直者贯腋,出于项、耳”,提示《足臂》以及两具文物的足少阳脉与“腋下”这一部位的关系密切。老官山《十二脉》足少阳脉的循行为“夜(腋),循口而上耳前,系目外眦”。这一循行路径似乎是墓主

^[1] 周一谋,萧佐桃. 马王堆医书考注[M]. 天津:天津科学技术出版社,1988:6.

人刻意将“腋下”“耳前”“目外眦”这些与足少阳脉密切相关的部位串联起来。而《十二脉》与老官山漆人之间的循行路线可以相互接续补充，笔者推测，可能因漆人本身难以刻画出“贯腋”这样的循行路线，加之漆人头部位位置面积有限，故将足少阳脉的止点刻画至腋下便停止，又在医简《十二脉》中加以补充，若将老官山漆人与《十二脉》的循行路线结合在一起，便近似于《灵枢·经脉》篇的足少阳脉循行路线，老官山《经脉》残简中足少阳脉的循行路径经过“(足)小指之次，循外踝前廉，上循□/□□膂外廉”，也与《灵枢·经脉》高度相似。马王堆《足臂》《阴阳》足少阳脉起点一致，均位于踝前，而老官山漆人、《经脉》残简起点在小趾次趾，《足臂》“其病”中，已出现“病足小指次指废”，证明足少阳脉起点从脚踝移向足趾末端的过程中，受到了临床实践经验积累的影响，实际上这一情况也见于其他经脉。足小趾次趾也是《灵枢·经脉》篇足少阳脉的止点，但双包山木人的止点则在“足底外侧”，提示秦汉时期在足少阳脉循行路径从由脚踝向足趾末端延伸的过程中，出现了认识上的差异，极有可能是归属于不同医学流派所致，最终《灵枢·经脉》篇的编者采纳了老官山漆人所代表的经脉理论体系（可能与《足臂》提及“足小指次指废”相关，也可能是循行至足趾末端的这种形式能够更好地构建经脉环形流注体系），可见，《灵枢·经脉》篇的成书参考了先秦两汉时期不同针灸流派的理论认识，并最终加以整合而成。

足少阳脉主干与分支的情况，通过对比出土文献、文物与《灵枢·经脉》，可以发现从外踝前至腋下的经脉循行较为一致，足少阳脉从腋到目外眦之间有两种不同的走行方式，其中《足臂》与《灵枢·经脉》从耳后上行，而《阴阳》《十二脉》从耳前上行。《足臂》有一条支脉“枝之肩髃”，《阴阳》、双包山木人、《十二脉》均无分支，老官山漆人经考察有两条支脉，整理人员称为“从髀枢斜行至乳内廉交足阳明”“从髀枢向后斜行至肩胛交下背（左右）2线”，老官山漆人支脉的特点明显，均从髀枢发出，一条走向前胸与足阳明脉相联系，一条走向后背与足太阳脉相联系，与《足臂》相同之处是，支脉均与肩胛相关。《灵枢·经脉》足少阳脉有2条支脉，其中，支脉1：“从耳后入耳中，出走耳前，至目锐眦后”；支脉2：“别跗上，入大指之间……还贯爪甲，出三毛”，推测支脉1是为联系《阴阳》足少阳脉止点“目眦”“耳前”而设，《灵枢·经脉》篇足少阳脉首次与脏腑（肝

胆)相联系。支脉2则是为与肝足厥阴之脉相联系,肝经起始处为“大指丛毛之际”,胆经第2条支脉其止点就是“还贯爪甲,出三毛”,“三毛”是足大趾爪甲后生毛处,实际上,“三毛”所在之处才是秦汉时期大敦穴的准确位置(参见“先秦两汉腧穴演变分述”中对大敦穴的梳理),支脉2明显是为构建十二脉环形流注体系而设立。另外,《灵枢·经脉》足少阳脉的循行路径上还有“其支者,别锐眦,下大迎……以下胸中,贯膈络肝属胆……横入髀厌中”,此处虽言“其支者”,其实描述的是经脉主干的循行,并且借其构建了经脉(足少阳脉)-脏腑(肝、胆)相关。足少阳脉与脏腑之间的联系,已知的出土文献、文物中并未出现,仅在《灵枢·经脉》中提及。

在联系官窍方面,《足臂》足少阳脉循行与耳、目外眦联系,其官窍病症中便有“聋”“耳前痛”“目外眦痛”,体现循行路径与主治病症的一致性,《阴阳》足少阳脉循行与耳相联系,即“出耳前”,但“是动则病”与“其所产病”中并未出现耳部相关病症,《灵枢·经脉》足少阳脉与目外眦、耳联系,并且通过支脉“从耳后入耳中,出走耳前”,但是其经脉病症中却只有目外眦痛,并未出现耳部病症,不过在其他篇章中提到了足少阳与耳部病症有联系,如“少阳之厥,则暴聋”(《素问·厥论》)“少阳终者,耳聋”(《灵枢·终始》)。

在病症演变方面,《足臂》足少阳脉主治病症与经脉循行方向相关,《足臂》足少阳脉的循行路线可以大致归纳为“外踝前→骨间→膝外廉→股外廉→胁→肩髃→腋→项、耳→枕→目外眦”,《足臂》足少阳脉的主治病症也大致按照这一部位顺序进行排列“足小指次指废,肱外廉痛,肱寒,膝外廉痛,股外廉痛,髀外廉痛,胁痛,肩痛,产马,缺盆痛,癭,聋,枕痛,耳前痛,目外眦痛,胁外肿”,“产马”是指发生在腋下的疾病,张家山《脉书》:“(病)在夜(腋)下,为马。”《说文·疒部》中“癭,目病。一曰恶气着身也,一曰蚀创”可以参考。此外,“胁外肿”位于“目外眦痛”之后,应该是后人补入的病症。《阴阳》足少阳脉主治病症分为“是动则病”和“其所产病”两种,其中“其所产病”也是按照经脉循行路线进行排列,但是与经脉循行方向相反,《阴阳》足少阳脉“其所产病”中的“足中指痹”与其他出土文献不符,《足臂》作“足小指次指废”,《十二脉》作“足小

指之次指痛”，赵京生先生认为《阴阳》“足中指痹”是与足阳明脉混淆所致^[1]。“是动则病”所归纳的症状较为特殊，即“心与胁痛，不可以反侧，甚则无膏，足外反”，称之为“阳厥”，“厥”字在上古作为虚词使用^[2]，后来在医学典籍中“厥”有了特殊含义^[3]，如《释名·释疾病》^[4]：“蹶，气从下蹶起上行，外及心胁也。”《内经》中“厥”的含义也较多，单独使用时有“气逆”“神昏”等含义，与其他字组合使用时含义更广^[5]，《内经》之后，“阳厥”常作为阳气厥逆的简称，如杨上善曰：“甚为阳厥，热盛也。”张景岳：“足外反热，本病从火，故为阳厥。”《中藏经·卷上》中有“阳厥论”“阴厥论”两个专篇，其中“阳厥”表现出一派火热上逆症，如“咽干口焦，舌生疮”“双睛似火，一身如烧”等^[6]。但需注意，出土文献及《内经》中“阳厥”与热证还未建立关系，考察帛书《阴阳》中对诸脉“厥证”的命名，如下表所示：

表 12 帛书《阴阳》是动病“部位+厥”命名

巨阳脉	少阳脉	阳明脉	少阴脉	臂巨阴脉	臂少阴脉
踵厥	阳厥	骭厥	骨厥	臂厥	臂厥

《阴阳》对“是动病”主要是以“身体部位+厥”进行命名，并无阴阳寒热偏盛偏衰的因素在内，足少阳脉“是动病”的一系列症状称为“阳厥”，“阳厥”可能是“少阳脉发生厥证”的简称，并非是“阳气厥逆”的热证。

《阴阳》足少阳脉“是动病”所包含的症状便是“阳厥”的具体表现：其中，“心与胁痛”即“心胁痛”，《素问·脉解》对“心胁痛”的病机阐释为“少阳谓心胁痛者，言少阳盛也，盛者心之所表也。九月阳气尽而阴气盛，故心胁痛也”，对于“不可以反侧”的病机阐释为“阴气藏物也，物藏则不动”，落脚点均在于“阴气盛”，“甚则无膏”在《灵枢·经脉》中写作“甚则面微有尘，体无膏泽”，“面微有尘”是指面色灰暗，“体无膏泽”是指皮肤缺乏红润光泽，“足外反”中，“反”

[1] 赵京生. 阳经五官病候及治疗用穴分析——兼论经脉病候与腧穴主治关系[J]. 针刺研究, 2007(06): 411-418.

[2] 刘俊莉. 试论“厥”在上古的历史演变[J]. 襄阳师专学报, 1998, 19(01): 49-52.

[3] 郭培杰. 古籍中厥病的文献研究[D]. 北京中医药大学, 2013: 77.

[4] [汉]刘熙; [清]王先谦撰集. 释名疏证补[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1984: 398.

[5] 彭榕华, 高驰, 段逸山. 释“厥”[J]. 中华中医药杂志, 2016, 31(08): 2899-2904.

[6] [汉]华佗(托名). 中藏经[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2007: 4.

在《说文解字》中释为“覆”，意为足寒而外覆盖以物，“甚则”说明“阴气盛”的情况加重，《素问·厥论》称：“阴气盛，则从五指至膝上寒，其寒也，不从外，皆从内也。”因此“甚则无膏，足外反”均是寒邪加重的变现，《素问·解精微论》：“夫人厥则阳气并于上，阴气并于下。阳并于上则火独光也；阴并于下则足寒，足寒则胀也。”《灵枢·癫狂》：“厥逆为病也，足暴清。”《素问·通评虚实论》：“气逆者足寒也。”“阳厥”在《内经》中见于两处，一处是《素问·病能论》中将“病怒狂者……善怒”称为“阳厥”；另一处就是《灵枢·经脉》中胆足少阳之脉的“是动病”，此处“阳厥”为“阳气尽而阴气盛”之意，此外，《灵枢·经脉》将《阴阳》“足外反”后加一“热”字，即“足外反热”，学界多认为“热”为衍文，笔者认为，若按《说文解字》，将“反”释为“覆”，那么“足外覆热”实际上是针对“足寒”进行热敷治疗，查《灵枢·刺节真邪》言：“治厥者，必先熨调和其经，掌与腋，肘与脚，项与脊以调之，火气已通，血脉乃行，然后视其病，脉淖泽者，刺而平之，坚紧者，破而散之，气下乃止，此所谓以解结者也。”那么，“足外覆热”之目的就在于使“火气通，血脉行”，符合秦汉医家诊疗思维。《灵枢·经脉》主治病症与《阴阳》有较高的重合，在“是动则病”中又增加了“口苦”“善太息”，两者均为胆腑病症，如“胆虚气上溢而口为之苦”（《素问·奇病论》），实际上是属于脏腑辨证混杂入经脉辨证中的典型。

2.1.12 足太阳脉

2.1.12.1 出土文献、文物足太阳脉考订

马王堆《足臂十一脉灸经》

足泰（太）陽溫（脈）：出外踝窻^[1]（婁）中，上貫臑（臑），出於郤^[2]（却）；枝之下臑^[3]；其直者貫臀^[4]，夾（挾）脊，出項^[5]，上於豆（頭）；枝顙（顙）下，之耳；其直者貫目內漬（眦），之鼻。其病_二（病：病）足小指廢，臑（臑）痛，臑^[6]（攣）（攣），脾^[7]痛，產（產）寺（痔），嬰（要-腰）痛，夾（挾）脊痛，北^[8]（背）痛，項痛，手（首）^[9]痛，顙（顙）寒，產聾，目痛，𩑦（𩑦）𩑦（𩑦），數瘖（癰）疾。諸病此物者，皆久（灸）泰（太）陽溫（脈）。

马王堆《阴阳十一脉灸经》（甲本）

【鉅陽脈（脈），𩑦（繫）於潼外踝婁中，出却中，上穿振（臀），出𩑦（𩑦）中，夾（挾）脊，出於項，上頭角，下顙（顙），夾（挾）𩑦，𩑦（繫）目內廉。是動（動）則病：衝（衝）頭，目以（似）脫，項以（似）伐，胃（胸）痛，腰以（似）折，脾（脾）不可以運，臑（却）如結】，臑如【裂，此】為踵（踵）𩑦（𩑦一𩑦），是鉅陽脈（脈）【主治。其所產病：頭痛，耳聾，項痛。耳】強，瘡，北（背）痛（痛），嬰（要—腰）痛（痛），尻痛（痛），痔（痔），臑（臑—却）痛（痛），臑痛（痛），【足小】指踝<𩑦—瘖>，【為十】二病。

^[1] 裘锡圭：帛书“婁”本从宀作婁，原释文作从穴的“婁”，失之。经过核查图版，裘说是。

^[2] 整理小组原来写作“臑”，经过核查原图版，应该写作“郤”，“郤”通“却”，指膝关节后方的腘窝，《素问·刺腰痛篇》王冰注：“膝后两旁，大筋双上，股之后，两筋之间，横文之处，努肉高起，则郤中之分也。古《中诂》以腘中为太阳之郤”。

^[3] 原整理小组识为“脾”，经过核查图版，左边“月（肉）”旁比较清楚，右边则难释，因此裘锡圭等认为应该识作“臑”，黄龙祥认为此字系“脾（脾）”之俗讹，可从。

^[4] 原释文贯后缺一字，整理小组写作“贯口”，老官山汉简《十二脉》足太阳脉循行此处为“直者贯尻夹脊”，而《灵枢·经脉》篇足太阳脉循行“其直者，从巅入络脑，还出别下项，从腰中挟脊贯臀，入腘中”，所以此处补入“臀”或“尻”均可，《声类》：“尻，臀也。”两字义相同，学者多补入“臀”字，故从，写作臀。

^[5] 夹（挾）脊后缺两字，原释文作“夹（挾）脊，口口”，《阴阳》甲本此处残缺，乙、丙本作“出于项”，老官汉简《十二脉》写作“以上出项”，因此补入“出项”。

^[6] 原释作“臑”，核查图版后，依裘锡圭等厘定，应作“臑”，“臑攣”意为腓肠肌痉挛。

^[7] 此处原整理小组识作“脾”，经查图版后，依《集成》识作“脾”。《说文》尸部：“尻，脾也。”前文经脉循行“其直者贯臀”，因此“脾”可释为“臀”。

^[8] 夹（挾）脊痛后原残缺一字，裘锡圭所编《集成》补“头”字，刘春语认为当补入“北（背）”字，观此残缺前为“夹（挾）脊痛”，后为“项痛”，两者之间补入“北（背）痛”更加合理，故从刘说。

^[9] 足阳明脉不经过上肢，此处“手”应该是“首”，为帛书抄写者失误，古代抄写帛书，有一人读，另一人写的情况，猜测可能是听写失误导致。

马王堆《阴阳十一脉灸经》(乙本)

【鉅陽脈：• 𦵏（繫）于】踵（踵）外踝（踝）婁中，出却中，上穿振（臀），出猷（猷）中，夾（挾）脊，出于項，【上】頭角，下顏（顏），夾（挾）髑（髑），𦵏（繫）目內廉。是僮（動）則病：踵（衝—衝）頭，【目以（似）脫，項以（似）伐，胃（胸）】痛，嬰（要—腰）以（似）折，脾（脾）不可以運，【胎（却）如結，腦如裂，此為踵（踵）】厥，是巨（鉅）陽腓（脈）主治。其所產病：頭痛，耳聾，項痛，耳彊，瘡（瘡），北（背）痛，嬰（要—腰）痛，尻【痛】，痔（痔），胎（却）痛，腦痛，足小指【痺】，為【十二病】。

张家山《脉书》载《阴阳十一脉灸经》(丙本)

• 鉅陽之脈，𦵏（繫）於踵（踵）外踝【婁】中，出脛（却）衷（中），上穿腓（臀），出壓（猷）中，夾（挾）脊，出於項，上頭角，下顏（顏），夾實<頤>，𦵏（繫）目內廉。是動（動）則病：衝（衝）頭，目以（似）脫，項以（似）伐，胃（胸），要（腰）以（似）折，脾（脾）不可運，胎（却）如結，腦如裂，此為踵（踵）蹶，是鉅陽之脈主治。其所之（產）病：頭痛，耳聾，項痛，濡強，瘡，北（背）痛，要（腰）痛，尻痛，痔（痔），胎（却）痛，腦痛，足小指蹶<蹶>，為十二病。

老官山《十二脉》

• 足大（太）陽脈，𦵏（繫）足小指，循足腓外廉，出外果（踝）后脛中，循[腦]而上，出[肱]中以上，其支者入州，直者貫尻夾脊，以上出項，上頭角，夾頤，下顏頤，𦵏（繫）目內眦。其病：□□，顏痛，訖衄，頭痛，北（背）痛，夾脊痛，脊強，要（腰）痛，尻脾（脾）痛，痔，州痛，肱痛，腦痛，踵与果（踝）痛，足小指𦵏（痺）。癲狂，回目，目莫（暮）如毋見，□目，□踵，頭瘡風^[1]。

老官山《经脉》残简

• 大阳脉，起足小指外廉，循外踝后，以上𦵏（膝）□……□□腦皆痛□□^[2]。

^[1] 黄龙祥. 老官山出土汉简脉书简解读[J]. 中国针灸, 2018, 38(01): 97-108.

^[2] 顾漫, 周琦, 柳长华, 等. 天回医简《经脉》残篇与《灵枢·经脉》的渊源[J]. 中国针

老官山漆人足太阳脉

具体循行路线，目前公开发表的资料中有两个版本，笔者依据论文发表的年份，简称为“2017年”^[1]和“2022年”^[2]。

“2017年”循行路线：第一侧线起点位于“小趾外侧”，在脚踝后方交第二侧线后，向上经过腓中、臀部、脊柱两侧、项、后头部、巅顶、目内眦，止点位于鼻。第二侧线起点在“跟中”，在脚踝后与第一侧线相交后，走行于第一侧线外侧，循行路径与第一侧线大致平行，止点位于目上正中。分支1从腓中发出，止点在肛（左右均从第一侧线分出）；分支2从肩胛下发出，止点在胸前壁（左侧从第二侧线，右侧从第一侧线）。

“2022年”也提到了老官山足太阳脉的循行路径，差异之处在于：

1：第一侧线在足外踝下发出一条分支（即图21中line 12-2，止于足少阳脉，而且左侧的分支line 12-2在中点处又发出了line 12-2-1，向后止于第二侧线）。

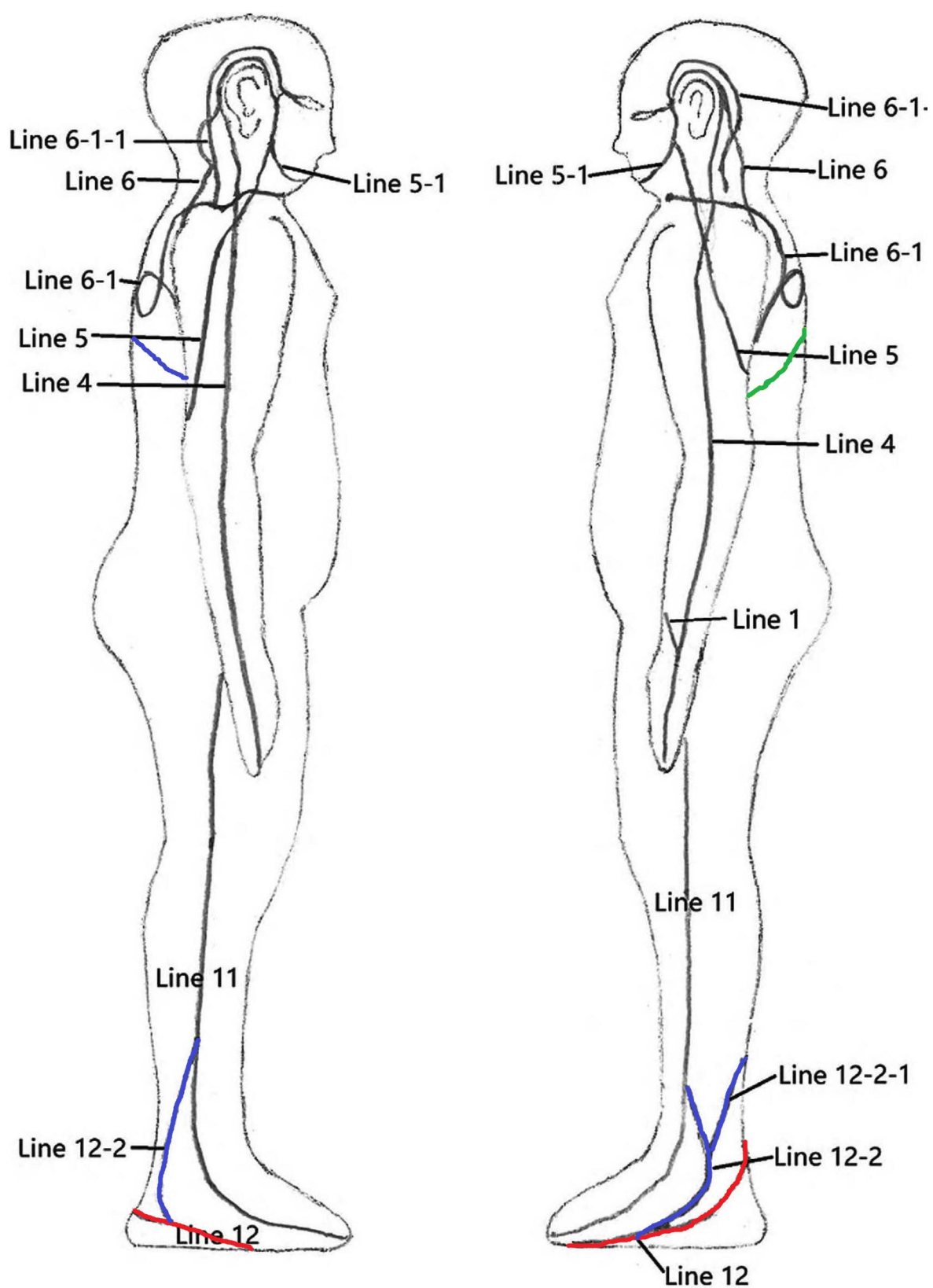
2：并未提到分支2（左侧从第二侧线，右侧从第一侧线）：肩胛下→横行至胸前壁→左右相关（笔者仔细观察发现，分支2确实存在，但仅能从背面图中看到肩胛下到腋下这一段，而“横行至胸前壁→左右相关”由于正面图较为模糊，无法辨认）。

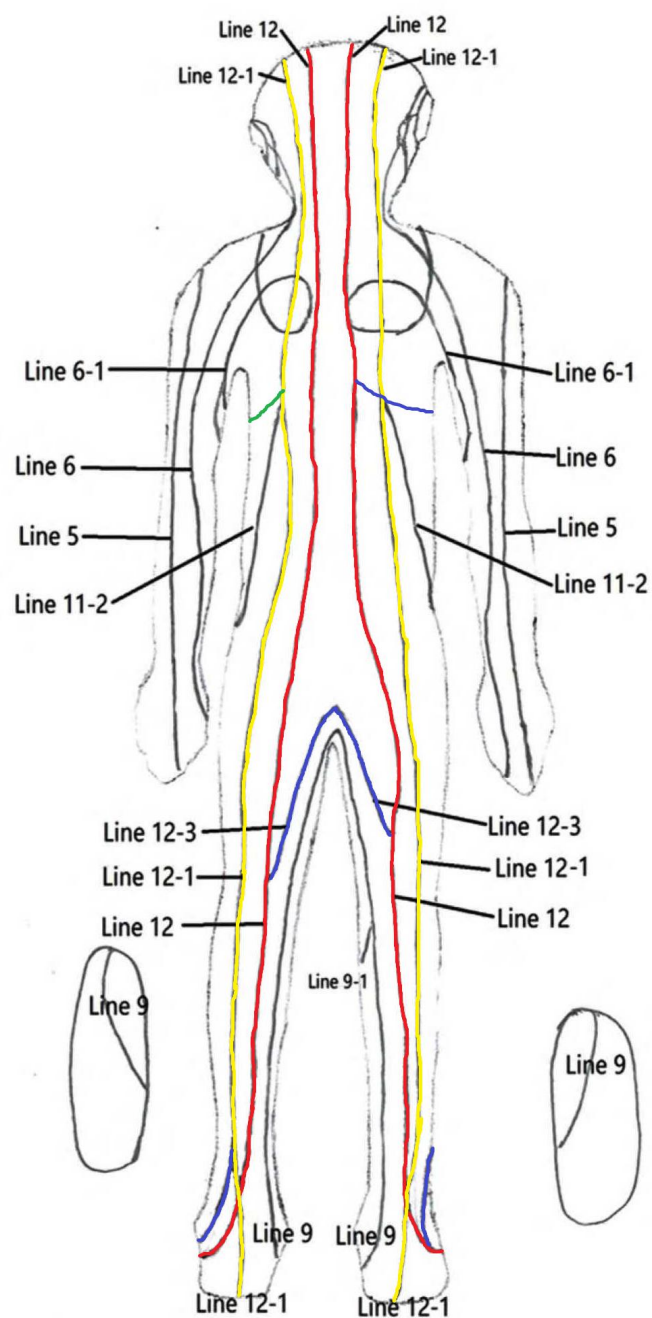
笔者综合整理两个版本的循行路线后，用不同颜色绘出老官山漆人足太阳脉体表循行：第一侧线用红色，第一侧线分支用蓝色，第二侧线用黄色，第二侧线分支用绿色。

灸, 2019, 39(10): 1117-1123.

^[1] 印帅, 曾芳, 周兴兰, 等. 成都老官山汉墓髹漆人像足太阳经脉循行浅析[J]. 辽宁中医杂志, 2017, 44(06): 1281-1283.

^[2] 程施瑞, 周兴兰, 邱科, 等. 成都老官山汉墓经穴髹漆人像十二经脉循行考证(英文)[J]. World Journal of Acupuncture-Moxibustion, 2022, 32(01): 40-48.





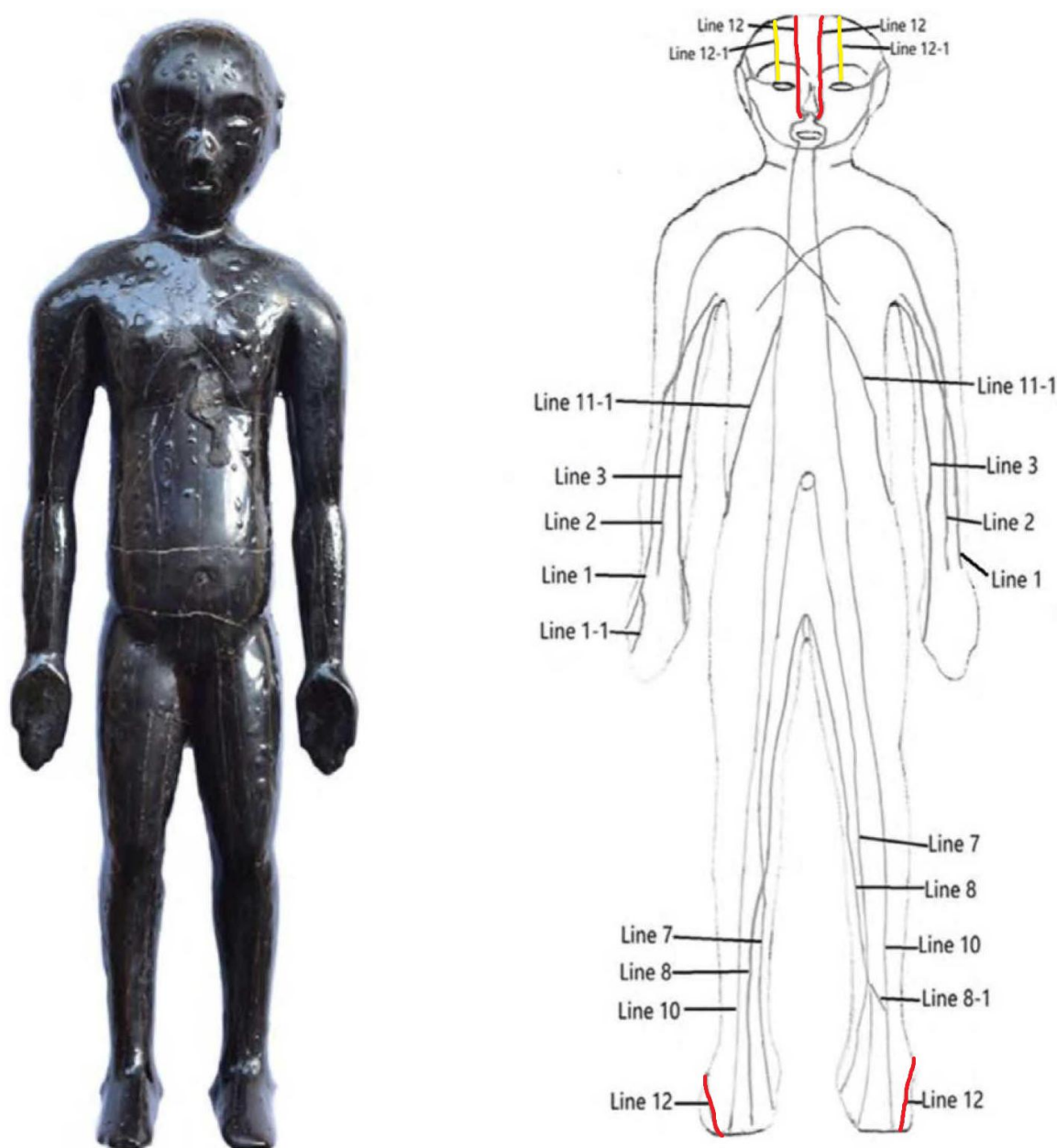


图 21 老官山漆人足太阳脉循行路径（侧面观、背面观、正面观）

双包山木人足太阳脉

本脉有一条主干，一条分支，主干（图 22 中红色线）起于鼻孔外侧，向上经过目内眦、眉头、前额、巅顶（与督脉平行），而后继续与督脉平行向下经过后头部、项、脊柱两侧、腰部，大概在第十二椎处发出分支（图 22 中蓝色线），分支向前下部走行，于侧腹部并入足少阳脉，主干继续向下经过大腿后面正中，穿过腘窝，经过小腿后侧正中，向下到达足跟，止于足跟下方^[1]。

^[1] 马继兴. 双包山汉墓出土的针灸经脉漆木人形[J]. 文物, 1996(04): 55-65+98.

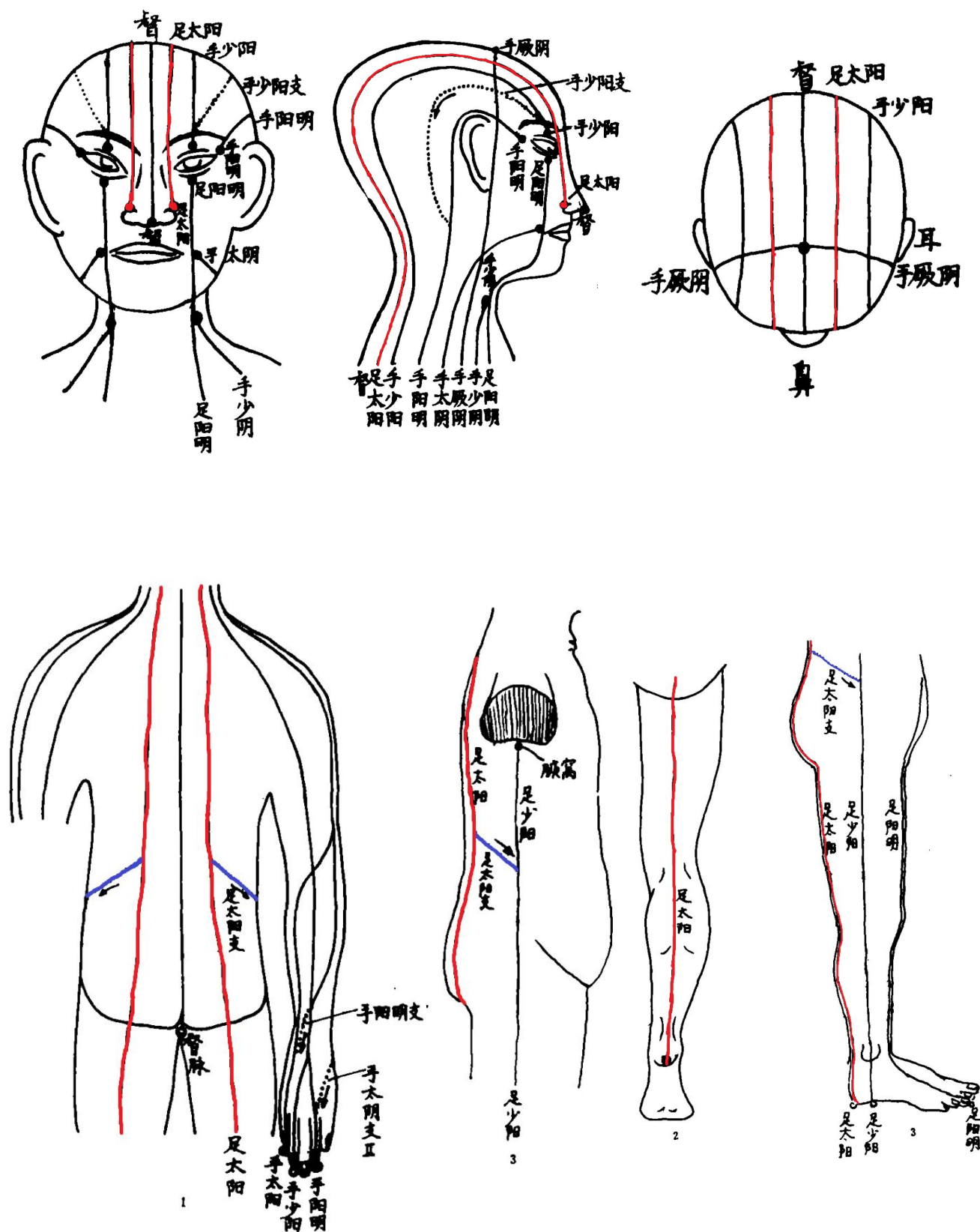


图 22 双包山木人足太阳脉循行路径

2.1.12.2 讨论

表 13 先秦两汉足太阳脉演变特点对比

	《足臂》	《阴阳》 (甲本)	《阴阳》 (乙本)	《阴阳》 (丙本)	《十二脉》	老官山漆人	双包山木人	《灵枢·经脉》
命名	足泰陽溫	鉅陽脈	鉅陽脈	鉅陽之脈	足太陽脈	/	/	膀胱足太陽之脉
起点	外踝婁中	外踝婁中	外踝婁中	外踝婁中	足小指	第一侧线:小趾外侧 第二侧线:跟中	鼻孔外侧	目内眦
止点	鼻	目内廉	目内廉	目内廉	目内眦	第一侧线:鼻 第二侧线:目上	足跟下方	小指外侧
流注方向	向心性	向心性	向心性	向心性	向心性	向心性	远心性	远心性
支脉	2条	无	无	无	1条	第一侧线:3条 第二侧线:1条	1条	2条
脏腑	无	无	无	无	无	/	/	
官窍	目、耳、鼻	目内廉	目内廉	目内廉	目内眦	第一侧线:目内眦、鼻、肛 第二侧线:目上	鼻、目内眦	目内眦、耳

马王堆帛书《足臂》《阴阳》足太阳脉呈向心性流注（《足臂》由外踝→鼻，《阴阳》由外踝→目内廉），老官山漆人足太阳脉参考《十二脉》，可知也是向心性流注，双包山木人足太阳脉的循行方向经马继兴先生考证为远心性，《灵枢·经脉》篇中膀胱足太阳之脉的循行方向也是远心性（由目内眦→小趾外侧），对于经脉循行方向有“远心性”和“向心性”这两种不同的循行模式，有学者认为或许是早期医家已经观察到经气运行方式的多样性，即现代研究所称的“双向传导”^[1]，但目前出土的经脉文献中，尚未见到同一篇文献中记载有经气可以双向传导的情况，因此这一说法还有待商榷。

诸文献、文物足太阳脉之间最显著的差异在于起止点的位置，《足臂》《阴阳》起点在外踝，而老官山漆人、《十二脉》的起点在足小指外侧，明显向四肢末端移行。在联络脏腑方面，老官山漆人、双包山木人的经脉循行只能刻画在体表，无法展示体内的脏腑属络情况，《足臂》《阴阳》未提及脏腑属络，《灵枢·经脉》提到“入络脑”“络肾属膀胱”。在联络官窍方面，《足臂》足太阳脉“之耳”“贯目内眦”“之鼻”，下肢三阳脉中，《足臂》足太阳脉与官窍联系最多，在经脉病症中

^[1] 印帅,曾芳,周兴兰,等. 成都老官山汉墓髹漆人像足太阳经脉循行浅析[J]. 辽宁中医杂志, 2017, 44(06): 1281-1283.

有“聋”“目痛”“鼯衄”与之对应；《阴阳》足太阳脉“系目内廉”，在“是动病”中有“目似脱”；老官山《十二脉》足太阳脉“系目内廉”，在疑似后补条文中有多目病如“回目”“目莫如毋见”等，表现出经脉循行与经脉病症的高度一致性；老官山漆人体表循行联系“目、鼻、肛”；双包山木人联系“目内眦、鼻孔外侧”。可见，出土文献中足太阳脉联系最多的官窍是“目、鼻”，《灵枢·经脉》足太阳脉与“目、耳”相连，但经脉病症包含目与鼻的症状，如“目似脱”“目黄泪出”“鼯衄”，并未出现耳部病症。《素问·脉解》在解释足太阳脉的病症时，提到了“耳鸣”，表明《素问·脉解》篇作者所看到的文献中，足太阳脉病症包括“耳鸣”。

从经脉主干与分支的情况来看，经脉主干方面，除老官山漆人外，其余文献、文物足太阳脉均只记载一条主干，而老官山漆人背部左右两侧分别有两条纵行的白线，整理小组对比《灵枢·经脉》以及其他出土经脉文献后，认为其属于足太阳脉，并且两条线之间没有主次之分，依据距离后正中线的远近关系，分别命名为“第一侧线”“第二侧线”，左右两侧白线呈对称分布，近乎平行，相交点位于足跟，其中第一侧线与其他文献、文物记载的足太阳脉相似。足太阳脉走行于背部，背部范围较广，仅有一条主干不足以囊括先民在医疗活动中逐渐积累的治疗刺激点（即后世的腧穴），这可能是促使老官山漆人足太阳脉出现两条主干的一个重要原因。两条主干之间没有主次之分（或难以区分主次），笔者推测其原因可能是漆人身体背部面积太小，难以刻画出两者的差异，也可能是老官山墓主人所传承的经脉理论体系中，足太阳脉本身就是双线并行的。

足太阳脉的分支情况，诸文献、文物中记载的差别较大，《足臂》有两条分支，即“枝之下腓”“枝颜下，之耳”，此处“枝”是分支，而“之”意为“到达”。《阴阳》足太阳脉未记载经脉分支，老官山《十二脉》记载“足大（太）阳脉……其支者入州”，黄龙祥先生认为，《十二脉》是将《足臂》的“腓”改为了“州”字，有“髀枢”之意^[1]。老官山漆人支脉比较复杂，除与肛、胸前壁联系外，两条侧线在足部也通过支脉进行相互联系，老官山漆人分支入肛，可能参考了《足臂》足太阳脉病症中有“产寺（痔）”。双包山木人足太阳脉的支脉从腰部发出，分布在侧腹部。《灵枢·经脉》篇中足太阳脉有2条分支，分别是“其支者，从巅至耳上

^[1] 黄龙祥. 老官山汉墓出土针方简解读[J]. 中华医史杂志, 2018, 48(02): 18.

角”“其支者，从髀内左右……下合膕中”，此外，循行路线中“其支者，从腰中下挟脊贯臀，入膕中”，笔者认为应视做为主干。

《足臂》足太阳脉的起始处为“出外踝窻（婁）中”，但是在其病候中已出现“病足小指废”，此处“指”是指“足趾”，而“废”意为“无用、作废、毁坏”，马继兴先生指出，古代医家习惯将运动障碍称为“不用”，将感觉障碍称为“不仁”，“废”则兼有运动、感觉障碍的意思。《足臂》足太阳脉经脉循行起始处在脚踝，但是所主病症已经延伸至足趾端，这是经脉起始处从腕踝移向四肢末梢的一个征兆。出土文献、文物中足太阳脉循行均经过了“外踝→膝→臀→背→项→头→目→颜”，整体上又保持了一致性，从局部来看，出土文献文物中（老官山漆人除外），足太阳脉均以足至腰为经脉主干，而膕窝到项的路径差异较大^[1]，表明经脉理论来源不同，也提示先秦两汉时期经脉理论的多样化。

足太阳脉主治病症的演变：《足臂》足太阳脉循行部位与主治病症吻合度较高，其循行所经过的部位可简化为“外踝窻→膕→郄→腓→臀→脊→项→头→颜、耳→目内眦→鼻”，主治病症也主要是循行部位的痛症。其中“颜寒”一症，马继兴先生按照字面意思释为“颜面部发凉”，老官山《十二脉》作“颜痛”，笔者认为，“寒”在此处有“邪气”之意，如战国儒者孟子提到阿谀奉承的小人对君王不利时称“吾退而寒之者至矣”^[2]，再如《难经·五十八难》中描述：“伤寒有五，有中风，有伤寒，有湿温，有热病，有温病。”我们习惯称之为“广义伤寒”，此处“寒”泛指一切邪气，并非仅仅是自然界气候异常，因此“颜寒”可以理解为颜面部有邪气，相当于老官山《十二脉》中的“颜痛”。“数癫疾”在简帛医书足太阳脉主治病症中除《足臂》外，老官山《十二脉》疑似后增条文中也提及“癫狂”，“数”为多次、反复之意，《广雅》：“瘖，狂也。”故“数癫疾”意为狂病反复发作。《阴阳》足太阳脉未记载，《灵枢·经脉》称“狂癫疾”，并将其归于“所生病”中。

《阴阳》足太阳脉分为“是动则病”与“其所产病”两大类型，多为经脉循行部位所产生的病症。值得注意的是，其中有部分病症与外感表证相似，如“是动则病”中的“冲头”“目似脱，项似伐”，“其所产病”中的“头痛”“项痛”“疟”“背痛”等，在简帛医书时代，足太阳脉最先与外感表证建立了联系，而后在《灵

^[1] 陈晓红. 简帛医书经脉文献比较研究[D]. 广西中医药大学, 2020.

^[2] [战国]孟轲. 孟子[M]. 长沙: 岳麓书社, 2000: 188.

枢·经脉》中才让位于肺手太阴脉，前者是在经脉辨证下形成的，而后者是在脏腑辨证基础上形成^[1]，这样一来，便形成了外感表证的经脉在足太阳脉，而内脏在肺的理论模式^[2]，对后世医家外感表证的辨证与治疗产生了极大的影响，《伤寒论》将外感表证统归于“辨太阳病脉证并治”，如“伤寒一日，太阳受之”，仲景在茯苓桂枝白术甘草汤条文中提到“发汗则动经”，在抵挡汤条文中提到“以太阳随经”，这里“动经”“随经”指的便是足太阳脉^[3]，体现外感表证与太阳脉之间的密切关系。“冲头（痛）”这一病症，刘阳先生等通过考证认为指“头内似有撞突而痛”^[4]。“目似脱”“项似拔”“腰似折”“脊如结”“膈如裂”连用五个比喻，形象地描述了目、项、腰、脊、膈几个部位病变的主观感受特点^[5]。老官山《十二脉》主治病症也主要以循行部位的病变为主，在“足小指痹”之后的病症与经脉循行关系不大，疑为后人所补入，即“癫狂，回目，目莫（暮）如毋见，口目，口踵，头疟风”，老官山《经脉》残简中足太阳脉的循行以及病症与《灵枢·经脉》接近，后者足太阳脉主治病症的形成受多种简帛医书的影响^[6]。

[1] 赵京生. 阳经五官病候及治疗用穴分析——兼论经脉病候与腧穴主治关系[J]. 针刺研究, 2007(06): 411-418.

[2] 赵京生. 阳脉理论演进及其意义[J]. 中国针灸, 2011, 31(11): 1035-1039.

[3] 王峰. 《足臂》《阴阳》《内经》与伤寒六经提纲病症的联系研究[D]. 云南中医学院, 2017: 13.

[4] 刘阳, 顾漫. 足太阳经病“冲头”“冲头痛”辨义[J]. 中华医史杂志, 2018, 48(04): 228-231.

[5] 天津中医学院第一附属医院针灸科. 石学敏针灸临证集验[M]. 天津: 天津科学技术出版社, 1990: 551-554.

[6] 杨峰, 赵京生. 从简帛医书看《内经》足六脉病候[J]. 中国针灸, 2007(11): 865-868.

2.2 奇经八脉理论演变梳理

2.2.1 冲脉

冲脉在出土文献中均未提及，在秦汉时期的传世文献，则集中体现在《内经》《难经》中，《说文·水部》：“冲，涌繇也。”^[1]“冲”即“冲”，段玉裁注“涌”为“上涌”，而“繇”为“旁摇”，意为冲脉的特性是向上涌动，病理状态下，脉气向上涌动太过，则容易出现相关病症，如《素问·骨空论》称：“冲脉为病，逆气里急。”^[2]因此，冲脉之“冲”，最初的含义就是指脉气向上涌动。李时珍在《奇经八脉考》中也称：“冲直而通，故谓之冲。”^[3]此外，冲脉在《灵枢·百病始生》《灵枢·岁露论》中称之为“伏冲之脉”，病变时主要出现的症状是“体重身痛”。在《素问·上古天真论》中还称之为“太冲脉”，论述其对于人体生长衰老过程中，尤其是女性生殖功能方面的重要性，如“太冲脉盛”，则月事正常，也能生子，但是“太冲脉衰少”就会使得妇人“形坏而无子也”，将太冲脉与任脉功能等同。

冲脉循行记载较为复杂，仅其起点所在位置便有数种说法，如《素问·骨空论》认为冲脉起点在“气街”，其循行路径合并于足少阴脉，止点在于“胸中而散”，病理状态下可出现“逆气里急”，这一描述在《难经·二十八难》作：“冲脉者，起于气冲……夹脐上行，至胸中而散也。”^[4]《难经》中“气冲”实际上指的就是“气街”。

《灵枢·五音五味》中将冲脉与任脉合并而论：“冲脉任脉，皆起于胞中，上循背里，为经络之海。”这里所提的冲脉起点位于“胞中”，与任脉沿着脊柱内里上行。但随后又提到“宦者去其宗筋，伤其冲脉”，冲脉与“宗筋”的关系，又见于《素问·痿论》：“冲脉者，经脉之海也……与阳明合于宗筋。”说明冲脉与足阳明脉之间的关系密切。阳明脉的特点，如“多气多血”（《素问·血气形志》）“五脏六腑之海”（《灵枢·五味》）“十二经脉之长”（《素问·热论》），皆与冲脉的特点类似。冲脉与阳明脉之间的关系在明代确立，明如《济阴纲目·调经门》提出了“太冲属阳明，为血之海”的认识^[5]。

^[1] [汉]许慎.说文解字[M].北京:中华书局,2015:229.

^[2] [春秋]佚名.黄帝内经素问[M].北京:人民卫生出版社,2012:217.

^[3] [明]李时珍.奇经八脉考[M].北京:中国医药科技出版社,2012:56,59-60.

^[4] [春秋]秦越人著;南京中医学院校释.难经校释(第二版)[M].北京:人民卫生出版社,2011:59.

^[5] 闫培坦,许昕.明代冲脉与阳明关系的文献研究[J].环球中医药,2019,12(05):708-713.

《灵枢·动输》提及冲脉的性质为“十二经之海”，与冲脉相关者为“少阴之大络”，两者共同“起于肾下”，笔者认为，此处“肾下”，指的是男性睾丸之下，即会阴穴所在位置，后世也有医家将会阴穴认作是冲、任、督三脉的共同起点，盖源于此。随后循行路径与足少阴脉相并，从腹部向下，分布于下肢，止点在“大指之间”。实际上，《灵枢·动输》应该只是描述了冲脉循行的一部分，在《灵枢·逆顺肥瘦》中记载了冲脉更详细的循行路径，首先提及冲脉为“五藏六府之海”（与“十二经之海”同义），随后分别记述了冲脉向上与向下的循行路径及功能，向上“出于颜颡”，其作用是“渗诸阳，灌诸精”，向下的循行则与《灵枢·动输》一致，其作用是“渗诸络而温肌肉”。类似者再如《灵枢·海论》，首先定义冲脉为“十二经之海”，其次提及冲脉循行路径的腧穴分别与“大杼”“巨虚之上下廉”相联系。《素问·举痛论》则认为冲脉的起点在“关元”，循行路径为“随腹直上”，并且认为冲脉容易受到寒邪的侵袭，而张介宾在《类经》中认为关元与胞中实为一物：“冲脉起于胞中，即关元也。”

此外，《内经》中还论述了与女子胞宫相关的一些脉、络，如《素问·评热病论》认为女子闭经的原因主要是“胞脉闭”，而胞脉又属于心，其正常生理功能与心肺相关，若“气上迫肺”，导致“心气不得下通”，就会出现闭经的情况。可见“属心而络于胞中”是胞脉的循行路径，直接将心与女子胞联系起来。《素问·痿论》对女子崩漏（数溲血）从情志不遂角度做了解释，认为“悲哀太甚”是引起“胞络绝”的主要原因，进而引起“阳气内动，发则心下崩”，又与心相关，其中“胞络绝”是主要病机。《素问·奇病论》记载孕期妇女出现“九月而瘖”（《玉篇·疒部》：“瘖，哑不能言。”），也是从胞络角度进行解释，即“胞之络脉绝也……胞络者系于肾，少阴之脉，贯肾系舌本，故不能言。”胞络的循行路径又与女子胞一肾一舌相关，是为解释“人有重身，九月而瘖”这一现象设立的络脉，故胞脉与胞络可看做是冲任二脉的补充。

综上所述，冲脉起点在《内经》中有几种不同的说法，如“气街”“胞中”“肾下”“关元”^[1]，共同特点是均位于少腹部，与少阴、阳明联系较为密切，冲脉的循行路径，有前行支、后行支与下行支^[2]。现代学者对于冲脉的起始部位，

[1] 林琪家. 冲脉古代文献研究[D]. 北京中医药大学, 2011.

[2] 李博灵, 张保亭. 由释名探析冲脉之循行[J]. 中国中医基础医学杂志, 2019, 25(06): 718-720+723.

发表了自己的认识,如衣华强先生认为冲脉的起始部位定为“肾下胞中”较为合适^[1]。在冲脉与临床诊疗之间的联系中,杜元灏先生提出了冲脉与内分泌相关的认识,尤其与“下丘脑—垂体—性腺轴”密切相关^[2],冲脉实际上是起到了沟通上下内外的功能,冲脉与十二正经几乎均有联系^[3],故张介宾称其:“阴阳表里,无所不涉。”有学者对冲脉的现代解剖结构与胚胎发生学进行了探讨^[4],此外也有学者认为冲脉的起点处(气街)有动脉搏动,冲脉沿着前正中线上行也有古人对动脉搏动触诊积累的经验(腹主动脉),黄龙祥先生也认为古人对冲脉的最初认识起源于腹主动脉的诊察过程^[5]。而冲脉循行过程的复杂性,是秦汉时期经脉学说尚未成熟的一个证据,可能属于同时期不同医派独特的见解,又被《内经》编者汇集在一起,从上述“冲脉”“太冲脉”“伏冲之脉”“伏膺之脉”“胞脉”“胞络”诸多名称及含义可见一斑^[6]。

^[1] 衣华强. 冲脉起始部位探析[J]. 上海针灸杂志, 2017, 36(03): 354-356.

^[2] 杜元灏. 从《内经》中冲脉的功能和循行特点探讨冲脉实质——论冲脉与内分泌性腺轴的关系[J]. 中医药学刊, 2006(02): 206-207.

^[3] 闫培烜. 明清两代冲脉与阳明关系的文献研究[D]. 北京中医药大学, 2020.

^[4] 马宁. 冲脉的胚胎发生学探讨[J]. 山东中医药大学学报, 2017, 41(06): 507-511.

^[5] 黄龙祥. 任脉、冲脉概念的形成与演变[J]. 中国针灸, 2002(08): 26-28.

^[6] 李磊, 尤传香. 冲脉循行考[J]. 中华中医药杂志, 2013, 28(01): 190-192.

2.2.2 任脉

老官山漆人体表刻画有 29 条白线，其中有一条大致居于身体前正中线（图 23 中红色线），从目前公开发表的资料来看，老官山汉墓出土医简中并无该脉的文字记载，观察漆人正面照，可见此脉两端分别在“前阴”与“咽”，循行路径与任脉类似，但黄龙祥先生认为应将此脉看做是“冲脉”^[1]。

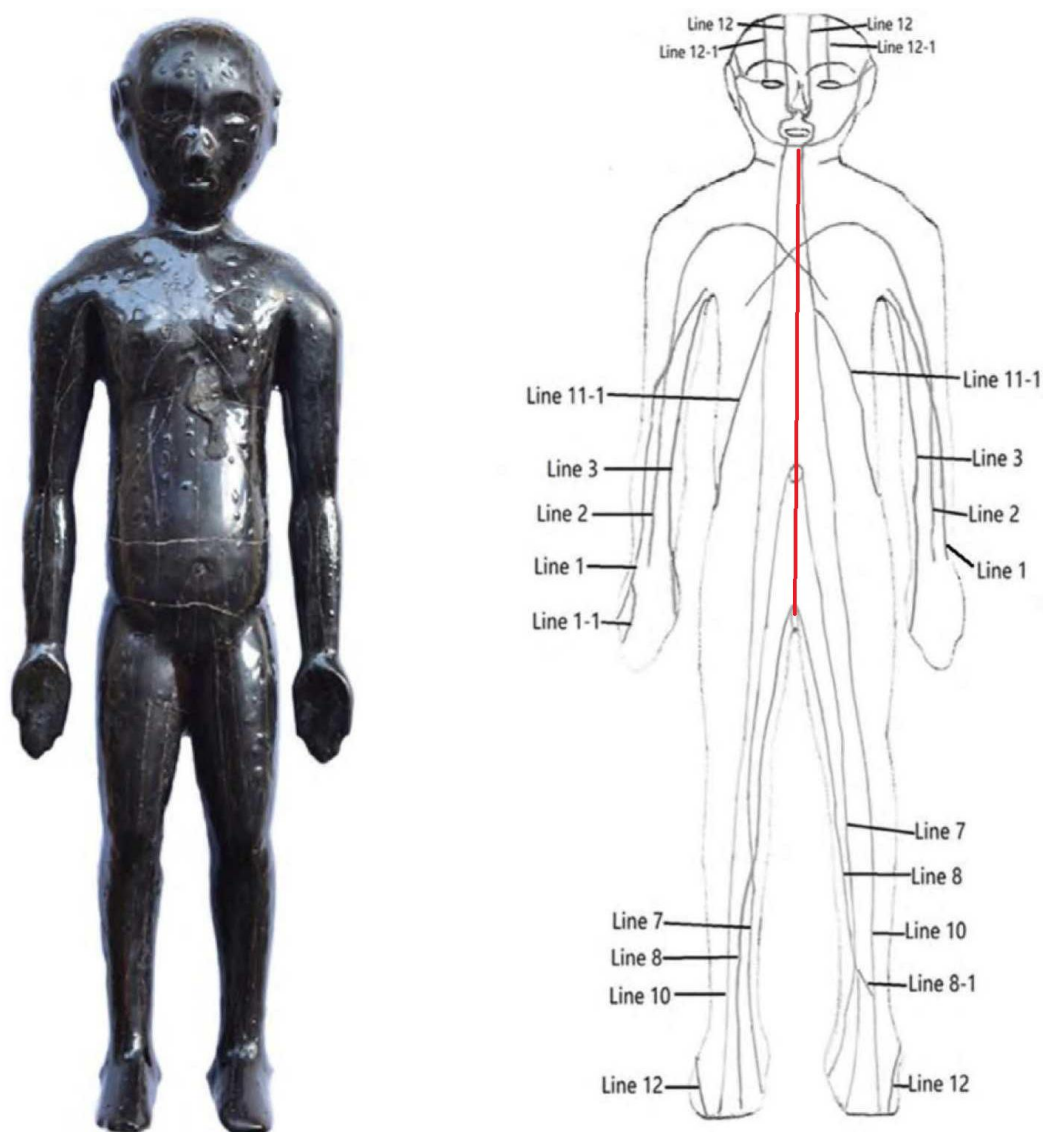


图 23 老官山漆人疑似任脉线循行路径

任脉名称的来源诸学者认识不一，有认为“任”与“妊”同义，即孕胎养子、妊养生育的意思，如王冰称：“所以谓之任脉者，女子得之以任养也。”也有认为

^[1] 黄龙祥. 老官山出土西汉针灸木人考[J]. 中华医史杂志, 2017, 47(03): 131-144+194.

任脉循行前正中线，与衣襟接近而得名，如《素问·绍识》称：“行犹衣衽之在于腹前也。”^[1]此外在女性妊娠期，其腹部中线颜色会变深，肉眼观察较为明显，可能是古代医家为任脉定名的一个原因^[2]。有学者专门对腹中线色素沉着带进行调查研究，发现无论是妊娠期还是青春期女性，出现率均较高，而男性出现率较低，即使男性出现类似的色素沉着带，在形态上也并不明显^[3]。

根据《素问·上古天真论》中对任脉功能的论述，可见秦汉医家一般将任脉与女子生理发育联系起来，尤其是生育功能与任脉密切相关，“任脉通”与“任脉虚”分别是“有子”以及“形坏而无子”的直接原因。女子“二七”之前，任脉可能未通，而“七七”之后，任脉随着人体衰老也开始变得“虚弱”。秦汉医家赋予任脉这种“拟人化”的特性，实际上是将人体生长衰老的正常过程借助任脉进行阐述。《内经》将先天性生殖器官发育不全的男性患者称为“天宦”，对这种患者伴有“须不生”的症状，《灵枢·五音五味》也从任脉角度对其进行解释，由于“任冲不盛”导致血不能荣养唇口，表明任脉对于男性的生长发育过程也是比较重要的。

《内经》中多处记述任脉循行以及功能，且并不一致，如《素问·骨空论》记述了任脉的循行路径以及主治病症，其中任脉循行起点在“中极之下”，止点在“目”，循行过程中“前阴-关元-咽喉”这一段路径与老官山漆人前正中线刻画的白线相似，主治病症集中于少腹部，为“男子内结七疝，女子带下瘕聚”。此外，《素问·气府论》中所记载的任脉所属的腧穴，即“任脉之气所发者二十八穴”，也大致分布在这一循行路线上，尤其是“鸠尾下三寸，胃脘五寸，胃脘以下至横骨六寸半一”后有“腹脉法也”四字进行总结，提示秦汉时期医家已经根据骨度测量法进行定位，并且将这种方法命名为“脉法”，《灵枢·五音五味》中记载了另一种任脉循行路径，冲脉与任脉循行路径似乎完全一致，起点在“胞中”，沿着脊柱内里向上走行，止点在“口”，这一循行路径主要是为阐释冲任二脉与胡须之间的关系，若冲任二脉气血旺盛，则“充肤热肉，血独盛则澹渗皮肤，生毫毛”，而妇女由于月事影响，故“有余于气，不足于血”，使得冲任二脉气血不足，导致“不荣口，故须不生焉”，对妇女“须不生”也从冲任二脉角度进行

[1] [日]丹波元坚编. 素问绍识[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1955: 152.

[2] 黄龙祥. 任脉、冲脉概念的形成与演变[J]. 中国针灸, 2002, (08): 26-28.

[3] 杜广中, 马颜玲, 王淑香, 等. “任脉色素沉着带”现象的调查[J]. 针刺研究, 2006(04): 239-242+257.

阐释。

《灵枢·经脉》还记载任脉之络（尾翳）的循行路径以及病理变化，“下鸠尾，散于腹”进一步加强了任脉与腹部的关系，而病理变化又分为虚实两端，即“实则腹皮痛，虚则痒搔”，此外《内经》中也论及天突穴与任脉之间的关系，即《灵枢·本输》：“缺盆之中，任脉也，名曰天突。”

现代学者研究，《内经》中论述的任脉与督脉，具有胚胎发育学的痕迹，表明古人很早就认识到人体会阴部发育来源与过程^[1]。也有学者对任脉的具体定位提出思考，认为依靠前正中线的定位方式所取得的临床疗效不如以“腹白线”进行定位，因“腹白线”不一定与前正中线完全重合，两者之间存在差异^[2]，提示我们秦汉医家对任脉的认识来源之一可能与解剖所见的腹白线有关。

奇经八脉的概念是在《难经》中首次提出的，但是早在《内经》中就已经零星记载了关于蹻脉、任脉、督脉等相关内容，只不过较为混乱，难成系统。奇经八脉与脏腑之间关系的研究，又可以补充完善经脉-脏腑相关理论^[3]。

^[1] 马宁. 任脉、督脉的胚胎发生学探讨[J]. 山东中医药大学学报, 2017, 41(05): 412-416.

^[2] 林泰骄, 叶声, 林超岱. 任脉与“腹白线”关系研究[J]. 中华中医药杂志, 2012, 27(07): 1750-1752.

^[3] 张倩, 周美启. 奇经八脉的经脉脏腑相关研究[J]. 中国针灸, 2017, 37(12): 1299-1302.

2.2.3 督脉

双包山木人记载的督脉，只有一条主干（图 24 中红色线），没有分支，马继兴先生认为其起点在会阴部，沿着后正中线上经过骶部、腰背、项、后头部、巅顶、前额正中、鼻根、鼻梁，止于鼻尖^[1]。

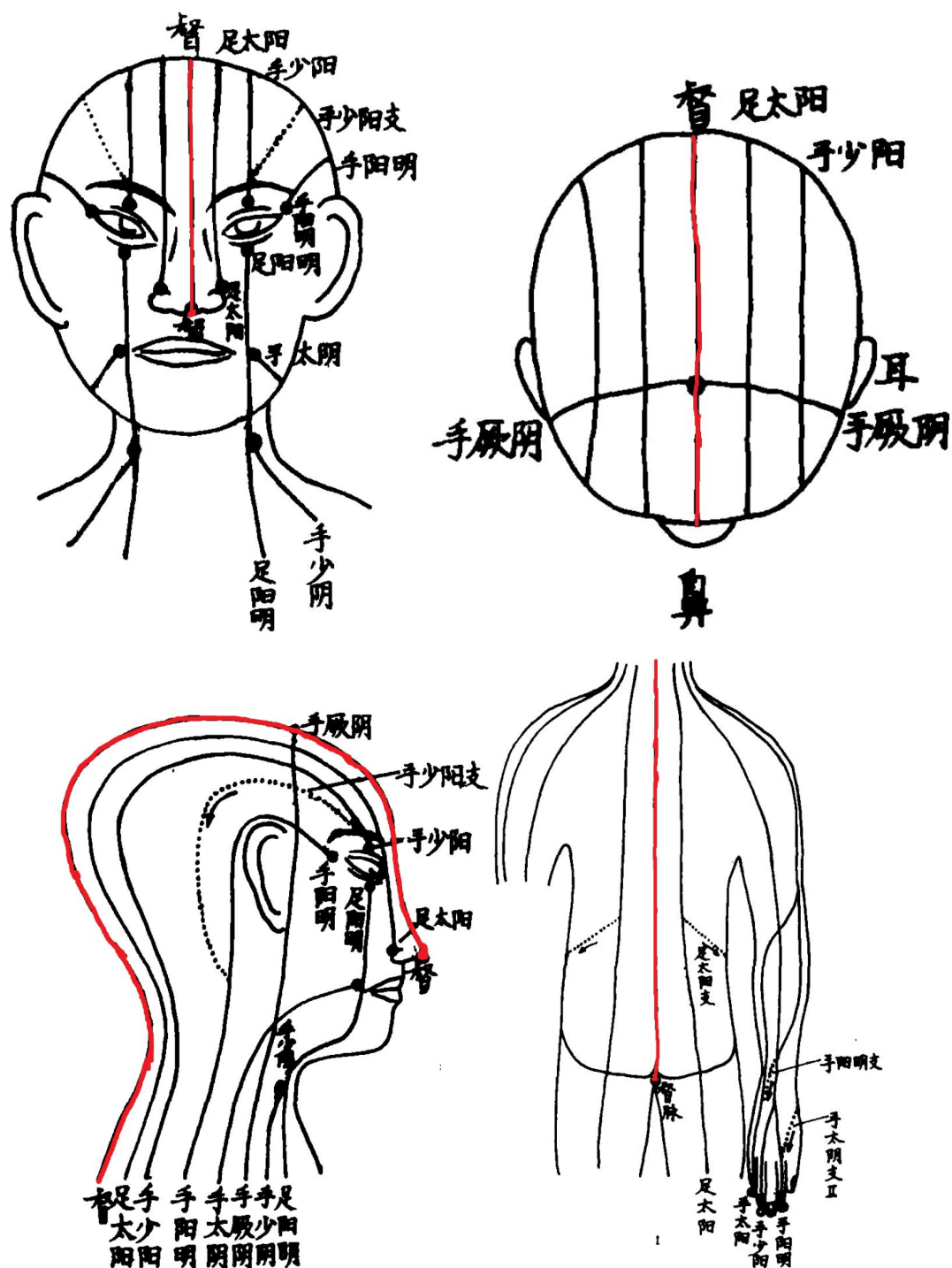


图 24 双包山木人督脉循行路径

^[1] 马继兴. 双包山汉墓出土的针灸经脉漆木人形[J]. 文物, 1996(04): 55-65+98.

出土文献《足臂》《阴阳》《十二脉》中均未记载督脉，老官山漆人在前正中线上刻有疑似任脉线，但后正中线上未见督脉，双包山木人在后正中线上刻画有督脉，起于会阴部正中，止于鼻尖端，《素问·气府论》记载了“督脉气所发者二十八穴”，根据腧穴所分布的位置，也大致可以推测出督脉循行部位经过“项中央→发际后中→面中→大椎以下至尻尾”，实际上与双包山木人的循行路径相似。其中“至骶下凡二十一节”后提及“脊椎法也”，与任脉“腹脉法也”这样的提法相似，笔者推测“脊椎法也”“腹脉法也”应该是秦汉时期医家在穴位定位时对某种测量方法的称呼。

《内经》中主要记述了督脉两种不同的循行方式：

《灵枢·营气》中督脉起点在鼻（畜门），先后经过额头、巅顶、后项部，在后背正中循行方向是从上到下，绕过阴部之后，在胸腹部则由下向上循行，最后“入缺盆，下注肺中”，与手太阴脉相连，之后紧接着又强调“此营气之所行也，逆顺之常也”。在此处督脉是作为连接十二脉环形流注体系的中转站（从肝脉到肺脉之间），因此《灵枢·营气》中所记述的督脉，应该是属于秦汉晚期医家的理论成果，是伴随十二脉环形流注体系形成的产物。

《素问·骨空论》中也记载了督脉的循行路径，较之《灵枢·营气》更为复杂，该篇首先强调“督脉为病，脊强反折”，其次论述督脉的循行路径（笔者对原文顺序略有修改）：起点在于“少腹以下骨中央”，即耻骨联合处，在此处发出两条脉（均为主干），其中第一条主干先与阴器相连，即“女子入系廷孔”“男子循茎下至篡，与女子等”，再向后绕过臀部，与足少阴脉及足太阳脉的络脉相交汇，然后循脊柱、属于肾，第二条主干循腹部正中line直向上，经过肚脐中央后进入胸腔内，穿过心脏向上与喉相连，再环绕口唇，止点在“目之下中央”，而后又与足太阳脉同起于目内眦，“上额交巅，上入络脑，还出别下项，循肩髃，内侠脊抵腰中，入循膂络肾”，可见两条主干的起点均在于耻骨联合处，终点均在肾，随后又言及督脉主治病症为“冲疝，女子不孕，瘕，痔，遗溺，嗌干”，多位于督脉循行所过处，并且提出治疗原则为“督脉生病治督脉，治在骨上，甚者在齐下营”。“骨上”是指曲骨穴，“齐下营”是指阴交穴，二穴均属于任脉腧穴，《素问·骨空论》所描述的督脉循行路径，包括了我们现在所熟知的任脉所在的前正中line，因此笔者推测在经脉早期演变过程中的某一阶段，任督二脉可能只有

督脉的概念，其循行包括了前后正中线，主治病症以少腹、阴部及口咽部症状为主，后来由于某种原因，前正中线的循行路径归属于任脉，而王冰曾提到古《经脉流注图》中将前正中线的循行线“也谓之督脉”，说明任脉、督脉在早期演变过程中较为混乱，甚至可以互相替代。《灵枢·经脉》中还提到督脉之别“长强”的循行路径以及病理变化，其循行路径与头部和足太阳脉相关，病理变化也分为虚实两端，即“实则脊强，虚则头重，高摇之”，此外，马继兴先生还在《中国出土古医书考释与研究》一书中系统考察了《明堂经》《太素》等书中督脉的循行路径，一共总结出秦汉时期有六种不同的督脉循行方式^[1]。

战国时期的《庄子·养生主》中，强调督脉能起到“保身、全生、养亲、尽年”的作用^[2]，通过其中所记载“庖丁解牛”的故事，有学者认为经脉在战国中期就已经基本形成了体系^[3]。《五十二病方》：“取垢，以艾裹，以久（灸）颊者中颠。”^[4]以及《史记》中记载扁鹊治疗“尸厥”时取穴为“三阳五会”，均记载了百会穴的临床应用，百会穴属于督脉循行路径上较为重要的一个腧穴，可见督脉在早期医家的临床实践中应用较多。

督脉的主治病症，最早见于《内经》，主要涉及“嗑干”“脊强反折”“遗溺”“冲疝”“癰”“痔”“不孕”等病症，《难经·二十九难》中也记载督脉的病症为“脊强而厥”。可见脊柱病变是秦汉医家应用督脉的治疗对象，脊柱与督脉很早就建立了关系，同时“脊柱法”也是认识古代医家形成“督脉”这个概念的一个途径^[5]，《内经》对督脉主治病症的认识主要基于循行部位与所涉及的脏腑^[6]。

[1] 马继兴. 中国出土古医书考释与研究[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 2015: 358-361.

[2] [战国] 庄周. 庄子[M]. 北京: 商务印书馆, 2018: 48.

[3] 杜正胜. 从眉寿到长生——医疗文化与中国古代生命观[M]. 台北: 三民书局, 2006: 110-111.

[4] 马王堆汉墓帛书整理小组. 马王堆汉墓帛书·五十二病方[M]. 北京: 文物出版社, 1979: 25.

[5] 张建斌, 王玲玲. 古“督脉经”探析[J]. 浙江中医杂志, 2006, 41(5): 249-251.

[6] 孙征, 张建斌. 督脉病候的古代界定和现代范畴[J]. 中国针灸, 2017, 37(10): 1077-1080.

2.2.4 带脉

带脉名称来源，杨上善称：“如束带而前垂故名。”《说文》：“带，绅也。象系佩之形。”^[1]带脉见于《内经》，共有三处，《灵枢·经别》在描述足少阴经别循行路径时提到“当十四椎，出属带脉”，提示带脉的位置横平第十四椎。此外《灵枢·癫狂》在论述“脉癫疾”的症状及治疗时提到“灸带脉于腰相去三寸”，但此处提到的“带脉”无法确定是“经脉”还是“腧穴”。在《素问·痿论》中提到冲脉、督脉、足阳明脉“皆属于带脉”，可以理解为冲脉、督脉、足阳明脉皆被带脉所束（带脉围绕身体一周），如《儒门事亲》中称：“冲、任、督三脉……皆络带脉。”^[2]若根据后世李时珍《奇经八脉考》中对带脉的循行路线描述，起于章门穴，又与五枢、维道相连，则大致呈现为一条下垂的曲线^[3]。

带脉的病变，在《内经》中只有《素问·痿论》提到，当人体气血虚衰，带脉失去收引能力时可见“足痿不用”，“足”在甲骨文中写作，其形状像是整个下肢，故早期“足”字有整个下肢的含义^[4]，“痿”在《说文解字》中解释为“痹也”，实际上“足痿”是指下肢受风寒湿邪侵袭而发病之意，并非字面意思的“脚萎缩”，《难经》对带脉为病的记载为“腹满，腰溶溶若坐水中”，也是风寒湿侵袭的症状，仲景在《金匮要略·五脏风寒积聚病篇》中对“肾着”的临床表现记载为“腰中冷，如坐水中……腰以下冷痛，腹重如带五千钱”^[5]，“肾着”的病机为“肾受冷湿，着而不去，而为肾着”，可见，秦汉时期带脉病变主要以风寒湿邪侵袭人体下部为主，现代学者有将带脉发病分为带脉不和与带脉失约^[6]，也有学者对“带脉-内脏-带下病”进行研究，发现穴位与内脏之间有特异性的联系^[7]。

老官山漆人躯干部刻画有三条横绕身体的白线，以及连接三条横线呈现“∩”形的曲线，这三条横线，梁繁荣先生考证^[8]分别位于：乳根水平、季肋水平、脐下2～3寸水平，皆大致绕身体一周。并提到其中第二条横线符合《难经》中“回

[1] [汉]许慎.说文解字[M].北京:中华书局,2015:155.

[2] [金]张从正撰;徐江雁,刘文礼校注.儒门事亲校注[M].郑州:河南科学技术出版社,2015:32.

[3] 郝亚薇,杨晓倩,汤立新.带脉理论探析[J].北京中医药大学学报(中医临床版),2013,20(02):58-60.

[4] 蔡红.古代汉语人体下肢名称系统研究[D].南通大学,2014:20.

[5] [汉]张仲景.金匮要略方论[M].北京:人民卫生出版社,2012:46.

[6] 陈继明.浅谈带脉[J].中医杂志,1983(07):54-56.

[7] 赵敬军,黄海龙,张祎平,等.穴位功能态“经穴-内脏-疾病”特异性联系探析[J].中国中医基础医学杂志,2015,21(12):1555-1557.

[8] 梁繁荣,曾芳,周兴兰,等.成都老官山出土经穴髹漆人像初探[J].中国针灸,2015,35(01):91-93.

身一周”的描述，可以视为带脉。黄龙祥先生则认为，若将三条横线当成一个整体来认识，中间的横线很难看做是带脉。第一、二条横线在背部只到达足太阳脉的第二侧线，留有缺口，失去了“回身一周”的特点，应该是属于三焦学说^[1]。刘澄中先生在论著中将这三条横线分别命名为肺俞环体带脉、胃俞环体带脉与肾俞环体带脉，认为是刺激背俞穴而引发的环绕身体的感传线^[2]。现代学者对带脉的解剖基础进行分析，认为带脉解剖结构的主体是腹横筋膜^[3]，值得一提的是，有学者在艾灸过程中，还发现了与带脉循行路径重合的体表反映^[4-5]，对于理解带脉的形成过程颇有启发。

^[1] 黄龙祥. 老官山出土西汉针灸木人考[J]. 中华医史杂志, 2017, 47(03): 131-144+194.

^[2] 刘澄中. 论老官山脉穴木人的白脉循行系统——兼评“经穴髹漆人像初探”[J]. 中国针灸, 2018, 38(02): 198-202.

^[3] 马宁. 带脉结构的解剖还原[J]. 中国针灸, 2020, 40(10): 1133-1135+1148.

^[4] 吴盛宏. 临床艾灸发现带脉循行 1 例[J]. 针刺研究, 2009, 34(03): 198.

^[5] 田宁, 贾萍, 陈日新. 艾条温和灸阴交穴激发带脉感传 3 例[J]. 江西中医药, 2004(04): 58.

2.2.5 蹻脉

蹻脉不见于出土文献，在传世文献中最早见于《内经》，《灵枢·脉度》指出阴蹻脉与阳蹻脉本为一脉，但在男女则有区别：“男子数其阳，女子数其阴，当数者为经，其不当数者为络也。”^[1]男子以阳蹻为脉，以阴蹻为络，而女子以阴蹻为脉，以阳蹻为络。

《灵枢·脉度》中记载黄帝向岐伯请教关于蹻脉的起止循行以及主要功能时，岐伯则以阴蹻脉为例进行回答，并明确阴蹻脉属于足少阴脉的一条支脉，起点在“然骨之后”，分别经过“内踝之上”“阴股”“缺盆”“人迎”，止点在“目外眦”，而“合于太阳、阳蹻而上行”说明足太阳脉与阴蹻脉、阳蹻脉之间互有联系，其病变主要在于目，即“气并相还则为濡目，气不荣则目不合”，同篇还对阴蹻脉与阳蹻脉的长度进行论述，“从足至目”大致是蹻脉的循行路径。这里黄帝问蹻脉的起止点，而岐伯只回答阴蹻脉，笔者认为可能是秦汉时期阴蹻脉的理论首先发展起来，也可能是传抄过程中脱失了阳蹻脉的论述，后世医籍如元代滑寿《十四经发挥》中，对阴蹻脉的循行记载与《内经》一致。

《灵枢·寒热病》首先论述项部穴位可以治疗目病“头目苦痛，取之在项中两筋间”，而这一治疗方法，与足太阳脉相关，是由于足太阳脉“通项入于脑”，主管眼系，而后便紧接着论述阴蹻脉与阳蹻脉相交于“目锐眦”，故主管眼目的开阖，在病理状态下表现为“阳气盛则瞑目，阴气盛则瞑目”。有学者根据《灵枢·寒热病》此处记载，认为阴蹻脉与阳蹻脉是足太阳脉在脑内一分为二形成的，实际上此处“入脑乃别”是指“眼系”从后项部进入脑内，分属于左右眼球，并非后文所提及的阴阳蹻脉。

《内经》中对阳蹻脉的论述见于《素问·缪刺论》，主要提到了阳蹻脉病变可出现“目痛从内眦始”的症状，以及用缪刺法治疗时选取“外踝之下半寸”，《灵枢·脉度》载阴阳蹻脉汇合于“目内眦”，《素问·调经论》还载：“病不知所痛，两蹻为上。”^[2]《灵枢·经筋》中论述足少阳经筋的循行时，提到了“并蹻脉而行”，应该是指阳蹻脉。《难经·二十八难》进一步论述了蹻脉的循行路径，阴阳蹻脉起点均在“跟中”，但阳蹻脉止点在“风池”，而阴蹻脉止点则在“咽喉”。明代李时珍

^[1] [春秋]佚名. 灵枢经[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2012: 49.

^[2] [春秋]佚名. 黄帝内经素问[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2012: 233.

《奇经八脉考》在《难经》的基础上，对跷脉循行论述更为详细，如对阳跷脉的起止点记载与《难经》相同“其脉起于跟中……入风池而终”，但在循行过程中与诸多经脉、腧穴都有联系。关于跷脉的腧穴，《内经》中仅记载其数量，并未提及定位及主治病症，《素问·气穴论》记载“阴阳跷四穴”，《素问·气府论》中也有“阴阳跷各一”的记载。

综上，秦汉时期阴阳跷脉相关理论还处于初步发展阶段，阴跷脉循行路径较阳跷脉更为清晰，关于跷脉主治病症的演变，《内经》中提到“目瞋”“目瞑”“目痛”等眼目疾病、肢体疾病“维筋急”以及“病不知所痛”^[1]。跷脉病变产生运动功能障碍肇始于《难经》中“阴跷为病，阳缓而阴急；阳跷为病，阴缓而阳急”一语，至《奇经八脉考》中才明确提出跷脉与下肢拘挛或者迟缓的症状^[2]，现代医家对跷脉的应用主要在睡眠障碍以及脑病、运动系统障碍等^[3]。

^[1] 李牧月. 跷脉的古今文献整理研究[D]. 广西中医药大学, 2019.

^[2] 田辉, 卞镡, 隋月皎, 等. 跷脉与人体平衡功能相关性探讨[J]. 中国针灸, 2015, 35(04): 352-354.

^[3] 王磊, 谷世哲, 马惠芳. 跷脉的循行特点及主治规律[J]. 中国针灸, 2001(04): 29-31.

2.2.6 维脉

维脉与蹻脉一样，不见于出土文献，秦汉时期对维脉的论述主要见于《内经》《难经》。维脉之名首载于《内经》，其功能有别于十二正经，可维系全身诸经以及调节营卫气血满溢。《说文解字·糸部》曰：“维，车盖维也。”^[1]意为古代固定车盖的绳子，引申为维持、维系的含义，《内经》对维脉的记载，见于《素问·刺腰痛》中对“飞阳之脉”“阳维之脉”等相关针刺部位具体位置的描述中，其中“飞阳之脉”与阴维脉交汇点在“内踝上五寸”，而“阳维之脉”与足太阳脉的交汇点在“去地一尺所”，均位于下肢。维脉本身没有所属腧穴，腧穴主要分布于和其它经脉交汇处^[2]。

《难经》发展了奇经八脉理论，对维脉的论述更为详细，首先《难经·二十八难》提出了维脉的作用以及起点，阴阳维脉均可以“维络于身”，还可以对经脉气血起到调节作用，但《难经》强调维脉只能对十四经脉的气血进行溢蓄调节，并不直接参与气血的循环流注。对于起点，阳维脉在“诸阳会”，而阴维脉在“诸阴交”，实际上，“诸阳会”“诸阴交”所指是部位还是腧穴并不明确，有学者认为“诸阳会”为头肩部阳经交会处，“诸阴交”为胸腹部阴经交会处^[3]。

《难经·二十九难》进一步论述维脉的作用“阳维维于阳，阴维维于阴”，这里“阳”是指手足三阳脉，“阴”是指手足三阴脉，正如杨玄操对维脉解释：“为诸脉之纲维。”明代李时珍在《奇经八脉考》中进一步将维脉的功能与一身之表里联系起来：“阳维主一身之表，阴维主一身之里，以乾坤言也。”

《难经·二十九难》又提到维脉病变可以出现神志失常的症状，即“忪然失志，溶溶不能自收持”，汉代刘向在《九叹·愍命》中写道“心溶溶其不可量兮，情澹澹其若渊”^[4]，“溶溶”表示“宽广”“盛大”，是对“忪然失志”的修饰，笔者认为，神志病变无常，像如“忪然失志”这样的轻度抑郁类病变，严重性不及“登高而歌、恶人与火”的阳明病变，故归属于维脉，似有阴阳不和之意。此外阳维病变可以出现“苦寒热”，阴维病变可以出现“苦心痛”。清代黄元御在《难经悬解》中以表里两个部位对维脉病变进行解释，认为“苦寒热”与“表伤”有

^[1] [汉]许慎.说文解字[M].北京:中华书局,2015:277.

^[2] 袁静,高希言.对阳维脉交会腧穴的文献探讨[J].针刺研究,1998(03):237-238.

^[3] 李冲.阴、阳维脉的文献整理研究[D].广西中医药大学,2019.

^[4] [战国]屈原撰;黄寿祺,梅桐生译注.楚辞全译[M].贵阳:贵州人民出版社,2008:276.

关，而“苦心痛”则属于“里伤”^[1]。阳脉多属于表，上行头面，“苦寒热”应该是“恶寒发热”之意，属于表证；阴维脉维系诸阴经，王叔和在《脉经》中称阴维脉病变的脉象为“沉大而实”，可以出现“胸中痛，胁下支满，心痛”等症状^[2]，现代学者高希言先生对维脉主治病症讨论较多，认为“阳维为病苦寒热”是对三阳经病症共性的高度概括，而“阴维为病苦心痛”是对腹部诸疾患的概括^[3]，此外维脉还对精神神志疾病以及腰腿病症有治疗作用^[4]，李鼎先生将维脉比作网络，连接着各经络气血，并将经络气血归属于任督二脉^[5]。总之，依据目前所能查阅到的文献来看，秦汉时期是维脉理论的萌芽期（或概念期）^[6]。

[1] [清]黄元御. 难经悬解·黄元御医书全集[M]. 北京: 中医古籍出版社, 2016: 551.

[2] [晋]王叔和撰; 广州中医学院《脉经》整理研究课题组校注. 脉经校注[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2016: 47.

[3] 袁静, 贾登云, 高希言. 对“阴维为病苦心痛”“阳维脉苦寒热”的探讨[J]. 中医研究, 2006(03): 55-57.

[4] 高希言, 王栋斌, 王鑫, 等. 对维脉病候的探讨[J]. 上海针灸杂志, 2015, 34(06): 572-574.

[5] 高希言, 陈岩, 孙婵娟. 李鼎教授对奇经八脉的认识[J]. 中国针灸, 2011, 31(07): 653-656.

[6] 陈泽林. 阴阳维脉古今观[J]. 上海针灸杂志, 2004(03): 35-37.

2.3 经别理论演变梳理

“经别”意为别道而行的正经，最早见于《灵枢·经别》，用“XX之正”引出，“正”是指经别也属于十二正经的一部分，但与经筋理论、络脉理论一样，长久以来不如十四经脉更受重视。《灵枢·经别》将十二经别表里经两两相合，称为“六合”，其循行特点是我们熟知的“离、入、出、合”，值得讨论处有：

十二经别的起点，一般是从正经分出，称作“离”，意为离开正经而别行，但所“离”之处较为模糊（范围较大），且位置不定（并非我们常说的从肘膝关节附近别出），如足厥阴经别“别跗上”，手太阳经别“别于肩解”，手少阴经别“别入于渊腋两筋之间”，手少阳经别“别于巅”等。十二经别的止点，最大的特点就是阳经经别合于本经，而阴经经别合于相表里的阳经^[1]，相合的部位一般在头面颈项部，如足太阳经别在下肢从本经发出后“从髀上出于项，复属于太阳”，而足少阴经别“复出于项，合于太阳”，足太阳经别与足少阴经别是在项部合并于足太阳脉；再如手阳明经别“出缺盆，合于阳明也”，而手太阴经别“循喉咙，复合阳明”，手阳明经别与手太阴经别在前颈部合于手阳明脉，足少阳经别“散于面，系目系，合少阳于外眦也”，而足厥阴经别“上至毛际，合于少阳，与别俱行”，“与别俱行”意为与足少阳经别一齐向上走行，在目外眦处合并于足少阳脉，足阳明经别“上循咽出于口，上頰頄，还系目系，合于阳明也”，而足太阴经别“上至髀，合于阳明，与别俱行，上结于咽，贯舌中”，足太阴经别止点“贯舌中”，但在髀枢处“合于阳明，与别俱行”。手太阳经别循行方向为远心性“别于肩解，入腋走心，系小肠也”，借助手少阴经别“别入于渊腋两筋之间，属于心，上走喉咙，出于面，合目内眦”。手少阳经别循行方向也是远心性“别于巅，入缺盆，下走三焦，散于胸中也”，手心主经别“出循喉咙，出耳后，合少阳完骨之下”。

经别的循行方向，手太阳经别与手少阳经别属于远心性，其余经别属于向心性。经别循行过程中皆进入胸腹腔，称为“入”，循行一段路径后，又从颈项处出于体表，称为“出”，而手太阳经别与手少阳经别进入胸腹腔之后，不再出于体表，其中手太阳经别联系小肠，手少阳经别散于胸中。

经别与络脉不同，络脉起始部位便是腧穴（治疗点），并且具有“实则XX，虚

^[1] 侯书伟,胡志强.《灵枢》十二经别分布规律探讨[J].上海中医药杂志,1995(02):42-43.

则XX”的主治病症，但经别无腧穴也无主治病症，其作用主要是联系表里两经以及经脉与脏腑之间的关系。另外，值得注意的是，经别与“心”的关系密切，手足共有五条经脉的经别与心直接产生联系，笔者认为，秦汉早期医家注重心在脏腑中的地位，故诸多经别与心脏发生联系，经别的循行方向与帛书《足臂》《阴阳》的循行方向一致，赵京生先生认为《灵枢·经别》无论是循行方向还是用字习惯，与马王堆帛书《足臂》《阴阳》更为贴近，是早期“十一脉”在《内经》中的遗存，反应“初始经脉模式的规律”^[1]，说明经别理论的出现可能早于《灵枢·经脉》。如足太阳经别“别入于肛”以及足少阳经别“别者入季胁之间”，较为贴近老官山漆人足太阳脉的循行特点。

十二经别提示我们对针灸基本概念的正确把握，对经脉学说进行溯源，有助于理解《内经》相关理论，经别对表里之间联系的论述，启发我们对人体复杂性、系统性的思考与探索^[2]，但是需要我们注意的是：经别理论仅是作为秦汉时期经脉理论过度下的一个产物吗？经别理论是否有临床实用价值？已有学者进行了相关讨论，如黄月莲先生通过对“六合”位置的分析，提出“六合穴”的概念^[3]，实际上，黄氏所提的“六合穴”，类似于《内经》中“七次脉”“天牖五部”，表达了颈项部腧穴对实证、急症以及头面部病症的治疗作用^[4]。

^[1] 赵京生. 经别求是[J]. 中国针灸, 2008(09): 691-695.

^[2] 刘兵. 表里关系的经脉理论研究——基于两种经脉模式认识的古代文献理论分析[D]. 南京中医药大学, 2011.

^[3] 黄月莲. 浅析十二经别“六合”理论及其在临床上的应用[J]. 广西中医药, 2014, 37(01): 61-63.

^[4] 高兵, 程悦, 曾永蕾, 等. 十二经别析疑[J]. 中国针灸, 2020, 40(08): 887-890.

2.4 经筋理论演变梳理

2.4.1 “筋”“经筋”“十二经筋”概念演变

“经筋”一词最早见于《灵枢·经筋》，但在先秦时期，“筋”已成为重要的医学概念，马王堆帛书借助“筋”这一解剖结构描述经脉的循行路线，如“循筋上廉”，《五十二病方》在论述“痉”的临床表现时，借助“筋”进行解释，即“筋挛难以伸”^[1]，秦汉时期对“筋”的论述还见于非医文献，如《史记·扁鹊仓公列传》中记载“割皮、解肌、决脉、结筋”^[2]，由浅到深进行描述，其中最深层属于“骨”。《素问·上古天真论》论述人体生长发育时将“筋”与“骨”合并而论，“筋”属于实体解剖结构，从“筋骨劲强”“筋骨隆盛”“筋不能动”“筋骨解堕”可知，首先“筋”的生理活动是以运动为主，其次“筋”与“骨”虽为不同的解剖结构，但是在运动功能中密切相关，显然此处“筋”偏向于指骨骼肌。

“筋”是人体的组成部分，属“五体”之一，“五体”常单独或合并表示某一类解剖结构，如“筋骨”侧重指由骨与骨骼肌共同构成的运动系统，“筋肉”侧重于指四肢骨骼肌，“筋脉”侧重于指脉管系统，即体表可见的青筋（浅静脉）与动脉。在单字使用中，学者多引《说文》中“筋，肉之力也。从力，从肉，从竹。竹，物之多筋者”^[3]一语进行解释，《说文》“筋”之义偏向于指骨骼肌，竹由竹丝构成，正如肌腹由肌纤维构成，肌腱横跨关节，骨骼肌的收缩引起关节运动，产生力量。因此在古医籍中，单独用“筋”时，所指之意较多，肌腱、肌肉、浅静脉、某些神经均可以用“筋”字进行论述^[4]，若要明确所指，就必须组合成多字概念，如表示解剖结构的“婴筋”“宗筋”“筋膜”等；表示疾病症状的“筋急”“筋挛”“筋痛”等，再如用作疾病名称的“筋痹”“筋痿”“筋瘤”等，体现出早期解剖名词含义的不确定性^[5]。

“经”最初指丝织品的纵线，《说文》：“经，织也。”《玉篇》：“经纬以成缙布也。”在织布时“经静而纬动”，刘勰《文心雕龙》：“经正而后纬成。”^[6]“经”的特殊地位，逐渐使该字蕴含常行的义理、法则之意。在医学概念中，“经”可意为

^[1] 马王堆汉墓帛书整理小组. 马王堆汉墓帛书·五十二病方[M]. 北京: 文物出版社, 1979: 11.

^[2] [汉]司马迁. 史记[M]. 北京: 中华书局, 1959: 2788.

^[3] [汉]许慎. 说文解字[M]. 北京: 中华书局, 2015: 85.

^[4] 黄龙祥. 中国针灸学术史大纲[M]. 北京: 华夏出版社, 2001: 444.

^[5] 王一品. 《黄帝内经》筋骨理论及相关术语研究[D]. 辽宁中医药大学, 2021.

^[6] [南朝]刘勰撰; 周振甫注. 文心雕龙注释[M]. 北京: 人民文学出版社, 1981: 346.

常行之事、有规律之事，如妇人月事有常，称为“经水”，再如“脉”在人体一般是指输送气血的管道，而全身诸“脉”其行有常者称之为“经脉”，现代学者认为“经脉”概念的产生、演变，与古人从体表诊察动脉规律性的搏动密切相关^[1]。诊脉之搏动“脉动处”，即黄龙祥先生所说的“经脉穴”，又是早期经脉理论中的治疗部位，体现“诊疗一体”的特点。《灵枢·经筋》是秦汉时期系统总结经筋理论的篇章，该篇首次出现“经筋”这一朴素概念，是古人对“筋”这一解剖结构长期诊察基础之上并总结其规律而形成的，“经筋”是“筋”的下位概念，凡“筋”之常者、“筋”病有规律可显者，称之为“经筋”，其中“筋”之常者，是指其具有“结、聚、散、络”的特点，“筋”病有规律可显者，是指经筋病变时产生典型的“结筋处”病灶，正类似经脉病变时“脉动处”出现的异常情况（即《灵枢·经脉》中“盛、虚、寒、热、陷下、不盛不虚”）。

一般我们所讲的“经筋”，是指《灵枢·经筋》篇中论述的“十二经筋”，对“十二经筋”这一概念的定义目前主要有：

表 14 “十二经筋”概念定义对比

定义	出处
十二经筋是在经脉形式的启发下，对机体组织构成中的部分结构的一种认识和表述方式 ^[2] 。	《针灸经典理论阐释》
十二经筋是指为十二经脉所联系的筋肉系统 ^[3] 。	《针灸学释难》
十二经筋是古人运用当时解剖学知识，用当时的医学术语，以十二条运动力线为纲，对人体韧带学、肌学及附属组织生理和病理规律的概括和总结 ^[4] 。	《中国经筋学》
经筋是古人对人体体表主要筋肉的统称，对数目的认识受到了当时哲学思想的影响，较之经脉而言，经筋更为具体，理论化程度较低 ^[5] 。	《针灸关键概念术语考论》
十二经筋，是指与十二经脉相应的筋肉部分，其分布范围与十二经脉大体一致 ^[6] 。	十四五教材《经络腧穴学》
十二经筋是十二经脉之气濡养筋肉骨节的体系，是十二经脉的外周连属部分，是古人运用当时解剖学知识，按照十二经脉循行分布划分的全身 12 个肌筋膜群 ^[7] 。	《实用壮医筋病学》

[1] 李永明. 汉代十一脉到十二经脉转变的解剖依据[J]. 中国针灸, 2021, 41(10): 1153-1158.
[2] 赵京生. 针灸经典理论阐释[M]. 上海: 上海中医药大学出版社, 2000: 77.
[3] 李鼎. 针灸学释难(重修本)[M]. 上海: 上海中医药大学出版社, 2006: 19.
[4] 薛立功, 李江舟. 经筋的现代解剖学重组分析[C]//中国针灸学会经筋诊治专业委员会成立大会论文集, 2009: 32-39. 也见于薛氏专著: 薛立功. 中国经筋学[M]. 北京: 中医古籍出版社, 2015: 33.
[5] 赵京生. 针灸关键概念术语考论[M]. 人民卫生出版社, 2012: 127.
[6] 沈雪勇主编. 经络腧穴学[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2021: 14.
[7] 韦英才. 实用壮医筋病学[M]. 南宁: 广西科学技术出版社, 2016: 14.

综上，对“十二经筋”概念要素的阐述包括三点：①附属于十二经脉系统；②有一定的走向（循行路线）、分布；③串联周身组织（骨骼、肌肉等）。对于第一点要素，经筋学说与经脉学说在早期是独立并行发展的，十二经筋附属于十二经脉是后世学者的认识。对于第二点要素，《灵枢·经筋》篇记载的十二经筋的循行方向全部起于手足，呈“向心性”流注。现代解剖学中，与经筋理论类似的肌筋膜链、十二运动力线也有方向，但《解剖列车》^[1]论及臂线时，其臂前线与臂后线起于胸背，止于手指，呈现“远心性”。其实对于经筋循行方向，古人带有很大的臆测性，与现代肌筋膜链的认识基础并不一致。对于第三点要素，经筋具有“起、结、聚、散”等特点，结聚之处多在腕肘膝髌等较大关节处，即张介宾所言“惟四肢溪谷之间为最，以筋会于节也”，由骨骼肌肌腹收缩时，跨过关节牵引肌腱使关节产生“屈、伸、收、展”等动作，可以在体表明显触及骨骼肌的收缩，瘦人甚至在体表可观察到肌腱活动。但应注意，在古人的认识中，肌肉只是“经筋”的一部分，单纯地将“经筋”定义为串联（联系）周身骨骼是不准确的。

笔者认为，对“经筋”进行定义，除了基本的循行以及联系周身组织外，还应体现其生理功能及病理表现，对经筋生理特点，应该从结构与功能两方面分别进行认识，首先在结构方面，包含了现代解剖学概念中的肌腹、肌腱、关节、浅深筋膜等结构，此外古人还将部分神经（如手少阳经筋中尺神经）、体表可视的浅静脉亦归入经筋系统。在功能方面，第一是“主束骨而利关节”，约束骨骼，构成运动系统；第二是“筋为刚，肉为墙”，保护重要脏器及大动脉；第三是为“卫气”循行提供道路；第四是“筋结处”既是病理反映处，又是诊治所在。

2.4.2 “经筋”与“经脉”异同处

“筋”“脉”关系紧密，甚至有时连称为“筋脉”，如“气口治筋脉，经输治骨髓”“筋脉不通，病生于不仁”“筋脉和同，骨髓坚固，气血皆从”。秦汉医家将“筋”和“脉”共同用于对某些临床病候的解释^[2]，如《灵枢·经脉》篇对足厥阴病候中“唇青舌卷卵缩”这一症状，用“脉”与“筋”共同进行解释“筋者络于阴器，而脉络于舌本也”，“筋”的病变主要是“筋急”和“筋纵”，“舌卷卵缩”这一症状很明显是由于“筋急”引起的，“筋”与“脉”有很多相关性，还可以表

^[1] [美] Thomas W. Myers 著. 解剖列车——徒手与动作治疗的肌筋膜经线[M]. 北京: 北京科学技术出版社, 2016.

^[2] 黄龙祥. 经脉理论还原与重构大纲[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2016: 25.

现在二者有着共同的主病因“寒邪”，秦汉时期针灸医家重视“风、寒”二邪，其中又偏向于“寒邪”，经筋病变包括“筋急”和“筋纵”两种，在《灵枢·经筋》篇中论及的经筋病症主要是因寒邪引起的“筋急”。

古人对经筋主要是从肌腱、肌腹、肌筋膜等结构进行认识，在对人、畜体解剖过程中，认识到肌腱、肌腹是实心的，而脉管则是中空的，因此提出经筋“中无有空”（《太素》）的认识，故经筋病变大多停留在发病处，治疗原则也“以痛为输”，而动静脉则“中空”可以循行营血，成为腧穴（早期诊疗均在腕踝“脉动处”）循经远取的依据。两者之间这一根本性的区别在一定程度上促进了经脉与经筋的独立发展。早期经筋、经脉理论均是对劳损所致疼痛点的系统反映，是以点成线的延伸，少有曲折、分支，多数表现为一条平直的纵线，但随着临床诊疗经验的积累，“病灶点”“诊疗点”越来越多，其性质差异也越来越明显，经脉理论的“脉动处”有明显的远端调节功能，而属于经筋理论的“筋结点”有明显“近治作用”的特点，且随着解剖认识的加深，经脉理论偏于“中空”运输气血，经筋则“中无有空”多为局部调节。又因秦汉医家可以根据自己临床经验任意增加一条相关的支脉，所以经筋、经脉循行过程中，曲折、回旋、支脉便越来越多。为了描述这种规律，古人先从解剖学角度研究了骨骼与肌肉，将出土经脉文献与《灵枢》对比发现，后者引入了专门用来描述运动系统及其功能的“骨”“肌”“腠”“腠肉”“分肉”“筋”等概念，并借助对运动系统相关疾病（肌肉劳损、关节痹痛等）的观察分析，形成了早期以部位为主的筋病理论。现代解剖学认识到骨骼肌有跨关节分布的特点，当某一块骨骼肌受损时，由于关节活动，牵引肌腱起点与止点同时出现疼痛，呈线状分布。在《内经》中便用十二条经筋进行总结，但十二经筋形成体系时，十二经脉也完成了首尾循环流注模式，经脉理论以极具特色的理论整合形式以及极强的临床指导作用逐渐为后世医家所青睐，刚成体系的经筋理论，其闪光之处又被整合在经脉学说中，十二经筋最迟从汉末开始，就仅以十二经脉的附属形式存在。正是由于“筋”“脉”两者之间有太多相似之处，就更应该拨开当今经脉理论“一统江湖”的表象，总结古人对经筋理论的实践经验，而不是一味地将经脉理论视为解释所有针灸临床现象的“百宝箱”。

现行教材认为十二经筋是十二经脉的附属组成，甚至认为十二经筋理论的建

立,是受到了十二经脉学说的影响,然综合秦汉时期经脉文献后发现,《灵枢·经筋》篇中十二经筋的循行及病候与《足臂》《阴阳》更为吻合^[1]。如手太阳脉从颈部循行至目外眦有耳前、耳后两种不同路径,出土文献、老官山漆人以及《灵枢·经筋》从耳后走行,而《灵枢·经脉》篇则从耳前走行,黄龙祥先生认为前者的处理方式更符合“三阴三阳分布”的规律^[2]。再如《灵枢·经筋》中足阳明经筋为“向心性”走行,在头部合于“目上、下网”,主病中有“急者目不合,热则筋纵,目不开”,手太阳经筋循行“上属目外眦”,其病包括“目瞑,良久乃得视”,并且在篇末强调“足之阳明,手之太阳,筋急则口目为噤,眦急不能卒视”,重点强调了足阳明经筋、手太阳经筋与目病的相关性。《灵枢·经脉》篇中胃足阳明之脉循行从头下足,未提及与目有直接联系,在主病中头面部可见“𩈶衄,口喎唇𦐇”,未见目疾。马王堆帛书《足臂》《阴阳》中足阳明脉循行均呈向心性,并且在《阴阳》中循行“穿颊,出目外廉”,提示《灵枢·经筋》篇与马王堆出土早期经脉文献的一致性。学者薛立功在其著作《中国经筋学》中也提到^[3],出土经脉文献中经脉主治病症以痹痛为主,更接近于《灵枢·经筋》,故认为经脉理论可能是从经筋理论中脱胎而来,《足臂》《阴阳》所论述的经脉主治病症与《灵枢·经筋》更为接近,早期先民对以劳损疼痛为主的疾患关注度较高,因此结筋病灶点的认识也较早,结筋病灶点除可治疗相关部位疼痛外,随着所在病灶点卡压现象的解除,也治疗了筋性经络、筋性内脏疾病,加之筋结点的疼痛只有在损伤合并炎症渗出时才比较明显,古人逐渐将原始疼痛点的关注转移到了筋性经络、筋性内脏病,从而总结出“远治作用”。《足臂》以经筋痹证为主,《阴阳》中“是动则病”“其所产病”试图将经筋病与其他病症区分开来,《灵枢·经筋》更加明确了循经筋所过的疼痛、转筋以及少量筋性经络、内脏病,《灵枢·经脉》中包含了大量的经筋病,但是未作区分。

出土经脉文献处于经脉理论的早期阶段,无论对循行还是主病的描述均处于原始古朴状态,是古人对机体纵向治疗规律的探索与总结。《内经》中论述的经筋理论及经脉理论是这种纵向治疗规律不同的体现形式,但《灵枢·经脉》篇在构

^[1] 董宝强,李春日,黄凤云,等.从经筋治痛谈经络起源[J].中国针灸,2011,31(08):711-713.

^[2] 黄龙祥.老官山出土汉简脉书简解读[J].中国针灸,2018,38(01):97-108.

^[3] 薛立功.中国经筋学[M].北京:中医古籍出版社,2015:21.

成十二经脉环形流注的模式时，添加了许多人为因素，因此使得向心流注且未与脏腑相连的经筋理论在循行模式上更接近于帛书经脉文献，《足臂》中疼痛性病症占了大部分，黄龙祥先生认为早期医家对疼痛类病症的治疗经验，为经脉理论奠定了基础^[1]。而经筋理论“以痛为输”，因此两者之间有更多的相似性。经筋理论在其形成到发展的过程中，后人改动较少，所以其循行和主病更为古朴，经筋在四肢部的循行与经脉大体一致，但在头面部的循行则多超出了经脉循行所及，并且分布范围亦较广，能补充经脉循行之不足。

2.4.3 经筋理论的自身特点

2.4.3.1 通行卫气与解结

经筋、经脉与营卫关系密切，“营行脉中，卫行脉外”，营卫是气血的层次关系，经筋不仅是经脉的外围结构，使得经脉伏藏于其间，还能通过调节卫气，进而对经脉的流通气血功能进行调节。尽管现代针灸理论中，常以“经脉”为主体，“经筋”附属其后，实际上早期经脉理论与经筋理论二者并行，经脉理论偏向于对针灸实践现象层面的解释，而经筋理论更多的是在描述人体解剖实体结构，《太素》称经筋“中无有孔”，仅有网络联动之功，而无传输气血的功能，笔者将十二经筋理解为经脉的外围结构，经脉在经筋包裹下进一步发挥其功能。

人体筋膜作用较广，不仅能固定限制运动系统，“主束骨而利机关”，协助结缔组织生长，阻止感染扩散，现代医家还认为筋膜之间可以形成筋膜链，对针刺治疗相关痛症起到指导作用^[2]。针刺时“痛”感主要出现在针至皮肤与骨膜，而“酸胀”感以及特定的传导则出现在浅深筋膜处^[3]。以四肢部为例，经脉循行于分肉之间，而分肉之间则是肌肉与肌肉的间隙，深筋膜包裹着骨骼肌，因此经脉循行于筋膜之间，筋膜为经脉的循行提供了场所与支持。

“人之所有者，血与气耳”，血气是针灸理论最基本的概念，是针灸生理病理以及诊断治疗的基石。“营行脉中，卫行脉外”，而“脉外”又是筋膜所在，因此卫气行于脉外，也可以理解为卫气行于筋膜之中，腧穴的位置，一般位于肌肉与肌肉之间，肌肉与肌腱之间，现代解剖学中，肌肉被深筋膜包裹形成一个独立的

^[1] 黄龙祥. 黄龙祥看针灸[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2008: 53.

^[2] 陈德成. “动筋针法”和靶点概述[J]. 中国针灸, 2016, 36(09): 941-944.

^[3] 陈德成. 针刺层次与针感的关系[J]. 中国针灸, 2017, 37(11): 1219-1222.

结构,“经筋”中的“筋膜”,包含了深筋膜在内,“筋膜”之间行有卫气,针灸的调气作用才能在此施展开来,《灵枢·禁服》提到卫气“为百病母”,故在治病之前需“审察卫气”,张介宾对《灵枢·邪客》中“地有泉脉,人有卫气”一语解释为“泉水出于地下,卫气行于肉中”^[1],“泉水”是地下及地表细流联通水脉,实则与“十二经水”不同,故以此比喻卫气,说明“卫气行于分肉之中”,“分肉之中”是指肉与肉之间,即包裹骨骼肌的深筋膜之间,因此“分肉之中”即“筋膜之间”。赵京生先生认为四街理论与卫气相关,主要用于说明头身部腧穴的近治作用^[2],气街所在的胸、腹、头、胫四个部位,分别包括了胸膜、腹膜、脑膜、四肢骨骼肌浅、深筋膜,均是卫气所循行留止的部位。《素问·五脏生成》认为人体“溪谷”是“卫气留止”之处,而“溪谷”与经筋“结”“聚”之处密切相关,“针石缘而去之”也是局部取穴之意。《灵枢·邪客》认为卫气的循行“先行于四末分肉皮肤之间而不休”,继而“行于五脏六腑”。经筋与卫气无论生理还是病理两者关系紧密,卫气布散于皮肤分肉之间,即筋膜之间,其运行失常易产生痹证^[3]。

《灵枢·天年》所说的“肌肉解利”是经筋的生理常态,《灵枢·刺节真邪》载“一经上实下虚而不通者”,是指在病理状态下出现的“筋结处”,代表着邪气在此聚集,即“横络盛加于大经”,导致气血不能流畅,又可引起远端继发性病变,因此“解结法”起到了散邪、疏通经络阻塞的作用。薛立功先生认为“横络”便是指经筋病变时产生的黏连、条索等病理产物,这些病理产物又可以成为新的致病原因,卡压经脉,因此松解“筋结”“结络”,减轻压迫,便是《灵枢·官能》所记载的“解结法”。

有学者将经筋病变分为外周经筋病变与中枢经筋病变两大类型,其中外周经筋病变的过程包括瘀沫期、拘挛期、病灶期^[4],经筋病变时可触及阳性反应物,并且以“痛性反应物”“筋结处”“结筋病灶点”“横络”称之,均可产生相应的“筋结点”,进而影响气血运行,出现“经筋累及病变”,此时先解除“筋结点”,使气血恢复通畅,再根据脉之虚实施以补泻。经筋刺法其目的在于“解结”,与经脉刺法中的“气至病所”不同,有学者总结为“针至病所”,是对局灶性病变的治疗方

[1] [明]张介宾.类经[M].北京:中国中医药出版社,1997:32.

[2] 赵京生.气街理论研究[J].针刺研究,2013,38(06):502-505.

[3] 刘农虞.经筋与卫气[J].中国针灸,2015,35(02):185-188.

[4] 程永,王竹行,唐成林,等.经筋病中医病理机制理论探讨[J].辽宁中医药大学学报,2014,16(06):101-108.

法^[1]，“筋结点”和激痛点^[2]、压痛点^[3]之间的关系，也逐渐为学者所重视。

2.4.3.2 经筋病诊查方法

黄敬伟医师在《经筋疗法》一书中认为^[4]，经筋损伤后因挛缩产生的病灶“筋结”，是经筋病的病理基础，病灶点不仅可以产生局部症状，还可以引发其他器官的功能障碍，产生各种筋性症状，并将检查阳性病灶的方法称为“经筋查灶法”。薛立功先生也认为可以根据经筋病痛处，沿着所属经筋循行分布，通过按揉检查出所有阳性和隐性的结节，此外病变所在部位左右相邻以及身体对侧经筋均在诊查范围内^[5]。诸学者对“筋结”成因的认识不同，但一致认为“筋结”可反应病理状态，作为病理产物又可以导致新的症候，同时也是疾病的治疗点。对“筋结”的检查主要是以触诊为主，人体十二条经筋均是从四肢末端循行向头颈胸腹，即呈“向心性”，临床上初步确定是哪条（或哪几条）经筋发病，以手指的指尖、指腹对发病经筋顺其循行路径由浅至深分层搜查病灶筋结，有无条索、结节、酸胀感、压痛等，并探知筋结与周围组织的关系。

《灵枢·经筋》中经筋病变的选穴原则为“以痛为输”，此处“痛”不能单纯理解为“疼痛之处”，秦汉时期医家常以“痛”字代表病痛处、病变处，不一定是以“疼痛”的症状表现出来，因此经筋病变的“以痛为输”也可以理解为“以筋急处为输”，经筋病产生疼痛并不固定，诸疼痛部位可能是由于某一处“筋急”引起。因此寻找到“筋急”所在的位置，便是施治的部位。春秋时期医家水平高低多是以其诊断能力作为考核标准^[6]，无论是经筋理论还是经脉理论，都具有“诊疗一体”的特点。此外还需注意，临床上筋结不止一处，需通过触诊探查出所有的筋结所在，并分清原发筋结与继发筋结，针对原发筋结进行重点治疗，收效会更快。此外在触诊过程中，对寒热、虚实的辨别也很重要，提示在去除筋结之后如何选用针刺补泻，经筋疾患大多属运动系统，易出现疼痛、寒热、肢体形态体位、肢体功能变化等，故在诊察方面较侧重切诊。

[1] 董宝强,林星星,王树东,等.经筋刺法与针至病所理论的关系[J].中医杂志,2017,58(03):189-191+194.

[2] 沈宇平,董宝强,林星星,等.结筋病灶点与激痛点的比较[J].中华中医药学刊,2016,34(11):2646-2649.

[3] 王列,马帅,马铁明,等.激痛点与阿是穴、压痛点、腧穴、经筋点、结筋病灶点辨析[J].中西医结合研究,2021,13(6):415-417.

[4] 黄艺,黄敬伟.经筋疗法(第二版)[M].北京:中国中医药出版社,2018:74.

[5] 薛立功.中国经筋学[M].北京:中医古籍出版社,2015:57.

[6] 王秦汉.《左传》所见疾病、医疗及其与社会的关系[D].湖北省社会科学院,2020.

陈泽林先生提出的“筋象”理论体现了中医“象思维”理论在经筋诊查中的特点，并且依此用拔罐法进行“度筋论治”，对经筋理论的发展颇具启发^[1]。此外笔者认为，经筋病变除了寻找局部病灶“筋结处”之外，还需要充分应用“望闻问切”四法，对经筋发病进行全面的诊察，如望诊中应对损伤局部充分暴露以便观察，望病人走路姿势以及做某些动作（关节屈伸收展、颈腰部活动）时是否困难，面部表情有无改变（痛苦面容），在活动关节的时候听关节处有无响声以及响声的大小、性质（弹响声、捻发音），还可以问患者疼痛拘挛的位置、程度、加重减轻因素，在此基础上，重点使用切（触）诊法准确寻找局部病灶。一般的触诊属于物理学检查，在此基础上，还需结合影像学检查，排除其他疾患，确诊属于经筋病变。

2.4.3.3 经筋病症的分类

《灵枢·经筋》中所记载的由寒热因素导致的“筋急”和“筋弛纵”是经筋病变最早分类方法。但是在《经筋》篇十二经筋的主病中，论述较多者为“当所过者支转筋痛”，表现为关节活动障碍，经筋病变易出现“十二痹”，清代医家张志聪在《黄帝内经灵枢集注·经筋第十三》称：“痹者，血气留闭而为痛也。”^[2]在经筋病候中，多以痛症为主，秦汉时期，肢体、关节酸麻痹痛、筋肉拘急及活动不利的痹证较为常见。此外还有口僻、目不合等五官病，以及息贲、吐血等少数内脏病。还有将经筋病变分类为外周病候与内脏病候；或者分类为一般筋病、特殊筋病、经筋病累及病症。对经筋病症与经脉病症的区分有其必要性，两者侧重点不同，经筋病取穴时多注重部位辨证，而经脉病症其特点就在于远端取穴，选取五输穴治疗相应的脏腑病^[3]。

《足臂》“脉”字写作“温”，有学者认为“温”又是古字“筋”之误，“筋”即今之肌腱，肌腱属于狭义的“筋”，故《足臂》《阴阳》论述的是经筋系统，不是经脉系统，揭示《灵枢》中的经筋理论与经脉理论同渊共源，早期针灸文献中记载的病症多被整合在《灵枢·经脉》篇中，在忽视经筋病变的情况下，“是动病”“所生病”的界限逐渐被模糊化，也使得经脉理论包容性越来越强、准确性反而

^[1] 杜旭,陈泽林.试论“筋象”与拔罐疗法的“度筋论治”[J].中国针灸,2019,39(05):541-544.

^[2] [清]张志聪.黄帝内经灵枢集注[M].北京:中医古籍出版社,2012:149.

^[3] 陈采益,徐斌.基于区分经筋病症与脏腑病症进行针灸辨证论治的思考[J].中国针灸,2017,37(10):1105-1107.

越来越弱。结合“是动病”“所生病”以及《灵枢·经筋》篇主病，提炼出经筋病症，区分经筋、经脉病症的范畴，是较为关键的一步。

运动、神经系统疾病是针灸科的常见病，其病变多发生在关节、筋肉处，是典型的经筋病症，但医家在临床诊疗过程中，常未加思考地用“经脉所过，主治所及”进行辨证治疗，致使用经脉理论指导经筋病症的现象谬传至今^[1]。刘农虞先生将经筋病变分为筋性痹病、筋性腔病与筋性窍病^[2]。现代理论指导下还出现了新的经筋病症，如肌肉损伤或痉挛时，可以卡压相关神经，引起相应的脏腑器官病变^[3]。如对颈部经筋病变治疗中，应排除椎管内组织病变，确定属于经筋病范畴，除处理相应病灶“结筋处”之外，还应该注意纠正因病灶处导致的颈椎关节紊乱，在松解颈部肌肉的挛缩后，改变颈椎周围受力，恢复受力平衡状态，则颈部血管、神经不同程度的压迫都能改善。这些新的经筋病症提示我们，经筋病症的分类应尽快规范化。

2.4.3.4 经筋病治疗方法

“施治处”是针灸疗法应用过程中的关键点，腧穴是其重要组成部分，但并非唯一^[4]，经脉病变时多选取特定腧穴“五输穴”进行治疗，而经筋病变时，可选取的“施治处”较多，且大多数并非传统意义上的“经穴”，即使是“经穴”，其理论指导也并非是经脉理论。《灵枢·经筋》篇所提出的治疗法则有三：①治在燔针劫刺，以知为数，以痛为输；②足少阳经筋“维筋相交”，即左、右交叉取穴；③综合治疗，如足阳明经筋的“颊筋症”。刘农虞先生对“燔针劫刺”^[5]“以知为数”^[6]“以痛为输”^[7]有专文论述。学者多将“以痛为输”与“阿是穴”联系在一起，认为经筋病变就是选取阿是穴进行治疗，这种认识是片面的：首先“以痛为输”的“痛”不一定就是单纯指“疼痛部位”，黄龙祥先生指出，秦汉时期“痛”有时候指“病”，“以痛为输”相当于“以病变部位为输”，如《太素》：“遂以病居

[1] 刘农虞. “筋脉系统”假说[J]. 中国针灸, 2017, 37(01): 79-83.

[2] 刘农虞. “筋针”的作用机制探析[J]. 中国针灸, 2015, 35(12): 1293-1296.

[3] 薛立功. 经筋系统的生理结构与解剖内涵[C]//中国针灸学会经筋诊治专业委员会成立大会论文集, 2009: 81-93.

[4] 赵京生. 从应用角度检视针灸理论[J]. 中国针灸, 2017, 37(10): 1115-1118.

[5] 刘农虞. 议“燔针劫刺”[J]. 中国针灸, 2013(S1): 102-104.

[6] 刘农虞. 谈“以知为数”[J]. 针灸临床杂志, 2013, 06: 67.

[7] 刘农虞. 析“以痛为输”[J]. 针灸临床杂志, 2014, 02: 55-57.

痛处为输。”^[1]因经筋“中无有空”“筋病无阴无阳，无左无右，候病所在”，因此外邪从体表而入，病位多固定不移，不像经脉病变时会发生传变，因而取痛处为输，实际上是取病变所在部位为输。赵吉平认为“以痛为输”的取穴原则尚可引申为“选取病变局部穴位”，经筋病除痛症以外，还包括转筋、拘急、掣引等病证。此外，王茵萍医师^[2]认为疼痛本身不能反应病位（如牵涉痛），同时疼痛处也并非最佳针刺点，如急性扭伤处于出血水肿期时，就不宜直接针刺病灶，因此“以痛为输”的治疗原则的前提，应是深入探知病灶解剖结构病理变化，方能使治疗具有针对性，达到一定治疗效果。“维筋相交”是古人对于延髓锥体交叉的初步认识^[3]，但“维筋”并不是延髓，古人将“维筋”归属于足少阳经筋，从“维筋”与目之间的关系，有学者认为“维筋相交”是指足少阳经筋从一侧目眦交至另一侧目眦，再上至头顶并入蹻脉^[4]，除此之外，阴蹻脉、阳蹻脉也是古人对一侧大脑支配对侧躯体运动及感觉的认识，说明足少阳“维筋相交”与蹻脉关系密切。古人治疗面瘫时选取对侧合谷，治疗运动系统障碍时选取申脉、照海皆是在“维筋相交”的理论指导下进行的。

经筋病变有其特殊刺激点可以选取^[5]，这些刺激点与归属于十二经脉的“经穴”位置不同，且自成体系，无转输气血之功能，为区分“腧穴”的转输气血功能，不至于混淆，可称为经筋穴位，或经筋刺激点。一般经筋病变，主穴应该“以痛（病变处）为输”，以筋结处或压痛点为首选。将“以痛为输”视为“阿是穴”，单纯地理解为指压痛点，是不准确的，孙思邈“阿是穴”的“阿”，并不是因疼痛而发出的叫喊，“阿”是询问，相当于问“是不是”，因此“阿是穴”是医师切诊时问患者：“是不是这个地方？”除了疼痛点外，还意为病灶反映处。近年来有学者提出“反阿是穴”的概念^[6]，在临床上用于肌肉、肌腱疼痛性疾病效果较好，对此现象有学者从针刺改变骨骼肌张力的横向、纵向传导通路的角度做了解释^[7]。

此外，治疗经筋病变的选穴方法还有：①选取同名经脉经穴，《太素·经筋》：

[1] [隋]杨上善.黄帝内经太素[M].北京:中医古籍出版社,2016:187.

[2] 王茵萍.经筋病“以痛为腧”辨析[J].安徽中医学院学报,2000(01):38-39.

[3] 许军峰,卞金玲,吕建明.石学敏院士对《内经》“维筋相交”理论探析[J].中国针灸,2015,35(08):830.

[4] 刘文秀,马凯强,李博灵,等.“维筋相交”之我见[J].中国针灸,2018,38(03):261-262.

[5] 王燕平,侯学思.论腧穴分类[J].中国针灸,2019,10:1069-1072+1074.

[6] 张文兵,霍则军.反阿是穴肌肉起止点取穴法初探[J].辽宁中医杂志,2001,28(7):432-433.

[7] 曹曷焱,饶毅,庄威,等.从骨骼肌张力传递解读反阿是穴的治疗效果[J].中国针灸,2021,41(02):217-220.

“明堂依穴疗筋病者，此乃依脉引筋气也。”^[1]近年来，学者对“依脉引经气”进行研究，认为经筋病可以根据该原则，选取足阳明、足厥阴相关穴位，或是同名经经穴进行治疗^[2]。②足太阳经“是主筋所生病”，《灵枢·经筋》认为足太阳之筋是十二经筋的起始。又《素问·生气通天论》记载：“阳气者，精则养神，柔则养筋。”^[3]古人认为“卫气始于足太阳，而复会于太阳，故太阳主外”（张介宾《类经·经络类》），因此，卫气、足太阳与经筋之间关系密切^[4]。③运用“四结”关系取穴：名老中医管遵惠提及经筋排列顺序为足三阳、足三阴、手三阳、手三阴，手足经筋结聚于同一个部位，称之为“四结”，即：足三阳结于颞（颞部），足三阴结于阴器，手三阳结于角（头侧部），手三阴结于贲（胸膈部）^[5]。

2.4.4 经筋理论未来研究刍议

2.4.4.1 对病灶“筋结点”进行详辨

借助现代解剖学以及生理病理学对经筋进行研究，“结筋处”为历代医家所重视，但古代医家受时代所限，不能有更深入的认识，在现代科学环境下，后学者则不能“浅尝辄止”，比如许多文献对“结筋处”以“多表现为团块状、条索状、杆状、线状”笼统概括，其实“结筋处”所在的解剖层次不同，其形状也不同，深筋膜病灶多呈条索状、线状，且活动度较小；滑液囊病灶多呈团块状；肌肉组织随其病变肌束的范围而呈现不同的症状，如部分肌束痉挛时呈痛性条索，而大量肌束被涉及时，可出现痉挛性团块，且常牵涉到远端的抵止点及附属组织^[6]。如学者研究，无论是肩周炎^[7]还是膝关节炎^[8]，其病变附近的病灶“结筋处”出现的部位频率与其解剖结构和生物力学特点密切相关。与针灸治疗最相关的便是体表组织，针灸施治处与解剖结构直接相关，各个时期的医学认识其实是建立在该时期对人体的认识基础之上的^[9]，对体表“皮肉筋脉骨”这些结构的认识，决定着针灸治疗的科学性^[10]。薛立功先生根据张介宾《类经》：“足太阳之筋……结于昆仑

[1] [隋]杨上善. 黄帝内经太素[M]. 北京: 中医古籍出版社, 2016: 187.

[2] 胡忍杰, 蒋永亮, 李荣荣, 等. 经筋病“依脉引筋气”探微[J]. 中国针灸, 2021, 41(03): 335-338.

[3] [春秋]佚名. 黄帝内经素问[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2012: 12.

[4] 李怡廷, 武平, 廖晨希. 太阳主筋释疑[J]. 中国针灸, 2019, 39(06): 659-660.

[5] 叶建, 管遵惠. 管遵惠老师经筋理论的运用经验[J]. 云南中医中药杂志, 2005(03): 2-3.

[6] 薛立功, 张海荣. 经筋理论与临床疼痛诊疗学[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2002: 45.

[7] 尤柱, 于本性, 邓甜甜, 等. 肩周炎结筋病灶点临床触诊规律分析[J]. 中国针灸, 2014, 34(06): 565-568.

[8] 张书剑, 张小卿, 韩煜, 等. 膝骨性关节炎经筋病灶点触诊规律分析[J]. 中国针灸, 2012, 32(03): 267-272.

[9] 余新忠. 中国疾病、医疗史探索的过去、现实与可能[J]. 历史研究, 2003(4): 158-168.

[10] 赵京生. 针灸视域下的身体表达[J]. 中国针灸, 2019, 39(03): 307-312.

之次。”将昆仑穴附近的经筋称为“昆仑次”，在生理状态下是一个正常点，病理状态下则是病灶“结筋处”所在。“次”在《说文解字》中解释为：“次，不前，不精也。”^[1]有“位居其后”之意，而昆仑之后则是跟腱，体表可以明显触及，但并非所有穴位与附近经筋都如“昆仑-跟腱”这般明显，并且经筋包含范围较广，除肌腱外，肌肉、筋膜皆是，此外，该处称之为“昆仑次”，若称之为“太溪次”同样指跟腱。因此这种“XX次”的命名方法还有待商榷。

2.4.4.2 膜系统理论与内脏建立联系

人体膜系统可维持形体状态和正常生理功能，“筋膜”属于膜系统的下位概念，脏腑也有“筋膜”，陈潮祖先生曾提出筋膜在人体表里上下无处不有^[2]，“大至五脏经隧，小至每一细胞，均由筋膜构成”，全身之筋膜属于广义三焦，陈潮祖先生认为三焦之膜分布在“皮肤之中、分肉之间、胸腹盲膜、五脏经隧夹层、眼膜间隙、脑外腔隙”，对于卫气与三焦，认为“卫气运行其间（三焦），才能温煦形骸”，进一步提出“气血津精环流全身，只有血管、三焦两条道路”^[3]。陈氏所说的“血管”“三焦”，在针灸理论中分别对应经脉理论与筋膜系统。经脉理论主行血（营），筋膜系统通行气（卫），构成了中医学的整体特征。现代医学已经进入细胞、分子层面，对经筋的研究也应当深入，如有学者提出微观经筋结构的概念^[4]。

筋膜系统属于经筋理论的重要组成部分，《内经》时代经筋理论未能与内脏产生联系，指导性不强，又由于经脉理论“一枝独秀”，且能通过经别、络脉联系周身上下，使得经筋理论逐渐没落，经筋理论让位于经脉理论最主要的原因在于：疾病不能完全根据“以痛为输”的理论进行指导，如心痹不能直接刺心，“针至病所”这种以病症部位为刺灸点的方法便无法施展，后来在“气街理论”的支撑下，“从阴引阳”“从阳引阴”的刺法应运而生，而这种理论又无法为十二经筋所包容，原本由经筋理论指导的病症（如痛症、面瘫、痹证等）皆归于经脉理论。故“脏腑经筋”理论的提出有其必要性，尤其在解释某些内脏病的发病机理方面，如经筋重要功能之一就是固定内脏，当脾气虚不能化生水谷精微，精血津液亏虚，筋

^[1] [汉]许慎.说文解字[M].北京:中华书局,2015:178.

^[2] 陈潮祖.中医治法与方剂[M].北京:人民卫生出版社,2009:19

^[3] 和靖,李炜弘,欧阳双,等.基于陈潮祖“膜腠三焦”学说再探三焦的形质与功能[J].中华中医药杂志,2021,36(04):1969-1971.

^[4] 魏子耿,李丽肖,刘永强,等.《灵枢·经筋》“十二经筋”组织解剖结构浅析[J].河北中医,2016,38(02):272-274+301.

肉失养则可并发胃下垂、子宫脱垂、脱肛等经筋病。经脉理论主要用于阐释腧穴的远治作用，正如赵京生先生所讲“腧穴如果只有近治作用，那么经脉理论也没有存在的必要了”，经脉理论是对人体纵向体表-体表，体表-内脏之间关系的阐释，偏于理论化。而经筋理论则是从解剖角度进行阐释，经脉学说与经筋学说相辅相成，并无主次之分，在未来研究中，若能将脏腑（巨视）经筋、微观经筋理论进一步完善，使得四肢躯干头面之“经筋”，得以进入体内，与胸腹腔内的膈膜、育膜产生联系，形成全身体表-脏腑膜系统的统一，那么对于当下经脉-脏腑相关理论，亦可以提供解剖层面的依据。

2.4.4.3 从解剖层面阐释经筋实质

经筋理论本身起源于古人对人体解剖的认识^[1]，分析《灵枢·经筋》篇可知，经筋的循行范围较经脉更广，某些经筋的止点（如足太阴经筋、手厥阴经筋）呈现片状分布^[2]。在此基础上，现代学者借鉴西方解剖学的发展，对经筋理论的实质提出了较多假说，如肌筋膜链学说^[3]、十二条运动力线学说^[4]、肌筋膜复合体学说^[5]等。均是从解剖结构角度探讨“经筋”的实质，笔者认为，经筋理论本身就源于古人对肌腱、关节等结构的观察总结，更偏向于解剖形态，但这些认识仅能解释经筋的结构问题，对于经筋中筋膜之间通行卫气，以及对经筋病变的解释力度则略显不足。

2.4.5 小结

先秦两汉时期发展起来的经筋学说是古人对临床诊疗经验的总结，“十二经筋”是对“筋”的归纳体系，“筋”是散在的，而“经筋”则是成系统的，就像“脉”是散在的，而“经脉”则是对“脉”观察诊疗规律的归纳，并进一步具有了解释生理病理现象，以及指导临床实践的作用，早期经筋、经脉、经别以及气街、四海等理论是独立并行的，从《灵枢》的篇名中也可以看出来，“经脉第十”“经别第十一”“经筋第十三”均是独立成篇。《太素》将经别归属于经脉，“经脉”分为三卷，而“经筋”则与“骨度”“肠度”“脉度”合为一卷，命名为“身度”。后世

[1] 刘斌. 经筋定义及特性之启发[J]. 中华中医药杂志, 2019, 34(03): 888-891.

[2] 梁宜, 方剑乔. 《灵枢》经筋理论探析[J]. 中医杂志, 2006, 49(6): 488-489.

[3] [美] Thomas W. Myers. 解剖列车——徒手与动作治疗的肌筋膜经线[M]. 北京: 北京科学技术出版社, 2016: 8.

[4] 颜富雄. 经筋系统—人体十二条运动力线的探讨与临床应用[D]. 山东中医药大学, 2016.

[5] 魏子耿, 李丽肖, 刘永强, 等. 《灵枢·经筋》“十二经筋”组织解剖结构浅析[J]. 河北中医, 2016, 38(02): 272-274+301.

针灸理论的发展过程中，经脉学说的地位越来越被医家所重视，甚至本属于“经筋学说”所解释的主治病症也归于“经脉系统”，“经脉”在发展过程中被人为地赋予了许多“功能”。当下对经脉的实质研究既有从气血层面进行解释，也有在实体解剖层面苦寻者，使得经脉学说的实质既是“虚空”又是“实体”，表面看似将经脉理论的范围扩大、含义更广，实际上是对经脉学说“解释力”的削弱，其“解释准度”的模糊化，反而不利于经脉学说的发展。对“经筋学说”相关理论进行合理认识，提高与“经筋”相关病症诊疗的准确性，此外还可以为经脉学说减压，有利于对经脉学说本质的认识，推动经脉学说的合理发展。

2.5 络脉理论演变梳理

《灵枢·经脉》记载了十五络脉，即十二经脉之络、任督二脉之络以及脾之大络，此外，在《素问·平人氣象论》中还载有“胃之大络”，故也有认为应该是“十六络”。十二经脉以及任、督二脉的络脉均以“XX之别”引出，如手少阴脉的络脉“通里”，既作为穴名，又作为络脉名。十五络脉属于正经发出的别行分支，一般认为其作用是沟通表里两经，即“别走XX”。实际上络脉的循行与主病也具有临床价值，手少阴络脉“入于心中，系舌本，属目系”，其主治病症“实则支膈，虚则不能言”与循行路径关系密切，治疗也是取通里穴，在秦汉晚期的腧穴专著《明堂经》中，手少阴络脉病候“实则支膈，虚则不能言”成为通里穴的主治病症。从络脉的循行以及主治病症来看，十五络脉实际上与正经类似，沟通表里两经只是“形式上”的一个功能。秦汉时期属于络脉的形成与发展时期，《灵枢·脉度》在对十二经脉与任督二脉的长度进行论述之后，总结道：“经脉为里，支而横者为络，络之别者为孙。”《内经》编者将先秦两汉时期的络脉学说进行系统论述^[1]，络脉学说不仅在针灸学范畴占有重要的地位，在方剂学范畴也发挥着重要的指导作用，汉末医圣张仲景将活血化瘀通络法应用于临床，如大黄蛰虫丸、鳖甲煎丸等。

《内经》成书是络脉学说形成的标志，其实在《内经》之前，络脉学说已经存在，成都老官山汉墓出土的《别脉》（后归入《脉书·下经》）中，首次出现“间别脉”的内容，梁繁荣等人在著作《揭秘帛书与漆人：老官山汉墓医学文物文献初识》中认为“间别脉”应该是“别脉”的意思^[2]，而且“别脉”与《内经》中十二经脉主干、分支以及络脉、经别等均有关系，称老官山医简《别脉》可能是络脉的前身。广濂薰雄先生认为这一说法所指的范围非常广泛，广氏认为“间别”是并列式双音词，其实与《内经》中的十五络脉非常相似，《灵枢·经脉》中“XX之别”是指经脉发出的分支，“间别”也有此意^[3]，早期马王堆帛书《足臂》《阴阳》中仅记载十一条经脉，而老官山《脉书》中将经脉与络脉合并而论，《灵枢·经脉》也承袭了这种框架。因此，老官山医简《别脉》中所提到的“间别脉”，可以视作是十五络脉的早期形式。此外老官山针方简《刺数》中也提到

[1] 李洁. 络脉文献的整理与研究[D]. 成都中医药大学, 2006.

[2] 梁繁荣, 王毅. 揭秘帛书与漆人[M]. 成都: 四川科学技术出版社, 2016: 65.

[3] 广濂薰雄. 天回老官山汉简《别脉》初探[J]. 出土文献与古文字研究, 2020(00): 316-328.

了“足巨阳落”“巨阳落”“腹阳明落”“肩阳明落”“心落”等概念^[1]，整理人员认为“落”即“络”。这些概念指络脉或者络穴，《刺数》是一部针刺预设方的合集，可见络脉的概念在汉代早期已经广泛用于临床诊疗中。

秦汉时期对络脉的认识，除十五络脉之外，还有无数细小的孙络，《素问·四时刺逆从论》^[2]对经脉与孙络的关系介绍为：“经满气溢，入孙络受血，皮肤充实。”常人面色红润，体态丰腴，说明孙络气血旺盛，由此推测，行于体内的经脉气血也常处于充盈状态，且经脉气血充盈过剩，多余的气血才会进入孙络，使得“皮肤充实”。《灵枢·痈疽》《灵枢·经脉》则提出了相反的认识，认为由中焦运化的水谷精微先进入孙脉，而后孙脉满溢之后方才进入经脉，有学者认为这是络脉气血可以双向流注的特点^[3]。《内经》一般将生理状态下的孙络又称之为“浮络”（根据部位命名）“横络”（根据循行走向命名）“血络”（根据容纳物质命名），病理状态下则称为“盛络”“虚络”“结络”，此外还用“阴阳”区分，如《灵枢·百病始生》记载若过度用力时可能会损伤细小的络脉，“阳络伤则血外溢……阴络伤则血内溢”，阳络较为浅表，阴络位于深层，据此有学者认为，“久病入络”应该是指位于深层的阴络，而学术界目前则多停留在浅表的阳络，故提出络脉分层次的重要性^[4]。

秦汉时期，络脉还有一个最主要的功能，就是用来诊察疾患，《灵枢·经脉》提到由于经脉循行于身体内部，一般不能用肉眼直接观察，所以只能通过触诊浅表动脉，如寸口处桡动脉，以诊察病之虚实，《内经》时期医家强调凡是在体表能够看到的“脉”，皆为络脉，即“诸脉之浮而常见者，皆络脉也”。《内经》多处提到了利用络脉进行望诊，如《灵枢·经脉》首先提到络脉的“青”“赤”分别代表“寒且痛”与“热”，是总的原则，接着又专门以胃的寒热病变进行举例，其中“手足之络多青”代表“胃中寒”，而“鱼际络赤”代表“胃中有热”，《灵枢·论疾诊尺》也集中总结为：“多赤多热，多青多痛，多黑为久痹。”^[5]络脉病变时，秦汉医家多用刺络放血法进行治疗，即“宛陈则除之，去血脉也”（《灵枢·小

[1] 赵丹,段逸山,王兴伊.试析老官山汉墓《刺数》“经脉穴”与《黄帝内经》腧穴的对应关系[J].中国中医基础医学杂志,2019,25(02):205-208.

[2] [春秋]佚名.黄帝内经素问[M].北京:人民卫生出版社,2012:240.

[3] 萧淑芳.络脉的古代文献研究[D].北京中医药大学,2006.

[4] 冉维正,陈志刚.从“久病入络”看络脉层次分类的必要性[J].中国中医基础医学杂志,2019,25(07):883-884+981.

[5] [春秋]佚名.灵枢经[M].北京:人民卫生出版社,2012:127.

针解》)。

在络脉的临床应用中,现代吴以岭院士对经脉、络脉等概念研究的基础上,提出了脉络学说^[1],对于心血管疾病具有重要的指导意义^[2]。陆鹏先生提出“玄府—络脉体系”,将中医学的两个微观概念综合在一起^[3],对中医学基础理论提出了诸多创新,如“肾玄府—络脉与肾小球滤过屏障”^[4]“肺玄府—络脉与气血屏障论”^[5]等,对脏腑经脉理论以及相关系统疾病均有启发。诸学者对络脉学说临床应用^[6]以及病理机制^[7]等方面也有新的认识。

^[1] 吴以岭. 络病病机探析[J]. 中医杂志, 2005, 46(4): 243-245.

^[2] 吴以岭. 脉络学说构建及其指导血管病变防治研究[J]. 中国中西医结合杂志, 2017, 37(2): 147-148.

^[3] 陆鹏, 由凤鸣, 胡幼平, 等. 玄府—络脉体系概论[J]. 中国中医基础医学杂志, 2017, 23(01): 29-30+92.

^[4] 陆鹏, 刘丽香, 潘迪, 等. 论肾玄府络脉与肾小球滤过屏障[J]. 中医杂志, 2016, 57(21): 1888-1890.

^[5] 陆鹏, 任凤艳, 潘迪, 等. 肺玄府络脉与气血屏障论[J]. 中医杂志, 2016, 57(16): 1433-1435.

^[6] 李红梅, 王显. 从“玄府—气血—络脉”新视点探讨动脉粥样硬化“络风内动”学说[J]. 中医杂志, 2015, 56(05): 441-443.

^[7] 王显, 王永炎. 对“络脉、病络与络病”的思考与求证[J]. 北京中医药大学学报, 2015, 38(09): 581-586.

3 先秦两汉经脉理论演变讨论

3.1 经脉理论的起源

3.1.1 “脉”“血脉”“经脉”概念演变

张家山《脉书》对诊体表脉动处做了简单总结：“夫脉固有动者，骭之少阴，臂之钜阴、少阴。”^[1]其中“脉固有动者”是指正常之脉，病理状态下则变为“有过之脉”，治疗应“视有过之脉，当环而灸之……当郄与肘之脉而砭之”，灸与砭的对象皆是实体的“脉”^[2]。此时先民对“脉”的认识还停留在“左右血先出，为脉”，即脉容纳血的认识层次，而后将“气”引入脉的生理中，构成了早期特殊的“血气”学说。

古人对“脉”的概念，早在先秦时期就已经形成，“脉”的本意就是指解剖而见的血管，《灵枢·经水》记载对于活体可以“度量切循”，对于尸体可以“解剖而视之”，其脏、腑、血、脉皆在解剖观察范围内，脉为“血之府”，最初的作用就是容纳血液。后来由于“气”的概念逐渐为医家所重视，于是脉行“血气”的理念逐渐流行起来，《灵枢·经脉》在描述人体生长发育的特点时称：“谷入于胃，脉道以通，血气乃行。”以及《灵枢·本脏》对经脉功能描述为“行血气而营阴阳”，将“血”与“气”并称为“血气”，随着医疗活动的发展，在导引行气、针刺感传现象的启发下^[3]，“脉”的功能已经从单纯的解剖结构变为了解释人体生理病理的“说理工具”，笔者认为这一现象出现时间较早，《周礼》^[4]：“凡药……以咸养脉……”《足臂》《阴阳》已经出现“脉”的概念，大致成书于战国中期的《管子》中已经提及^[5]：“水者，地之血气，如筋脉之通流者也。”说明“脉”中通行血气的认识至迟在战国中期就已经形成，对于脉的正常生理状态有初步认识。

《汉书·艺文志》：“医经者，原人血脉经落（络）骨髓阴阳表里……”^[6]说明在汉代，人们已经将“血脉”与“经络”彻底区分开来，用“经络”高度提炼了血脉过多承载的功能，而现代研究者多将“经络”的概念及范围进一步扩大，将

[1] 张家山二四七号汉墓竹简整理小组. 张家山汉墓竹简（二四七号墓）（释文修订版）[M]. 北京：文物出版社，2006：126.

[2] 赵京生. 针灸经典理论阐释[M]. 上海：上海中医药大学出版社，2000：69.

[3] 孙静文，田艳鹏，郭妍，等. 脉之本义及其学术演变[J]. 中国针灸，2015，35（06）：619-622.

[4] [西周]姬旦撰；杨天宇译注. 周礼译注[M]. 上海：上海古籍出版社，2016：95.

[5] 于春燕. 从出土材料看《管子》相关篇章的成书年代[D]. 山东师范大学，2021.

[6] [汉]班固. 汉书[M]. 长沙：岳麓书社，2009：402.

“血脉”的概念缩小，甚至在经脉理论中全无血脉的影子^[1]。其实，经脉学说在先秦时期尚未形成完整的体系，直到《内经》成书之后，才逐渐完善起来^[2]。因此，在研究先秦两汉经脉文献时，尤其是研究出土文献时，可以适当将“血脉”的概念放大，将“经络”的概念缩小。

3.1.2 精气学说促成“血气”概念

冯友兰先生在《中国哲学史新编》中对战国时期精气思想在医学领域的影响进行了探讨，认为精气思想可以用来“说明健康和疾病的原因”，并且认为《内经》强调养形实际上就是在保护精气^[3]。精气学说起源于先秦道家，尤其是稷下道家学派认为物得到精气才能有生命，人得到精气才能有思维^[4]。张家山《引书》是一部战国中晚期汇集而成的医学著作，在此书中已经显示出了精气学说在中医学领域的特点。张家山《引书》中，多次提及精气学说，如“吸精气而咽之”“吹呬呼吸天地之精气”等等。更重要的是，《引书》中所论述的气已经具体到了人体的某个部位，如“头气下流”“苦两手少气”“跌指以利足气”等，将精气的概念由模糊到清晰，由整体的精气到分散至头、手、足各个部位，成为医学文献的特点所在，在这种认识的影响下，产生了四气街理论^[5]。

对针灸理论原理及实践过程的阐释中，“气”无疑占据了一个非常重要的地位，“气”本身就是一个难以准确界定的概念，在战国中期，人们对于“气”的认识还局限在“云气”“雾气”“湿气”等显而易见的环境状态上。除此之外，“气”还用于对感觉和情绪的描述，如“怒者血气也”（帛书《老子》），“气”的这种变幻无形，既作为实体（云、雾、湿气），又作为虚空（感觉、情绪），使得其概念有了无限的扩展性、适用性，广泛应用于阐释人体内部现象的讨论，如《内经》提到“人之所有者，血与气耳”。“气”与“血”作为人体内最重要的两大物质而存在，在战国秦汉早期的文献中，“气”在人体内多是以情绪的状态而存在（或者说是用“气”来解释人的情绪变化），如张家山《引书》中提到“喜则阳气多，怒则阴气多”，“喜”“怒”这种常见的情感体验被解释为“阴气”与“阳气”的过剩。

[1] 赵京生. 简帛脉学文献对经脉认识的意义[J]. 医疗社会史研究, 2016, 1 (02): 36-50+328.

[2] 赵容俊. 先秦中国医学基础理论形成的考察[J]. 历史文献研究, 2014 (01): 88-108.

[3] 冯友兰. 中国哲学史新编(修订本)第二册, 三松堂全集[M]. 郑州: 河南人民出版社, 2000 (8): 474-476.

[4] 裘锡圭. 稷下道家精气说的研究. 裘锡圭学术文集·古代历史、思想、民俗卷[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2012, 291-292.

[5] 刘娇. 据张家山汉简《引书》中的“精气”思想解读其中两处文字[J]. 出土文献, 2020 (02): 93-103+157.

“气”与脉的结合，最终形成了“气循环”的概念，形成时间应该是在马王堆和张家山文献之后，《史记·扁鹊仓公列传》中，由扁鹊区分了“暴厥”与“尸厥”，“暴厥”是一种致命的症候，而“尸厥”却是一种假死现象，然而两者在扁鹊看来，都是气运行失调导致的，《史记》：“……血气不时……邪气蓄积而不得泄……暴厥而死……会气闭而不通……形如死状。”《史记》所记载的病例中，对气与经脉相关性的论述，相较于马王堆医书更为具体、复杂^[1]。

秦汉医家最早观察到的人体之气，应该是呼吸之气，张家山《脉书》中记载了一段关于“六痛”的论述：“夫骨者柱毆，筋者束毆，血者濡毆，脉者瀆毆，肉者附毆，气者胸（响）毆。故骨痛如斲，筋痛如束，血痛如泥，脉痛如流，肉痛如浮，气動（動）则憂（擾），夫六痛者皆存于身而人莫之智（知）治。”^[2]其中，“胸”与《难经》中的“响”是同义，可训为“吹”“嘘”，“气動则憂”中“動”意为“痛”，训作“病”，“憂”训为“气逆”^[3]。这段论述涉及到了“骨、筋、血、脉、肉、气”，其中“骨、筋、血、脉、肉”为肉眼可见，而“气”则不可见，体现秦汉医家对“气”较为重视，“人之所有者，血与气耳”（《素问·调经论》），“气”与血液流动、动脉搏动密切相关，常以呼吸一次时气血在脉内走行距离进行论述，如“呼吸定息，气行六寸”（《灵枢·五十营》），这一认识普遍见于秦汉时期医学文献中，如《素问·平人氣象论》《难经·一难》《脉经·诊损至脉》等。

经脉的概念最初来源于诊脉疗法，包括体表所能触及到的动脉搏动，以及所能看到的浅表静脉，如《灵枢·九针十二原》：“审视血脉，刺之无殆。”均是经脉产生与发展的重要基础。《淮南子·泰族训》^[4]载扁鹊之所以为人之所贵，并不在于施方开药，而是其诊断技术特别强，即“贵其摩息脉血，知病之所从生也”。《盐铁论·轻重》^[5]云：“扁鹊抚息脉而知疾所由生。”其中“息”指“呼吸”，“脉”指“脉搏”，扁鹊学派已经将呼吸与脉搏结合起来作为诊断的要点。正合“人之所有者，血与气耳”（《素问·调经论》），血气与经脉关系密切，《灵枢·九针十二原》论及针刺疗法的本质时，称可以“通其经脉，调其血气”，先秦两汉时期医家所总

^[1] [英] 罗维前著，邬文玲译. 痛的溯源——论痛、厥与经脉中气循环理论的形成[J]. 简帛研究, 2001: 275.

^[2] 张家山二四七号汉墓竹简整理小组. 张家山汉墓竹简（二四七号墓）（释文修订版）[M]. 北京：文物出版社, 2006: 125.

^[3] 程少轩. 也谈张家山汉简《脉书》的“气動则忧”[J]. 出土文献, 2018(02): 277-284.

^[4] [汉] 刘安. 淮南子[M]. 长沙：岳麓书社, 2015: 212.

^[5] [汉] 桓宽撰；王利器校注. 盐铁论校注[M]. 北京：中华书局, 2018: 198.

结的手三阴脉与足三阴脉，均大致位于体表能触及到的动脉搏动处，提示解剖诊察特点的总结与思考对于经脉演变的重要性^[1]。秦汉时期扁鹊学派以脉学闻名于世，《史记·扁鹊仓公列传》：“至今天下言脉者，由扁鹊也。”^[2]2012年成都老官山出土的医简，其中“敝昔”二字认为是“扁鹊”之意，故属于扁鹊学派的著作。老官山医简中有非常丰富的“损至脉”内容，刘小梅^[3]、广濑薰雄^[4]、袁开惠^[5]等学者均有论及，“损脉”是指跳动无力的脉象，皆为病脉，而“至脉”是指跳动有力且快速的脉象，既有正常脉也有病脉^[6]。但值得注意的是，老官山医简中的脉学内容，伴有主观理论假说的色彩，并非完全符合临床实际，如“人一息脉二动曰平”这一论述，就与人的生理状态下脉搏跳动情况不相符合，学者多将其视为纯粹的理论假说，是单纯为阐释《敝昔诊法》中“再至曰平”。体现早期医学不成熟的特征，而后发展至《脉经》中又进行了补充与完善。

3.1.3 先秦两汉巫医并用

《礼记》中记载孔子有言：“殷人尊神，率民以事神，先鬼而后礼。”^[7]对人类上古历史的研究，不可回避宗教信仰的问题，早期巫术、宗教和科学因素交杂在一起^[8]，清华简《尹至》写了商汤灭夏的细节，其中许多语句都与祝诅巫术相关，说明夏商文化之间存在着以巫术祈求神灵驾驭世界的现象。中国古代社会中，巫医不分，楚人崇拜巫覡，由此诞生了发达的医学。马王堆、张家山都与楚文化有着密切的关系。秦汉早期巫者兼医^[9]，东汉学者何休《春秋公羊解诂》称：“巫者，事鬼神，祷解以治病，请福者也。”^[10]陈邦贤在《中国医学史》中认为早期医学的演进中，经历了“巫→巫医混合→巫医分立”的过程^[11]。马伯英《中国医学文化史·医学启源》^[12]中也认为巫医是中国历史上首次形成的“有结构、成体系”的

[1] 李永明. 经脉的科学依据及三部九候新释[J]. 中国中西医结合杂志, 2021, 41(10): 1168-1173.

[2] [汉]司马迁. 史记[M]. 北京: 中华书局, 1959: 2794.

[3] 刘小梅, 李继明. 老官山汉墓医简中脉诊理论学术思想初探[J]. 中医药文化, 2017, 12(01): 4-6.

[4] [日]广濑薰雄. 谈老官山汉简医书中所见的诊损至脉论, 简帛研究论集[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2019: 517-539.

[5] 袁开惠, 王小芸, 赵怀舟. 也谈老官山汉墓医简所载“损至脉”[J]. 中医药文化, 2019, 14(04): 75-82.

[6] 丁媛. 呼吸、脉搏与疾病——从老官山汉墓医简所载之“损至脉”谈起[J]. 古籍整理研究学刊, 2022(01): 52-60.

[7] [汉]戴圣撰; 滕一圣译注. 礼记译注[M]. 北京: 商务印书馆, 2015: 218.

[8] 李凯. 出土文献与商周文明初探[M]. 北京: 北京联合出版公司, 2015: 246.

[9] 李学勤. 出土文献与中国古代文明——李学勤先生八十寿诞纪念论文集[M]. 上海: 中西书局, 2016: 641.

[10] [汉]何休注; [唐]徐彦疏. 春秋公羊传注疏[M]. 上海: 上海古籍出版社, 1990: 29.

[11] 陈邦贤. 中国医学史[M]. 北京: 商务印书馆出版社, 1954: 7-10.

[12] 马伯英. 中国医学文化史[M]. 上海: 上海人民出版社, 2010: 113-144.

一种医学模式，并且将其意义提升为“原始思维产生的第一个有价值的理论和实践成果”。

秦汉之际，治疗疾病的方法众多，医学史研究者应该充分认识到经脉、腧穴等理论仅仅是众多治疗方法（巫医混杂）中的一种。以巫术之法治疗疾病的情况，普遍存在于周朝社会中，最初经脉的产生，与巫术关系密切，山田庆儿称：

用艾施行咒术疗法的人们认为，侵入体内引起疾病的疫鬼的通行路径或区域，因而亦是疾病发展的路径或区域，是一种通道（route）。我认为这就是脉的发现或脉概念的最初的形成。这个通道，说不定最初曾被认为是血脉。由此逐渐形成了与血脉具有不即不离之关系的、作为与其不同之气的通路的脉，这样一种概念。由于是气的通路，因而亦是引发疾病之邪气的通路^[1]。

先秦时期统治阶级信仰鬼神致病说，这一现象被汉代所承袭，汉代巫鬼信仰盛行，东汉时期王充在《论衡·辨崇篇》中记载了这一风气：“世俗信祸祟……触鬼逢神，忌时相害……人之疾病……当风卧湿，握钱问祟……”^[2]并对汉时民众患病之后不求医而求助巫鬼的现象给予了批评，称为“俗人之知也”。汉代信巫鬼习俗比汉以前更盛行，比如我们现代所熟知的道符就是在汉代盛行起来的^[3]，道符象征了神灵的力量，用来驱散邪魅。但同时汉代的巫医界限已经越来越明显^[4]。

汉代为巩固君权神授的概念，建立了一套巫官系统^[5]。尽管巫、医在对病因、病理的认识以及治疗方法上均有天壤之别，但巫医并用，仍然是战国秦汉时期人们普遍的医疗选择^[6]。秦汉时期，医疗制度渐趋完善，秦汉政府都设有一套专为官僚阶级服务的医疗体系，尽管统治阶级占有相当丰富的资源，但在实际的医疗选择中，也是巫、医并用，如《史记》：“天子病鼎湖甚，巫医无所不致。”简帛文献中许多关于民间习俗的记载，都涉及到了医学范畴^[7]，如马王堆医书《杂禁方》中记载“……多恶薨（梦），蜎（涂）床下方三尺……婴儿善泣，蜎（涂）牖上方五尺。”

^[1] [日]山田庆儿著；廖育群，李建民编译. 中国古代医学的形成·传统医学的历史与理论（原名：中国医学の起源）[M]. 台北：东大图书股份有限公司，2003：8-9.

^[2] [汉]王充. 论衡[M]. 上海：上海人民出版社，1974：373.

^[3] 汪桂海. 符水疗疾——汉代医疗信仰的一个侧面[J]. 简帛研究，2017（02）：180-190.

^[4] 周琦，李志芳. 荆州胡家草场西汉墓医方木牍“已痢方”初探[J]. 简帛研究，2020（02）：150-161.

^[5] 赵光怀. 汉代民间巫术与知识信仰[J]. 民俗研究，2011（04）：79-88.

^[6] 杨勇. 从出土文献再论战国秦汉时期的巫、医关系[J]. 简帛研究，2019（02）：188-201.

^[7] 张显成，庄利果. 论简帛的民俗史研究价值——兼论民俗史研究的文献材料问题[C]//古籍整理研究与中国古典文献学学科建设国际学术研讨会. 山东大学文史哲研究院，2009：191-209.

这与早期医学书籍巫医不分的情况有关。而从楚简到汉简，医巫合流逐渐实现了医巫之间的分离^[1]。《内经》中的巫术、占卜治疗，可视为对殷商甲骨医学的一种承袭，巫医共用也成为了经脉理论形成过程中的一个影响因素。

3.1.4 早期针灸实践经验的积累

针灸学术是先民在医疗实践中不断产生的懵懂认识基础上发展起来的，承淡安先生认为针刺治病出现的时间“远在 5000 年以前”，先民用锋利的石块切痈排脓、捶打筋骨，从而缓解病痛，经过“无数人民治疗经验之汇集”，才形成了针灸治疗技术^[2]。李学勤先生指出，对历史的研究，要突出重视“开首部分”^[3]，秦代以前的历史，中国学术界通称为“先秦史”，即“古史”或“上古史”，以区别于“中古史”，大概就是先秦两汉的范围内。新石器时代，已经有专门用于针刺的石针、骨针、竹针等。针灸医疗活动，最早可见于各处遗址发现的医疗用具^[4]，如藁城台西村商墓遗址中，曾出土砭石 3 件^[5]。湖南石门皂市商代遗址中^[6]，也曾出土一种长约 13cm，外表光滑的石棒，可用于叩击体表^[7]。

图 25、26 是 1963 年内蒙古多伦多旗头道洼新石器时代遗址出土的砭石，长 4.5cm，其一端扁平并开刃，可以用来治疗痈肿，另一端则呈锥状用作针刺，说明针砭疗法至迟在新石器时代中晚期就已经出现^[8]。



图 25 新石器时代砭石

[1] 李均明,刘国忠,刘光胜,等.当代中国简帛学研究 1949-2019[M].北京:中国社会科学出版社,2020:118.

[2] 承淡安.中国针灸学[M].上海:上海科学技术出版社,2016:3.

[3] 李学勤.出土简帛与古史再建[M].北京:经济科学出版社,2017:205.

[4] 宋镇豪.夏商社会生活史[M].北京:中国社会科学出版社,1994.755

[5] 马继兴.台西村商墓中出土的医疗器具砭镰[J].文物,1979(6):3.

[6] 周世荣.湖南石门县皂市发现商殷遗址[J].考古,1962(3):4.

[7] 中国社会科学院考古研究所.殷墟发掘报告 1958-1961[M].北京:文物出版社,1987:285.

[8] 周一谋.略论针灸的起源[J].针灸临床杂志,2001(01):2-4.

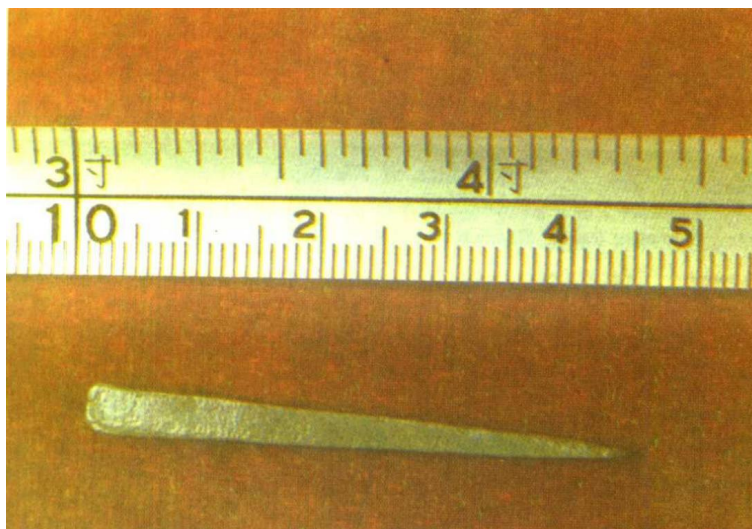


图 26 新石器时代砭石

图 27 是内蒙古达拉特旗树林召公社于 1978 年出土的战国时期的青铜砭针，此针一端为针尖，腰呈三棱形；一端为半圆状刃^[1]。其形状与头道洼砭石非常相似。图 28 是河北省满城县西汉刘胜墓出土的 4 枚金针。



图 27 战国青铜砭针



图 28 西汉金针

^[1] 徐文斌,李素云,徐青燕,等. 浅说针灸器具的发展演变[J]. 针刺研究,2010,35(06):474-477.

上世纪以来,甲骨学、考古学等相关学科的不断发展,使夏商周时代的中医史研究有据可考,尤其是甲骨文及卜辞中所反映的商人对阴阳五行、脏腑解剖、疾病种类的初步认识,是中医学由实践经验上升为理论体系的关键因素^[1]。甲骨是指中国古代早期(出现于新时期时代晚期,盛于商代)占卜时用的龟甲和兽骨(多用牛的肩胛骨^[2]),有字甲骨反映着殷商时期社会文化。甲骨文中有许多内容涉及到了医学,如明确了“疾”是小病,而“病”则是“疾”的加重,还记载了各种疾病名称。先秦时期,“毆”“醫”“鑿”三字相通,其中,非药物治疗称“毆”,以酒与汤液治疗称“醫”,以巫术治疗称“鑿”。

甲骨文的“疾”有两种写法,比较早期的“疾(𠄎)(𠄎)(𠄎)”,作一人躺在床上,又身上淌汗或流血之形。后期的“疾(𠄎)(𠄎)”,增一形作人身上中矢之状^[3]。实际上,甲骨医学只是殷商时代的卜辞,无法说明该时期医疗实际情况,殷商时期的“医学知识”,偏向于是对疾病的一种“识别”^[4]。青铜器文化盛于殷商时期,随着金属冶炼技术的提升,以青铜制作的医疗工具逐渐用于临床,从砭石、骨针到金属针,使针灸学术的演进发生了质的变化^[5]。甲骨文中,已经有形似以手执针(利器)以刺腹部的字形^[6]。

殷商时期是否有针刺、艾灸的记载(注:此处用“记载”二字,意为仅讨论文字记载,而并非讨论针刺、艾灸的最早起源,针刺、艾灸作为医疗技术的起源远早于殷商时期,但最早确切有文字的记载,学术界目前尚未有定论),胡厚宣先生在《殷人疾病考》一文中,认为殷人的治病方法主要包括祈祷和祭祀,40年后又在《论殷人治疗疾病之方法》^[7]一文中,指出殷人已经使用针刺、艾灸和按摩的方法来治疗疾病。但李宗焜先生则认为^[8],卜辞中并未出现这三种治疗方法,并且认为胡厚宣先生仅仅从“字形”角度出发,过度解读了字义。张杰先生认为^[9],祭祀在商代治疗方法处于首要位置,此外分别还有针刺、艾灸、按摩、药物。

[1] 张炜. 商代医学文化史略[M]. 上海:上海科学技术出版社,2005:2.

[2] 李学勤. 西周甲骨的几点研究[J]. 文物,1981(09):7-12.

[3] 许进雄. 中国古代社会:文字与人类学的透视(修订本)[M]. 北京:中国人民大学出版社,2008:499.

[4] 胡厚宣. 殷人疾病考·甲骨学商史论丛初集[M]. 石家庄:河北教育出版社,2002:1-13.

[5] 李良松,刘学春. 甲骨文化与中医学[M]. 北京:中国中医药出版社,2017:61.

[6] 温少峰,袁庭栋. 殷墟卜辞研究——科学技术篇[M]. 成都:四川省社会科学院出版社,1983:333.

[7] 胡厚宣. 论殷人治疗疾病之方法[J]. 中原文物,1984(4):4.

[8] 李宗焜(Zong-Kun Li). 从甲骨文看商代的疾病与医疗[J]. 中央研究院历史语言研究所集刊,2001:339-391.

[9] 张杰. 试论殷人对疾病及其治疗的认识[D]. 郑州大学,2002.

3.2 经脉命名演变

《足臂》十一条脉均采用“足/臂+阴/阳+脉”的完整命名方式,《阴阳》的命名方式较为特殊,下肢经脉采用“阴/阳+脉”的命名形式,上肢阳脉采用“身体部位+脉”的方式命名,而上肢阴脉采用“臂+鉅(泰)/少阴+脉”的命名形式,体现秦汉早期经脉命名的多样化。秦汉后期(尤其是《灵枢·经脉》成篇后),经脉的命名逐渐统一规范,形成“脏/腑+手/足+阴/阳+脉”的命名方式。在这一过程中,“阴阳”这一命名元素,首先用于下肢足三阴三阳,其次普及到上肢手三阴三阳。赵争先生认为《阴阳》中“身体部位+脉”的命名方式要比三阴三阳更早^[1],而《足臂》在经脉的命名上更依靠三阴三阳的命名原则,反映了秦汉时代早期经脉名称从不同的命名方式到统一以三阴三阳命名的一个过渡阶段^[2]。老官山《十二脉》中经脉的命名方式有自身特点,如手三阴脉分别命名为“臂太阴脉”“臂少阴脉”和“心主之脉”。由于手三阴脉的起点皆起于掌中,还没有与手指端建立联系,因此仍旧以“臂+三阴”进行命名,其中“心主之脉”的命名方式,明显受到了张家山《阴阳》(丙本)的影响,于“脉”之前加一“之”字,而老官山《十二脉》中其余十一脉的命名未用“之”字。《十二脉》共计35枚竹简,其编联方式在出土发掘时已经断裂,无法确定次序。诸文献经脉命名情况如下表所示:

表 15 先秦两汉十二经脉命名对比

	《足臂》	《阴阳》 (甲本)	《阴阳》 (乙本)	《阴阳》 (丙本)	《十二脉》	《灵枢·经脉》
足三阳	足泰陽溫	鉅陽脈	鉅陽脈	鉅陽之脈	足大陽脈	膀胱足太陽之脈
	足少陽溫	少陽脈	少陽脈	少陽之脈	足少陽脈	胆足少陽之脈
	足陽明溫	陽明脈	陽明脈	陽明之脈	足陽明脈	胃足陽明之脈
足三阴	足少陰溫	少陰脈	少陰脈	少陰之脈	足少陰脈	腎足少陰之脈
	足泰陰溫	鉅陰脈	巨陰脈	泰陰之脈	足大陰脈	脾足太陰之脈
	足泰陰溫	麤陰脈	厥陰脈	麤陰之脈	蹶陰脈	肝足厥陰之脈
手三阳	臂泰陽溫	肩脈	肩脈	肩脈	手大陽脈	小腸手太陽之脈
	臂少陽溫	耳脈	耳脈	耳脈	手少陽脈	三焦手少陽之脈
	臂陽明溫	齒脈	齒脈	齒脈	手陽明脈	大腸手陽明之脈
手三阴	臂泰陰溫	臂鉅陰脈	臂巨陰脈	臂鉅陰之脈	辟大陰脈	肺手太陰之脈
	臂少陰溫	臂少陰脈	臂少陰脈	臂少陰之脈	辟少陰脈	心手少陰之脈
	/	/	/	/	心主之脈	心主手厥陰心包絡之脈

^[1] 赵争. 古脉书《足臂十一脉灸经》与《阴阳十一脉灸经》相对年代问题考论[J]. 出土文献, 2015(02): 193-215.

^[2] 黄龙祥. 中国针灸学术史大纲[M]. 北京: 华夏出版社, 2001: 291.

对于经脉命名之间的异同点,韩建平先生认为“肩脉”“耳脉”“齿脉”属于经脉演变早期的一种命名方式,虽然随着经脉学说认识的发展,经脉循行路线在延续增长,但以肩、耳、齿部位为名的情况则被延续下来^[1],也许与当时阴阳概念尚未和经脉理论完全相合有关^[2],林磊先生认为《足臂》《阴阳》的经脉名称异常是古人抛弃部位命名时留下的部分结果^[3],李鼎先生则认为《阴阳》的“肩脉”“耳脉”“齿脉”是以主治部位进行命名^[4]。

《足臂》中凡属上肢经脉均冠以“臂”字,但其文末总结性的语句中有“上足脉六,手脉五”一语,有学者认为“已经彰显臂脉、手脉共同使用的端倪,推测《足臂》收录来自不同体例的经脉文献”,这一认识应基于“上足脉六、手脉五”一语与《足臂》正文是源自同一抄写者,或者至少抄写年代相差不大,若这一总结性的语句是来自后人的注释,则无法判断《足臂》正文文本流行的时代,经脉命名是否存在“臂”与“手”同用的情况。在《阴阳》对上肢经脉的命名情况中,除“肩脉”“耳脉”“齿脉”外,均冠以“臂”字,而老官山《十二脉》中,则明显出现了“臂”“手”混用的情况,据此,有学者便推测早期经脉名称发展过程是先称“臂脉”,随后共用“臂”“手”,最后以“手脉”统称^[5]。也有学者认为“臂”脉和“手”脉命名的不同,应该是经脉循行起点的差异而导致的,我们从老官山《十二脉》分析可见,手大(太)阳脉“系小指”,手阳明脉“系次指与大指”之上,臂大(太)阴脉“系手掌中”,臂少阴脉“系掌中”,心主之脉“系掌中”,可见,老官山十二脉命名的特点是:当经脉循行至手时,统一称之为“手XX脉”,再看《足臂》中,臂太阳脉“出小指”、臂少阳脉“出中指”、臂阳明脉“出中指间”,尽管经脉循行于手指,但其命名仍冠以“臂”,说明循行路径的延伸,并不是“臂”与“手”命名差异的主要原因,笔者认为可能与古代医家或医派的用语或行文习惯有关。《灵枢·经脉》成篇以前,“臂”“手”“肩、耳、齿脉”等多种命名方式共存,比较复杂,且医者之间的交流也不太方便,《灵枢·经脉》将复杂的经脉命名情况统一以“脏/腑+手/足+阴/阳+脉”的名称,是符合中医名词术语

[1] 韩健平. 马王堆古脉书研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1999: 32-34.

[2] 中医研究院医史文献研究室. 马王堆帛书四种古医学佚书简介[J]. 文物, 1975(06): 16-19.

[3] 林磊, 图娅. 简帛医书经脉命名剖析[J]. 针灸临床杂志, 2005(09): 1.

[4] 李鼎. 《脉书》臂五脉与手六经及其经穴主治关系的分析[J]. 上海中医药大学上海市中医药研究院学报, 1996(2): 34-37.

[5] 陈晓红. 简帛医书经脉文献比较研究[D]. 广西中医药大学, 2020.

在古代的发展演变规律的。

经脉命名的演变过程中还有一个较为复杂的情况，就是“太”的不同表达，以足太阳脉为例，《足臂》称为“足泰陽温”，《阴阳》（甲本）为“鉅陽脈”，老官山《十二脉》为“足大陽脈”，“鉅”与“大”同义，而“泰、太、大”三字互通，《经脉》篇后统一为“太”，因此可以粗略认为“太阳”的演变过程经历了“泰阳→鉅陽→太阳”。简帛文献中的命名特点，也见于《内经》的其他篇章，实际上是《内经》对早期医学传承的体现^[1]。

3.3 经脉数量演变

严健民先生认为，在《足臂》《阴阳》“十一脉”之前，还流行有“人有四经”的认识，先民对心脏的解剖观察，尤其对心脏底部大血管的认识，导致了我国经脉医学的诞生^[2]。严先生还认为，目前有一种观点“有了人类，便有了医药”是值得商榷的，对医药起源的探讨不能忽略人脑解剖结构和人脑生理功能的渐进性进化史的认识，人类只有进化到新人（晚期智人）时，才有主动积累医事活动中经验的可能^[3]。直至殷商时期，依类象形的甲骨文创立，才有将医疗经验用文字进行承载的现象。殷商之后，经脉理论首先经历了“四经说”^[4]，《晏子春秋》记载春秋时期齐景公用“心之有四支”来比喻自己的五位谋臣可令其“得佚”，文中“佚”有安乐之意，《广雅》：“佚，乐也。”《淮南子·原道训》也提到：“夫心者……所以制使四支，流行血气。”^[5]是指心脏底部发出四条分支，起到了“流行血气”的作用，《素问·阴阳别论》称：“人有四经十二丛。”严先生认为正确理解这句话的意思是：经脉理论提出的十二丛（经），是从心脏底部的四条大经脉派生出来的。但是，由于历史原因的限制，历代学者都没有弄清“人有四经”与“十二丛”的关系^[6]。因此，在帛书《足臂》《阴阳》所载的“十一脉”之前，还有“心有四支”“人有四经”的认识。

经脉数量最基本的一个特点，就是经历了由少到多的过程，这个过程持续了多长时间，目前无从考察，上世纪70年代马王堆帛书的出土，为学术界打开了《内

[1] 李海峰,张如青,张显成.出土文献与《内经》的经脉异名分析[J].上海针灸杂志,2015,34(11):1126-1128.

[2] 严健民.经脉学说起源·演绎三千五百年探讨[M].北京:中医古籍出版社,2010:18-30.

[3] 严健民.中国医学起源新论[M].北京:北京科技出版社,1999:63-70.

[4] 严健民.远古中国医学史[M].北京:中医古籍出版社,2006:151.

[5] [汉]刘安.淮南子[M].长沙:岳麓书社,2015:8.

[6] 严健民.《素问·阴阳别论》“人有四经”考释[J].湖南中医学院学报,1997(03):7-8.

经》之前针灸理论特点的一个“观察口”，自此，对经脉数量的演变情况的讨论越来越多，尤其是集中在“十一脉”与“十二脉”之间的转变方面。马王堆汉墓帛书是“十一脉”学说的代表，其抄写年代大致在公元前 221 至公元前 168 之间^[1]，包括后来出土的张家山《脉书》，都是早于《内经》的文献，所记载的内容属于春秋晚期或秦汉早期医家对人体生理病理的认识^[2]。“十一脉”到“十二脉”之间的转变，是经脉数量演变中较为重要的一个问题，秦汉早期流行“天六地五”的数术观^[3]，如《国语》云：“天六地五，数之常也。”《灵枢·经别》云：“余闻人之合于天道也，内有五脏……外有六腑……”人体与天道相合，那么在确定经脉数量以及阴阳归属时，难免会受到当时数术观的影响，廖育群先生认为，“十一脉”就是在“天六地五”数术观念影响下制定的，并非是不完善的情况^[4]。在秦汉中后期，天人相应的现象越来越受到医家重视，《灵枢·经水》载：“经脉十二者，外合于十二经水。”十二脉、十二经水、三百六十五络等数字与月数、经水数、日数相应，汉武帝太初改历以后，“十二”这一数字被用于记时^[5]，并逐渐影响到医学领域。但天人相应并不是影响经脉数量从十一脉转变为十二脉的唯一原因，表面解剖学与气血管卫理论的建立也是重要的影响因素^[6]，李永明先生从现代进化解剖学的视角，为我们揭示了上臂遗留正中动脉与秦汉早期医家发现手厥阴脉的情况密切相关^[7]。《足臂》首述六足脉，继述五臂脉，在六足脉后，又记录了足三阴三阳的病死证，证明早期经脉医学对足六经的认识起源较早，也较上肢经脉更为详细。从出土经脉文献内容可知，早期足六脉学说差异较小，而经脉数量、命名、循行等差异，主要体现在上肢经脉。有学者便认为早期可能存在“足六脉”学说^[8]。但笔者认为，足脉与手脉只有认识程度的差异，并无先后之分，仅仅根据目前出土文献，还难以得出经脉数量从“足六脉→十一脉→十二脉”演变的一般线性发展结论，黄龙祥先生也认为，“十一脉”并不代表着《足臂》《阴阳》所处时代只发现

[1] 马继兴. 马王堆出土的古医书[J]. 中华医史杂志, 1980, 10(1): 41-46.

[2] 马继兴. 马王堆古医书考释[M]. 长沙: 湖南科学技术出版社, 1992: 21.

[3] 韩健平. 经脉学说的早期历史: 气、阴阳与数字[J]. 自然科学史研究, 2004(04): 326-333.

[4] 廖育群. 歧黄医道[M]. 沈阳: 辽宁教育出版社, 1992: 187.

[5] 王洪弘. 《黄帝内经》术数思想研究[D]. 北京中医药大学, 2017.

[6] 李素云, 赵京生. 从经脉的循行变化探讨其概念内涵的演变——由“十一脉”至“十二经脉”循行变化引发的思考[J]. 针刺研究, 2009, 34(02): 132-135.

[7] 李永明. 汉代十一脉到十二经脉转变的解剖依据[J]. 中国针灸, 2021, 41(10): 1153-1158.

[8] 袁玮. “十一脉”说之前可能存在足“六脉”说[J]. 上海针灸杂志, 1988, (1): 37-38.

了十一条经脉^[1]，出土经脉文献的丰富性提示我们，不能以一种线性发展的角度去审察早期经脉的演变，当前出土针灸文献时间跨度并不大，以从“低级”到“高级”的顺序，单纯地按照时间早晚判定其成熟度，是不可取的，应该在充分掌握材料内涵的基础之上，从横向、纵向两个方面进行把握，才能挖掘出早期经脉理论中更大的价值。

目前出土经脉文献、文物中经脉数量的情况主要为：

《足臂》：十一脉

《阴阳》：十一脉

双包山木人：十脉（缺足三阴，有督脉）

老官山漆人红色脉行线：十一脉

老官山漆人白色脉行线：十二脉（另有疑似任脉线）

老官山《十二脉》：十二脉

双包山木人体表刻画有手三阴脉、手三阳脉、足三阳脉以及督脉，共 19 条经脉线，无腧穴记录^[2]。双包山木人经脉数目最有特点者，在于缺少足三阴脉，马继兴先生认为是空间不够导致^[3]，何志国先生认为可能归因于古人对死亡的忌讳（足三阴脉多死证）^[4]，但有学者对比老官山漆人后，对何氏的认识提出了质疑，认为正是因为足三阴脉的重要性，才使之成为了养生保命“首要关注的对象”，并且老官山出土文物也不支持此种认识^[5]。双包山木人“十脉”特色非常鲜明，如经脉之间汇合交叉之处较多、经脉与头面部的联系较为紧密、对督脉的记载等，有其独特的理论体系，早在《庄子·养生主》^[6]中提到“缘督以为经”便可以达到“保身、全生、养亲、尽年”的目的，这里“督”有学者认为即指督脉，也有学者认为是“督统纲要”之意^[7]。杜正胜先生提到^[8]：“一般而论，医者重视十二经脉，谓正经，奇经之八脉则为道徒仙家所讲习。”而《内经》中督脉学说记载丰富，作为身

[1] 黄龙祥. 中国针灸学术史大纲[M]. 北京: 华夏出版社, 2001: 495-540.

[2] 马继兴. 双包山汉墓出土的针灸经脉漆木人形[J]. 文物, 1996(04): 55-65+98.

[3] 马继兴. 双包山西汉墓出土经脉漆木人型的研究, 马继兴医学文集[M]. 北京: 中医古籍出版社, 2009: 281.

[4] 何志国. 西汉人体经脉漆雕再考[J]. 四川文物, 2000(06): 6-11.

[5] 赵争. 从出土文献看早期经脉学说[J]. 医疗社会史研究, 2016, 1(02): 51-74+328-329.

[6] [战国]庄周. 庄子[M]. 北京: 商务印书馆, 2018: 48.

[7] 汪登伟. 战国时期道家与方仙家的交集——以《庄子》为例[J]. 中国道教, 2020(03): 51-57.

[8] 杜正胜. 从眉寿到长生——中国古代生命观念的转变[J]. 中研院历史语言研究所集刊. 1995, 66(2): 457-459.

体中轴线的督脉在秦汉医家思想中占有重要地位^[1]。

老官山漆人记载有红线与白线两套经脉体系，所传达的信息非常丰富，其中红线代表“十一脉”，白线代表“十二脉”，且白线系统还有一条疑似任脉线以及三条环绕身体的横线^[2]，漆人红白两套经脉系统在循行方面也存在着较大差异。老官山医简《十二脉》（最初称为《经脉书》，整理小组后来归入《脉书·下经》）中记载有十二条经脉，这是“十二脉”体系第一次出现在出土文献中，赵争先生认为这是早期经脉学说多元图景的一个体现^[3]，并且提示我们秦汉时期经脉数量的不同也许有地域性的因素在内^[4]。黄龙祥先生认为起源于腕踝处动脉搏动的“脉动处”，是古人发现经脉最初的契机，手太阴脉在腕关节屈面位于太渊穴下桡动脉的搏动非常明显，出土文献表示太渊穴搏动处与心的关系较为密切，如《足臂》中“臂太阴脉”的循行路径“循筋上廉……之心”，主治病症有“心痛，心烦而噫”，《阴阳》“臂钜阴脉”的循行“入心中”，主治病症有“心滂滂如痛”，可见秦汉早期医家对于手太阴脉与心脏之间关系的认识较早，故经脉体系先出现足脉，后出现手脉的认识，还有待商榷。

从经脉数目的演变中我们可以看出，古人对经脉学说的创建，基于多种因素，包括解剖学诊察、人文哲学渗透以及医家主观推测等等，因此，在对经脉本质的研究中，不能单纯寻求经脉的解剖物质基础，《灵枢·经脉》对简帛医书中的经脉理论虽然进行了“改造”，但是具有实用性的经脉循行、主治病症等指导临床诊断与治疗的内容，则传承了下来。

经脉数量演变除十一脉与十二脉之间的转变外，奇经八脉的出现也值得讨论，出土文献中未见奇经八脉这一概念，后在《难经》中首先提出，但冲、任、督、带、维、跷诸脉相关内容已详略不等地见于《内经》，与“八风”“八纪”“八正”“八极”等概念的出现有关^[5]，奇经八脉主要是为了弥补十二经脉理论的缺陷与不足，《内经》中虽然已经出现了奇经八脉的相关论述，但是并没有刻意地去总结十二脉之外的这些经脉理论，《难经》属于秦汉晚期的作品，可能《难经》的作者已

[1] 李贞德. 性别、身体与医疗[M]. 北京: 中华书局, 2012: 20-21.

[2] 梁繁荣, 曾芳, 周兴兰, 等. 成都老官山出土经穴髹漆人像初探[J]. 中国针灸, 2015, (01): 91-93.

[3] 赵争. 从出土文献看早期经脉学说[J]. 医疗社会史研究, 2016, 1 (02): 51-74+328-329.

[4] 李建民. 发现古脉——中国古典医学与数术身体观: 周秦汉脉学之源流[M]. 北京: 社科文献出版社, 2007: 78-85.

[5] 程雅君, 赵怡然. 中医经络学说的哲学渊源[J]. 哲学研究, 2017 (09): 65-74.

经认识到十二脉理论的不足，于是对十二经脉以外的“奇经八脉”进行总结，用于进一步解释人体的生理病理现象及过程^[1]。

3.4 经脉循行方向演变

老官山医简《十二脉》是以张家山《脉书》所载的《阴阳》（丙本）以及《足臂》为底本，合抄改编而成，但是《十二脉》抄写者习惯将经脉的起止点用“系”字表示，说明抄写者（或墓主人）有意用“系”对经脉的起止点做统一规范^[2]。经脉起止点的演变，一定程度上促进了经脉流注理论的发展，随着秦汉医家对气血管卫理论的认识逐步加深，逐步认识到气血管卫在体内循环流通的特点，《灵枢·营卫生会》中“阴阳相贯，如环无端”可以理解为阴经与阳经在四肢末端相交接，也就是《灵枢·动输》中所提到的：“营卫之行也，上下相贯，如环之无端。”在出土文献中，《足臂》均是向心性流注，《阴阳》肩脉、足太阴脉属于远心性流注，其余经脉流注方向为向心性，老官山医简《十二脉》均呈向心性流注；《灵枢·经筋》《灵枢·脉度》《灵枢·本输》中的经脉也均为向心性流注；双包山木人根据马继兴先生的考证^[3]，全部经脉都是远心性循行；而《灵枢·经脉》通过延伸经脉路径、增加经脉分支等方法，形成的首尾相连、经脉-脏腑相关的十二脉环形流注体系，秦汉时期医家还为这一新的经脉气血循环模式做出了总结性的描述，即《灵枢·逆顺肥瘦》：“手之三阴，从脏走手；手之三阳，从手走头。足之三阳，从足走头；足之三阴，从足走腹。”^[4]而根据人体呼吸频率制定的气血流注时间周期，如“营周不休，五十而复大会”（《灵枢·营卫生会》），则明显带有主观臆测的成分在内。此外，五输穴、标本根结理论均有向心性流注的特点^[5]，尤其是标本根结揭示了经脉的纵向（四肢与头颈躯干）远道主治的关系^[6]，经脉循行方向的不同，导致经脉起止点也不同。

3.5 经脉分支的产生、演变及其意义

经脉分支的出现，最早可追溯到马王堆汉墓帛书《足臂》，计有3条分支，而

[1] 张建斌. 经典经络原理探析[C]//中国针灸学会经络分会第十二届全国针灸经络学术研讨会论文集, 2012: 6-13.

[2] 黄龙祥. 老官山出土汉简脉书简解读[J]. 中国针灸, 2018, 38(01): 97-108.

[3] 马继兴. 针灸学通史[M]. 长沙: 湖南科学技术出版社, 2011: 120.

[4] [春秋]佚名. 灵枢经[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2012: 75.

[5] 臧颖颖, 王朝阳, 刘清国. 标本根结理论与十二经脉流注关系之探讨[J]. 中华中医药杂志, 2021, 36(06): 3118-3120.

[6] 赵京生. 足经腧穴远道主治规律的理论形式——根结理论解读[J]. 中国针灸, 2008, 28(5): 387-391.

经脉均以主干循行至终点,《阴阳》中没有直接描述分支,到《灵枢·经脉》中,十二经脉分支大量出现,各脉分别有1~3条不等的分支,总计有17条支脉,与《足臂》不同的是经脉多以分支循行至终点,十二经脉之间多通过支脉相互衔接,老官山出土的文献、文物,尤其漆人体表记载有大量的经脉分支,填补了早期经脉分支演化中的空白。对于经脉分支的文字记载,早期文献用“枝”“支”“别”引出,如《足臂》“枝之+部位”,老官山汉简“其支者”,《灵枢·经脉》“其支者”“其别者”。出土简帛文献经脉循行多呈向心性流注,而《灵枢·经脉》篇经脉却呈环形流注,这一转变过程中,经脉分支发挥了重要的作用,笔者综合诸文献、文物资料,对早期经脉分支的产生、演变及其意义试探讨如下:

3.5.1 经脉分支产生的原因

3.5.1.1 古人观察、解剖实体经验的积累

《灵枢·经水》记载秦汉医家对活体可“度量切循”,对尸体则可“解剖而视之”,《汉书·王莽传》记载一例由政府下令的人体解剖过程,其中提到了“以竹筴导其脉,知所终始”,这里解剖实体所见且可以用竹条穿导的“脉”应是血管。由此,古人也认识到了经脉的“虚空”作用(与之相对的是经筋的“中无有空”),以“虚”为用的思想逐渐为医家所重视。古人对体表动脉搏动、静脉走向的观察,是形成经脉及其分支形态认识的重要基础。如《灵枢·卫气》中记载“气在腹者,止之背腧与冲脉于脐左右之动脉者。”黄龙祥先生认为,冲脉是古人触诊腹主动脉总结的认识,腹主动脉粗且深,于脐左右深按皆有触感,因此古人便认为冲脉在腹部有两道分支^[1]。早期针灸诊疗部位,多在于腕踝动脉搏动处^[2],黄龙祥先生称之为“脉动处”,通过“脉动处”治疗远端病症的经验,古人逐渐建立了人体远隔部位相关联的认识,早期经脉的形态便是从腕踝部“脉动处”到远端治疗部位之间一条几乎无分支的直线。但《内经》时代,交通不发达,医者之间交流并不频繁,医学很容易形成不同的流派,每个流派临床诊疗经验的积累均不同,经脉分支的出现,兼容了不同时期不同流派的医家诊疗经验。

3.5.1.2 “象”思维影响下比附自然河流

古代医家重视天人合一的思想,人与天地自然相应,与生活环境和谐统一,

^[1] 黄龙祥. 黄龙祥看针灸[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2008: 37-39.

^[2] 李海峰. 简帛踝部诊脉法发微[J]. 中国中医基础医学杂志, 2022, 28(01): 33-35+43.

是早期医家基本思维方式,《灵枢·本脏》称经脉的特点是“行血气而营阴阳”,经脉“中空”且“行血气”这一特点,与自然界河流沟渠的功能相似,《灵枢·经水》认为十二经脉内属于五脏六腑,在外则与“十二经水”相合,《灵枢·邪客》提到:“地有十二经水,人有十二经脉。”我国古代是农耕社会,农业活动对人们思维意识形态影响较深,《内经》中关于经脉大小浅深的认识,多来源于对自然界水流的观察,人们将经脉运行血气并营养全身的功能,比附于河流对于耕地的灌溉,古人将水流分为大的“经水”“落渠”,水流的分支称之为“枝水”“枝渠”等^[1],对水流分支的认识是形成经脉分支的影响因素之一,如《太素》认为十二经脉以外的“大络小络”,就如同十二经水以外的“小山小水”。

在《足臂》《阴阳》中,“脉”写作古体字,如《阴阳》乙本“脉”写作“𩑦”,而“𩑦”右边的“川”在甲骨文中写作“𣶒”^[2],似水流动的样子,“脉”古体字与古人对水流的观察认识相关^[3]。《难经·二十七难》将络脉对气血满溢的调节,比喻为水利工程中的所设置的沟渠,即“天雨降下,沟渠溢满”,河流有支流,正如经脉有支脉。《论衡·书虚》:“夫地之有百川也,犹人之有血脉也。”^[4]山川河流有支流,人体经脉有分支。将经脉比附自然河流的认识,是古人的一般观念。

3.5.1.3 临床诊疗经验的积累

“中气穴则针游于巷”(《灵枢·邪气藏府病形》)“吹灼九窍而定经络”(《说苑·辨物》)均是指循经感传现像,当早期经脉“脉动处”所能治疗的远端部位逐渐增多时,只能采取分支的方式进行串联。经脉病候对于经脉循行的影响,远大于解剖认识的积累。最初的经脉病候直接来源于诊脉病候,而经脉循行路径(包括支脉的形成)与经脉病候的逐渐积累相关,尤其“是动病”与经脉循行的关系更为密切。黄龙祥先生认为,如果新增的病候与经脉处于同一条直线上,那么就表现为经脉循行路径的增长,如果不在一条直线上,那么就表现为经脉分支的出现。如《足臂》中足太阳脉病候有“颜寒,产聋”,因此经脉循行中便出现支脉“枝颜(颜)下,之耳”,秦汉医家可以随时为新发现的临床诊疗经验增加支脉^[5]。

^[1] 黄龙祥. 经脉理论还原与重构大纲[M]. 北京:人民卫生出版社,2016:15.

^[2] 中国科学院考古研究所. 甲骨文编[M]. 北京:中华书局,1965:447.

^[3] 李丽. 战国秦汉简帛文献医学词汇研究[D]. 北京中医药大学,2019:34.

^[4] [汉]王充. 论衡[M]. 上海:上海人民出版社,1974:55.

^[5] 黄龙祥. 经脉理论还原与重构大纲[M]. 北京:人民卫生出版社,2016:28.

3.5.2 出土文献、文物中经脉分支情况

从总体上看，出土文献《足臂》《阴阳》以及老官山《十二脉》中经脉分支数量较少，且各经脉之间并未直接衔接，经脉分支的主要作用是将疾病部位与经脉主干联系在一起，形成一个整体。而出土文物如老官山漆人、双包山木人经脉分支则相对较多。出土简帛描述经脉分支时一般用“枝”字引出，再用“直者”继续论述主干循行。“枝”字在《足臂》出现4处，“支”在老官山《十二脉》见于1处。《说文解字·木部》曰：“枝，木别生条也。”“支”与“枝”属于同音通假，可以引申为分枝、支脉的意思^[1]。

《足臂》有3条支脉，循行所过部位与病症密切相关：足太阳脉“枝之下腓”“上于脰；枝颧（颜）下，之耳；其直者贯目内眦，之鼻”，足少阳脉“枝于骨闲（间）”“枝之肩薄（膊）”，其中“枝于骨闲（间）”并不属于分支，是指足少阳脉在两骨之间走行较为曲折。因此严格来讲，足少阳脉应该有一条支脉“枝之肩薄（膊）”。《阴阳》中虽然没有“枝/支+于/之+部位”这样描述经脉分支的论述形式，但有学者认为手阳明脉循行起点“起于次指与大指上”，提示有支脉至大指，笔者认为这一看法有待商榷，如果明确是一条分支，早期医家会以“枝/支+于/之+部位”这一标准格式进行书写，其次，出土文献、文物中，支脉一般都是从主干发出，这里“起于次指与大指上”，可知无论是次指还是大指，均属于起点，老官山漆人手阳明脉起点为“大指次指之端”，整理人员对其描述少了一个“与”字，说明漆人起点在“大指的次指”，即示指端，详细情况还待清晰图版照片的公布。

《足臂》足太阳脉分支“枝之下腓”，《阴阳》中描述为“出臑中（髀枢）”，因此，《阴阳》虽然没有明确描述经脉分支，但是其行文过程中，已经将《足臂》的经脉分支整合在内，再如《足臂》足太阳脉在头面部的分支为“上于脰；枝颧下，之耳；其直者贯目内眦，之鼻”，这一经脉主干与分支的描述方式，在《阴阳》中则被简化为“上头角，下颜，夹颞，系目内廉”，完全去除了支脉的痕迹，似乎《阴阳》有刻意将《足臂》支脉融入循行主干的倾向，因此《阴阳》经脉循行路径的特点就在于不分“直”与“支”，如足太阳脉只是粗略地描述经脉的走向。

老官山《十二脉》足太阳脉有1条支脉“其支者入州”，与《足臂》“枝之下腓”

^[1] 周一谋，萧佐桃. 马王堆医书考注[M]. 天津: 天津科学技术出版社, 1988: 3.

的“肥”同义，说明《足臂》是老官山《十二脉》的底本之一^[1]。

笔者认为，老官山《十二脉》中“心主之脉”（手厥阴脉）还应有1条支脉。“心主之脉”的循行路径为“𦣻（繫）掌中，上出辟（臂）中，出紂（肘）中，走亦（腋）下，□□，入匈（胸），循匈（胸）裏，上加大陰，上循□嚨，下𦣻（繫）心”，這裏“上循□嚨，下𦣻（繫）心”明显是两个不同方向，老官山《十二脉》中“心主之脉”的循行与《灵枢·经脉》篇的“心手少阴之脉”循行更加接近，后者有支脉“从心系上挟咽”，因此，笔者认为老官山《十二脉》中“心主之脉”的循行“上循□嚨”应该视为支脉。黄龙祥先生已经提到老官山汉墓文献抄写者有粗心大意之弊，此处本属于支脉却未写作支脉也属于疏忽之一。

《十二脉》还单独记录3条支脉：“足大（太）阳脉、足阳明脉、足大（太）阴脉”。此外《间别之脉》（又称《别脉》，后归入《脉书·下经》，共九枚简）中的内容，综合已经发表的文献，目前可以看到八枚简的内容^[2]，有学者认为《别脉》内容应属于经脉支脉。对此，笔者认为不能仅仅根据《别脉》中“别”字，就认为是与正经相对立的支脉，如足少阴脉在老官山《十二脉》中的循行为“足少陰脈，𦣻（繫）□□，出內果后脛□循□□□內廉，穿陰股而上，夾脊內廉，【系于腎】，上夾舌本”，在《别脉》中，“间别少阴脉”的循行过程则是“出口，出少腹，出肥，胃，肝，亢狼（頄頰），奏舌本”，可见老官山《十二脉》足少阴脉循行至“夹脊内廉，系于肾”后直接“上夹舌本”，而“间别少阴脉”循行过程“少腹→肥→胃→肝→頄頰→舌本”正好补全了《十二脉》中足少阴的循行所缺，并非别行的支脉。再如老官山《十二脉》手阳明脉的循行为“𦣻（繫）次指与大指直上，出辟（臂）上廉……”，而《别脉》中“间别齿脉”虽图版模糊不能识别循行，但文末“久（灸）齿脉乘手北（背）者”一语中，“乘手背”补全了老官山《十二脉》手阳明脉的循行，若将其视为支脉则不合适。因此，将老官山《别脉》全部看作是经脉分支的认识还有待商榷。笔者认为比较准确的认识是：一部分“间别之脉”可视作支脉，一部分为补全正经循行路径，一部分则与正经循行路径相同，如老官山《十二脉》中手太阴脉循行“……至亦（腋），入心”，而“间别臂阴脉”的循行路径是“出腠（腋），奏心”，两者循行路径完全一致；再如《别脉》中记载

^[1] 黄龙祥. 老官山出土汉简脉书简解读[J]. 中国针灸, 2018, 38(01): 97-108.

^[2] 广瀨薰雄. 天回老官山汉简《别脉》初探[J]. 出土文献与古文字研究, 2020(00): 316-328.

“足大（太）阳脉，出肩胛下廉，绕胸属乳下。其病：肩胛下廉痛，胸衡肩”，沟通了足太阳脉与足阳明脉之间的关系。因此笔者认为《别脉》可能属于另一种经脉体系，或可将“别”理解为“别有版本之脉”。此外，将“间别XX脉”和《内经》中十五络脉视为相对应也应商榷，其循行路线、病症、与灸治部位完全不同。老官山医简将“十二脉”与“别脉”相区别论述的这种形式，对于《灵枢·经脉》篇的行文体例起到了一定的影响^[1]。

综合整理人员公开发表的资料，老官山漆人体表刻画的循行线提示有13条支脉（其中足太阴脉有一条支脉待考）：

漆人右侧手太阴脉有1条分支，从鱼际发出，到达次指内廉，与《灵枢·经脉》篇手太阴脉的支脉“其支者，从腕后直出次指内廉，出其端”相同，说明在《内经》之前，老官山漆人已经具有沟通表里两经的支脉出现^[2]。

漆人手少阳脉有1条：“耳前→颊→下颌”^[3]。

漆人手太阳脉有2条：“腋→上行绕肩胛→颈→耳后→绕耳1线→耳上→目眦”“颈→喉”^[4]，在老官山《十二脉》中手少阳脉主治有“颈痈（肿），痛喉（喉）”的记载，但其经脉主干循行的文字描述为“循颈出耳后，属目外眦（眦）”，因此，结合老官山漆人白线手太阳脉第二条分支“颈→喉”，可知早期医家临床过程中逐渐发现手太阳脉可以治疗“痛喉（喉）”这一症状，便增加一条支脉用作解释。出土文献中，手太阳脉的支脉仅见于老官山漆人，且均分布于头面。

漆人足太阳脉有4条：分支1（左右均从第一侧线分出）：腠中→大腿后内侧→肛；分支2、3（左侧从第二侧线，右侧从第一侧线）：肩胛下→横行至胸前壁→左右相关；分支4：第一侧线在足外踝下发出一条分支，止于足少阳脉，而且左侧的分支在中点处又发出了分支，向后止于第二侧线^[5]。

老官山《十二脉》中，足太阳脉从腠窝部上行至肛“直者贯尻夹脊”对应漆

^[1] 黄龙祥. 老官山出土医简脉书简解读[J]. 中国针灸, 2018, 38(01): 108.

^[2] 程施瑞, 周兴兰, 邱科, 等. 成都老官山汉墓经穴髹漆人像十二经脉循行考证（英文）[J]. World Journal of Acupuncture-Moxibustion, 2022, 32(01): 40-48.

^[3] 周兴兰, 张乙小, 曾芳. 成都老官山汉墓出土髹漆经穴人像手少阳脉循行特点研究[J]. 中医杂志, 2020, 61(11): 942-945.

^[4] 张迪, 周兴兰, 曾芳, 等. 成都老官山汉墓出土髹漆经穴人像手太阳小肠经循行研究[J]. 中医杂志, 2019, 60(08): 636-639.

^[5] 印帅, 曾芳, 周兴兰, 等. 成都老官山汉墓髹漆人像足太阳经脉循行浅析[J]. 辽宁中医杂志, 2017, 44(06): 1281-1283.

人足太阳脉的支脉1。老官山《别脉》中“足大（太）阳脉，出肩胛下廉，绕胸属乳下。其病：肩胛下廉痛，胸衡肩”，对应分支2、3。提示足太阳脉分支连接“肩胛下廉”与“乳下”两个部位，其主病也是起点“肩胛下廉痛”与止点“胸衡肩”，“乳下”属于足阳明脉所过，因此老官山漆人足太阳脉与足阳明脉通过“间别之脉”进行相联系，这一现象为“偶刺”提供了理论支撑。

足厥阴脉有1条：左侧“胫前→交足阳明”；足少阴脉有1条支脉；足太阴脉有1条分支待考证：左侧（正面）大腿根部发出一条分支，交于足阳明脉^[1]。

足少阳脉有2条：一条从髀枢向后分支至足太阳脉，一条向腹部分支至足阳明脉^[2]，体现“髀枢”这一部位与足三阳脉均有联系^[3]。

老官山漆人以红、白二线标记经脉，两者之间虽有重合，但整体上差异较大，代表两套经脉体系，红线较早，代表早期“十一脉”体系，白线较晚，接近《灵枢》中“十二脉”以及三焦理论^[3]。其中白线体系中部分经脉有分支存在，此外经脉之间还有交汇现象^[4]。

双包山木人体表刻画的循行线提示有5条支脉^[5]：手太阴脉2条、手阳明脉1条、手少阳脉1条、足太阳脉1条，一般用来和其他经脉进行交汇。此外，双包山木人本脉也与其他经脉产生交叉，如手厥阴脉从起点（头顶部正中中线略前方）至终点（中指内侧端）的循行过程中，在头部与足太阳脉、手少阳脉、手少阳脉支脉交叉，在耳下部与手太阴脉交叉，体现经脉之间联系紧密性。双包山木人5条支脉中，只有手太阴脉的第二条支脉与《灵枢·经脉》相同，其余4条支脉则不见于《灵枢·经脉》，木人经脉之间共有6处交叉^[6]，其中部分通过支脉进行联系，如手太阴脉在拇指发出支脉流入手阳明脉。说明双包山木人体表循行的支脉，较《足臂》《阴阳》有了进一步的发展，出现联系表里两脉的作用^[7]，由支脉联系表里经脉的现象仅散见于手臂经脉，即手厥阴脉与手少阳脉，以及手太阴脉与手阳明脉，说明双包山木人支脉用于联系表里两经这一特征还处于早期阶段。

[1] 邱科. 老官山汉墓经穴髹漆人像六阴经循行特点研究[D]. 成都中医药大学, 2016.

[2] 黄柳杨, 曾芳, 周兴兰, 等. 从西汉出土经穴髹漆人像看足少阳经脉的循行演变[J]. 成都中医药大学学报, 2017, 40(01): 91-94.

[3] 黄龙祥. 老官山出土西汉针灸木人考[J]. 中华医史杂志, 2017, 47(03): 131-144+194.

[4] 梁繁荣, 曾芳, 周兴兰, 等. 成都老官山出土经穴髹漆人像初探[J]. 中国针灸, 2015, 35(1): 92.

[5] 马继兴. 双包山汉墓出土的针灸经脉漆木人形[J]. 文物, 1996(04): 55-65+98.

[6] 马继兴. 出土西汉古医籍研究[M]. 北京: 中医古籍出版社, 2005: 286-288.

[7] 梁繁荣, 谢克庆, 和中浚, 等. 西汉人体漆雕经脉研究[J]. 上海中医药杂志, 1998(05): 36-39.

从《足臂》、老官山漆人、双包山木人，到《灵枢·经脉》，支脉不断增多，且用途从联系病症转变为联系经脉，这一现象无疑为《灵枢·经脉》构成十二脉循环时新增加的 11 条支脉，做出了铺垫。

表 16 出土文献、文物及《灵枢·经脉》篇经脉分支数目表

经脉名称	《足臂》	《阴阳》	《十二脉》	老官山漆人	双包山木人	《灵枢·经脉》
手太阴				1	2	1
手少阴						1
手厥阴			1			1
手阳明					1	1
手太阳				2		1
手少阳				1	1	1
足太阴				1（待考）		1
足少阴				1		1
足厥阴				1		2
足阳明						3
足太阳	2		1	4	1	2
足少阳	1			2		2
总计	3	0	2	13	5	17

3.5.3 《灵枢·经脉》篇经脉分支特点

在《灵枢·经脉》中，经脉分支总数目虽有所增多，但同时亦有消亡，如《足臂》中足少阳脉分支不见于《灵枢·经脉》。

足太阳脉在《足臂》中有“枝之下腓”与“枝颧（颜）下”两条分支，发展至《灵枢·经脉》中，分别是“其支者，从巅至耳上角”“其支者，从髀内左右别下贯胛，挟脊内，过髀枢，循髀外，从后廉下合腠中”。其中，《足臂》头面部分支“枝颧（颜）下”在《经脉》篇变为足太阳脉的主干，即“起于目内眦，上额交巅”，又增加一条支脉“从巅至耳上角”。《足臂》中臀下分支“枝之下腓”在《经脉》篇变为“其支者，从髀内左右别下贯胛，挟脊内，过髀枢，循髀外，从后廉下合腠中”，新增的支脉的循行路径也变长：从“髀（肩甲）内”向下，经过“髀枢（即《足臂》中的“腓”）”，最后汇入“腠中”。

再如足少阳脉，以往认为《足臂》此脉有两条支脉，即“枝於骨閒（間）”“枝之肩薄（薄-髀）”，实际上“枝於骨閒（間）”的“枝”指足少阳脉走行较为弯曲，并不是描述其分支，因此，足少阳脉在《足臂》中只有 1 条分支“枝之肩薄（薄-

膊)”，《灵枢·经脉》中胆足少阳之脉主干的循行与《足臂》一致，但是支脉增加至2条：如“从耳后入耳中，出走耳前，至目锐眦后”“别跗上，入大指之间，循大指歧骨内出其端，还贯爪甲，出三毛”。

足阳明脉在出土文献《足臂》《阴阳》中均未论及支脉，但是在《灵枢·经脉》篇中，胃足阳明之脉的支脉增至3条，“其支者，起于胃口，下循腹里，下至气街中而合”“其支者，下廉三寸而别，以下入中指外间”“其支者，别跗上，入大指间，出其端”。增加的这3条分支，分布范围较广，其作用在于与脏腑建立联系，构成十二脉环形流注体系。

足太阴脉在《足臂》《阴阳》中都没有支脉，但是与脏腑相关，提及“被胃”，而《灵枢·经脉》篇与脏腑相关的主干论述详细，且循行亦较远：“入腹，属脾，络胃，上膈，挟咽，连舌本，散舌下”，此外还新增加一条支脉“其支者，复从胃别上膈，注心中”。

经脉分支的演变中，有主干演变为分支的现象，如老官山汉简《十二脉》中，手阳明脉的循行中“循经”，是经脉主干循行所过，然而在《灵枢·经脉》中则变为“其支者，从缺盆上颈”，演化为手阳明的一条支脉。

经脉分支的增加，是为解释临床病候，如《阴阳》手少阴脉的循行为：“起于臂两骨之间，之下骨上廉，筋之下，出腠内阴。”主病为“是动则病：心痛，噎干，渴欲饮……其所产病：胁痛”，“噎”是指咽喉部，心病出现咽喉部的症状，但是《阴阳》手少阴脉的循行与咽部还没有建立联系。此后在《内经》时代，心病与咽喉之间的关系不断被临床认识，如《素问·痹论》中“心痹者，脉不通，烦则心下鼓，暴上气而喘，噎干善噫，厥气上则恐。”^[1]再如《素问·咳论》中：“心咳之状，咳则心痛，喉中啞啞如梗状，甚则咽肿喉痹。”^[2]也是对心病与咽喉之间关系的认识。古人是从经脉分支的角度进行联系，最早在张家山汉简《脉书》中出现了手少阴脉循行“入心中”的记载，此后在《灵枢·经脉》篇对手少阴脉分支描述为“其支者，从心系上挟咽”，在《灵枢·经别》中也有“属于心，上走喉咙”的记载，提示心病与咽喉之间的关系，说明古人对临床现象所进行的细致观察，是经脉分支产生并演变的一个很重要的原因。

^[1] [春秋]佚名. 黄帝内经素问[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2012: 165.

^[2] [春秋]佚名. 黄帝内经素问[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2012: 147.

《灵枢·经脉》整合了简帛文献中的经脉分支，如老官山《别脉》中“间别臂阳脉”的循行路径为“出髀，髀下，出项，耳上，奏颠”，《灵枢·经脉》篇将“间别臂阳脉”拆分为支脉与主干，归属于膀胱足太阳脉的循行中，即“其支者，从巅至耳上角；其直者，从巅入络脑，还出别下项，循肩髃内”，学者广濑薰雄认为两者描述的循行线路高度一致，提示某种相关性^[1]。《灵枢·经脉》篇部分经脉是以分支的形式到达经脉终点，通过支脉完成了十二脉之间气血环形流注模式，使得表里经脉、脏腑之间的联系更加紧密，实现了气血阴阳在人身环周不休的理论基础，对于中医整体观的形成有促进作用。手三阴与手三阳的支脉，是表里脏腑之间的联系；手三阳与足三阳的支脉，是六腑之间的联系，同时也是同名阳经之间的联系；足三阳与足三阴之间的支脉，是表里脏腑之间的联系；而足三阴与手三阴之间的支脉，是同名阴经之间的联系，实际上是五脏之间的联系。

《灵枢·经脉》中计有 17 条支脉，其中有 10 条支脉专门用于构建表里经脉之间的联系（如表 17 所示），进一步构建了十二经脉环形流注模式，元代滑寿称之为“络脉”（并非十五络），即：“络脉传注，周流不息……络脉之传注于他经，犹沱潜之旁导于他水也。”这 10 条支脉对于临床诊疗的参考作用并不大，专用于说理。赵京生先生认为这些分支构建了“气血循环流行、脏腑表里相合、阴阳协调转化”^[2]。使得脏腑之间通过经脉表里的联系变为一个整体。但是需要强调的是，古人是为了构建经脉环形流注模式，以及为说明体表-内脏（或是经脉-脏腑）之间的相关性，才在《内经》中“形式化”地新增了 10 条支脉用于构建联系，因此，这些支脉并无实体解剖基础，也无临床诊疗价值。

《灵枢·经脉》篇中经脉分支还有一个特点，就是整合简帛经脉文献的相关内容而成，如出土文献中，足少阳脉从腋胁到目外眦之间有“耳前”“耳后”两种不同的循行路径，前者如《阴阳》《十二脉》《灵枢·经别》，后者如《足臂》《灵枢·经筋》，《灵枢·经脉》篇编者在整合这些文献时，将足少阳脉的主干根据《足臂》定位“耳后”，此外又用一条支脉将“耳前”也照顾到^[3]，这样《灵枢·经脉》篇“胆足少阳之脉”循行为“起于目锐眦，上抵头角，下耳后，循颈……其支者，

^[1] 广濑薰雄. 天回老官山汉简《别脉》初探[J]. 出土文献与古文字研究, 2020(00):316-328.

^[2] 赵京生. 经脉分支的形成过程与意义[J]. 上海中医药大学学报, 1999(02):11-13.

^[3] 黄龙祥. 老官山出土汉简脉书简解读[J]. 中国针灸, 2018, 38(01):97-108.

从耳后入耳中，出走耳前，至目锐眦”，既经过耳前又经过耳后，体现该篇编者面对不同理论认识时采取兼容并包的处理方式，笔者将《灵枢·经脉》篇经脉分支分类如下表所示：

表 17 《灵枢·经脉》篇经脉分支分类情况

经脉（分支数）	构建经脉环形新增支脉	简帛经脉主干演化	简帛经脉分支演化	其他新增支脉
手太阴（1）	从腕后……出其端			
手少阴（1）				从心系上挟咽，系目系
手厥阴（1）	别掌中，循小指次指出其端			
手阳明（1）		从缺盆……上挟鼻孔		
手太阳（1）	别颊……斜络于颧			
手少阳（1）	从耳后……至目锐眦			
足太阴（1）	复从胃别上膈，注心中			
足少阴（1）	从肺出络心，注胸中			
足厥阴（2）	复从肝别贯膈，上注肺、从目系下颊里，环唇内			
足阳明（3）	别跗上……出其端	下膝三寸……中指外间		起于胃口……下至气街中（足阳明之别）
足太阳（2）			从巅至耳上角 （演化自《足臂》）	从髀内……下合腘中 （《经脉》篇首见）
足少阳（2）	别跗上……出三毛	从耳后……至目锐眦后		
总计（17）	10	3	1	3

说明：1. 本表受篇幅所限，部分文字省略处理。
2. 手阳明脉分支演化自《十二脉》，其余演化自《足臂》。

3.5.4 经脉分支演变的意义

3.5.4.1 解释临床病症

早期经脉分支数量不断增加，主要用以解释逐渐增多的临床诊疗经验，如督脉在双包山木人中没有分支，其循行起自鼻尖端，向上经过鼻→额→头顶→项→背→腰→骶，最终到达会阴。唯有手厥阴脉，在侧头部交汇手阳明脉及其支脉、足太阳脉、手少阳脉之后（与三条阳脉形成四个交点），直上头顶会于督脉“百会”，学者认为可能是扁鹊治疗虢国太子取穴“三阳五会”的由来^[1]。尽管督脉在《内经》之前就已经运用于临床，但是本身并无支脉，在《内经》中，督脉循行复杂且分

^[1] 颜纯淳. 百会穴古代文献研究[D]. 山东中医药大学, 2012.

支较多，其分支联系足少阴脉和肾，又有分支“上入络脑”说明督脉与脑之间的联系，在腹部还有分支经小腹中央（同任脉）→脐中央→心→喉咙→环绕唇口→两目下中央（承泣）。说明督脉的循行越来越复杂，分支联系的体表部位、脏腑也越来越多，早期虽然有将任脉称为督脉的可能，导致了督脉循行联系广泛，但不可否认督脉在古人心中的重要地位，尤其自双包山木人之后至《内经》之间，是督脉分支演化发展的重要时期。

再如老官山针方简《刺数》中，有“□□山，暴，仑，癢，转胞，两肱蹶阴各五”的记载，《史记》中淳于意对于“难于前后溲……腹肿”这一症状，用“蹶阴之络结小腹也”进行解释，说明秦汉医家已经认识到足厥阴脉不仅用于治疗前阴疾患，还可以用于治疗小腹疾患，于是将足厥阴脉从前阴处演化出一条分支“蹶阴之络”，通过这条分支“结小腹”。

《灵枢·经脉》篇中，经脉的分支还有一个比较重要的作用，就是专门用来串联腧穴，其中最具典型者，属于足太阳脉。早期《足臂》中“足泰（太）阳脉”的循行有“夹脊”，是紧贴脊柱的意思，并无第二条侧线分支，因此，早期背俞穴可以看作是独立分布的，并无经脉贯通，在具体定位上以触按相应的疼痛点进行确定，如《灵枢·背腧》记载：“按其处，应在中而痛解，乃其腧也。”《灵枢·经脉》篇为使背俞穴归属于经脉，故将足太阳脉第一侧线从“夹脊”改为旁开一寸五分，又于脊柱旁开三寸增加第二侧线，将背俞穴统归于足太阳脉。经脉分支的出现，使得主干与分支之间界限明显，避免经脉循行路线过于复杂，还能解释特定穴对于脏腑的调整作用，如六腑下合穴均位于足三阳，足阳脉也以支脉的形式进入体内联系六腑^[1]，即“此阳脉之别入于内，属于腑者也”，支脉在此处的作用也直接体现腧穴与脏腑之间的联系。

3.5.4.2 构建经脉环形流注体系

古人在对自然现象的观察中，认识到人体气血是循环往复的，因此在已有部分阴经与五脏联系的基础之上，《灵枢·经脉》篇的编者借助“经别”完成了阳经与六腑之间的联系，又通过体表络脉完成了表里经脉之间的联系，形成一个表里循环的系统。《灵枢·经脉》篇中不少新增的经脉分支，就是为达到经脉之间、经

^[1] 赵京生. 阳脉理论演进及其意义[J]. 中国针灸, 2011, 31(11): 1035-1039.

脉-脏腑之间的这种联系而出现的。如《灵枢·经脉》篇手太阳脉“其支者，别颊上颔抵鼻，至目内眦”一语，就是专门为建立经脉循环体系而新增的支脉，足少阳脉“其支者，别跗上，入大指之间，循大指歧骨内出其端，还贯爪甲，出三毛”也是为建立经脉循环流注而新增，手太阴脉“其支者，从腕后直出次指内廉，出其端”，手厥阴脉“其支者，别掌中，循小指次指出其端”，足厥阴脉“复从肝别贯膈，上注肺”“从目系下颊里，环唇内”，足太阴脉“其支者，复从胃，别上膈，注心中”，手少阳脉“其支者，从耳后入耳中，出走耳前，过客主人前，交颊，至目锐眦”，足阳明脉“其支者，别跗上，入大指间，出其端”，足少阴脉“其支者，从肺出络心，注胸中”，这10条支脉是专门用来构建经脉环形流注体系而人为添加的，这些人为添加的分支与简帛经脉文献的分支意义完全不同，“首尾循环”的经脉体系形成之后，对中医理论发展影响颇深，气血循环有了理论基础，脉诊由“三部九候”转变为“寸口诊法”，同时经脉理论发展也受到了阻碍^[1]。

背部足太阳脉与胸腹部足阳明脉之间的相关性，老官山医简和漆人已显示有联系，《刘涓子鬼遗方》载有“腰太阳脉有肿，交脉属于阳明”一语^[2]，而老官山文献与《刘涓子鬼遗方》均与扁鹊医学有较深渊源。《素问·举痛论》提到“心与背相引而痛”，并且解释为“寒气客于背俞之脉则脉泣……其俞注于心，故相引而痛”，这些论述都提示胸腹部与背部之间有联系，而早期文献均以经脉进行联系。这为《内经》中前后相关的“偶刺”提供了理论支持^[3]。

经脉与脏腑相关方面，由于阴经位于身体屈侧，与五脏接近，故两者关系建立较早，如简帛经脉与脏腑相关者有“臂太阴-之心”“足少阴-出肝”“足太阴-被胃”（早期胃为脏），六阳经与六腑的联系则相对较晚，古人认为是通过经别进行联系的，即《灵枢·邪气脏腑病形》：“此阳脉之别入于内，属于腑者也。”六腑疾患，一般通过经别理论选取位于足三阳脉的下合穴进行治疗，而不是选取相关的手三阳脉。经脉分支早期是为解释病症、沟通经脉之间、经脉-脏腑之间的联系而产生的，后世理论发展中，逐渐演化出脏腑本身也可以发出分支，如《素问·平人气象论》中载有“胃之大络”，《诸病源候论·心痛候》也载有“心有支别之络

^[1] 黄龙祥. 经脉理论还原与重构大纲[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2016: 94-103, 316.

^[2] [晋]刘涓子. 刘涓子鬼遗方[M]. 长沙: 湖南科学技术出版社, 2014: 16.

^[3] 黄龙祥. 老官山出土汉简脉书简解读[J]. 中国针灸, 2018, 38(01): 108.

脉”^[1]，这些由脏腑本身发出的分支，也能出现生理、病理现象，无疑是理论高度固化后形成的产物。

3.5.5 小结

关于十五络，应该首先明确的一点是：十五络最初形成是来自于临床实践，因此将十五络的作用单纯描述为联系表里经脉是不准确的，十五络和经脉一样，是“平级”的概念，此外阳经的络脉多上走头面（如“手阳明之别……入耳”“足阳明之别……上络头项”），而阴经的络脉多深入体腔与脏腑相关。值得一提的是，当前针灸学教材一致认为十五络脉可以沟通表里经脉，实际上只有足少阴经的这个作用较为突出，故应正确认识十五络脉的作用，络脉的产生与经脉一样，来源于临床诊疗实践，络脉甚至有自己的分支，如“手阳明之别……其别者，入耳合于宗脉”，因此，十五络不能单纯地认为是十二经脉的补充，或是支脉等等。经别则是为构建体内外联系而产生的，《灵枢·经别》中十二经别均无相应的病候，说明经别理论大概率不是来源于临床实践。十二经别的成书年代要早于十二经脉完成环形流注的时间^[2]，十二经别不仅用于解释“合治内腑”，还被用于构建经脉环形流注体系，帮助完善经脉与脏腑之间的联系，尤其是阳脉经别和脏腑之间的联系更具有特点，如与足三阳联系的脏腑有膀胱、肾、胆、肝、心、胃、脾，与手三阳联系的脏腑有心、小肠、三焦、大肠、肺。相对足三阴仅联系肾脏，手三阴联系心、三焦与肺^[3]。

经脉分支的出现，实际上是经脉主干作为线状结构，不能完全覆盖体表的局限性导致的，以“络脉”为例，经脉分支有大有小，但整体上起到了疏导气血运行支流的作用，气血不能只在经脉主干中运行，全身脏腑组织、皮肉筋骨皆需要气血濡养，在经脉主干中气血运行较快，大的络脉运行相对较为和缓，再经过无数的孙络、浮络将气血输送到全身。古典针灸理论重视联系的身体观，尤其是表里相关以及上下前后相关^[4]，经脉主干所揭示的是人体纵向治疗规律，而表里经脉之间的关系、经脉与脏腑之间的关系，则是靠经脉分支进行联系。经脉分支的演变过程，也就是经脉之间、经脉-脏腑之间关系的演变史。

^[1] [隋]巢元方撰；南京中医学院校释. 诸病源候论校释[M]. 北京：人民卫生出版社，2009：383.

^[2] 黄龙祥. 经脉理论还原与重构大纲[M]. 北京：人民卫生出版社，2016：349-359.

^[3] 赵京生. 针意[M]. 人民卫生出版社，2019：151.

^[4] 黄龙祥. 中国古典针灸学大纲[M]. 北京：人民卫生出版社，2019：29.

十二经脉中只有五阴脏经脉的起点和终点是经脉主干，其余经脉的起点和终点是通过支脉进行相连接的。对经脉分支的研究，有助于对针灸理论“规律”的把握，医学是一门实践性很强的学科，早期经脉分支的出现，就是为解释临床诊疗现象应运而生，然而经脉理论发展至《灵枢·经脉》篇时，经脉分支又具有构成十二脉环形流注模型的新作用，对经脉分支的梳理分析，能够正确把握不同经脉理论阶段的特征。针灸理论在漫长的发展过程中，不断整合着不同认识、不同学说。最初经脉理论是人们对于机体远隔部位之间联系规律的总结，而后来发展成为将经络、脏腑甚至术数融为一体的学说，经脉分支在其中起着重要的联络阐释作用。黄龙祥先生曾说过，经络理论的价值并不在于经脉循行本身，而在于经脉循行所示的人体上下内外特定部位间特定联系的规律。对经脉分支的梳理，也在于寻找其演化背后所展示出来的本质和规律。

3.6 经脉主治病症演变

对秦汉时期经脉主治病症演变的研究，目前所能依据的材料主要有《足臂》《阴阳》《十二脉》以及《灵枢·经脉》，《足臂》以“其病：病XX”引出经脉所主病症，《阴阳》则以“是动则病”与“其所产病”进行归类，老官山《十二脉》在描述手太阳脉的循行之后，用“治所生病”引出经脉所主病症，《灵枢·经脉》以“是动则病”“所生病”引出。在具体内容中，《足臂》经脉主治病症相当于《阴阳》的“其所产病”。对于“是动则病”“其所产病”的具体含义，秦汉时代仅有《难经·二十二难》从气与血的角度进行了解释，后世医家又有许多不同的认识^[1]。《足臂》“其病”与《阴阳》“其所产病”以及《灵枢·经脉》“所生病”之间有相似性，尤其是所归纳的疼痛病症，可能是古人对经脉概念认识产生的一个原因^[2]。

《足臂》的主治病症与其循行路径近乎一致，甚至连排列顺序也同样是向心性，如《足臂》足少阳脉循行为：“出於踝前，枝於骨間（間），上貫臑（膝）外兼（廉），出於股外兼（廉），出脅；枝之肩薄（薄-膊）；其直者貫腋，出於項、耳，出臑（枕），出目外眦（眦）。”可简单概括为“踝前→骨间→膝外廉→股外廉→胁→肩→腋→项、耳→枕→目外眦”，随后主治病症包含“足小指次指廢，胛外

^[1] 曹晷焱. 小议《灵枢·经脉》篇“是动”“所生病”及其区分依据[J]. 中国针灸, 2017, 37(07): 776-778.

^[2] 李海峰. 从出土和传世早期经脉类文献中的疼痛病症看经脉理论的形成[J]. 吉林中医药, 2020, 40(06): 820-822.

廉痛，脘寒，膝外廉痛，股外廉痛，髀外廉痛，脅痛，肩痛，產馬……聾，枕痛，耳前痛，目外漬（眚）痛”，可见病变所在部位与经脉循行所过高度一致。而《阴阳》足少阳脉“其所产病”排列顺序与经脉的循行顺序正好相反，且主治病症的描述《足臂》《阴阳》也有差别，属于秦汉时期不同医派认识上的差异。无论是《足臂》的“其病”还是《阴阳》的“其所产病”，在《灵枢·刺节真邪》中总结为：“有一脉生数十病者，或痛，或痠，或热，或寒，或痺，或不仁，变化无穷。”

《史记·扁鹊仓公列传》曰：“厥阴有过则脉结动，动则腹肿。”《说文解字》：“动，作也。”有发作、变动之意。是指经脉在异常情况下发生的病变，而这种异常情况《灵枢·经脉》又归纳为：“盛则泻之，虚则补之，热则疾之，寒则留之，陷下则灸之，不盛不虚，以经取之。”黄龙祥先生认为这些“盛”“虚”“热”“寒”“陷下”是脉口处诊动脉搏动的经验积累，也是“是动则病”的来源^[1]，“是动则病”中“动”指的是脉的异常搏动^[2]，而老官山《十二脉》只有手太阳脉作“所生病”，其余经脉主治病症均以“其病”引出。具体每条经脉病症的演变，参考论文2.1小节中“十二经脉理论演变梳理”。

^[1] 黄龙祥. 经脉病候考源[J]. 中华医史杂志, 1994(04): 219-222+194.

^[2] 黄龙祥. 中国针灸学术史大纲[M]. 北京: 华夏出版社, 2001: 236.

4 先秦两汉腧穴理论演变分述

先秦两汉时期的腧穴内容，主要集中在老官山漆人、《刺数》《内经》《明堂经》中，老官山漆人大致呈“标准解剖学姿势”，高14厘米，可见耳廓、下颌、肩胛骨、肚脐、臀横纹、腘窝、内外踝等重要的体表标志，体表所刻画的红白线只能看出大致走向，所刻画的圆点也并无直接证据证明是后世的腧穴，因此整理人员称为“疑似腧穴点”，最初考察认为漆人体表可见119个疑似腧穴点，包括左右对称的双穴51个，单穴17个^[1]，而后续研究认为漆人体表分布的疑似腧穴点共有116个^[2]。对于分布在足三阳脉上的老官山漆人“疑似腧穴点”与后世腧穴之间的关系，整理人员用“当”“约当”“近”三种术语进行描述^[2]，其中“当”“约当”所处的位置多被后世文献所传承，但部分“近”所在的位置，不见于后世文献，可能属于后来被“淘汰”掉的治疗点。《内经》中的腧穴内容比较丰富，同时也较为原始，苏壮^[3]、张胜男^[4]通过整理分析，认为《内经》中明确命名的腧穴有148个，此外苏壮还考察《内经》中未记载名称但有位置的腧穴74个。以下依据老官山漆人、《刺数》《内经》《明堂经》等，对先秦两汉时期腧穴演变逐个梳理如下：

4.1 足太阳脉腧穴

4.1.1 老官山漆人足太阳脉腧穴演变梳理

老官山漆人左侧足太阳脉第二侧线上，根据骨度折量法计算，前发际直上5.5寸（同身寸，后同），旁开约2.5寸处刻有一处疑似腧穴点，整理人员认为与“络却穴”位置相近，故命名为“近络却穴”，如图29所示。络却穴别名有强阳、脑盖、反行等，该穴具体定位及主治出自《明堂经》，定位为“通天后一寸五分”，后世医籍从之，主治病症为“主脑风眩，头痛，癫疾僵仆，目妄见，恍惚不乐，狂走，癰疽”^[5]，《明堂经》用了描述症状群组的表述方式，临床使用较为方便，这种描述症状群组的方法秦汉医籍多采用，如《伤寒论》便是典型。笔者推测，类似“近络却穴”这样的单穴，大多刻画在头部和腰背部，可能是以一侧单穴代表左右均有该穴，而另一侧不刻画腧穴的原因，或为省时省力，或为更好地展示

^[1] 梁繁荣,曾芳,周兴兰,等.成都老官山出土经穴髹漆人像初探[J].中国针灸,2015,(01):91-93.

^[2] 张乙小.成都老官山汉墓经穴髹漆人像足三阳脉腧穴考证研究[D].成都中医药大学,2020.

^[3] 苏壮.《黄帝内经》腧穴理论的发生学研究[D].辽宁中医药大学,2013.

^[4] 张胜男.《黄帝内经》腧穴相关理论探析[D].辽宁中医药大学,2014.

^[5] [汉]佚名撰;黄龙祥辑校,王雪苔审订.黄帝明堂经辑校[M].北京:中国医药科技出版社,1987:11.

经脉的循行路径。络却穴是足太阳膀胱经“入络脑还出”之处，黄龙祥先生认为“络却”作为穴名应当是在《灵枢·经脉》成篇并流行之后才出现的^[1]，老官山漆人提示我们，至少在西汉景、武帝时期，络却穴所在部位已经成为了治疗选取处。

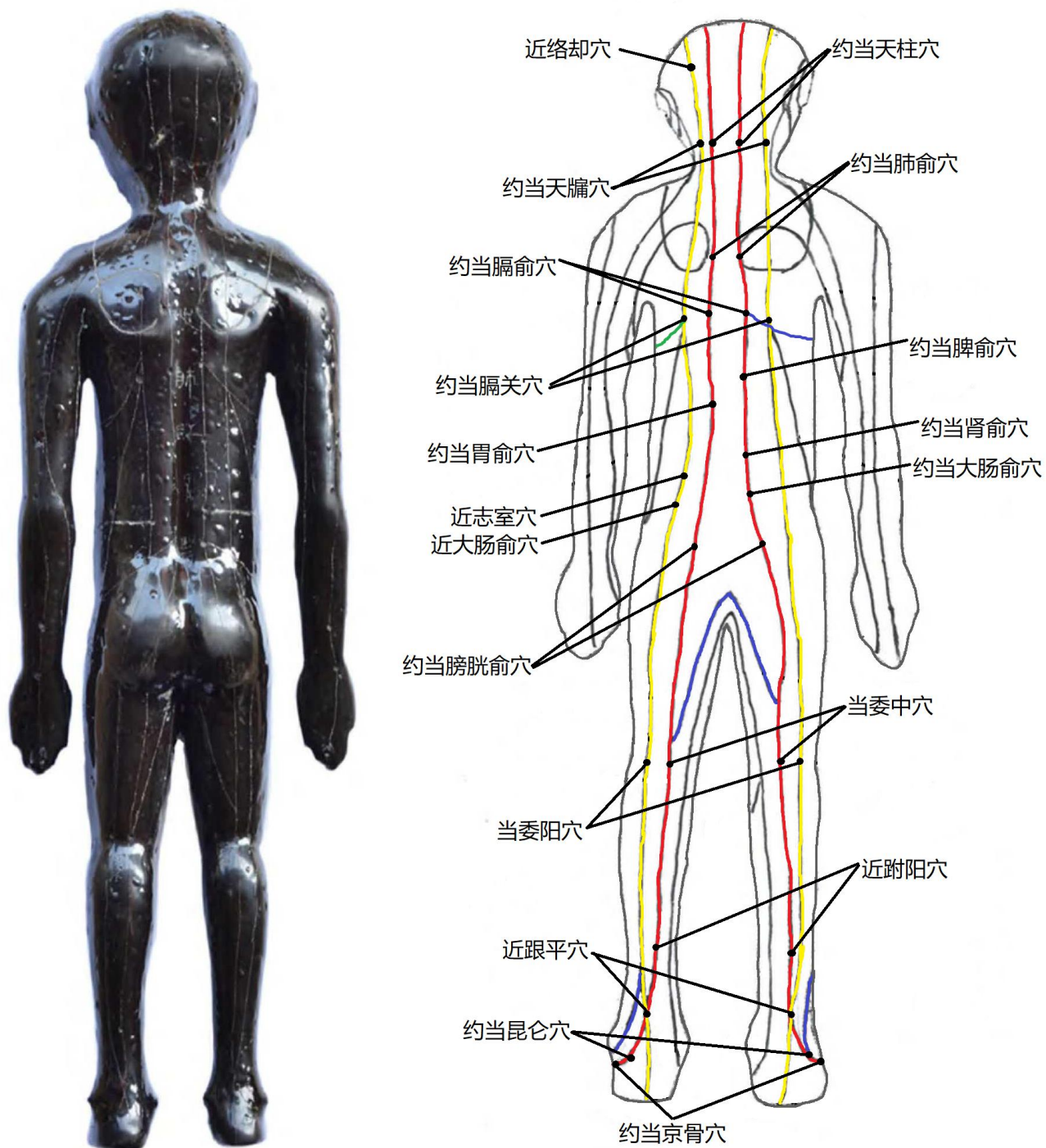


图 29 老官山漆人足太阳脉腧穴分布示意图

^[1] 黄龙祥,黄幼民. 针灸腧穴通考:《中华针灸穴典》研究. 第一版[M]. 北京:人民卫生出版社,2011:605.

老官山漆人足太阳脉约平后发际处分布有“约当天柱穴”“约当天牖穴”，分别位于第一侧线与第二侧线处。“天柱”“天牖”见于《灵枢·寒热病》中的“天牖五部”（天柱、天牖、扶突、天府、人迎），由于天牖居中，故以其命名，即“以天牖居中，统前后上下而言也”（《类经·刺头项七窍病》），并且记载了各自的主治病症，证明秦汉时期这些穴位已经积累了较为丰富的临床经验。两穴还归属于《灵枢·本输》所记载的颈项部十穴（天突、天容、天窗、风府、人迎、扶突、天牖、天柱、天府、天池），前七穴又分别称为“七次脉”，“天牖五部”与十二经别和根结理论密切相关，是头部与躯干四肢联系的重要通道^[1]。天柱穴是足太阳脉所入之处，《灵枢·根结》：“足太阳根于至阴……入于天柱、飞扬也。”《明堂经》定位为“夹项后发际，大筋外廉陷者中”，归经为“足太阳脉气所发”，《明堂经》载天柱穴主治病症中头项、目疾及“癫狂”等，与足太阳脉“是动则病”相符合，天柱穴也常见于《内经》治疗头目疾病的针方中，如“暴挛病眩，足不任身，取天柱”（《灵枢·寒热病》）“厥头痛……先取天柱，后取足太阳”（《灵枢·厥病》）“精不灌则目无所见矣……泣出，补天柱经侠颈”（《灵枢·口问》）。天牖穴的归经，在《内经》中已经有归于手少阳脉（《灵枢·本输》）和足少阳脉（《灵枢·寒热病》）两种不同认识，具体定位则首载于《明堂经》，是根据周围腧穴及体表标志而定：“在颈筋，缺盆上，天容后，天柱前，完骨下，发际上。”归经为“手少阳脉气所发”，天牖穴的主治病症，与耳、目相关，如“暴聋气蒙，耳目不明，取天牖”（《灵枢·寒热病》）。这一主治被《明堂经》承载，除此之外还治疗其他头目病症如“头颌痛，泪出，洞鼻不知香臭”等。天柱、天牖可以治疗目疾，与古人对“项-脑-目”的认识相关，早期医家认为，后头部与项部的穴位可以通过脑组织与目相联系，如《灵枢·大惑论》中对“邪中于项”与“目眩”之间的关系，就是通过“眼系”进行解释的，《灵枢·寒热病》也记载“眼系”与足太阳脉相关，故“头目苦痛”之类的眼目疾患，可以“取之在项中两筋间”进行治疗。张家山汉简《引书》中也记载“引目痛……压两目内脉而上循之至项”，此处“两目内脉”当是《灵枢》所言“眼系”，说明“项-脑-目”关联由来已久。

天柱穴在《内经》中也称为“项太阳”，老官山医简《刺数》中“项钜阳”是

^[1] 童艳,瞿巧钰,朱超,等.浅析人体“天牖五部”[J].中国针灸,2021,41(08):937-940.

天柱穴最早的腧穴名称,《刺数》:“癫疾,两辟(臂)肱阳明、项钜阳各五。”这条针方的基本组成结构是“病症+穴位/部位+刺激量”,“辟(臂)肱阳明”“项钜阳”是用作腧穴名,而非经脉名。“项钜阳”即《内经》中的“项太阳”,《灵枢·癫狂》在治疗“脉癫疾”时,具体根据症状差异而选取针刺或艾灸。首先,该病表现为“暴仆,四肢之脉皆胀而纵”,在诊断时需观察“脉满”与“不满”,前者应“尽刺之出血”,而后者选取“挟项太阳”进行艾灸。其中“挟项太阳”意为足太阳脉行于项部两侧,《素问·气府论》:“足太阳脉气所发……项中大筋两傍各一。”诸多学者指出^[1]，“项太阳”就是天柱穴^[2]。此外,老官山《刺数》还记载有一条针方:“涕出,辟阳明、项钜阳各五。”“涕”在秦汉时期意为目中流泪,《说文解字》:“涕,泣也。”^[3]表明“项钜阳”(天柱穴)可以治疗目病,《灵枢·口问》中“泣出,补天柱经侠颈”是对老官山《刺数》此条针方的注解。

表 18 先秦两汉时期天柱穴命名、定位演变

出处	《刺数》	《内经》	《明堂经》
名称	项钜阳	项太阳《灵枢·癫狂》 天柱《灵枢·五乱》《灵枢·本输》《灵枢·厥病》 《灵枢·寒热病》	天柱
定位	/	项中大筋两傍《素问·气府论》	夹项后发际,大筋外廉陷者中

天柱穴早期名称“项钜阳”,是“部位(腧穴所在大体位置)+阴阳(腧穴所属经脉)”命名方式下的产物,这一腧穴名称延续至《内经》时代,便逐渐弃而不用,改称为“天柱”,在“项钜阳”与“天柱”之间,还经历了“项太阳”“项大经”等命名方式。赵京生先生认为,天柱穴的早期名称“项钜阳”,其本质是一个面,而非一个点,随着医疗经验的积累,在“项钜阳”所在表的较大体表范围内,又出现了新的经验用穴,这时候“部位+阴阳”的命名方式就已然无法满足记录治疗部位的需求,于是便在原先“项钜阳”所辖范围内,另外设立了较多的“点”来代表刺灸处,这样“项钜阳”就演化为了天柱穴。

老官山漆人背部第一侧线,约平第3胸椎处刻有一个疑似腧穴点,整理人员

^[1] 赵丹,段逸山,王兴伊.试析老官山汉墓《刺数》“经脉穴”与《黄帝内经》腧穴的对应关系[J].中国中医基础医学杂志,2019,25(02):205-208.

^[2] 赵京生.腧穴命名的演变:基于天回医简分析[J].中国针灸,2019,39(09):1017-1020.

^[3] [汉]许慎.说文解字[M].北京:中华书局,2015:237.

将其定名为“约当肺俞穴”，肺俞穴的定位，在宋以前差异很大，如《灵枢·背腧》纵向定位“在三焦（椎）之间”，横向定位“夹脊相去三寸所”，《明堂经》与之相同“在第三椎下两旁各一寸五分”，而《素问·血气形志》则用草量法进行定位，首先用草“度其两乳间”取其 $\frac{1}{2}$ ，其次“更以他草度去半已”，然后“以两隅相拄”形成一个三角形，将三角形上角“齐脊大柱”，两个下角就是肺俞穴，按这种草度折量法计算，五脏背俞约间隔3个椎骨，肺俞在第3椎下，横向去脊中2寸^[1]。而《医心方》引《扁鹊针灸经》：“第八椎名肺俞，夹脊左右各一寸半或一寸二分。”引《龙衔素针经》：“肺俞，第五椎相去三寸。”^[2]武威汉简记载：“次刺项从上下十一椎侠椎两刺……名曰肺腧。”^[3]可见先秦两汉时期，肺俞穴的纵向定位，有第3椎下、第5椎下、第8椎下、第11椎的差异，而横向定位，有后正中线旁开1.5寸、1.2寸、2寸的差异，在具体定位特征上，又有“按其处，应在中而痛解”（《灵枢·背腧》）“以手疾按之，快然乃刺之”（《灵枢·五邪》）的要求。笔者认为，医家在按压背俞穴反应点时，“所应”“快然”的部位不一致、不固定，可能导致了肺俞穴定位上的差异，但第3椎下和第11椎这样较大的定位差异，应该是不同流派理论认识上的差异，或者是医籍在传抄过程中出现的抄写失误。黄龙祥先生认为，这种差异一般归因于医家对脏腑位置认识的分歧^[4]。肺俞穴主治病症见于《灵枢·五邪》：“皮肤痛，寒热，上气喘，汗出，咳动肩背。”主要是肺系病变，另外《伤寒论》提到针刺肺俞可以治疗“太阳少阳并病，心下硬，颈项强而眩者”。《素问·水热穴论》：“大杼、膺俞、缺盆、背俞，此八者，以泻胸中之热也。”《明堂经》肺俞穴主治病症较多^[5]，除《内经》《伤寒论》所提及的肺俞穴主治病症外，《明堂经》中增加了足太阳脉的典型病症“癫”“狂”“癰疽”等，这些主治病症是由早期针灸方汇集而来，有学者指出早期针灸方多以单穴为主，因此《明堂经》在总结腧穴主治病症时，往往将多个早期针灸方的主治病症抄在具体腧穴主治病症之下^[6]。

[1] 曹曷焱,朱世鹏,刘通.背俞穴定位考辨[J].中国针灸,2017,37(08):851-855.

[2] [日]丹波康赖.医心方[M].北京:华夏出版社,2011:64-66.

[3] 张延昌,吴祗骥,田雪梅,等.《武威汉代医简》句读补正注解[J].甘肃中医,2004(07):10-11.

[4] 黄龙祥,黄幼民.针灸腧穴通考:《中华针灸穴典》研究.第一版[M].北京:人民卫生出版社,2011:621.

[5] 因篇幅所限,本节“腧穴理论演变分述”中涉及到《明堂经》腧穴主治病症,并不会全文引录,具体腧穴主治病症可参阅:黄龙祥.黄帝明堂经辑校[M].北京:中国医药科技出版社,1987.

[6] 黄涛,黄龙祥.针灸方的分类[J].上海针灸杂志,2004(02):34-38.

老官山漆人背部足太阳脉第一侧线，约平第7胸椎处刻有一个疑似腧穴点，整理人员命名为“约当膈俞穴”。膈俞穴在早期医学中占有较为重要的地位，《灵枢·背腧》载“愿闻五脏之腧出于背者……膈腧在七焦之间……”，可见膈在早期某些医家的认识中属脏腑之一，横向定位为“挟脊相去三寸所”，《明堂经》：“在第七椎下两旁各一寸五分。”古代医籍多遵此说。膈俞穴主治《内经》未提及，《明堂经》主要集中在“气膈”之呕吐、上气以及“胸满”“胁痛”“胃脘暴痛”等局部病症，古人对膈的生理功能、病理表现认识较为清晰，如经脉循行有“上膈属肺”“下膈属脾络胃”，并且《灵枢·上膈》作专篇论述，可能与古人消化系统疾病高发相关。《灵枢·官能》：“膈有上下，知其气所在，先得其道”，说明膈与气的正常运行有关，若膈的功能失调，则表现为“上气”“心痛”“腹满”等一系列气机运行失常的症状。

老官山漆人背部足太阳脉第二侧线，与“约当膈俞穴”齐平（即第7胸椎）处有一对疑似腧穴点，整理人员命名为“约当膈关穴”，《经穴解》称“此穴与膈俞横平相直，俱在七椎下，故曰膈关”，膈关穴最早见于《明堂经》，定位“在第七椎下两旁各三寸陷者中”，主治多为局部病症、胃肠病症：“背痛恶寒，脊强俯仰难，食不下，呕吐多涎。”值得一提的是，由于“膈俞”与“膈关”相近，古代医籍中多有将二者主治相混的情况^[1]。

老官山漆人背部右侧足太阳脉第一侧线，约平第11胸椎处，刻有一个疑似腧穴点，整理人员命名为“约当脾俞穴”。脾俞穴在《灵枢·背腧》中定位为“第十一焦之间，皆夹脊相去三寸所”，《明堂经》定位与之相同：“在第十一椎下两旁各一寸五分。”《灵枢》《明堂经》所记载的脾俞均为左右各一，然老官山漆人脾俞穴仅见于右侧足太阳脉第一侧线，左侧则未刻画。无独有偶的是，脾俞穴仅在右侧的情况也见于《素问·血气形志》，按该篇所记载的草度折量法，脾俞位于第9椎下右侧，横向则去脊中2寸。由此可见，脾俞穴的定位，不仅在纵向（椎数）与横向（夹脊寸数）上有差异，在单穴或双穴的认识上也有不同，《素问·血气形志》与老官山漆人提示先秦两汉时期有一种理论认为脾俞穴仅位于右侧足太阳脉上。关于脾俞穴的主治，《明堂经》主要用于治疗“食晦”“脾胀”等胃肠道消化系统

^[1] 黄龙祥,黄幼民. 针灸腧穴通考:《中华针灸穴典》研究. 第一版[M]. 北京:人民卫生出版社,2011:719.

病变，其中“腹中气胀引脊痛，饮食多，身羸瘦，名曰食晦，先取脾俞，后取季胁”应该是一首完整的针方，《明堂经》中腧穴主治病症多来源于秦汉时期广为流传的针灸方，《明堂经》大肠俞与脾俞主治中均有“大肠转气，按之如覆杯”，应该是出自同一首针方。此处“食晦”为古病名，有学者考证后认为与《素问》中的“食亦”同病异名，均属于消渴范畴^[1]。此外，《明堂经》中所提到的脾俞穴主治病症在《内经》中也多能找到对应条文，如《灵枢·胀论》对“脾胀”的症状描述为“善哕，四支烦，体重不能胜衣，卧不安”，其他症状也多出自《内经》中“脾风”“脾病”等，《素问·玉机真脏论》描述“脾风”的症状为“发痒，腹中热，烦心出黄”，《素问·风论》进一步描述：“多汗恶风，身体怠惰，四肢不欲动，色薄微黄，不嗜食，诊在鼻上，其色黄。”^[2]

老官山漆人背部左侧足太阳脉第一侧线，约平第12胸椎处刻有一处疑似腧穴点，整理人员命名为“约当胃俞穴”，胃俞穴的定位在《明堂经》为“在第十二椎下两旁各一寸五分”，后世医籍多从之。而《明堂经》胃俞穴的主治病症与下合穴足三里多有重复，足三里是临床常用穴，多见于先秦两汉医籍中，而背俞穴则是医家根据脏腑位置高低不同而设立的腧穴，早期医籍中腧穴主治有相互移植的特点，胃俞穴主治病症可能直接移植自足三里。

老官山漆人背腰部右侧足太阳脉第一侧线，约平第2腰椎处刻有一处疑似腧穴点，整理人员命名为“约当肾俞穴”，肾俞穴定位见于《灵枢·背腧》：“肾腧在十四焦之间，皆夹脊相去三寸所。”《明堂经》定位与《灵枢》同，若根据《素问·血气形志》篇的定位记载，肾俞穴在第12椎下，旁开2寸，《明堂经》载本穴主治病症多是以“骨寒热，洩难，洞泄，腰痛，面黑，肾胀”等肾病症状为主^[3]，此外肾俞穴主治病症中的“心下臍痛，心如悬”还见于然谷、大钟、复溜的主治病症中，或是出自同一首针灸方，或是直接移植五输穴主治病症而来。

老官山漆人腰区左侧足太阳脉第二侧线，约平第2腰椎处刻有一处疑似腧穴点，比“约当肾俞穴”位置低一点，与“志室穴”距离相近，因此整理人员命名为“近志室穴”，志室穴最早载于《明堂经》，定位为“第十四椎下两旁各三寸陷

^[1] 李绍林.“食晦”、“食亦”考[J].中医杂志,2011,52(05):443-444.

^[2] [春秋]佚名.黄帝内经素问[M].北京:人民卫生出版社,2012:163.

^[3] 黄龙祥,黄幼民.针灸腧穴通考:《中华针灸穴典》研究.第一版[M].北京:人民卫生出版社,2011:657

者中”，主治腰腹局部病变“腰痛脊急，胁下满，小腹坚急”^[1]，老官山漆人此处疑似腧穴点只是靠近志室穴，从公布的漆人照片可见，“近志室穴”与“约当肾俞穴”并不在一个水平线，“近志室穴”的下方，约平第4腰椎水平处也刻有疑似腧穴点，整理人员命名为“近大肠俞穴”，这些“近XX穴”可能在老官山墓主人所处的时代作为常用治疗点，而在《内经》《明堂经》成书年代，或是由于治疗效果欠佳（如志室穴的主治几乎均见于肾俞穴），或是由于医家理论体系有异，逐渐被主流医学所淘汰，后世并无传承。

老官山漆人在腰区，右侧足太阳脉第一侧线，约平第4腰椎处刻有疑似腧穴点，整理人员命名为“约当大肠俞穴”，大肠俞的定位，《明堂经》载“在第十六椎下两旁各一寸五分”，后世医籍多从，敦煌卷子《佚名灸方》载“大肠俞在第十六椎两厢相去二寸三分”。《明堂经》大肠俞主治以局部症状为主，其中“大肠转气，按之如覆杯”又见于脾俞穴主治，“饮食不下，腹膜”又见于膈俞穴主治。

老官山漆人骶区，位于双侧足太阳脉第一侧线上，约当臀部上1/3与中下2/3交点处，刻有一点，整理人员命名为“约当膀胱俞穴”，《明堂经》定位为“第十九椎下两旁各一寸五分”，从第2版《针灸学讲义》开始，将“十九椎下”改为“平第二骶后孔”或“第二骶椎棘突下”，《明堂经》主治病症主要是腰部和小便等局部症状，以及足太阳脉典型病症。

老官山漆人膝后区，位于双侧足太阳脉，当腘窝中央刻有一对疑似腧穴点，整理人员命名为“当委中穴”，《内经》记载委中较详，在定位、归经方面，《灵枢·本输》：“膀胱出于至阴……入于委中，委中，腘中央。”《素问》多处提及的“刺足太阳郄中出血”（《素问·刺腰痛》）“刺郄中出血”（《素问·刺疟论》），其中“郄中”一词，王冰认为就是委中：“古法以委中为郄中。”帛书《阴阳》（乙本）记载足太阳脉循行“出郄中”，证明王冰所言为实。委中在《内经》时代既是部位名，也是腧穴名，作为腧穴其具体定位方法在《内经》之后多以腘横纹中点动脉搏动处为准，如《明堂经》定位为“在腘中央约纹中动脉”，腘横纹中央动脉即现代解剖学中的“腘动脉”，腘动脉在俯卧位，膝关节弯曲45°~90°时，沿股骨腘面中线即可以触摸到动脉搏动，后世一些口语化定位描述，实际上也是指动脉搏动处，

^[1] [汉]佚名撰；黄龙祥辑校，王雪苔审订。黄帝明堂经辑校[M].北京：中国医药科技出版社，1987：48.

只是不一定能够清楚触摸到,如“甄权云曲踞内,两筋两骨宛宛”(《太平圣惠方·针经》)。委中穴的主治,在《内经》中记载较为丰富,主要治疗“腰痛”(《灵枢·杂病》)《素问·刺腰痛》《素问·刺疟》)“风痉身反折”(《灵枢·热病》)“膝痛”(《素问·骨空论》),取用委中穴多为“刺络放血”,此外还可以治疗膀胱病候(《灵枢·邪气脏腑病形》)和衄血不已(《灵枢·杂病》),反应了阳经下合穴的主治规律^[1]。《明堂经》中委中穴主治病症承自《内经》,甚至病症的排列组合形式也是高度相似。

老官山漆人双下肢膝后区,位于腘窝外廉(委中穴外侧)刻有一处疑似腧穴点,整理人员命名为“当委阳穴”,委阳穴《灵枢·本输》定位为:“三焦下腧……出于腘中外廉,名曰委阳,是太阳络也。”故“腘中外廉”是委阳穴的具体定位,《灵枢·邪气脏腑病形》中又提出具体取穴要求:“取之委阳者,屈伸而索之。”当膝关节做围绕冠状轴的屈伸运动时,有助于寻找股二头肌肌腱,从而对委阳穴(股二头肌肌腱内侧)进行定位。《明堂经》对委阳穴的定位为“出于腘中外廉两筋间,扶承下六寸”,其中“扶承下六寸”为殷门穴,并非委阳穴。关于委阳穴的主治病症,《灵枢·本输》以前阴病症为主,即“实则闭癃,虚则遗溺”,此外还包括“腹满”“不得小便”“水肿”等三焦病证(《灵枢·邪气脏腑病形》),《明堂经》委阳穴主治病症也集中在前阴、三焦,此外“腰痛引腹不得俯仰”“痔”,属于足太阳脉的典型病变。

老官山漆人小腿后方,位于双侧足太阳脉第一侧线,约在昆仑穴(外踝后凹陷中)直上4.5寸处刻有一个疑似腧穴点,与后世文献中跗阳穴位置相近,故整理人员命名为“近跗阳穴”,“跗阳”在《明堂经》中写作“付阳”,定位为“足外踝上三寸”,但付阳穴与经脉之间的关系为“太阳前,少阳后”,说明该穴早期并未归入足太阳脉,《明堂经》言该穴为“阳蹻之郄”,故应归入阳蹻脉,因此笔者推测老官山漆人“近跗阳穴”可能是被秦汉医家逐渐淘汰的治疗点。

老官山漆人外踝后,位于足太阳脉两条侧线相交处刻有一处疑似腧穴点,由于与经外奇穴跟平穴位置相近,故整理小组命名为“近跟平穴处”,这一现象提示我们,老官山漆人疑似腧穴点存在“二次发现”的可能,即较晚出现的腧穴却在出土文献、文物中找到相关记载,漆人“近跟平穴处”可能在秦汉时期的第一次

^[1] 黄龙祥,黄幼民. 针灸腧穴通考:《中华针灸穴典》研究. 第一版[M]. 北京:人民卫生出版社,2011:703

腧穴整理过程中（即《明堂经》的成书），由于某种原因被淘汰，未流传下来，但后世医家在诊疗过程中，再次发现了被“淘汰”的古老腧穴，这样巧合性的演变过程，提示我们对腧穴的来源认识，一定要注意临床实践这一重要因素，经脉、腧穴理论根源在于临床，理论创新也在临床。

老官山漆人双侧足太阳脉外踝尖与跟骨之间的凹陷中刻有一处疑似腧穴点，整理人员认为与大多数古籍记载的昆仑穴位置相符合，故命名为“约当昆仑穴”，昆仑穴为本经经穴，其定位早在《内经》就有记载，《灵枢·本输》定位为“在外踝之后，跟骨之上”，成为了后世医籍描述昆仑穴定位的标准，如《明堂经》：“在足外踝后，跟骨上陷中。”昆仑穴既是足太阳脉经穴，又是根溜注入中所注之处，《灵枢·根结》：“足太阳根于至阴……注于昆仑。”昆仑穴主治病症，在马王堆帛书《五十二病方》中便有记载：“癰，先上卵，引下其皮，以砭穿其腓旁，□□澧及膏□，挠以醇□，有（又）久（灸）其痛，勿令风及，易瘳；而欠（久一灸）其泰阴、泰阳□□。”此处“泰阴”“泰阳”根据李建民先生考证，属于腧穴概念^[1]，“泰阳”在外踝后下方，为昆仑穴所在。昆仑穴主治病症在《内经》中多是以针灸方的形式出现，如《灵枢·五邪》取涌泉、昆仑用以治疗“阴痹”，《灵枢·厥病》取京骨、昆仑、然谷治疗“厥心痛”，而后在《明堂经》中所记载的病症更为详细，大多是“痉”“癫狂”“腰痛”等足太阳脉的典型病症，此外还有妇科病如“女子字难，若胞衣不出”以及局部病变“腓跟肿”等。

老官山漆人双侧足太阳脉在足跖区，第5跖骨下缘处刻有一点，整理人员认为与传世文献中的京骨穴位置相当，因此命名为“约当京骨穴”。京骨穴是足太阳脉原穴，又是足太阳所溜之处，《灵枢·本输》定位在“足外侧大骨之下”，“足外侧大骨”即第5跖骨，《明堂经》增“赤白肉际陷者中”进一步定位，而《太素·本输》定位在“外踝之下”，恐另有所本。该穴主治病症，《内经》中仅有一条针灸方，即《灵枢·厥病》取京骨、昆仑、然谷治疗“厥心痛”，《明堂经》中本穴主治多为足太阳脉的典型病症，此外，“心痛，肩背相引，如从后触之状，身伛偻”承自《内经》，而“痿厥，身体不仁，手足偏枯，先取京骨，后取中封、绝骨，皆泻之”明显属于一条针灸方；本穴还多治疗眼目疾病，如“目白翳”“目赤眦烂无

^[1] 李建民. 生命史学——从医疗看中国历史[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2008: 265-283.

所见，痛从内眦始”“目反”等。

4.1.2 足太阳脉其余腧穴演变梳理

睛明穴《内经》称为“目内眦”，《素问·气府论》将其归属于手太阳脉，而《明堂经》归于“手足太阳、足阳明之会”，其主治病症《内经》未载，《明堂经》主要针对目病：“主目不明恶风，目泪出憎寒，头痛目眩瞽，内眦赤痛，目眦眦^[1]无所见，眦痒痛，淫肤白翳。”攒竹穴《内经》称为“眉头”“眉本”，王冰皆注为本穴，《素问·骨空论》载其主治：“从风憎风，刺眉头。”“从风憎风”应该是属于“头风”病的症状，《灵枢·口问》：“噫……补眉本也……嚏，补足太阳荣眉本，一曰眉上也。”《明堂经》载其主治病症包括足太阳脉的典型症状和伴见眼目症状的各种疾病，如“头风痛”“小儿痫发”“癫疾”伴见眼目症状“目如欲脱”“目系急”“目上插”“戴眼”等等，因此我们认为，秦汉时期医家在诊疗过程中，凡取攒竹穴所治疗的疾病，多应伴见眼目症状，攒竹穴属于针对眼目病症的配穴之一，该穴应用较为广泛，老官山医简《刺数》中提到其古称为“头钜阳”，《刺数》：“风，刺头钜阳，陕颀各十。”

曲差、五处、承光、通天、玉枕诸穴均首见于《明堂经》，主治病症也以头面局部病症为主，应该属于秦汉后期医家总结命名的腧穴，如曲差的主治病症为：“主头痛身热，鼻塞，喘息不利，烦满汗不出。”属于典型的伤寒表实证，再如风门穴定位首载于《明堂经》：“在第二椎下两旁各一寸五分。”该穴位于足太阳脉，又与肺俞穴相近，主治病症也为一组典型的太阳伤寒表证：“风眩头痛，鼻鼾不利，时嚏，清涕自出。”与《伤寒论》中外感表证的症状类似。再如五处穴在《明堂经》中主治病症可以分为两组，其中“主痉，脊强反折，痙痙，痙疾，头重”是足太阳脉的典型症候，因五处穴归于“足太阳脉气所发”，而“寒热”“此以泻诸阳气，热，衄，善嚏，风头痛，汗出”描述的是伤寒表证的一系列症状，因该穴位于头部，与曲差相近。故笔者推测，五处穴这种明显“拼凑”在一起的腧穴主治，证明了该穴在秦汉时期出现较晚，属于临床应用中的“冷门”腧穴，《明堂经》中类似的腧穴不少，证明了从《内经》到《明堂经》之间腧穴数量的“井喷式”增长，不是完全属于临床实践的新发现。大抒早期为第1胸椎（即大椎）的名称，后来

^[1] 《玉篇·目部》：“眦，目不明。”

才移植为腧穴名称,《素问·水热穴论》用以“泻胸中之热”,而后《明堂经》提出具体定位“在项第一椎下,两旁各一寸五分陷者中”,《难经》提及的“骨会大杼”,实指骨名,而非穴名。大杼在《内经》中主要用于热病和癫疾的治疗,《灵枢·刺节真邪》论及“彻衣”的治疗方法时,取“天府、大杼”进行泻热,《灵枢·癫狂》针刺“项大经之大杼脉”用以治疗“筋癫疾者,身倦挛急大”,《明堂经》中用以治疗足太阳脉的典型病症如“癫疾”“颈项痛,头痛,腰背痛”“痉,脊强互引”以及“大气满,喘息,胸中郁郁”等胸肺病变。

心俞穴定位见于《灵枢·背腧》:“心腧在五焦之间,皆夹脊相去三寸所。”按《素问·血气形志》中草度折量法计算,五脏背俞约间隔3个椎骨,心俞在第6椎下,横向去脊中2寸。该穴主治则首载于《明堂经》,主要治疗心胸疾患如“心痛”“不得息”“心胀”,以及目疾如“目眦眦”“泪出”等^[1]。肝俞穴定位在《内经》中已经有不同的记载,《灵枢·背腧》载:“肝腧在九焦之间,皆夹脊相去三寸所。”而按《素问·血气形志》草度折量法计算,肝俞在第9椎下左侧,横向去脊中2寸。《明堂经》定位:“在第九椎下两旁各一寸五分。”《医心方》所引古代医书中肝俞穴的定位更为复杂,其引《华佗针灸经》:“第八椎名肝俞,又云胃俞,夹脊相去一寸。”引《龙衔素针经》:“肝俞,第七椎相去三寸。”引《金腾灸经》:“下头正中央名为肝俞。”秦汉时期肝俞的纵向定位,有第7椎下、第8椎下、第9椎下的差异;肝俞的横向定位,有第9椎下左侧(2寸)、脊正中央(第9椎棘突正下方)、旁开各1.5寸、旁开各2寸的差异。肝俞穴主治病症主要见于《明堂经》,涉及肝脏、肝经以及筋(肝在体合筋)、目(肝在窍为目)的病症,明显有脏腑辨证的特点,是对先秦两汉涉及肝俞穴主治的集合。肝俞在脊正中央(椎骨棘突正下方)的这种定位方法,失去了取穴的灵活性,第9椎下是督脉筋缩穴所在的位置,筋缩穴出自《明堂经》,《千金方》记载:“筋缩,在第九椎下,筋间。”因此孙思邈《千金方》为肝俞定位“一云:在椎节中”时,应该已经知道此处存在筋缩穴,故不属于低级失误,肝主筋,筋缩穴主治“小儿惊痫,瘕疝,狂走,癫疾,脊急强”,而肝俞主治“……目上视,目中循循然,惊狂……癫狂……筋急而痛反折”,两穴主治病症之间有极大的相似性,可能古代医家将第9椎棘突下以及旁开

^[1] [汉]佚名撰;黄龙祥辑校,王雪苔审订.黄帝明堂经辑校[M].北京:中国医药科技出版社,1987:31.

2 寸范围内的治疗点，皆命名为肝俞。胆俞载于《内经》，《素问·奇病论》：“胆瘕……治以胆募俞。”《明堂经》定位为“第十一椎下两旁各一寸五分”，主治病症为“胸满，呕无所出，口苦舌干，饮食不下”，这些症状也多见于《内经》对胆病的描述，如《灵枢·四时气》：“胆液泄则口苦……故曰呕胆。”《灵枢·邪气脏腑病形》：“胆病者，善太息，口苦，呕宿汁，心下澹澹，恐人将捕之，啞中咢咢然，数唾。”

三焦俞、小肠俞、膀胱俞、中膂俞、白环俞、上髎、次髎、中髎、下髎、会阳、承扶、浮郄，以及足太阳脉第二侧线上的腧穴（除譙譙外）在传世文献中均首见于《明堂经》，定位与后世文献差异不大，值得注意的是，其主治多为局部病变，并有拼凑文献的嫌疑，如小肠俞穴在《明堂经》中主治病症可以分为两个症状群组，其中“主少腹痛热控辜引腰脊，疝痛，上冲心”又见于《灵枢·四时气》。这些腧穴主治条文中也有相互抄引者（或者是出于古代同一个针灸方），如白环俞在《明堂经》中的主治病症似乎与膀胱俞来源于秦汉时期同一个针灸方。上髎、次髎、中髎、下髎在《内经》中称作“八髎”，《素问·骨空论》论述了主治及定位：“腰痛不可以转摇，急引阴卵，刺八髎与痛上，八髎在腰尻分间。”至《明堂经》，“八髎”演化为四穴，这四个腧穴均可以治疗腰部病症，除此之外，还可以治疗妇科病、前阴病等。其实，《内经》所谓“八髎”，左右各有四穴，应该已经存在“上、次、中、下”这样不同的腧穴名称。

表 19 先秦两汉时期八髎穴主治病症演变

出处	《内经》	《明堂经》			
	八髎	上髎	次髎	中髎	下髎
定位	腰尻分间	在第一空腰髁下一寸，侠脊陷者中	在第二空侠脊陷者中	在第三空侠脊陷者中	在第四空侠脊陷者中
	腰痛……急引阴卵。 《素问·骨空论》 腰痛……不可以仰。 主治 《素问·刺腰痛》	腰脊痛而清，善伛，辜跳寡。	腰痛快快不可以俛仰，腰以下至足不仁，脊腰背寒。	腰痛，大便难，飧泄，腰尻中寒，小肠胀。	腰痛不可反侧，尻膂中痛，肠鸣澀泄。
		女子绝子，阴挺出，不禁白沥。	女子赤白沥，心下积胀。	女子赤淫时白，气瘕，月事少，男子瘕。	女子下苍汁不禁，赤沥，阴中痒，痛引少腹控眇不可俯仰。

諛諛穴首载于《素问·骨空论》，主要灸治“大风汗出”，“大风”本指比较强烈的自然气候，如《管子·七臣七主》：“大风漂屋折树。”^[1]代指邪气侵袭，该穴定位仅提及横向定位为“背下侠脊傍三寸所”，未提及纵向定位，取穴法也比较特殊“压之令病者呼諛諛，諛諛应手”，“压”意为“压”，如《汉书·五行志》：“地震陇西，压四百余家。”“諛”通“噫”，作为叹词，如《论语》载颜渊死后，孔子叹道：“噫！天丧予！天丧予！”^[2]“諛”字《说文》解释为“痛也”^[3]，故“諛諛”就是按压背俞穴反应点时，患者因疼痛而发出的声音（或叹息或哀嚎），此方法实为秦汉医家在背部寻按压痛点，《明堂经》确定该穴位置为“夹第六椎下两旁各三寸”。除《内经》所载病症外，諛諛穴在《明堂经》中还治疗胸肺部病症。殷门、合阳、承筋、承山首见于《明堂经》，主治病症集中在腰腿局部。其中殷门穴定位“在肉郤下六寸”，“肉郤”为承扶穴的别名，殷门穴在《素问·刺腰痛》中称之为“衡络之脉”，病变主要原因是“举重伤腰”，症状为“腰痛，不可以俯仰，仰则恐仆”，这一主治被《明堂经》全文收录。可见殷门穴也是由古脉名演化而来。飞扬穴在《内经》属于足太阳络脉，因此飞扬既是络脉名，又是腧穴名，《灵枢·经脉》中载其病变分虚实两端“实则鼽窒头背痛，虚则鼽衄”，主要治疗头面部病症，而《明堂经》主治病症除头面病症外，还包括腰腿、前后阴病症。

仆参穴首见于《明堂经》，定位为“跟骨下陷中”，取穴方法要求“拱足取之”，是“足太阳、阳蹻脉所会”，主治除下肢局部病症外，还可治疗“癫疾”“尸厥”“痢”，故又有别名“安邪”。金门穴主治与仆参穴类似：“主尸厥暴死，霍乱转筋，癫疾，小儿马痢。”笔者认为秦汉时期医家可能习惯两穴同用，老官山竹方简《刺数》中载有：“转筋，足巨阳落各五。”结合老官山漆人体表足太阳脉循行走向（仆参穴刚好位于足跟部两脉交叉处），黄龙祥先生认为“足巨阳落”就是后世的仆参穴，观《明堂经》载仆参穴主治病症中有“转筋”，与《刺数》主治正相合。

申脉穴位于阳蹻脉的起始部位，《素问·气穴论》提及“阴阳蹻四穴”，王冰认为“阳蹻穴是谓申脉”，《明堂经》定位于“足外踝下陷者中”，值得注意的是《明堂经》对金门穴的定位也是“足外踝下”，与申脉穴“足外踝下陷中”重出，若非

^[1] [春秋]管仲. 管子[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2015: 347.

^[2] [春秋]孔子及其弟子撰; 杨伯峻译注. 论语译注[M]. 北京: 中华书局, 2015: 164.

^[3] [汉]许慎. 说文解字[M]. 北京: 中华书局, 2015: 49.

《明堂经》编者失误，则说明秦汉时期对腧穴定位认识还不够统一。《素问·缪刺论》载阳蹻脉病变主要表现为“目痛从内眦始”，治疗部位在“外踝之下半寸”，正是申脉穴所在，《灵枢·寒热病》载蹻脉病变的主要症状为“阳气盛则瞑目，阴气盛则瞑目”，可见，《内经》认为蹻脉病变多与“目”相关，申脉穴是阳蹻脉所生，故用来治疗目病。《明堂经》申脉穴主治病症明显是由三个针灸方组成，其中“癫狂互引，僵仆，申脉主之，先取阴蹻，后取京骨”是一条完整的针灸方。《明堂经》申脉穴主治与目病无关，应该是秦汉时期医家临床经验的总结，申脉穴虽属于阳蹻，但与目相距较远，临床主治目病关联性也不是很强，反而治疗腰腿痛效果较好，故主治病症也随之转变，后世医籍如《千金要方》灸阳蹻主要治疗“劳冷气逆，腰髀冷痹，脚屈伸难”，可见腰腿病症是申脉穴的适应症。至阴、足通谷、束骨分别属于本经井穴、荣穴和输穴。首见于《灵枢·本输》，主治病症集中载于《明堂经》，多为头项部病症。

《足臂》《阴阳》足太阳脉未记载腧穴。老官山漆人足太阳脉双穴 12 个^[1]。老官山漆人足太阳脉腧穴后世归经演变：京骨、昆仑、天柱分别属于足太阳脉“所溜、所注、所入”（《灵枢·根结》）的部位，在《内经》中有明确的归经，委中、委阳（《灵枢·本输》）也明确归属于本经。天牖穴在《内经》中的归经并不明确，《灵枢·本输》归于手少阳，而《灵枢·寒热病》归于足少阳，《明堂经》归经为“手少阳脉气所发”，然老官山漆人天牖穴大致位于足太阳脉的循行路线上，可见早期腧穴的归经情况并不明确，提示存在“经穴分离”的可能性。老官山漆人背部足太阳脉第一侧线上分布有肺俞、膈俞、脾俞、胃俞、肾俞、大肠俞、膀胱俞等背俞穴，说明对背俞穴归于足太阳脉的认识较为清晰，然而在《内经》《明堂经》中对背俞穴的归经并不是很明确，《灵枢·背腧》载：“五脏之俞，出于背者……”提示背俞穴其实与脏腑直接相关，此外也有可能秦汉时期背俞穴与足太阳脉的归属关系较为流行，为医家所熟知，无需著之于书。老官山漆人足太阳脉所涉及的背俞穴，在传世文献中直至《外台》《铜人》中，才有“足太阳脉气所发”的记载；跗阳穴在《明堂经》中归属于阳蹻脉；“近跟平穴”这一疑似腧穴点，早期文献并无相关记载，故归经演变不明。

^[1] 张乙小. 成都老官山汉墓经穴髹漆人像足三阳脉腧穴考证研究[D]. 成都中医药大学, 2020.

《内经》委中、昆仑、京骨、束骨、足通谷、至阴归属于足太阳脉；攒竹（眉本）、天柱为“足太阳脉气所发”；委阳为“太阳络”；飞阳为“足太阳之别”。

《明堂经》委中、昆仑、京骨、束骨、足通谷、至阴归属于足太阳脉；睛明为“手足太阳、足阳明之会”；攒竹、曲差、五处、承光、通天、络却、玉枕、天柱、胆俞、三焦俞、白环俞、魄户、神堂、諛諛、膈关、魂门、阳纲、意舍、胃仓、盲门、志室、胞肓、秩边、承筋属于“足太阳脉气所发”；大抒为“足太阳、手少阳之会”；风门为“督脉、足太阳之会”；上髂为“足太阳、少阳之络”；中髂、下髂为“太阴、厥阴、少阴所结”；会阳为“督脉气所发”；委阳为“足太阳之别络”；附分为“手足太阳之会”；飞阳为“足太阳络，别走少阴者”；仆参为“足太阳、阳蹻所会”；申脉为“阳蹻之所生”；金门为“足太阳郄”；跗阳为“阳蹻之郄”；脏腑背俞穴除胆俞外，未提及经脉归属。

4.2 足少阳脉腧穴

4.2.1 老官山漆人足少阳脉腧穴演变梳理

老官山漆人足少阳脉体表循行路线上，一共刻画有 10 个疑似腧穴点，包括 4 个双穴，以及左右各 1 个单穴，左侧单穴位于侧腹部，右侧单穴位于大腿外侧面，故躯干分布 3 个疑似腧穴点，下肢分布 7 个疑似腧穴点，图 30 示老官山漆人右侧（除去上肢）足少阳脉腧穴分布情况。

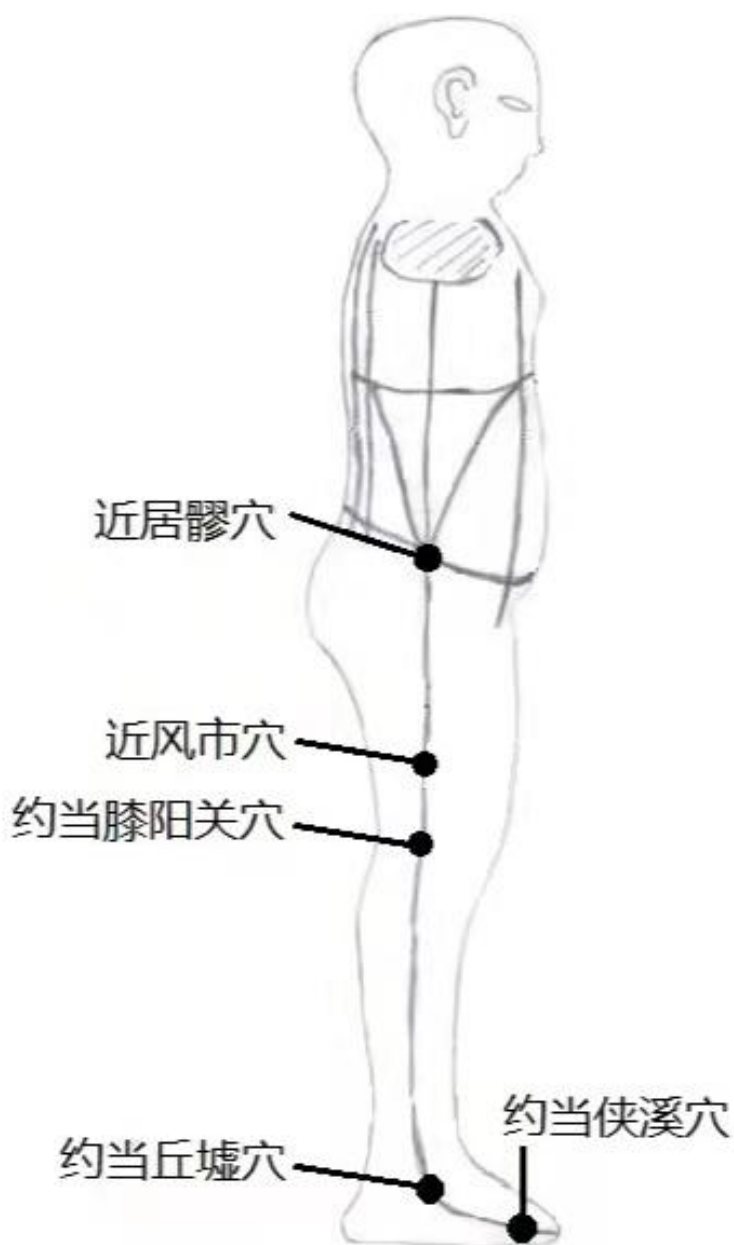


图 30 老官山漆人足少阳脉腧穴分布示意图（右侧）

老官山漆人足少阳脉于左侧腹部，脐水平线上约 1.5 寸刻有一处疑似腧穴点，整理人员认为与传世文献中章门穴位置相近，故命名为“近章门穴”，章门穴的定位及主治见于《明堂经》，其定位“在大横外，直脐季肋端”，经脉归属于“足厥阴、少阳之会”，“季肋”是章门穴的早期名称，见于《内经》，既指部位，又指治疗刺激点，如《素问·长刺节论》中“病在少腹有积……刺两髂季肋肋间”是作为针刺治疗点，作为具体部位，与足少阳经脉、经别、经筋的循行相关，《难经·四十五难》中“脏会季肋”也是作为部位名。归经方面，《内经》将季肋与足少阳脉相连，宋以后章门穴则归入足厥阴脉（《铜人腧穴针灸图经》），后世医籍多从《铜人》之说。章门穴主治病症在《明堂经》集中于胸胁胃肠，如“肠鸣”“肋痛”“喘息”“心痛”以及腰部病变“腰痛不得转侧”等。《明堂经》脾俞穴主治病症中有“腹中气胀引脊痛，饮食多，身羸瘦，名曰食晦，先取脾俞，后取季肋”，可见脾俞和季肋是作为针灸方中的配合选穴，故两穴主治中均有“食晦”相关症状。

老官山漆人双侧足少阳脉，靠近髋关节，于腋中线上刻有一处疑似腧穴点，整理人员认为与居髎穴位置相近，故称“近居髎穴”，《明堂经》定位为“在长平下八寸三分，监骨上陷中”，此处“监骨”指髂骨^[1]，其主治较为简单：“主腰痛引少腹。”经脉归属于“阳蹻、足少阳之会”。后世医籍主治中也多集中在腰腿病症，如《窦太师针经》与环跳穴同治：“腿疼，脚叉风，腰弱无力，半身不遂。”^[2]

老官山漆人右下肢股外侧，位于足少阳脉上，当右上肢自然下垂时，中指尖到处刻有一处疑似腧穴点，整理人员认为与风市穴相近，故命名为“近风市穴”。风市穴在先秦两汉医籍中未载，传世文献中最早见于《肘后备急方》，主要用于治疗“脚气”，治疗量为“灸风市百壮”，“脚气病”在古代的源流演变较为复杂，《肘后备急方》对该病描述为^[3]：“脚气之病，先起岭南，稍来江东，得之无渐。或微觉疼痛，或两胫小满，或行起忽弱，或小腹不仁，或时冷时热，其候也。不即治，转上入腹，便发气上，则杀人。”廖育群先生认为晋唐时期“脚气病”的出现，与当时习惯服用丹药石散有关，重金属铅、砷、汞中毒，引发“多发性神经炎”^[4]，所谓“便发气上，则杀人”是急性药物中毒肾衰竭与风湿热并发性心脏病导致的

[1] 田凯文,李顺保,柳直.新编古今骨学名词对照表[J].西部中医药,2018,31(06):61-64.

[2] 黄龙祥,黄幼民整理.元代珍稀针灸三种[M].北京:人民卫生出版社,2008:92.

[3] [晋]葛洪.补辑肘后方[M].合肥:安徽科学技术出版社,1996:95.

[4] 廖育群.关于中国古代的脚气病及其历史的研究[J].自然科学史研究,2000,(03):206-221.

充血性心脏衰竭^[1]，也有学者认为与当时稻米加工技术的进步有关^[2]。

老官山漆人膝关节外双侧足少阳脉上，横平腓窝处刻有一处疑似腧穴点，整理人员认为与后世膝阳关穴位置大致相当，命名为“约当膝阳关穴”，膝阳关穴在《内经》中称为“寒府”，王冰释为“寒气喜中，故名寒府也”，《素问·骨空论》用以治疗“鼠瘻，寒热”，而后《明堂经》称此处为“阳关”，意为阳气之关隘，定位为“阳陵泉上三寸，犊鼻外陷中”，后世医籍多从此说。该穴治疗病症简单，主要是下肢疾患，如《明堂经》：“主膝外廉痛，不可屈伸，胫痹不仁。”

老官山漆人双侧踝区足少阳脉上，位于外踝前上方刻有一处疑似腧穴点，整理人员认为与丘墟穴位置大致相当，故称“约当丘墟穴”。丘墟穴的定位《灵枢·本输》载“外踝之前下，陷者中也”，《明堂经》增“去临泣三寸”，丘墟穴的主治病症也集中在《明堂经》中，主要治疗目病如“目视不明，目翳，瞳子不见”，胸胁病如“胸胁痛，善太息，胸满膨膨然”以及运动系统障碍等。

老官山漆人足背双侧足少阳脉上，约当足4、5趾之间刻有一处疑似腧穴点，整理人员认为与后世侠溪穴位置相近，命名为“约当侠溪穴”，该穴传世文献中最早见于《内经》，《灵枢·本输》定位为“足小指次指之间”，《明堂经》定位与《内经》相同：“在足小指次指岐骨间，本节前陷者中。”侠溪穴主治最早见于《内经》，以“足小指次指间”代指该穴，如《素问·骨空论》：“灸寒热之法，先灸项大椎……足小指次指间灸之。”《明堂经》对侠溪穴主治有集中记载，其中“胸胁支满”“多汗”在《内经》中属于“足小指次指爪甲上”（即足窍阴穴）的主治。

4.2.2 足少阳脉其余腧穴演变梳理

瞳子髎首见于《明堂经》，称为“瞳子窠”，其定位“在目外去眦五分”，直至宋代《铜人》将其归属于足少阳脉，主治眼部疾患：“青盲无所见，远视，目中淫肤白膜。”听会穴也首见于《明堂经》，定位“在耳前陷者中”，取穴要求“张口得之，动脉应手”，此处动脉为面动脉，属“手少阳脉气所发”，宋代《铜人》将其归属于足少阳脉。主治可分为两组，一组是耳目病症如“聋”“耳中颠颞颠颞者若风”，另一组是癫狂病病症如“狂，惊，癡疾，眩仆，瘖不能言，羊鸣吐沫”。

上关《内经》又称为“客主人”（《素问·气府论》），《素问·气穴论》载“上

^[1] 李浩. 晋唐“脚气”考[J]. 广东技术师范学院学报, 2014, 35(12): 44-49.

^[2] 彭卫. 脚气病、性病、天花: 汉代疑问疾病的考察[J]. 浙江学刊, 2015(02): 54-70.

关二穴”，但“客主人”有时也作为部位名，如《灵枢·经脉》：“三焦手少阳之脉……过客主人前……”《灵枢·动输》：“胃气上注于肺……下客主人……”等，该穴主治见于《灵枢·口问》：“耳鸣……补客主人。”《明堂经》主治以五官病为主。

《灵枢·杂病》：“颌痛，刺足阳明曲周动脉见血，立已。”此处“曲周动脉”即古代“颞颥”这一部位，为耳前动脉，此处演化为颌厌、悬颅、悬厘三穴，均载于《明堂经》中，这也是古代诊脉刺脉处演化为一个或多个腧穴的典型^[1]。曲鬓、率谷、天冲、浮白、头窍阴均首见于《明堂经》，主治头面部病症。完骨在《灵枢》中用作骨名，如《灵枢·本输》：“上加完骨之上。”《灵枢·经别》：“结于耳后完骨。”然《素问·气穴论》载有“完骨两穴”，提示随着针灸经验的积累，便将此处治疗刺激点命名为“完骨”，用作腧穴名。故完骨穴是一个典型的从部位名（骨名）演化而来的腧穴名，《明堂经》中主治头项、口齿病症。本神、阳白、头临泣、目窗、正营、承灵、脑空均首见于《明堂经》，主治也多为头面五官病症。

风池穴最早载于《灵枢·热病》：“所谓五十九刺……风池二。”在《伤寒论》中用于外感病的加强治疗：“太阳病，初服桂枝汤，反烦不解者，先刺风池、风府，却与桂枝汤则愈。”^[2]《明堂经》主治病症集中在目、耳、鼻部，风池、天柱等后头部腧穴反映头枕部与眼、鼻之间有关联。肩井、渊腋、辄筋、日月、京门首见于《明堂经》，主治胸胁局部病症。带脉在《内经》中用作脉名，如《灵枢·癫狂》：“脉癫疾者，暴仆……灸带脉于腰相去三寸。”《素问·痿论》：“带脉不引，故足痿不用也。”《明堂经》确定为腧穴名，定位于“季肋下一寸八分”，主治妇科病证“少腹坚痛，月水不通”。五枢、维道、居髎、环跳、中渎均出自《明堂经》，主治病症为局部病症。阳陵泉穴是本经合穴，《灵枢·本输》定位为“在膝外陷者中”，《明堂经》定位为“膝下一寸外廉陷者中”，《内经》主要用来治疗胆腑的病变，如《灵枢·邪气脏腑病形》取阳陵泉治疗“善太息，口苦，呕宿汁，心下澹澹，恐人将捕之，嗌中呿呿然，数唾”，《素问·奇病论》取阳陵泉治疗“胆痺”，在《素问·咳论》中也记载：“胆咳之状，咳呕胆汁，治府者治其合。”均为《明堂经》阳陵泉主治病症所承载。阳交、外丘首见于《明堂经》，主治神志、局部病症。

光明在《灵枢·经脉》中作为足少阳络脉名，该脉病变时可出现虚实病症“实

^[1] 黄龙祥,黄幼民. 针灸腧穴通考:《中华针灸穴典》研究. 第一版[M]. 北京:人民卫生出版社,2011:992-1003.

^[2] [汉]张仲景撰;[金]成无己注. 注解伤寒论[M]. 北京:人民卫生出版社,2012:58.

则厥，虚则痿躄”，《明堂经》固定为腧穴名，定位为“外踝上七寸”，《明堂经》光明穴主治病症几乎均见于《内经》相关条文，如下表所示：

表 20 《内经》《明堂经》光明穴主治条文对比

《内经》	《明堂经》
足少阳之疟，令人身体懈惰，寒不甚，热不甚，恶见人，见人心惕惕然，热多汗出甚，刺足少阳。《素问·刺疟》	主身懈惰，寒，少气，热甚，恶人，心惕惕然，取光明及绝骨、附上临泣立已。
淫泆胫酸，不能久立，治少阳之维，在外上五寸。《素问·骨空论》	淫泆胫酸
实则厥，虚则痿躄，坐不能起。《灵枢·经脉》	虚则痿躄，坐不能起，实则厥。

阳辅穴定位首见于《灵枢·本输》，定位为“外踝之上，辅骨之前，及绝骨之端”，在《素问·刺腰痛》中又称为“同阴之脉”，黄龙祥先生认为：“隋唐时期，将外踝上三四寸小骨头绝陷中定为‘绝骨’。”该穴又是本经经气所注之处，《明堂经》定位与《内经》相同，又增以丘墟穴作为定位参考“去丘墟七寸”，《明堂经》主治病症中“痛如小锤居其中，怫然肿痛”，也见于同阴之脉的病变症状，故“同阴之脉”可能是阳辅穴的早期腧穴名。

悬钟《明堂经》定位为“在足外踝上三寸动者中”，“动者中”是指此处有胫前动脉搏动，具体取穴要求“按之阳明脉绝乃取之”，是指压迫悬钟穴下的胫前动脉时，远心端的阳明脉（即冲阳穴处的足背动脉）则不能触及搏动，这种二重定位法，说明秦汉时期医家对于部分腧穴的准确定位比较重视，腧穴选穴方法的逐步完善，是秦汉针灸理论体系的一个特点，也是必然的发展趋势。

足临泣为本经“所注为输”，《灵枢·本输》称之为“临泣”，定位为“上行一寸半陷者中也”，是以“足小趾次趾之间”的侠溪穴为定位参考，《明堂经》进一步明确其定位为“足小指次指本节后间陷者中，去侠溪一寸五分”，《明堂经》本穴主治病症包括足少阳脉典型病症如“胸中满，腋肿，马刀瘰”“目外眦痛”“季胁下支满”等，还见妇科病证如“月水不利”等。地五会首载于《明堂经》，其定位“在足小指次指本节后陷中”，主治“内伤唾血不足，外无膏泽”，明显是由足少阳脉“是动病”移植而来。地五会夹于荣穴侠溪与输穴足临泣之间，秦汉时期应属晚出，故临床经验积累不多，表现为主治病症较少，且多为经脉病候直接移植。足窍阴在《灵枢·本输》中称之为“窍阴”，定位于“足小指次指之端”，《明

《明堂经》增“去爪甲如韭叶”，主治病症由三组症候群构成，其中“主胁痛，咳逆不得息”见于《素问·缪刺论》，而“喉痹，舌卷，口干，臂内廉痛不可及头，耳聋鸣”属《内经》中关冲穴（手中指次指爪甲）主治，笔者认为这种编排方式，或是《明堂经》编者误入此处，或是想要体现手足同治思想。

《足臂》《阴阳》足少阳脉未记载腧穴。老官山漆人体表载有双穴4个，单穴2个，这些疑似腧穴点在传世文献中的归经记载并不一致：《内经》将章门穴称为“季胁”归属于足少阳脉，但在《明堂经》中则归于“足厥阴、少阳之会”；居髎在《明堂经》为“阳蹻、足少阳之会”；风市穴在先秦两汉医籍中未记载；膝阳关穴在秦汉医籍中未明确其归经；丘墟、侠溪两穴，《内经》已明言归于足少阳脉。

《内经》阳陵泉、阳辅、丘墟、足临泣、侠溪、窍阴归属于足少阳脉；上关（客主人）为“足少阳脉气所发”，但与手少阳、足阳明循行均有联系；环跳（髀枢中）为“足少阳脉气所发”；光明为“足少阳之别”。

《明堂经》阳陵泉、阳辅、丘墟、足临泣、侠溪、窍阴归属于足少阳脉；瞳子髎为“手太阳、手足少阳之会”；听会为“手少阳脉气所发”；上关为“手少阳、足阳明之会”；颌厌、悬厘为“手足少阳、足阳明之会”；悬颅、辄筋、环跳、中渚为“足少阳脉气所发”；曲鬓、率谷、天冲、浮白、完骨为“足太阳、少阳之会”；头窍阴、本神、阳白、目窗、正营、承灵、脑空、风池为“足少阳、阳维之会”；头临泣为“足太阳、少阳、阳维之会”；肩井为“手足少阳、阳维之会”；日月为“足太阴、少阳之会”；维道为“足少阳、带脉之会”；居髎为“阳蹻、足少阳之会”；阳交为“阳维之郄”；外丘为“足少阳郄，少阳所生”；光明为“足少阳络”；悬钟为“足三阳络”；渊腋、京门、带脉、五枢、膝阳关、地五会未言经脉归属。

4.3 足阳明脉腧穴

4.3.1 老官山漆人足阳明脉腧穴演变梳理

老官山漆人足阳明脉共有 10 个疑似腧穴点，躯干部有 4 个疑似腧穴点，位于腹部脐水平线以下，下肢分布有 6 个疑似腧穴点，如图 31 所示。

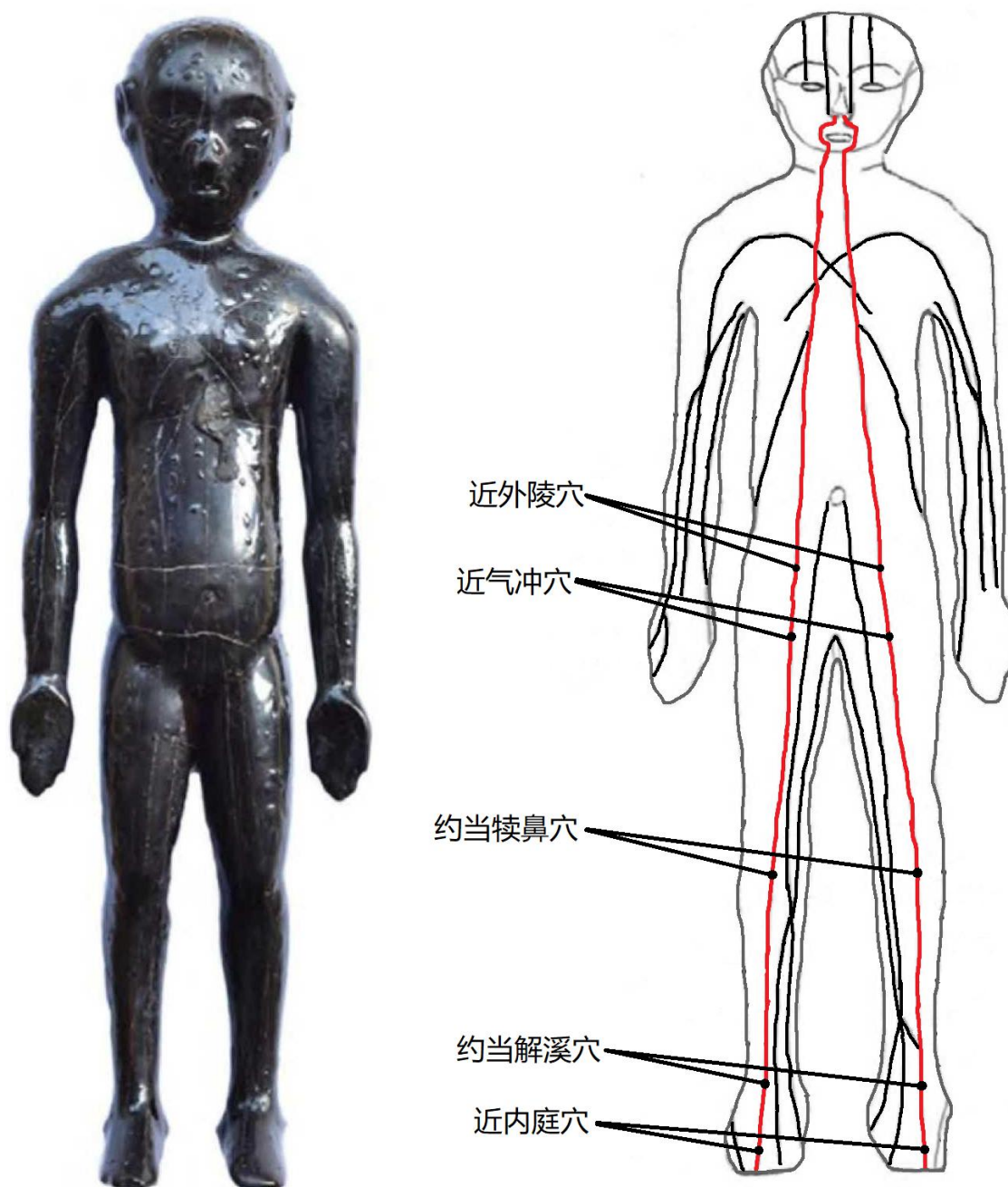


图 31 老官山漆人足阳明脉腧穴分布示意图

老官山漆人双侧腹股沟区，锁骨中线内侧，脐水平线下 1.5 寸，位于足阳明脉上有一处疑似腧穴点，整理人员认为与后世“外陵穴”位置相当，命名为“近外陵穴”，外陵穴在传世文献中出自《明堂经》，经黄龙祥先生考证，此穴具体定位在《明堂经》佚文中已经有三种不同的表述方式，当以《甲乙经》《千金翼方》《医心方》的定位“在天枢下，大巨上”更为贴近原文，《明堂经》主治“腹中尽痛”，后世医籍未出腹部疾患范围。

老官山漆人双侧腹股沟区，“近外陵穴”直下，约脐水平线下 4 寸，左右侧各有一处疑似腧穴点，整理人员认为与后世“气冲穴”位置相近，故命名为“近气冲穴”，气冲穴在《内经》中称为“气街”，此处有髂外动脉通过，深按可明显感觉到动脉搏动，早期医家认为脉之搏动是气行于内所致，因此，气街所在位置又与冲脉密切相关，如《素问·骨空论》《灵枢·逆顺肥瘦》《灵枢·动输》均提到冲脉与气街之间的关系，或是“出于气街”，或是“起于气街”。“气街”可作为“气行的通道”，也作为一个重要的治疗刺激点，如《灵枢·杂病》中针刺用以治疗“腹痛”，《灵枢·卫气失常》：“积于下者，泻三里与气街。”《素问·水热穴论》选取气街、三里、巨虚上下廉用以泻“胃中热”，由于此处有髂外动脉，刺之过深容易出现刺破动脉的情况，《内经》中已有记载，如《素问·刺禁论》：“刺气街中脉，血不出为肿，鼠仆。”指出皮下出血后肿胀之处类似老鼠仆伏于此一般^[1]。《明堂经》对气冲穴主治的记载，采集自多首治疗疝病的针灸方，体现局部选穴的特点，如“痿，茎中痛，两丸蹇，痛不可仰卧”均为“阴疝”的具体症状，因此《明堂经》气冲穴的主治，可以总结为腹部、男科、妇科病。

老官山漆人双下肢膝关节前方，髌骨外侧凹陷中，位于足阳明脉上有一处疑似腧穴点，整理人员认为与“犊鼻穴”相当，故命名为“约当犊鼻穴”，犊鼻穴在《内经》中已有记载，《灵枢·本输》：“刺犊鼻者，屈不能伸。”指出针刺犊鼻穴时膝关节应该处于后屈状态。此外在《灵枢·杂病》中指出犊鼻穴的主治为“膝中痛”，并且对针刺用具也提出要求：“以员利针，发而间之，针大如牦，刺膝无疑。”犊鼻穴的现代定位是“在膝前区，髌韧带外侧凹陷中”^[2]，《内经》中并未记

^[1] 王振国. 鼠仆、鼠仆考辨[J]. 中华医史杂志, 2001(01): 31-33.

^[2] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会发布. 腧穴名称与定位[M]. 北京: 中国标准出版社, 2006: 12.

载犊鼻穴的具体定位,《明堂经》定位为“在膝髌下,胫上夹解大筋中”,明确指出“犊鼻穴”的位置在“大筋中”,《医心方》卷二引《小品方》云:“膝内外目,一膝有两穴,各在犊鼻两旁陷者中,如猴孙眼者是也。”^[1]“膝内外目”即内膝眼与外膝眼。可见,早期医家认为犊鼻穴在“大筋中”,而内外膝眼位于“大筋旁”。实际上这一认识一直持续到宋元时期,《窦太师针经》:“膝眼两穴,在膝盖骨下,犊鼻穴外旁陷中。横针透膝眼穴,治疗膝肿疼,泻。灸二七壮。”明清时期则将犊鼻穴与外膝眼相混,如《医学入门》称犊鼻穴定位“在膝头眼外侧大筋陷中”。笔者观察老官山漆人犊鼻穴的位置,正位于髌骨下方的髌韧带中央,即《明堂经》所言“大筋中”。该穴主治病症在《灵枢·杂病》中已经明言“膝中痛”,后世医籍也主要以膝关节病变为主,如《明堂经》载该穴主治病症:“主犊鼻肿,可灸,不可刺,其上坚勿攻,攻之者死。膝中痛不仁,难跪起。”

老官山漆人踝关节前方双侧足阳明脉上,大致位于内、外踝连线中点处刻有一对疑似腧穴点,整理人员认为与“解溪穴”位置大致相当,故命名为“约当解溪穴”。解溪穴在《灵枢·本输》中以冲阳穴作为定位标准“上冲阳一寸半陷者中”,后世医家从之,如《明堂经》定位为“在冲阳后一寸五分,腕上陷者中”,《内经》未载解溪穴主治病症,《明堂经》该穴主治病症较广,包括足阳明脉典型病症如“腹胀满”“谵语”“狂易,见鬼与火”“颜黑”“癫疾”等,还见头面五官病症如“风水面浮肿”“头眩痛”“面目赤,口痛,啮舌”,以及局部病症“足大指搏伤”等。

老官山漆人足背第2、3足趾间,足阳明脉上刻有一点,整理人员认为与“内庭穴”位置相近,故命名为“近内庭穴”,内庭穴《灵枢·本输》定位为“次指外间”,成为后世文献对内庭穴定位的参考,如《明堂经》定位为“足大指次指外间陷者中”,内庭穴主治病症集中见于《明堂经》^[2],包括足阳明脉的典型病症“腹胀”“善伸数欠”“恶人与木音”“热病汗不出”等,以及头目病如“下齿痛”“目急”“𪔐^[3]口噤僻”等。

4.3.2 足阳明脉其余腧穴演变梳理

承泣穴在《内经》中称为“目下”,《素问·气府论》:“目下各一。”唐代王冰

^[1] [日]丹波康赖.医心方[M].北京:华夏出版社,2011:60.

^[2] [汉]佚名撰;黄龙祥辑校,王雪苔审订.黄帝明堂经辑校[M].北京:中国医药科技出版社,1987:205.

^[3] 古同“龈”,《说文解字》:“𪔐,齿本也。”

注为：“谓承泣二穴也。”“承泣”用作腧穴名首见于《明堂经》，定位于“目下七分，直目瞳子”，主治病症也主要是眼目疾患，体现腧穴的近治作用。四白穴在《内经》中称之为“面髑骨空”，《素问·气府论》：“面髑骨空各一。”唐代王冰注为：“谓四白穴也。”“四白”在《内经》中用作部位名，见于《素问·六节藏象论》：“仓廩之本……其华在唇四白。”这里“唇四白”指的是“唇四际之白色肉也”（王冰注）。“四白”用作穴名首见于《明堂经》，定位于“目下一寸”，主治病症也主要是目疾：“主目痛，口僻，泪出，目不明。”

巨髑与地仓均首见于《明堂经》，其定位与后世无异，均可主治口面部疾病，值得一提的是，地仓穴在《明堂经》中主治病症为：“口缓不收，不能言语，手足痿痹不能行。”笔者认为这一症状群组类似中风后遗症的临床表现，而地仓穴则是针对“口缓不收，不能言语”的一个配穴，黄龙祥先生认为完整的针灸方中，应该还有针对“手足痿痹不能行”的配穴，推测可能会选取四肢局部腧穴，表明秦汉时期针灸医家临床实践时依病症部位进行选取配穴的特点。

大迎穴首见于《素问·气府论》：“大迎骨空各一。”又《素问·骨空论》：“或骨空在口下当两肩。”大迎穴在秦汉早期，既是脉名（面动脉），又是腧穴名。《明堂经》定位为“曲颌前一寸二分骨陷者中动脉”，其主治病症，《灵枢·寒热病》载“臂阳明有入髑遍齿者，名曰大迎，下齿龋取之”，“臂阳明”指手阳明脉，又《素问·气府论》：“手阳明脉气所发……大迎骨空各一痛。”而《素问·气府论》：“足阳明脉气所发者六十八穴……大迎之骨空各一。”可见《内经》本身对大迎穴归经也不明确，《明堂经》称为“足阳明脉气所发”，可知在秦汉后期，大迎穴方确定归属于足阳明脉，《明堂经》该穴主治面口部病症，如“口喎”“口噤”“口僻”“口不收”“下牙痛”“颊肿”“舌不能言”等，此外，主治病症中“癰疾互引”“瘰”“厥”应伴见口面症状才选取本穴。《素问·三部九候论》：“上部地，两颊之动脉，以候口齿之气。”老官山医简《刺数》中提到的“颊阳明”，应该是大迎穴的古称，即《刺数》：“血龋：龋在上，两耳前少阳；在下，颊阳明各五。”

颊车穴在《内经》中既作为部位名，又作为腧穴名，作为部位名见于《灵枢·经脉》，如“胃足阳明之脉……循颊车……”“胆足少阳之脉……下加颊车……”，指的是下颌骨（古称颊车、曲牙、牙车等），作为腧穴名，见于《素问·气穴论》：“曲

牙二穴。”《灵枢·经筋》：“手少阳之筋……上曲牙。”《素问·气府论》：“耳下牙车之后各一。”《明堂经》定位为“耳下曲颊端陷者中”，主治病症主要为面口局部病症：“主颊车骨痛，齿不可以嚼，颊肿口急。”老官山医简《刺数》中“风，刺头鉅阳，陕颧各十”中的“陕颧”应该是颊车穴的古称（但黄龙祥先生认为“陕颧”是位于眉心之上的天庭^[1]）。

下关穴《内经》记载较详，《素问·气穴论》：“下关二穴。”《素问·气府论》：“下关各一。”取穴要求也载于《灵枢·本输》：“刺上关者，喆不能欠；刺下关者，欠不能喆。”《明堂经》定位为“在客主人下，耳前动脉下空下廉”。主治病症为五官病变，如“口僻”“下齿齲”“耳聋鸣”等。头维穴首载于《明堂经》，主治病症为可分为两组症候群，第一组症状群“寒热，头痛如破”，承自《素问·疟论》对“疟之始发”的描述，第二组症候群“目痛如脱，喘逆，烦满”属“肺胀”，即《灵枢·胀论》：“肺胀者，虚满而喘。”《金匱要略》：“上气，喘而躁者，属肺胀。”

人迎穴位于颈总动脉搏动处，既作为脉名，又作为腧穴名，秦汉医家对此穴认识较详，《灵枢·本输》：“足阳明也，名曰人迎，足阳明，夹喉之动脉也。”仔细观察老官山漆人足阳明脉在颈部走行路线，当喉两侧，与颈动脉体表投影大致重合。《灵枢·寒热病》：“颈侧之动脉人迎。人迎，足阳明也，在婴筋之前。”“婴筋”即“胸锁乳突肌”，也是《内经》定位颈部诸穴的一个重要的体表标志。人迎脉又是《内经》中一个较为重要的诊脉部位，如《灵枢·四时气》：“持气口人迎以视其脉……气口候阴，人迎候阳也。”《灵枢·寒热病》：“热病三日而气口静、人迎躁者，取之诸阳，五十九刺。”《灵枢·禁服》：“寸口主中，人迎主外，两者相应……”先民已经观察到寸口桡动脉与人迎颈动脉搏动的一致性，人迎、寸口相对比而诊又是《内经》时代较为流行的诊病方法，“人迎”作为腧穴名，也见于《内经》，《素问·气府论》：“足阳明气所发……人迎各一。”并提到主治病症为“阳迎（别本作“逆”）头痛，胸满不得息”（《灵枢·寒热病》）。《明堂经》定位为“在颈大动脉应手，夹结喉旁”，更为准确，不仅依据局部颈动脉搏动，还依据结喉进行横向定位。其主治病症：“主阳逆霍乱头痛，胸满呼吸喘喝，穷咄窘不得息^[2]。”

^[1] 黄龙祥. 老官山出土汉简脉书简解读[J]. 中国针灸, 2018, 38(01): 97-108.

^[2] 《说文解字》：“穷，极也。”《广雅·释诂》：“咄，屈也。”《说文解字》：“窘，仍也。”“穷咄窘不得息”意为弯曲身体仍然难以呼吸，形容呼吸极度困难。

与《灵枢·寒热病》相似，应有传承关系。水突、气舍传世文献首载于《明堂经》，主治病症均为肺、咽喉局部病症。

缺盆在《内经》中多作为部位名，《素问·骨空论》：“其上气有音者，治其喉中央，在缺盆中者。”《灵枢·骨度》：“结喉以下至缺盆中长四寸。”两侧锁骨上窝连同胸骨柄上缘凹陷均为缺盆所在，《内经》时代缺盆穴应用广泛，积累了很多临床经验，如“失枕”（《素问·骨空论》）“胸中热”（《素问·刺热》）等，缺盆处下方就是肺组织（肺尖高出锁骨3cm左右），故针刺不当又容易引发气胸等医疗事故。《素问·刺禁论》载“刺缺盆中内陷，气泄，令人喘咳逆”，其中“喘咳逆”是气胸的典型症状。《明堂经》定位为“肩上横骨陷者中”，主治胸肺部病症以及肩臂活动受限等肢体病症，其中“缺盆中满痛者死，外溃不死”明显是秦汉时期诊断学范畴的文献。《灵枢·五邪》中记载治疗胸肺病症时有“取之缺盆中以越之”一语，笔者认为应断句为“取之缺盆中，以越之”。“越”有“散、扬”之意，如《尔雅·释言》：“越，扬也。”意为缺盆穴可以散肺邪。《明堂经》要求缺盆穴不能“刺太深”，否则“令人逆息”，也说明秦汉医家对缺盆穴应用较为频繁。

气户、库房、屋翳、膺窗、乳中、乳根、不容、承满、梁门、关门、太乙、滑肉门均首见于《明堂经》，主治均为局部病症，其中气户、库房、屋翳、膺窗、乳中、乳根、不容主治胸肺病变，而承满、梁门、关门主治胃肠病变。这些穴位中值得讨论的是：

①乳中穴禁刺，《素问·禁刺论》：“刺乳上，中乳房，为肿，根蚀。”《明堂经》载：“禁不可刺灸。灸刺之，不幸生蚀疮，疮中有脓血清汁者，可治；疮中有息肉若蚀疮者，死。”描述了刺灸之后乳腺组织炎症化脓，以及不同的预后。

②乳根穴主治乳房、胸部病症：“主胸下满痛，膺肿，乳痛，凄索寒热，痛不可按搔。”其中“凄索寒热，痛不可按搔”描述了乳痛（乳腺炎）初起症状。

天枢穴之名见于《内经》，以“天枢”区分天气地气（《素问·六微旨大论》）、身半上下（《素问·至真要大论》），应该是指与脐水平的一条分界线，作为腧穴名称则始于《明堂经》，定位为“去肓俞一寸五分，夹脐两旁各二寸陷者中”，主治胃肠、妇科病症，其中部分主治来源于《内经》，如“腹胀肠鸣，气上冲胸，不能久立”承自《灵枢·四时气》；“肠中切痛而鸣濯濯，冬日重感开寒则泄，当脐而

痛”源于《灵枢·邪气脏腑病形》中“大肠胀”的典型症状。

大巨、水道、归来、髀关、伏兔、阴市、梁丘在传世文献中最早均载于《明堂经》中，主治局部病症，其中大巨、水道、归来主治腹部、前阴病症，髀关、伏兔、阴市、梁丘主治下肢病症。足三里穴详载于《内经》，又称之为“下陵”“下陵三里”“三里”（《素问·针解》），《灵枢·邪气脏腑病形》：“取之三里者，抵跗。”《明堂经》定位：“在膝下三寸，胫外廉。”《内经》中足三里穴应用非常广泛，主治条文多被《明堂经》所收录，如下表所示：

表 21 《内经》《明堂经》足三里穴主治条文对比

《内经》	《明堂经》
洒洒振寒……甚则欲上高而歌。《灵枢·经脉》	悽悽而寒……狂歌妄言。
恶人与火，闻木音则惕然而惊。《素问·阳明脉解》	怒恐……恶人与火。
胃无气，故恶闻食臭也。《素问·脉解篇》	胃无气，故恶闻食臭也。
著痹不去，久寒不已，卒取其三里。《灵枢·四时气》	膝痿寒
厥头痛，面若肿起而烦心，取之足阳明太阴。《灵枢·厥病》	头痛
卫气并脉循分为肤胀，三里而泻。《灵枢·胀论》	皮肿
风痉身反折……取三里。《灵枢·热病》	苦痉，身反折。
喉痹不能言，取足阳明。能言，取手阳明。《灵枢·杂病》	喉痹不能言
喘不能久立……刺盲之原、巨虚上廉、三里。《灵枢·四时气》	不能久立
善呕，呕有苦，长太息……取三里以下胃气逆。《灵枢·四时气》	善噫，善呕，善哕。
乱于肠胃，则为霍乱。《灵枢·五乱》	霍乱
霍乱，刺……足阳明。《素问·通评虚实论》	
小腹痛肿，不得小便……取三里。《灵枢·四时气》	胀满，少腹坚，小腹胀。
邪在脾胃，则病肌肉痛……热中善饥……寒中肠鸣腹痛……有寒有热。皆调于三里。《灵枢·五邪》	腹中寒……肠鸣腹痛……热中，消谷善饥，腹热身烦。
两胁中痛，寒中，恶血在内……补三里以温胃中。《灵枢·五邪》	胸中瘀血，胸骨痞满，鬲痛。
阳明令人腰痛，不可以顾，顾如有见者，善悲，刺阳明于髀前三痛。《素问·刺腰痛》	腰痛不可以顾，顾而有似拔者，善悲，上下取之，出血，见血立已。

上巨虚和下巨虚在《内经》中称为“巨虚上廉”“巨虚下廉”（《灵枢·本输》），《明堂经》所载两穴主治包括《灵枢》所述之“邪在大肠”“大肠病”和足阳明胃经病候，如表 22 所示。条口穴首载于《明堂经》，定位为“下廉上一寸”，主治下肢局部病症：“胫寒不得卧，胫痛，足缓失履，湿痹，足下热，不能久立。”丰隆是本经络脉，故丰隆既是足阳明络脉名，又是腧穴名，老官山《刺数》中提到的“胫阳明”，应该是丰隆穴的古称（黄龙祥先生认为“胫阳明”是足三里穴^[1]），《刺数》：“癫疾，两辟（臂）胫阳明、项钜阳各五”“狂，两臂、两胫阳明各五”“啞

^[1] 黄龙祥. 老官山汉墓出土针方简解读[J]. 中华医史杂志, 2018, 48(2): 18.

痛不可咽，不甚，刺辟阳明、胫阳明各五”“痲，两胫阳明各五。”其中“痲”即“厥”，“胫”指的是小腿，“胫阳明”即足阳明经在小腿部的治疗点。《灵枢·经脉》提及丰隆主治病症为：“其病气逆则喉痹瘖瘖，实则狂巅，虚则足不收胫枯。”《明堂经》中丰隆穴主治病症均来源于内经相关条文（见表23），老官山《刺数》中的“癡疾”“狂”“噤痛”“厥”也均见于《明堂经》主治病症。

表 22 《内经》《明堂经》上、下巨虚穴主治条文对比

《内经》	《明堂经》	
	上巨虚	下巨虚
巨虚上下廉……泻胃中之热。《素问·水热穴论》	大肠有热	内有热
腹中常鸣，气上冲胸，喘不能久立，邪在大肠，刺盲之原、巨虚上廉、三里。《灵枢·四时气》	肠鸣腹满，侠脐痛，食不化，喘，不能久立。	
大肠病者，肠中切痛而鸣濯濯，冬日重感于寒即泄……取巨虚上廉。《灵枢·邪气脏腑病形》	飧泄，大肠痛。	
小肠病者，小腹痛……及手小指次指之间热……取之巨虚下廉。《灵枢·邪气脏腑病形》		少腹痛……次指间热。
胃足阳明之脉……善呻数欠，病至则恶人与火，闻木声则惕然而惊……甚则欲上高而歌，弃衣而走……狂……大腹水肿。《灵枢·经脉》	狂，妄走，善欠……胸胁痞满，恶闻人声与木音，风水面肿。	暴惊，狂言非常。

表 23 《内经》《明堂经》丰隆穴主治条文对比

《内经》	《明堂经》
厥逆为病也，足暴清，胸若将裂，肠若将以刀切之，烦而不能食，脉大小皆涩，暖取足少阴，清取足阳明。《灵枢·癫狂》	主厥逆，足暴清，胸痛如刺，腹若刀切之，闷不能食，大小便涩难。
风逆暴四肢肿，身漯漯 ^[1] ……取手太阴表里，足少阴、阳明之经。《灵枢·癫狂》	四肢肿，身湿。
厥头痛，面若肿起而烦心，取之足阳明太阴。《灵枢·厥病》	厥头痛，面浮肿，烦心。
狂者多食，善见鬼神，善笑而不发于外者，得之有所大喜《灵枢·癫狂》	狂见鬼，善笑不休，发于外，有所大喜。
喉痹不能言，取足阳明。《灵枢·杂病》	喉痹不能言。

^[1] 漯漯：汗出不断貌。《素问·刺腰痛》：“会阴之脉，令人腰痛，痛上漯漯然汗出。”张介宾注：“漯，音磊，形容汗出。”

冲阳穴为足阳明原穴，古称“足阳明”，由趺阳脉、冲阳脉（即足背动脉）演化而来，《灵枢·本输》定位为“足跗上五寸陷者中”，《明堂经》本穴主治病症多为足阳明脉的典型病症如“狂妄而行，登高而歌，弃衣而走”“疟……汗出”“胃脘痛”等，此外还包括“口中热痛”“齿齲痛”等五官病症，由于冲阳穴处有足背动脉搏动“刺跗上中大脉，血出不止，死”（《素问·刺禁论》），故《内经》时代也作为一个重要的诊脉点，如《素问·至真要大论》：“冲阳绝，死，不治。”老官山《刺数》载：“肤偃，足大阴、阳明各五。”其中“偃”就是“胀”，“肤胀”是秦汉时期的一个病名，张家山汉简《脉书》^[1]：“身、面、足、胕尽盈，为肤胀。”而《明堂经》本穴主治病症有“风水面附肿”，与老官山《刺数》中“肤偃”相合。

陷谷穴是本经“所注为输”，《灵枢·本输》定位于“上中指内间上行二寸陷者中”，《明堂经》中陷谷穴主治病症中出现三次“刺陷谷”，是采集自多个针灸方的有力证据。厉兑穴为本经井穴，《灵枢·本输》定位为“足大指内次指之端”，《明堂经》厉兑穴主治病症多见于《内经》，如“主尸厥，口噤，气绝，脉动如故，其形无知，如中恶状”与《素问·缪刺论》中对“尸厥”症状描述相一致，而“鼽衄”也见于《素问·缪刺论》，“振寒，恶人与木音”是足阳明脉的典型病症。

老官山漆人足阳明脉有5个双穴，均在传世文献中有相当或相近的记载。《内经》足三里、上巨虚（巨虚上廉）、下巨虚（巨虚下廉）、解溪、冲阳、陷谷、内庭、厉兑归属于足阳明脉；丰隆为“足阳明之别”；承泣（目下）为“任脉之气所发”；四白（面髁骨空）、大迎（大迎之骨空）、人迎、气冲（气街动脉）为“足阳明脉气所发”；颊车（耳下牙车之后）、下关为“足少阳脉气所发”。

《明堂经》足三里、上巨虚（巨虚上廉）、下巨虚（巨虚下廉）、解溪、冲阳、陷谷、内庭、厉兑归属于足阳明脉；丰隆为“足阳明络也”；承泣为“阳蹻、任脉、足阳明之会”；四白、大迎、颊车、人迎、水突、气舍、气户、库房、屋翳、乳根、不容、承满、梁门、关门、太乙、滑肉门、天枢、外陵、大巨、水道、气冲、伏兔、阴市、犊鼻、条口为“足阳明脉气所发”；巨髃为“蹻脉、足阳明、任脉之会”；地仓为“蹻脉、手足阳明之会”；下关、头维为“足阳明、少阳之会”；梁丘为“足阳明郄”；缺盆、膺窗、乳中、归来、髀关未言经脉归属。

^[1] 张家山汉墓竹简整理小组. 张家山汉墓竹简二四七号墓(释文修订本)[M]. 北京: 文物出版社, 2006: 116.

老官山漆人足阳明脉头颈部无腧穴，疑似腧穴点主要集中于少腹部、下肢，但观察漆人足阳明脉的循行路径，从少腹部向上，经脐两侧、上腹部、胸前壁到达口周，但从脐两侧到口周之间无腧穴分布，应该是与早期医家对胸腹部重要脏器的“刺禁”理论相关，《素问·刺禁论》中“藏有要害，不可不察”的观念在医家心中占有重要的地位，而下肢肌肉丰厚，感传作用较为明显，多为医家所选用，尤其是肘膝关节以下的部位，腧穴分布较为密集，其理论成熟时间也较早。

笔者观察老官山漆人足三阳脉照片及绘制图，可以明显发现老官山漆人足三阳脉腧穴多分布于关节附近，与特定穴相关：

表 24 老官山漆人足三阳脉与特定穴关系

	足太阳	足少阳	足阳明
原穴	京骨	丘墟	
五输穴	京骨、昆仑、委中	侠溪、丘墟	内庭、解溪
背俞穴	肺俞、脾俞、胃俞、肾俞、大肠俞、膀胱俞	/	/

4.4 手太阴脉腧穴

4.4.1 老官山漆人手太阴脉腧穴演变梳理

老官山漆人手太阴脉刻有 3 个疑似腧穴点，左侧手太阴脉有 1 个，整理人员记为“a3”，右侧手太阴脉有 2 个，整理人员分别记为“a1”“a2”，如图 32 所示。

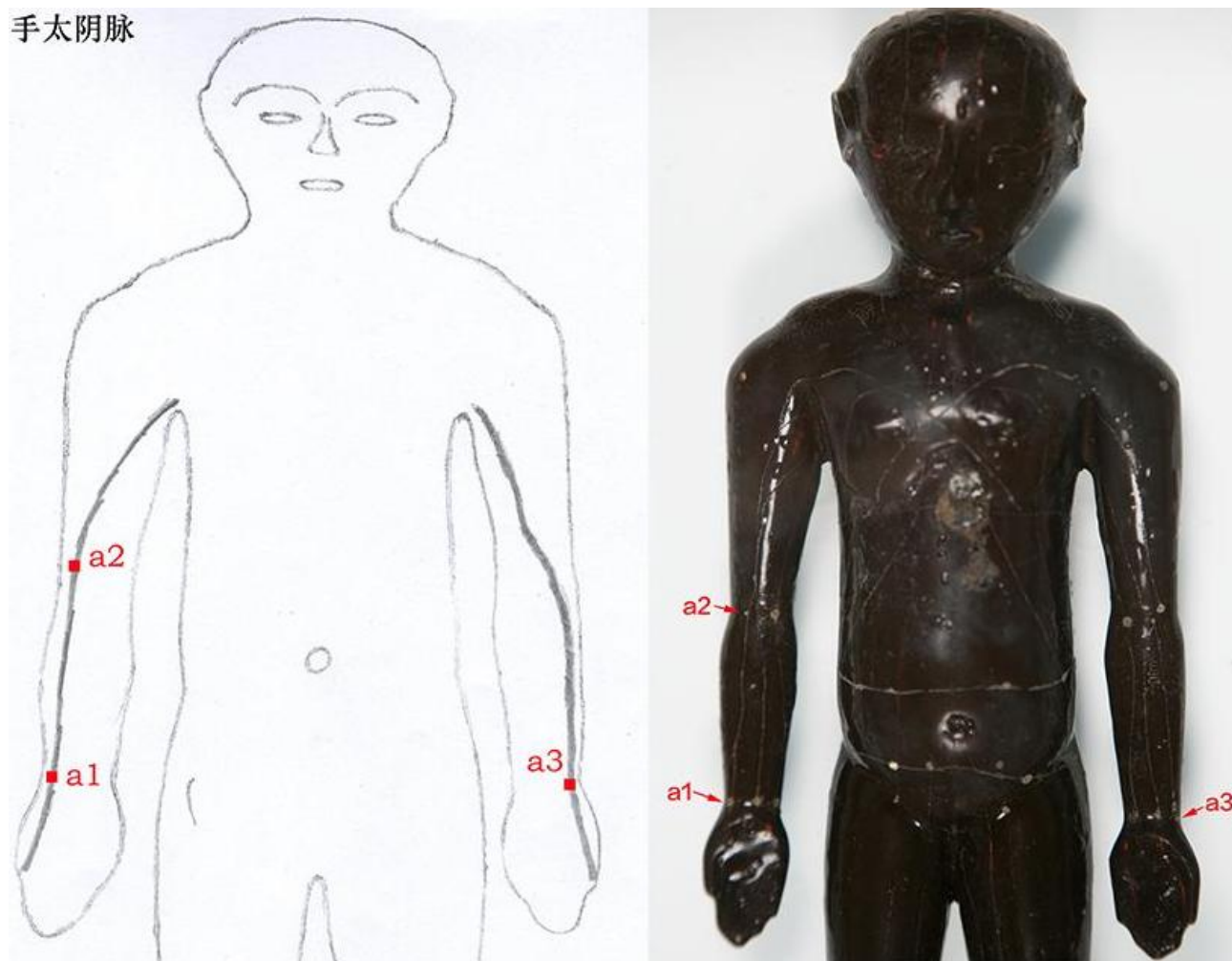


图 32 老官山漆人手太阴脉腧穴分布示意图^[1]

其中，疑似腧穴点“a1”与“a3”分别位于腕掌侧横纹桡侧端，整理人员认为与太渊穴相近，太渊穴在早期针灸文献中的内容非常丰富，《灵枢·本输》定位为“鱼后一寸陷者中”，太渊为肺之原穴、输穴，在《难经·四十五难》中又将其定为八会穴之脉会。太渊穴所在的位置下有桡动脉经过，《内经》时代太渊穴还作为诊断生死的一个重要的参考部位，如“太渊绝者，死，不治”（《素问·气交变大论》），太渊穴《内经》明确归于手太阴脉，如《灵枢·邪客》：“手太阴之脉……”

^[1] 图片引自：黄柳杨. 老官山汉墓出土经穴髹漆人像手三阴经腧穴特点研究[D]. 成都中医药大学, 2017: 20.

至本节之后太渊留以澹……”《明堂经》中太渊穴的定位、归经也与《内经》相同：“在手掌后陷者中，手太阴之所注也。”太渊穴的临床应用，《内经》以针灸方的形式出现，主要治疗心痛、热病，如《灵枢·厥病》取鱼际、太渊治疗“肺心痛也”，《灵枢·热病》取鱼际、太渊、大都、太白用以泻热。《明堂经》太渊穴主治更加广泛，包括了帛书《足臂》《阴阳》中的相关病症如“烦心”“哆噫”“心痛胀满彭彭”“臂厥”“肩膈胸痛”等，此外，还包括胸肺疾患如“逆气”“喘不得息”“唾血”等。

疑似腧穴点“a2”位于右侧手太阴脉与肘横纹外侧相交处，整理人员认为与后世“尺泽穴”相近，尺泽穴作为肺经五输穴之一，《内经》中已经有较为详细的记载，如《灵枢·本输》定位为“肘中之动脉也”，此处“肘中之动脉”成为早期医家对尺泽穴定位的一个标准，如《明堂经》定位为“在肘中约上动脉”，“肘中动脉”实际上就是现代解剖学中的“肘正中动脉”，因此秦汉时期医家也将此处作为诊断生死的一个重要参考标准，如《素问·至真要大论》：“尺泽死，不治。”现代教材“肱二头肌肌腱桡侧端”这一定位方法，是宋以后的医籍中才开始出现的。尺泽穴的主治病症《内经》未载，《明堂经》主治体现出心肺两脏同治的特点，如“心膨膨痛，心烦满，心乱”属于心系病变，而“咳逆上气，少气不足以息”属于肺系病变，此外，“目眦纵衄，左室刺右，右室刺左”“不得汗，补手太阴以出其汗”明显是辑自古代针灸方，后世文献（宋以后）将尺泽穴定位于肱二头肌肌腱桡侧缘，则与手太阴脉的位置演变相关。

老官山漆人手太阴脉上只有“太渊”“尺泽”两个疑似腧穴点，这两个疑似腧穴点有一个共同特征：均位于动脉搏动处，可推测早期医家对动脉搏动处较为重视，我们若将太渊与尺泽两点连成一线，就是前臂屈面桡侧缘手太阴脉的循行路径。故早期医学体系中腧穴点与经脉循行路径的建立，与动脉搏动处密切相关。

4.4.2 手太阴脉其余腧穴演变梳理

中府穴在《内经》中称为“膺中外腧”“膺中陷”“膺俞”，《说文解字》：“膺，胸也。”关于该穴的定位《内经》未提及，《明堂经》定位为“云门下一寸，乳上三肋间，动脉应手陷者中”，此穴主治病症《内经》有载，《灵枢·五邪》用以治疗“邪在肺”的一系列症状，《素问·水热穴论》用以“泻胸中之热”，可治疗胸

肺病症。均被《明堂经》中府穴主治病症收引。笔者认为“膺中陷”其实应该作为部位名，主要指锁骨下窝外侧，肩胛骨喙突内侧的凹陷，胸前壁凹陷此处最为明显，故称“膺中陷”，《灵枢·杂病》：“气逆上，刺膺中陷者与下胸动脉。”可治疗肺病，但此处深部就是肺组织，因此也极容易出现气胸这类医疗事故，如《素问·刺禁论》：“刺膺中陷，中肺，为喘逆仰息。”

云门穴最早载于《内经》，《素问·水热穴论》用以“泻四支之热”，《明堂经》云门穴的定位为：“在巨骨下，气户两傍各二寸陷者中，动脉应手。”“巨骨”指锁骨，可见云门穴定位主要借助体表标志，而“动脉应手”是指此处有腋动脉通过，“举臂取之”可使喙突与腋动脉搏动在指下更易触及。后世医籍对云门穴定位多从《明堂经》之说，云门穴主治病症集中于《明堂经》，主要针对胸肺、肩臂部病变和无脉症。其中“喉痹，胸中暴逆。先取冲脉，后取三里、云门皆泻之”明显出自某个针灸方。中府穴与云门穴位置相近，《内经》中未明言归经，《明堂经》称中府穴为“手足太阴之会”，云门穴为“足太阴脉气所发”，盖因中府、云门均位于足太阴脉的循行路线上。中府穴是肺募穴，归入肺经，而云门穴主治胸肺病症，其位置又在于中府之上，故后世（王冰注《内经》开始）将两穴均归于肺经。

天府穴作为一个“诊脉处”，在早期针灸理论体系中占有重要的地位，《内经》记载涉及到定位、归经、主治、禁忌等，“腋内动脉”（《灵枢·本输》）“腋下动脉”（《灵枢·寒热病》）为准确定位的关键，“腋内动脉”指肱动脉，位于上臂屈面尺侧缘，《明堂经》对天府穴的定位更加详细，明确为“腋下三寸”。“天府”在早期秦汉医学中用作脉名，我们可以在肱二头肌内侧缘很长的一个范围内触及到肱动脉的搏动，而“腋下三寸”仅仅是一个点，考察《灵枢·本输》原文：“腋内动脉，手太阴也，名曰天府。腋下三寸，手心主也，名曰天池。”“腋下三寸”在《内经》中是天池穴的定位，《明堂经》是否将此误作为天府穴的定位？而这一失误又被后世医籍所转引。先秦两汉时期，天府穴位于上臂屈面内侧缘（尺侧缘，即现代教材中手少阴循行部位），而宋代以后则变为桡侧，这与经脉位置的演变密切相关^[1]。天府穴主治病症，《灵枢·寒热病》主要治疗急性出血，即“暴瘧内逆，肝肺相搏，血溢鼻口”，除此之外，《明堂经》载天府穴主治病症还包括胸肺咳喘病症，如“主

^[1] 黄龙祥,黄幼民. 针灸腧穴通考:《中华针灸穴典》研究. 第一版[M]. 北京:人民卫生出版社,2011:111.

咳，上气不得息”“喘喝多唾”等。若按秦汉时期《内经》《明堂经》主治病症进行临床治疗，应该选取上臂屈面尺侧缘的早期定位。由于早期天府穴位于肱动脉搏动处，《内经》载有较多的诊断条文，如《素问·至真要大论》：“天府绝，死，不治。”《明堂经》：“禁不可灸，使人逆气。”后世天府穴的位置发生了变化，便不再具有诊断意义以及治疗禁忌了。

天府穴所在的肱动脉搏动处，老官山医简《刺数》称为“辟（臂）大（太）阴”，是天府穴的古称，《刺数》：“单，两辟大阴、两肱阳明各五。”该针灸方中，“单”指“瘰”，老官山出土医简中，共有 25 个条文涉及到此病，整理人员认为老官山医简中的“瘰”，其病因主要是饮食不节、情志异常，并以“干”“热”“少气”为主要症状^[1]。《灵枢·寒热病》将血热上逆导致的口鼻出血称为“暴瘰”，选取天府进行治疗，而“腋下动脉，臂太阴也，名曰天府”。可见，老官山医简《刺数》中的“辟大阴”，就是天府肱动脉搏动处。

《内经》肱动脉搏动范围内，仅有天府一处治疗点，其所辖范围较广，可称之为“天府（脉）”，我们还可以借助侠白穴对天府进行分析：侠白穴《内经》未载，首见于《明堂经》：“侠白，在天府下，去肘五寸动脉，手太阴之别。刺入四分，灸五壮。主心痛，咳，干呕，烦满。”《明堂经》作者可能未理解天府脉的含义，将天府定位于“腋下三寸”，故天府由“脉”缩小为一个“点”，并在原“天府脉动处”又增加了侠白穴作为治疗刺激点，定位于“去肘五寸动脉中”。故《明堂经》天府穴、侠白穴实际上是由《内经》“腋下动脉”（肱动脉）演化而来，而侠白穴主治病症“心痛，咳，干呕，烦满”则直接移植于手太阴脉太渊、经渠的主治病症，后世侠白穴与天府穴一并移到上臂屈面外侧缘（桡侧缘），我们可以将秦汉时期天府穴演变总结为下表：

表 25 《刺数》《内经》《明堂经》天府穴演变简表

出处	《刺数》	《内经》	《明堂经》
名称	辟（臂）大（太）阴	臂太阴/天府（脉）	天府（穴）/侠白穴
性质	脉动处	脉动处	腧穴点

^[1] 王一童. 老官山医简诸“瘰”、诸“瘰”、诸“风”病名考释研究[D]. 成都中医药大学, 2016.

先秦两汉时期对孔最穴的记载较少，仅能从隋唐医籍辑校出《明堂经》孔最穴原文^[1]。列缺穴在《灵枢·经脉》中作为络脉名，其循行“起于腕上分间，并太阴之经直入掌中，散入于鱼际”，“腕上分间”是指拇长展肌腱与拇短伸肌腱之间，病变主要分为虚实两端“实则手锐掌热，虚则欠欬，小便遗数”，治疗部位则是“取之去腕半寸”，此处“去腕半寸”应写作“寸半”，而后《明堂经》中列缺穴定位与《内经》相同，但主治却不同，涉及小儿惊痫诸多症状，如“唇口聚，鼻张”“胁下满悸”等，是小儿惊风的典型症状表现。

经渠穴与太渊穴同位于腕掌侧横纹桡侧端，此处有桡动脉通过，秦汉早期统称之为“手太阴”，经渠穴是五输穴之经穴，在《内经》中记载较为丰富，《灵枢·本输》阐明了经渠穴的定位在“寸口中”（太渊穴定位“鱼后一寸陷者”），经渠穴与太渊穴均位于寸口桡动脉搏动处，两者距离相近，均由古穴“手太阴”分化而来，这一分化形式在《内经》中就已经完成，但《内经》重太渊而轻经渠，并未记载与经渠穴相关的针灸方或主治病症，《明堂经》中所记载的经渠穴主治病症，也明显有“拼凑感”，其中“咳，上气，喘，掌中热，数欠，汗出，胸中彭彭，甚则交两手舞”均见于《灵枢·经脉》篇手太阴脉主要症候，而“心痛欲呕”代表的心症状又多见于帛书《足臂》《阴阳》中，此外“暴瘁内逆”在《内经》中属于“臂太阴”（天府脉）所主，误入经渠穴主治中，更能说明经渠穴主治病症的“拼凑”痕迹。此外，古代腧穴名“手太阴”与“臂太阴”所指不同，“手太阴”在《内经》中演化为“太渊”“经渠”两个穴位，而“臂太阴”在《内经》中称“天府”，《内经》中“天府”仍作为一个脉名存在，直至《明堂经》中才演化为天府穴与侠白穴，而“臂太阴脉”是指手太阴肺脉整条经脉。

鱼际穴所在的赤白肉际处，由于其血络丰富，“与诸阴络会于鱼际”（《灵枢·邪客》），早在《内经》时期就作为重要的望诊部位以及刺络放血处。“手鱼”与“鱼际”均指第一掌骨桡侧中点的赤白肉际处，在《灵枢·本输》中载：“鱼际者，手鱼也。”似将鱼际作为腧穴名，而将“手鱼”作为一个部位名，鱼际处血络颜色的改变与胃病相关，如“鱼络血者手阳明病”（《灵枢·邪气脏腑病形》）“鱼上白肉有青血脉者，胃中有寒”（《灵枢·论疾诊尺》），如《灵枢·经脉》以鱼际颜色改

^[1] 黄龙祥,黄幼民. 针灸腧穴通考:《中华针灸穴典》研究. 第一版[M]. 北京:人民卫生出版社,2011:123-126.

变“青”“赤”诊断“胃中寒”或“胃中有热”，早期医家以肠胃为脏（《素问·五脏别论》），重视消化系统功能，可能与先民茹毛饮血的不良饮食习惯，导致胃肠道疾病多发有关^[1]。鱼际作为一个腧穴，其具体定位在《明堂经》中仍未固定：“鱼际者，火也，在手大指本节后内侧散脉中。”《明堂经》所称“散脉”指鱼际部肉眼可见的表浅静脉。鱼际主治病症，《内经》中已有论述，主要以肺心痛（《灵枢·厥病》）与汗症（《灵枢·热病》）为主，且均被《明堂经》收录，《明堂经》中所记载的鱼际主治病症较多，其中“刺鱼际及阳明出血”“皆虚也，刺鱼际补之”“泻鱼际，补尺泽”等，可以看出采集自不同的针灸方，表明秦汉时期鱼际临床应用范围广泛，需要注意的是，鱼际处血络旺盛，针刺处理不当，容易引发感染、瘀血，即“刺手鱼腹，内陷为肿”（《素问·刺禁论》），这也从侧面显示秦汉医家对鱼际应用广泛。

少商穴为肺经井穴，《灵枢·本输》中载有定位：“肺出于少商，少商者，手大指端内侧也，为井木。”黄龙祥先生指出，《内经》中井穴的定位，除手太阴脉少商、足太阴脉隐白以及足少阴脉涌泉外，均定位于手足指/趾端，如下表所示：

表 26 《内经》十二经脉井穴定位

经脉	井穴	定位	经脉	井穴	定位
肺	少商	手大指端内侧	膀胱	至阴	足小指之端
大肠	商阳	大指次指之端	肾	涌泉	足心
胃	厉兑	足大指内次指之端	心包	中冲	手中指之端
脾	隐白	足大指之端内侧	三焦	关冲	手小指次指之端
心	少冲	手小指内廉之端（《明堂经》）	胆	窍阴	足小指次指之端
小肠	少泽	小指之端	肝	大敦	足大指之端及三毛之中

以隐白与大敦为例，随着早期经脉循行向手足末端延伸，尤其是足大指端，需要容纳脾、肝两条经脉时，便不能同时定位于足趾尖端，在《内经》中可以看到肝经井穴大敦在“足大指之端及三毛之中”，那么脾经井穴隐白就不能循行至足大指之端，而只能改为“足大指之端内侧”，现代教材中，仅有心包经井穴中冲位于手指端，其余井穴多属于奇穴“十宣”，这一现象与经脉循行路线的延长、十二经脉循环流注理论体系的形成密切相关。对这一问题，黄龙祥先生指出，井穴的

^[1] 刘滴川. 大瘟疫——病毒、毁灭和帝国的抗争[M]. 成都: 天地出版社, 2019: 4.

治疗效果，需分清是取指趾尖端，还是依现代教材定位，或是二者效果相当，是亟待解决的一个问题。少商穴在《内经》中位于“手大指端内侧”，是否在更早的某一阶段，少商穴位于手大指尖端？或是由于手指尖端针刺较痛？才将少商穴从手指尖端移位于手大指端内侧？仅做推测。《明堂经》对少商穴的定位为：“在手大指端内侧，去爪甲角如韭叶。”其中“去爪甲角如韭叶”比单言“手大指端内侧”更为准确，是秦汉医家对井穴定位的一个进步。但韭叶本身亦有宽窄者，故杨上善讲：“韭叶有大小，正取非大非小阔二分评量中度之人，若大小以意量之也。”

《内经》尺泽、经渠、太渊、鱼际、少商属于手太阴脉；天府为“手太阴也”；列缺为“手太阴之别”。

《明堂经》尺泽、经渠、太渊、鱼际、少商属于手太阴脉；中府为“手足太阴之会”；云门为“足太阴脉气所发”；天府为“手太阴脉气所发”；侠白为“手太阴之别”；孔最为“手太阴之郄”；列缺为“手太阴之络”。

4.5 手厥阴脉腧穴

4.5.1 老官山漆人手厥阴脉腧穴演变梳理

老官山漆人手厥阴脉刻有 3 个疑似腧穴点，左侧手厥阴脉刻画有 2 个点，整理人员命名为“b2”“b3”，右侧手厥阴脉刻画有 1 个点，整理人员命名为“b1”，如图 33 所示。



图 33 老官山漆人手厥阴脉腧穴分布示意图^[1]

其“b1”“b2”大致位于左右侧腕掌侧横纹中点，整理人员认为与后世文献所载的“大陵穴”位置相近，大陵穴在早期医籍中定位、归经、主治的记载已经非常丰富，大陵穴是心经五输穴之输穴，又是原穴，其定位“掌后两骨之间方下者”（《灵枢·本输》）为后世医籍定位大陵穴的标准，如《明堂经》定位为“在掌后

^[1] 图片引自：黄柳杨. 老官山汉墓出土经穴髹漆人像手三阴经腧穴特点研究[D]. 成都中医药大学, 2017: 25.

两筋间陷者中”，此外，古代“心主”“手心主”“手厥阴”“鬼心”均是大陵穴的别称。如《脉经·卷二》“心主在掌后横理中”指的便是大陵穴，再如《诸病源候论·卷四十一》：“手心主穴，在掌后横文是。”《千金要方·卷十二》：“心主，在手腕后第一约横纹当中指。”但“心主”“手心主”除可以代指大陵穴之外，还可指手厥阴心经整条经脉、心脏本身或大陵穴所在的部位，如《灵枢·胀论》：“膻中者，心主之宫城也。”此处“心主”指心脏本身，大陵穴的主治病症见于《内经》，《素问·通评虚实论》用以治疗“掖痛大热”，《素问·缪刺论》用以治疗“尸厥”，《灵枢·口问》治疗“忧思则心系急”导致的“太息”，而后《明堂经》中大陵穴主治病症也在于心与心神病变。

老官山漆人手厥阴脉疑似腧穴点“b3”，整理人员认为位于“左侧手厥阴脉与肘横纹中点相交处”，笔者仔细观察照片后，认为“b3”应该位于手厥阴脉与肘横纹桡侧端相交，在图33中用“↓”标记，此处刻画的疑似腧穴点与传世文献所载“曲泽穴”相近，曲泽穴为手厥阴经五输穴之合穴，《灵枢·本输》定位为“肘内廉下陷者之中”，取穴要求“屈而得之”，是因屈肘关节时肱二头肌肌腱较为明显，《明堂经》曲泽穴定位与《内经》同，主治病症也以心与心神病变为主，如“心痛”“烦心”等，曲泽穴现代教材中的位置，正位于肘中动脉搏动处，原本是尺泽穴所在的位置，手太阴肺经的腧穴多位于动脉搏动处，如桡动脉（太渊、经渠）、肘中动脉（尺泽）、肱动脉（侠白、天府）、腋动脉（中府、云门）。由于手三阴脉的重新分布，手太阴肺经向上肢屈面桡侧缘移位，因此尺泽穴移至肱二头肌肌腱桡侧缘，而尺侧缘则成为曲泽穴所在，我们观察老官山漆人肘窝处的经脉分布以及尺泽、曲泽疑似腧穴点的位置，可知这一转变在《内经》之前就已经完成。

老官山漆人手厥阴脉上仅刻有大陵、曲泽两处腧穴，均属于五输穴，且位于腕、肘关节处，体现出腧穴所居之处，多为躯体“节”“会”等部位的特点。

4.5.2 手厥阴脉其余腧穴演变梳理

《灵枢·经脉》篇描述“心主手厥阴心包络之脉”的循行有“其支者，循胸出胁，下腋三寸……”此处“下腋三寸”就是天池穴，《明堂经》对天池穴的定位更为详细，增加了“乳后一寸”横向定位以及“掇肋”（肋骨凸起处）局部定位特征。《明堂经》载本穴主治多为胸肺部病症，如“寒热，胸满颈痛”“上气，胸中

有声，喉中鸣”等。

天泉穴《内经》未载，《明堂经》定位为“在曲腋下三寸，举臂取之”，正位于肱二头肌肌腹上，但天泉穴主治病症表述并不明确：“主石水，足不收，痛不可以行。”《素问·阴阳别论》：“石水，少腹肿。”故《明堂经》中天泉穴主治应来自古代某个针灸方，或是其他腧穴主治误入而成，提示我们秦汉医家对天泉穴的临床应用可能不太频繁。

郄门穴《内经》不载，《明堂经》定位为“去腕五寸”，主治病症以心胸部病症及心神病症为主，如“心痛”“惊恐畏人”等，《明堂经》手厥阴脉诸穴多可以治疗心神病症，或许是秦汉医家大量临床经验的积累，方使手三阴脉中有两条脉均与心有关。间使穴在《内经》中定位为：“两筋之间，三寸之中也，有过则至，无过则止。”杨上善解释“有过则至，无过则止”为“有虚实之过，则气使至此；无过不至，故止也。”^[1]《明堂经》定位与《内经》同：“在掌后三寸两筋间陷者中。”主治心系病症，如“心痛善悲”“心澹澹而惊”“卒心中痛”等。

内关穴名称及定位最早见于《灵枢·经脉》“去腕二寸，出于两筋之间”，内关在早期针灸学中，既作为络脉的名称，又可作为腧穴名，具有早期针灸医学“脉穴同名”的特征。病变主要分为虚实两端“实则心痛，虚则为头强”，《明堂经》定位为“在掌后去腕二寸”，此时只作为腧穴名而存在，主治病症重点在于心脏与心神病变。

劳宫穴是心包经的荥穴，《灵枢·本输》定位为“掌中中指本节之内间”，笔者认为指的是第3掌骨尺侧，有学者根据少商穴在手大指端内侧（即大指桡侧），推论劳宫穴也应该在第三掌骨桡侧，即第2、3掌骨之间，笔者认为，上肢自然下垂时，拇指桡侧实际朝向躯干，拇指作对掌运动时，其桡侧缘与第3掌骨尺侧位于同一个方向，因此可以认为《灵枢》“掌中中指本节之内侧”即第3掌骨尺侧。《明堂经》所称“在掌中央动脉”，实际上掌浅弓与掌深弓在手掌心难以触及。

中冲穴《内经》《明堂经》定位均在“手中指之端”，《明堂经》又增“去爪甲如韭叶陷者中”一语，其中“陷者中”令人不解，中指端圆润饱满，不太可能出现“陷者”，《明堂经》中冲穴主治病症以热证为主：“主热病烦心，心闷而汗不出，

^[1] [隋]杨上善. 黄帝内经太素[M]. 北京: 中医古籍出版社, 2016: 141.

掌中热，心痛，身热如火，浸淫烦满，舌本痛。”《内经》主要用来治疗耳鸣耳聋，见于《灵枢·厥病》《素问·缪刺论》中。

《内经》曲泽、间使、大陵、劳宫、中冲归属于手少阴脉；天池为“手心主也”；内关为“手心主之别”。

《明堂经》曲泽、间使、大陵、劳宫、中冲归属于手心主脉；天池为“手心主、足少阳脉之会”；郄门为“手心主郄”；内关为“手心主络，别走少阳”；天泉未提及经脉归属。

4.6 手少阴脉腧穴

4.6.1 老官山漆人手少阴脉腧穴演变梳理

老官山漆人手少阴脉上共有 4 个疑似腧穴点，左右完全对称，分别位于腕关节（腕掌侧横纹尺侧端）和肘关节（肘横纹内侧）处，如图 34 所示：

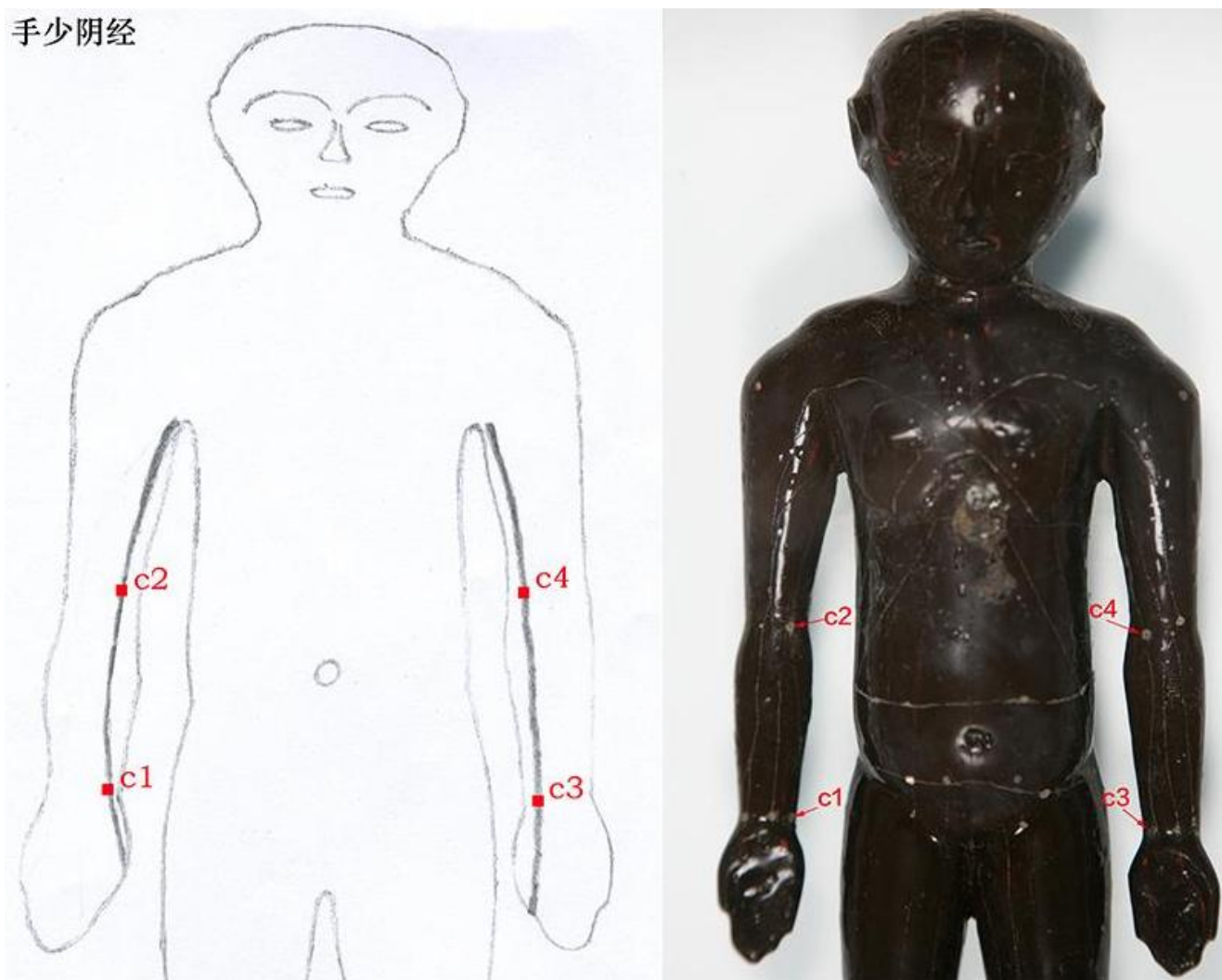


图 34 老官山漆人手少阴脉腧穴分布示意图^[1]

位于双侧手臂腕掌侧横纹尺侧端的 2 处疑似腧穴点，整理小组记为“c1”和“c3”，认为此处与传世文献中的记载的神门穴相似，“神门”在《内经》中主要用于诊断，即“神门绝者，死，不治”，因神门穴所在部位有尺动脉通过，故为古代诊断生死的部位之一，出自《气交变大论》《至真要大论》，此两篇属于运气七

^[1] 图片引自：黄柳杨. 老官山汉墓出土经穴髹漆人像手三阴经腧穴特点研究[D]. 成都中医药大学, 2017: 29.

篇，因唐代以前没有文献记载其内容，故有学者疑为唐代王冰补入^[1]，可能不属于秦汉时期的针灸文献，“神门穴”在《内经》中称之为“手少阴”，但“手少阴”所在的尺动脉搏动处实际上包含了神门、阴郄两个穴位，对于神门穴的定位，《明堂经》记载“在掌后兑骨之端陷者中”，“兑骨”在早期医书中指的是尖锐的小骨，所以“掌后兑骨之端”相当于现代解剖学中的“豌豆骨”，《明堂经》神门穴主治病症以心经、心络典型病症为主，此外还包括“狂，恐悸，悲哭”等心神症状。老官山漆人左右侧手少阴脉与肘横纹内侧相交处刻有一个疑似腧穴点，整理人员将其命名为“c2”“c4”，认为与后世文献中“少海穴”相似，少海穴《内经》未载，其定位与主治病症主要见于《明堂经》：“在肘内廉节后陷者中，动脉应手……主身热，痲疟，气逆，呼吸噫，哕，呕吐，手臂挛急。”此处“动脉应手”实际上与曲池穴所在动脉一致，当肘窝动脉搏动处。

老官山漆人手少阴脉上刻有神门、少海两处腧穴，《灵枢·本输》与心相关的五输穴为手厥阴经穴，《灵枢·经脉》对手少阴脉的循行、主治病症记载较为详细，但手少阴脉腧穴数量较少，这与古人对手少阴脉的独特认识有关，《灵枢·邪客》中载黄帝对岐伯提出了一个问题：“手少阴之脉，独无腧，何也？”“手少阴之脉独无腧”是当时医学界的一种普遍认识，而岐伯的回答则体现出秦汉医家对心脏这一器官的重视，即“其藏坚固，邪弗能容”，心脏昼夜跳动不停，故“其藏坚固”，邪气无法侵袭坚固的心脏，而腧穴是体表之“孔窍”，因邪气无法通过心脉进入心脏，所以手少阴经不存在腧穴，但黄帝接着又提问：“少阴独无俞者，不病乎？”心脉与心脏到底“病不病”？也成为了秦汉医家思考的一个问题，岐伯给出的回答是：“其外经病而藏不病”，也就是说心脉会出现病症，而心脏（藏）则不会。当心脉出现病症时，就表现为《灵枢·经脉》篇心手少阴之脉的典型病候，可见，心脉产生的病症与心脏本身的症状相差较大，“嗌干”“胁痛”“臑臂内后廉痛厥”“掌中热痛”均是心脉循行所过病症，仅有“心痛”是心脏本身的病变，而心主手厥阴心包络之脉是动病有“心中憺憺大动”，所生病有“烦心，心痛”，对于手少阴脉“外经病而脏不病”的特点，在治疗时可以选择手厥阴脉的腧穴进行治疗，也可以“独取其经于掌后锐骨之端”，即神门穴所在。老官山漆人左右侧手少阴脉

^[1] 樊经洋.《黄帝内经素问》“运气七篇”思想研究[D].北京大学,2020.

上清晰刻有神门穴，证明神门穴在秦汉时期医家临床实践中已采用较多。手少阴脉神门、阴郄这两个位于尺动脉搏动处的腧穴最早为秦汉医家所认识，而其余腧穴主治则是汉代以后医家逐渐补入，此外，由于少海穴位于肘关节处，也是“动脉应手”处。

4.6.2 手少阴脉其余腧穴演变梳理

极泉穴与古人对腋动脉搏动的诊察有关，在腋窝处能明显触及到腋动脉的搏动，《明堂经》定位为“腋下筋间动脉入胸”，腋窝深处腋动脉“入胸”，与心脏联系密切，故《明堂经》极泉穴的主治病症也与“心痹”联系密切，与《灵枢·经脉》篇是动则病高度一致，笔者推测可能是由于秦汉时期医家通过体表触诊，认识到腋窝处腋动脉搏动与心脏跳动关系密切（距离也较近），于是将心经病症直接移植于极泉穴。灵道、通里、阴郄、神门四穴相近，灵道穴最早载于《明堂经》，定位为“在掌后一寸五分，或曰一寸”，黄龙祥先生认为，若依“或曰一寸”，则与通里穴重合，故有可能出现灵道、通里两穴横平的情况，早期通里可能仅作为“手少阴之别”的脉名，还不作为腧穴名，因此灵道穴存在掌后一寸五分和一寸的两种认识。《明堂经》所记载灵道穴的主治病症均来自《内经》心病的相关记载。通里最初是作为络脉的名称，因此络脉病症便成为通里穴的最初主治病症，“实则支膈，虚则不能言”也被《明堂经》引作通里穴的主治病症，此外，《明堂经》通里穴主治还见到《素问·刺热》篇中“心热病”的全部症状表现^[1]，表明《内经》《明堂经》中部分针灸方可能属于一脉相承。

阴郄、神门两穴是由古穴“手少阴”分化而来，因此《明堂经》对阴郄穴定位“在掌后脉中，去腕五分”，其主治病症较为简单：“主凄凄寒，咳吐血，气惊心痛。”但神门穴的主治病症记载较为丰富，笔者推测古穴“手少阴”分化为神门、阴郄二穴后，秦汉医家较为重视神门穴，老官山漆人疑似腧穴点约当于神门穴处也提示该穴可能较早为医家使用。

少府穴《明堂经》定位为“在手小指本节后陷者中，直劳宫”，其中“直劳宫”意为与劳宫穴齐平，“手小指本节后”指第4、5掌骨之间，其主治病症据《外台秘要》中的相关记载进行辑佚，即“烦满，少气，悲恐畏人，臂酸，掌中热，手

^[1] 黄龙祥. 腧穴主治的形成[J]. 中国针灸, 2000(11): 37-42.

卷不伸”，《千金》《医心方》此穴与肝经蠡沟穴主治相混^[1]。由于“手少阴独无腧”，少冲穴首见于《明堂经》，定位为“手小指内廉之端”，所主病症为热病、心胸病症及经脉循行部位病症。

《内经》手少阴脉载有通里、神门、少海三穴，但只有通里（手少阴之别）明确归经于手少阴脉。《明堂经》少海、灵道、神门、少府、少冲归属于手少阴脉；极泉为“手少阴脉气所发”；通里为“手少阴络，别走太阳”；阴郄为“手少阴郄”。

老官山漆人手三阴脉所刻画的疑似腧穴点，均位于腕关节、肘关节处，多位于动脉搏动处，又归属于相应的特定穴：

表 27 老官山漆人手三阴脉疑似腧穴点与特定穴对比

手太阴		手厥阴		手少阴	
太渊	尺泽	大陵	曲泽	神门	少海
输穴/原穴	合穴	输穴/原穴	合穴	输穴/原穴	合穴

从上表可以推测，老官山漆人手三阴脉上的腧穴点，是否有可能是为方便刻线定位而存在，毕竟在没有参照点的情况下，在狭小的漆人前臂屈面刻画三条经脉线稍有困难，因此在腕横纹和肘横纹上每条经脉各选取两个腧穴进行定位，而选取这两个腧穴也有一定的依据，五输穴理论在《内经》时期就已经比较成熟，有明确的定位、归经，老官山手三阴脉所刻画的腧穴均为“所注”“所入”之处，此外老官山手三阴脉位于腕横纹上的腧穴又属于原穴，总之，老官山漆人手三阴脉腧穴的特征明显，充分展示了墓主人所在时代对特定穴、动脉搏动处的重视。

^[1] 黄龙祥,黄幼民. 针灸腧穴通考:《中华针灸穴典》研究. 第一版[M]. 北京:人民卫生出版社,2011:507.

4.7 手阳明脉腧穴

商阳穴是本经井穴,《灵枢·本输》定位为“大指次指端”,位于食指尖端,而《明堂经》定位将指尖改为了食指桡侧:“在大指次指内侧爪甲如韭叶。”《内经》中多以“手大指次指爪甲上”代指商阳穴。《素问·缪刺论》载其主治胸肺病症、热证以及耳齿病症,其中部分主治病症为《明堂经》所承载。二间穴、三间穴位置相近,《灵枢·本输》分别定位于“本节之前”“本节之后”,《明堂经》中两穴的主治也有相同之处,如“身热”“多卧善唾”“齿痛”“喉痹如哽”等。

合谷、阳溪两穴所在部位可以触及动脉搏动,故早期以“手阳明”作为穴名,合谷穴《内经》《明堂经》均定位于“大指歧骨间”,即第1、2掌骨交叉处骨缝中,尤其《窦太师针经》言“手大指两歧骨间动脉”,只有在第1、2掌骨最底端交叉处才可以触及微弱的桡动脉,而依照现代教材中合谷穴的定位则无法触及动脉搏动,《明堂经》中合谷穴主治病症多可以在《内经》中找到对应条文。合谷与阳溪两穴处可触及桡动脉,故阳溪穴也属于古穴“手阳明”分化而来,《灵枢·本输》定位在“两筋间陷者中”,《明堂经》:“在腕中上侧两筋间陷者中。”“两筋间”指的是手背外侧部拇长伸肌腱与拇短伸肌腱之间形成的一个凹陷,此处可以明显触及桡动脉搏动,《明堂经》阳溪穴部分主治病症也可以从《内经》中寻找找到相应条文,见下表:

表 28 《内经》《明堂经》合谷穴、阳溪穴主治病症对比

《内经》条文	《明堂经》 合谷穴主治病症	《明堂经》 阳溪穴主治病症
齿痛颈肿……鼽衄,喉痹。《灵枢·经脉》	鼻鼽衄,龋齿痛,喉痹。	齿痛,喉痹。
聋而痛者,取手阳明。《灵枢·杂病》	口噤不开聋,耳中不通。	耳聋鸣
狂者多食,善见鬼神,善笑而不发于外者。《灵枢·癫狂》	狂易	狂言,善笑见鬼。

《明堂经》合谷穴主治病症“主热病汗不出,瞋目,目痛瞑,头痛”与《明堂经》阳溪穴主治病症“主热病烦心,瞋目,目痛泣出,厥头痛”类似,应该是出于同一个针灸方^[1]。合谷穴与阳溪穴主治病症,多以《内经》古穴“手阳明”有关的针灸方撷取而来,老官山《刺数》:“癫疾,两臂(臂)肱阳明、项钜阳各五……

^[1] [汉]佚名撰;黄龙祥辑校,王雪苔审订.黄帝明堂经辑校[M].北京:中国医药科技出版社,1987:156.

狂，两臂、两肱阳明各五……涕（泣）出，辟（臂）阳明、项钜阳各五……嗑痛不可咽，不甚，刺辟阳明、肱阳明各五。”其中“辟阳明”主治的“癫疾”“狂”“涕（泣）出”均见于合谷、阳溪穴主治病症中，而“嗑痛”与“喉痹”之间关系密切，如明代刘纯：“盖病喉痹者，必兼咽嗑痛，病咽嗑痛者，不能兼喉痹也。”此外，老官山针方简《刺数》中还有“咳，上气，两辟阳明各五、右心落”，在《脉书·下经》中有“咳，上气，胸胁盈口，口臂阳明”，可见，这一时期咳喘类病症与手阳明的关系较为密切，盖因马王堆帛书、老官山医简中的手太阴脉与心关系密切，与肺还未建立关系，因此秦汉早期咳喘类病症多选取手太阴脉以外的经脉进行治疗。其中“辟阳明”整理人员认为是阳溪穴，笔者认为此处“辟阳明”演化为《内经》中的“手阳明”，而后“手阳明”又演化为合谷、阳溪穴，因此“辟阳明”是指合谷、阳溪穴所在的范围。

偏历早期作为手阳明络脉名，后来变为络穴的名称，《灵枢·经脉》定位为“去腕三寸，别入太阴”，“去腕三寸”成为后世医籍定位偏历穴的标准。偏历穴主治病症《灵枢·经脉》以虚实进行区分：“实则聾聋，虚则齿寒痹隔。”为《明堂经》所承载，《明堂经》中除了收录络脉主治外，还包括手阳明脉常见病症。温溜、下廉、上廉、手三里首见于《明堂经》，其定位均与桡侧腕长伸肌有关^[1]，《明堂经》所载温溜穴多属古穴“手阳明”的主治病症。而上廉、手三里主治病症多为他穴主治误入。曲池穴属于手阳明合穴，《灵枢·本输》定位为“在肘外辅骨陷者中”，《明堂经》定位与《灵枢》类似“在肘外辅屈肘曲骨之中”，主治病症除手阳明脉典型病症外，还可见肘臂局部病变，如“肩肘中痛，难屈伸”“腕重急”等，曲池周围的穴位在秦汉医籍中多可以治疗局部症状，如肘髎穴《明堂经》主治“肩肘节酸重痹痛，不可屈伸”，曲池、肘髎均位于肘关节附近，《明堂经》中所载的这些局部病症，多为秦汉医家从临床经验中总结而来。

秦汉时期医家常有将脉名用作腧穴名，如《灵枢》中记载有“五里之脉”，即上臂屈面尺侧的肱动脉，秦汉医家多将其视为禁针处，如“阴尺动脉在五里，五腧之禁也”（《灵枢·本输》），手阳明脉“手五里”穴则位于上臂曲面桡侧，仅是借用“五里”之名，《明堂经》首载手五里定位为“肘上三寸，行向里大脉中央”，

^[1] 黄龙祥,黄幼民. 针灸腧穴通考:《中华针灸穴典》研究. 第一版[M]. 北京:人民卫生出版社,2011:190.

此处“行向里大脉中央”意为与“五里之脉”相对，老官山《刺数》载：“逆气，两臂、肘阳明各五及督。”其中“肘阳明”大概是指手五里穴，因为其主治病症中“心下胀满痛，上气……咳，呼吸难”均是“逆气”的表现，较为符合。臂臑在《内经》中用作部位名，多指上臂，如《素问·至真要大论》：“少阴司天……肩背臂臑及缺盆中痛……”《明堂经》径作为腧穴名，定位为“肘上七寸腠肉端”，“腠肉端”即三角肌下缘。其主治病症：“主寒热，颈痠适，肩痛不可举。”肩髃穴在《内经》中用作部位名，如《灵枢·经脉》：“……上循臂，乘肩髃。”《灵枢·经别》：“……从手循膺乳，别入肩髃。”《明堂经》中载其定位“在肩端两骨间”，主治也是局部病症：“主肩中热，指痹臂痛。”手五里、臂臑、肩髃都是从部位名转变为腧穴名。从《内经》到《明堂经》，腧穴数量由178增至365，这些新增加的穴位，其中有一部分是直接从部位名改为腧穴名，其主治病症的形成，也多是秦汉医家在该部位长期刺灸经验的积累。

巨骨穴《素问·气府论》归属“手太阳脉气所发”，未提定位与主治，《明堂经》定位为“肩上行两叉骨间陷者中”，“两叉骨”指锁骨与肩胛骨，其主治病症较为局限：“主肩背痹痛，臂不举，血瘀肩中，不能动摇。”天鼎穴由于其位置近扶突穴，故主治病症多与扶突穴相似，针对咽喉部病症。《灵枢·寒热病》将扶突穴归属为“天牖五部”，《灵枢·本输》所载颈项部十穴中也有扶突，其定位、归经与主治见于《灵枢·寒热病》，笔者认为这种情况属秦汉时期腧穴新增的一种方式，即在古穴附近发现治疗作用类似的新穴。口禾髎、迎香从现有文献来看，均是汉代中后期所发现、定名的腧穴，其定位、归经、主治病症均首载于《明堂经》，主治病症较为局限，多为口鼻部病症。

《内经》商阳、二间、三间、合谷、阳溪、曲池、扶突归属于手阳明脉；偏历为“手阳明之别”。

《明堂经》商阳、二间、三间、合谷、阳溪、曲池归属于手阳明脉；手五里、天鼎、扶突、口禾髎为“手阳明脉气所发”；臂臑为“手阳明络会”；肩髃、巨骨为“手阳明、蹻脉之会”；偏历为“手阳明络”；温溜为“手阳明郄”；迎香为“手足阳明之会”；下廉、上廉、手三里、肘髎未言经脉归属。

4.8 手少阳脉腧穴

关冲穴是本经井穴，其定位、归经、主治病症详载于《内经》，《灵枢·本输》定位为“手小指次指之端”，主治病症主要是心系和五官病症，如“烦心，心痛”（《灵枢·热病》）“耳聋”（《灵枢·厥病》），均为《明堂经》所承载，老官山《刺数》中有：“聋，两辟（臂）少阳各五。”“辟少阳”后世称“手少阳”，意为耳聋可选择手少阳脉腧穴进行治疗。液门、中渚分别是手少阳脉荣穴、输穴，其定位载于《灵枢·本输》，即“液门，小指次指之间也……中渚，本节之后陷者中也”，主治病症见于《明堂经》，多为头面五官病症。

阳池穴是本经原穴，《灵枢·本输》定位为“腕上陷者之中”，主治病症载于《明堂经》：“主寒热，痃疟，肩痛不能自举，汗不出，颈痛。”外关穴首载于《内经》，既是络脉名，又是腧穴名，《灵枢·经脉》定位为“去腕二寸”，主治病症分虚实两端：“实则肘挛，虚则不收。”在《明堂经》中则变为“肘中濯濯，耳渟渟浑浑无所闻，臂内廉痛，不可及头”，文字改动较大，说明《明堂经》作者在撷取《内经》条文进行编著时加入了自己的理解认识，或者另有所本。支沟穴为本经经穴，《灵枢·本输》定位为“上腕三寸，两骨之间陷者中”，与支沟穴位于同一水平者还有会宗穴，会宗穴首见于《明堂经》，其定位为“腕后三寸空中”，但会宗穴主治较为特殊：“上空主皮毛，中空主肌肉，下空主耳聋，羊痫。”意为会宗穴在空间层次上由浅至深可以分为三层，且每一层主治都不同，提示我们秦汉医家已对腧穴的空间层次进行思考，不同层次主治不同病症，或许与刺激量的大小或针尖到达的组织不同有关。三阳络、四渎、清冷渊、消泺、臑会、肩髃、天髃，此七穴均首见于《明堂经》，主治病症较为局限，应是汉代中后期发现并定名的腧穴。天井穴为本经合穴，《灵枢·本输》定位于“肘外大骨之上陷者中”，其中“肘外大骨”指的是尺骨鹰嘴，天井穴主治肘肩局部症状外，还治疗心及心神的病变。翳风穴《内经》未载，《明堂经》定位为“在耳后陷者中，按之引耳中”，主治病症均与口耳相关：“主聋，口僻不正，失欠，口不开，瘖，喑不能言。”

《灵枢·论疾诊尺》：“婴儿病……耳间青脉起者，掣痛。”《灵枢·五邪》：“邪在肝……行善掣……取血脉以散恶血，取耳间青脉，以去其掣。”《千金要方·惊

病》：“治小儿暴病者……次灸两耳后完骨上青脉，亦可以针刺令血出。”^[1]《灵枢》中的“掣”意为抽搐，即“瘈”之意，《说文》：“瘈，小儿瘈病也。”《说文义证》：“谓小儿惊风，乍掣乍纵也。”故“掣”为瘈病（即痫病或惊风）的典型症状。《灵枢·五邪》即采取耳后青脉（浅表静脉）放血治疗此病。此处在《明堂经》中分布有两个穴位，即瘈脉穴、颅息穴，其中瘈脉穴定位“耳本鸡足青络”，主治：“主小儿病，瘈病，呕吐，泄注，惊恐失精，视瞻不明，眇眇。”颅息穴定位于“在耳后间青脉”，主治：“主身热头胁痛，不可反侧。小儿惊病，喘不得息。耳鸣，不闻人言。”^[2]可见瘈脉、颅息两穴，是由古人于耳后静脉刺络放血治疗小儿痫病、惊风的方法演化而来，是典型的由脉分化为穴（一脉分化为两穴）的情况。

角孙穴《灵枢·寒热病》定位于“鼻与颧前”，主要治疗“上齿齲”，《明堂经》定位于“耳廓中间上开口有孔”，主治“齿牙不可嚼，龈肿”。老官山《刺数》：“血齲：齲在上，两耳前少阳；在下，颊阳明各五。”整理人员认为“耳前少阳”是耳门穴，笔者认为应该是角孙穴。耳门、耳和髎、丝竹空均出自于《明堂经》，为汉代中晚期医家治疗头面五官疾病时发现、命名的腧穴，均治疗局部病症，而丝竹空穴又可治疗“风病，癲疾，狂，烦满”等精神、神经类疾病，应该与其位于头部，属阳经有关。

《内经》关冲、液门、中渚、阳池、支沟、天井、天牖归属于手少阳脉；外关为“手少阳之别”；角孙《内经》有载，但属于足太阳脉。

《明堂经》关冲、液门、中渚、阳池、支沟、天井归属于手少阳脉；外关为“手少阳络”；会宗为“手少阳郄”；臑会为“手阳明之络”；天髎为“手足少阳、阳维之会”；天牖为“手少阳脉气所发”；翳风为“手足少阳之会”；颅息、丝竹空为“足少阳脉气所发”；角孙为“手足少阳、手阳明之会”；耳和髎为“手足少阳、手太阳之会”；三阳络、四渎、清冷渊、消泺、肩髎、瘈脉、耳门未言及经脉归属。

^[1] [唐]孙思邈撰；李景荣等校释. 备急千金要方校释[M]. 北京：人民卫生出版社，2018：157.

^[2] [汉]佚名撰；黄龙祥辑校，王雪苔审订. 黄帝明堂经辑校[M]. 北京：中国医药科技出版社，1987：69.

4.9 手太阳脉腧穴

少泽为本经井穴,《灵枢·本输》定位为“小指之端”,即手小指尖端,其主治病症《内经》未载,《明堂经》中除“小指不用”“小指之间热”外,多采集自其他经、穴的主治病症^[1]。前谷穴为本经荣穴,《灵枢·本输》定位为“手外廉本节前陷者中”,《明堂经》前谷穴主治病症多见于《内经》中手太阳经脉、络脉、经筋以及“手太阳”相关条文。后溪穴为手太阳脉输穴所注,《灵枢·本输》定位于“在手外侧本节之后”,后溪穴即古穴“手太阳”,《明堂经》中后溪穴的主治病症几乎均见于《内经》涉及“手太阳”的相关条文。

表 29 《内经》《明堂经》后溪穴主治条文对比

出处	《内经》	《明堂经》
定位	手外侧本节之后	手小指外侧本节后陷中
	嗌痛颌肿,不可以顾……耳聋……颈颌肩臑肘臂外后廉痛。《灵枢·经脉》	颈颌肿……颈项强。 肩臑肘臂痛,头眩痛不可顾。 发聋,臂重痛,肘挛。
	手太阳之别……实则节弛肘废,虚则生疣,小者如指痂疥。《灵枢·经脉》	痂疥
主治病症	癫疾始生,先不乐,头重痛,视举目赤。《灵枢·癫狂》	癫疾数发……目赤痛。
	狂,目妄见。《灵枢·癫狂》	狂互引
	手太阳厥逆,耳聋泣出。《素问·厥论》	泣出而惊
	若寒甚,若独肩上热甚。《灵枢·邪气脏腑病形》	主振寒,寒热,烦满身热。 恶寒……身寒。

腕骨在《内经》中,既作为部位名“骨名”,又作为腧穴名,《灵枢·本输》定位为“手外侧腕骨之前”,作为骨名,则是指三角骨。该穴主治集中载于《明堂经》中,多为手太阳经脉病症。阳谷穴为本经经穴,《灵枢·本输》定位于“锐骨之下陷者中”,此处“锐骨”指的是尺骨茎突,《明堂经》中该穴主治也多是手太阳脉病候。养老穴首见于《明堂经》,定位“在手踝骨上一空,在后一寸陷者中”,其主治较为简单,为上肢局部病症,如“肩痛”“手不能自上下”等,直接承自《内经》手太阳脉的“是动病”。支正是手太阳络穴,《内经》时代“支正”既是手太阳络脉的脉名,又是腧穴名,其定位《灵枢·经脉》为“上腕五寸”,所主病症分虚实两端,即“实则节弛肘废,虚则生疣,小者如指痂疥”,均被《明堂经》所承。

^[1] 黄龙祥,黄幼民. 针灸腧穴通考:《中华针灸穴典》研究. 第一版[M]. 北京:人民卫生出版社,2011:519.

小海穴为本经合穴,《灵枢·本输》定位为“肘内大骨之外,去端半寸陷者中”,《明堂经》本穴主治多为手太阳脉病候。

肩贞穴最早见于《素问·气府论》,仅记载穴名、归经:“手少阳脉气所发……肩贞各一。”《明堂经》定位为“肩曲胛下两骨解间,肩髃后陷者中”,但经脉归属则与《内经》不同,为“手太阳脉气所发”,可见肩贞穴归经在秦汉时期已经发生转变(手少阳脉→手太阳脉)。其主治也多为寒热病、局部病症如“肩中热痛”“手臂麻痹不举”等。臑俞、天宗、秉风、曲垣、肩外俞、肩中俞均首载于《明堂经》,主治多为局部病变。笔者认为可能均为汉代中后期定位、命名的腧穴。

天窗穴《内经》有载,《灵枢·根结》中为手太阳脉所入之处,又是《灵枢·本输》颈项部十穴之一,《明堂经》定位为“曲颊下,扶突后,动脉应手陷者中”,此处“动脉”应是颈动脉,主治病症多为头颈部病变,如“喉痛”“耳鸣”“耳聋无闻”“颊肿痛”等,主治病症中两次出现“耳鸣”,说明《明堂经》天窗穴主治病症至少是由两个症候群构成,也说明《明堂经》腧穴主治病症是辑自不同的针灸方。天容穴《内经》详载穴名、定位、归经及主治,《灵枢·本输》:“次脉足少阳也,名曰天容。”《明堂经》改其归经为“手少阳脉气所发”。《灵枢·刺节真邪》中记载了哮喘病急性发作时的症状,并称患者“病恶埃烟,饒不得息”,故并将其命名为“振埃”,在治疗时选取天容穴,并且强调“无过一里”,“一里”即“一寸”,《明堂经》所载天容穴主治病症,多与《内经》相合。

颧髎穴位于颧骨下缘,《素问·气府论》中“颧骨下各一”即指此穴,《明堂经》定位为“面颧骨下廉陷者中”,更为准确,主治面口五官局部病症:“口僻,頔肿唇痛,面赤,目赤,目黄,口不能嚼,齿痛。”

听宫穴《内经》有“听宫”“多所闻”不同称谓,“多所闻”为本穴的俗名、别名,是按照腧穴主治功效进行命名,《素问·气穴论》:“耳中多所闻二穴。”提示定位于“耳中”,《灵枢·刺节真邪》中用大段文字描述“发蒙”这一古代治疗方法时,提到“刺其听宫”,而后《明堂经》定位:“听宫,在耳中珠子,大如赤小豆。”后世文献则将其定位于耳屏正中与下颌骨髁突之间的凹陷中,《明堂经》听宫穴主治病症可分为两个症状群组:

症状群组 1: 主惊狂,瘖疾,眩仆,癰疾,瘖不能言,羊鸣沫出。

症状群组 2：耳聋填填如无闻，**聵聵聵聵**若蝉鸣、頔鳩鸣。

其中症状群组 1 与听会穴主治病症相同，应该是抄自同一首针灸方。

《内经》少泽、前谷、后溪、腕骨、阳谷、小海、天窗归属于手太阳脉；支正为“手太阳之别”；天容属于“足少阳也”；听宫（耳中）为“手太阳脉气所发”。

《明堂经》少泽、前谷、后溪、腕骨、阳谷、小海归属于手太阳脉；养老为“手太阳郄”；支正为“手太阳络”；肩贞、天宗、天窗、天容为“手太阳脉气所发”；臑俞为“手足太阳、阳维、蹻脉之会”；秉风为“手阳明、太阳、手足少阳之会”；颛髷为“手少阳、太阳之会”；听宫为“手足少阳、手太阳之会”；曲垣、肩外俞、肩中俞未言经脉归属。

4.10 足太阴脉腧穴

《灵枢·本输》将隐白定位为“足大指之端内侧”，“足大指内侧”也是《内经》中隐白穴的别称，如《素问·缪刺论》：“尸厥，刺其足大指内侧爪甲上。”或称之为“足太阴大指之端”，如《灵枢·热病》：“气满胸中喘息，取足太阴大指之端。”《明堂经》隐白穴主治病症多可以在《内经》中找到对应原文，如下表所示：

表 30 《内经》《明堂经》隐白穴主治条文对比

《内经》	《明堂经》
太阴之厥，则腹满腹胀……不欲食，食则呕，不得卧。《素问·厥论》	腹中有寒气。不得卧，膈中闷，呕吐不欲食饮。
气满胸中喘息，取足太阴大指之端。《灵枢·热病》 气虚者肺虚也，气逆者足寒也。《素问·通评虚实论》	气喘，气满胸中热，仰息……足胫中寒，足下寒。
身脉皆动，而形无知也，其状若尸。《素问·缪刺论》	尸厥，死不知人，脉动如故。
是动则病……腹胀善噫……身体皆重。是主脾所生病者，舌本痛，体不能动摇，食不下，烦心，心下急痛，溏、痾、泄，水闭。《灵枢·经脉》	烦心善悲，腹胀逆息，暴泄，身体痛。
热厥取足太阴、少阳，皆留之。《灵枢·寒热病》	主热病，衄血不止……热气……饮渴，多唾。

大都为本经荣穴，《灵枢·本输》定位为“本节之后，下陷者之中也”，《内经》中多用于治疗“热病”（《灵枢·热病》）“胃心痛”（《灵枢·厥病》）“风逆暴四肢肿，身漯漯，唏然时寒，饥则烦，饱则善变”（《灵枢·癫狂》），这些症状多被《明堂经》所承载。

太白《灵枢·本输》定位为“腕骨之下也”，但容易与上肢腕骨相混，《明堂经》将其定位修改为“足内侧核骨下”，其中“核骨”指的是第一跖骨。《明堂经》主治病症属于《内经》中“脾热病”（《素问·刺热》）“胃心痛”（《灵枢·厥病》）以及足太阴络脉、经脉病症。其中“暴泄善饥而不欲食，善噫，热中，足清，腹胀食不化，善呕泄，有脓血，苦呕无所出，先取三里，后取太白、章门主之”这条针方提示我们，太白仅是针对其中的“腹胀”这一症状的配穴。

公孙穴是足太阴络脉，既是络脉名，又是腧穴名，《灵枢·经脉》定位为“去本节之后一寸”，病变分为虚实两端：“厥气上逆则霍乱，实则肠中切痛，虚则鼓

胀。”《明堂经》公孙穴主治病症多见于《内经》相关条文，如“足太阴之疟”（《素问·刺疟》）“厥头痛”（《灵枢·厥病》）“狂证”（《灵枢·癫狂》）以及足太阴脉的典型病症。

商丘为本经经穴，《内经》定位为“内踝之下，陷者之中也”，《明堂经》主治病症多见于《内经》相关条文，这些病症中，均伴有脾病症状，所以选择足太阴脉的穴位进行治疗：

表 31 《内经》《明堂经》商丘穴主治条文对比

《内经》	《明堂经》
厥头痛，面若肿起而烦心，取之足阳明太阴。《灵枢·厥病》	烦心……厥头痛。面肿起。
狂者多食，善见鬼神，善笑而不发于外者。《灵枢·癫狂》	狂，多食，善笑不发于外。
脾疟者……刺足太阴。《素问·刺疟》	疟寒，腹中痛，痛已汗出。
厥而腹向向然……便溲难，取足太阴……腹向向然，不能大便，取足太阴……心痛腹胀……大便不利，取足太阴。《灵枢·杂病》	腹满向向然，不便，心下有寒痛。
足太阴之疟，令人不乐，好太息，不嗜食。《素问·刺疟》	脾虚令人病寒不乐，好太息……不欲食。

三阴交穴最早见于《明堂经》，定位于“内踝上八寸”，主治下肢病症：“足下热，胫痛不能久立，湿痹不能行。”阴陵泉是本经合穴，《内经》中有两种称谓“阴之陵泉”“阴陵泉”，《灵枢·本输》定位为“辅骨之下，陷者之中”，《内经》用以治疗“飧泄”（《灵枢·四时气》）与“热病”（《灵枢·热病》），而《明堂经》主治病症主要以脾胃、妇科及前阴病为主。漏谷、地机、血海、箕门、冲门、府舍、腹结、大横、腹哀、食窦、天溪、胸乡、周荣诸穴均在传世文献中首见于《明堂经》，主要治疗局部病变，如漏谷、地机主要治疗脾胃症状，食窦、天溪、胸乡、周荣主要治疗胸胁部病症等。

大包穴首见于《灵枢·经脉》，作为脾之络脉的名称，《灵枢·经脉》载其循行为“出渊腋下三寸，布胸胁”，主治病症也分虚实两端，即“实则身尽痛，虚则百节尽皆纵”，《明堂经》中对大包穴的定位与《内经》相同，可知秦汉医家均习惯将大包作为一个络脉看待，《明堂经》主治病症除《内经》虚实病症外，还包括

胸肺局部病症，如“大气不得息”。

《内经》有明确定位及归经者共 6 穴：隐白、大都、太白、商丘、阴陵泉。

《明堂经》血海、箕门、食窦、天溪、胸乡、周荣为“足太阴脉气所发”；三阴交为“足太阴、厥阴之会”；漏谷为“足太阴络”；地机为“足太阴郄”；冲门、府舍、大横、腹哀为“足太阴、阴维之会”；大包《内经》也有载，与《明堂经》均定义为“脾之大络”，从脾脏直接发出，大包穴直至《铜人腧穴针灸图经》方才归于足太阴脾经。此外，腹结穴《明堂经》未提及经脉归属。

4.11 足厥阴脉腧穴

大敦穴是本经井穴,《灵枢·本输》定位为“足大指之端及三毛之中”,“及”有到达之意,《广雅》:“及,至也。”《韩非子·喻老》:“汤熨之所及也……针石之所及也……”^[1]秦汉时期,大敦穴的定位在足大趾背丛毛(即三毛穴)处。《灵枢·经脉》对足厥阴脉的起点定位为“起于大指丛毛之际”,《明堂经》定位与《内经》相同。《内经》中一般用“三毛”或“足大指爪甲”代称,用以治疗“卒疝暴痛”(《素问·缪刺论》)“癰”(《灵枢·热病》),《明堂经》主治病症多为前阴病变,其中“卒心痛汗出,大敦主之,出血立已”应该是抄自某个早期针灸方,属于单穴点刺出血疗法。“卒疝暴痛,灸刺之,男子立已”应该撷取自《素问·缪刺论》,但并未全引,有所遗漏。

行间穴为本经荥穴,《灵枢·本输》定位为“足大指间也”,太冲穴的古穴名为“足厥阴”,是足大指间整个脉动处,演化为行间、太冲两穴,太冲穴是本经输穴,《灵枢·本输》定位以行间穴为参照“行间上二寸陷者之中”,《明堂经》中两穴的部分主治病症直接撷取自《内经》。中封穴为本经经穴,《灵枢·本输》载其定位为“内踝之前一寸半,陷者之中”,《明堂经》定位与《内经》相同“在足内踝前一寸”,“内踝之前”准确定位应该是前下方,《内经》和《明堂经》有“一寸半”和“一寸”的差别,《明堂经》主治病症主要是疟病和阴疝的症状。

蠡沟是本经络脉名,《灵枢·经别》定位为“去内踝五寸”,病变集中在阴部,分虚实两端:“其病气逆则辜肿卒疝,实则挺长,虚则暴痒。”《明堂经》定位为“足内踝上五寸”,主治病症多为前阴病症。老官山《刺数》中记载有“肱厥阴”这一古穴,《刺数》:“□□山,暴、仑、癰,转胞,两肱厥阴各五……颓疝,两肱臑(厥)阴各五。”“肱厥阴”是指足厥阴肝经经过小腿这一段经脉上所分布的穴位,根据《内经》记载,认为“肱厥阴”相当于蠡沟穴(黄龙祥先生认为在足背太冲脉处)。

曲泉穴是本经合穴,《灵枢·本输》定位为“辅骨之下,大筋之上”,主治病症《内经》有散论,如《灵枢·癫狂》取曲泉治疗“狂而新发,未应如此者”,《灵枢·厥病》治疗“病注下血”。《明堂经》主治针对妇科病、前阴病。中都、膝关、阴包、足五里、阴廉、章门、期门诸穴,传世文献中均首载于《明堂经》,主治也

^[1] [战国]韩非撰;张松辉,张景译注.韩非子译注[M].上海:上海三联书店,2018:191.

以局部病症为主，如妇科病、前阴病等。其中，膝关穴的主治病症中“连腹引咽喉痛”，是曲泉穴主治“少腹痛引噎”的另外一种表述方法。期门穴又见于《伤寒论》^[1]：“伤寒腹满而谵语寸口脉浮而紧者，此为肝乘脾，名纵，当刺期门。”又：“妇人中风，发热恶寒，经水适来，得之七八日，热除而脉迟身凉，胸胁下满，如结胸状，谵语者，此为热入血室也，当刺期门，随其实而取之。”记载期门穴可以治疗“纵”“热入血室”两个疾病，为仲景使用最多的穴位^[2]，而《明堂经》中期门穴的主治病症，多是肝胆胸胁处发生病变之后表现的具体症状，如“胸胁痞满”“奔肭胁下气上下，胸中有热”“胁下积聚”“胁下满”等，故古代针灸方中，期门是针对胸胁病变而常用的腧穴之一。

《内经》大敦、行间、太冲、中封、曲泉归属于足厥阴脉；蠡沟为“足厥阴之别”。

《明堂经》大敦、行间、太冲、中封、曲泉归属于足厥阴脉；蠡沟为“足厥阴之络，别走少阳”；中都为“足厥阴郄”；膝关为“足厥阴脉气所发”；阴包为“足厥阴别走”；章门为“足厥阴、少阳之会”；期门为“足太阴、厥阴、阴维之会”；足五里、阴廉则未提及与经脉的关系。

^[1] [汉]张仲景撰；[金]成无己注. 注解伤寒论[M]. 北京：人民卫生出版社，2012：89.

^[2] 卞楠，隋月皎，田辉. 伤寒论期门穴应用探究[J]. 中国针灸，2018，38(04)：387-389.

4.12 足少阴脉腧穴

涌泉穴秦汉时期又称之为“足心”“足下中央之脉”，《灵枢·本输》：“涌泉者，足心也。”此外，“涌泉”二字还见于《内经》对脉象的描述中，如“浑浑革至如涌泉”（《素问·脉要精微论》）“脉至如涌泉”（《素问·大齐论》），涌泉穴的主治病证《内经》有载，《灵枢·五邪》取涌泉、昆仑主要治疗“阴痹”，《灵枢·热病》用以治疗“热病挟齐急痛，胸胁满”以及刺络放血治疗“男子如蛊，女子如阻，身体腰脊如解，不欲饮食”，《史记·扁鹊仓公列传》中记载了淳于意用涌泉治疗“热厥”的案例，“足心”与“热厥”之间的关联，《内经》也有论述，《素问·厥论》中黄帝问：“热厥之为热也，必起于足下者何也？”提出足下是热厥起始处，岐伯回答：“阳气起于足五指之表，阴脉者集于足下，而聚于足心，故阳气盛则足下热也。”“厥”与足之间的关系，还见于《吕氏春秋》以及张家山《引书》^[1]，可见涌泉穴秦汉时期应用较为频繁，《明堂经》记载其主治病症较为丰富，多伴有热证如“身热，热争则项痛而强”“足下热”“热中少气”“身热痛”等，其中部分主治病症已见于《内经》中。

然谷穴是本经荣穴，《灵枢·本输》定位为“然骨之下”，《明堂经》进一步定位为“足内踝前起大骨下”，相当于对“然骨”这一位置进行解释，本穴主治病症见于《灵枢·厥病》，用以治疗“发狂不已”“脾心痛”。太溪穴是本经输穴，属于古穴“足少阴”，《灵枢·本输》定位为“内踝之后，跟骨之上陷中”，主治病症为“脾心痛”，《明堂经》定位“跟骨上动脉陷者中”，指出太溪穴所在位置能触及到动脉搏动（即胫后动脉）。

大钟是本经络穴，故早期大钟既是足少阴肾经络脉名称，又是腧穴名（络穴），《灵枢·经别》载其定位为“当踝后绕跟，别走太阳”，病变也分虚实两端：“其病气逆则烦闷，实则闭癰，虚则腰痛。”《明堂经》记载其主治病症可分为五组症状群，均见于《内经》相关条文，如表 35 所示。

复溜穴是本经经穴，《灵枢·本输》定位为“上内踝二寸”，并且提及此处“动而不休”，《明堂经》中将“昌阳”作为本穴的别名，“昌阳”已出现在《内经》中，即“昌阳之脉”（《素问·刺腰痛》），“昌阳”是脉穴同名的典型。“昌阳之脉”病

^[1] 杨峰,赵京生.“蹶”的探析——一个早期医学名词的考察[J].中国中医基础医学杂志,2009,15(02):92-95.

变（腰痛，痛引膺，目眈眈然，甚则反折，舌卷不能言）也被《明堂经》归入复溜穴主治病症中。阴谷穴是本经合穴，《灵枢·本输》：“肾出于涌泉……入于阴谷，阴谷，辅骨之后，大筋之下，小筋之上也，按之应手，屈膝而得之，为合，足少阴经也。”《明堂经》主治病症涉及前阴及妇科病证。水泉、照海、交信、筑宾、横骨、大赫、气穴、四满、中注、盲俞、商曲、石关、阴都、腹通谷、幽门、步廊、神封、灵墟、神藏、臑中、俞府诸穴均在传世文献中首载于《明堂经》，主治局部病变，如横骨、大赫、气穴、四满主治前阴、妇科病，盲俞、商曲、石关、阴都、腹通谷、幽门主治腹部、胃肠病，步廊、神封、灵墟、神藏、臑中、俞府多主治胸肺部病症，笔者认为这些穴位在秦汉时期较为晚出。

表 32 《内经》《明堂经》大钟穴主治条文对比

《内经》	《明堂经》
肾疟者……刺足太阳少阴。《素问·刺疟》	主疟多寒少热，凄凄然腰脊痛，宛转，目循循然。
腹大，亦上走胸膈，喘息喝喝然，取足少阴。《灵枢·杂病》	腹满，大便难，时上走胸中鸣，喘，少气不足以息。
实则闭癃，虚则腰痛。《灵枢·经别》	实则闭癃，嗜卧，口中热。虚则腰痛，寒厥，烦心闷。
邪客于足少阴之络……噎痛，不可内食，无故善怒……刺足下中央之脉各三痛。《素问·缪刺论》	咽中痛，不可内食，善怒，惊恐不乐。
咳唾则有血，喝喝而喘……心惕惕如人将捕之……口热舌干，咽肿上气，噎干及痛……《灵枢·经脉》	咳，喉中鸣，咳唾血。 胀满，口舌干，口中吸吸，善惊。

《内经》涌泉、然谷、太溪、复溜、阴谷归属于足少阴脉；大钟为“足少阴之别”

《明堂经》涌泉、然谷、太溪、复溜、阴谷归属于足少阴脉；大钟为“别走太阳、足少阴络”；水泉为“足少阴郄”；照海为“阴跷脉所生”；交信为“阴跷之郄”；筑宾为“阴维之郄”；横骨、大赫、气穴、四满、中注、盲俞、商曲、石关、阴都、腹通谷、幽门为“冲脉、足少阴之会”；步廊、神封、灵墟、神藏、臑中、俞府为“足少阴脉气所发”。

4.13 督脉腧穴

长强穴《内经》又称为“穷骨”“骶下”“骶骨”“骨骶”，属于督脉之别络，《灵枢·经脉》记载其循行路径为“挟脊上项，散头上，下当肩胛左右，别走太阳，入贯膂”，病变分虚实两端，与头项脊柱相关，即“实则脊强，虚则头重，高摇之”，此外，《灵枢·癫狂》中记载艾灸此穴可治疗癫狂类病症，2018年荆州胡家草场西汉墓M12出土了一枚简牍，载有治疗小儿痫病“灸药并施”的医方，由于条文开始有“已痫”二字，故被称为“已痫方”^[1]：

已間（癇），先灸尻（尾）上三壯，取牡搗矢美棗，飢，乳計（汁）孰（熟）摩（摩），小未能（飲），以涂其母乳=（乳乳）之。

“尻（尾）上”大概在尾骶处，即传世医籍中的长强穴^[2]。荆州胡家草场西汉墓的时代下限为汉文帝后元元年（公元前163年）^[3]，可见长强穴这一部位在秦汉时期较早用于临床。无论是出土文献，还是《内经》，此处多用灸法。《明堂经》记载其定位为“在脊骶端”，主治集中于癫狂即前后阴局部病症，其中“小儿惊痫，瘕瘕，脊强互相引”与出土文献记载的“已痫方”可互参。

腰俞《素问》又称“脊骨下空”“腰尻交者”“腰尻之解”，《内经》主要用以治疗“腰痛”（《素问·刺腰痛》《素问·缪刺论》），《明堂经》定位为“在第二十一椎节下间，督脉气所发”，主治病症除腰痛外，还有妇科病证如“女子闭溺”“乳子下赤白”等。

命门在秦汉时期有不同的含义，命门一词，《内经》指“目”（《灵枢·根结》《灵枢·卫气》），是足太阳脉上结之处，足太阳脉在头面部止于目内眦，因此这里的“目”实际上是指睛明穴，而《难经·三十六难》中“肾两者，非皆肾也，其左者为肾，右者为命门……”表明命门是“右肾”。“命门”作为腧穴名称见于《明堂经》，定位为“在第十四椎节下间，督脉气所发”，取穴需“伏而取之”。主治病症为：“主头痛如破，身热如火，汗不出，瘕瘕里急，腰腹相引痛。”悬枢穴见于《明堂经》，定位为“在第十三椎节下间”，主治病症为腹部病变：“主腹中积气上下行，不仁。”脊中《素问·骨空论》用以治疗“失枕”，《明堂经》定位为“在

^[1] 周琦,李志芳.荆州胡家草场西汉墓医方木牍“已痫方”初探[J].简帛研究,2020(02):150-161.

^[2] 袁开惠.荆州胡家草场木牍载痫病方药物与疗法考[J].中医药文化,2022,17(01):85-90.

^[3] 李志芳,蒋鲁敬.湖北荆州市胡家草场西汉墓M12出土简牍概述[J].考古,2020(02):21-33+2.

第十一椎节下间”，取穴方法“俯而取之”，主治腰腹部病症：“主腰脊强，不得俛仰，黄痺，腹满不能食。”筋缩穴出于《明堂经》，定位为“在第九椎节下间”，主治病症均见于肝俞穴，与小儿惊痫相关。

至阳、神道、身柱、陶道、强间、后顶、百会、前顶、囟会、上星、神庭、素髻、水沟、兑端诸穴在传世医籍中均首见于《明堂经》，主治病症多为局部病症，如神道、身柱主治神志病变，陶道、大椎主治热病，强间、后顶、百会、前顶、囟会、上星主治头面部病变，水沟、兑端由于刺激性强，主治神志病以及局部口齿病变。大椎见于《内经》，既作为骨名，又作为腧穴名，《素问·骨空论》用作“灸寒热”，并且强调“以年为壮数”，《明堂经》定位为“第一椎上陷者中，三阳督脉之会”，主治“伤寒热盛，烦呕”，其中“烦呕”应该是热证的伴发症状，因此，秦汉时期大椎主治病症是热证。哑门穴《素问·气穴论》称为“瘖门”，《明堂经》称“暗门”，宋代《铜人腧穴针灸图经》作“痙门”，《明堂经》定位为“项后发际宛宛中”，主治病症主要是局部、舌咽病变：“项强，舌缓，暗不能言。”

风府穴载于《内经》，风府所在部位容易为风邪所客，故称之为“风府”，如《灵枢·岁露论》：“邪客于风府，病循脊而下……故每至于风府则腠理开，腠理开则邪气入……”《灵枢·本输》对该穴进行定位与归经：“颈中央之脉，督脉也，名曰风府。”《内经》时代医家认为该穴与脑相通，《灵枢·海论》：“脑为髓之海，其输上在于其盖，下在风府。”并且归属于《灵枢·本输》所记载的颈项部十穴之一。主治病症主要是外感发热病和舌咽病变，《伤寒论》第二十四条中也有所提及：“太阳病，初服桂枝汤，反烦不解者，先刺风池、风府，却与桂枝汤则愈。”《素问·骨空论》对风府治疗外感病进行详细的论述：“风从外入，令人振寒，汗出头痛，身重恶寒，治在风府。”但《明堂经》中并未记载风府穴可以治疗外感热病，主要是头目病症以及癫狂等。

脑户穴首载于《内经》，由于穴下就是脑组织，刺太深容易出现医疗事故，故《素问·刺禁论》：“刺头，中脑户，入脑立死。”《明堂经》中主要用于治疗头目病症，如“头重项痛”“头中恶风”“目不明”，以及癫狂类病症如“癫疾”“狂，瘖痴”等。

龈交穴首见于《内经》，《素问·气府论》将其归属于任脉，即“任脉之气所

发……断交一”，但并未提及定位及主治，直至《铜人》中归于督脉。《明堂经》定位为“在唇内齿上龈缝”，主要治疗口、齿、鼻部病症如“口僻”“齿间出血”“齿床落痛”“鼻中息肉不利”“目痛不明”等。

《内经》长强为“督脉气所发”；风府为“颈中央之脉，督脉也”。

《明堂经》长强为“督脉别络，少阴所结”；腰俞、命门、悬枢、脊中、筋缩、至阳、神道、身柱、强间、后顶、前顶、囟会、上星、素髌为“督脉气所发”；陶道、脑户、百会为“督脉、足太阳之会”；大椎为“三阳、督脉之会”；哑门、风府为“督脉、阳维之会”；神庭为“督脉、足太阳、阳明之会”；水沟为“督脉、手阳明之会”；兑端为“手阳明脉气所发”。

4.14 任脉腧穴

会阴在《内经》中用作脉名，如《素问·刺腰痛》中引起腰痛的“会阴之脉”，而会阴穴在《内经》中则称之为“尾翳”，既作为脉名，又作为腧穴名，为“任脉之别”（《灵枢·经脉》），其循行为“下鸠尾，散于腹”，主治病症也分为虚实两端“实则腹皮痛，虚则痒搔”，《明堂经》定位为“两阴之间”，主要治疗前后阴诸证。

关元最早载于《内经》，主要用以治疗“体惰”（《灵枢·寒热病》）“寒热”（《素问·骨空论》），并且定位于“脐下三寸”，关元在《素问·举痛论》中又是冲脉的起点，《素问·气穴论》中还将关元称为“上纪”。《明堂经》主要用于治疗前阴、妇科病证，关元穴治疗妇科病，还见于《金匱要略》：“妇人伤胎怀身，腹满，不得小便，从腰以下重，如有水气状，怀身七月，太阴当养不养，此心气实，当刺泻劳宫及关元，小便微利则愈。”表明秦汉医家对关元穴应用较为频繁。气海穴在《内经》称为“膻腧”，为“肓之原”（《灵枢·九针十二原》），《明堂经》定位在“脐下一寸五分”，主治疝病。

神阙穴首载于《内经》，《素问·气穴论》仅记载“脐一穴”，神阙作为腧穴名首见于《铜人腧穴针灸图经》。《明堂经》称之为“脐中”，明确提出禁止针刺，并且描述针刺后发生感染导致死亡的医疗事故：“脐中，禁不可刺，刺之令人脐中恶疡，溃矢出者死不治。”故《明堂经》所提到的本穴诸多主治病症，应该主要是采用艾灸治疗：“主水肿，大脐平腹，无理不治，绝子，脐疝绕脐痛，冲胸不得息，肠中常鸣，时上冲心。”上脘、中脘、下脘三穴已见于《内经》，均作为部位名，是将胃府从上到下分为三个部分，主要治疗“饮食不下，膈塞不通”（《灵枢·四时气》），作为腧穴名则见于《明堂经》，主要针对胃肠腹部疾患。

鸠尾在《内经》中，既作为部位名，又作为腧穴名，作为部位名是指胸骨下端的剑突，如《素问·气府论》：“足阳明脉气所发……侠鸠尾之外，当乳下三寸……任脉之气所发……鸠尾下三寸……冲脉气所发……侠鸠尾外各半寸至齐寸一……”将鸠尾作为定位参考标准。该穴具体定位则出自《明堂经》：“在臆前蔽骨下五分。”主要针对胸腹部病症，其中需要注意的是任脉别络病变“实则腹皮痛，虚则痒搔”也归属于鸠尾主治病症之下，黄龙祥先生认为^[1]这一现象是因为鸠尾穴

^[1] 黄龙祥. 试论非实践因素对经穴主治演变的影响[J]. 中国中医基础医学杂志, 2000(11): 4-12.

别名“尾翳”与任脉之络同名，这也提示我们，《明堂经》中的腧穴主治并非全部来自于临床实践总结。

膻中《内经》用作部位名，即“心主之官城”（《灵枢·胀论》），《素问·灵兰秘典论》将“膻中”与五脏六腑并列，其重要性与脏腑等同，膻中与手厥阴脉关系密切，如《素问·刺法论》：“膻中者，臣使之官，喜乐出焉，可刺心包络所流。”，膻中作为腧穴名见于《明堂经》，定位为“在玉堂下一寸六分，直两乳间陷者中”，主要治疗心胸局部病症，如“胸痹心痛”“短气不得息”等。

天突《灵枢·本输》定位于“缺盆之中”，实际上是指胸骨柄正上方，《明堂经》进一步详细定位于“颈结喉下五寸中央宛宛中”，主要治疗胸、肺、咽喉等呼吸系统病症。廉泉最早见于《内经》，主要指舌下青脉（《素问·刺疟》），《灵枢·口问》：“胃缓则廉泉开，故涎下，补足少阴。”廉泉在此处明显指的是舌下腺的功能。

《灵枢·胀论》：“廉泉玉英者，津液之道也。”《内经》取廉泉也多为刺络放血，治疗“上气”“胸痛”（《素问·刺节真邪》），《内经》将此脉归属于足少阴脉，即《灵枢·根结》：“少阴根于涌泉，结于廉泉。”在《灵枢·癫狂》中直接称之为“舌下少阴”，用以治疗“狂始发”。《明堂经》定位于“在颌下结喉上舌本”，经脉归属为“阴维、任脉之会”，可见《内经》《明堂经》所讲的廉泉有差异，《明堂经》廉泉穴主治病症为：“主舌下肿，难以言，舌纵涎出，咳逆上气，喘息呕沫，齿噤。”

承浆在《内经》中，仅见于《灵枢·经脉》：“胃足阳明之脉……还出挟口环唇，下交承浆……”《明堂经》定位为“颐前下唇之下”，属于“足阳明、任脉之会”，取穴时要求“开口取之”，实际上取承浆穴开口闭口均可。《明堂经》主治多为急性病症，如“癫疾呕沫”“衄血不止”“痉，口噤互引”等。

曲骨、中极、石门、阴交、水分、建里、巨阙、中庭、玉堂、紫宫、华盖、璇玑诸穴在传世文献中首载于《明堂经》，主要治疗局部病变，如水分、建里主治腹部病症，玉堂、紫宫、华盖、璇玑主治胸肺部病症。其中，曲骨既是骨名，又是腧穴名，定位“中极下一寸毛际陷者中，动脉应手”，主要治疗前阴、妇科病。

《内经》明确归属于任脉的腧穴为会阴、天突。

《明堂经》会阴为“任脉别络，夹督脉、冲脉之会”；曲骨为“任脉、足厥阴之会”；中极、关元为“足三阴、任脉之会”；石门、气海、水分、巨阙、中庭、

膻中、玉堂、紫宫、华盖、璇玑为“任脉气所发”；阴交为“任脉、阴冲之会”；下脘为“足太阴、任脉之会”；中脘为“手太阳、少阳、足阳明所生，任脉之会”；上脘为“任脉、足阳明、手太阳之会”；鸠尾为“任脉之别”；天突、廉泉为“阴维、任脉之会”；承浆为“足阳明、任脉之会”；神阙、建里直至《外台》才归属于任脉。

5 先秦两汉腧穴理论演变讨论

5.1 腧穴理论的起源

5.1.1 早期腧穴理论载体

医学理论起源于先民懵懂且稚嫩的医疗经验,最初通过长期大量的临证实践后形成一定的经验认识,而这些经验的传承方式,首先是口耳相传,其次才以文字或绘图的形式出现,模型的出现应是在文字之后,只有经脉、腧穴理论发展到一定程度,形成较为完善的理论之后,方能刻画于模型,以先秦两汉时期的经济水平来看,制作一件栩栩如生的人体木胎髹漆模型,较为耗时耗力,只有经脉、腧穴理论的成熟,甚至在一定程度上的定型后,才可以保证一次性刻画准确无误。

《医心方·卷二·灸例法》中载有张仲景语:“凡欲灸者,当详所宜,审应灸处疏孔穴名,应灸壮数,出之以疏临图像,依注明寸数,量度点灸处,疏如<经>所记壮数也。”^[1]但目前并未发现秦汉时期的“明堂图”实物,后世所绘制的“明堂图”,有专绘经脉循行路线者,有专绘腧穴部位者,也有经脉腧穴同绘者,凡绘腧穴者,大多是根据《明堂经》中所记载的内容^[2]。现存秦汉时期的针灸模型,仅有绵阳双包山木人与成都老官山漆人,其中,双包山木人体表仅刻有经脉而无腧穴,老官山漆人不仅有红线、白线两套经脉系统,还有百余个清晰可见的腧穴,老官山漆人所代表的脉穴系统,处于马王堆帛书与《内经》之间,填补了两者之间的历史空白,对于梳理经脉、腧穴理论的源流具有重要的参考价值。下面笔者利用新出土的针灸文献、文物对先秦两汉时期影响腧穴演变的因素以及腧穴本身特点(如数量、命名、归经、主治病症等)的演变过程进行梳理:

5.1.2 腧穴形成因素探讨

腧穴的发展经历了从开始到成熟的过程,作为中医学的一个组成部分,也符合医学发展的一般规律,即由经验积累上升为理论指导。腧穴的起源时间,要远早于目前所见的文献、文物记载,远古时期先民劳动、生活过程中,由于卫生水平低、住宿条件简陋等原因,易患疾病。若某部位疼痛时,习惯于疼痛部位进行按、揉、锤打,以缓解痛楚,于是便将疼痛处作为最初的治疗点,是最早的自我诊疗过程,按、揉、锤打的部位只能算是体表刺激点,还不能称得上是腧穴。此

^[1] [日]丹波康赖.医心方[M].上海:上海科学技术出版社,1998:146.

^[2] 潘萍,郭义,王东强.“明堂图”源流简考[J].针灸临床杂志,2008,(05):1-3+58.

后，先民借助一些原始的医疗器械进行辅助治疗，比如将光滑的石头烤热后进行体表熨烫，用来治疗寒邪引起的痹痛，或者用较为锋利的石片进行切痈排肿。在这一过程中，治疗疾病与审察自身相互促进，在自我治疗的过程中对机体解剖结构、生理功能、病理改变的认识积累了越来越多的经验。这些经验的积累逐渐使得先民认识到：体表的某些固定部位具有较为广泛的治疗作用。

老官山漆人手足太阴脉上只有“太渊”“尺泽”两个疑似腧穴点，其共同特征是均位于动脉搏动处。可推测早期医家对动脉搏动处较为重视，我们将太渊与尺泽两点连成一线，大致等同于前臂屈面桡侧缘手太阴脉的循行路径。故早期医学体系中腧穴点以及经脉循行路径的建立，与动脉搏动处密切相关。秦汉医家多选取“脉动处”进行刺灸，《史记·扁鹊仓公列传》：“（病）在血脉，针石之所及也。”《论衡·顺鼓》：“投一寸之针，布一丸之艾于血脉之蹊，笃病有瘳。”^[1]对血脉的诊疗过程中，先民逐渐建立了“气穴”“气府”的概念，早期的血脉疗法，进一步促进了腧穴概念的形成。

老官山针方简《刺数》中提及的“肩阳明络”“腹阳明络”“足巨阳落”是“身体部位+阴阳+落/络”的命名形式，而“心落”是“脏腑+落”的命名形式，可见“落”在躯体内外均有广泛分布，“落”与“络”同意，如《灵枢·经脉》篇：“三焦手少阳之脉……布膻中，散落心包。”而其他篇章中又有“络心系”一词，络脉多为肉眼可见的浅表静脉，如《灵枢·经脉》：“诸脉之浮而常见者，皆络脉也。”整理人员认为“肩阳明络”这些早期腧穴名称，均是指刺络放血之处^[2]，是腧穴来源于刺血脉部位的一个有力的证据。根据《刺数》中已经公布的内容来看，针刺部位多在动脉搏动处，“阴阳”的概念与划分似乎与动脉搏动相关，进一步说明诊脉、治脉与腧穴概念形成之间的密切关系：

表 33 老官山《刺数》位于动脉搏动处的腧穴

《刺数》	《内经》	《明堂经》	动脉名称
辟（臂）阳明	手阳明	合谷、阳溪	桡动脉
颊阳明	手阳明	大迎	面动脉
辟（臂）太阴	手太阴	天府	肱动脉

^[1] [汉]王充. 论衡[M]. 上海: 上海人民出版社, 1974: 239.

^[2] 赵丹, 段逸山, 王兴伊. 试析老官山汉墓《刺数》“经脉穴”与《内经》腧穴的对应关系[J]. 中国中医基础医学杂志, 2019, 25 (02): 205-208.

随着生产力的发展,秦汉时期金属冶炼和加工水平有较大的提升^[1],随之针灸治疗工具也有了改善,“九针”的出现对当时针灸医疗水平有质的提升,“九针”不仅是针刺治疗用具,还是外科手术的操作器械,如《灵枢·九针十二原》:“锋针者,刃三隅,以发痼疾。铍针者,末如剑锋,以取大脓。员利针者,大如薙,且员且锐,中身微大,以取暴气。”临床经验的不断积累使得腧穴理论体系得到快速发展,“九针”的出现,提示“刺脉疗法”进入了一个全盛的发展阶段,实际上,青铜针、铁针出现之前,有骨针、石针可供选用。故腧穴形成要素主要是大量临床经验的积累,以及对皮、肉、筋、脉、骨等五体部位的刺灸认识。

5.1.3 早期腧穴、经脉的“共存关系”

先民消毒意识及水平有限,用骨针、石针刺破皮肤之后容易发生炎症化脓,造成严重的感染(如《明堂经》中乳中穴的禁忌,就是针刺之后出现的感染),甲骨文中已经出现“灸”字^[2],马王堆帛书提示我们经脉的出现可能与艾灸刺激有关,艾灸可以对较小范围的体表进行热刺激,灸感明显,如灸法大师周楣声先生对艾灸感传提出了“灸感三相”的认识,即定向传导期、作用发挥期、下降中止与循经再传期^[3]。古人在灸疗实践过程中,发现经气的感传可以呈现一定的路径,可能受此启发形成经脉理论,在这一过程中,艾灸的部位就逐渐成为了固定的治疗点,尤其是四肢远心端(肘膝关节以下)的感传作用更为明显,古人逐渐形成了对穴位的特殊认识。这一时期,腧穴与经脉之间是“共存关系”,而不是“互生关系”,腧穴(治疗刺激点)与经脉(艾灸感传路径)之间是独立发展的。笔者推测,人体体表面积有限,诊疗过程中积累的“脉”与“穴”逐渐增多,难免出现重合者,可能有医家会在灸感的循行路径上,再去主动寻找“刺激点”,使得灸感感传路径上的刺激点逐渐增多,循经而找的刺激点治疗作用与周围非经脉上的刺激点相比,局部治疗作用并无差别,但循经而找的刺激点却又具有较好的远端治疗作用,即刘兵先生所说的经穴与非经穴之间的区别主要是“气”与“形”的区别^[4],于是先民淘汰了原来散在的“非经穴”,保留了循经所找的治疗点,这样就使得腧穴归经,

^[1] 郭太品,任玉兰,刘沂滩,等.古代冶炼工艺技术与毫针的形质及手法演变[J].中医杂志,2014,55(19):1626-1629.

^[2] 冯时.商医灸炳考[J].中原文物,2022(01):139-144.

^[3] 周楣声.灸绳[M].青岛:青岛出版社,2017:191.

^[4] 刘兵.非穴的效应——基于传统针灸理论的分析[J].中国针灸,2019,39(02):161-165.

并逐渐成为了老官山漆人脉穴合一的理论体系。腧穴所在的部位，又称之为“气府”，“气”是指经脉之气，“府”是指汇集之处，故腧穴是经气汇集之处，“气府”的概念，应该是“腧穴归经”理论成熟之后才出现的。老官山《十二脉》中已经完整记载了十二经脉的循行走向与主治病症，但老官山漆人身上归于经脉的腧穴数目却仅有百余个，这一现象也体现在《内经》中，《灵枢·经脉》虽然已经形成了完整的经脉环形流注体系，但是腧穴理论却并不成熟^[1]。

腧穴在先秦两汉医家的认识中，并不是单纯由“皮、肉、筋、骨”等组合而成的治疗部位，腧穴有其自身的生理功能“神气所游行出入也”，《内经》中“气穴”“气府”“节”“会”“脉气所发”，是对腧穴的早期称呼。当机体处于疾病状态下，腧穴又可以起到反映病邪的作用，如《灵枢·九针十二原》：“五脏有疾也，应出十二原，而原各有所出，明知其原，睹其应，而知五脏之害也。”“明知其原”指的是十二原穴，而“睹其应”是指观察腧穴的反应，其中“睹其应”不仅仅是观察皮肤表面的颜色变化，还涉及到《灵枢·九针十二原》所讲的：“凡用针者，虚则实之，满则泄之，宛陈则除之，邪胜则虚之。”是指下针之后根据病的缓急和气的虚实而决定行针补泻的方法。腧穴、经脉在早期医学观念中，并无孰先孰后的情况，而是处于共存状态，并相互影响^[2]，现代学者对经脉、腧穴之间的关系从顶层本体角度进行了分析^[3]。

5.2 腧穴数量演变

先秦两汉时期腧穴数量总体上呈现由少到多的发展特点，老官山漆人约有 116 个疑似腧穴点，《内经》约有 148 个有名称的腧穴^[4]，《难经》第六十二至六十八难专论腧穴，提出了八会穴的概念，对原穴、俞募穴均有补充^[5]，《明堂经》一书早佚，但大多数内容为《甲乙经》《外台秘要》《医心方》等后世文献所转引，目前所见的《明堂经》是黄龙祥先生辑校本，其中腧穴达 349 个^[6]。根据出土文献、文物与传世文献的记载，可知先秦两汉时期腧穴数量由少到多，处于不断发展完善

[1] 张昌云,郭桂华. 经络与腧穴的发展及关系[J]. 山西中医学院学报,2007,(01):13-14.

[2] 刘清,王晓梅,王素,等. 关于经与穴起源先后的探讨[J]. 中医药学报,2016,44(06):4-6.

[3] 付璐,李宝金,姚克宇,等. 顶层本体指导下的经络腧穴语义框架构建探索研究[J/OL]. 中国针灸:1-13[2022-03-16].

[4] 苏壮.《黄帝内经》腧穴理论的发生学研究[D]. 辽宁中医药大学,2013.

[5] 陈婷婷,何晶,李珊珊,等. 论《难经》对腧穴学的贡献及对后世的影响[J]. 河南中医学院学报,2008,(01):22-24.

[6] [汉]佚名撰;黄龙祥辑校,王雪苔审订. 黄帝明堂经辑校[M]. 北京:中国医药科技出版社,1987:265.

中，这与古人针灸临床经验的不断积累有关^[1]。

腧穴增多的过程中，其中一个比较明显的特点，就是从局部发展到全身，早期腕踝处动脉搏动明显，是古人对体表诊疗点的最初认识，四肢部的腧穴在早期医学体系中占有很重要的地位，医家以五输穴作为常用诊疗点，《内经》中四肢部的腧穴就占了所有腧穴的70%，老官山漆人足三阳脉，也是以四肢部腧穴为主，多属于特定穴，与四肢部肌肉丰厚、医疗事故发生率较小有密切的关系（先秦时期针体较粗，在胸腹部治疗时容易出现医疗事故）。而后《内经》《明堂经》中腧穴遍布全身，这与针刺用具的改良，以及医家临床经验的增多，针刺注意事项等经验的不断积累相关。此外，艾灸激发经气，产生灸感传导与《内经》“得气”关系密切^[2]，而四肢远心端灸感的感传效果，要明显强于四肢近心端、躯干等部位，先秦两汉时期，腧穴所在部位有着从四肢向全身分布的特点。

腧穴数量增加的形式，主要有：①骨名演变为腧穴名，如腕骨（三角骨）演变为腕骨穴，大抒穴演化自骨名（第一胸椎）等；②脉名演变为腧穴名，如络脉名借作络穴名；③一个部位演变为多个腧穴，由于医疗器械的进步，刺灸的部位更加精确，其范围逐渐缩小，使得早期所刺灸之处，被区分为多个穴位，如瘰脉穴、颅息穴就是由部位名（耳间青脉）分化而来，曲周动脉演化为颌厌、悬颅、悬厘三个穴位，再如太渊与经渠、合谷与阳溪等在早期“经脉穴”概念中都属于同一个穴位^[3]；④在常用穴的附近或经脉循行路径上增加腧穴，如“先秦两汉腧穴理论演变分述”一章中，提到可能为秦汉后期发现、定名的腧穴，多属于此类。

5.3 腧穴命名演变

先秦两汉时期，腧穴命名方式较为复杂，苏妆博士对《内经》中腧穴命名情况进行考证后认为：《内经》中有148个腧穴有具体名称，在具体名称中又包括27个腧穴有古（别）名，此外《内经》中还有74个腧穴未命名，但涉及到了具体的部位。秦汉医家对腧穴的形态有着不同的认识，反应在“砭灸处”“节”“会”“气穴”“气府”“骨孔（空）”等不同称呼中，最初腧穴有直接以所在部位进行命名，如委中在《内经》中又称为“腠中”（《灵枢·杂病》《灵枢·热病》）“郄中”（《素

^[1] 逯阳. 腧穴名称及穴性的文献研究与理论探讨[D]. 辽宁中医药大学, 2018.

^[2] 陈日新, 陈彦奇, 谢丁一. 试论艾灸得气[J]. 中国针灸, 2019, 39(10): 1111-1114.

^[3] 黄龙祥, 黄幼民. 针灸腧穴通考: 《中华针灸穴典》研究. 第一版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2011: 4.

问·刺腰痛》《素问·刺疟》),也有直接以经脉名冠之,如《灵枢·癫狂》:“癫疾始作先反僵,因而脊痛,候之足太阳、阳明、太阴、手太阳,血变而止。”此处“足太阳”“阳明”“太阴”“手太阳”均指对足太阳脉、足阳明脉、足太阴脉、手太阳脉上的某个部位进行放血疗法,且要求“血变而止”,以治疗由癫疾引起的躯体反僵、脊痛等症状。将经脉名用于腧穴命名的情况在秦汉时期出现较早,这与早期一脉只有一穴的现象有关。

老官山《刺数》载有40首针方,每首针方的书写体例较为规范,均为“病症+部位+刺激量”,整理人员认为这些针方中所使用的腧穴名称,是一种更为古老的命名方式^[1],如“项钜阳”“胫少阴”等,老官山医简《刺数》中载“郛(膝)挛痛,因痛所,以剧易为数”“跟下痛,因病所在,刺之四”。其中“因痛所”“因病所在”说明其他针方中“身体部位+阴/阳”的表述方式,指的就是具体治疗部位。黄龙祥先生认为《刺数》中腧穴的命名方式有三种^[2]:①“部位+阴/阳”;②直接用脉或络名;③直接用部位名。如:“癫疾,两辟(臂)肱阳明、项钜阳各五。”其中“肱阳明”的“肱”指小腿,因此“肱阳明”指足阳明脉在小腿部的治疗点,整理人员认为此处“肱阳明”与《灵枢·癫狂》所载的“足阳明”均指丰隆穴。《灵枢·经脉》称:“足阳明之别,名曰丰隆……实则狂巅,虚则足不收胫枯。”《明堂经》载丰隆穴主治病症中也有“烦心,狂见鬼,善笑不休,发于外,有所大喜”,是对“癫狂”具体症状的记载,可见,丰隆穴早期以“肱阳明”“足阳明”直接代称,这种以“身体部位+阴/阳”的命名方式是腧穴早期名称,老官山《刺数》中记载有较多的古穴名,通过目前整理人员公开发表的资料,我们将《刺数》中的腧穴名与传世医籍做一个大致的对比如下:

表 34 老官山医简《刺数》腧穴名称演变

《刺数》	《内经》	《明堂经》
项钜阳	项太阳	天柱穴
辟(臂)阳明	手阳明	阳溪穴
肱阳明	足阳明	丰隆穴
肱少阴	昌阳之脉	复溜穴
颊阳明	手阳明	大迎穴

^[1] 赵丹,段逸山,王兴伊.试析老官山汉墓《刺数》“经脉穴”与《内经》腧穴的对应关系[J].中国中医基础医学杂志,2019,25(02):205-208.

^[2] 黄龙祥.老官山出土汉简脉书简解读[J].中国针灸,2018,38(01):97-108.

耳前少阳	手少阳	角孙穴
辟（臂）大（太）阴	手太阴、天府	天府穴
头钜阳	足太阳	攒竹穴
陕颞	曲牙、耳下牙车	颊车穴
肱厥阴	足厥阴	蠡沟穴

老官山汉墓医简的抄写年代，经过梁繁荣等学者的考证，认为应该在西汉高祖后期至西汉文帝时期（公元前 195～公元前 158 年之间），值得一提的是，在出土文献中，武威汉代医简也记录了三个穴位：

简 20：次刺膝下五寸之间，荣深三分，留（留）箴如炊一升米顷，名曰三里。

简 21：次刺项从上下十一椎侠椎两刺，荣深四分，留（留）箴百廿息，乃出箴，名曰肺腧。刺后三日病德平复。

简 27：□者，名曰水泉也，先从□气逆膝以下寒气脉先不通。

武威汉代医简的成书年代，整理人员研究认为在公元一世纪左右^[1]，由此可见，老官山《刺数》中所记载的腧穴名称，属于目前所见出土文献中较早期的一种命名方式，如“项钜阳”“肱阳明”“颊阳明”“辟（臂）阳明”“头钜阳”“胫少阴”“肱厥阴”“腹阳明络”“足巨阳落”等这种“身体部位+阴/阳”的命名方式使用较为普遍，并且持续了较长一段历史时期，《史记·扁鹊仓公列传》中“灸其足少阳脉口……连属结绝乳下阳明”也是这种命名方式的体现，尤其是“乳下阳明”这样的称谓，其中“乳下”是指大致范围，“阳明”则进一步定位，与老官山《刺数》中腧穴的命名方式类似，直至《内经》中仍有这种命名方式的遗存，如《灵枢·寒热病》：“病始头首者，先取项太阳而汗出。”其中“项太阳”就是指膀胱足太阳之脉在项部的穴位。《内经》成编年代较晚，有学者认为今本《内经》成编时代大概是东汉末年（公元 184～公元 220 年）^[2]，老官山《刺数》成书年代与《内经》成编年代之间至少相差了三百余年，因此腧穴命名方式发展到《内经》中则进一步成熟，但由于《内经》是一部论文集类型的著作，故混有较为早期的腧穴命名方式，但整体上《内经》已经抛弃了这种“身体部位+阴/阳”的命名方式，笔者推测，可能是由于经脉命名方式的成熟及固定，即“脏/腑+手/足+阴/阳+脉”成为经脉的固定名称（见于《灵枢·经脉》），因此，“身体部位+阴/阳”这种腧穴

^[1] 甘肃省博物馆，甘肃省武威县文化馆. 武威旱滩坡汉墓发掘简报——出土大批医药简牍[J]. 文物, 1973(12): 18-22+73-76.

^[2] 傅海燕，李君. 今本《内经》成编于东汉的一条佐证[J]. 中华中医药学刊, 2014, 32(01): 15-17.

命名方式与“脏/腑+手/足+阴/阳+脉”的经脉命名方式极易混淆，故逐渐淘汰了“身体部位+阴/阳”的这种腧穴命名方式。《内经》中与经脉同名的腧穴命名方式，仅见于腕踝关节处的“脉动处”，这些尚存在于腕踝关节处与经脉名称相同的腧穴，黄龙祥先生将其称为“经脉穴”，赵京生先生将其称为“类经脉名”。此外像头面部的腧穴在《内经》时代已经完全发生了“更名换姓”，如“项钜阳”（《刺数》）转变为天柱，“颊阳明”（《刺数》）转变为大迎等等，赵京生先生将这种情况称之为“穴名与经脉名的离合”^[1]。

“阴阳”本作为经脉命名的基本要素，即使用于腧穴的命名，也是代表腧穴所在位置的经脉归属，也就是说，在老官山《刺数》所处的汉代早期，“阴阳”还是经脉命名的专属品，腧穴命名中有“阴阳”的元素，也只不过是作为一个“指路标”，在“身体部位+阴/阳”作为腧穴命名方式的开始，就注定着要面临“更名换姓”的情况，从马王堆帛书《足臂》《阴阳》，到老官山医简《十二脉》，再到《灵枢·经脉》篇，“脏/腑+手/足+阴/阳+脉”的经脉命名方式越来越规范，在这一过程中，原先借用经脉名的治疗部位，也开始在有意无意地更换命名方式，最先完成腧穴命名更换的是头面部的腧穴，四肢部的腧穴名称更换较为迟缓，其原因不外乎古代医家在使用、记录、交流时已经形成习惯，一时难以完全更改，比如《史记》这种非医学文献中所记载的医案，也存在用经脉名称代替腧穴的情况：《史记·扁鹊仓公列传》治疗“龋齿”提及“灸其左大阳明脉”。现将出土文献、传世文献中经脉、腧穴命名的这种差别作对比分析，如表 35 所示：

表 35 出土文献经脉、腧穴名称对比

出处	名称	性质
《足臂》	足泰陽溫、足少陽溫、足陽明溫、足少陰溫、足泰陰溫、足泰陰溫、臂泰陰溫、臂少陰溫、臂泰陽溫、臂少陽溫、臂陽明溫。	经脉名称
《阴阳》（甲本）	鉅陽脈、少陽脈、陽明脈、肩脈、耳脈、齒脈、鉅陰脈、癰陰脈、少陰脈、臂鉅陰脈、臂少陰脈	经脉名称
《阴阳》（乙本）	鉅陽脈、少陽肱、肩肱、耳肱、齒肱、巨陰肱、少陰肱、厥陰肱、臂巨陰肱、臂少陰肱	经脉名称
《阴阳》（丙本）	鉅陽之脈、少陽之脈、陽明之脈、肩脈、耳脈、齒脈、泰陰之脈、癰陰之脈、少陰之脈、臂鉅陰之脈、臂少陰之脈	经脉名称

^[1] 赵京生. 腧穴命名的演变：基于天回医简分析[J]. 中国针灸, 2019, 39(09): 1017-1020.

《十二脉》	手大陽脈、手陽明脈、辟大陰脈、辟少陰脈、心主之脈、足大陽脈、足大陰脈、足少陰脈、足厥陰脈	经脉名称
《刺数》	项钜阳、辟阳明、肱阳明、肱少阴、颊阳明、耳前少阳、辟大阴、头钜阳、陕颞、肱厥阴	腧穴名称

值得一提的是，经脉名称与借用“阴阳”等经脉命名元素而命名的腧穴名称之间是有根本差别的，其差别在于名称的结尾有无“脉”字，目前出土的几处汉墓经脉文献中，经脉名称多是“身体部位+阴/阳+脉”的形式，而借用经脉名称命名的腧穴名，一般没有“脉”字，这是两者之间的最大差别。

实际上秦汉时期文本中的这种差别，有助于读者区分针灸医籍中所提及的名称到底是经脉还是腧穴。尤其是老官山医简《别脉》中，这种经脉名与腧穴名之间的对比更加明显，如：“問別大陰脈：出口繚婢（髀），出深食，臍上痛，奏于心痛，山口癢，遺弱（溺），久（灸）大陰。”“問別臂陰脈，出臑，湊心。臑痛，心痛，久（灸）臂陰。”此处“大阴脉”“臂陰脈”指经脉名（别脉），而“大阴”“臂阴”则指所灸之处。

综上所述，早期腧穴名称的来源，可能是部位名、脉名、骨名等，笔者总结如表 36 所示：

表 36 先秦两汉时期腧穴名称演变来源

归属经脉	穴名	名称来源
足太阳脉	承筋	《素问》会阴之脉
	委中	部位名（《内经》腘中、郄中），腘动脉搏动处
	攒竹	《刺数》“头钜阳”《内经》“足厥阴”
	天柱	《刺数》“项钜阳”《内经》“项太阳”
	大抒	骨名：第一胸椎（即大椎）
	仆参	《刺数》足巨阳落
	殷门	《素问》衡络之脉
	申脉	阳蹻（之所生）
足少阳脉	阳辅	《素问》同阴之脉
	颞颥	曲周动脉→颌厌、悬颅、悬厘（一脉演化为三穴）
	完骨	骨名
	带脉	脉名
	悬钟	胫前动脉搏动处
	气冲	《内经》“气街”，髂外动脉搏动处
	大迎	《刺数》“颊阳明”，面动脉搏动处

足阳明脉	颊车	《刺数》“陕颧”（骨名）
	人迎	颈总动脉搏动处
	天枢	部位名（脐水平线）
	丰隆	《刺数》“肱阳明”（黄龙祥先生认为“肱阳明”是足三里）
	冲阳	《内经》“足阳明”“趺阳脉”，足背动脉搏动处
手太阴脉	经渠、太渊	《内经》“手太阴”，桡动脉搏动处
	尺泽	肘正中动脉搏动处
	列缺	络脉名
	天府、侠白	《刺数》“臂太阴”，肱动脉搏动处
	中府、云门	腋动脉搏动处
手厥阴脉	大陵	《内经》“手心主”“手厥阴”
	内关	络脉名
手少阴脉	神门、阴郄	《内经》“手少阴”，尺动脉搏动处
手阳明脉	合谷、阳溪	《刺数》“臂阳明”《内经》“手阳明”
	偏历	络脉名
	五里	《刺数》“肘阳明”《内经》“五里之脉”，肱动脉搏动处
手少阳脉	瘰脉、颊息	部位名（《内经》耳间青脉）
	角孙	《刺数》“耳前少阳”
手太阳脉	后溪	《内经》“手太阳”
	腕骨	骨名（三角骨）
	支正	络脉名
	天窗	颈动脉搏动处
足太阴脉	公孙	络脉名
	大包	络脉名（脾之大络）
足厥阴脉	行间、太冲	《内经》“足厥阴”
	蠡沟	《刺数》“肱厥阴”，络脉名
	涌泉	《内经》“足下”（部位名）“足下中央支脉”（脉名）
足少阴脉	大钟	络脉名
	太溪	《内经》“足少阴”
	复溜	《刺数》“肱少阴”《内经》“昌阳之脉”

5.4 腧穴归经、定位逐渐明确

腧穴名称发展至东汉时期，几乎已经完全褪去了经脉命名元素的“外衣”，尤其是汉代腧穴专著《明堂经》中，腧穴皆有专名，甚至有较多的别名，腧穴由早期的“身体部位+阴/阳”的命名方式，到汉末腧穴名出现正名以及别名的转变过程，表明临床经验的积累促进了经穴理论的完善，但同时我们应该认识到，早期

腧穴以“身体部位+阴/阳”进行命名时，“阴阳”就是指其所属的经脉，此时不存在（也无需存在）腧穴归经的问题，然而在腧穴名称演变后期，穴名逐渐变得隐晦难懂，如《明堂经》中存在别名的腧穴有 91 个，腧穴的正名有以部位特点进行命名（如攒竹、客主人、承筋），有以治疗效果进行命名（如睛明、光明、漏谷），有以生活建筑进行命名（如膺窗、库房、华盖）等，这时候对大量增加的，更换命名方式后的腧穴，如何进行分门别类，就成为了古代医家较为棘手的问题，于是从《内经》《明堂经》开始，逐渐拉开了腧穴归经的幕布，并且一直持续到了现代，这场历时长久且学说各异的腧穴归经演变过程，以 2006 年国标将印堂穴归于督脉为标志，方暂时结束^[1]。

老官山漆人出土之前，我们对于早期腧穴归经的认识，只能依据传世文献中的文字记载，最先归经的是肘膝关节以下的五输穴，见于《内经》，秦汉以后，直到魏晋《甲乙经》中，依旧是将四肢肘膝关节以下的五输穴归入相应的经脉，而将其余腧穴分行排列，六朝时《产经》始将四肢部所有腧穴归入相应经脉^[2]，老官山漆人体表所见的 119 个疑似腧穴点归属经脉的情况并不完全清楚，还待图版释文全部公布，但目前所公布的足三阳脉与手三阴脉的疑似腧穴点，主要沿经脉分布，提示我们古人对腧穴归经的认识较早，为腧穴归经问题的研究提供了一个很好的原始材料，但笔者认为，老官山漆人腧穴归经情况，只能说是先秦两汉时期腧穴归经中某一派医家的认识，并不能称得上为《内经》等后世医籍“奠定基础”，因为《内经》中的理论承自不同的医学流派。

腧穴归经问题的产生，是腧穴数量增加和命名方式改变的必然结果，对腧穴归经的考察，传世文献中最早可以追溯到《内经》，其不止一篇提及腧穴数目为 365，这是受秦汉时期“类推法”哲学思想的影响，将一年三百六十五天之数移植于腧穴数目，杨上善在《太素·气府》中解释：“此言三百六十五穴者，举大数为言，过与不及，不为非也。”《内经》所载的腧穴，去掉重复者有 173 个，其中 125 穴有归经记载，分属于十四经，且大多数分布在四肢（有 88 穴，占 70%）^[3]。

《内经》对腧穴归经的处理方式是以五输穴（11 条经脉，手少阴经除外）和

^[1] 毛苗. 督脉经穴数目的古今文献研究[D]. 宁夏医科大学, 2021.

^[2] 黄龙祥. 腧穴归经源流初探[J]. 针灸临床杂志, 1994(05): 1-2.

^[3] 苏壮. 《内经》腧穴理论的发生学研究[D]. 辽宁中医药大学, 2013.

“脉气所发”（手足三阳、任、督、冲脉）进行归类。而后在《明堂经》中，腧穴数量增至 349 个，对于腧穴归经的处理方式与《内经》类似：四肢肘膝关节以下的五输穴归入相应的经脉，其余腧穴按照所在部位进行排列，如腹部所有腧穴分类为“腹自鸠尾循任脉下行至会阴凡十五穴”“腹自幽门侠巨阙两傍各半寸循冲脉下行至横骨凡二十二穴”“腹自不容侠幽门两傍各一寸五分至气冲凡二十四穴”“腹自期门上直两乳侠不容两傍各一寸五分下行至冲门凡一十四穴”“腹自章门下行至居髎凡十二穴”，将腹部所有的腧穴分成五行，但在各论腧穴时，又注明腧穴与经脉之间的关系，如不容、承满、梁门、关门、太乙、滑肉门、天枢等虽然属于“腹自不容侠幽门两傍各一寸五分至气冲凡二十四穴”，但在腧穴定位之后均注明“足阳明脉气所发”，《明堂经》成书年代大致为西汉末与东汉延平年间，《明堂经》的腧穴排列方式，对后世腧穴归经影响较大。魏晋时期皇甫谧作《甲乙经》，其腧穴归经也依此方式，六朝时期《产经》首先将四肢部所有腧穴归入相应经脉，现代教材中的腧穴归经方式源自于北宋王唯一编纂的《铜人腧穴针灸图经》。本论文仅讨论先秦两汉时期腧穴归经情况，我们可以大致得出这样一个结论：先秦两汉时期腧穴归经理论的出现，是腧穴数量增多以及命名改变之后的必然趋势，腧穴归经的形式也较为统一，并且延续了整个秦汉时代，即四肢肘膝关节以下的五输穴归于相应经脉，而其他腧穴则按部分行排列。这与四肢部腧穴以局部和远端主治为主，而头面、躯干部腧穴多为局部治疗作用规律有关。结合老官山漆人腧穴归经情况，可知漆人体表所刻画的疑似腧穴点，也多是以四肢部腧穴为主，尤其是手三阴脉腧穴全部位于肘关节以下，大致符合秦汉时期腧穴归经的规律。

现行教材对腧穴的定位非常具体明确，尤其是现代解剖学知识的引入，使得腧穴的定位“不差毫厘”，似乎取穴在“毫厘之外”，便已经“离经叛穴”，甚至有学者对腧穴在体表的具体范围作了详细的计算^[1]，为腧穴体表面积的讨论推波助澜。实际上，早期针灸医学中，尤其是“气穴”“气府”概念形成之前，古人针刺的部位非常广泛，符合“经络支节，各生虚实，其病所居，随而调之”较为简便、原始的治疗特点。全身皮肉筋脉骨均在治疗选取范围内，并且对于不同部位针刺时有不同的命名，如《灵枢·官针》提到的“凡刺有九，以应九变”中，就对不

^[1] 肖永俭,肖沛.腧穴体表面积探讨[J].山东中医药大学学报,1999(01):12-18+79.

同部位及不同针刺方法进行了分类,除此之外,骨孔也是针刺的可选部位之一,《素问》专门有“骨空论”一篇对其进行总结,针刺部位的宽泛性,实际也是早期针灸医学不成熟的体现,《内经》传承自流派众多、学说各异的先秦医学,纷繁复杂的医学理论体系集中于《内经》中,但如此之多的刺灸部位并未全部传于后世,我们从《明堂经》中发现,传于后世的多是从“诊脉治脉处”演变而来的“经脉穴”“十二原穴”“十五络穴”“五输穴”等等,故黄龙祥先生推论:“早期作为诊脉部位的表浅动脉、络脉,一般都演变为重要的腧穴。”

5.5 腧穴主治病症形成

腧穴主治病症的形成因素,学者讨论较为丰富,主要总结为临床经验的积累和中医理论类推两大因素^[1],此外还有直接抄录自经脉主治病症或早期针灸方的情况。

5.5.1 临床经验的积累

早期先民患病时由于病痛驱使,本能地寻求缓解痛楚的方法,如徒手按、揉、锤或者借助器械(砭石、骨针等)进行物理治疗(草药治疗不在本论文讨论范围内),又由于治疗器械的进步(如青铜针、铁针的出现),使得较大范围的治疗部位逐渐集中在某一点,便产生了“孔”“窍”“穴位”的概念,在这个漫长的经验积累过程中,逐渐总结出了腧穴主治病症,当然,最初形成的腧穴主治病症,与先民所处的时代、对疾病的病因、症状以及预后等认识密切相关,古人认识到某些脏腑病可以在身体的某处出现反应点,便将两者直接联系起来,如《灵枢·九针十二原》:“五藏有疾也,应出十二原,而原各有所出,明知其原,睹其应,而知五藏之害矣。”临床经验的积累,是促使腧穴主治病症形成的最主要原因。

5.5.2 中医理论的推理

“类推”法是中国古代一个特色鲜明的研究方法,源于《荀子·儒效》篇^[2],荀子自认为“以类行杂,以一行万”(《荀子·王制》)可以达到“以近知远,以一知万,以微知明”(《荀子·非相》)的目的,荀子本人对战国学术进行批评、传承与发展,被统治者所接受,其终结了先秦子学,又影响了两汉经学,荀子的这种“类推”理论,无疑也影响了秦汉时期的中医学理论,如《素问·标本病传论》:

^[1] 黄龙祥. 中国针灸学术史大纲[M]. 北京: 华夏出版社, 2001: 614.

^[2] 任秀玲. 论中医理论的模式类推方法[J]. 中华中医药杂志, 2010, 25(11): 1735-1738.

“以浅而知深，察近而知远，言标与本，易而勿及。”但是类推法用于自然科学，难免有先入为主的弊端，尤其是某些穴位的主治功效也是由类推得出，而不是从临床实践经验中去总结，这种情况下，类推法就更不值得提倡。从中医理论类推腧穴主治，主要依藏象学说、五行学说等^[1]。

5.5.3 抄录经脉病症或针灸方

早期医家认为腧穴是由经脉的“脉气所发”，所以腧穴的治疗作用与经脉关系密切，尤其是体现在经脉的“是动病”“所生病”直接移植为腧穴主治病症的情况，如《明堂经》中对足厥阴肝经荣穴行间的主治病症中“主咳逆上气……溺难痛……卒疝，少腹肿，咳逆呕吐，卒阴跳腰痛不可以俯仰……嗑干渴”，是直接移植自足厥阴肝经的典型症候。《明堂经》是汉末腧穴专著，受《内经》影响较深，《明堂经》中某些腧穴的主治病症，也是从《内经》针灸方中撷取而成，如《素问·刺疟》载：“疟，不渴，间日而作，取足太阳。”《明堂经》则作：“疟，不渴，间日而作，昆仑主之。”体现出早期针灸治病取穴部位，从不固定（“足太阳”可代指足太阳脉上的所有腧穴）到固定的过程。早期针灸文献中对腧穴主治的描述，多录症状，因为症状是最直观的表现，《明堂经》对腧穴主治病症的描述，又多是从更为古老的针灸方中撷取而成，且部分腧穴主治，有明显“拼凑文献”的情况，可能并非来自于临床实践，这是先秦两汉时期腧穴主治病症形成中比较重要的一个方面。

^[1] 黄龙祥. 中国针灸学术史大纲[M]. 北京: 华夏出版社, 2001: 611-706.

结语

本研究基于出土文献、文物与传世文献中经脉、腧穴相关内容,运用文献学定量研究法、历史分析法、科学研究(比较、抽象、归纳)等方法,对先秦两汉时期经脉、腧穴理论的发展演变进行梳理、分析。首先,着重探讨了简帛医学文献对于早期中国医学史研究的重要性,以及出土经脉、腧穴文献本身的特点;其次,对《足臂》《阴阳》《十二脉》《灵枢·经脉》以及老官山漆人、双包山木人所记载的经脉循行路径及主治病症进行比较研究,继而对老官山漆人体表刻画的疑似腧穴点以及《内经》《明堂经》中所记载的腧穴内容进行分析,考察先秦两汉时期腧穴理论的演变过程及特点,尤其是借助老官山出土的针方简《刺数》,系统讨论了腧穴命名的演变。

研究结果主要体现在以下五个方面:

第一:先秦两汉时期影响经脉、腧穴理论形成和发展的因素众多。主要包括:

①对血管等解剖结构的认识,对体表动脉搏动(即“脉动处”)、浅表静脉(即浮络)的诊察;利用骨针、石针、竹针、艾灸进行早期医疗活动时,出现循经感传现象,以及针对病症治疗效果而总结积累的经验;《内经》以前巫医并用时代,古人对邪魅入侵体内路径的臆测,促使形成“经脉”的概念,到了东汉时期,人们已经将“经络”和“血脉”彻底区分开来;

②“精气学说”在战国中期已经基本形成,“气”的概念由宏观角度下的“云气”“雾气”“湿气”等环境状态,逐渐抽象到身体之气,将“气”概念引入血脉、身体局部是秦汉时期经脉学说转型的重要因素,如扁鹊学派已经将“呼吸”与“脉搏”结合起来作为诊断的要点,在张家山汉简《引书》中进一步形成了“血气”“头气”“足气”等概念,促进了经脉运行血气、经脉环形流注体系以及“气街”等认识的形成;

③数术观念的影响,出土文献“十一脉”体系与“天六地五”的观念有关,而“十二脉”体系,则可能与“十二月”“十二经水”影响相关,类似再如奇经八脉的数量与“八极”,腧穴总数与“三百六十五日”等。

第二:经脉命名方面,《足臂》采用“足/臂+阴/阳+脉”较为统一的命名形式;《阴阳》经脉命名方式比较特殊,首先下肢经脉未提“足”字,直接以“阴/

阳+脉”的形式进行命名，上肢手三阴脉的命名方式为“臂+巨（泰）/少阴+脉”，而手三阳脉的命名方式为“身体部位+脉”；《灵枢·经脉》篇中则统一以“脏/腑+手/足+阴/阳+脉”的方式进行命名，《内经》中其他篇章还存在较早的命名方式，说明影响经脉命名的因素不仅与经脉循行起止点的变化相关，还与先秦两汉医家习惯性的用语、行文有关。

经脉数量方面，主要体现在“心有四支”（《晏子春秋》《淮南子》）“人有四经”（《素问·阴阳别论》）“十一脉”（《足臂》《阴阳》）“十脉”（双包山木人）“十二脉”（老官山漆人、《十二脉》《灵枢·经脉》）之间的变化。其中“十一脉”至“十二脉”之间的转变，既有哲学数术层面的影响，也有解剖角度的认识，甚至还存在医家主观推测等，经脉数量的转变，不仅影响手三阴脉的循行及主治病症，包括经脉的内涵也发生了转变。

经脉循行方面，其演变特点首先体现在循行路径的延长，经脉起点或止点从腕踝延伸至指趾末端，也是经脉环形流注体系形成的重要基础；其次表现为循行方向的差异，在出土文献中，经脉流注方向多为向心性流注，《足臂》十一脉均是向心性流注，《阴阳》肩脉、足太阴脉属于远心性流注，其余经脉流注方向为向心性，老官山《十二脉》均呈向心性流注；《灵枢·经筋》《灵枢·脉度》《灵枢·本输》中的经脉也均为向心性流注；双包山木人根据马继兴先生的考证，全部经脉都是远心性循行。《灵枢·经脉》通过延伸经脉路径、增加经脉分支等方法，形成的首尾相连、经脉脏腑相关的环形流注体系，即《灵枢·逆顺肥瘦》中“手之三阴，从藏走手；手之三阳，从手走头；足之三阳，从头走足；足之三阴，从足走腹”的循行特点，可见经脉循行方向在先秦两汉时期经历了多学说并存至《灵枢》中逐渐固化的一个演变过程。

经脉病症方面，帛书《阴阳》对经脉主治病症以“是动则病”和“其所产病”进行归类，帛书《足臂》则以“其病：病XX”引出经脉所主病症，老官山《十二脉》在描述手太阳脉的循行之后，用“治所生病”引出经脉所主病症，《灵枢·经脉》则以“是动则病”和“所生病”引出。在具体内容中，《足臂》经脉主治病症相当于《阴阳》的“其所产病”。可见，先秦两汉医籍主要用“是动病”“所产（生）病”对经脉病症进行归纳，出土文献与传世文献之间存在明显的传承关系，而经脉病症又与腧穴主治病症的形成相关，《明堂经》中所记载的腧穴主治病症，

有很大一部分来源于所属经脉的“是动病”“所产（生）病”。

第三：先秦两汉时期大致完成了经脉分支的产生、演化以及定型。解剖实体组织的认识、象思维的影响以及临床经验的积累，尤其是为解释不断增加的主治病证所在部位，秦汉医家便建立了经脉分支进行联系，整体上，经脉分支数量呈现逐渐增多的趋势，其功能从联系病证部位转变为构建经脉-脏腑相关理论以及经脉环形流注体系，如《足臂》3条分支（见于足太阳脉与足少阳脉）均与临床诊治经验相关，经脉分支在演变过程中，逐渐赋予了新的内涵，如老官山漆人13条经脉分支以及双包山木人5条经脉分支，与《足臂》相比，不仅数量上有增加，后两者除联系病证所在部位外，还有联系经脉的作用，至《灵枢·经脉》中，经脉分支增至17条，其中有10条支脉专门用于构建表里经脉之间的联系，进一步构建十二经脉环形流注模式，经脉分支的功能从“联系病证部位”转变为“构建循环理论”。

第四：十二经筋在早期演化过程中，逐渐转变为十二经脉的附属结构。“经筋”这一概念是秦汉医家长期对运动系统解剖结构及其生理病理特点的认识上形成的，“经筋”是“筋”的下位概念，凡“筋”之常者、“筋”病有规律可显者，称之为“经筋”，其中“筋”之常者，是指其具有“结、聚、散、络”的特点，“筋”病有规律可显者，是指经筋病变后出现典型的“结筋处”。早期经筋、经脉理论系统反映了劳损形成的疼痛点，十二经筋循行与主治病症与帛书相似度较高，其理论核心是“通行卫气”，取穴特点主要是“在筋守筋，以痛为输”“维筋相交”“依脉引筋气”等，但随着《灵枢·经脉》篇所构建的十二脉环形流注体系的形成与流行，十二经筋逐渐演变为了经脉理论的附属结构，使得经脉理论的包容性越来越强，其实用性、针对性反而被削弱。因此，“重拾”经筋理论显得尤为重要，在对先秦两汉经脉演变的研究中，识别出经筋理论的特色，并且进一步深化经筋理论的解释力与指导力，如对病灶“筋结点”进行详辨，筋膜通行卫气与内脏之间的联系，以及从解剖层面对经筋实质进行探讨，突出经筋理论的特色，可为经脉理论“减压”。

第五：先秦两汉时期腧穴数量呈现由少变多的趋势，老官山漆人体表约有116个疑似腧穴点，《内经》记载148个有名称的腧穴，而《明堂经》中腧穴的数量多达349个，呈现“井喷式”的增长，与数术理论中“三百六十五”这一概

念的影响有关,腧穴数量增加的形式,主要有:①骨名演变为腧穴名,如腕骨(三角骨)演变为腕骨穴,大抒穴演化自骨名(第一胸椎)等;②脉名演变为腧穴名,如络脉名借作络穴名;③一个部位演变为多个腧穴,由于医疗器械的进步,刺灸的部位更加精确,腧穴范围逐渐缩小,使得早期所刺灸之处,被划分为多个穴位,如瘰脉穴、颅息穴就是由部位名(耳间青脉)分化而来,再如曲周动脉演化为颌厌、悬颅、悬厘三个穴位,以及太渊与经渠、合谷与阳溪等在早期“经脉穴”概念中都属于同一个穴位;④在常用穴的附近或经脉循行路径上增加腧穴,如“先秦两汉腧穴理论演变分述”一章中,属于秦汉后期发现、定名的腧穴多为此类。

腧穴数量的增加,也体现了**腧穴命名**的演变,老官山针方简《刺数》中载有40首针方,是早期腧穴以“身体部位+阴/阳”方式进行命名的代表,如“肱阳明”“项钜阳”“耳前少阳”等,此外还有以“脉”“络”进行命名者,如“足巨阳落”“腹阳明络”等,这种命名方式在《内经》中仍有遗存,实际上是直接借用了经脉的名称,但两者之间区别之处在于是否在结尾使用了“脉”字,腧穴采取“身体部位+阴/阳”的命名方式这一现象直至汉末《明堂经》中彻底抛弃,转而使用我们目前所熟知的腧穴名。

腧穴归经是腧穴数量增多以及腧穴命名改变影响下形成的,老官山漆人已经出现了腧穴归经的现象,从已公布的足三阳脉、手三阴脉腧穴分布特点来看,所归经的腧穴主要在关节、动脉搏动处附近,体现了早期“脉穴合一”的特点,腧穴归经的概念还未成熟,而后演变至《内经》《明堂经》中才逐渐形成腧穴归经理论,《内经》对腧穴归经的处理方式是以五输穴(11条经脉,手少阴脉除外)和“脉气所发”(手足三阳、任、督、冲脉)进行归类,《明堂经》对于腧穴归经的处理方式,与《内经》类似:四肢肘膝关节以下的五输穴归入相应的经脉,其余腧穴按照所在部位进行排列,且多以“脉气所发”进行归纳。

腧穴主治病症的形成较为复杂,主要有:①临床经验的积累,是腧穴主治病症形成的根源,这一过程持续了较长时期,主要靠原始的口耳相传以及早期甲骨、简帛等文献载体的零星记载,这一时期所形成的腧穴主治病症临床特色较强,也是后世文献中腧穴主治病症的最初来源;②中医理论的推理,主要依据战国时期形成的“类推法”,根据藏象学说、五行学说对腧穴主治进行推演,但这种“推理”得来的主治病症脱离了临床实际,其实践性与针对性大大降低,是哲学思想

影响下的产物；③经脉主治病症和早期针灸方主治病症的移植。早期针灸文献中对腧穴主治的描述，多录症状，因为症状是疾病过程中最直观的表现，《明堂经》对腧穴主治病症的描述，又多是更为古老的针灸方中撷取而成，这是先秦两汉时期腧穴主治病症形成的一个总的规律。但需要注意的是，《明堂经》的部分腧穴主治，有明显“拼凑文献”的特点，可能并非来自于临床实践。

本研究的创新点主要有：

第一：综合目前所能搜集到的出土文献、文物以及传世文献资料，全面梳理先秦两汉时期经脉、腧穴理论的发展演变过程及特点，尤其是对于部分理论研究空白处，如经筋理论早期发展特点以及经脉分支的演变过程等，进行补充完善。

第二：综合运用多种学科研究方法及成果，如利用考古学、古文字学、古史学（医学史）等多学科交叉研究，从宏观与微观角度，全面把握先秦两汉时期的文化背景以及从字词研究角度准确理解出土文献中的思想内涵。

本研究的结论主要有以下四点：

第一：先秦两汉时期经脉理论的转型受多种因素影响，象数思维、哲学意识等非医疗实践因素也不可忽视，故不能单从某一方面对其进行阐释，对于“十一脉”到“十二脉”之间的转变，也不能看作是一个简单的线性发展过程；腧穴主治病症的形成中包含有实践因素和非实践因素两部分，尤其《明堂经》中记载的腧穴主治病症中非实践因素较多，并且被后世针灸文献所转引，因此准确辨别腧穴主治病症中非实践因素，对针灸临床规范化至关重要。

第二：“经脉”概念最早来源于先民对血管形态和功能的观察，《足臂》内容提示早期经脉的发展受灸疗活动影响较深，在用于联系病症部位的过程中，逐渐演化出了经脉分支，经脉分支的功能转变与经脉理论内涵之间密切相关，随着十二经筋“附属”于十二经脉，以及在秦汉时期藏象学说、阴阳五行学说的影响下，经脉的“理论指导”作用越来越强。

第三：腧穴概念的产生以及早期分布位置，与体表触诊所及的动脉搏动点相关，在腧穴数量逐渐增多的过程中，其定位也越来越明确，早期腧穴名称中的经脉命名元素，随着腧穴命名的改变而逐渐隐退，必然导致腧穴归经专门化现象的出现，秦汉时期对腧穴归经的情况主要记载于《内经》《明堂经》中，两者认识较为一致，主要是分经排列与分部排列两种归经方式的结合。

第四：在对先秦两汉经脉理论进行考察时，除了依据《足臂》《阴阳》《十二脉》《别脉》《灵枢·经脉》等文本文献外，还应该综合出土文物资料，即老官山漆人与双包山木人，特别是双包山木人所记载的经脉体系尤为迥殊，综合诸文献、文物，才能对定型以前的经脉体系有一个全面的了解，经脉的定型则以《灵枢·经脉》篇的形成代表。

研究局限与展望

本研究的局限性在于，首先，先秦两汉时期的针灸理论体系中，除经脉、腧穴相关的基本概念外，尚未对刺灸法、身体观、疾病观等进行专门研究，这些内容的缺失对于梳理分析经脉、腧穴的演变特点有一定的影响；对于先秦两汉时期社会背景、文化背景未进行深入的研究，这对探讨经脉、腧穴理论演变过程中的影响因素有一定影响，此外，对老官山汉墓文献、文物的研究探讨依据的是“二次文献”，以及笔者考古学、古文字学的认识及处理能力有限，均对本研究有一定影响，此外，若能将先秦两汉时期的经脉、腧穴演变特点与后世针灸文献特点进行对比研究，对于整体把握历史长河中经脉、腧穴理论的演变特点，以及针灸理论体系的现代化建设均有重要的价值，这些不足之处都是将来需要解决的问题。

参考文献

古代文献

- [1] [西周]姬旦撰;杨天宇译注.周礼译注[M].上海:上海古籍出版社,2016.
- [2] [春秋]佚名.黄帝内经素问[M].北京:人民卫生出版社,2012.
- [3] [春秋]佚名.灵枢经[M].北京:人民卫生出版社,2012.
- [4] [春秋]秦越人著;南京中医学院校释.难经校释(第二版)[M].北京:人民卫生出版社,2011.
- [5] [春秋]晏婴著;李新城,陈婷珠译注.晏子春秋译注[M].上海:上海三联书店,2018.
- [6] [春秋]管仲.管子[M].上海:上海古籍出版社,2015.
- [7] [春秋]孔子及其弟子撰;杨伯峻译注.论语译注[M].北京:中华书局,2015.
- [8] [战国]墨翟撰;蒋重母,邓海霞译注.墨子译注[M].长沙:岳麓书社,2014.
- [9] [战国]荀况.荀子[M].长沙:岳麓书社,2019.
- [10] [战国]孟轲.孟子[M].长沙:岳麓书社,2000.
- [11] [战国]庄周.庄子[M].北京:商务印书馆,2018.
- [12] [战国]屈原撰;黄寿祺,梅桐生译注.楚辞全译[M].贵阳:贵州人民出版社,2008.
- [13] [战国]韩非撰;张松辉,张景译注.韩非子译注[M].上海:上海三联书店,2018.
- [14] [汉]桓宽撰;王利器校注.盐铁论校注[M].北京:中华书局,2018.
- [15] [汉]张仲景撰;[金]成无己注.注解伤寒论[M].北京:人民卫生出版社,2012.
- [16] [汉]张仲景.金匱要略方论[M].北京:人民卫生出版社,2012.
- [17] [汉]王充.论衡[M].上海:上海人民出版社,1974.
- [18] [汉]佚名撰;黄龙祥辑校,王雪苔审订.黄帝明堂经辑校[M].北京:中国医药科技出版社,1987.
- [19] [汉]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1959.
- [20] [汉]许慎.说文解字[M].北京:中华书局,2015.
- [21] [汉]刘熙;[清]王先谦撰集.释名疏证补[M].上海:上海古籍出版

- 社,1984.
- [22] [汉]华佗(托名).中藏经[M].北京:人民卫生出版社,2007.
- [23] [汉]班固.汉书[M].长沙:岳麓书社,2009.
- [24] [汉]戴圣撰;滕一圣译注.礼记译注[M].北京:商务印书馆,2015.
- [25] [汉]何休注;[唐]徐彦疏.春秋公羊传注疏[M].上海:上海古籍出版社,1990.
- [26] [汉]刘安.淮南子[M].长沙:岳麓书社,2015.
- [27] [晋]王叔和撰;广州中医学院《脉经》整理研究课题组校注.脉经校注[M].北京:人民卫生出版社,2016.
- [28] [晋]刘涓子.刘涓子鬼遗方[M].长沙:湖南科学技术出版社,2014.
- [29] [晋]葛洪.补辑肘后方[M].合肥:安徽科学技术出版社,1996.
- [30] [南朝]刘勰撰;周振甫注.文心雕龙注释[M].北京:人民文学出版社,1981.
- [31] [隋]杨上善.黄帝内经太素[M].北京:中医古籍出版社,2016.
- [32] [隋]巢元方撰;南京中医学院校释.诸病源候论校释[M].北京:人民卫生出版社,2009.
- [33] [唐]孙思邈撰;李景荣等校释.备急千金要方校释[M].北京:人民卫生出版社,2018.
- [34] [金]张从正撰;徐江雁,刘文礼校注.儒门事亲校注[M].郑州:河南科学技术出版社,2015.
- [35] [元]滑寿.读素问钞[M].北京:人民卫生出版社,1998.
- [36] [明]李时珍.奇经八脉考[M].北京:中国医药科技出版社,2012.
- [37] [明]张介宾.类经[M].北京:中国中医药出版社,1997.
- [38] [清]黄元御.难经悬解·黄元御医书全集[M].北京:中医古籍出版社,2016.
- [39] [清]张志聪.黄帝内经灵枢集注[M].北京:中医古籍出版社,2012.

学术专著

- [1] 王国维.古史新证[M].长沙:湖南人民出版社,2010.

- [2] [日]山田庆儿. 中医学的历史与理论. 科学: 中国与世界[M]. 北京: 科普出版社, 1992.
- [3] 李均明, 刘国忠, 刘光胜, 等. 当代中国简帛学研究 1949-2019[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2020.
- [4] 钱存训. 印刷发明前的中国书和文字记录[M]. 北京: 印刷工业出版社, 1988.
- [5] 李学勤. 文物中的古文明[M]. 北京: 商务印书馆, 2008.
- [6] 李瑞良. 中国古代图书流通史[M]. 上海: 上海人民出版社, 2000.
- [7] 徐建委. 文本革命——刘向、《汉书·艺文志》与早期文本研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2017.
- [8] 傅荣贤. 出土简帛与中国早期藏书研究[M]. 北京: 知识产权出版社, 2013.
- [9] 陈邦贤. 中国医学史[M]. 郑州: 河南人民出版社, 2017.
- [10] [日]西山尚志. 古书新辨——先秦出土文献与传世文献相对照研究[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2015.
- [11] [美]夏含夷著, 周博群译. 重写中国古代文献[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2012.
- [12] 张显成. 先秦两汉医学用语汇释[M]. 成都: 巴蜀书社, 2002.
- [13] 陈梦家. 汉简缀述[M]. 北京: 中华书局, 1980.
- [14] 张显成. 简帛文献学通论[M]. 北京: 中华书局, 2004.
- [15] 李学勤. 清华简及古代文明[M]. 南昌: 江西教育出版社, 2017.
- [16] 严健民. 经脉学说起源·演绎三千五百年探讨[M]. 北京: 中国古籍出版社, 2010.
- [17] 杜正胜. 从眉寿到长生: 医疗文化与中国古代生命观[M]. 台北市: 三民书局, 2006.
- [18] 林果为, 王吉耀, 葛均波主编. 实用内科学 (第 15 版) (上册) [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2017: 982.
- [19] 李良松, 郭松涛. 中国传统文化与医学[M]. 厦门: 厦门大学出版社, 1990.
- [20] 李鼎. 针灸学释难 (重修本) [M]. 上海: 上海中医药大学出版社, 2006.
- [21] 李建民. 发现古脉——中国古典医学与术数身体观[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2007.

- [22] 赵京生. 针灸经典理论阐释[M]. 上海: 上海中医药大学出版社, 2000.
- [23] 黄龙祥. 中国针灸学术史大纲[M]. 北京: 华夏出版社, 2001.
- [24] 天津中医学院第一附属医院针灸科. 石学敏针灸临证集验[M]. 天津: 天津科学技术出版社, 1990.
- [25] [日]丹波元坚编. 素问绍识[M]. 北京: 人民卫生出版社, 1955.
- [26] 马继兴. 中国出土古医书考释与研究[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 2015.
- [27] 马王堆汉墓帛书整理小组. 马王堆汉墓帛书·五十二病方[M]. 北京: 文物出版社, 1979.
- [28] 薛立功. 中国经筋学[M]. 北京: 中医古籍出版社, 2015.
- [29] 赵京生. 针灸关键概念术语考论[M]. 人民卫生出版社, 2012.
- [30] 沈雪勇主编. 经络腧穴学[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2021.
- [31] 韦英才. 实用壮医筋病学[M]. 南宁: 广西科学技术出版社, 2016.
- [32] [美]Thomas W.Myers 著. 解剖列车——徒手与动作治疗的肌筋膜经线[M]. 北京: 北京科学技术出版社, 2016.
- [33] 黄龙祥. 经脉理论还原与重构大纲[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2016.
- [34] 黄龙祥. 黄龙祥看针灸[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2008.
- [35] 黄艺, 黄敬伟. 经筋疗法(第二版)[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2018.
- [36] 薛立功, 张海荣. 经筋理论与临床疼痛诊疗学[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2002.
- [37] 陈潮祖. 中医治法与方剂[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2009.
- [38] 梁繁荣, 王毅. 揭秘敝昔遗书与漆人[M]. 成都: 四川科学技术出版社, 2016.
- [39] 张家山二四七号汉墓竹简整理小组. 张家山汉墓竹简(二四七号墓)(释文修订版)[M]. 北京: 文物出版社, 2006.
- [40] 冯友兰. 中国哲学史新编(修订本)第二册, 三松堂全集[M]. 郑州: 河南人民出版社, 2000.
- [41] 裘锡圭. 稷下道家精气说的研究. 裘锡圭学术文集·古代历史、思想、民俗卷[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2012.

- [42] [日]广濑薰雄. 谈老官山汉简医书中所见的诊损至脉论, 简帛研究论集[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2019.
- [43] 李凯. 出土文献与商周文明初探[M]. 北京: 北京联合出版公司, 2015.
- [44] 李学勤. 出土文献与中国古代文明——李学勤先生八十寿诞纪念论文集[M]. 上海: 中西书局, 2016.
- [45] 马伯英. 中国医学文化史[M]. 上海: 上海人民出版社, 2010.
- [46] [日]山田庆儿著; 廖育群, 李建民编译. 中国古代医学的形成·传统医学的历史与理论(原名: 中国医学の起源)[M]. 台北: 东大图书股份有限公司, 2003.
- [47] 承淡安. 中国针灸学[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 2016.
- [48] 李学勤. 出土简帛与古史再建[M]. 北京: 经济科学出版社, 2017.
- [49] 宋镇豪. 夏商社会生活史[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1994.
- [50] 中国社会科学院考古研究所. 殷墟发掘报告 1958-1961[M]. 北京: 文物出版社, 1987.
- [51] 张炜. 商代医学文化史略[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 2005.
- [52] 许进雄. 中国古代社会: 文字与人类学的透视(修订本)[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2008.
- [53] 胡厚宣. 殷人疾病考·甲骨学商史论丛初集[M]. 石家庄: 河北教育出版社, 2002.
- [54] 李良松, 刘学春. 甲骨文化与中医学[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2017.
- [55] 温少峰, 袁庭栋. 殷墟卜辞研究——科学技术篇[M]. 成都: 四川省社会科学院出版社, 1983.
- [56] 韩健平. 马王堆古脉书研究[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1999.
- [57] 严健民. 中国医学起源新论[M]. 北京: 北京科技出版社, 1999.
- [58] 严健民. 远古中国医学史[M]. 北京: 中医古籍出版社, 2006.
- [59] 马继兴. 马王堆古医书考释[M]. 长沙: 湖南科学技术出版社, 1992.
- [60] 廖育群. 歧黄医道[M]. 沈阳: 辽宁教育出版社, 1992.
- [61] 马继兴. 双包山西汉墓出土经脉漆木人型的研究, 马继兴医学文集[M]. 北京: 中医古籍出版社, 2009.

- [62] 李贞德. 性别、身体与医疗[M]. 北京: 中华书局, 2012.
- [63] 马继兴. 针灸学通史[M]. 长沙: 湖南科学技术出版社, 2011.
- [64] 中国科学院考古研究所. 甲骨文编[M]. 北京: 中华书局, 1965.
- [65] 周一谋, 萧佐桃. 马王堆医书考注[M]. 天津: 天津科学技术出版社, 1988.
- [66] 马继兴. 出土亡佚古医籍研究[M]. 北京: 中医古籍出版社, 2005.
- [67] 赵京生. 针意[M]. 人民卫生出版社, 2019.
- [68] 黄龙祥. 中国古典针灸学大纲[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2019.
- [69] 黄龙祥, 黄幼民. 针灸腧穴通考: 《中华针灸穴典》研究. 第一版[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2011.
- [70] 刘滴川. 大瘟疫——病毒、毁灭和帝国的抗争[M]. 成都: 天地出版社, 2019: 4.
- [71] [日]丹波康赖. 医心方[M]. 北京: 华夏出版社, 2011.
- [72] 李建民. 生命史学——从医疗看中国历史[M]. 上海: 复旦大学出版社, 2008.
- [73] 黄龙祥, 黄幼民整理. 元代珍稀针灸三种[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2008.
- [74] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会发布. 腧穴名称与定位[M]. 北京: 中国标准出版社, 2006.
- [75] [日]丹波康赖. 医心方[M]. 北京: 华夏出版社, 2011.
- [76] 张家山汉墓竹简整理小组. 张家山汉墓竹简二四七号墓(释文修订本)[M]. 北京: 文物出版社, 2006.
- [77] 周楣声. 灸绳[M]. 青岛: 青岛出版社, 2017.

学术论文

- [1] 夏鼐. 关于考古学上文化的定名问题[J]. 考古, 1959(04): 169-172.
- [2] KIM B H. On the Kyungrak System[J]. J Acad Med Sci DRP Korea, 1963, 90: 1-41.
- [3] BENIAS P C, WELLS R G, SACKEY-ABOAGYE B, et al. Structure and distribution of an unrecognized interstitium in human tissues[J]. Sci Rep, 2018, 8(1): 4947.

- [4] 宋晓晶,王广军,李宏彦,等. 经络研究 60 年——一条多学科交叉之路[J]. 针刺研究,2021,46(06):527-532.
- [5] 余琛,徐东升,崔晶晶,等. 腧穴结构研究的思考[J]. 针刺研究,2018,43(05):285-289.
- [6] 周琦,李志芳. 荆州胡家草场西汉墓医方木牍“已痢方”初探[J]. 简帛研究,2020(02):150-161.
- [7] 金陵,曾帆,薄咏,等. 四川成都天回汉墓医简整理简报[J]. 文物,2017(12):48-57.
- [8] 桑兵. 近代学术转承:从国学到东方学——傅斯年《历史语言研究所工作之旨趣》解析[J]. 历史研究,2001(03):29-44+189.
- [9] 杨博. 出土战国秦汉简牍典籍的史料特点[J]. 简帛研究,2020(01):336-344.
- [10] [英]鲁惟一著;张书生译. 秦汉简帛与秦汉史研究[J]. 简帛研究,1993:34.
- [11] 冯胜君. 出土材料所见先秦古书的载体以及构成和传布方式[J]. 出土文献与古文字研究,2011:195.
- [12] 张显成. 论简帛的文献学研究价值[J]. 古籍整理研究学刊,2005(01):34-40.
- [13] 徐建委. 战国秦汉间的“公共素材”与周秦汉文学史叙事[J]. 中山大学学报(社会科学版),2012,52(06):1-9.
- [14] 张显成. 论简帛的中医药学史研究价值[J]. 简牍学研究,2004(00):251-263.
- [15] 赵容俊. 秦汉中国医学基础理论确立的考察[J]. 医疗社会史研究,2016,1(02):75-110+329.
- [16] 柳长华. 天回医简整理研究引领中医学学术前沿[J]. 天府新论,2021(03):2+161.
- [17] 桑兵. 从眼光向下回到历史现场——社会学人类学对近代中国史学的影响[J]. 中国社会科学,2005(01):191-204+209.
- [18] 周书灿. 论“走出疑古”与古史重建[J]. 贵州大学学报(社会科学版),2007(06):51-57.

- [19] 裘锡圭,曹峰.“古史辨”派、“二重证据法”及其相关问题——裘锡圭先生访谈录[J].文史哲,2007(04):5-16.
- [20] 裘锡圭.出土文献与古典学重建[J].出土文献,2013(00):1-18.
- [21] 谢科峰.早期古书流传问题研究——以相关出土文献与传世文献的比较为例[D].上海大学,2015.
- [22] 来国龙.论战国秦汉写本文化中文本的流动与固定[J].简帛,2007:515-527.
- [23] 彭浩.张家山汉简《引书》初探[J].文物,1990(10):87-91+106.
- [24] [法]风仪诚:古代简牍形式的演变——从丧葬物疏说起[J].简帛,2009:357.
- [25] 李学勤.简帛书籍的发现及其影响[J].文物,1999(10):7.
- [26] 王玉德,吕金伟.晚周秦汉初医学知识传承研究[J].医学与哲学(A),2014,35(10):80-82.
- [27] [美]夏含夷,孙夏夏.出土文献与《诗经》口头和书写性质问题的争议[J].文史哲,2020(02):21-38+165.
- [28] 周琦.天回医简中的刮削校改痕迹研究[J].简帛研究,2018(01):185-201.
- [29] 杨伯峻.孙臆和《孙臆兵法》杂考[J].文物,1975(3):6.
- [30] 郭珏.秦汉出土文献中的“知死”与“事死”——一个基于“形成框架”的试分析及方法论上的思考[J].简帛,2013(00):49-67+579.
- [31] 马继兴.双包山汉墓出土的针灸经脉漆木人形[J].文物,1996(04):55-65+98.
- [32] 黄龙祥.老官山出土汉简脉书简解读[J].中国针灸,2018,38(01):97-108.
- [33] 顾漫,周琦,柳长华,等.天回医简《经脉》残篇与《灵枢·经脉》的渊源[J].中国针灸,2019,39(10):1117-1123.
- [34] 邱科.老官山汉墓经穴髹漆人像六阴经循行特点研究[D].成都中医药大学,2016.
- [35] 邱科,曾芳,孙睿睿,等.成都老官山汉墓经穴髹漆人像手三阴经循行考证

- [J]. 中华中医药杂志, 2018, 33 (04): 1480-1482.
- [36] 程施瑞, 周兴兰, 邱科, 等. 成都老官山汉墓经穴髹漆人像十二经脉循行考证 (英文) [J]. World Journal of Acupuncture-Moxibustion, 2022, 32 (01): 40-48.
- [37] 赵坤, 李成卫, 王庆国. 基于《黄帝内经》形气观分析心与血脉的关系 [J]. 中医杂志, 2018, 59 (05): 361-364.
- [38] 孙迪, 朱鹏举, 陈磊, 等. 《黄帝内经》“手”相关术语研究 [J]. 长春中医药大学学报, 2021, 37 (03): 497-500.
- [39] 黄龙祥. 心经、肺经“是动”病新解——解读经络学说的新证据 [J]. 中国中医基础医学杂志, 2005 (11): 19-21.
- [40] 邱科, 周兴兰, 孙睿睿, 等. 从西汉出土经穴髹漆人像看手厥阴经脉的循行演变 [J]. 中国中医基础医学杂志, 2016, 22 (10): 1372-1373+1390.
- [41] 张建斌, 王玲玲. “心包经”质疑 [J]. 中国针灸, 2001 (03): 37-38.
- [42] 周波. 心主是中枢神经的佐证——兼探讨心包络的实体 [J]. 医学与哲学 (人文社会医学版), 2010, 31 (11): 80-81.
- [43] 洪晓帆, 陈思婷, 李红霞. “心主手厥阴心包络之脉”早期演化考 [J]. 中国针灸, 2021, 41 (03): 349-353.
- [44] 刘峰, 黄晓红, 龚小钢, 等. 心主刍议 [J]. 医学与哲学 (A), 2016, 37 (12): 84-86+97.
- [45] 李瑞超, 李岩, 焦召华, 等. 手厥阴心包经刍议 [J]. 山西中医, 2013, 29 (6): 37-45.
- [46] 侯书伟, 胡志强. 帛书《经脉》缺手太阴脉论 [J]. 山东中医学院学报, 1989, 13 (4): 49-50.
- [47] 李鼎. 《脉书》臂五脉与手六经及其经穴主治关系的分析 [J]. 上海中医药大学上海市中医药研究院学报, 1996 (2): 34-37.
- [48] 廖育群. 《阴阳十一脉灸经》研究——兼论经络体系的形成与发展 [J]. 中华医史杂志, 1989 (1): 20-24.
- [49] 韩健平. 经脉学说的早期历史: 气、阴阳与数字 [J]. 自然科学史研究, 2004, 23 (4): 326-333.
- [50] 张苇航. “手心主脉”考——兼论早期经脉学说的演变 [J]. 医疗社会史研

- 究,2016,1(02):111-121+330.
- [51] 李永明. 汉代十一脉到十二经脉转变的解剖依据[J]. 中国针灸,2021,41(10):1153-1158.
- [52] 吕晓雪,王育林. 考释“咽”“喉”“咙”“嗑”“噎”“嘶”“喝”[J]. 浙江中医药大学学报,2020,44(04):391-393+406.
- [53] 孟凡琪,张荷,陈秀华. 《黄帝内经》中的“咽嗑”病[J]. 中国医药导报,2020,17(10):122-125.
- [54] 周昌清,严江涛,范巧,等. 咽、颈、胸痛与心脏反应新的临床综合征[J]. 中华心血管病杂志,2010(02):147-151.
- [55] 王雪,朱鹏举. 《黄帝内经》“手少阴脉动甚者妊子”说古注述评[J]. 国医论坛,2022,37(01):14-16.
- [56] 吕亚虎. 帛书《胎产书》所见早期孕育信仰浅析[J]. 江汉论坛,2009(06):70-77.
- [57] 张乙小,周兴兰,曾芳,等. 老官山汉墓出土经穴髹漆人像手阳明经脉循行演变研究[J]. 中医杂志,2019,60(23):1985-1987+1992.
- [58] 周兴兰,张乙小,曾芳. 成都老官山汉墓出土髹漆经穴人像手少阳脉循行特点研究[J]. 中医杂志,2020,61(11):942-945.
- [59] 孙玉龙. 三焦名实考[J]. 北京中医药大学学报,2008(03):153-157+161.
- [60] 卫杨. 三焦气化理论研究[D]. 广州中医药大学,2017:17.
- [61] 张迪,周兴兰,曾芳,等. 成都老官山汉墓出土髹漆经穴人像手太阳小肠经循行研究[J]. 中医杂志,2019,60(08):636-639.
- [62] 赵争. 古书成书与古书年代学问题探研——以出土古脉书《足臂十一脉灸经》和《阴阳十一脉灸经》为中心[J]. 中国典籍与文化,2016(01):7-12.
- [63] 何宋禹. 马王堆帛书《足臂十一脉灸经》有关的问题再探[J]. 中华医史杂志,1984,14(3):172-175.
- [64] 顾植山. 六经探源[J]. 安徽中医学院学报,1991(03):2-5.
- [65] 赵京生. 阳经五官病候及治疗用穴分析——兼论经脉病候与腧穴主治关系[J]. 针刺研究,2007(06):411-418.
- [66] 赵争. 古脉书《足臂十一脉灸经》与《阴阳十一脉灸经》相对年代问题考

- 论[J]. 出土文献, 2015(02): 193-215.
- [67] 黄龙祥. 扁鹊医籍辨佚与拼接[J]. 中华医史杂志, 2015, 45(01): 33-43.
- [68] 俞海跃, 郑文江, 李卓明. 以出土文献视角考证《神农本草经》“胃络脉绝”[J]. 中医药导报, 2021, 27(11): 201-203+210.
- [69] 王宝华, 赵京生. 足太阴经“所生病”辨析[J]. 中国针灸, 2011, 31(08): 761-763.
- [70] 刘春语. 汉简帛医书十三种字词集释[D]. 西南大学, 2016.
- [71] 李晓彤, 何丽云, 付璐, 等. 浅析秦汉时期足厥阴经的形成及早期演变[J]. 中华中医药杂志, 2021, 36(03): 1567-1570.
- [72] 赵京生, 王为群. 足厥阴经与消渴[J]. 中国针灸, 2002(09): 60-62.
- [73] 黄龙祥. 从“厥阴脉”概念的形成过程看经络学说的意义与价值[J]. 针刺研究, 2003(04): 280-287.
- [74] 杨峰, 赵京生. 出土经脉文献中足厥阴经脉病候“热中”的由来与演变——从《史记·扁鹊仓公列传》之“中热”说起[C]//中国针灸学会针灸文献专业委员会 2006 年学术年会论文汇编, 2006: 86-88.
- [75] 赵京生. 足厥阴肝经主小便病候的由来与演变[J]. 上海针灸杂志, 1999(02): 42-43.
- [76] 王为群. 唐以前足厥阴经主治病症的研究[D]. 南京中医药大学, 2001.
- [77] 吴晓玲, 林怡, 彭超, 等. 足厥阴肝经循行与肝联系之析疑[J]. 福建中医药, 2021, 52(12): 28-30.
- [78] 赵争. 从出土文献看早期经脉学说[J]. 医疗社会史研究, 2016, 1(02): 51-74+328-329.
- [79] 李丽, 王育林. 《足臂十一脉灸经》“牧牧”考[J]. 吉林中医药, 2016, 36(04): 421-425.
- [80] 刘立安. 宋以前灸疗学术发展史研究[D]. 北京中医药大学, 2020: 30.
- [81] 印帅, 程施瑞, 曾芳, 等. 从成都老官山汉墓髹漆人像看足阳明经脉循行演变[J]. 辽宁中医杂志, 2017, 44(01): 71-73.
- [82] 王凡, 曹一鸣. 关于《内经》中阳明经几个问题的探讨[J]. 天津中医学院学报, 1987(03): 2-5.

- [83] 周国琪. 试从《内经》探析足阳明脉与精神疾病的关系[J]. 中国中医基础医学杂志, 2010, 16(11): 981-983.
- [84] 张建斌, 王玲玲. 足阳明脉“是动病”病候探讨[J]. 安徽中医学院学报, 2005(06): 1-4.
- [85] 高薇, 李瑞, 张雯, 等. 足阳明胃经病候“洒洒振寒”与胃之关系浅析[J]. 中国针灸, 2020, 40(04): 435-438.
- [86] 刘枫凤, 李瑞. 论“独闭户塞牖而处”与抑郁症[J]. 中国针灸, 2018, 38(03): 315-318.
- [87] 黄柳杨, 曾芳, 周兴兰, 等. 从西汉出土经穴髹漆人像看足少阳经脉的循行演变[J]. 成都中医药大学学报, 2017, 40(01): 91-94.
- [88] 刘俊莉. 试论“厥”在上古的历史演变[J]. 襄阳师专学报, 1998, 19(01): 49-52.
- [89] 郭培杰. 古医籍中厥病的文献研究[D]. 北京中医药大学, 2013: 77.
- [90] 彭榕华, 高驰, 段逸山. 释“厥”[J]. 中华中医药杂志, 2016, 31(08): 2899-2904.
- [91] 印帅, 曾芳, 周兴兰, 等. 成都老官山汉墓髹漆人像足太阳经脉循行浅析[J]. 辽宁中医杂志, 2017, 44(06): 1281-1283.
- [92] 陈晓红. 简帛医书经脉文献比较研究[D]. 广西中医药大学, 2020.
- [93] 赵京生. 阳脉理论演进及其意义[J]. 中国针灸, 2011, 31(11): 1035-1039.
- [94] 王峰. 《足臂》《阴阳》《内经》与伤寒六经提纲病症的联系研究[D]. 云南中医学院, 2017: 13.
- [95] 刘阳, 顾漫. 足太阳经病“冲头”“冲头痛”辨义[J]. 中华医史杂志, 2018, 48(04): 228-231.
- [96] 杨峰, 赵京生. 从简帛医书看《内经》足六脉病候[J]. 中国针灸, 2007(11): 865-868.
- [97] 闫培烜, 许昕. 明代冲脉与阳明关系的文献研究[J]. 环球中医药, 2019, 12(05): 708-713.
- [98] 林琪家. 冲脉古代文献研究[D]. 北京中医药大学, 2011.
- [99] 李博灵, 张保亭. 由释名探析冲脉之循行[J]. 中国中医基础医学杂志

- 志,2019,25(06):718-720+723.
- [100] 衣华强. 冲脉起始部位探析[J]. 上海针灸杂志,2017,36(03):354-356.
- [101] 杜元灏. 从《内经》中冲脉的功能和循行特点探讨冲脉实质——论冲脉与内分泌性腺轴的关系[J]. 中医药学刊,2006(02):206-207.
- [102] 闫培烜. 明清两代冲脉与阳明关系的文献研究[D]. 北京中医药大学,2020.
- [103] 马宁. 冲脉的胚胎发生学探讨[J]. 山东中医药大学学报,2017,41(06):507-511.
- [104] 黄龙祥. 任脉、冲脉概念的形成与演变[J]. 中国针灸,2002(08):26-28.
- [105] 李磊,尤传香. 冲脉循行考[J]. 中华中医药杂志,2013,28(01):190-192.
- [106] 黄龙祥. 老官山出土西汉针灸木人考[J]. 中华医史杂志,2017,47(03):131-144+194.
- [107] 杜广中,马颜玲,王淑香,等. “任脉色素沉着带”现象的调查[J]. 针刺研究,2006(04):239-242+257.
- [108] 马宁. 任脉、督脉的胚胎发生学探讨[J]. 山东中医药大学学报,2017,41(05):412-416.
- [109] 林泰骄,叶声,林超岱. 任脉与“腹白线”关系研究[J]. 中华中医药杂志,2012,27(07):1750-1752.
- [110] 张倩,周美启. 奇经八脉的经脉脏腑相关研究[J]. 中国针灸,2017,37(12):1299-1302.
- [111] 张建斌,王玲玲. 古“督脉经”探析[J]. 浙江中医杂志,2006,41(5):249-251.
- [112] 孙征,张建斌. 督脉病候的古代界定和现代范畴[J]. 中国针灸,2017,37(10):1077-1080.
- [113] 郝亚薇,杨晓倩,汤立新. 带脉理论探析[J]. 北京中医药大学学报(中医临床版),2013,20(02):58-60.
- [114] 蔡红. 古代汉语人体下肢名称系统研究[D]. 南通大学,2014:20.
- [115] 陈继明. 浅谈带脉[J]. 中医杂志,1983(07):54-56.
- [116] 赵敬军,黄海龙,张祎平,等. 穴位功能态“经穴-内脏-疾病”特异性联系

- 探析[J]. 中国中医基础医学杂志, 2015, 21(12): 1555-1557.
- [117] 梁繁荣, 曾芳, 周兴兰, 等. 成都老官山出土经穴髹漆人像初探[J]. 中国针灸, 2015, 35(01): 91-93.
- [118] 刘澄中. 论老官山脉穴木人的白脉循行系统——兼评“经穴髹漆人像初探”[J]. 中国针灸, 2018, 38(02): 198-202.
- [119] 马宁. 带脉结构的解剖还原[J]. 中国针灸, 2020, 40(10): 1133-1135+1148.
- [120] 吴盛宏. 临床艾灸发现带脉循行 1 例[J]. 针刺研究, 2009, 34(03): 198.
- [121] 田宁, 贾萍, 陈日新. 艾条温和灸阴交穴激发带脉感传 3 例[J]. 江西中医药, 2004(04): 58.
- [122] 李牧月. 跷脉的古今文献整理研究[D]. 广西中医药大学, 2019.
- [123] 田辉, 卞镬, 隋月皎, 等. 跷脉与人体平衡功能相关性探讨[J]. 中国针灸, 2015, 35(04): 352-354.
- [124] 王磊, 谷世哲, 马惠芳. 跷脉的循行特点及主治规律[J]. 中国针灸, 2001(04): 29-31.
- [125] 袁静, 高希言. 对阳维脉交会膺穴的文献探讨[J]. 针刺研究, 1998(03): 237-238.
- [126] 李冲. 阴、阳维脉的文献整理研究[D]. 广西中医药大学, 2019.
- [127] 袁静, 贾登云, 高希言. 对“阴维为病苦心痛”“阳维脉苦寒热”的探讨[J]. 中医研究, 2006(03): 55-57.
- [128] 高希言, 王栋斌, 王鑫, 等. 对维脉病候的探讨[J]. 上海针灸杂志, 2015, 34(06): 572-574.
- [129] 高希言, 陈岩, 孙婵娟. 李鼎教授对奇经八脉的认识[J]. 中国针灸, 2011, 31(07): 653-656.
- [130] 陈泽林. 阴阳维脉古今观[J]. 上海针灸杂志, 2004(03): 35-37.
- [131] 侯书伟, 胡志强. 《灵枢》十二经别分布规律探讨[J]. 上海中医药杂志, 1995(02): 42-43.
- [132] 赵京生. 经别求是[J]. 中国针灸, 2008(09): 691-695.
- [133] 刘兵. 表里关系的经脉理论研究——基于两种经脉模式认识的古代文献

- 理论分析[D]. 南京中医药大学, 2011.
- [134] 黄月莲. 浅析十二经别“六合”理论及其在临床上的应用[J]. 广西中医药, 2014, 37(01): 61-63.
- [135] 高兵, 程悦, 曾永蕾, 等. 十二经别析疑[J]. 中国针灸, 2020, 40(08): 887-890.
- [136] 王一品. 《黄帝内经》筋骨理论及相关术语研究[D]. 辽宁中医药大学, 2021.
- [137] 薛立功, 李江舟. 经筋的现代解剖学重组分析[C]//中国针灸学会经筋诊治专业委员会成立大会论文集, 2009: 32-39.
- [138] 董宝强, 李春日, 黄凤云, 等. 从经筋治痛谈经络起源[J]. 中国针灸, 2011, 31(08): 711-713.
- [139] 陈德成. “动筋针法”和靶点概述[J]. 中国针灸, 2016, 36(09): 941-944.
- [140] 陈德成. 针刺层次与针感的关系[J]. 中国针灸, 2017, 37(11): 1219-1222.
- [141] 赵京生. 气街理论研究[J]. 针刺研究, 2013, 38(06): 502-505.
- [142] 刘农虞. 经筋与卫气[J]. 中国针灸, 2015, 35(02): 185-188.
- [143] 程永, 王竹行, 唐成林, 等. 经筋病中医病理机制理论探讨[J]. 辽宁中医药大学学报, 2014, 16(06): 101-108.
- [144] 董宝强, 林星星, 王树东, 等. 经筋刺法与针至病所理论的关系[J]. 中医杂志, 2017, 58(03): 189-191+194.
- [145] 沈宇平, 董宝强, 林星星, 等. 结筋病灶点与激痛点的比较[J]. 中华中医药学刊, 2016, 34(11): 2646-2649.
- [146] 王列, 马帅, 马铁明, 等. 激痛点与阿是穴、压痛点、腧穴、经筋点、结筋病灶点辨析[J]. 中西医结合研究, 2021, 13(6): 415-417.
- [147] 王秦江. 《左传》所见疾病、医疗及其与社会的关系[D]. 湖北省社会科学院, 2020.
- [148] 杜旭, 陈泽林. 试论“筋象”与拔罐疗法的“度筋论治”[J]. 中国针灸, 2019, 39(05): 541-544.
- [149] 陈采益, 徐斌. 基于区分经筋病症与脏腑病症进行针灸辨证论治的思考[J]. 中国针灸, 2017, 37(10): 1105-1107.

- [150] 刘农虞. “筋脉系统”假说[J]. 中国针灸, 2017, 37(01): 79-83.
- [151] 刘农虞. “筋针”的作用机制探析[J]. 中国针灸, 2015, 35(12): 1293-1296.
- [152] 薛立功. 经筋系统的生理结构与解剖内涵[C]//中国针灸学会经筋诊治专业委员会成立大会论文集, 2009: 81-93.
- [153] 赵京生. 从应用角度检视针灸理论[J]. 中国针灸, 2017, 37(10): 1115-1118.
- [154] 刘农虞. 议“燔针劫刺”[J]. 中国针灸, 2013, S1: 102-104.
- [155] 刘农虞. 谈“以知为数”[J]. 针灸临床杂志, 2013, 06: 67.
- [156] 刘农虞. 析“以痛为输”[J]. 针灸临床杂志, 2014, 02: 55-57.
- [157] 王茵萍. 经筋病“以痛为输”辨析[J]. 安徽中医学院学报, 2000(01): 38-39.
- [158] 许军峰, 卞金玲, 吕建明. 石学敏院士对《内经》“维筋相交”理论探析[J]. 中国针灸, 2015, 35(08): 830.
- [159] 刘文秀, 马凯强, 李博灵, 等. “维筋相交”之我见[J]. 中国针灸, 2018, 38(03): 261-262.
- [160] 王燕平, 侯学思. 论腧穴分类[J]. 中国针灸, 2019, 10: 1069-1072+1074.
- [161] 张文兵, 霍则军. 反阿是穴肌肉起止点取穴法初探[J]. 辽宁中医杂志, 2001, 28(7): 432-433.
- [162] 曹曷焱, 饶毅, 庄威, 等. 从骨骼肌张力传递解读反阿是穴的治疗效果[J]. 中国针灸, 2021, 41(02): 217-220.
- [163] 胡忍杰, 蒋永亮, 李荣荣, 等. 经筋病“依脉引筋气”探微[J]. 中国针灸, 2021, 41(03): 335-338.
- [164] 李怡廷, 武平, 廖晨希. 太阳主筋释疑[J]. 中国针灸, 2019, 39(06): 659-660.
- [165] 叶建, 管遵惠. 管遵惠老师经筋理论的运用经验[J]. 云南中医中药杂志, 2005(03): 2-3.
- [166] 尤柱, 于本性, 邓甜甜, 等. 肩周炎结筋病灶点临床触诊规律分析[J]. 中国针灸, 2014, 34(06): 565-568.
- [167] 张书剑, 张小卿, 韩煜, 等. 膝骨性关节炎经筋病灶点触诊规律分析[J]. 中

- 国针灸,2012,32(03):267-272.
- [168] 余新忠. 中国疾病、医疗史探索的过去、现实与可能[J]. 历史研究,2003(4):158-168.
- [169] 赵京生. 针灸视域下的身体表达[J]. 中国针灸,2019,39(03):307-312.
- [170] 和靖,李炜弘,欧阳双,等. 基于陈潮祖“膜腠三焦”学说再探三焦的形质与功能[J]. 中华中医药杂志,2021,36(04):1969-1971.
- [171] 魏子耿,李丽肖,刘永强,等. 《灵枢·经筋》“十二经筋”组织解剖结构浅析[J]. 河北中医,2016,38(02):272-274+301.
- [172] 刘斌. 经筋定义及特性之启发[J]. 中华中医药杂志,2019,34(03):888-891.
- [173] 梁宜,方剑乔. 《灵枢》经筋理论探析[J]. 中医杂志,2006,49(6):488-489.
- [174] 颜富雄. 经筋系统—人体十二条运动力线的探讨与临床应用[D]. 山东中医药大学,2016.
- [175] 魏子耿,李丽肖,刘永强,等. 《灵枢·经筋》“十二经筋”组织解剖结构浅析[J]. 河北中医,2016,38(02):272-274+301.
- [176] 李洁. 络脉文献的整理与研究[D]. 成都中医药大学,2006.
- [177] 广濑薰雄. 天回老官山汉简《别脉》初探[J]. 出土文献与古文字研究,2020(00):316-328.
- [178] 赵丹,段逸山,王兴伊. 试析老官山汉墓《刺数》“经脉穴”与《黄帝内经》腧穴的对应关系[J]. 中国中医基础医学杂志,2019,25(02):205-208.
- [179] 萧淑芳. 络脉的古代文献研究[D]. 北京中医药大学,2006.
- [180] 冉维正,陈志刚. 从“久病入络”看络脉层次分类的必要性[J]. 中国中医基础医学杂志,2019,25(07):883-884+981.
- [181] 吴以岭. 络病病机探析[J]. 中医杂志,2005,46(4):243-245.
- [182] 吴以岭. 脉络学说构建及其指导血管病变防治研究[J]. 中国中西医结合杂志,2017,37(2):147-148.
- [183] 陆鹏,由凤鸣,胡幼平,等. 玄府—络脉体系概论[J]. 中国中医基础医学杂志,2017,23(01):29-30+92.
- [184] 陆鹏,刘丽香,潘迪,等. 论肾玄府络脉与肾小球滤过屏障[J]. 中医杂

- 志,2016,57(21):1888-1890.
- [185] 陆鹏,任凤艳,潘迪,等.肺玄府络脉与气血屏障论[J].中医杂志,2016,57(16):1433-1435.
- [186] 李红梅,王显.从“玄府-气血-络脉”新视点探讨动脉粥样硬化“络风内动”学说[J].中医杂志,2015,56(05):441-443.
- [187] 王显,王永炎.对“络脉、病络与络病”的思考与求证[J].北京中医药大学学报,2015,38(09):581-586.
- [188] 孙静文,田艳鹏,郭妍,等.脉之本义及其学术演变[J].中国针灸,2015,35(06):619-622.
- [189] 于春燕.从出土材料看《管子》相关篇章的成书年代[D].山东师范大学,2021.
- [190] 赵京生.简帛脉学文献对经脉认识的意义[J].医疗社会史研究,2016,1(02):36-50+328.
- [191] 赵容俊.先秦中国医学基础理论形成的考察[J].历史文献研究,2014(01):88-108.
- [192] 刘娇.据张家山汉简《引书》中的“精气”思想解读其中两处文字[J].出土文献,2020(02):93-103+157.
- [193] [英]罗维前著,邬文玲译.痛的溯源——论痛、厥与经脉中气循环理论的形成[J].简帛研究,2001:275.
- [194] 程少轩.也谈张家山汉简《脉书》的“气勤则忧”[J].出土文献,2018(02):277-284.
- [195] 李永明.经脉的科学依据及三部九候新释[J].中国中西医结合杂志,2021,41(10):1168-1173.
- [196] 刘小梅,李继明.老官山汉墓医简中脉诊理论学术思想初探[J].中医药文化,2017,12(01):4-6.
- [197] 袁开惠,王小芸,赵怀舟.也谈老官山汉墓医简所载“损至脉”[J].中医药文化,2019,14(04):75-82.
- [198] 丁媛.呼吸、脉搏与疾病——从老官山汉墓医简所载之“损至脉”谈起[J].古籍整理研究学刊,2022(01):52-60.

- [199] 汪桂海. 符水疗疾——汉代医疗信仰的一个侧面[J]. 简帛研究, 2017(02): 180-190.
- [200] 赵光怀. 汉代民间巫术与知识信仰[J]. 民俗研究, 2011(04): 79-88.
- [201] 杨勇. 从出土文献再论战国秦汉时期的巫、医关系[J]. 简帛研究, 2019(02): 188-201.
- [202] 张显成, 庄利果. 论简帛的民俗史研究价值——兼论民俗史研究的文献材料问题[C]//古籍整理研究与中国古典文献学学科建设国际学术研讨会. 山东大学文史哲研究院, 2009: 191-209.
- [203] 马继兴. 台西村商墓中出土的医疗器具砭镰[J]. 文物, 1979(6): 3.
- [204] 周世荣. 湖南石门县皂市发现商殷遗址[J]. 考古, 1962(3): 4.
- [205] 周一谋. 略论针灸的起源[J]. 针灸临床杂志, 2001(01): 2-4.
- [206] 徐文斌, 李素云, 徐青燕, 等. 浅说针灸器具的发展演变[J]. 针刺研究, 2010, 35(06): 474-477.
- [207] 李学勤. 西周甲骨的几点研究[J]. 文物, 1981(09): 7-12.
- [208] 胡厚宣. 论殷人治疗疾病之方法[J]. 中原文物, 1984(4): 4.
- [209] 李宗焜(Zong-Kun Li). 从甲骨文看商代的疾病与医疗[J]. 中央研究院历史语言研究所集刊, 2001: 339-391.
- [210] 张杰. 试论殷人对疾病及其治疗的认识[D]. 郑州大学, 2002.
- [211] 中医研究院医史文献研究室. 马王堆帛书四种古医学佚书简介[J]. 文物, 1975(06): 16-19.
- [212] 林磊, 图娅. 简帛医书经脉命名剖析[J]. 针灸临床杂志, 2005(09): 1.
- [213] 李海峰, 张如青, 张显成. 出土文献与《内经》的经脉异名分析[J]. 上海针灸杂志, 2015, 34(11): 1126-1128.
- [214] 严健民. 《素问·阴阳别论》“人有四经”考释[J]. 湖南中医学院学报, 1997(03): 7-8.
- [215] 马继兴. 马王堆出土的古医书[J]. 中华医史杂志, 1980, 10(1): 41-46.
- [216] 王洪弘. 《黄帝内经》术数思想研究[D]. 北京中医药大学, 2017.
- [217] 李素云, 赵京生. 从经脉的循行变化探讨其概念内涵的演变——由“十一脉”至“十二经脉”循行变化引发的思考[J]. 针刺研

- 究,2009,34(02):132-135.
- [218] 袁玮.“十一脉”说之前可能存在足“六脉”说[J].上海针灸杂志,1988,(1):37-38.
- [219] 何志国.西汉人体经脉漆雕再考[J].四川文物,2000(06):6-11.
- [220] 汪登伟.战国时期道家与方仙家的交集——以《庄子》为例[J].中国道教,2020(03):51-57.
- [221] 杜正胜.从眉寿到长生——中国古代生命观念的转变[J].中研院历史语言研究所集刊.1995,66(2):457-459.
- [222] 程雅君,赵怡然.中医经络学说的哲学渊源[J].哲学研究,2017(09):65-74.
- [223] 张建斌.经典经络原理探析[C]//中国针灸学会经络分会第十二届全国针灸经络学术研讨会论文集,2012:6-13.
- [224] 臧颖颖,王朝阳,刘清国.标本根结理论与十二经脉流注关系之探讨[J].中华中医药杂志,2021,36(06):3118-3120.
- [225] 赵京生.足经腧穴远道主治规律的理论形式——根结理论解读[J].中国针灸,2008,28(5):387-391.
- [226] 李海峰.简帛踝部诊脉法发微[J].中国中医基础医学杂志,2022,28(01):33-35+43.
- [227] 李丽.战国秦汉简帛文献医学词汇研究[D].北京中医药大学,2019:34.
- [228] 梁繁荣,谢克庆,和中浚,等.西汉人体漆雕经脉研究[J].上海中医药杂志,1998(05):36-39.
- [229] 赵京生.经脉分支的形成过程与意义[J].上海中医药大学学报,1999(02):11-13.
- [230] 颜纯淳.百会穴古代文献研究[D].山东中医药大学,2012.
- [231] 曹曷焱.小议《灵枢·经脉》篇“是动”“所生病”及其区分依据[J].中国针灸,2017,37(07):776-778.
- [232] 李海峰.从出土和传世早期经脉类文献中的疼痛病症看经脉理论的形成[J].吉林中医药,2020,40(06):820-822.
- [233] 黄龙祥.经脉病候考源[J].中华医史杂志,1994(04):219-222+194.

- [234] 张乙小. 成都老官山汉墓经穴髹漆人像足三阳脉腧穴考证研究[D]. 成都中医药大学, 2020.
- [235] 苏妆. 《黄帝内经》腧穴理论的发生学研究[D]. 辽宁中医药大学, 2013.
- [236] 张胜男. 《黄帝内经》腧穴相关理论探析[D]. 辽宁中医药大学, 2014.
- [237] 童艳, 瞿巧钰, 朱超, 等. 浅析人体“天牖五部”[J]. 中国针灸, 2021, 41(08): 937-940.
- [238] 赵京生. 腧穴命名的演变: 基于天回医简分析[J]. 中国针灸, 2019, 39(09): 1017-1020.
- [239] 曹曷焱, 朱世鹏, 刘通. 背俞穴定位考辨[J]. 中国针灸, 2017, 37(08): 851-855.
- [240] 张延昌, 吴祗骧, 田雪梅, 等. 《武威汉代医简》句读补正注解[J]. 甘肃中医, 2004(07): 10-11.
- [241] 黄涛, 黄龙祥. 针灸方的分类[J]. 上海针灸杂志, 2004(02): 34-38.
- [242] 李绍林. “食晦”、“食亦”考[J]. 中医杂志, 2011, 52(05): 443-444.
- [243] 田凯文, 李顺保, 柳直. 新编古今骨学名词对照表[J]. 西部中医药, 2018, 31(06): 61-64.
- [244] 廖育群. 关于中国古代的脚气病及其历史的研究[J]. 自然科学史研究, 2000, (03): 206-221.
- [245] 李浩. 晋唐“脚气”考[J]. 广东技术师范学院学报, 2014, 35(12): 44-49.
- [246] 彭卫. 脚气病、性病、天花: 汉代疑问疾病的考察[J]. 浙江学刊, 2015(02): 54-70.
- [247] 王振国. 鼠仆、鼠仆考辨[J]. 中华医史杂志, 2001(01): 31-33.
- [248] 黄龙祥. 老官山汉墓出土针方简解读[J]. 中华医史杂志, 2018, 48(2): 18.
- [249] 王一童. 老官山医简诸“瘕”、诸“痺”、诸“风”病名考释研究[D]. 成都中医药大学, 2016.
- [250] 樊经洋. 《黄帝内经素问》“运气七篇”思想研究[D]. 北京大学, 2020.
- [251] 黄龙祥. 腧穴主治的形成[J]. 中国针灸, 2000(11): 37-42.
- [252] 卞镡, 隋月皎, 田辉. 伤寒论期门穴应用探究[J]. 中国针灸, 2018, 38(04): 387-389.

- [253] 杨峰,赵京生.“蹶”的探析——一个早期医学名词的考察[J].中国中医基础医学杂志,2009,15(02):92-95.
- [254] 袁开惠.荆州胡家草场木牍载痼病方药物与疗法考[J].中医药文化,2022,17(01):85-90.
- [255] 李志芳,蒋鲁敬.湖北荆州市胡家草场西汉墓 M12 出土简牍概述[J].考古,2020(02):21-33+2.
- [256] 黄龙祥.试论非实践因素对经穴主治演变的影响[J].中国中医基础医学杂志,2000(11):4-12.
- [257] 潘萍,郭义,王东强.“明堂图”源流简考[J].针灸临床杂志,2008,(05):1-3+58.
- [258] 赵丹,段逸山,王兴伊.试析老官山汉墓《刺数》“经脉穴”与《内经》腧穴的对应关系[J].中国中医基础医学杂志,2019,25(02):205-208.
- [259] 郭太品,任玉兰,刘沂淮,等.古代冶炼工艺技术与毫针的形质及手法演变[J].中医杂志,2014,55(19):1626-1629.
- [260] 冯时.商医灸炳考[J].中原文物,2022(01):139-144.
- [261] 刘兵.非穴的效应——基于传统针灸理论的分析[J].中国针灸,2019,39(02):161-165.
- [262] 张昌云,郭桂华.经络与腧穴的发展及关系[J].山西中医学院学报,2007,(01):13-14.
- [263] 刘清,王晓梅,王素,等.关于经与穴起源先后的探讨[J].中医药学报,2016,44(06):4-6.
- [264] 付璐,李宝金,姚克宇,等.顶层本体指导下的经络腧穴语义框架构建探索研究[J/OL].中国针灸:1-13[2022-03-16].
- [265] 陈婷婷,何晶,李珊珊,等.论《难经》对腧穴学的贡献及对后世的影响[J].河南中医学院学报,2008,(01):22-24.
- [266] 逯阳.腧穴名称及穴性的文献研究与理论探讨[D].辽宁中医药大学,2018.
- [267] 陈日新,陈彦奇,谢丁一.试论艾灸得气[J].中国针灸,2019,39(10):1111-1114.

- [268] 甘肃省博物馆,甘肃省武威县文化馆.武威旱滩坡汉墓发掘简报——出土大批医药简牍[J].文物,1973(12):18-22+73-76.
- [269] 傅海燕,李君.今本《内经》成编于东汉的一条佐证[J].中华中医药学刊,2014,32(01):15-17.
- [270] 黄龙祥.腧穴归经源流初探[J].针灸临床杂志,1994(05):1-2.
- [271] 肖永俭,肖沛.腧穴体表面积探讨[J].山东中医药大学学报,1999(01):12-18+79.
- [272] 任秀玲.论中医理论的模式类推方法[J].中华中医药杂志,2010,25(11):1735-1738.

综述

先秦两汉经脉腧穴演变现代研究进展

摘要：综合先秦两汉时期经脉、腧穴理论演变相关现代学术成果，并分别对其研究内容、特点进行分析。首先，在特点方面，近年来呈现多学科（如考古学、古文字学、史学）交叉研究的趋势。在内容方面，目前学界研究重心偏向于经脉理论的演变，尤其在经脉数量演变方面讨论较多，而对腧穴理论演变研究关注度相对较低，对经脉、腧穴起源问题方面的研究较为零散，此外，在出土医学文献方面，学界对老官山医简、漆人的研究热度较高，对马王堆、张家山等汉墓医学文献的研究有“重温现象”。

关键词：经脉理论 腧穴理论 出土文献 研究进展 医学史

先秦两汉时期是中医学理论体系的萌芽及发展阶段，在很长一段时间内，研究该时期医学发展演变过程，只能依据传世文献，上世纪70年代马王堆帛书《足臂》《阴阳》的出土，揭开了“二重证据法”（出土文献与传世文献相结合）研究早期医学发展史的帷幕，几十年来，相关研究成果层出不穷，随着张家山、双包山、老官山等汉墓文献、文物的发掘，出土医学内容的丰富性引起了学术界的重视，本文重点梳理学术界对于先秦两汉经脉、腧穴理论演变过程研究的主要成果，包括期刊论文、硕博论文以及专著等。

1 经脉理论演变研究进展

1.1 早期经脉理论的建立

李建民先生根据马王堆帛书、张家山汉简、双包山木人等文献，对先秦两汉脉学的演变，如流传问题（依托、密传、文本叠压）、地域问题（燕齐、秦蜀、荆楚等派别）等进行多方面的梳理，并且认为“脉”起源于早期史官对自然界的观察与想象，而脉学形成系统，也是由于“数术化”，即天人关系的重新认识导致的^[1]。张苇航先生以手心主脉为研究对象，认为在考察经脉演变的过程中应注意自然哲学以及社会思潮的影响^[2]。林磊先生认为应当将经脉学说的起源看做是一个非线性过程，并且依据“天人同构”和“气一元论”世界观，可取“源于气功说”，经脉是古人在“内求”与“实证”的过程中形成的^[3]。“气”在简帛文献中

与针灸理论，尤其是“脉”的关系密切，秦汉早期已经形成了脉气概念的雏形，且认识到脉气的流动方向以自上而下较为重要^[4]。孙静文等认为，早期医家在对“血”与“脉”的认识基础上，逐渐形成了经络的概念^[5]，脉诊法（对血管的诊察）与针灸的关系较为密切，尤其是十二经脉环形流注理论形成之后，促使秦汉医家逐渐开始独重寸口诊法^[6]。

对于十二经脉体系的形成，杨凤、陈敏等学者认为与古人象数思维相关^[7-8]，张其成先生也认为象数符号模型在早期经络学说的建立中产生了较大的影响^[9]，邢玉瑞先生认为《素问·刺腰痛》体现着经脉理论的发生与演变^[10]。《内经》在形式上展现了经脉理论构建的古代阶段^[11]，张树剑先生认为经脉形成问题中，实体组织解剖与观察是最基本的形态，又对奇经八脉的命名问题进行论述，认为经脉的演变有一个意义积累和转化的过程^[12]。此外巫术^[13]、天文学^[14]、哲学^[15]、血管功能及解剖^[16]、人体对体表刺激产生的直观感受和客观反映^[17]等，均对经络学说的形成有影响，在这些因素影响下，逐渐形成秦汉时期中医学基础理论体系^[18]。

经脉学说演变过程中与临床实际逐渐不符合者，多是由于五行学说的植入，黄龙祥先生称之为“机械的阴阳五行学说”^[19]，《内经》《庄子》两书分别记载了任督二脉的起源，秦汉时期道家思想的盛行，成为了任督二脉发展的社会背景^[20]，相反，冲任二脉的起源则与古人对解剖生理的观察相关^[21]。姚克宇先生对经络理论的演变从起源、形成、发展和当代四个阶段进行分别论述，最终认为经络的演变存在一定的内在规律，首先在发展模式表现为“经典传承式”，其次经络理论结构的核心稳定发展，但是外延结构则有一定变化^[22]。

1.2 经脉文献成书时间

学术界一般认为，从马王堆《足臂》《阴阳》到《灵枢·经脉》之间，经脉学说呈现连续不断的线性发展过程^[23-27]，也有学者认为《阴阳》成书年代早于《足臂》^[28]，也有认为《足臂》《阴阳》两者分别属于不同的医学体系，因此没有太大的线性发展过程，这一认识最早由日本学者山田庆儿提出^[29]，后来得到不少学者的肯定^[30-31]。赵争先生通过对《足臂》《阴阳》原始文本和主体文本的梳理，认为即使是此类篇幅不长的古书，也可以分为不同层次，且相互之间可以产生影响，因此探讨成书年代早晚的问题时，应该分不同层面进行分析，比如《阴阳》中有“肩脉”“耳脉”“齿脉”等较为原始的命名方式，那么在原始文本阶段，《阴

阳》要早于《足臂》，但是《阴阳》经脉主治病症分为“是动则病”和“其所产病”两大类型，较《足臂》丰富，故主治病症应属于晚出^[32]，提示我们在对经脉演变分析时，不能笼统地以整本书为单位，或是以所属墓葬的下葬时间来区分成书时间先后，而是应该深入文本中，通过文本不同层次的对比，才能有一个准确的结论^[33]，早期经脉理论出现的多元化图景的原因，与医学流派之间的不同认识相关^[34]。陈晓红先生对出土文献、文物的经脉特点及演变进行了梳理，认为秦汉时期足脉较手脉更早成书，且《足臂》《阴阳》《十二脉》以及两具出土文物中的经脉学说应该是来自不同的医学流派^[35]。

1.3 经脉理论本身特点

出土文献中对早期经脉学说演变研究贡献最大者应属马王堆帛书^[36]，黄龙祥先生对比帛书与《灵枢·经脉》，从经脉数目、命名、循环特点以及病候演变等方面均做了研究^[37]，认为经脉学说的演变主要体现在三个方面，即同一方向上量的增加、理论体系中的“辅助添加”、经脉脏腑相连以及十二经脉环形流注体系的形成。据此，黄氏又对《灵枢·经脉》十二经脉的循行与主治病症进行“理论重构”，对早期扁鹊脉学的内容与特点也进行了梳理^[38]，在对古典针灸学特点的认识上，黄氏认为“落脚点”应该在“血气”，而经脉腧穴则是血气调节的开关^[39]。

1.3.1 经脉数量

在“十一脉”到“十二脉”的转变过程中，李永明先生认为上臂遗留正中动脉的发现是一个关键因素^[40]。李素云等学者指出，从“十一脉”演化至“十二脉”，并不是单纯的经脉数目的改变，而是代表着经脉的内涵与本质也发生了改变^[41]。对手三阴脉的整体演变过程，陈思婷等认为老官山“心主之脉”的出现是十二脉环形流注体系形成的基础^[42]。洪晓帆等对手厥阴脉的早期演化也进行考证，认为“心主之脉”的出现是为了实现三条手阴经配上焦两个脏器的目的^[43]。陈敏等对《素问·刺腰痛》中的九条脉进行分析，认为这九条脉的来源与发展与十二经脉以及奇经八脉关系密切^[44]。

1.3.2 经脉病症

对于经脉主治病症的演变原因，赵京生先生认为主要与古人对经脉的认识、对古文献的采用方式，甚至在传抄过程中出现的文字错误等因素相关^[45]。《足臂》《阴阳》中对于经脉循行与主治病症的总结，李晓彤等认为其正是早期医家对于

人体生理病理以及诊疗过程的“事实”与“解释”^[46]，李氏对足厥阴脉循行和主治病症的演变进行梳理，认为经脉学说未来理论的创新，是经脉的“物质基础”和“固有的联系”^[47]。贾杰等认为《内经》中经脉病候的形式有十二脉、足六脉、腧穴主治、脏腑病候等4种^[48]。朱丹焯先生认为出土帛书《足臂》中足太阳脉相关内容为后世描述经脉时“循行-主治”的模式开创先河^[49]。刘清先生指出古今经络内涵不同的原因，在于古代文献不加辨析而直接引用解释病因症治^[50]。

1.3.3 经脉循行

邱科等对早期经脉循行方向进行研究，将其分为“全向心性”“半向心、半离心性”“部分向心性”“全远心性”四种情况^[51]。赵京生先生认为简帛经脉文献蕴含的箭形（向心性、离心性）与《灵枢·经脉》中的环形流注体系，对腧穴与经脉之间的关系有影响^[52]，此外还认为足六脉在经脉理论中较早出现，以及从阳脉出发对经脉表里、脏腑、辨证以及主治病候的探讨^[53]。用经脉循行联系病候的产生，以及经脉理论“树形”与“环形”的演变，均与扁鹊学派的色脉诊法以及对人体生理病理的认识相关^[54]。扁鹊医学的研究对秦汉时期中医学的演变具有重要意义^[55-56]。马继兴先生对双包山木人进行考证，认为木人身上刻画有十九条经脉线，包括手三阴三阳、足三阳以及督脉，流注方向均为远心性，并对每一条经脉的循行演变进行详细考证^[57]，此外在《中国出土古医书考释与研究》中对督脉的循行演变做了详尽的考证^[58]。

1.3.4 早期经脉-脏腑相关理论研究

秦汉时期经脉脏腑产生联系，最早见于马王堆帛书，但并未形成系统，周逸平教授提出“经脉脏腑相关是经络理论的核心”^[59]，张倩博士认为《内经》基本完成了经脉与脏腑之间的联系，但六腑与经脉之间的联系理论尚不完整，并且《内经》经脉-脏腑相关理论的形成受哲学思想影响，因此在临床应用角度有其局限性^[60-61]，经脉-脏腑相关理论在《难经》中进一步补充完善^[62]。赵京生教授对经脉与脏腑之间的关系进行深入分析，认为经脉-脏腑相关理论中有太多非针灸学的成分，在经脉演变过程中，应该注意经脉理论的自身特点^[63]，此外，标本、根结、气街、四海理论也属于经脉-脏腑相关的基础^[64]。学者对经脉-脏腑相关理论从生理学角度也进行了分析^[65-66]。张建斌先生认为先秦两汉时期是“经脉起源与理论固化”时期^[67]，张氏著作《经络千古裂变——理论演变与临床应用的断代研

究》也基本理清了经脉-脏腑相关理论的发展过程^[68]。

1.3.5 经脉理论相关概念及认识

刘兵探讨了表里经脉之间的共性与个性特点,认为经脉理论的表里关系最早在《内经》中确立^[69]。并从“身形之脉、由脉到经、以脉代经”三个方面对“脉”与“经脉”进行辨析^[70]。李海峰先生对出土文献中的经脉学说进行分析,认为帛书属于经脉演变体系中的第一阶段,第二阶段则是《灵枢·经脉》^[71]。吴敦序先生以元代为界,认为元代之前的经络学说有两套(层)理论,浅层主要是腧穴之间的脉气流通,深层则是人体气血循环的通道。而元代以后这两层体系则融为一体^[72]。从解剖学角度再次认识针灸理论的本质在悄然兴起,如刘兵等从“身形”角度出发,对传统概念的现代表达做出了一些探讨。

胡蓉等对足太阳脉的演变进行梳理,发现《灵枢·经筋》中足太阳经筋更贴近于出土帛书^[73],黄佩怡先生对经筋理论古代文献,从概念、分布、特点等方面进行系统梳理^[74],颜富雄先生认为经筋理论相当于是运动系统,十二经筋则对应十二运动力线^[75],席肖晓先生对出土经脉文献进行对比研究,主要在字词方面有些新的认识^[76]。

1.4 老官山医简、漆人经脉理论研究现状

梁繁荣等在《揭秘帛书与漆人》中,对老官山汉简与漆人中的经脉、腧穴内容做了初步介绍^[77]。随着整理文献的逐步公布,学术界对老官山医简在秦汉经脉演变过程中的地位及作用进行了一系列探讨,尤其成都中医药大学研究人员发表的期刊、学位论文,对于老官山医简《十二脉》以及漆人的经脉循行进行了专门梳理并讨论^[78-87]。老官山《十二脉》是最早记载手厥阴脉(心主之脉)以及最早完整记载“十二脉”的文献^[88],李雯先生认为《十二脉》与老官山漆人、马王堆帛书代表着不同的经脉体系^[89],黄龙祥先生认为《十二脉》是综合《足臂》《阴阳》两部医籍而成^[90],并且指出《刺数》中的针灸方是预设方^[91]。广濂薰雄先生对老官山出土的《别脉》分析后认为与十五络脉有传承关系^[92]。老官山《经脉》残简与《灵枢·经脉》的内容较为相近^[93]。老官山医简记载的“损至脉”,属于扁鹊学派的典型特点^[94],但“损至脉”的理论直至《脉经》才大致完善^[95]。

黄龙祥先生认为老官山漆人体表刻画的红脉系统代表“十一脉”,而白脉系统则贴近《灵枢·经脉》中“十二脉”系统^[96]。刘澄中先生对老官山漆人体表白

线系统进行研究后认为是体表刺激腧穴时产生的感传现象^[97]。此外对于老官山漆人的命名,张雷先生认为应称作“西汉髹漆脉穴木人式”(简称“脉式”)^[98]。老官山汉墓出土的文献、文物对于秦汉时期医学典籍的重新认识,对巴蜀医学以及扁鹊学派的源流梳理,均有较为重要的意义^[99]。李建民先生指出老官山漆人对于早期中医学术史,尤其是重写扁鹊医学的重要意义^[100]。

老官山医简对于外治法的记载较多,除针刺、艾灸之外,还包括“发、石、洗、浴、渍、摩、熨、涂”等^[101]。柳长华先生提到,在《脉书·上经》《刺数》和《逆顺五色脉藏验精神》中都记载了“发法”和“石法”^[102],老官山医简对于“发”法的记载非常详细,从医理、主治病症、施治部位、操作注意事项等方面均有论述,并且“发法”“石法”也常有互用,如“发之方,病浅石而发之,病深则发而石之”。李家浩先生通过对字音的考证,认为老官山医简中的“发”法,即传世文献中的“发”^[103]。

2 腧穴理论演变研究进展

2.1 腧穴本身特点

张树剑先生认为早期腧穴的形态特点,主要与脉动、压痛、凹陷、筋骨等体表标志或结构相关,体现早期腧穴的形态学基础,后世以骨度法进行定位,逐渐失去了早期腧穴形态学的特点^[104],张胜男先生对《内经》腧穴的本身特点(数目、归经、主治)以及相关针灸方进行梳理^[105]。李建民先生在《扁鹊别脉》中认为老官山漆人的腧穴体系,显示了秦汉医家对人体大范围“区域”能量的想象,同时解读了老官山漆人体表刻画的文字含义^[106]。

董珍等对早期腧穴的别名作了专门探讨,认为《明堂经》对早期腧穴别名的研究提供了原始文献,《明堂经》中腧穴别名集中在头面部与躯干部^[107]。腧穴别名中,以人体部位进行命名的比例占到所有腧穴别名的一半以上,可能是与秦汉时期医家用以对腧穴的定位有关,腧穴别名是对主治功效的总结,是秦汉医家的医疗经验积累^[108],张旭东等对《内经》中的循经取穴问题做了专门研究,认为由于病症归经的方法不同,导致《内经》时代的循经取穴与现代有很大的差别^[109]。赵京生先生对腧穴的意义和本质进行探讨,认为腧穴的意义是其归经以及与气的关系,腧穴的本质则是作为施治处的体表固定部位^[110],以《内经》为界限,从横向(“类穴”、身形分部)与纵向(经脉、上下点位对应)分别分析腧穴主治共

性规律，从而构建腧穴的概念体系^[111]。并通过对阳经五官病候的分析，认为腧穴的主治病症，实际是由经脉病候演化而来^[112]，对厥头痛和厥心痛的腧穴选取进行分析，认为越靠近四肢远端的腧穴，其远端主治的特点就越突出^[113]。

在《内经》时代，腧穴的数目受到如数术思想^[114]、经脉归属^[115]的影响。对腧穴主治演变的影响因素，黄龙祥先生认为一些非实践因素，如类推（从“经脉穴”主治、经脉病候、藏象学说）、错会（多穴针灸方、禁忌症/脉证/脏腑病候误作主治症、腧穴判别失误、同名异穴鉴别失误等）、传抄失误等均可以导致腧穴主治的演变^[116]。赵舒蒙等对《内经》腧穴配伍规律分析，认为多穴处方中主要以左右配穴法和本经配穴法为主^[117]，梁爽等认为腧穴配伍理论的萌芽在《内经》，提出了局远配穴、表里配穴等^[118]。刘兵先生对体表非穴区的针刺效应认为，经穴与非经穴之间的区别主要是“气”与“形”的区别^[119]。像如“标”“本”以及腧穴的命名体现了“隐喻”对于经典理论概念的构建^[120]。毛茁先生对督脉数目演变进项梳理，认为《内经》中督脉有二十八穴，不能单纯认为是与二十八星宿对应，而应该放到一个动态变化过程中理解^[121]。

2.2 腧穴理论体系的建立与发展

苏妆先生将早期腧穴的演变过程分为三个阶段，第一阶段：从无到有，以痛为输；第二阶段：从少到多；第三阶段：理论升华，寻找支撑（归经）^[122]。魏然先生对秦汉时期出土文献与传世文献中腧穴归经情况进行研究，认为经脉与腧穴在《内经》之前有一个相互独立发展的阶段，而《内经》中只有一小部分的腧穴进行了经脉归经^[123]。汉以前腧穴文献主要是由《明堂经》一书进行总结集成，该书早佚，内容散见于后世医籍，黄龙祥先生于上世纪八十年代曾进行辑校^[124]。李素云先生对《明堂经》的主治病症进行考辨，认为《明堂经》中腧穴主治病症主要辑自更古的针灸方，故其行文特点是将症状与病名混杂而论^[125]。关于经脉、腧穴起源先后问题，刘清等认为两者是在临床实践过程中相互补充而形成，并不存在绝对的先后问题^[126]。张昌云等认为腧穴理论要晚于经络理论^[127]。

针灸学理论的现代化构建中，关键术语的准确表达有着重要意义^[128]，而对经脉腧穴演变史的梳理，有助于对关键术语概念的制定。理论基础的发展对于针灸学科体系建设以及针灸未来发展至关重要^[129]，对经脉腧穴理论的研究，本质上是对针灸视域下身体表达的研究^[130]。

2.3 对单个腧穴的研究

腧穴理论的发展特征,金传阳等认为应包括“名称”“定位描述”“主治内容”“分类”及“内涵”五个方面^[131],具体每个腧穴的演变过程,黄龙祥先生在《针灸腧穴通考》中,从“提要索隐”“名实考”“定位”“类属”“适应症”“操作”六个方面做了详尽的考证^[132]。张雷先生分析了马王堆帛书、武威医简、老官山汉简中的腧穴问题,重点指出了指出了传世文献中“渊腋”是“腋渊”的误倒^[133]。赵京生先生从颈项穴出发,对腧穴与经脉之间的关系做了思考,认为颈项穴的主治具有跨节段的特点,与五输穴分属于身体上下的要穴^[134]。

老官山漆人体表疑似腧穴点,最初由梁繁荣等学者进行专门研究^[135],目前仅公开了足三阳脉^[136]以及手三阴脉^[137]的疑似腧穴点,赵丹等对老官山《刺数》中腧穴名称进行分析,并指出与《内经》中相关腧穴名的对应,认为“项钜阳”可能是天柱穴,“辟阳明”可能是阳溪穴,“肱阳明”可能为丰隆穴,“肱少阴”可能是复溜穴,“颊阳明”可能是大迎穴,“耳前少阳”可能是耳门穴,“辟大阴”可能是天府穴,“头钜阳”可能是攒竹穴,“陕颞”可能是颊车穴,“肱厥阴”可能是蠡沟穴^[138]。赵京生先生借助老官山医简,考察了早期腧穴命名的演变过程,认为《刺数》中的“项太阳”是后世的天柱穴,“颊阳明”后来演化为大迎穴。对《内经》中复杂的穴名进行梳理,有助于区别早期文献中穴名与经脉名^[139]。

周琦等对荆州胡家草场出土的汉代医方木牍上记载的“已痢方”进行分析,考证了长强穴在秦汉时期的演变过程^[140]。牟东晓等对“丰隆治痰”进行专门考证,认为这一提法出现于金元时期^[141]。杨鸿静等对三阴交的定位变迁进行梳理^[142],曾天笑等对井穴与十宣穴的源流进行梳理,认为《内经》是其源头,二者可看做是一组穴位^[143],赵京生先生对背俞穴与十二经脉之间的关系进行分析,认为《内经》以标本的形式阐释了五脏背俞穴与五脏阴经之间的关系,而《千金方》中背俞穴与十二经脉的关系则更为合理^[144-145]。刘萍等对心经原穴从大陵到神门的演变过程进行梳理,认为拓宽了中医对于心病、神志病的治疗思路^[146],张娟娟对甘肃天水放马滩秦简,以及武威、敦煌、居延汉简中经脉腧穴的内容进行研究,认为这些秦汉简牍针灸文献的时间与《内经》相近,反映了甘肃等西北地区的针灸面貌,如足三里穴定位以及泉水穴主治均是特色^[147]。

3 早期针灸发展史研究情况

秦汉时期经脉、腧穴理论处于起源阶段，同时也是多元发展的阶段^[148]，先秦两汉时期经脉、腧穴的演变，还常见于一些医学专门史著作中，如王雪苔^[149]、马继兴^[150]、陈邦贤^[151]、范行准^[152]、肖少卿^[153]、黄龙祥^[154]、严健民^[155]等人所著的中医学史、针灸学史著作。两部通鉴对于早期经脉腧穴研究也给予了一定的指引^[156-157]，学者的专著中也常涉及到早期经脉腧穴相关概念术语的分析考证^[158]。赵京生先生在《针意》中对腧穴的主治规律，以及“气街”“根结”理论、经脉系统的重构等进行了深入的探讨^[159]，黄龙祥先生的《针灸典籍考》对于秦汉时期针灸著作做了源流梳理^[160]，李鼎先生在《针灸学释难》中也对早期经脉腧穴理论的演变做了梳理^[161]，廖育群先生在《岐黄医道》中对早期医学发展史，置于总的社会背景下作了简要论述，对帛书以及《内经》针灸发展进程也进行了考证^[162]，而《重构秦汉医学图像》则站在一个更高的角度，描绘了秦汉时期的医学发展概况，出土医学文献、文物的丰富，也引起了有关学者对“医学考古学”这门新兴学科的讨论^[163]。

谭奇纹先生对汉代及汉代以前的经络腧穴文献做了梳理分析，对于早期经脉腧穴理论在针灸学中的地位给予了较高评价^[164]。张树剑先生在新作《中国针灸思想史》中对针灸基本概念的起源和演变进行探讨^[165]，该书特点是内史与外史、传统与现代相结合^[166]。对早期经脉、腧穴演变研究，最终的目的是为了服务于临床，近来有学者认识到理论联系实际的重要性与必然性^[167]。

4 出土经脉文献命名研究现状

马王堆帛书《足臂》《阴阳》的命名，是由当时整理小组根据两部文献的具体内容，以及《七录》《隋书·经籍志》等传世目录类文献的体例而命名，但当时诸学者之间并未达成一致认识，如李鼎先生认为应该命名为帛书《经脉篇》第一种、第二种^[168]，王雪苔先生认为应该将二者统称为《经脉》^[169]，唐兰先生称为《经温经脉》^[170]，郭兵权先生称为《足臂十一脉》（甲种）、《足臂十一脉》（乙种）^[171]，彭坚先生则认为应该命名为《足臂十一脉》《阴阳十一脉》^[172]。

老官山出土的经脉文献，也经历了更为复杂的命名过程，最早由成都考古研究所在2013年《中国文物报》公布时分类命名为《经脉书》《脉死候》《脉数》等^[173]，随后梁繁荣等人在《揭秘》一书中，将其分类命名为《十二脉（附相脉之过）》《别脉》《刺数》等，柳长华团队将其重新命名为《脉书·下经》《刺数》，

《脉书·上经》则收录了同墓出土的《敝昔医论》。

李海峰先生认为马王堆、张家山、老官山的经脉文献在主题内容与体例上都较为相近,且张家山汉简《脉书》有明确的提名,因此诸经脉文献应该统一命名为《脉书》,再根据出土地点和文献载体的不同相区别,如张家山汉简《脉书》,可以称为《脉书》(张家山汉简本),马王堆汉墓《阴阳》(甲本)《脉法》《阴阳脉死候》可以称为《脉书》(马王堆帛书本甲),《足臂》可称为《脉书》(马王堆帛书本乙),《阴阳》(乙本)与《却谷食气》《导引图》合称为《导引食气》,有学者认为《阴阳》(乙本)是为了指导导引、行气、按摩等自我疗法,因此与《脉书》无关,老官山医简最初命名的《十二经脉(附相脉之道)》可以称为《脉书》(老官山汉简本)^[174]。

根据刘春语先生的考证,老官山汉墓出土医简的命名,应该综合考虑地理因素、历史渊源、考古学命名原则(小地名原则)、考古所发掘汉简整体命名方式等因素后,认为使用“成都老官山汉墓医简”较为妥当,出土汉简影响较大的马王堆汉简、张家山汉简、银雀山汉简均以“XXX(小地名)+汉简”的形式命名^[175]。

赵争先生考证,《阴阳脉死候》是将原本分属于特定经脉的内容纂集而成的,并且否定了《阴阳脉死候》参考了《阴阳十一脉灸经》的认识。《阴阳脉死候》反映了当时医家对于经脉死候的一般化趋势^[176],需要注意的是,这里提到的经脉死候,并不是“死亡”之意,而是指病情严重,难以治疗,秦汉医书中所提到的“死”,多是指“难以治疗”之意。老官山《脉死候》的成文方式,与马王堆《阴阳脉死候》类似,都是将原本分属于相应经脉的内容集中成篇,反映了秦汉医家对待经脉死候的认识方式,是经脉理论的一种进步。

老官山《刺数》最初称为《归脉数》,共有41简(简号629-670),李继明先生定名为《刺数》,有45简,武家璧先生认为:“《归脉数》记载各种疾病归属于何种脉络的经穴数,体现了疾病归脉的原则,开启了后世中医六经辨证的先河。”所谓“疾病归属于何种脉络”的情况,也可以从《足臂》《阴阳》两书中反映出来,《归脉数》中的这一特征,实际上并不是很具有代表性,后来梁繁荣等在《揭秘》一书中便认为此书“属针刺方法专书”,从《归脉数》的行文体例来看,如第657号简:“聋,两臂(臂)少阳各五。”其中“聋”为首列病名或症状,“两臂(臂)少阳”属于治疗(针刺)部位,“各五”属于针刺量,赵怀舟等人

认为重新定名为《刺数》之后,与原命名相比,“脉学”的特征要相对变弱^[177]。

综上所述,学术界对于先秦两汉时期经脉、腧穴理论演变的研究比较丰富,但主要集中在经脉理论的演变,期待老官山汉墓整理小组《天回医简》的出版,能够为学术界带来更多的研究材料。

参考文献

- [1] 李建民.发现古脉——中国古典医学与数术身体观:周秦汉脉学之源流[M].北京:社科文献出版社,2007:4-6.
- [2] 张苇航.“手心主脉”考——兼论早期经脉学说的演变[J].医疗社会史研究,2016,1(02):111-121+330.
- [3] 林磊.浅论经脉概念的起源及经脉理论的演变[D].北京中医药大学,2003.
- [4] 姜姗.经典针灸理论之气研究[D].中国中医科学院,2017.
- [5] 孙静文,田艳鹏,郭妍,等.脉之本义及其学术演变[J].中国针灸,2015,35(06):619-622.
- [6] 郑志杰.古脉诊法的演变及与针灸的关系[D].北京中医药大学,2008.
- [7] 杨凤,钱会南.从象数思维角度解析《黄帝内经》十二经脉理论[J].中华中医药杂志,2020,35(07):3400-3402.
- [8] 陈敏,邬昌求,吴雪仪.浅谈数术对针灸学的影响[J].中国针灸,2016,36(04):421-424.
- [9] 张其成.从简帛医书经络描述探讨早期医家身体观[J].中国针灸,2021,41(02):225-228.
- [10] 邢玉瑞.从《素问·刺腰痛篇》看经脉理论的发生与演变[J].中医杂志,2019,60(09):727-729.
- [11] 赵京生.针灸理论体系构建的早期过程与方法分析[J].中国中医基础医学杂志,2014,20(06):807-810.
- [12] 张树剑.《内经》针灸理论与概念的观念研究[D].南京中医药大学,2009.
- [13] 杨勇.战国秦汉医疗研究[D].武汉大学,2016.
- [14] 陈德成.中国古代天文学对经络学说形成的影响[J].中国针灸,1997(09):567-568.

- [15] 程雅君,赵怡然. 中医经络学说的哲学渊源[J]. 哲学研究,2017(09):65-74.
- [16] 杨坤,杨铭. 论古代经络实质与血管功能解剖的联系[J]. 世界最新医学信息文摘,2019,19(96):267+270.
- [17] 刘兵. 论针灸概念的产生——从具象基础到抽象规律[J]. 科技导报,2019,37(15):20-23.
- [18] 赵容俊. 秦汉中国医学基础理论确立的考察[J]. 医疗社会史研究,2016,1(02):75-110+329.
- [19] 黄龙祥. 经络学说的演变[J]. 中国针灸,1994(03):43-46+43.
- [20] 刘怡彬. 任、督二脉源流探析[D]. 北京中医药大学,2013.
- [21] 黄龙祥. 任脉、冲脉概念的形成与演变[J]. 中国针灸,2002(08):26-28.
- [22] 姚克宇. 从框架角度探讨中医经络理论演变[D]. 北京中医药大学,2017.
- [23] 马王堆汉墓帛书整理小组. 马王堆汉墓帛书·五十二病方[M]. 北京:文物出版社,1979:141.
- [24] 李鼎. 经络腧穴理论的形成与发展[J]. 上海中医药大学学报,2011,25(01):6-9.
- [25] 何宗禹. 马王堆帛书《足臂十一脉灸经》有关的问题再探[J]. 中华医史杂志. 1984(3):174-175.
- [26] 周一谋,萧佐桃. 马王堆医书考注[M]. 天津:天津科技出版社,1988:4.
- [27] 赵希睿,熊益亮,王群,等. 早期经脉演变浅析[J]. 中医杂志,2018,59(16):1354-1356.
- [28] 姚纯发. 马王堆帛书《足臂十一脉灸经》初探[J]. 中华医史杂志. 1982(3):171-174.
- [29] [日]山田庆儿. 《黄帝内经》的成立. 古代东亚哲学与科技文化:山田庆儿论文集[M]. 沈阳:辽宁教育出版社,1996:234-254.
- [30] 廖育群. 重构秦汉医学图像[M]. 上海:上海交通大学出版社,2012:341-350.
- [31] 赵京生. 针灸经典理论阐释[M]. 上海:上海中医药大学出版社,2000:1-8.
- [32] 赵争. 古书成书与古书年代学问题探研——以出土古脉书《足臂十一脉灸经》和《阴阳十一脉灸经》为中心[J]. 中国典籍与文化,2016(01):7-12.

- [33] 赵争. 古脉书《足臂十一脉灸经》与《阴阳十一脉灸经》相对年代问题考论[J]. 出土文献, 2015(02): 193-215.
- [34] 赵争. 从出土文献看早期经脉学说[J]. 医疗社会史研究, 2016, 1(02): 51-74+328-329.
- [35] 陈晓红. 简帛医书经脉文献比较研究[D]. 广西中医药大学, 2020.
- [36] 中医研究院医史文献研究室. 马王堆帛书四种古医学佚书简介[J]. 文物, 1975(6): 16-19.
- [37] 黄龙祥. 中国针灸学术史大纲[M]. 北京: 华夏出版社, 2001.
- [38] 黄龙祥. 经脉理论还原与重构大纲[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2016: 180-359.
- [39] 黄龙祥. 中国古典针灸学大纲[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2019: 114.
- [40] 李永明. 汉代十一脉到十二经脉转变的解剖依据[J]. 中国针灸, 2021, 41(10): 1153-1158.
- [41] 李素云, 赵京生. 从经脉的循行变化探讨其概念内涵的演变——由“十一脉”至“十二经脉”循行变化引发的思考[J]. 针刺研究, 2009, 34(02): 132-135.
- [42] 陈思婷, 刘锦光, 梁子杰, 等. 手三阴经脉演变探析[J]. 中国中医基础医学杂志, 2020, 26(10): 1526-1528.
- [43] 洪晓帆, 陈思婷, 李红霞. “心主手厥阴心包络之脉”早期演化考[J]. 中国针灸, 2021, 41(03): 349-353.
- [44] 陈敏, 肖璐. 《素问·刺腰痛论篇》中特殊九条经脉考辨[J]. 中国中医基础医学杂志, 2021, 27(07): 1062-1064.
- [45] 赵京生. 经脉病候的演变[J]. 江苏中医, 1998(10): 9-11.
- [46] 李晓彤, 何丽云, 付璐, 等. 试论针灸经脉理论发展过程中的“事实”与“解释”[J]. 中国中医基础医学杂志, 2020, 26(06): 812-813+849.
- [47] 李晓彤, 何丽云, 付璐, 等. 浅析秦汉时期足厥阴经的形成及早期演变[J]. 中华中医药杂志, 2021, 36(03): 1567-1570.
- [48] 贾杰, 赵京生. 《内经》中经脉病候表述形式探讨[J]. 中国针灸, 2007(01): 63-65.

- [49] 朱丹焯. 唐代及唐代以前足太阳膀胱经文献研究[D]. 广州中医药大学, 2012.
- [50] 刘清. 经络概念及其基础理论溯源[D]. 黑龙江中医药大学, 2017.
- [51] 邱科, 孙睿睿, 黄柳杨, 等. 试论古代经脉循行方向发展和演变[J]. 世界最新医学信息文摘, 2016, 16(40): 33-34.
- [52] 赵京生. 简帛脉学文献对经脉认识的意义[J]. 医疗社会史研究, 2016, 1(02): 36-50+328.
- [53] 赵京生. 阳脉理论演进及其意义[J]. 中国针灸, 2011, 31(11): 1035-1039.
- [54] 黄龙祥. 经脉学说与扁鹊脉法的血缘[J]. 中国针灸, 2015, 35(05): 517-523.
- [55] Shelley Denise Ochs (欧阳珊婷). 扁鹊医学之研究[D]. 中国中医科学院, 2013.
- [56] 黄龙祥. 扁鹊医籍辨佚与拼接[J]. 中华医史杂志, 2015, 45(01): 33-43.
- [57] 马继兴. 双包山汉墓出土的针灸经脉漆木人形[J]. 文物, 1996(04): 55-65+98.
- [58] 马继兴. 中国出土古医书考释与研究(上卷)[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 2014: 358-361.
- [59] 周逸平. 经脉一脏腑相关是经络理论的核心[J]. 针刺研究, 1999, 24(3): 238-241.
- [60] 张倩. 《黄帝内经》经脉脏腑相关理论研究[D]. 安徽中医药大学, 2019.
- [61] 张倩, 周美启. 经脉脏腑相关特点比较[J]. 中国针灸, 2020, 40(10): 1093-1096.
- [62] 左海燕. 《难经》经脉脏腑相关理论研究[D]. 安徽中医药大学, 2019.
- [63] 赵京生. 上下内外: 经脉脏腑相关探赜[J]. 针刺研究, 2018, 43(07): 397-399.
- [64] 左海燕, 吴生兵, 吴欣, 等. 标本、根结、气街理论在经脉脏腑相关中的认识[J]. 中国针灸, 2020, 40(12): 1357-1360.
- [65] 张维波, 王燕平, 李宏彦. 《黄帝内经》经脉脏腑相关解析[J]. 针刺研究, 2018, 43(07): 424-429.

- [66] 柳伟婷, 张亮平, 郑美凤. 经脉脏腑相关的研究与思路[J]. 针刺研究, 2018, 43(7): 430-432.
- [67] 张建斌. 经络千古裂变——理论演变与临床应用的断代研究[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2017.
- [68] 张树剑. 对经络理论史研究的讨论——评张建斌《经络千古裂变——理论演变与临床应用的断代研究》[J]. 中国针灸, 2019, 39(01): 105-107.
- [69] 刘兵. 表里关系的经脉理论研究——基于两种经脉模式认识的古代文献理论分析[D]. 南京中医药大学, 2011.
- [70] 刘兵, 朱璐. 身形之脉与经脉内涵探讨——从具象到抽象[J]. 中国针灸, 2015, 35(05): 497-500.
- [71] 李海峰. 从出土文献看战国秦汉经脉学说[D]. 上海中医药大学, 2015.
- [72] 吴敦序, 张煜. 经络学说的历史演变概述[J]. 上海中医药大学学报, 2014, 28(06): 3-6.
- [73] 胡蓉, 田永衍, 赵小强, 等. 从马王堆文献看中医灸法理论的演变——以足太阳脉为例[J]. 中国中医基础医学杂志, 2017, 23(06): 830-832.
- [74] 黄佩怡. 经筋理论的古代文献研究[D]. 北京中医药大学, 2020.
- [75] 颜富雄. 经筋系统——人体十二条运动力线的探讨与临床应用[D]. 山东中医药大学, 2016.
- [76] 席肖晓. 出土秦汉经脉文献整理与研究[D]. 贵州大学, 2019.
- [77] 梁繁荣, 王毅. 揭秘敝昔遗书与漆人[M]. 成都: 四川科学技术出版社, 2016.
- [78] 邱科. 老官山汉墓经穴髹漆人像六阴经循行特点研究[D]. 成都中医药大学, 2016.
- [79] 邱科, 周兴兰, 孙睿睿, 等. 从西汉出土经穴髹漆人像看手厥阴经脉的循行演变[J]. 中国中医基础医学杂志, 2016, 22(10): 1372-1373+1390.
- [80] 黄柳杨, 曾芳, 周兴兰, 等. 从西汉出土经穴髹漆人像看足少阳经脉的循行演变[J]. 成都中医药大学学报, 2017, 40(1): 91-94.
- [81] 印帅, 曾芳, 周兴兰, 等. 成都老官山汉墓髹漆人像足太阳经脉循行浅析[J]. 辽宁中医杂志, 2017, 44(6): 1281-1283.

- [82] 印帅,程施瑞,曾芳,等.从成都老官山汉墓髹漆人像看足阳明经脉循行演变[J].辽宁中医杂志,2017,44(01):71-73.
- [83] 邱科,曾芳,孙睿睿,等.成都老官山汉墓经穴髹漆人像手三阴经循行考证[J].中华中医药杂志,2018,33(4):1480-1482.
- [84] 张迪,周兴兰,曾芳,等.成都老官山汉墓出土髹漆经穴人像手太阳小肠经循行研究[J].中医杂志,2019,60(08):636-639.
- [85] 张乙小,周兴兰,曾芳,等.老官山汉墓出土经穴髹漆人像手阳明经脉循行演变研究[J].中医杂志,2019,60(23):1985-1987+1992.
- [86] 周兴兰,张乙小,曾芳.成都老官山汉墓出土髹漆经穴人像手少阳脉循行特点研究[J].中医杂志,2020,61(11):942-945.
- [87] 程施瑞,周兴兰,邱科,等.成都老官山汉墓经穴髹漆人像十二经脉循行考证(英文)[J].World Journal of Acupuncture-Moxibustion, 2022, 32(01): 40-48.
- [88] 任玉兰,梁繁荣,李继明,等.成都老官山汉墓出土医简《十二脉》《别脉》内容与价值初探[J].中华医史杂志,2017,47(1):37-40.
- [89] 李雯,赵争.从成都老官山汉墓医简看早期经脉理论[J].中国针灸,2016,36(12):1314-1318.
- [90] 黄龙祥.老官山出土汉简脉书简解读[J].中国针灸,2018,38(1):97-108.
- [91] 黄龙祥.老官山汉墓出土针方简解读[J].中华医史杂志,2018,48(2):67-84.
- [92] 广濑薰雄.天回老官山汉简《别脉》初探[J].出土文献与古文字研究,2020(00):316-328.
- [93] 顾漫,周琦,柳长华,等.天回医简《经脉》残篇与《灵枢·经脉》的渊源[J].中国针灸,2019,39(10):1117-1123.
- [94] 袁开惠,王小芸,赵怀舟.也谈老官山汉墓医简所载“损至脉”[J].中医药文化,2019,14(04):75-82.
- [95] 丁媛.呼吸、脉搏与疾病——从老官山汉墓医简所载之“损至脉”谈起[J].古籍整理研究学刊,2022(01):52-60.
- [96] 黄龙祥.老官山出土西汉针灸木人考[J].中华医史杂

志,2017,47(3):131-144.

[97] 刘澄中.论老官山脉穴木人的白脉循行系统——兼评“经穴髹漆人像初探”[J].中国针灸,2018,38(2):198-202.

[98] 张雷.老官山汉墓经穴俑应是脉式[J].医疗社会史研究,2017:244-251.

[99] 张逸雯,翁晓芳,顾漫.四川成都天回镇(老官山)汉墓出土医简和髹漆经脉木人研究综述[J].中华中医药杂志,2020,35(01):287-291.

[100] 李建民.作为方法的中醫出土文物[J].医疗社会史研究,2016,1(02):3-35+327.

[101] 陈星.老官山汉墓医简外治法研究[D].成都中医药大学,2018.

[102] 柳长华,顾漫,周琦,等.四川成都天回汉墓医简的命名与学术源流考[J].文物,2017(12):58-69+1.

[103] 李家浩.关于老官山医简发法的一点意见[J].出土文献,2019(01):297-299.

[104] 张树剑.早期腧穴形态观念阐微[J].中国针灸,2011,31(12):1127-1130.

[105] 张胜男.《黄帝内经》腧穴相关理论探析[D].辽宁中医药大学,2014.

[106] 李建民.扁鹊别脉:反思中国早期医学的历史[M].北京:社会科学文献出版社,2020.

[107] 董珍,侯中伟.汉及汉以前腧穴别名的来源及厘定[J].中华中医药杂志,2018,33(06):2282-2284.

[108] 董珍.汉及汉以前腧穴别名内涵及命名规律发掘研究[D].北京中医药大学,2018.

[109] 张旭东,赵吉平,刘清国.试论《黄帝内经》之循经取穴[J].中华中医药杂志,2020,35(10):4864-4867.

[110] 赵京生.腧穴概念析[J].中国针灸,2017,37(02):149-152.

[111] 赵京生.腧穴主治共性规律的表达[J].中医杂志,2019,60(24):2075-2078+2102.

[112] 赵京生.阳经五官病候及治疗用穴分析——兼论经脉病候与腧穴主治关系[J].针刺研究,2007(06):411-418.

- [113] 赵京生. 头痛心痛刺治对认识腧穴主治规律的启示[J]. 针刺研究, 2008(05): 344-347.
- [114] 卓廉士. 揭秘腧穴的数术原理[J]. 中国针灸, 2013, 33(12): 1094-1098.
- [115] 路树超, 陈思思, 刘炜, 等. 从《黄帝内经》腧穴数目演变看腧穴发展[J]. 中华中医药杂志, 2011, 26(09): 1937-1939.
- [116] 黄龙祥. 试论非实践因素对经穴主治演变的影响[J]. 中国中医基础医学杂志, 2000(11): 4-12.
- [117] 赵舒蒙, 郭义, 郭永明. 《黄帝内经》针刺处方及其腧穴配伍规律研究[J]. 中国针灸, 2019, 39(04): 439-443.
- [118] 梁爽, 陈泽林, 陈波, 等. 《黄帝内经》中腧穴配伍理论及特点探析[J]. 上海针灸杂志, 2015, 34(07): 600-602.
- [119] 刘兵. 非穴的效应——基于传统针灸理论的分析[J]. 中国针灸, 2019, 39(02): 161-165.
- [120] 肖建喜. 隐喻对针灸学经典理论建构的研究[D]. 广州中医药大学, 2011.
- [121] 毛茁. 督脉经穴数目的古今文献研究[D]. 宁夏医科大学, 2021.
- [122] 苏妆. 《黄帝内经》腧穴理论的发生学研究[D]. 辽宁中医药大学, 2013.
- [123] 魏然. 宋以前腧穴归经演变研究[D]. 北京中医药大学, 2021.
- [124] 黄龙祥. 黄帝明堂经辑校[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 1987.
- [125] 李素云. 《黄帝明堂经》腧穴主治考辨[D]. 中国中医研究院, 2005.
- [126] 刘清, 王晓梅, 王素, 等. 关于经与穴起源先后的探讨[J]. 中医药学报, 2016, 44(06): 4-6.
- [127] 张昌云, 郭桂华. 经络与腧穴的发展及关系[J]. 山西中医学院学报, 2007(01): 13-14.
- [128] 赵京生. 针灸概念史: 针灸理论的历史书写与重构基础[J]. 中国针灸, 2021, 41(08): 834-837.
- [129] 杨龙会, 景向红, 杨峰. 基于理论视域的针灸医学发展思考[J]. 中国针灸, 2020, 40(07): 685-689.
- [130] 赵京生. 针灸视域下的身体表达[J]. 中国针灸, 2019, 39(03): 307-312.

- [131] 金传阳,张建斌,许骞,等. 腧穴理论发展特征分析[J]. 针刺研究,2021,46(11):967-972.
- [132] 黄龙祥,黄幼民. 针灸腧穴通考:中华针灸穴典研究[M]. 北京:人民卫生出版社,2011.
- [133] 张雷. 老官山汉墓文物所见腧穴问题初步研究[J]. 中医文献杂志,2021,39(01):4-7.
- [134] 赵京生,姜姍. 颈项穴:“腧穴-经脉”关系认识的思辨与重识[J]. 中国针灸,2020,40(10):1085-1091.
- [135] 梁繁荣,曾芳,周兴兰,等. 成都老官山出土经穴髹漆人像初探[J]. 中国针灸,2015,35(1):91-93.
- [136] 张乙小. 成都老官山汉墓经穴髹漆人像足三阳脉腧穴考证研究[D]. 成都中医药大学,2020.
- [137] 黄柳杨. 老官山汉墓出土经穴髹漆人像手三阴经腧穴特点研究[D]. 成都中医药大学,2017.
- [138] 赵丹,段逸山,王兴伊. 试析老官山汉墓《刺数》“经脉穴”与《黄帝内经》腧穴的对应关系[J]. 中国中医基础医学杂志,2019,25(02):205-208.
- [139] 赵京生. 腧穴命名的演变:基于天回医简分析[J]. 中国针灸,2019,39(09):1017-1020.
- [140] 周琦,李志芳. 荆州胡家草场西汉墓医方木牍“已痢方”初探[J]. 简帛研究,2020(02):150-161.
- [141] 牟东晓,杨峰. 追本溯源,穷流知变——“丰隆治痰”考证[J]. 中国针灸,2021,41(09):1036-1042+1054.
- [142] 杨鸿静,谢俊,张萌,等. 浅谈三阴交位置的变迁[J]. 中国针灸,2020,40(06):683-684.
- [143] 曾天笑,梁靖蓉,郝晓敏,等. 井穴与十宣穴源流及其关系探析[J]. 中国针灸,2020,40(05):553-556.
- [144] 赵京生. 脏腑背俞穴与十二经脉关系再识[J]. 中国针灸,2015,35(08):795-799.

- [145] 贾杰,赵京生.脏腑背俞主治与足太阳膀胱经之关系[J].中国针灸,2005(06):414-416.
- [146] 刘萍,诸毅晖,张元庆,等.心经原穴的演变及其对临床的指导[J].时珍国医国药,2014,25(03):662-663.
- [147] 张娟娟.甘肃出土秦汉简牍针灸文献的比较研究[D].甘肃中医药大学,2021.
- [148] 张建斌.经络理论的断代研究与学术轨迹考察[J].南京中医药大学学报,2021,37(06):801-806+811.
- [149] 王雪苔.针灸史图录[M].北京:中国医药科技出版社,1987.
- [150] 马继兴.针灸学通史[M].长沙:湖南科学技术出版社,2011.
- [151] 陈邦贤.中国医学史[M].北京:团结出版社,2006.
- [152] 范行准.中国医学史略[M].北京:中医古籍出版社,1986.
- [153] 肖少卿.中国针灸学史[M].银川:宁夏人民出版社,1997.
- [154] 黄龙祥.中国针灸史图鉴[M].青岛:青岛出版社,2003.
- [155] 严健民.远古中国医学史[M].北京:中医古籍出版社,2006.
- [156] 邓良月.中国针灸经络通鉴[M].青岛:青岛出版社,2004.
- [157] 王德深.中国针灸穴位通鉴[M].青岛:青岛出版社,2004.
- [158] 赵京生.针灸关键概念术语考论[M].北京:人民卫生出版社,2012.
- [159] 赵京生.针意[M].北京:人民卫生出版社,2019.
- [160] 黄龙祥.针灸典籍考[M].北京:北京科学技术出版社,2017.
- [161] 李鼎.针灸学释难(重修版)[M].上海:上海中医药大学出版社,2006.
- [162] 廖育群.岐黄医道[M].沈阳:辽宁教育出版社,1991.
- [163] 赵丛苍,汶翰,张朝.医学考古学初论[J].文物,2020(12):60-65+1.
- [164] 谭奇纹.汉代及汉代以前经络腧穴文献研究[D].山东中医药大学,2004.
- [165] 张树剑.中国针灸思想史论[M].北京:社会科学文献出版社,2020.
- [166] 袁媛,李成林.追本溯源,内外兼修——评张树剑《中国针灸思想史论》[J].中医药文化,2020,15(05):59-63.
- [167] 龚萌,林栋,齐诗仪,等.从“经脉穴”反思针灸临床局部施针用穴规律[J].

中华中医药杂志,2021,36(11):6294-6297.

[168] 李鼎.从马王堆汉墓医书看早期的经络学说[J].浙江中医学院学报,1978(02):47-51.

[169] 王雪苔.中国针灸源流考[J].中医杂志,1979(08):59-64+54.

[170] 唐兰.马王堆帛书《却谷食气篇》考[J].文物,1975(06):14-15.

[171] 郭兵权.从马王堆汉墓医帛谈经络及“是动”、“所生”病候[J].山东中医学院学报,1980(04):19.

[172] 彭坚.马王堆医书学术研究一瞥——上篇:帛书经脉四种[J].湖南中医学院学报,1990(03):171-173.

[173] 成都考古研究所.成都“老官山”汉墓.中国文物报[N].2013.12.20 第4版

[174] 李海峰.论简帛经脉类文献的命名[J].出土文献综合研究集刊,2018(1):11.

[175] 刘春语,张媛.成都老官山汉墓医简命名刍议[J].出土文献综合研究集刊,2019(00):50-57.

[176] 赵争.马王堆帛书《阴阳脉死候》成书问题考论[J].出土文献综合研究集刊,2018(1):10.

[177] 赵怀舟,卢海燕,王小芸,等.老官山汉墓医简中的脉学内容初探[J].出土文献综合研究集刊,2018(1):10.

致谢

马继兴先生在《中国出土古医书考释与研究》的“前言”中提到，在其研究生涯中，或直接或间接地接触到了数量丰富的出土文献，马老感慨到：“作为一位中国古代医药文献的研究者，我是相当幸运的。”这句话对我很有触动，记得2013年秋天刚进入大三阶段的学习，在宿舍里用手机刷到了成都老官山汉墓相关新闻，犹记得标题为“成都老官山汉墓发现医简，确认为扁鹊学派失传医书”，与室友兴奋交谈之余，对第一次接触到的“简帛医学”概念充满了未知的迷茫，大四阶段在河北邢台医专附院见习之际，利用自习和闲暇时间抄写了《五十二病方》，其漫漶不清的文字，晦涩难懂的医理，是我对出土战国秦汉简帛医籍的最初印象，后来在硕士、博士研究阶段，陆续接触了其它简帛医药文献，在这个过程中，我也觉得自己是幸运的，以本论文的参考文献为例，在阅读诸学者的研究成果时，我常常觉得是如获至珍，百年来诸学者的研究心血渗透在字里行间，为我博士课题的展开提供了丰富的参考资料，尤其是阅读《回忆地动山摇的一天》《回忆简帛整理》《红楼纪事》等文章时，老一辈文献学、考古学、医学史专家对出土文献的整理与保护，可谓是披荆斩棘、呕心沥血，付出了极大的代价，我们生活在来之不易的和平年代，幸得站在前辈的肩膀上进行研究，在此为诸位学术界前辈的辛劳致以谢意。

我的导师王荃教授从2016年开始，指导我硕士与博士阶段的学习，王老师在选题以及完成论文过程中给予我极大的启发与帮助，常能一语破的地指出我的疏忽和错误，在此感谢王老师的言传身教，让我在学习、研究的过程中能够严于律己，不断地要求自己、提升自己。感谢张梅教授、李平教授、李泽庚教授、许钜教授、申国明教授、唐巍教授、王鹏教授、朱国旗教授、戴小华教授、方向明教授、吴元洁教授、黄金玲教授、童佳兵教授在开题、中期考核、预答辩以及答辩过程中给予的建议和指导。

安徽省针灸医院肿瘤科曾永蕾主任、吴勇师兄、冷玉玲老师，榆林市星元医院李强老师、刘文秀老师、李生斌老师、王志辉老师，在我临床实习过程中不嫌愚笨，殚其精而竭其虑，对我耐心指导，本科阶段教授我大学语文的孟晓燕老师，在我毕业之后仍推荐古籍让我阅读，带我进入古典文学的世界，《论语·子罕》

中有言：“夫子循循善诱人，博我以文，约我以礼，欲罢不能。”正是由于诸位老师的谆谆教诲，才能让我在学术的道路上不断前行，在此向诸位老师致以诚挚的谢意。

我的家乡在黄土高坡的一个小村庄里，我读小学五年级时，随着父母走出大山，在榆林城郊区种植蔬菜大棚，父母起早贪黑经营菜棚，母亲总是苦笑道：“我们只是从农村种地换到了在城里种地。”当春天榆林城沙尘暴卷来时，我只能用身体压在温室大棚上，不让草帘被风沙刮走，冬天则依靠一个炭炉和一间泥草堆砌的砖屋过寒，因为生活拮据，父亲后来当了一位普通的煤矿工人，我清楚地记得2005年的国庆节，当时读初一的我去父亲所在的神木县燕家塔煤矿待了几天，工人们每天升井之后全身都是煤渣，脸上更是被煤尘堆得漆黑，几乎认不出样子，矿底的寒湿和煤尘让父亲的健康也不如从前，父母用青春与汗水浇灌着我的成长，也许我用一生也无法回报。

完成博士阶段学习后，我的年龄也进入了“三十而立”，我常想“立”的是什么？是思想独立？亦或是经济独立？孔子曰：“不知礼，无以立也。”而“礼”在《礼记·曲礼上》中释为“定亲疏、决嫌疑、别同异、明是非”，我理解为道德信仰和行为规范，在接下来新的人生阶段中，也许这是对自己最好的约束与要求，自2011年学习中医学至今，已十年有余，恍惚间青春已随风而散，一句“逝者如斯夫”怎能道尽无奈，古谚云“山川而能语，葬师食无所；肺腑而能语，医师色如土”，深刻地指出了山川的本来面目也许并不如葬师所云，脏腑的真实情况可能也与医师的认识相去甚远，科学知识之无限，生命之短暂，更值得我们奉献出一生的热忱。

原定于2021年底出版的《天回医简》，在我完成“致谢”时仍无消息，为本论文的完整性带来太多的遗憾，期待《天回医简》的出版能为早期医学发展史研究带来新的认识，并对相关整理人员的辛苦致以谢意。

我在撰写这篇致谢时，正值俄乌冲突之际，战争的硝烟在每一篇新闻报道中都让人触目惊心，深感正是祖国的繁荣与稳定，才保证了我读博期间文献研究工作能够顺利进行，在此向祖国母亲致以深深的谢意和祝福。